

Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações

3ª
Edição



Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações

3^a
Edição



Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações. 3ª edição

ISBN: 978-92-75-73165-9 (PDF)

ISBN: 978-92-75-23165-4 (versão impressa)

© **Organização Pan-Americana da Saúde, 2026**

Alguns direitos reservados. Esta obra está disponível nos termos da licença Atribuição-Não Comercial-Compartilha Igual 3.0 Organizações Intergovernamentais da Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 IGO).



De acordo com os termos da licença, é permitido copiar, redistribuir e adaptar a obra para fins não comerciais, desde que se utilize a mesma licença ou uma licença equivalente da Creative Commons e que ela seja citada corretamente, conforme indicado abaixo. Nenhuma utilização desta obra deve dar a entender que a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) endossa uma determinada organização, produto ou serviço. Não é permitido utilizar o logotipo da OPAS.

Adaptações: em caso de adaptação da obra, deve-se acrescentar, juntamente com a forma de citação sugerida, o seguinte aviso legal: “Esta publicação é uma adaptação de uma obra original da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). As opiniões expressas nesta adaptação são de responsabilidade exclusiva dos autores e não representam necessariamente a posição da OPAS”.

Traduções: em caso de tradução da obra, deve-se acrescentar, juntamente com a forma de citação sugerida, o seguinte aviso legal: “Esta publicação não é uma obra original da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). A OPAS não assume nenhuma responsabilidade pelo conteúdo nem pela exatidão da tradução”.

Citação sugerida: Organização Pan-Americana da Saúde, como parte da Secretaria Executiva da Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações. 3ª edição. Brasília, D.F.: OPAS; 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.37774/9789275731659>.

Dados da catalogação: podem ser consultados em: <http://iris.paho.org> e <https://www.ripsa.org.br/>.

Direitos e licenças: para solicitações de uso comercial e consultas sobre direitos e licenças, ver www.paho.org/es/publicaciones/permisos-licencias.

Materiais de terceiros: caso um usuário deseje reutilizar material contido nesta obra que seja de propriedade de terceiros, como tabelas, figuras ou imagens, cabe a ele determinar se necessita de autorização para tal reutilização e obter a autorização do detentor dos direitos autorais. O risco de ações de indenização decorrentes da violação de direitos autorais pelo uso de material pertencente a terceiros recai exclusivamente sobre o usuário.

Avisos legais gerais: as denominações utilizadas nesta publicação e a forma como os dados são apresentados não implicam nenhum juízo, por parte da OPAS, com respeito à condição jurídica de países, territórios, cidades ou zonas ou de suas autoridades nem com relação ao traçado de suas fronteiras ou limites. As linhas tracejadas nos mapas representam fronteiras aproximadas sobre as quais pode não haver total concordância.

A menção a determinadas empresas comerciais ou aos nomes comerciais de certos produtos não implica que sejam endossados ou recomendados pela OPAS em detrimento de outros de natureza semelhante. Salvo erro ou omissão, nomes de produtos patenteados são grafados com inicial maiúscula.

A OPAS adotou todas as precauções razoáveis para confirmar as informações constantes desta publicação. Contudo, o material publicado é distribuído sem nenhum tipo de garantia, expressa ou implícita. O leitor é responsável pela interpretação do material e seu uso; a OPAS não poderá ser responsabilizada, de forma alguma, por qualquer prejuízo causado por sua utilização.

Esta publicação contém as opiniões coletivas dos membros da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e não representa necessariamente as opiniões, decisões ou políticas da OPAS, enquanto parte da Secretaria Executiva da RIPSA.

Elaboração, distribuição e informações

Rede Interagencial de Informações para a Saúde
Tels.: (61) 3315-3511 / 3315-2220
Site: <https://www.ripsa.org.br>
E-mail: ripsa@saude.gov.br

Secretaria Técnica da Ripsa

Alexander Rosewell (OPAS/OMS)
Felipe Ferré (Conass)
Luci Fabiane Scheffer Moraes (SEIDIGI/MS)
Marizélia Leão Moreira (Conasems)
Paulo Eduardo Guedes Sellera (SEIDIGI/MS)

Editores-Gerais

Alexandre Padilha (MS)
Ana Estela Haddad (SEIDIGI/MS)

Editor-Executivo

Paulo Eduardo Guedes Sellera (SEIDIGI/MS)

Editores Científicos

Andréa de Paula Lobo (SVSA/MS)
Carolina de Campos Carvalho (Icict – Fiocruz/RJ)
Cássia Rebeca de Lima Souza (SAES/MS)
Deborah Carvalho Malta (UFMG)
Isis Moura Santos (SAES/MS)
Izabel Guimarães Marri (IBGE)
José Ueleres Braga (UERJ)
Juan Cortez-Escalante (OPAS/OMS)
Juliana Lourenço Sousa (BIREME/OPAS/OMS)
Leonildo Pereira de Souza (IPARDES)
Luci Fabiane Scheffer Moraes (SEIDIGI/MS)
Maria de Fátima Marinho (UFMG)
Marli de Mesquita Silva Montenegro (SVSA/MS)
Pauline Cristine da Silva Cavalcanti (SAES/MS)
Pedro Herculano Guimarães Ferreira de Souza (IPEA)

Organizadores

Deborah Carvalho Malta (UFMG)
Juan Cortez-Escalante (OPAS/OMS)
Luci Fabiane Scheffer Moraes (SEIDIGI/MS)

Revisão Técnica

Elisabete Carmen Duarte (UnB)
Jacques Levin (SEIDIGI/MS)
Leila Posenato Garcia (Fundacentro)

Equipe Editorial**Capa e arte**

Adla Marques de Almeida Lacerda
Igor Gutemberg Mota da Silva
Milena Hernández Bendicho

Projeto gráfico e diagramação

Milena Hernández Bendicho

Revisão de português

Maria Irene Lima Mariano

Normalização

Maria Irene Lima Mariano

AGRADECIMENTOS

A 3ª edição do livro *Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações* é resultado de um esforço coletivo, colaborativo e intersetorial, que reflete o compromisso do Ministério da Saúde com a transparência, a qualidade da informação e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta obra não poderia ter sido concretizada sem a dedicação, o conhecimento técnico e a inestimável contribuição das equipes que atuam nos diferentes departamentos e secretarias desta Casa.

Expressamos nosso mais profundo reconhecimento a todos os profissionais que, direta ou indiretamente, participaram da construção desta edição. Em função da magnitude da iniciativa e do expressivo número de colaboradores, registramos nosso agradecimento de forma institucional, certos de que contemplamos cada pessoa que, com seu saber e empenho, tornou este projeto uma realidade.

Agradecemos, de maneira especial, às equipes técnicas que atuaram na linha de frente da produção desta edição. Nos diferentes departamentos, esses profissionais dedicaram-se à extração, ao tratamento, à consistência e à análise crítica das bases de dados que alimentam os indicadores ora apresentados. Foi esse trabalho silencioso, rigoroso e incansável que transformou registros administrativos dispersos em informação qualificada, tempestiva e estrategicamente relevante para a gestão do SUS.

Estendemos nosso reconhecimento, igualmente, às instituições parceiras que compartilharam conosco o compromisso com a informação em saúde. Disponibilizar fontes de dados, abrir seus sistemas, ceder acesso a bases estruturantes e colaborar ativamente nos processos de extração, tratamento, consistência e análise crítica foi um gesto de confiança e demonstração inequívoca de que a produção do conhecimento em saúde se faz no encontro de saberes, na abertura ao diálogo e na disposição coletiva de construir, em conjunto, respostas mais qualificadas para os desafios do SUS. A cada instituição, nosso respeito e gratidão.

O diferencial desta 3ª edição reside exatamente na riqueza do diálogo interinstitucional e interdepartamental, na complementaridade dos saberes e na disposição coletiva de superar desafios técnicos e operacionais em prol de um objetivo comum: oferecer à sociedade brasileira, aos gestores, pesquisadores e profissionais da saúde uma ferramenta capaz de qualificar análises, subsidiar decisões e fortalecer a gestão do SUS.

Ministério da Saúde (MS)

Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI)

- Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde (Demas)
 - › Coordenação-Geral de Monitoramento e Avaliação em Saúde (CGMA)
 - › Coordenação-Geral de Gestão da Informação Estratégica em Saúde (CGGIE)
 - › Coordenação-Geral de Disseminação e Integração de Dados e Informações em Saúde (CGDDI)

Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA)

- Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis (DAENT)
 - › Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas (CGIAE)

- › Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis (CGDNT)
- › Coordenação-Geral de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes e Promoção da Cultura de Paz (CGVIVA)
- Departamento de Doenças Transmissíveis (DEDT)
 - › Coordenação-Geral de Vigilância das Arboviroses (CGARB)
 - › Coordenação-Geral da Hanseníase e Doenças em Eliminação (CGHDE)
 - › Coordenação-Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial (CGZV)
 - › Coordenação-Geral de Vigilância da Covid-19, Influenza e Outros Vírus Respiratórios (CGCOVID)
- Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI)
 - › Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (CGVDI)
- Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente (DAEVS)
 - › Coordenação-Geral de Inteligência Epidemiológica (CGIEPI)
 - » Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE)

Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS)

- Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde (DEPPROS)
 - › Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN)
- Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária (DESCO)
 - › Coordenação-Geral de Saúde Bucal (CGSB)
 - › Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres (CGSM)

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES)

- Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (DAHU)
 - › Núcleo de Informações Estratégicas (NIE)
- Departamento de Regulação Assistencial e Controle (DRAC)
 - › Coordenação-Geral de Sistemas de Informação (CGSI)

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (SCTIE)

- Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde (DESID)
 - › Coordenação de Avaliação em Economia da Saúde (CAES)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

- Diretoria de Pesquisas (DPE)

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (DISOC/IPEA)

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

- Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES)
 - › Gerência de Padronização, Interoperabilidade e Análise de Informações e Desenvolvimento Setorial (GPIND)

Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME/OPAS/OMS)



SUMÁRIO

PREFÁCIO	15
APRESENTAÇÃO	17
CAPÍTULO 1 – INDICADORES DE SAÚDE E A RIPSa	19
1. A iniciativa Ripsa.....	21
2. Mecanismos e instrumentos operacionais de gestão.....	21
3. Indicadores e Dados Básicos (IDB)	24
CAPÍTULO 2 – MATRIZ DE INDICADORES BÁSICOS DA RIPSa	37
CAPÍTULO 3 – FICHAS DE QUALIFICAÇÃO DE INDICADORES (FQIs)	89
Demográficos (DEM)	91
Dimensão 1 – População	
DEM.1.01 – População residente.....	95
DEM.1.02 – Razão de sexo	99
DEM.1.03 – Taxa de crescimento anual da população.....	103
DEM.1.04 – Proporção de menores de 5 anos de idade na população.....	106
DEM.1.05 – Proporção de pessoas idosas na população	109
DEM.1.06 – Índice de envelhecimento	112
DEM.1.07 – Razão de dependência	115
Dimensão 2 – Fecundidade e natalidade	
DEM.2.01 – Taxas específicas de fecundidade	118
DEM.2.02 – Taxa de fecundidade total	121
DEM.2.03 – Taxa bruta de natalidade.....	124
Dimensão 3 – Mortalidade	
DEM.3.01 – Taxas específicas de mortalidade por idade e sexo	127
DEM.3.02 – Taxa bruta de mortalidade	131
DEM.3.03 – Taxa de mortalidade padronizada por idade.....	134
DEM.3.04 – Esperança de vida ao nascer.....	137
DEM.3.05 – Esperança de vida aos 60 anos de idade.....	140
Dimensão 4 – Cobertura dos sistemas de informações de nascidos vivos e de mortalidade do Ministério da Saúde	
DEM.4.01 – Cobertura do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)	143
DEM.4.02 – Cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)	147
Socioeconômicos (SOC)	151
Dimensão 1 – Educação	
SOC.1.01 – Proporção de analfabetismo na população	155
SOC.1.02 – Proporção da população sem educação básica.....	160
Dimensão 2 – Ocupação da força de trabalho	
SOC.2.01 – Proporção de desocupação na população.....	165
SOC.2.02 – Proporção da população com força de trabalho subutilizada	170
SOC.2.03 – Proporção da população ocupada sem contribuição para a previdência social	175
SOC.2.04 – Proporção de jovens que não estudam e não trabalham.....	180

SOC.2.05 – Proporção da população de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil.....	185
Dimensão 3 – Renda	
SOC.3.01 – Rendimento domiciliar <i>per capita</i> a preços correntes.....	190
SOC.3.02 – Proporção da população abaixo da linha de pobreza	195
SOC.3.03 – Coeficiente de Gini da distribuição da renda domiciliar <i>per capita</i>	201
SOC.3.04 – Razão entre a renda total dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres	206
SOC.3.05 – Produto interno bruto <i>per capita</i>	211
Dimensão 4 – Saneamento	
SOC.4.01 – Proporção da população urbana sem acesso seguro à água	214
SOC.4.02 – Proporção da população urbana sem instalações sanitárias adequadas	218
SOC.4.03 – Proporção da população sem coleta direta ou indireta de lixo	223
Dimensão 5 – Segurança alimentar	
SOC.5.01 – Proporção da população em situação de insegurança alimentar moderada ou grave	227
Mortalidade (MRT).....	231
Dimensão 1 – Mortalidade infantil e na infância	
MRT.1.01 – Taxa de mortalidade infantil.....	235
MRT.1.02 – Taxa de mortalidade neonatal precoce.....	241
MRT.1.03 – Taxa de mortalidade neonatal tardia	246
MRT.1.04 – Taxa de mortalidade pós-neonatal.....	251
MRT.1.05 – Taxa de mortalidade em menores de 5 anos	256
Dimensão 2 – Mortalidade materna	
MRT.2.01 – Razão de mortalidade materna	262
MRT.2.02 – Mortalidade materna segundo grupos de causas.....	268
Dimensão 3 – Mortalidade geral	
MRT.3.01 – Mortalidade proporcional por causas.....	274
MRT.3.02 – Proporção de óbitos por causas mal definidas.....	279
Dimensão 4 – Mortalidade por causas externas	
MRT.4.01 – Taxa de mortalidade por agressão.....	284
MRT.4.02 – Taxa de mortalidade por lesão autoprovocada.....	290
MRT.4.03 – Taxa de mortalidade por lesão de trânsito.....	296
MRT.4.04 – Taxa de mortalidade por causas acidentais	302
Dimensão 5 – Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis	
MRT.5.01 – Taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis	308
MRT.5.02 – Taxa de mortalidade por neoplasias malignas.....	314
MRT.5.03 – Taxa de mortalidade por diabetes <i>mellitus</i>	320
MRT.5.04 – Taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares	325
MRT.5.05 – Taxa de mortalidade por doenças respiratórias crônicas.....	331
MRT.5.06 – Probabilidade de morte prematura por doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes <i>mellitus</i> e doenças respiratórias crônicas	337
Dimensão 6 – Mortalidade por doenças transmissíveis	
MRT.6.01 – Taxa de mortalidade específica por doenças infecciosas e parasitárias	342

Morbidade (MRB).....349

Dimensão 1 – Incidência de doenças transmissíveis

MRB.1.01 – Incidência de sarampo.....	353
MRB.1.02 – Incidência de rubéola	358
MRB.1.03 – Incidência de síndrome da rubéola congênita	363
MRB.1.04 – Incidência de difteria.....	367
MRB.1.05 – Incidência de coqueluche.....	371
MRB.1.06 – Incidência de tétano neonatal.....	376
MRB.1.07 – Incidência de tétano acidental.....	380
MRB.1.08 – Incidência de febre amarela.....	384
MRB.1.09 – Incidência de raiva humana.....	388
MRB.1.10 – Incidência de cólera	393
MRB.1.11 – Incidência de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika	397
MRB.1.12 – Incidência de Zika em gestante	401
MRB.1.13 – Incidência de doença meningocócica	406
MRB.1.14 – Incidência de meningite não meningocócica.....	411
MRB.1.15 – Incidência de leptospirose.....	416
MRB.1.16 – Incidência de febre maculosa	421
MRB.1.17 – Incidência de esquistossomose mansoni não grave	425
MRB.1.18 – Incidência de doença de Chagas aguda	429

Dimensão 2 – Taxa de incidência de doenças transmissíveis

MRB.2.01 – Taxa de incidência de aids.....	433
MRB.2.02 – Taxa de incidência de sífilis congênita.....	438
MRB.2.03 – Taxa de incidência de hepatite B.....	442
MRB.2.04 – Taxa de incidência de hepatite C.....	447
MRB.2.05 – Taxa de incidência de tuberculose	452
MRB.2.06 – Taxa de incidência de hanseníase.....	457
MRB.2.07 – Taxa de incidência de hanseníase na população menor de 15 anos.....	462
MRB.2.08 – Taxa de incidência de leishmaniose tegumentar	467
MRB.2.09 – Taxa de incidência de leishmaniose visceral.....	472
MRB.2.10 – Taxa de incidência de toxoplasmose adquirida durante a gestação.....	476
MRB.2.11 – Taxa de incidência de toxoplasmose congênita.....	481
MRB.2.12 – Taxa de incidência parasitária anual de malária	486
MRB.2.13 – Taxa de incidência de dengue.....	490
MRB.2.14 – Taxa de incidência de dengue grave.....	495
MRB.2.15 – Taxa de incidência de chikungunya	500
MRB.2.16 – Taxa de incidência de Zika.....	505
MRB.2.17 – Taxa de incidência da síndrome respiratória aguda grave por COVID-19.....	510

Dimensão 3 – Prevalência de exposição em doenças transmissíveis

MRB.3.01 – Proporção de categoria de exposição de aids.....	515
---	-----

Dimensão 4 – Morbidade hospitalar

MRB.4.01 – Taxa de internação hospitalar (SUS) por causas externas.....	520
MRB.4.02 – Taxa de internação hospitalar (SUS) por condições sensíveis à atenção primária	525

Fatores de Risco e Proteção (FRP) 531

Dimensão 1 – Doenças crônicas

FRP.1.01.1 – Prevalência de diabetes <i>mellitus</i> autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	537
FRP.1.01.2 – Prevalência de diabetes <i>mellitus</i> autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	542
FRP.1.02.1 – Prevalência de hipertensão arterial autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	547
FRP.1.02.2 – Prevalência de hipertensão arterial autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	551

Dimensão 2 – Consumo de álcool

FRP.2.01.1 – Prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas referido por indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	556
FRP.2.01.2 – Prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas referido por indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	561
FRP.2.02.1 – Prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade dirigindo veículos motorizados após consumo de bebidas alcoólicas (Vigitel)	566
FRP.2.02.2 – Prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade dirigindo veículos motorizados após consumo de bebidas alcoólicas (PNS)	571
FRP.2.03 – Consumo de álcool em litros de álcool puro <i>per capita</i> (entre pessoas com 15 anos ou mais de idade) por ano	577

Dimensão 3 – Tabagismo

FRP.3.01.1 – Prevalência de fumantes atuais com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	581
FRP.3.01.2 – Prevalência de fumantes atuais com 18 anos ou mais de idade (PNS)	586
FRP.3.02.1 – Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	591
FRP.3.02.2 – Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	595
FRP.3.02.3 – Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em escolares de 13 a 17 anos de idade (PeNSE)	600
FRP.3.03.1 – Prevalência de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	604
FRP.3.03.2 – Prevalência de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade (PNS)	609

Dimensão 4 – Atividade física

FRP.4.01.1 – Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	614
FRP.4.01.2 – Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	619
FRP.4.02.1 – Prevalência de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	625
FRP.4.02.2 – Prevalência de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	631

Dimensão 5 – Estado nutricional

FRP.5.01.1 – Prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	638
FRP.5.01.2 – Prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	643
FRP.5.02 – Prevalência de excesso de peso em crianças menores de 5 anos de idade	648

FRP.5.03 – Prevalência de déficit ponderal para a idade em crianças menores de 5 anos de idade	653
FRP.5.04 – Prevalência de déficit estatural para a idade em crianças menores de 5 anos de idade	658
FRP.5.05 – Prevalência de dupla carga da má nutrição em crianças menores de 5 anos de idade	663
Dimensão 6 – Consumo alimentar	
FRP.6.01 – Prevalência de aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida	668
FRP.6.02 – Prevalência de aleitamento materno continuado em crianças menores de 2 anos	674
FRP.6.03 – Participação relativa diária <i>per capita</i> das calorias de frutas, verduras e legumes no total de calorias dos alimentos adquiridos no domicílio	680
Dimensão 7 – Parto	
FRP.7.01 – Proporção de nascidos vivos por idade da parturiente	684
FRP.7.02 – Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer por idade gestacional no momento do parto	688
FRP.7.03 – Prevalência de nascidos vivos com anomalias congênitas	692
Dimensão 8 – Violência	
FRP.8.01 – Prevalência de violências contra mulheres com 18 anos ou mais de idade (PNS)	696
FRP.8.02 – Prevalência de violência sexual contra meninas de 13 a 17 anos de idade (PeNSE)	703
Dimensão 9 – Saúde bucal	
FRP.9.01 – Índice CPO-D (número de dentes cariados, perdidos e obturados) aos 12 anos de idade	708
FRP.9.02 – Proporção de criança de 5 a 6 anos de idade livres de cárie (índice ceo-d igual a 0)	712
Indicadores de Cobertura (COB)	717
Dimensão 1 – Consultas médicas e odontológicas	
COB.1.01 – Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Primária à Saúde por 100 habitantes	721
COB.1.02 – Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Especializada em Saúde por 100 habitantes	725
COB.1.03 – Razão de consultas médicas (saúde suplementar) por beneficiários de planos privados de saúde	729
COB.1.04 – Proporção da população que referiu ter consultado médico nos últimos 12 meses (PNS)	733
COB.1.05 – Proporção da população que referiu ter realizado consulta odontológica nos últimos 12 meses (PNS)	737
COB.1.06 – Proporção da população que referiu nunca ter realizado consulta odontológica (PNS)	741
Dimensão 2 – Internações hospitalares	
COB.2.01 – Taxa de internações hospitalares (SUS) por 100 habitantes	745
COB.2.02 – Taxa de internações hospitalares (saúde suplementar) por 100 beneficiários de planos privados de saúde	749
COB.2.03 – Proporção da população que referiu internação hospitalar nos últimos 12 meses (PNS)	753

Dimensão 3 – Saúde da mulher

COB.3.01.1 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero há menos de três anos (PNS)	757
COB.3.01.2 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero há menos de três anos (Vigitel).....	762
COB.3.02.1 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero (PNS)	767
COB.3.02.2 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero (Vigitel)	772
COB.3.03.1 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de dois anos (PNS).....	777
COB.3.03.2 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de dois anos (Vigitel).....	781
COB.3.04.1 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia (PNS).....	786
COB.3.04.2 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia (Vigitel)	790

Dimensão 4 – Assistência ao parto e saúde reprodutiva

COB.4.01 – Proporção de nascidos vivos segundo o número de consultas de pré-natal.....	795
COB.4.02 – Proporção de partos hospitalares.....	799
COB.4.03 – Proporção de partos cesáreos.....	803
COB.4.04 – Proporção da população do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiu uso de métodos anticoncepcionais (PNS)	807

Dimensão 5 – Cobertura por planos de saúde

COB.5.01 – Proporção da população coberta por planos privados de assistência à saúde	811
COB.5.02 – Proporção da população que referiu cobertura por planos de saúde (PNS)	815

Indicadores de Recursos (REC)..... 819

Dimensão 1 – Recursos humanos

REC.1.01 – Trabalhadores da saúde por população.....	823
--	-----

Dimensão 2 – Capacidade instalada

REC.2.01 – Leitos hospitalares por população	828
REC.2.02 – Distribuição proporcional de leitos hospitalares segundo natureza jurídica.....	834
REC.2.03 – Equipamentos de imagem por população	839

Dimensão 3 – Recursos financeiros: assistência à saúde

REC.3.01 – Valor médio de referência por atendimento ambulatorial no Sistema Único de Saúde	844
REC.3.02 – Valor médio de referência por autorização de internação hospitalar	848
REC.3.03 – Gasto em ações e serviços públicos de saúde como percentual do produto interno bruto	852
REC.3.04 – Gasto em ações e serviços públicos de saúde <i>per capita</i>	857

Dimensão 4 – Recursos financeiros: despesas em saúde

REC.4.01 – Despesa com saúde autorreferida como proporção da renda familiar	861
REC.4.02 – Despesa com saúde estimada como proporção da renda familiar	864
REC.4.03 – Gasto nacional com saúde como percentual do produto interno bruto	868
REC.4.04 – Gasto nacional <i>per capita</i> com saúde	872
REC.4.05 – Gasto federal com saúde como percentual do produto interno bruto	876
REC.4.06 – Gasto federal com saúde como percentual do gasto federal total	881

Dimensão 5 – Recursos financeiros: gasto com saneamento

REC.5.01 – Gasto público com saneamento básico como percentual do produto interno bruto	886
REC.5.02 – Gasto federal com saneamento básico como percentual do produto interno bruto	891
REC.5.03 – Gasto federal com saneamento básico como percentual do gasto federal total	895

Dimensão 6 – Recursos financeiros: bens e serviços

REC.6.01 – Proporção das importações de bens e serviços de saúde na oferta nacional	899
---	-----

CAPÍTULO 4 – FONTES DE INFORMAÇÃO903

1. Sistemas de informações do Ministério da Saúde	905
1.1 Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)	905
1.2 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)	906
1.3 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)	906
1.4 Sistema de Informações RESP-Microcefalia	907
1.5 Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica – Malária (Sivep-Malária)	907
1.6 Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe)	907
1.7 Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)	908
1.8 Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)	908
1.9 Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde (Siaps)	908
1.10 Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)	909
1.11 Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel)	909
1.12 Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom)	909
1.13 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)	909
1.14 Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP)	910
2. Outros sistemas de informações de entidades públicas	910
2.1 Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos	910
2.2 Sistema de Informações de Beneficiários (SIB)	911
2.3 Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS)	911
2.4 Sistema de Contas Nacionais (SCN)	912
2.5 Sistema de Contas Regionais (SCR)	912
2.6 Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)	913
2.7 Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi)	913
2.8 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi)	913
2.9 SIGA Brasil (Senado Federal)	913

3. Pesquisas e inquéritos populacionais.....	914
3.1 Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS)	914
3.2 Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).....	914
3.3 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)	914
3.4 Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)	914
3.5 Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)	915
3.6 Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE).....	915
3.7 Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil)	915
3.8 Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN).....	915
3.9 Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI).....	915
3.10 Pesquisa Industrial Anual-Produto (PIA-Produto).....	916
4. Projeções populacionais	916
4.1 População Residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade, 2000-2024.....	916
4.2 Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: estimativas e projeções. Revisão 2024.....	917
LISTA DE SIGLAS	923
EQUIPE TÉCNICA DOS COMITÊS DE GESTÃO DE INDICADORES.....	931

PREFÁCIO

É com satisfação que apresento este livro de indicadores da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa), uma publicação que reforça um princípio essencial para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS): não há gestão pública de qualidade sem informação de qualidade. Em um país com a dimensão, a diversidade e os desafios do Brasil, produzir, qualificar e utilizar indicadores de forma consistente é parte do caminho para ampliar o acesso, reduzir desigualdades e melhorar resultados em saúde.

A Ripsa representa, historicamente, um esforço de cooperação técnica e institucional que valoriza o consenso, a transparência metodológica e a articulação entre diferentes áreas e níveis de gestão. Esse trabalho, construído de maneira interagencial, contribui para que indicadores não sejam apenas números em tabelas, mas instrumentos de leitura da realidade, capazes de orientar prioridades, acompanhar tendências e apoiar decisões em tempo oportuno. Quando bem definidos e corretamente interpretados, os indicadores ampliam nossa capacidade de enxergar onde estão os maiores riscos, as populações mais vulnerabilizadas e os pontos da rede de atenção que precisam de maior apoio.

Este livro foi concebido para ser uma referência prática e confiável para gestores, técnicos, profissionais de saúde, equipes de planejamento, pesquisadores, estudantes e toda pessoa interessada em compreender melhor a situação da saúde no Brasil. Ao organizar indicadores e seus elementos de qualificação, a publicação favorece o uso responsável da informação, reduzindo ambiguidades e facilitando a comparabilidade entre territórios, períodos e fontes.

Os indicadores aqui apresentados dialogam diretamente com os grandes eixos de gestão e de cuidado no SUS – como as mudanças demográficas, as condições sociais e seus impactos sobre a saúde, a morbidade e a mortalidade, a cobertura de serviços e o desempenho da rede de atenção, além dos fatores de risco e proteção que influenciam adoecimentos e agravos. Essa visão integrada reforça que saúde não se explica apenas pela ocorrência de doenças, mas também por determinantes sociais, ambientais, econômicos e culturais. Ao mesmo tempo, ela evidencia que avanços duradouros dependem de políticas públicas articuladas, com acompanhamento contínuo e capacidade de correção de rumos.

Mais do que disponibilizar uma lista de indicadores, esta obra busca apoiar o leitor em perguntas fundamentais concernentes ao trabalho em saúde pública:

- O que exatamente este indicador mede?
- Qual é a fonte e como ela é produzida?
- Quais são as limitações e cuidados quanto à interpretação?
- Como comparar adequadamente municípios, estados e regiões?
- Como utilizar o indicador para planejar e avaliar políticas, programas e serviços?

Ao responder a essas questões, o livro ajuda a promover o uso de indicadores com rigor e responsabilidade, evitando conclusões apressadas e fortalecendo a cultura de análise crítica. Isso é especialmente importante porque indicadores, embora essenciais, não “falam sozinhos”. Eles exigem contexto, método, leitura qualificada – e, sobretudo, compromisso com a melhoria da vida das pessoas.

Também merece destaque o papel desta publicação na consolidação de práticas de padronização e qualificação metodológica. Em um cenário de rápida evolução tecnológica e de ampliação do uso de dados, cresce a necessidade de instrumentos que organizem conceitos, alinhem definições e favoreçam a interoperabilidade. A construção de bases sólidas para a informação em saúde contribui para aprimorar políticas de vigilância, planejamento, avaliação e comunicação com a sociedade, além de apoiar a formulação de estratégias nacionais e subnacionais alinhadas às necessidades reais dos territórios.

Por fim, registro meu reconhecimento às instituições e equipes que, por meio do trabalho técnico colaborativo, tornaram possível a produção de um livro com este nível de estrutura, utilidade e ambição. Publicações como esta demonstram que o SUS é também um projeto de inteligência coletiva, capaz de somar esforços para qualificar decisões e aumentar a eficiência de políticas públicas, sem perder de vista sua finalidade maior: promover saúde com equidade, dignidade e cuidado integral.

Que este livro seja amplamente utilizado – não apenas como fonte de consulta, mas como apoio concreto à prática cotidiana de quem planeja, executa, monitora e avalia ações no SUS. E que ele contribua para fortalecer uma gestão orientada por evidências, sensível às desigualdades e comprometida com resultados para a população brasileira.

Alexandre Padilha

Ministro de Estado da Saúde do Brasil

APRESENTAÇÃO

A produção e o uso qualificado de indicadores em saúde são condições essenciais para planejar, monitorar e avaliar políticas públicas, identificar desigualdades e orientar respostas oportunas do Sistema Único de Saúde (SUS). Em um país com a diversidade e a complexidade do Brasil, fortalecer a capacidade de transformar dados em informação útil – e informação em decisão – é parte do compromisso com a gestão pública, a transparência e a garantia de direitos.

É nesse contexto que se insere o livro *Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações* (2026), concebido como um guia prático e técnico para apoiar gestores, profissionais, pesquisadores e estudantes na compreensão, na seleção e na utilização de indicadores e fontes de informação em saúde. Esta publicação dialoga com uma necessidade concreta do cotidiano: reduzir ambiguidades, padronizar conceitos, explicitar métodos e tornar mais clara a trajetória que vai da fonte de dados ao indicador, do indicador à análise, e da análise à ação.

A Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa) é uma iniciativa colaborativa voltada à geração, análise e disseminação de informações aplicadas a políticas, programas e ações de saúde pública, reunindo instituições governamentais e não governamentais que atuam de forma consensual na produção e divulgação de dados e indicadores sobre as condições de saúde e seus determinantes.

Criada em 1996 por cooperação entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), a Rede consolidou, ao longo de sua história, um modo de trabalho baseado no diálogo técnico, na construção coletiva e na busca por consistência metodológica – características que se refletem diretamente na qualidade e na credibilidade de seus produtos.

Após um período de paralisação, a Ripsa foi reativada em 2023, por iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com a OPAS/OMS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), no âmbito de sua Secretaria Técnica.

Essa retomada não significa apenas recomeçar: representa atualizar propósitos, incorporar aprendizados e responder a demandas contemporâneas, como a necessidade de sistemas mais ágeis, interoperáveis e orientados à ciência aberta, em um cenário de transformação tecnológica e de crescente exigência social por acesso qualificado à informação.

Esta edição foi organizada para oferecer um percurso de leitura e consulta que ajude o usuário a: (i) entender o papel e a governança da Ripsa; (ii) reconhecer seus instrumentos operacionais e produtos; (iii) localizar a matriz de indicadores; (iv) utilizar fichas de qualificação e fontes; e (v) compreender como acessar e extrair dados em ambientes digitais. Ao reunir esses elementos em um único volume, o *Livro Verde* busca facilitar a navegação entre conceitos, códigos, fontes e procedimentos, contribuindo para análises mais consistentes e comparáveis.

Um dos avanços estruturantes desta edição é a renumeração e a padronização dos códigos dos indicadores, resposta a um desafio acumulado ao longo de edições anteriores: a expansão e a reorganização do conjunto de indicadores, ainda que necessárias, acabaram por produzir códigos menos intuitivos e menos coesos.

Para superar essas limitações, foi implementada uma nova estratégia de classificação e codificação, substituindo-se o sistema baseado em letras únicas por um padrão com siglas de três letras que identificam sete categorias temáticas consolidadas (DEM, SOC, MRT, MRB, FRP, COB e REC).

Além disso, os indicadores passaram a ser organizados por dimensões temáticas, o que torna a estrutura mais clara, sustentável ao longo do tempo e mais amigável para busca e referência – especialmente em ambientes digitais e em processos de comunicação técnica que exigem precisão.

Outro eixo central é o fortalecimento das Fichas de Qualificação do Indicador (FQIs) como ferramenta de padronização metodológica e de transparência. Para acompanhar a reorganização dos Indicadores e Dados Básicos (IDB) e as atualizações metodológicas, o Portal de Fichas de Qualificação foi modernizado: houve revisão e reorganização de categorias, atualização de *templates* e leiautes e desenvolvimento de recursos para apresentação mais dinâmica, buscando tornar a consulta mais clara e coerente.

Para assegurar atualização contínua e maior consistência entre sistemas, o portal passou a se conectar diretamente ao Módulo de Gestão de Dados e Indicadores (MGDI) por meio de uma *application programming interface* (API), reduzindo etapas manuais e fortalecendo a confiabilidade das informações publicadas.

A evolução do ecossistema digital da Ripsa também é parte desta história. O Portal da Rede tem raízes na integração com a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e em iniciativas de cooperação técnica que buscaram, desde cedo, ampliar o acesso e a padronização do conhecimento em saúde.

No ciclo recente de reativação, o portal passou por ampla reformulação, conduzida pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME/OPAS/OMS), com abordagem orientada à experiência do usuário, reorganização de conteúdos, modernização tecnológica e aprimoramento de serviços de manutenção, suporte e segurança.

A nova versão foi apresentada na 30ª Oficina de Trabalho Interagencial (OTI), em 2024, como marco de um portal mais robusto e alinhado às necessidades da Rede e de seus usuários.

A retomada da Ripsa, e esta nova edição do *Livro Verde*, refletem a capacidade de reinvenção e de pactuação institucional do SUS e de seus parceiros. Nesses anos recentes, novos indicadores foram propostos para dialogar com desafios atuais do país e com compromissos nacionais e globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e agendas de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, entre outras prioridades.

Ao mesmo tempo, reforça-se uma premissa fundamental: indicadores não são fins em si mesmos. Eles ganham sentido quando usados com rigor técnico, leitura crítica, transparência metodológica e responsabilidade pública – e quando ajudam a iluminar problemas e orientar soluções.

Por fim, registro o reconhecimento ao trabalho coletivo que sustenta a Ripsa: equipes técnicas, instâncias colegiadas, instituições participantes e parceiros que contribuem para a qualificação contínua da informação em saúde no Brasil. Espera-se que este *Livro Verde* seja um instrumento útil, convidando à consulta frequente, ao uso crítico e à aplicação prática dos indicadores em favor da melhoria das condições de vida e de saúde da população brasileira.

Ana Estela Haddad

Secretária de Informação e Saúde Digital



CAPÍTULO 1

INDICADORES DE
SAÚDE E A RIPSА

1. A iniciativa Ripsa

A Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa) constitui uma iniciativa colaborativa, solidária e integrada, voltada à geração, análise e disseminação de informações estratégicas para a saúde pública no Brasil. Criada em 1996 por meio de cooperação entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), sua missão fundamental é sistematizar dados e indicadores que ampliem o conhecimento da realidade sanitária nacional e de suas tendências, subsidiando decisões no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

De natureza técnica, interinstitucional e não hierarquizada, a Ripsa reúne instituições governamentais e não governamentais de reconhecida *expertise*, que atuam de forma consensual. A colaboração entre organizações com culturas e missões distintas tem sido um pilar essencial da Rede, permitindo fortalecer a continuidade e a qualidade da área de informação em saúde no país e, sobretudo, assegurar a relevância e a confiabilidade dos dados produzidos. Seu trabalho é pautado pela construção de acordos sobre conceitos, métodos e critérios para o uso de bases de dados, garantindo a comparabilidade das informações.

Após um período de paralisação, a Ripsa foi reativada em 2023 por iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com a OPAS/OMS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) – que compõem sua Secretaria Técnica. A retomada foi formalizada pelo Decreto nº 11.358/2023, que atribuiu ao Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde (DEMAS/SEIDIGI/MS) a competência de apoiar o desenvolvimento das metodologias, estratégias, instrumentos avaliativos e parâmetros da Rede.

Atualmente, a Ripsa é integrada por 45 instituições – a quantidade de integrantes da Rede é dinâmica, refletindo seu caráter evolutivo –, representativas dos segmentos produtores de informação, gestores do sistema de saúde e instituições de ciência e tecnologia. A adesão formal dessas entidades visa estabelecer parcerias voltadas ao aperfeiçoamento contínuo de informações de interesse comum.

Os produtos da Rede resultam de um processo contínuo de construção coletiva, no qual cada instituição contribui com sua *expertise* específica, assegurando pluralidade, legitimidade e credibilidade técnico-científica. Esse arranjo promove a integração de conhecimentos, o aprimoramento metodológico e a consolidação de práticas qualificadas de análise e disseminação de dados.

Por meio desse esforço cooperativo, a Ripsa visa assegurar a disponibilidade adequada, oportuna e abrangente de dados básicos, indicadores e análises, fornecendo aos gestores do SUS evidências relevantes para o planejamento e a avaliação das ações de saúde em todo o território nacional. Sua atuação consolida-se, assim, como uma instância técnica qualificadora e um fórum estratégico para o fortalecimento da informação em saúde no Brasil.

2. Mecanismos e instrumentos operacionais de gestão

O processo de trabalho da Ripsa é operacionalizado por meio de instâncias previstas em seus instrumentos legais de criação, os quais são pilares fundamentais que desempenham papel central na condução das ações, conforme especificado a seguir.

- **Oficina de Trabalho Interagencial (OTI):** Fórum colegiado responsável pelo planejamento participativo e pela tomada de decisões consensuais da Rede. Coordenada pela

Secretaria Técnica (ST) e integrada por representantes titulares e suplentes das instituições-membros, a OTI reúne-se semestralmente para deliberar sobre o Planejamento Operacional de Produtos (POP), bem como para definir e acompanhar a produção de indicadores básicos de saúde e seus determinantes. A depender da pauta, podem ser convidadas instituições de reconhecida excelência não integrantes da Rede.

A Ripsa realiza, desde 2023, reuniões com os coordenadores e relatores dos Comitês de Gestão de Indicadores (CGIs), instância operacional criada para articular e agilizar as decisões e atividades desses comitês. Entre 2023 e 2025, ocorreram vários encontros presenciais e *online*, sempre organizados cerca de um mês antes da OTI, para alinhamento de pautas comuns, padronização de procedimentos e tratamento de temas transversais. Os coordenadores e relatores funcionam como elos de comunicação com seus comitês, fortalecendo a governança participativa, a integração e a coerência na elaboração dos produtos e metas da Ripsa.

- **Secretaria Técnica (ST):** Instância responsável pela coordenação, planejamento e execução operacional das atividades da Ripsa. Composta pelo Ministério da Saúde (por meio da SEIDIGI/MS), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e OPAS/OMS, a ST reúne-se mensalmente para gerir as ações da Rede, apoiar as estruturas colegiadas, manter a interlocução com os comitês e com a OTI, analisar e aprovar a inclusão de novas instituições, coordenar o POP e assegurar a execução das propostas e recomendações pactuadas.

Para viabilizar o suporte técnico especializado, a Ripsa possui dois fóruns estratégicos que funcionam em caráter permanente e temporário com atribuições específicas, conforme explicitado a seguir.

- **Comitês de Gestão de Indicadores (CGIs):** Instâncias técnico-científicas responsáveis pelo aprimoramento contínuo dos indicadores de saúde, mediante revisão de dados, aspectos metodológicos e operacionais. Os CGIs reúnem-se periodicamente conforme deliberação de seus membros, e podem contar com a participação de outras instituições, de acordo com a temática. Cada CGI é composto por coordenador e relator(es) indicados pela OTI, além de representantes das instituições parceiras com *expertise* na área. A Ripsa estrutura-se atualmente em sete CGIs.
 1. **Demográfico:** Comitê responsável pelos indicadores demográficos, os quais são fundamentais para compreensão das tendências populacionais, como crescimento e distribuição etária. As informações geradas por esse indicador fornecem a base para planejar serviços de saúde adequados às necessidades específicas de diferentes grupos populacionais.
 2. **Socioeconômico:** Comitê responsável pelo acompanhamento dos fatores socioeconômicos, que desempenham um papel importante na saúde pública. Os indicadores desse CGI ajudam a entender como condições de educação, emprego, renda, acesso a serviços básicos e condições de moradia impactam o bem-estar e a qualidade de vida das populações. A partir desses dados, é possível identificar as disparidades entre diferentes grupos populacionais, indicando aqueles com maior exposição a riscos e possibilitando intervenções direcionadas para reduzir desigualdades em saúde.
 3. **Mortalidade:** Comitê responsável pelos indicadores que mensuram a magnitude e a distribuição dos óbitos, segundo atributos de pessoa, lugar e tempo. Possibilita a análise de variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade específica, orienta ações de saúde pública direcionadas, identifica situações de

desigualdade e tendências, subsidia processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas, além de fornecer dados importantes para pesquisas epidemiológicas e clínicas.

4. **Morbidade:** Comitê responsável pelos indicadores de morbidade, que mensuram a magnitude de eventos de saúde da população brasileira por medidas de incidência de doenças, ajudando a reconhecer os desfechos mais frequentes e emergentes. Tais indicadores permitem ainda aferir os riscos de internação hospitalar por condições graves realizadas no SUS.
 5. **Fatores de Risco e Proteção:** Comitê que monitora comportamentos e condições considerados fatores de risco (por exemplo, o uso de tabaco e o consumo de álcool) e/ou de proteção (como estado nutricional, alimentação saudável, aleitamento, prática de atividade física), os quais impactam a saúde, ao predisporerem ou protegerem contra doenças e agravos.
 6. **Cobertura:** Comitê responsável pelos indicadores de cobertura de utilização de serviços de saúde, como consultas médicas, realização de procedimentos e vacinação. Tais indicadores são importantes para avaliar o atendimento das necessidades de saúde da população pelo sistema de saúde e para subsidiar políticas públicas. Considerando-se as categorias de análise sugeridas para os indicadores, eles permitem identificar desigualdades e direcionar intervenções para a promoção da equidade em saúde.
 7. **Recursos:** Comitê responsável pelos indicadores que medem a disponibilidade e distribuição de recursos para a operação eficaz do sistema de saúde, incluindo pessoal, infraestrutura e financiamento. Tais indicadores são essenciais para subsidiar análises sobre adequação dos serviços e acesso a estes, pois ajudam a identificar lacunas de recursos e a desenvolver estratégias para melhorar o atendimento às necessidades de saúde da população, considerando-se os diferentes contextos (econômico, social, cultural, político e ambiental).
- **Comitês Temáticos Interdisciplinares (CTIs):** Os CTIs são grupos de trabalho temporários, formados por especialistas das instituições-membros e por convidados, com o objetivo específico de abordar temas prioritários, emergentes ou de natureza transversal para a saúde pública brasileira. Sua criação segue um protocolo que assegura rigor e foco: a proposta, que pode ser iniciativa de um Comitê de Gestão de Indicadores (CGI) ou de qualquer instituição integrante da Rede, é precedida pela elaboração de um Esquema Básico, aprovado pela OTI. Em seguida, formaliza-se um Termo de Referência (TR), documento submetido à ST e aprovado pela OTI, que estabelece com clareza o escopo, a duração, a periodicidade das reuniões e os produtos esperados do comitê. A atuação dos CTIs é orientada por um conjunto de atribuições estratégicas que os tornam verdadeiros motores de inovação e qualificação no âmbito da Ripsa. Suas principais competências são:
 1. Abordar temas transversais e prioritários em saúde pública.
 2. Desenvolver e testar novas metodologias e abordagens de análise em saúde.
 3. Identificar lacunas de conhecimento e propor soluções técnicas e operacionais.
 4. Atuar como fóruns qualificados para discussão de temas emergentes em saúde.
 5. Analisar criticamente e aprimorar metodologias, indicadores e ferramentas já existentes.

6. Propor novos indicadores para monitoramento de temas emergentes e prioritários.
7. Estabelecer e difundir padrões de qualidade para as informações em saúde utilizadas na Rede.

A pertinência dos CTIs é ilustrada por sua agenda recente. Entre 2023 e 2025, foram instituídos comitês sobre temas de grande impacto no SUS, como Atenção Primária à Saúde, Saúde Indígena, Estimativas Municipais de população, Desigualdades em Saúde e Saúde Digital.

Em síntese, os CTIs materializam os princípios de atuação da Ripsa. Por meio da construção coletiva de consenso e da mobilização de *expertise* multissetorial, asseguram que a informação estratégica para o SUS seja continuamente atualizada, qualificada e alinhada com os principais desafios nacionais em saúde.

A Ripsa dispõe de um conjunto integrado de instrumentos operacionais, concebidos para organizar, sustentar e documentar o trabalho colaborativo em prol da geração e disseminação de informações estratégicas para o SUS. Estes instrumentos garantem coerência técnica, transparência processual e eficácia na cooperação entre as diversas instituições que compõem a Rede.

Dentre eles, destacam-se três ações estratégicas:

1. **Matriz de Indicadores:** Constitui a base unificadora e o núcleo técnico da Ripsa. Definida por critérios rigorosos de relevância, validade e aderência ao SUS, esta matriz organiza um conjunto essencial de métricas para o diagnóstico e a vigilância da saúde da população. É um sistema dinâmico, continuamente atualizado e aprimorado por meio da contribuição articulada de todas as instituições integrantes da Rede.
2. **Planejamento Operacional de Produtos (POP):** Funciona como a agenda central de coordenação e gestão das atividades. Por meio dele, são pactuados semestralmente os produtos a serem gerados, as metas, as atividades necessárias e as responsabilidades institucionais. Este instrumento funciona como uma agenda operacional que orienta o trabalho colaborativo da ST e das demais instâncias da Ripsa, alinhando os objetivos estratégicos, promovendo transparência, previsibilidade e efetividade na execução dos produtos pactuados.
3. **Produtos da Informação:** Representam os resultados concretos do esforço coletivo da Rede. No conjunto destes produtos, merece especial destaque a publicação regular dos Indicadores e Dados Básicos (IDB), que consolida e disponibiliza, de forma sistemática, um painel essencial para a compreensão da situação de saúde e o monitoramento de suas tendências no país. A Ripsa dedica-se, desde sua origem, ao aprimoramento contínuo e à manutenção da disponibilidade deste e de outros produtos fundamentais.

3. Indicadores e Dados Básicos (IDB)

3.1 Conceitos e critérios

A disponibilidade de informações em saúde apoiadas em indicadores com dados válidos e confiáveis é uma condição essencial para a análise objetiva da situação sanitária e para a tomada de decisão baseada em evidências. A busca por medidas que representem o estado de saúde da população é uma atividade central em saúde pública, e os indicadores de saúde são propostos para esse fim.

Em termos gerais, indicadores de saúde são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde da população e do desempenho do sistema de saúde. Observados em conjunto, eles devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde e seus determinantes.

A construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar sobremaneira, desde a simples contagem direta de casos de determinada doença, até o cálculo de proporções, razões, taxas, intervalos de confiança ou índices mais complexos, como a esperança de vida ao nascer.

O grau de excelência de um indicador depende de uma série de atributos, como sua *validade* (capacidade de medir o que se pretende), *confiabilidade* (reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares), *sensibilidade* (capacidade de detectar o fenômeno analisado), *especificidade* (capacidade de distinguir o fenômeno de outras condições similares), *mensurabilidade* (basear-se na disponibilidade de dados), *relevância* (mostrar-se relativo a eventos de saúde prioritários) e *custo-efetividade* (permitir avaliar se o fenômeno mensurado justifica o investimento de tempo e recursos). A partir dessas características, espera-se que os indicadores possam ser analisados e interpretados, e que sejam compreensíveis pelos usuários da informação, especialmente gestores e atores do controle social. Além disso, os indicadores básicos devem ter dois importantes atributos: *integridade e completude* (dados completos e qualificados) e *consistência interna* (valores coerentes e não contraditórios).

A qualidade dos indicadores de saúde depende do uso sistemático de conceitos operacionais e de procedimentos padronizados de cálculo. A seleção e a manutenção de um conjunto básico de indicadores devem estar fundamentadas em instrumentos e métodos simples, que facilitem sua regular extração a partir dos sistemas de informação. Além disso, para assegurar a confiança dos usuários na informação produzida, é preciso assegurar a qualidade desses indicadores, revisar periodicamente a consistência da série histórica dos dados e disseminar a informação com oportunidade e regularidade.

Dessa forma, os indicadores são instrumentos valiosos para o monitoramento e a avaliação da situação de saúde e para a gestão em todos os níveis. Um conjunto básico de indicadores se destina a produzir evidências, criando uma base empírica capaz de identificar grupos humanos com maiores necessidades de saúde, estratificar o risco epidemiológico e identificar áreas críticas. Constitui, assim, insumo para o estabelecimento de intervenções em saúde pública adequadas às necessidades da população.

Além de prover substrato essencial para a análise da situação de saúde de uma população, a disponibilidade de um conjunto básico de indicadores tende a facilitar o monitoramento de objetivos e metas em saúde, estimular o fortalecimento da capacidade analítica das equipes e promover o desenvolvimento de sistemas de informação intercomunicados e interoperáveis que auxilie na disponibilidade de informações válidas, confiáveis e sistematizadas para apoiar a tomada de decisões baseadas em evidências.

Nesse contexto, os IDB da Ripsa emergem como ferramenta essencial, oferecendo medidas-síntese que refletem o estado de saúde da população e o desempenho do sistema. A importância e a contribuição desses indicadores são amplificadas por uma estrutura técnica robusta, que inclui a rigorosa definição de conceitos e critérios – garantindo

atributos como validade, confiabilidade e relevância –, o aperfeiçoamento contínuo das Fichas de Qualificação do Indicador (FQIs) – assegurando transparência, padronização e integração tecnológica – e uma recente reestruturação de sua codificação, que proporciona clareza temática, flexibilidade e facilidade de uso. Coletivamente, esses elementos consolidam um conjunto básico de indicadores capaz de produzir evidências empíricas para identificação de iniquidades, estratificação de riscos, monitoramento de metas e, sobretudo, fundamentação do planejamento de intervenções em saúde pública adequadas às necessidades da população, fortalecendo assim a gestão em todos os níveis do SUS.

3.2 Fichas de Qualificação do Indicador (FQIs)

Evolução histórica da FQI: da criação à atualização de 2024

Um importante marco na produção do livro de Indicadores Básicos foi a introdução de instrumentos de orientação técnica aos usuários, que esclarecem os conceitos e critérios adotados pela Ripsa para a construção dos indicadores. Por recomendação da 3ª OTI, realizada em 1997, cada indicador passou a ter uma ficha de qualificação padronizada, que estabelece as bases técnicas para a correta interpretação e utilização das informações.

As fichas de qualificação permitem uma comparação eficaz dos indicadores ao longo do tempo e entre diferentes regiões, facilitando a identificação de tendências e a avaliação do impacto das políticas de saúde. Elas também promovem a transparência e a confiabilidade das informações, oferecendo dados e análises que embasam a formulação de políticas e estratégias de saúde pública e apoiam o processo para a tomada de decisões informadas por evidências.

Esta iniciativa pioneira evoluiu significativamente ao longo dos anos, culminando em um novo marco em 2024, quando a 31ª OTI revisou e definiu novos campos para as fichas de indicadores. Esta atualização teve como objetivo principal assegurar maior transparência, padronização e reprodutibilidade das informações, adequando o instrumento às necessidades contemporâneas de gestão em saúde.

Um dos pilares centrais dessa atualização foi a integração com o Módulo de Gestão de Dados e Indicadores (MGDI), solução tecnológica desenvolvida pelo DEMAS/SEIDIGI/MS especificamente para a gestão de dados e indicadores. O MGDI desempenha um papel crucial como plataforma única para o cadastramento, armazenamento e gerenciamento de todas as FQIs da Ripsa, garantindo padronização e consistência no tratamento das informações.

Durante a 31ª OTI, decidiu-se pela adaptação do MGDI às necessidades específicas da Ripsa, o que demandou uma avaliação criteriosa da ficha original da Rede em comparação com a ficha utilizada no Ministério da Saúde. A importância do MGDI para o cadastro das FQIs é fundamental, pois esta plataforma permite: (i) o cadastramento padronizado e unificado de todas as FQIs; (ii) o gerenciamento eficiente da série histórica dos indicadores; (iii) a viabilidade de interoperabilidade com os sistemas do Ministério da Saúde; e (iv) a disponibilização integrada das FQIs no Portal da Ripsa e na Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE).

Um processo construtivo e colaborativo

O desenvolvimento e atualização da FQI foi resultado de um processo rigoroso, que compreendeu duas atividades principais: (i) a adequação da solução tecnológica MGDI às

necessidades específicas da Ripsa; e (ii) a utilização do MGDI para cadastramento das FQIs e gerenciamento da série histórica.

A partir de uma análise minuciosa, em que foram cotejados os oito campos da ficha original da Ripsa com os 36 campos da FQI do MGDI, emergiu um modelo otimizado e altamente focado, composto por 16 campos. Esta ampliação incorpora elementos fundamentais, visando especialmente facilitar o cadastramento das FQIs no sistema e o gerenciamento eficiente da série histórica dos indicadores.

Estrutura e funcionalidade da FQI: campos essenciais

Os 16 campos que compõem a versão atual da FQI constituem o núcleo essencial de informações necessárias para descrever, interpretar e gerenciar cada indicador, assegurando consistência técnica e padronização. Integrada ao MGDI, a FQI passou a incorporar os campos descritos abaixo.

1. Código da Ripsa: traz a identificação da dimensão e do número do indicador específico.
2. Título completo: deve descrever claramente o que está sendo mensurado, incluindo as intenções de dimensionamento.
3. Título resumido: deve expressar de forma concisa o que está sendo mensurado pelo indicador para uso em tabelas, quadros, gráficos e painéis.
4. Conceito: especifica os conceitos utilizados no indicador, definindo sua natureza e forma de expressão. Deve incluir elementos que facilitem a compreensão do que está sendo mensurado.
5. Interpretação: orienta a análise e compreensão dos dados do indicador, oferecendo uma explicação sucinta sobre o tipo de informação obtida e seu significado para a saúde.
6. Usos: descreve as principais formas e razões para a utilização dos dados e informações do indicador.
7. Limitações: indica os fatores que podem restringir a interpretação e aplicação do indicador. Essas limitações podem estar relacionadas à apuração dos dados, fonte, fórmula de cálculo, interpretação ou temporalidade, influenciando a avaliação da situação analisada.
8. Fontes de dados: refere-se à base de origem dos dados utilizados no cálculo.
9. Fórmula de cálculo: trata-se da expressão matemática que combina as variáveis e os elementos de um indicador para obtenção de resultado.
10. Método de cálculo: descreve o procedimento necessário para calcular o indicador, detalhando os processos envolvidos. Deve garantir a possibilidade de reprodutibilidade por equipe de tecnologia da informação autorizada, considerando-se a eventual confidencialidade dos dados.
11. Variáveis e categorias de análise: representam a segmentação do indicador para análises específicas, apresentando as variáveis como sexo, faixa etária, território, cor ou raça, estabelecimento de saúde com suas respectivas categorias, entre outros.

12. Granularidade: define o recorte espacial/territorial de referência do indicador recomendado para desagregação máxima do dado (menor grau da informação), dentro do prazo previsto para atualização do indicador.
13. Periodicidade de atualização: refere-se à frequência com que os dados são atualizados no banco de dados (diária, bimensal, mensal, anual, semestral).
14. Responsabilidade gerencial: identifica a unidade gestora encarregada de promover o acompanhamento sistemático e contínuo do indicador, assim como de proceder à tomada de decisão em relação ao resultado obtido.
15. Notas: é o campo aberto para informações complementares não contempladas nos demais campos, permitindo o registro de contextualizações adicionais, observações metodológicas ou alertas específicos para os usuários.
16. Análise descritiva do indicador: este é um componente especialmente diferencial da FQI da Ripsa. Vai além da definição técnica, apresentando uma descrição geral do indicador, um breve relato sobre a situação de saúde a ele referente e a forma como será representado nas análises descritivas, acompanhados das respectivas visualizações (figuras, tabelas, quadros, gráficos etc.). Essas visualizações são imediatamente precedidas de suas descrições, oferecendo aos usuários uma compreensão prática e contextualizada do comportamento do indicador na realidade do SUS. Este campo transforma a ficha de um documento técnico em uma ferramenta narrativa e analítica, enriquecendo significativamente a interpretação e a divulgação dos dados.

A seleção estratégica destes 16 campos, contidos na FQI e no MGDI, garante à Ripsa a agilidade e o foco necessários para o gerenciamento eficaz de seu portfólio de indicadores. Essa estrutura também possibilita sua disponibilização, por meio do MGDI, em outras plataformas de disseminação de indicadores, favorecendo a integração, automação e interoperabilidade dos dados.

Adoção de padrões científicos para as fichas de qualificação

No contexto da Ripsa, a implementação de padrões uniformes para a elaboração das FQIs reforça a integridade e a acessibilidade dos dados, melhora a qualidade e a confiabilidade dos conteúdos, e facilita sua interpretação e análise. Esse processo, desenvolvido em parceria com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME/OPAS/OMS), contribuiu para se estabelecer uma abordagem mais sistemática de gestão da informação e uma comunicação mais eficaz entre pesquisadores, profissionais e instituições da Rede.

A adoção de padrões para o desenvolvimento das FQIs melhora significativamente a visibilidade e a facilidade de acesso às informações, pois documentos padronizados são mais facilmente encontrados, compreendidos e utilizados. A uniformidade na apresentação permite que os usuários localizem rapidamente conteúdos relevantes e interpretem sua aplicação de maneira mais intuitiva. Além disso, ao estabelecer formatos consistentes para documentos não convencionais, como é o caso da FQI, a Ripsa assegura a integração harmoniosa de novas formas de apresentação e tipos de dados, mantendo a compatibilidade com normas científicas. Desse modo, a padronização das FQIs reforça a qualidade e a confiabilidade das informações e contribui para o avanço do conhecimento e da pesquisa na área da saúde.

No que concerne aos documentos científicos e técnicos, são estabelecidos padrões uniformes para a garantia de clareza, consistência e integridade na divulgação das informações. Esse processo assegura que todos os documentos, independentemente de sua origem ou propósito, sigam um padrão coerente, facilitando a comunicação, a compreensão e a integração das informações.

Para garantir esta padronização segundo critérios científicos, foram incorporados novos componentes que fortalecem a uniformização, a interoperabilidade e a visibilidade científica das FQIs. Os principais elementos acrescentados são descritos a seguir.

- Digital Object Identifier (DOI): assegura persistência e interoperabilidade, garantindo que o identificador digital permaneça funcional e facilite a citação correta da FQI em diferentes plataformas acadêmicas.
- Título traduzido: amplia o alcance internacional do conteúdo, facilita a indexação em bases de dados e estimula colaborações globais.
- Referências e modo de citação (“como citar”): reforçam a credibilidade do documento, asseguram o reconhecimento das fontes utilizadas e facilitam a verificação e o uso adequado das informações por terceiros, adotando-se o estilo Vancouver para apresentação das referências, por ser este amplamente utilizado na área da saúde.
- Creative Commons (licenciamento): estabelece de modo transparente os direitos de uso, compartilhamento e adaptação do conteúdo, aumentando a visibilidade e o impacto das publicações.
- Research Organization Registry (ROR) – identificação institucional: permite padronizar afiliações, eliminar ambiguidades na identificação das instituições e favorecer a integração com sistemas de ciência aberta, além de facilitar o monitoramento de métricas acadêmicas. A Ripsa está registrada no ROR sob o identificador <https://ror.org/02ng2c866>, o que assegura sua presença padronizada em bases e plataformas de informação científica.

Esses componentes, integrados às FQIs, reforçam a qualidade técnica dos indicadores e ampliam sua inserção nos ecossistemas contemporâneos de produção, circulação e avaliação da informação científica. Consolida-se, com essa inovação, a FQI como uma peça de referência no campo da informação em saúde, garantindo sua perenidade e reconhecimento formal na literatura especializada.

Esta estrutura, que será operacionalizada por meio do MGDI, não apenas facilita a correta utilização dos indicadores, mas também fortalece a integração de dados entre diferentes sistemas e instituições, consolidando a Ripsa como uma rede confiável e estratégica para a informação em saúde no Brasil. A nova FQI é, portanto, a base técnica que sustenta a credibilidade, a utilidade, a perenidade e o reconhecimento científico do vasto conjunto de indicadores disponibilizados pela Rede, promovendo, em tempo oportuno, a disponibilidade integral dessas informações no Portal da Ripsa.

3.3 Renumeração e padronização dos códigos dos indicadores

A renumeração e a estruturação dos indicadores da Ripsa representam um avanço significativo na organização e na usabilidade do sistema. O processo de construção e atualização do conjunto de indicadores da Rede é dinâmico e acompanha a evolução das políticas de

saúde, a incorporação de novas fontes de informação e o aprimoramento contínuo dos métodos de mensuração. Desde a primeira edição do livro *Indicadores e Dados Básicos* (IDB), em 2002, na qual foi estabelecida uma matriz inicial com indicadores numerados no formato X.n, sendo X a letra correspondente ao grupo temático, o sistema passou por expansões e ajustes importantes, refletindo a maturidade técnica da Ripsa e sua busca permanente por maior clareza, coerência e facilidade de uso.

Na edição subsequente, a inclusão, a exclusão, a subdivisão e a realocação de indicadores, embora necessárias, resultaram em uma numeração que não mais refletia uma sequência lógica e coesa dentro de cada grupo. Indicadores com números sequenciais passaram a tratar de assuntos distintos, enquanto novos temas eram alocados em números "quebrados", afastando-se da ordem original. Essa realidade, somada à divisão do grupo original "Morbidade e Fatores de Risco" em dois grupos distintos ("Morbidade" e "Fatores de Risco e Proteção"), que na sequência alfabética ficaram separados, evidenciou a necessidade de uma reformulação estrutural.

Para a presente edição, foi implementada uma nova estratégia de classificação e codificação, visando superar essas limitações. O sistema anterior, baseado em letras únicas, foi substituído por um padrão que utiliza siglas de três letras para identificar as sete categorias temáticas consolidadas dos indicadores (Quadro 1).

Dentro de cada categoria, os indicadores foram reorganizados em dimensões temáticas, representadas pelo primeiro dígito numérico após a sigla. O segundo e o terceiro dígitos compõem um sequencial único para cada indicador dentro de determinada dimensão (por exemplo, SOC.1.01). Indicadores que apresentam mais de uma FQI recebem um sub-número adicional (por exemplo, FRP.1.01.1 e FRP.1.01.2).

Quadro 1 – Classificação e codificação dos indicadores

Categorias e siglas	
Demográfico	DEM
Socioeconômico	SOC
Mortalidade	MRT
Morbidade	MRB
Fatores de Risco e Proteção	FRP
Cobertura	COB
Recursos	REC
Código Ripsa	
Categoria abreviada (3 letras)	XXX
Número da dimensão (1 dígito)	(1º nº)
Número do indicador (2 dígitos)	(2º nº)

A importância dessa reestruturação é tripla, conforme explicitado a seguir.

1. Clareza e lógica temática: A nova numeração agrupa e organiza os indicadores por temas afins dentro de dimensões específicas, facilitando a localização e a

compreensão das relações entre eles. Por exemplo, no grupo SOC (Socioeconômico), a Dimensão 1: Educação reúne indicadores relacionados ao nível de escolaridade, às condições educacionais da população etc. No grupo REC (Recursos), a Dimensão 2: Capacidade instalada agrupa indicadores que descrevem a infraestrutura disponível nos serviços de saúde, como a oferta de leitos, a distribuição desses recursos e a presença de equipamentos estratégicos. Essa lógica de agrupamento se repete nas demais dimensões, permitindo uma visualização mais intuitiva e coerente do conjunto de indicadores.

2. **Flexibilidade e sustentabilidade:** O novo sistema oferece uma estrutura robusta para acomodar futuras inclusões ou exclusões de indicadores. A adição de um novo tema não requer a renumeração de indicadores existentes, pois ele pode ser alocado na sequência numérica disponível dentro de sua dimensão correspondente. Isso elimina o problema de "códigos quebrados" e garante a estabilidade do sistema ao longo do tempo.
3. **Facilidade de busca e referência:** A codificação intuitiva, baseada em siglas temáticas e em uma numeração sequencial e previsível, potencializa a experiência do usuário, tornando a busca e a referência aos indicadores mais ágeis e menos suscetíveis a erros. Um código passa a identificar, de forma única e permanente, um conceito específico, o que evita a confusão gerada por um mesmo código representando indicadores diferentes, como acontecia em edições passadas.

Esta renumeração representa um marco na organização da informação em saúde pela Ripsa, consolidando um sistema mais inteligível, expansível e alinhado com as necessidades contemporâneas de gestão e análise de dados, para o aprimoramento da saúde pública no Brasil.

3.4 Portal da Ripsa para acesso e disseminação da informação em saúde

O desenvolvimento do Portal da Ripsa tem raízes em sua integração à Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A inserção da Ripsa na BVS foi concretizada em 2006, com a formalização do 5º Termo de Ajuste do 14º Termo de Cooperação (Fase I), entre a Representação da OPAS/OMS do Brasil, por meio da BIREME, e o Ministério da Saúde, para a criação da BVS Ripsa. O objetivo foi desenvolver um espaço de interação, compartilhamento e funcionamento da Ripsa, tornando-a acessível e padronizada segundo o modelo da BVS.

Estabelecida em 1998, a BVS é uma iniciativa coordenada pela BIREME, como modelo de gestão da informação baseado no trabalho colaborativo e em rede, que envolve diversos países e instituições na criação, organização, promoção do acesso e uso da informação científica e técnica atinente ao conhecimento em saúde.

Com a reativação da Ripsa em 2023, após quase uma década de paralisação, o Portal da Rede também foi retomado, por meio de um novo termo de cooperação firmado entre a OPAS/OMS – a ser executado por seu centro especializado, a BIREME – e a SEIDIGI/MS. A retomada ocorreu em um contexto de transformação tecnológica, marcado pelos avanços da indústria 4.0, pela digitalização dos processos de informação e pela crescente demanda por sistemas mais ágeis, interoperáveis e orientados à ciência aberta.

Nesse cenário, tornou-se indispensável reformular o portal da Ripsa, para que ele pudesse acompanhar as transformações tecnológicas e responder às necessidades atuais de

transparência e de acesso às informações. O início desse processo foi marcado pela 29ª OTI, realizada em 2023, que oficializou a retomada das atividades da Rede e reafirmou o compromisso com o fortalecimento da gestão e da disseminação da informação em saúde.

Como parte do processo de reativação da Rede, o portal da Ripsa passou por uma ampla reformulação, conduzida pela BIREME/OPAS/OMS, guiada por abordagens de *user experience* (UX) e *design thinking*, para aprimoramento da organização da informação, da usabilidade e da acessibilidade. O trabalho envolveu o mapeamento dos conteúdos existentes, estudos com usuários da Rede, o desenvolvimento de modelos de interface e protótipos navegáveis, a criação de um novo desenho gráfico e a revisão e atualização dos conteúdos. Além disso, a plataforma tecnológica foi modernizada, com a atualização de *plugins* e estruturas, e a manutenção do portal foi aprimorada, com serviços contínuos de suporte técnico, hospedagem e *backup*. Todo esse processo contou ainda com discussão técnica realizada em conjunto com o DEMAS/SEIDIGI/MS, incluindo sugestões que consolidaram a articulação interinstitucional e fortaleceram a governança técnica das soluções implementadas.

O objetivo foi consolidar um portal mais robusto, funcional e alinhado às necessidades da Ripsa e de seus usuários, capaz de ampliar o acesso, a transparência e a disseminação das informações produzidas pela Rede. O resultado desse trabalho foi apresentado durante a 30ª OTI, em 2024, quando a nova versão do portal foi oficialmente lançada.

Atualização do Portal de Fichas de Qualificação da Ripsa

Integrado ao Portal da Ripsa, o Portal de Fichas de Qualificação acompanha a evolução tecnológica recente e as atualizações realizadas tanto no portal principal quanto nos IDB, que passaram por renumeração, reorganização temática e aprimoramentos metodológicos. Diante desse novo cenário, o Portal de Fichas também foi modernizado, para que sua estrutura refletisse a organização atualizada dos indicadores e favorecesse o acesso à informação.

O processo envolveu a revisão do conteúdo disponível, a reorganização das categorias, a adequação da apresentação das fichas ao novo padrão adotado pela Rede, o desenvolvimento de um *plugin* para apresentação dinâmica das páginas, a elaboração dos novos *templates* e leiautes para as fichas e a definição dos campos a serem exibidos na interface pública. O objetivo foi oferecer um ambiente mais claro e coerente, facilitando a navegação e garantindo que o portal representasse fielmente a lógica estruturante das fichas da Ripsa.

Para assegurar atualização contínua e maior consistência entre os sistemas, o Portal de Fichas passou a se conectar diretamente ao MGDl por meio de uma *application programming interface* (API), o que permite ler as fichas e seus códigos atualizados. Essa integração reduz etapas manuais, aumenta a confiabilidade das informações e fortalece a gestão dos indicadores. Assim, o Portal de Fichas torna-se mais dinâmico e atualizado.

O portal da Ripsa, desde então sediado na BIREME/OPAS/OMS, consolidou-se como espaço de referência para a organização e acesso qualificado às informações produzidas pela Rede, garantindo visibilidade e acesso a conteúdos essenciais para gestores, pesquisadores, profissionais de saúde e para o público em geral. Com sua atualização, a Ripsa reafirma seu papel estratégico na gestão da informação e do conhecimento em saúde, fortalecendo a tomada de decisão e ampliando sua relevância para o SUS e para a sociedade.

3.5 Base eletrônica dos IDB: acesso, análise e transparência dos dados em saúde

A eficácia da informação em saúde como instrumento de gestão e controle social depende, fundamentalmente, de sua acessibilidade, confiabilidade e atualização contínua. Para garantir esses atributos essenciais, os IDB da Ripsa são sustentados por uma infraestrutura de divulgação sofisticada e dinâmica. Esta estrutura tem como propósito central transformar dados brutos em conhecimento público acessível e acionável, servindo como base empírica para decisões estratégicas e para o exercício da cidadania.

Para maximizar o potencial dessas informações, além do MGDl, a Ripsa opera por meio de outras três ferramentas complementares e estratégicas: o TabNet, a SAGE e o Portal de Dados Abertos do SUS. Juntas, elas formam um ecossistema integrado que democratiza o acesso, qualifica a análise e promove a transparência, fortalecendo a cultura do uso de evidências em todas as esferas do SUS.

TabNet: Consolida-se como a principal ferramenta de tabulação e disseminação de dados do SUS, evoluindo continuamente para atender às demandas contemporâneas de análise e gestão. Na sua versão mais recente, desenvolvida com tecnologia Python 3.11 e apoiada no banco analítico DuckDB, a ferramenta amplia significativamente sua capacidade de processamento, permitindo a geração dinâmica de gráficos interativos, mapas e painéis personalizáveis diretamente no navegador.

Mantendo a interface amigável e acessível que caracteriza sua trajetória, o TabNet permite não apenas a consulta a indicadores consolidados, mas também a exploração dos dados brutos que os originaram, a reconstrução de séries históricas para assegurar comparabilidade temporal e a criação de novas métricas definidas pelas áreas técnicas. Essa evolução, conduzida pelo DEMAS/SEIDIGI/MS, reafirma o compromisso com a inovação e a excelência na disponibilização de informações estratégicas para gestores, pesquisadores e a sociedade.

Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE): Configura-se como uma plataforma dinâmica e estratégica para a disseminação de informações em saúde, projetada para qualificar o acompanhamento de intervenções de saúde pública e reduzir as incertezas inerentes ao processo decisório. Reativada em 2023, após um período de descontinuidade, a SAGE retoma seu papel exitoso, ao disponibilizar painéis informativos integrados, baseados em *software* livre, que permitem visualizar e monitorar políticas, programas e ações de forma contextualizada e acessível.

Sua arquitetura facilita a análise de dados em diferentes níveis geográficos – municipal, estadual e federal – e apoia a elaboração de projeções e inferências setoriais. Dessa forma, a SAGE não apenas sistematiza e dissemina informações estratégicas de maneira ágil e transparente, mas também fortalece a confiança na gestão pública, promovendo a transparência ativa e servindo como uma ferramenta essencial para a correção de rumos e o aprimoramento contínuo das ações em saúde.

Portal de Dados Abertos do SUS: A nova plataforma digital reúne e disponibiliza informações públicas de saúde em formato acessível, gratuito e reutilizável, permitindo que qualquer pessoa consulte, análise e use esses dados para diferentes finalidades. Lançado em dezembro de 2025, o novo portal representa um avanço estratégico na forma como a sociedade acessa e reutiliza dados públicos em saúde. Essa iniciativa está alinhada ao

disposto no Decreto nº 8.777/2016, que institui a Política de Dados Abertos no Executivo Federal, fazendo com que o Ministério da Saúde avance na promoção da transparência, da participação social e do estímulo à inovação, por meio da abertura progressiva de bases de dados em formatos abertos, interoperáveis e de acesso livre, permitindo seu reúso pela sociedade, academia e setor produtivo.

Um ecossistema integrado para o futuro da informação em saúde

A atuação complementar do TabNet, da SAGE e do Portal de Dados Abertos do SUS potencializa decisivamente a publicização e a utilidade dos indicadores da Ripsa. Enquanto o TabNet oferece robustez analítica para uma exploração detalhada, a SAGE organiza o conhecimento em painéis visuais para uma gestão ágil, e o Portal de Dados Abertos do SUS garante a abertura e o reúso ampliado dos dados. Juntas, essas plataformas compõem um ecossistema integrado de disseminação que atende a diferentes perfis de usuário – desde a análise técnica especializada até a consulta gerencial e o controle social. Esta evolução representa um avanço substancial na infraestrutura de informação em saúde no Brasil, consolidando a Ripsa como referência nacional e fortalecendo os alicerces para uma gestão pública mais transparente, eficiente e baseada em evidências sólidas.

Avanços na nova edição do livro

A retomada da Ripsa reflete a resiliência do SUS e das instituições, e sua capacidade de continuar a produzir novos e criativos instrumentos de pactuação e consenso. Esta 3ª edição incorpora novos indicadores que respondem aos desafios sanitários contemporâneos do país e se alinham a pactos nacionais e globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Plano Global de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

A matriz de indicadores dialoga com os desafios de monitoramento contemporâneo de novos indicadores, e essa capacidade de revisá-los e adaptá-los é fundamental para que os dados subsidiem efetivamente a gestão em saúde, nos âmbitos local, estadual e federal. A organização da matriz em dimensões temáticas é outra fortaleza metodológica. Essa estrutura segmenta a complexidade dos dados de forma coerente, alinhando-se a boas práticas internacionais de organização de sistemas de informação em saúde, que preconizam arranjos lógicos para facilitar a análise e o uso de informações.

O desenho da matriz privilegia fontes de dados de reconhecida qualidade e robustez metodológica, um pilar para a credibilidade dos indicadores. Nota-se o avanço, nas últimas décadas, na estruturação e ampliação dos sistemas de informação em saúde e dos inquéritos epidemiológicos. O sistema de inquéritos de saúde do Brasil, com sua complexidade e abrangência, é um ativo estratégico para a vigilância, a gestão e a tomada de decisão. Tais inquéritos – como a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil), entre outros – evidenciam complexidade e abrangência, profundidade e representatividade nacional, sendo insubstituíveis para análises de desigualdades sociais, raciais e regionais em saúde. A sustentabilidade dessas fontes é, portanto, vital.

Destaca-se a relevância de a Ripsa incluir importantes métodos, como a padronização das taxas de mortalidade e de morbidade, refletindo uma demanda necessária em um país que modifica aceleradamente seu padrão etário, com rápido aumento da expectativa de vida

e consequente crescimento da população de idosos, a par da redução da fecundidade. As séries temporais dos indicadores demandam estes ajustes metodológicos incorporados na nova matriz de indicadores da Ripsa, apresentando indicadores com taxas brutas e taxas padronizadas. Destaca-se ainda a inclusão dos intervalos de confiança, nos indicadores que utilizam inquéritos amostrais, o que salienta a preocupação com dados qualificados, incorporando-se o erro-padrão da amostragem e a precisão das estimativas. A inclusão de um Identificador de Objeto Digital (Digital Object Identifier – DOI) para cada indicador facilita a rastreabilidade e a citação formal, promovendo a ciência aberta.

Paralelamente, a infraestrutura de disseminação foi significativamente aprimorada. A consagrada base eletrônica dos IDB é agora potencializada por um TabNet modernizado, que oferece capacidade analítica ampliada e visualização dinâmica. A SAGE fornece painéis temáticos para uma tomada de decisão ágil. O Portal de Dados Abertos do SUS consolida o compromisso com a transparência, disponibilizando informações em formatos abertos para reúso e inovação. Juntas, essas ferramentas formam um ecossistema integrado que democratiza o acesso à informação em saúde.

Por fim, todo esse esforço técnico é sustentado por um modelo colaborativo e solidário, que atualmente reúne 45 instituições na definição de métodos, prioridades e pactuações, demonstrando um singular compromisso com a melhoria da informação em saúde.

Assim, esta edição do livro da Ripsa busca contribuir com a gestão do SUS, as boas práticas e o monitoramento da saúde da população brasileira, indicando avanços, lacunas e prioridades.

Espera-se que esse modelo de produção de indicadores e evidências seja inspirador e replicável em todo o território nacional, fortalecendo a governança da informação em saúde, promovendo um ecossistema de aprendizado contínuo e ampliando a transparência e a efetividade das políticas públicas.



CAPÍTULO 2

MATRIZ DE INDICADORES
BÁSICOS DA RPSA

Matriz de indicadores básicos

A construção da matriz de indicadores básicos da Ripsa é pautada nos seguintes critérios: (i) relevância para a compreensão da situação de saúde, suas causas e consequências; (ii) validade para orientar decisões políticas e apoiar o controle social; (iii) identidade com processos de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS); e (iv) disponibilidade de fontes regulares.

Esses critérios se mantêm no processo de revisão e atualização periódicas da matriz, que resulta em alterações, acréscimos e supressões de indicadores. Por esse motivo, a consistência da série histórica disponibilizada demanda atenção constante.

A produção de cada indicador é responsabilidade dos Comitês de Gestão de Indicadores (CGIs), que se organizam com a participação das instituições-membros, as quais se voluntariam, de acordo com sua *expertise*, para discutir e definir as temáticas específicas, a partir de fontes relevantes para a análise da situação de saúde, vinculadas ou não diretamente ao SUS: sistemas nacionais de informação, bases demográficas, pesquisas de base populacional e outras.

De maneira geral, estão disponíveis, para cada indicador, dados desagregados por unidade geográfica (macrorregiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas e, quando possível, capitais das Unidades da Federação – UFs e municípios), idade, sexo e cor ou raça.

Dados sobre cor ou raça e situação de escolaridade, quando disponíveis, são utilizados como eixos de condição social. Há ainda categorias de análise específicas de determinados indicadores, a exemplo da situação urbana ou rural do domicílio.

A matriz orienta a elaboração anual do produto Indicadores e Dados Básicos (IDB), a partir do qual podem ser realizadas análises e elaborados informes sobre a situação de saúde no Brasil e suas tendências.

DEMOGRÁFICOS (DEM)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
DEM.1.01	População residente	Número de pessoas residentes, desagregado por idade e sexo, em um local e na data de 1º de julho do ano de referência.	• Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	• Não se aplica	• Faixa etária • Sexo	• Município
DEM.1.02	Razão de sexo	A razão de sexo mede a proporção entre homens e mulheres em uma população, considerando-se o número de homens para cada grupo de 100 mulheres, na população residente, em um local e ano de referência.	• Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{População residente do sexo masculino, em um local e ano de referência}}{\text{População residente do sexo feminino, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Faixa etária	• Município
DEM.1.03	Taxa de crescimento anual da população	Percentual de variação média anual da população total residente, em um local e período de referência.	• Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\left(\sqrt[n]{\frac{P_{t+n}}{P_t}} - 1 \right) \times 100$ Nota: • Cálculo de utilização direta de base de dados.	• Não se aplica	• Município
DEM.1.04	Proporção de menores de 5 anos de idade na população	Proporção de pessoas com menos de 5 anos de idade na população total residente, em um local e ano de referência.	• Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{População residente com menos de 5 anos de idade, em um local e ano de referência}}{\text{População residente total, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Não se aplica	• Município
DEM.1.05	Proporção de pessoas idosas na população	Proporção de pessoas com 60 anos ou mais de idade, na população total residente, em um local e ano de referência.	• Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{População residente com mais de 60 anos de idade, em um local e ano de referência}}{\text{População residente total, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Sexo	• Município
DEM.1.06	Índice de envelhecimento	O índice de envelhecimento (IE) é uma medida da razão entre as pessoas consideradas idosas, aquelas de 60 anos ou mais de idade, e a população de pessoas menores de 15 anos de idade, em um local e ano de referência.	• Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{População residente com 60 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência}}{\text{População residente com menos de 15 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Sexo	• Município

DEMOGRÁFICOS (DEM)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
DEM.1.07	Razão de dependência	A razão de dependência é a relação entre o segmento etário da população definido como potencialmente inativo (pessoas menores de 15 anos de idade e pessoas idosas de 60 anos ou mais) e o segmento etário potencialmente produtivo (pessoas entre 15 e 59 anos de idade), na população residente, em um local e ano de referência.	- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções; - Estimativos populacionais dos municípios desagregados por sexo e idade.	$\frac{\text{População residente de 0 a 14 anos de idade e de 60 anos ou mais, em um local e ano de referência}}{\text{População residente de 15 a 59 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	Não se aplica	Município
DEM.2.01	Taxas específicas de fecundidade	As taxas específicas de fecundidade (TEFs) correspondem ao número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher, por faixa etária específica do período reprodutivo, na população residente, em um local e ano de referência.	Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: indicadores implícitos.	$\frac{\text{Número de filhos nascidos vivos de mulheres de um grupo etário, em um local e ano de referência}}{\text{Total de mulheres do mesmo grupo etário, em um local e ano de referência}}$ Notas: - A taxa também pode ser apresentada por grupo de mil mulheres em cada faixa etária. - Usualmente, calcula-se a TEF por grupos quinquenais de idade. - O período reprodutivo compreende as idades de 10 a 54 anos.	Faixa etária	Unidade da Federação
DEM.2.02	Taxa de fecundidade total	A taxa de fecundidade total (TFT) é o número médio de filhos nascidos vivos que uma mulher sobrevivente ao final de seu período reprodutivo teria, caso ela experimentasse, ao longo de sua vida, o nível de fecundidade apresentado por todas as coortes de mulheres, em um local e ano de referência.	Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: indicadores implícitos.	$TFT = 5x \sum_{x=10-14}^{50-54} TEF_x$ Nota: Na fórmula, TEF_x é a taxa específica de fecundidade do grupo etário quinquenal x.	Não se aplica	Unidade da Federação
DEM.2.03	Taxa bruta de natalidade	A taxa bruta de natalidade (TBN) é o número de nascidos vivos, por mil habitantes, na população residente, em um local e ano de referência.	Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções.	$\frac{\text{Número total de nascidos vivos de residentes, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e no meio do ano de referência}} \times 1.000$	Não se aplica	Unidade da Federação

DEMOGRÁFICOS (DEM)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
DEM.3.01	Taxas específicas de mortalidade por idade e sexo	Número de óbitos ocorridos por idade e sexo, em relação à população média na mesma idade, sexo e ano de referência. A população média, usualmente estimada no meio do ano de análise, representa o número total de anos-pessoa vividos em exposição ao risco de morte, segundo idade e sexo, no ano de referência.	Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: tábuas de mortalidade.	$\frac{\text{Número de óbitos nas idades de } x \text{ a } x + n \text{ do sexo } s \text{ no ano } t \text{ de referência} \times \text{fator de correção}}{\text{População no meio do ano } t \text{ de referência nas idades de } x \text{ a } x + n \text{ do sexo } s}$ Nota: Na fórmula, n determina o tamanho do intervalo etário de análise, x determina a idade inferior do intervalo etário, e s o sexo.	- Faixa etária - Sexo	Unidade da Federação
DEM.3.02	Taxa bruta de mortalidade	A taxa bruta de mortalidade (TBM) é calculada pelo número total de óbitos, por mil habitantes, na população residente, em um local e ano de referência.	Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções.	$\frac{\text{Número total de óbitos de residentes, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e no meio do ano de referência}} \times 1000$	Sexo	Unidade da Federação
DEM.3.03	Taxa de mortalidade padronizada por idade	Número total de óbitos esperado por mil habitantes, em um local e ano de referência, caso a população em estudo tenha a mesma estrutura etária de uma população-padrão.	Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções.	$\frac{\sum_{x=0}^w \text{TEM}_x^s \times \frac{N_x}{n_x}}{\sum_{x=0}^w N_x}$ Nota: Na fórmula, $n^s \text{TEM}_x^s$ representa a taxa específica de mortalidade da população em análise, por sexo s, no grupo etário x; e n^N_x representa a população escolhida como padrão, no grupo etário x, onde n representa o número de anos do intervalo etário, x é a idade exata do limite inferior do intervalo etário e w a idade máxima de vida na população.	Sexo	Unidade da Federação
DEM.3.04	Esperança de vida ao nascer	A esperança de vida ao nascer, também conhecida como expectativa de vida, é o número médio de anos que se espera que um recém-nascido viva, mantidas constantes as taxas de mortalidade observadas na população residente, em um local e ano de referência.	Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: tábuas de mortalidade.	Não se aplica	Sexo	Unidade da Federação

DEMOGRÁFICOS (DEM)						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
DEM.3.05	Esperança de vida aos 60 anos de idade	Número médio de anos de vida esperados para uma pessoa ao completar 60 anos de idade, mantidas constantes as taxas de mortalidade observadas na população residente, em um local e ano de referência.	Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: tábuas de mortalidade.	Não se aplica	Sexo	Unidade da Federação
DEM.4.01	Cobertura do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)	Razão entre o número de notificações de nascidos vivos no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) em relação ao número estimado de nascidos vivos, em um local e ano de referência.	- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos através do método de captura e recaptura. - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).	$\frac{\text{Número de nascidos vivos informado no Sinasc, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de nascidos vivos, em um local e ano de referência}} \times 100$	Não se aplica	Unidade da Federação
DEM.4.02	Cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)	Razão entre o número de notificações de óbitos no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), em relação ao número estimado de óbitos, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos através do método de captura e recaptura.	$\frac{\text{Número de notificações de óbitos no SIM, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de óbitos, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Faixa etária Nota: - Para os municípios, não é possível a desagregação por idade. - Sexo	Unidade da Federação

Nota:

- O conteúdo completo de cada indicador está disponível nas fichas de qualificação.

SOCIOECONÔMICO (SOC)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
SOC.1.01	Proporção de analfabetismo na população	Proporção da população com 15 anos ou mais de idade em condição de analfabetismo.	• Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$\frac{\text{Número de analfabetos com 15 anos de idade ou mais, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População com 15 anos de idade ou mais, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Faixa etária • Renda domiciliar per capita • Sexo • Situação do domicílio • Tipo de município	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
SOC.1.02	Proporção da população sem educação básica	Proporção da população com 25 anos ou mais de idade sem educação básica.	• Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$\frac{\text{População sem educação básica, com 25 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População com 25 anos ou mais, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Faixa etária • Renda domiciliar per capita • Sexo • Situação do domicílio • Tipo de município	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
SOC.2.01	Proporção de desocupação na população	Proporção de pessoas desocupadas na força de trabalho. A população na força de trabalho é composta pelas pessoas em idade de trabalhar, ou seja, com 14 anos ou mais de idade, e que estavam ocupadas ou desocupadas na semana de referência da entrevista realizada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	• Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$\frac{\text{População desocupada com 14 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População na força de trabalho com 14 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Faixa etária • Renda domiciliar per capita • Sexo • Situação do domicílio • Tipo de município	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
SOC.2.02	Proporção da população com força de trabalho subutilizada	Proporção de pessoas cuja força de trabalho estava subutilizada na força de trabalho ampliada. A subutilização considera as situações em que a pessoa pode aumentar sua jornada de trabalho ou ser incorporada à população ocupada, uma vez que está disponível e/ou buscando trabalho.	• Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$\frac{\text{População com força de trabalho subutilizada com 14 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População na força de trabalho ampliada com 14 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Faixa etária • Renda domiciliar per capita • Sexo • Situação do domicílio • Tipo de município	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

SOCIOECONÔMICO (SOC)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
SOC.2.03	Proporção da população ocupada sem contribuição para a previdência social	Proporção de pessoas ocupadas na força de trabalho que não contribuíam para a previdência social. As pessoas ocupadas podem ser classificadas como contribuintes ou não de instituto de previdência social oficial.	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$\frac{\text{População ocupada com 14 anos ou mais de idade que não contribuiu para a previdência, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População ocupada com 14 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Situação do domicílio - Tipo de município	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
SOC.2.04	Proporção de jovens que não estudam e não trabalham	Proporção de pessoas de 15 a 29 anos de idade que não estudam e não trabalham.	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$\frac{\text{População jovem de 15 a 29 anos de idade que não estudava e não trabalhava, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População jovem de 15 a 29 anos de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Situação do domicílio - Tipo de município	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
SOC.2.05	Proporção da população de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil	Proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil.	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$\frac{\text{População de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População de 5 a 17 anos de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Situação do domicílio - Tipo de município	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
SOC.3.01	Rendimento domiciliar <i>per capita</i> a preços correntes	O indicador corresponde à média da renda domiciliar <i>per capita</i> na população.	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$\frac{\text{Soma da renda domiciliar per capita de todas as pessoas, exceto os pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População, exceto pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}$	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Situação do domicílio - Tipo de município	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

SOCIOECONÔMICO (SOC)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
SOC.3.02	Proporção da população abaixo da linha de pobreza	A pobreza é caracterizada quando a renda domiciliar <i>per capita</i> é inferior à linha de pobreza.	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	População com renda domiciliar <i>per capita</i> inferior à linha de pobreza, exceto os pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência $\frac{\text{População, exceto pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População}} \times 100$ Notas: Foram consideradas as três linhas internacionais de pobreza definidas pelo Banco Mundial: • A – US\$ 3,00 dólares <i>per capita</i> em dólares internacionais de 2021 (linha para países extremamente pobres); • B – US\$ 4,20 dólares <i>per capita</i> em dólares internacionais de 2021 (linha para países pobres); e • C – US\$ 8,30 dólares <i>per capita</i> em dólares internacionais de 2021 (linha para países de renda média-alta).	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Situação do domicílio - Tipo de município	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
SOC.3.03	Coefficiente de Gini da distribuição da renda domiciliar <i>per capita</i>	Coefficiente de Gini da distribuição da renda domiciliar <i>per capita</i> . O coeficiente mede o quanto uma distribuição difere de um padrão perfeitamente igualitário, sendo definido matematicamente como a razão entre a área entre a linha hipotética de igualdade perfeita e a curva de Lorenz, dividida pela área total sob a linha hipotética de igualdade perfeita.	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$1 - \sum_{i=2}^n (x_i - x_{i-1}) (y_i + y_{i-1})$ Nota: • Na fórmula, x é uma variável que armazena o <i>ranking</i> relativo de cada indivíduo na população distribuída em ordem ascendente da renda, em determinado local e ano de referência; y é uma variável que armazena a renda relativa acumulada até um indivíduo na população distribuída em ordem ascendente da renda, em um local e semana de referência.	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Situação do domicílio - Tipo de município	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
SOC.3.04	Razão entre a renda total dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres	Razão entre a renda total dos 10% mais ricos da população e a renda total dos 40% mais pobres, também conhecida como Razão de Palma. Os 10% mais ricos e os 40% mais pobres são definidos a partir da distribuição da renda domiciliar <i>per capita</i> , calculada para cada domicílio como a soma dos rendimentos mensais individuais dos moradores dividida pelo número de moradores, de acordo com as informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	Soma da renda domiciliar <i>per capita</i> de todas as pessoas, exceto os pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, em um local e ano de referência $\frac{\text{Soma da renda domiciliar per capita de todas as pessoas, exceto os pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, que pertenciam aos 10% mais ricos, em um local e ano de referência}}{\text{Soma da renda domiciliar per capita de todas as pessoas, exceto os pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, que pertenciam aos 40% mais pobres, em um local e ano de referência}}$	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Situação do domicílio - Tipo de município	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

SOCIOECONÔMICO (SOC)						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
SOC.3.05	Produto interno bruto <i>per capita</i>	O Produto Interno Bruto (PIB) <i>per capita</i> é o valor total anual, em moeda corrente (R\$) e a preços de mercado, dos bens e serviços finais produzidos em um local, dividido por sua população total no ano de referência.	- Sistema de Contas Nacionais (SCN). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções.	$\frac{\text{Produto interno bruto, em um local e ano de referência}}{\text{População total, em um local e ano de referência}}$	Não se aplica	Unidade da Federação
SOC.4.01	Proporção da população urbana sem acesso seguro à água	Proporção de pessoas em áreas urbanas residentes em domicílios sem acesso seguro à sua principal fonte de abastecimento de água.	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$\frac{\text{População sem acesso seguro à água em domicílios urbanos, em um local e ano de referência}}{\text{População em domicílios urbanos, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Tipo de município	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
SOC.4.02	Proporção da população urbana sem instalações sanitárias adequadas	Proporção de pessoas em domicílios urbanos sem banheiro de uso exclusivo dos moradores que tenha coleta de esgoto por rede geral ou pluvial.	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$\frac{\text{População sem banheiro de uso exclusivo dos moradores com escoadouro de esgoto por rede de captação, em domicílios urbanos, em um local e ano de referência}}{\text{População em domicílios urbanos, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Tipo de município	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
SOC.4.03	Proporção da população sem coleta direta ou indireta de lixo	Proporção de pessoas que vivem em domicílios sem coleta direta ou indireta de lixo.	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$\frac{\text{População sem coleta de lixo direta ou indireta, em um local e ano de referência}}{\text{População em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Situação do domicílio - Tipo de município	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
SOC.5.01	Proporção da população em situação de insegurança alimentar moderada ou grave	Proporção de pessoas em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. O grau de insegurança alimentar dos domicílios é medido pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). A EBIA é uma escala psicométrica que representa a percepção sobre o acesso e a regularidade da disponibilidade de alimentos para os moradores do domicílio.	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).	$\frac{\text{População com insegurança alimentar moderada ou grave, em um local e ano de referência}}{\text{População em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Situação do domicílio - Tipo de município	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

Nota:

- O conteúdo completo de cada indicador está disponível nas fichas de qualificação.

MORTALIDADE (MRT)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
MRT.1.01	Taxa de mortalidade infantil	Número de óbitos de menores de 1 ano de idade, por mil nascidos vivos, de um local e ano de referência. É expressa por mil nascidos vivos.	- De 2000 a 2014, os nascidos vivos estimados e óbitos estimados que constam nos indicadores implícitos na projeção da população (IBGE). - De 2015 em diante, os nascidos vivos estimados e óbitos infantis estimados que constam das Estimativas de sub-registro de nascimentos e óbitos (IBGE), construídas a partir de insumos derivados do pareamento entre os dados do SIM e do Sinasc e dados da pesquisa do Registro Civil (IBGE), e aplicação do método de captura e recaptura. - Para operacionalizar os cálculos com base nos dados diretos dos sistemas SIM e Sinasc, dispensando pesquisa nas fontes mencionadas acima, o Ministério da Saúde publica, anualmente, fatores de correção atualizados para cada UF, para aplicar ao resultado dos cálculos com dados diretos para todo o período a partir de 2000, de acordo com a fórmula e o método de cálculo descritos abaixo. Estes fatores de correção são divulgados nas páginas do Ministério da Saúde e nos Indicadores e Dados Básicos (IDB) da Ripsa.	1. Para uso com dados diretos do SIM e Sinasc $\frac{\text{Número de óbitos de residentes menores de 1 ano de idade obtidos diretamente do SIM, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de residentes obtidos diretamente do Sinasc, em um local e ano de referência}} \times 1.000 \times F.C.TMI^*$ Nota: *F.C.TMI = fatores de correção para a taxa de mortalidade infantil divulgados pelo Ministério da Saúde. 2. Para uso com dados estimados $\frac{\text{Número de óbitos estimados de residentes menores de 1 ano de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos estimados de residentes, em um local e ano de referência}} \times 1.000$	Não se aplica	Unidade da Federação

MORTALIDADE (MRT)						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
MRT1.02	Taxa de mortalidade neonatal precoce	Número de óbitos de crianças com menos de 7 dias de vida, por mil nascidos vivos, de mães residentes em um local e ano de referência. É expressa por mil nascidos vivos.	- De 2000 a 2014, os nascidos vivos estimados e óbitos, infantes estimados que constam nos indicadores implícitos na projeção da população. O número de óbitos neonatais precoces estimados é calculado a partir da proporção de óbitos neonatais precoces obtida do total de óbitos infantes observada no SIM para o recorte territorial e o ano definidos. - De 2015 em diante, os nascidos vivos estimados e óbitos infantes estimados que constam nas estimativas de sub-registro de nascimentos e óbitos, construídas a partir de insumos derivados do pareamento entre os dados do SIM e do Sinasc e dados da pesquisa do Registro Civil (IBGE), e aplicação do método de captura e recaptura. O número de óbitos neonatais precoces estimados é calculado a partir da proporção de óbitos neonatais precoces obtida do total de óbitos infantes observada no SIM para o recorte territorial e o ano definidos. - Para operacionalizar os cálculos com base nos dados diretos dos sistemas SIM e Sinasc, dispensando pesquisa nas fontes mencionadas acima, o Ministério da Saúde publica, anualmente, fatores de correção atualizados para cada UF, para aplicar ao resultado dos cálculos com dados diretos para todo o período a partir de 2000, de acordo com a fórmula e o método de cálculo descritos abaixo. Estes fatores de correção são divulgados nas páginas do Ministério da Saúde e nos Indicadores e Dados Básicos (IDB) da Ripsa.	1. Para uso com dados diretos do SIM e Sinasc $\frac{\text{Número de óbitos de residentes com 0 a 6 dias de idade, obtido diretamente do Sinasc, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de residentes, obtido diretamente do Sinasc, em um local e ano de referência}} \times 1.000 \times \text{F.C.TMNP}^*$ Nota: * F.C.TMNP = fatores de correção para taxas de mortalidade neonatal precoce divulgados pelo Ministério da Saúde. 2. Para uso com dados estimados $\frac{\text{Número de óbitos estimados de residentes com 0 a 6 dias de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de nascidos vivos, de residentes, em um local e ano de referência}} \times 1.000$	Não se aplica	Unidade da Federação

MORTALIDADE (MRT)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
MRT.1.03	Taxa de mortalidade neonatal tardia	Número de óbitos de crianças de 7 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos de mães residentes, em um local e ano de referência. É expressa por mil nascidos vivos.	- De 2000 a 2014, as estimativas de nascidos vivos e de óbitos infantis que constam nos indicadores implícitos na projeção da população. O número de óbitos neonatais tardios estimados é calculado a partir da proporção de óbitos neonatais tardios obtida do total de óbitos infantis observado no SIM para o recorte territorial e o ano definidos. - De 2015 em diante, os nascidos vivos estimados e óbitos infantis estimados que constam nas Estimativas de sub-registro de nascimentos e óbitos, construídas a partir de insumos derivados do pareamento entre os dados do SIM e do Sinasc e dados da pesquisa do Registro Civil (IBGE), e aplicação do método de captura e recaptura. O número de óbitos neonatais tardios estimados é calculado a partir da proporção de óbitos neonatais tardios obtida do total de óbitos infantis observado no SIM para o recorte territorial e o ano definidos. - Para operacionalizar os cálculos com base nos dados diretos dos sistemas SIM e Sinasc, dispensando pesquisa nas fontes mencionadas acima, o Ministério da Saúde publica, anualmente, fatores de correção atualizados para cada UF, para aplicação ao resultado dos cálculos com dados diretos para todo o período a partir de 2000, de acordo com a fórmula e o método de cálculo descritos abaixo. Estes fatores de correção são divulgados nas páginas do Ministério da Saúde e nos Indicadores e Dados Básicos (IDB) da Ripsa.	1. Para uso com dados diretos do SIM e Sinasc $\frac{\text{Número de óbitos de residentes de 7 a 27 dias de idade, obtido diretamente do SIM, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de residentes, obtido diretamente do Sinasc, em um local e ano de referência}} \times 1000 \times F.C.TMNT^*$ Nota: * F.C.TMNT = fatores de correção para taxa de mortalidade neonatal tardia divulgados pelo Ministério da Saúde. 2. Para uso com dados estimados $\frac{\text{Número de óbitos estimados, de residentes de 7 a 27 dias de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de nascidos vivos, de residentes, em um local e ano de referência}} \times 1000$	Não se aplica	Unidade da Federação

MORTALIDADE (MRT)						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
MRT.1.04	Taxa de mortalidade pós-neonatal	Número de óbitos de 28 a 364 dias de vida completos, por mil nascidos vivos de mães residentes, em um local e ano de referência. É expressa por mil nascidos vivos.	- De 2000 a 2014, as estimativas de nascidos vivos e de óbitos infantis que constam nos indicadores implícitos na projeção da população. O número de óbitos pós-neonatais estimados é calculado a partir da proporção de óbitos pós-neonatais obtida do total de óbitos infantis observado no SIM para o recorte territorial e o ano definidos. - De 2015 em diante, os nascidos vivos estimados e óbitos infantis estimados que constam nas Estimativas de sub-registro de nascimentos e óbitos, construídas a partir de insumos derivados do pareamento entre os dados do SIM e do Sinasc e dados da pesquisa do Registro Civil (IBCE), e aplicação do método de captura e recaptura. O número de óbitos pós-neonatais estimados é calculado a partir da proporção de óbitos pós-neonatais obtida do total de óbitos infantis observado no SIM para o recorte territorial e o ano definidos. - Para operacionalizar os cálculos com base nos dados diretos dos sistemas SIM e Sinasc, dispensando pesquisa nas fontes mencionadas acima, o Ministério da Saúde publica, anualmente, fatores de correção atualizados para cada UF, para aplicação ao resultado dos cálculos com dados diretos para todo o período a partir de 2000, de acordo com a fórmula e o método de cálculo descritos abaixo. Estes fatores de correção são divulgados nas páginas do Ministério da Saúde e nos Indicadores e Dados Básicos (IDB) da Ripsa.	1. Para uso com dados diretos do SIM e Sinasc $\frac{\text{Número de óbitos de residentes com 28 a 364 dias de idade, obtido diretamente do SIM, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de residentes, obtido diretamente do Sinasc, em um local e ano de referência}} \times 1.000 \times \text{F.C.TMPN}^*$ Nota: * F.C.TMPN = fatores de correção para taxa de mortalidade pós-neonatal divulgados pelo Ministério da Saúde. 2. Para uso com dados estimados $\frac{\text{Número estimado de óbitos, de residentes com 28 a 364 dias de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de nascidos vivos, de residentes, em um local e ano de referência}} \times 1.000$	- Não se aplica - Unidade da Federação	

MORTALIDADE (MRT)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
MRT.1.05	Taxa de mortalidade em menores de 5 anos	Número de óbitos de menores de 5 anos de idade, por mil nascidos vivos, de mães residentes em um local e ano de referência. É expressa por mil nascidos vivos.	- De 2000 a 2014, os nascidos vivos constam nos indicadores implícitos na projeção da população. - De 2000 a 2014, os óbitos foram obtidos reconstruindo-se as tábuas de mortalidade obtidas da projeção da população, edição 2024, publicadas pelo IBGE. - De 2015 em diante, os nascidos vivos e óbitos em menores de 5 anos constam das Estimativas de sub-registro de nascimentos e óbitos (IBGE), construídas a partir de insumos derivados do pareamento entre os dados do SIM e do Sinasc e dados da pesquisa do Registro Civil (IBGE), e aplicação do método de captura e recaptura. - Para operacionalizar os cálculos com base nos dados diretos dos sistemas SIM e Sinasc, dispensando pesquisa nas fontes mencionadas acima, o Ministério da Saúde publica, anualmente, fatores de correção atualizados para cada UF, para aplicar ao resultado dos cálculos com dados diretos para todo o período a partir de 2000, conforme fórmula e método de cálculo descritos abaixo. Estes fatores de correção são divulgados nas páginas do Ministério da Saúde e nos Indicadores e Dados Básicos (IDB) da Ripsa.	1. Para uso com dados diretos do SIM e Sinasc $\frac{\text{Número de óbitos de residentes com 0 a 4 anos de idade obtido diretamente do SIM, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de residentes obtido diretamente do Sinasc, em um local e ano de referência}} \times 1.000 \times F.C.TM < 5^*$ Nota: * F.C.TM < 5 = fatores de correção para taxa de mortalidade de menores de 5 anos divulgados pelo Ministério da Saúde. 2. Para uso com dados estimados $\frac{\text{Número estimado de óbitos de residentes com 0 a 4 anos de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de nascidos vivos de residentes, em um local e ano de referência}} \times 1000$	Não se aplica	Unidade da Federação
MRT.2.01	Razão de mortalidade materna	Razão entre o número de óbitos maternos e o de nascidos vivos, de mães residentes em um local e ano de referência. É expressa por 100 mil nascidos vivos.	- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).	$\frac{\text{Número de óbitos maternos entre mães residentes em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de mães residentes em um local e ano de referência}} \times 100.000$	Não se aplica	Unidade da Federação

MORTALIDADE (MRT)					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS
MRT.2.02	Mortalidade materna segundo grupos de causas	Distribuição proporcional de óbitos maternos, por grupo de causas obstétricas diretas, indiretas e inespecíficas, em um local e ano de referência. É expressa em percentual.	Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).	$\frac{\text{Número de óbitos maternos de residentes por grupo de causa, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de óbitos maternos de residentes, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Município
MRT.3.01	Mortalidade proporcional por causas	Distribuição proporcional de óbitos por grupos de causas definidas, na população residente em um local e ano de referência. É expressa em percentual.	Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).	$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados de aids segundo categoria de exposição hierarquizada, em um local provável de infecção e ano de referência}}{\text{Número total de óbitos de residentes, com causas definidas, no mesmo local e período de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Grupos de causas - Unidade da Federação
MRT.3.02	Proporção de óbitos por causas mal definidas	Proporção de óbitos por causas mal definidas na população residente em um local e ano de referência. É expressa em percentual.	Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).	$\frac{\text{Número de óbitos por causas mal definidas de residentes, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de óbitos de residentes, no mesmo local e ano de referência}} \times 100$	- Faixa etária - Sexo - Município
MRT.4.01	Taxa de mortalidade por agressão *Este indicador possui taxa padronizada	Taxa de mortalidade específica por agressão na população, em um local e ano de referência. A taxa é calculada por 100 mil habitantes.	- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de óbitos por agressão, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	- Faixa etária - Sexo - Grupos de causas - Município
MRT.4.02	Taxa de mortalidade por lesão autoprovocada *Este indicador possui taxa padronizada	Taxa de mortalidade específica por lesão autoprovocada, na população de 5 anos e mais de idade, residente em um local e ano de referência. A taxa é calculada por 100 mil habitantes desta faixa etária.	- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de óbitos por lesão autoprovocada, de pessoas com 5 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, na mesma faixa etária, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	- Faixa etária - Sexo - Grupos de causas - Município

MORTALIDADE (MRT)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
MRT.4.03	Taxa de mortalidade por lesão de trânsito *Este indicador possui taxa padronizada	Taxa de mortalidade específica por lesão de trânsito na população em um local e ano de referência. A taxa é calculada por 100 mil habitantes.	• Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). • Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de óbitos por lesão de trânsito, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	• Faixa etária • Sexo • Grupos de causas	• Município
MRT.4.04	Taxa de mortalidade por causas acidentais *Este indicador possui taxa padronizada	Taxa de mortalidade específica por causas acidentais na população em um local e ano de referência. A taxa é calculada por 100 mil habitantes.	• Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). • Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de óbitos por causas acidentais, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	• Faixa etária • Sexo • Grupos de causas	• Município
MRT.5.01	Taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis *Este indicador possui taxa padronizada	Taxa de mortalidade específica por doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) na faixa etária de 30 a 69 anos e por um grupo de causas de óbitos, que compreende as doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes mellitus e doenças respiratórias crônicas, em um local e ano de referência, por 100 mil habitantes da mesma faixa etária.	• Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). • Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de óbitos prematuros (30 a 69 anos de idade) por doenças crônicas não transmissíveis, em um local e ano de referência}}{\text{População residente de 30 a 69 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	• Faixa etária • Sexo • Grupos de causas	• Município
MRT.5.02	Taxa de mortalidade por neoplasias malignas *Este indicador possui taxa padronizada	Taxa de mortalidade específica por neoplasias malignas, em um local e ano de referência. A taxa é expressa por 100 mil habitantes.	• Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). • Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de óbitos por neoplasia, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	• Faixa etária • Sexo • Grupos de causas	• Município

MORTALIDADE (MRT)						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
MRT.5.03	Taxa de mortalidade por diabetes <i>mellitus</i> *Este indicador possui taxa padronizada	Taxa de mortalidade específica por diabetes <i>mellitus</i> , em um local e ano de referência. Exclui o diabetes gestacional. Este indicador é calculado por 100 mil habitantes.	- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de óbitos por diabetes mellitus, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	- Faixa etária - Sexo	Município
MRT.5.04	Taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares *Este indicador possui taxa padronizada	Taxa de mortalidade específica por doenças cardiovasculares, em um local e ano de referência. A taxa é expressa por 100 mil habitantes.	- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de óbitos por doenças cardiovasculares, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	- Faixa etária - Sexo - Grupos de causas	Município
MRT.5.05	Taxa de mortalidade por doenças respiratórias crônicas *Este indicador possui taxa padronizada	Taxa de mortalidade específica por doenças respiratórias crônicas, em um local e ano de referência. Taxa calculada por 100 mil habitantes.	- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de óbitos por doenças respiratórias crônicas, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	- Faixa etária - Sexo - Grupo de causas	Município
MRT.5.06	Probabilidade de morte prematura por doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes <i>mellitus</i> e doenças respiratórias crônicas	Probabilidade de morte, entre as idades de 30 a 69 anos, por qualquer doença cardiovascular, neoplasia maligna, diabetes <i>mellitus</i> ou doença respiratória crônica, em um local e ano de referência. O indicador é calculado como percentual.	- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$1 - \prod \text{probabilidades específicas por faixa de idade}$ Notas: - Onde $\prod$ é o produto das probabilidades específicas por faixa de idade. - São considerados os óbitos classificados com os códigos da CID-102: I00-I99, C00-C97, E10-E14 e J30-J98.	Sexo	Unidade da Federação

MORTALIDADE (MRT)						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
MRT.6.01	Taxa de mortalidade específica por doenças infecciosas e parasitárias *Este indicador possui taxa padronizada	Número de óbitos por doenças infecciosas e parasitárias, por 100 mil habitantes, na população residente em um local e ano de referência.	• Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). • Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de óbitos por doenças infecciosas e parasitárias de residentes em um local e ano de referência}}{\text{População residente em um local e ano de referência}} \times 100.000$	• Faixa etária • Sexo • Grupos de doenças (CID-10)	• Município

MORBIDADE (MRB)					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS
MRB.101	Incidência de sarampo	Número de casos incidentes confirmados de sarampo, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de sarampo, em um local e ano de referência.	- Faixa etária - Sexo - Situação vacinal - Tipo do caso
MRB.102	Incidência de rubéola	Número de casos incidentes confirmados de rubéola, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de rubéola, em um local e ano de referência.	- Faixa etária - Sexo - Situação vacinal - Tipo do caso
MRB.103	Incidência de síndrome da rubéola congênita	Número de casos incidentes confirmados clinicamente, laboratorialmente ou por vínculo epidemiológico de síndrome da rubéola congênita (SRC), em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\sum x$ Notas: - Na fórmula, $\sum x$ significa a soma do número de casos da SRC, em um local e ano de referência. - São incluídos casos confirmados clinicamente, laboratorialmente ou por vínculo epidemiológico, segundo o ano de detecção dos primeiros sintomas.	Sexo
MRB.104	Incidência de difteria	Número de casos incidentes confirmados de difteria, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de difteria, em um local e ano de referência.	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Evolução
MRB.105	Incidência de coqueluche	Número de casos incidentes confirmados de coqueluche, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de coqueluche, em um local e ano de referência.	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Evolução
MRB.106	Incidência de tétano neonatal	Número de casos incidentes confirmados de tétano neonatal (até 28 dias após o nascimento), em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de casos incidentes confirmados de tétano neonatal, em um local e ano de referência.	- Cor ou raça - Sexo

MORBIDADE (MRB)					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS
					GRANULARIDADE
MRB.1.07	Incidência de tétano acidental	Número de casos incidentes de tétano acidental, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes de tétano acidental, em um local e ano de referência.	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo
MRB.1.08	Incidência de febre amarela	Número de casos incidentes confirmados de febre amarela na população provável de infecção, residente em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de febre amarela em residentes, em determinado ano.	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo
MRB.1.09	Incidência de raiva humana	Número de casos incidentes confirmados de raiva humana, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes de raiva humana, em um local e ano de referência.	- Cor ou raça - Faixa etária - Espécie do animal agressor - Situação do domicílio - Situação vacinal do animal agressor
MRB.1.10	Incidência de cólera	Número de casos incidentes confirmados de cólera, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes de cólera, em um local e ano de referência.	- Faixa etária - Tipo do caso
MRB.1.11	Incidência de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika	Número de casos incidentes confirmados de síndrome congênita associada a infecção pelo vírus Zika (SCZ), em um local e ano de referência.	Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP-Microcefalia).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de casos incidentes confirmados de SCZ, em um local e ano de referência.	Sexo
MRB.1.12	Incidência de Zika em gestante	Número de casos confirmados de Zika em gestante, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de casos confirmados de Zika em gestante residente em um local e ano de referência.	- Cor ou raça - Trimestre gestacional no momento da infecção - Semana epidemiológica

MORBIDADE (MRB)					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS
					GRANULARIDADE
MRB.1.13	Incidência de doença meningocócica	Número de casos incidentes confirmados de doença meningocócica, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de doença meningocócica, em um local e ano de referência.	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Forma clínica
MRB.1.14	Incidência de meningites não meningocócica	Número de casos incidentes confirmados de meningites bacterianas (exceto a meningite meningocócica) e outras meningites causadas por vírus, fungos e outros agentes, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de meningite não meningocócica, em um local e ano de referência.	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Etiologia
MRB.1.15	Incidência de leptospirose	Número de casos incidentes confirmados de leptospirose, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de leptospirose, em um local e ano de referência.	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Situação do domicílio - Ambiente de infecção - Área provável de infecção
MRB.1.16	Incidência de febre maculosa	Número de casos incidentes confirmados de febre maculosa, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de febre maculosa, em um local e ano de referência.	- Faixa etária - Sexo - Ambiente de infecção
MRB.1.17	Incidência de esquistossomose mansoni não grave	Número de casos incidentes confirmados não graves de esquistossomose, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes não graves de esquistossomose, em um local e ano de referência.	- Faixa etária - Sexo
MRB.1.18	Incidência de doença de Chagas aguda	Número de casos incidentes confirmados de doença de Chagas aguda, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Intelligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIIE).	$\sum x$ Nota: Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de doença de Chagas aguda, em um local e ano de referência.	- Faixa etária - Sexo

MORBIDADE (MRB)					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS
MRB.2.01	Taxa de incidência de aids	Número de casos incidentes confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (aids), diagnosticados na população residente em um local e ano de referência.	• Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). • Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). • Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel). • Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom). Nota: • Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados de aids, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	• Faixa etária • Sexo
MRB.2.02	Taxa de incidência de sífilis congênita	Número de casos incidentes confirmados de sífilis congênita em menores de 1 ano, diagnosticados no ano, sobre o número de nascidos vivos de mães residentes em um local e ano de referência.	• Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). • Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Nota: • Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados de sífilis congênita em menores de 1 ano, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos, em um local e ano de referência}} \times 1.000$	• Faixa etária
MRB.2.03	Taxa de incidência de hepatite B	Número de casos incidentes diagnosticados de infecção pelo vírus de hepatite B, em um local e ano de referência.	• Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). • Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. Nota: • Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\text{Número de casos incidentes de infecção pelo vírus da hepatite B, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de residentes, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	• Faixa etária • Sexo

MORBIDADE (MRB)						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
MRB2.04	Taxa de incidência de hepatite C	Número de casos incidentes diagnosticados de infecção pelo vírus da hepatite C, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. Nota: - Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	Número de casos incidentes de infecção pelo vírus da hepatite C, em um local e ano de referência X 100.000 Número total de residentes, em um local e ano de referência	- Faixa etária - Sexo	Município
MRB2.05	Taxa de incidência de tuberculose	Número de casos incidentes confirmados de tuberculose (todas as formas), em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. Nota: - Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	Número de casos incidentes confirmados de tuberculose, em um local e ano de referência X 100.000 Número total residente, em um local e ano de referência	- Faixa etária - Sexo	Município
MRB2.06	Taxa de incidência de hanseníase	Número de casos incidentes de hanseníase, em relação à população residente em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. Nota: - Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	Número de casos incidentes de hanseníase, em um local e ano de referência X 100.000 Número total de residentes, em um local e ano de referência	- Sexo - Grau de incapacidade física no momento do diagnóstico	Município

MORBIDADE (MRB)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
MRB.2.07	Taxa de incidência de hanseníase na população menor de 15 anos	Número de casos incidentes de hanseníase em menores de 15 anos, em relação à população residente menor de 15 anos em um local e ano de referência.	• Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). • Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. Nota: • Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\text{Número de casos incidentes de hanseníase em menores de 15 anos de idade, em um local e ano de referência}}{\text{População residente de menores de 15 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	• Sexo • Grau de incapacidade física no momento do diagnóstico	• Município
MRB.2.08	Taxa de incidência de leishmaniose tegumentar	Número de casos incidentes confirmados de leishmaniose tegumentar, por local provável de infecção, na população residente em um local e ano de referência.	• Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). • Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. Nota: • Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados de leishmaniose tegumentar, em um local e ano de referência}}{\text{População residente em um local e no ano de referência}} \times 100.000$	• Faixa etária • Sexo	• Município
MRB.2.09	Taxa de incidência de leishmaniose visceral	Número de casos incidentes confirmados de leishmaniose visceral, por local provável de infecção, na população residente em um local e ano de referência.	• Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). • Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. • Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. Nota: • Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados de leishmaniose visceral, em um local e ano de referência}}{\text{População residente em um local e no ano de referência}} \times 100.000$	• Faixa etária • Sexo	• Município

MORBIDADE (MRB)					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS
MRB.2.10	Taxa de incidência de toxoplasmose adquirida durante a gestação	Número de casos incidentes de toxoplasmose adquirida durante a gestação, em gestantes residentes em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\text{Número de casos incidentes de toxoplasmose adquirida durante a gestação, em um local e ano de referência}}{\text{Número de gestantes na população residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$	- Faixa etária - Município
MRB.2.11	Taxa de incidência de toxoplasmose congênita	Número de casos incidentes de toxoplasmose congênita, em relação ao número de nascidos vivos de gestantes residentes em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Nota: - Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\text{Número de casos incidentes de toxoplasmose congênita em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de mães residentes em um local e ano de referência}} \times 10.000$	- Faixa etária - Município
MRB.2.12	Taxa de incidência parasitária anual de malária	Número de exames positivos de malária por população, no local provável de infecção e ano de diagnóstico de referência.	- Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica – Malária (Sivep-Malária). - Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. Nota: - Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\sum x}{y} \times 1.000$ Nota: Na fórmula, Σ significa a soma de x número de exames positivos de malária, em um local provável de infecção e ano de diagnóstico de referência – exceto as lâminas de verificação de cura (LVCs), por estarem relacionadas a recidivas (recrudescências e recaídas) –; e y significa a população total residente estimada para o mesmo local e ano de referência.	- Sexo - Resultado por espécie parasitária - Município

MORBIDADE (MRB)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
MRB.2.13	Taxa de incidência de dengue	Número de casos prováveis de dengue, em relação à população residente em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\sum x}{\sum y} \times 100.000$ Nota: Na fórmula, x é o número de casos prováveis de dengue (todas as formas), em um local e ano de referência e y é a população residente no local e no ano de referência.	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo	Município
MRB.2.14	Taxa de incidência de dengue grave	Número de casos confirmados de dengue com sinais de alarme e dengue grave, em relação à população residente em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. Nota: - Os dados estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\sum x}{\sum y} \times 100.000$ Nota: Na fórmula, x é o número de casos confirmados de dengue (finais de alarme e grave), em um local e ano de referência e y é a população residente em um local e ano de referência.	- Faixa etária - Sexo	Município
MRB.2.15	Taxa de incidência de chikungunya	Número de casos prováveis de chikungunya, em relação à população residente em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. Nota: - Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\sum x}{\sum y} \times 100.000$ Nota: Na fórmula, x é o número de casos prováveis de chikungunya, em um local e ano de referência, e y é a população residente em um local e ano de referência.	- Faixa etária - Sexo	Município

MORBIDADE (MRB)						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
MRB.2.16	Taxa de incidência de Zika	Número de casos confirmados de Zika, em relação à população residente em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. Nota: - Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	Nota: Na fórmula, x é o número de casos confirmados de Zika, em um local e ano de referência, e y é a população residente em um local e ano de referência. $\frac{\sum x}{\sum y} \times 100.000$	- Faixa etária - Sexo	Município
MRB.2.17	Taxa de incidência de síndrome respiratória aguda grave por COVID-19	Número de casos incidentes confirmados de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) relativa à infecção pelo SARS-CoV-2, na população residente, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados da SRAG pelo vírus SARS-CoV-2, em um local e ano de referência}}{\text{População residente em um local e ano de referência}} \times 100.000$	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo	Município
MRB.3.01	Proporção de categoria de exposição por aids	Percentual de casos confirmados de aids por categoria de exposição hierarquizada, na população residente em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). - Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). - Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel). - Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom). Nota: - Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).	$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados de aids segundo categoria de exposição hierarquizada, em um local e ano de referência}}{\text{Número de casos incidentes confirmados residente em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Escolaridade - Categoria de exposição	Município

MORBIDADE (MRB)					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS
MRB.4.01	Taxa de internação hospitalar (SUS) por causas externas	Número de internações hospitalares por causas externas, financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em relação à população residente em um local e ano de referência.	- Sistema de Informações Hospitalares (SIH). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\sum x}{y} \times 100.000$ Nota: Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de internações hospitalares de residentes, por causas externas, pagas pelo SUS, em um local e ano de referência, e y significa a população residente estimada para um local e ano de referência.	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Grupos de causas - Município
MRB.4.02	Taxa de internação hospitalar (SUS) por condições sensíveis à atenção primária	Número de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária (CSAP), financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em relação à população residente, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informações Hospitalares (SIH). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\sum x}{y} \times 100.000$ Nota: Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de internações hospitalares por CSAP pagas pelo SUS, de residentes em um local e ano de referência, e y significa a população residente estimada para um local e ano de referência.	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Grupos de causas - Município

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO (FRP)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
FRP1.011	Prevalência de diabetes <i>mellitus</i> autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	Prevalência de diabetes <i>mellitus</i> , por diagnóstico médico autorreferido, em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Faixa etária - Sexo - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP1.012	Prevalência de diabetes <i>mellitus</i> autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	Prevalência de diabetes <i>mellitus</i> , por diagnóstico médico autorreferido, em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Situação do domicílio - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP1.021	Prevalência de hipertensão arterial autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	Prevalência de hipertensão arterial, por diagnóstico médico autorreferido, em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Faixa etária - Sexo - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP1.022	Prevalência de hipertensão arterial autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	Prevalência de hipertensão arterial, por diagnóstico médico autorreferido, em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, no local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Situação do domicílio - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP2.011	Prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas referido por indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	Percentual de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas, nos últimos 30 dias, em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, no local e ano de referência. Considera-se consumo episódico pesado se o indivíduo ingeriu cinco ou mais doses (homem) ou quatro ou mais doses (mulher) em uma única ocasião, pelo menos uma vez nos últimos 30 dias.	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Faixa etária - Sexo - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO (FRP)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
FRP2.012	Prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas referido por indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	Percentual de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, no local e ano de referência. Na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013, foi considerado consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas a ingestão de cinco ou mais doses (por homem) ou quatro ou mais doses (por mulher), em uma única ocasião, pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. Na PNS 2019, considerou-se o consumo de cinco ou mais doses para homens e mulheres, em uma única ocasião, nos últimos 30 dias	• Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Faixa etária • Renda domiciliar <i>per capita</i> • Sexo • Situação de domicílio • Escolaridade	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP2.021	Prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade dirigindo veículos motorizados após consumo de bebidas alcoólicas (Vigitel)	Percentual de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram dirigir veículos motorizados após consumo de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas, em um local e ano de referência.	• Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram dirigir veículos motorizados após consumo de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de condutores de automóveis ou motocicletas, com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Faixa etária • Sexo • Escolaridade	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP2.022	Prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade dirigindo veículos motorizados após consumo de bebidas alcoólicas (PNS)	Prevalência de condutores de automóvel ou motocicleta que dirigiram logo depois de consumir bebida alcoólica nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência.	• Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de condutores de automóvel ou motocicleta com 18 anos ou mais de idade que conduziram automóvel ou motocicleta e referiram dirigir logo após consumirem bebidas alcoólicas, nos 12 meses anteriores à pesquisa, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de condutores de automóvel ou motocicleta com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Faixa etária • Renda domiciliar <i>per capita</i> • Sexo • Situação de domicílio • Escolaridade	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO (FRP)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
FRP.2.03	Consumo de álcool em litros de álcool puro <i>per capita</i> entre pessoas com 15 anos ou mais de idade (entre pessoas com 15 anos ou mais de idade) por ano	Consumo de álcool em litros de álcool puro <i>per capita</i> , entre pessoas com 15 anos ou mais de idade, por ano. A informação baseia-se na produção nacional, importação (reimportação), exportação e volume de álcool (gradação), para cada categoria de bebida alcoólica (álcool registrado + não registrado), ajustado pelo consumo de turistas.	- Pesquisa Industrial Anual – Produto (PIA-Produto). - Estatísticas de comércio exterior (Comex Stat). - Estatísticas de turistas da ONU. - Estatísticas da OMS. - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções.	$\frac{\text{Produção de bebidas alcoólicas} + \text{importação} - \text{exportação}}{\text{População total de 15 anos ou mais de idade}} + \frac{\text{Consumo de álcool per capita não registrado, ajustado pelo consumo de turistas}}{\text{População total de 15 anos ou mais de idade}}$	Não se aplica	Brasil
FRP.3011	Prevalência de fumantes atuais com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	Prevalência de fumantes na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram fumar atualmente, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Faixa etária - Sexo - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP.3012	Prevalência de fumantes atuais com 18 anos ou mais de idade (PNS)	Prevalência de fumantes na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram fumar atualmente, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Situação do domicílio - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP.302.1	Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar (DEF) entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram usar DEF atualmente, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Faixa etária - Sexo - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP.302.2	Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar (DEF) por indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram usar DEF atualmente, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Situação do domicílio - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP.302.3	Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em escolares de 13 a 17 anos de idade (PeNSE)	Prevalência do uso de dispositivos eletrônicos para fumar (DEF) nos últimos 30 dias, em escolares de 13 a 17 anos de idade, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE).	$\frac{\text{Número de escolares de 13 a 17 anos de idade que referiram usar cigarro eletrônico nos últimos 30 dias, em um local e ano de referência}}{\text{Número de escolares de 13 a 17 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO (FRP)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
FRP3.031	Prevalência de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	Prevalência de ex-fumantes entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	$\frac{\text{Número de indivíduos ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Faixa etária - Sexo - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP3.032	Prevalência de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade (PNS)	Prevalência de ex-fumantes entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Situação do domicílio - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP4.011	Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre, entre indivíduos com 18 ou mais anos de idade, em um local e ano de referência. Considera-se como nível recomendado de atividade física no tempo livre a prática de no mínimo 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou no mínimo 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa.	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram praticar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Faixa etária - Sexo - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO (FRP)						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
FRP4.012	Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre, entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência. Considera-se como nível recomendado de atividade física no tempo livre a prática de no mínimo 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou no mínimo 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram praticar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, em um local e ano de referência Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência X 100	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar per capita - Sexo - Situação do domicílio - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP4.021	Prevalência de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	Prevalência de prática de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência. Considera-se insuficientemente ativo o indivíduo que não alcança pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou no mínimo 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, ou uma combinação equivalente de ambas, somando-se os minutos de atividade física nos três domínios: tempo livre, deslocamento ativo e atividade ocupacional.	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade cuja soma de minutos despendidos em atividades físicas no tempo livre, deslocamento para o trabalho/escola e na atividade ocupacional não alcança o equivalente a pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, em um local e ano de referência Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência X 100	- Faixa etária - Sexo - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO (FRP)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
FRP4.022	Prevalência de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	Prevalência de prática de atividade física insuficiente entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência. Considera-se insuficientemente ativo o indivíduo que não alcança pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou no mínimo 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, ou uma combinação equivalente de ambas, somando-se os minutos de atividade física nos três domínios: tempo livre, deslocamento ativo e atividade ocupacional.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade cuja soma de minutos despendidos em atividades físicas no tempo livre, deslocamento para o trabalho/escola e na atividade ocupacional não atinja o equivalente a, pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, em um local e ano de referência $\frac{\text{Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência}}{100} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Situação do domicílio - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP5.011	Prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)	Prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade em um local e ano de referência.	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade com IMC maior ou igual a 25kg/m², em um local e ano de referência $\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}}{100} \times 100$	- Faixa etária - Sexo - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP-5.012	Prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)	Prevalência de excesso de peso em indivíduos de 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade com IMC maior ou igual a 25kg/m², em um local e ano de referência $\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}}{100} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Sexo - Situação do domicílio - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP-5.02	Prevalência de excesso de peso em crianças menores de 5 anos de idade	Percentual de crianças menores de 5 anos de idade com excesso de peso, em um local e ano de referência.	- Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), 1989. - Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996 e 2006. - Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 2019.	Número de crianças menores de 5 anos com IMC para a idade com percentil maior que 97 ou escore-z maior que 2, em um local e ano de referência $\frac{\text{Número de crianças menores de 5 anos, em um local e ano de referência}}{100} \times 100$	- Cor ou raça - Sexo - Indicador Econômico Nacional (IEN)	Região do Brasil

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO (FRP)						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
FRP.5.03	Prevalência de déficit ponderal para a idade em crianças menores de 5 anos de idade	Percentual de crianças menores de 5 anos de idade com déficit ponderal para a idade, em um local e ano de referência. Define-se como déficit ponderal a existência de valores abaixo do escore-z menor que -2 ou percentil menor que 3 do índice de peso para idade (P/I), de acordo com as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006).	• Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), 1989. • Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996 e 2006. • Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 2019.	$\frac{\text{Número de crianças menores de 5 anos com percentil } < 3 \text{ ou escore-z } < -2 \text{ no índice de peso para a idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número de crianças menores de 5 anos, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Sexo • Indicador Econômico Nacional (IEN)	• Região do Brasil
FRP.5.04	Prevalência de déficit estatutal para a idade em crianças menores de 5 anos de idade	Percentual de crianças residentes menores de 5 anos de idade que apresentam déficit estatutal para a idade, em um local e ano de referência. Define-se como déficit estatutal valores abaixo do percentil 3 ou do escore-z -2 do índice de estatura para a idade (E/I), de acordo com as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006).	• Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), 1989. • Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996 e 2006. • Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 2019.	$\frac{\text{Número de crianças menores de 5 anos com percentil } < 3 \text{ ou escore-z } < -2 \text{ no índice de estatura para a idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número de crianças menores de 5 anos, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Sexo • Indicador Econômico Nacional (IEN)	• Região do Brasil

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO (FRP)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
FRP.5.05	Prevalência de dupla carga da má nutrição em crianças menores de 5 anos de idade	Percentual de crianças menores de 5 anos de idade com dupla carga da má nutrição, em um local e ano de referência. A dupla carga da má nutrição em crianças menores de 5 anos é definida pela observação dos extremos do estado nutricional. Ou seja, Índice de Massa Corporal (IMC) para idade classificado como magreza acentuada/ magreza ou sobrepeso/ obesidade, de acordo com as curvas de crescimento infantil da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006).	• Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), 1989. • Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996 e 2006. • Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 2019.	Número de crianças menores de 5 anos com magreza acentuada/magreza (IMC para a idade com percentil menor que 3 ou escore – z menor que –2) ou sobrepeso/ obesidade (IMC para a idade com percentil maior que 97 ou escore – z maior que 2), em um local e ano de referência X100 Número de crianças menores de 5 anos, em um local e ano de referência	• Cor ou raça • Sexo • Indicador Econômico Nacional (IEN)	• Região do Brasil
FRP.6.01	Prevalência de aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida	Percentual de crianças residentes de 0 a 5 meses e 29 dias (0 a 179 dias) que estão sendo alimentadas exclusivamente com leite materno, em um local e ano de referência.	• Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 2006. • Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 2019.	Número de crianças em aleitamento materno exclusivo, por período, durante os 6 primeiros meses de vida, em um local e ano de referência X100 Número total de crianças menores de 6 meses de vida, em um local e ano de referência Nota: • O período corresponde a: menores de 6 meses (0-5 meses e 29 dias); menores de 4 meses (0 a 3 meses e 29 dias); e de 4 a 5 meses e 29 dias.	• Cor ou raça • Faixa etária • Sexo • Situação do domicílio • Indicador Econômico Nacional (IEN)	• Região do Brasil
FRP.6.02	Prevalência de aleitamento materno continuado em crianças menores de 2 anos	Percentual de crianças residentes menores de 2 anos que foram alimentadas com leite materno, diretamente do peito ou por expressão, concomitantemente à alimentação complementar, quando a criança está recebendo outros líquidos, tipos de leite ou alimentos sólidos e semissólidos, em um local e ano de referência.	• Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 2006. • Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 2019.	Número de crianças menores de 2 anos de idade em aleitamento materno continuado, por período, em um local e ano de referência X100 Número total de crianças menores de 2 anos de idade, em um local e ano de referência Nota: • Os períodos correspondem a: de 12 a 15 meses e 29 dias; de 16 a 19 meses e 29 dias; de 20 a 23 meses e 29 dias; e menores de 24 meses (0 a 23 meses e 29 dias).	• Cor ou raça • Faixa etária • Sexo • Situação do domicílio • Indicador Econômico Nacional (IEN)	• Região do Brasil

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO (FRP)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
FRP.6.03	Participação relativa diária <i>per capita</i> das calorias de frutas, verduras e legumes no total de calorias dos alimentos adquiridos no domicílio	Participação relativa diária <i>per capita</i> das calorias provenientes de frutas, verduras e legumes no total de calorias de alimentos adquiridos no domicílio para consumo pela população residente.	• Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003, 2008-2009 e 2017-2018. • Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA): o banco deve ser obtido diretamente com a equipe da TBCA, a partir do e-mail tbcacontato@usp.br.	$\frac{\text{Total de calorias (per capita) de frutas, verduras e legumes adquiridos para o consumo da população}}{\text{Total de calorias (per capita) dos alimentos adquiridos para consumo da população}} \times 100$	• Quinto de renda • Situação do domicílio	• Região do Brasil
FRP.7.01	Proporção de nascidos vivos por idade da parturiente	Proporção de nascidos vivos (NVs), por idade da parturiente, em relação ao total de NVs, filhos de parturientes residentes em um local e ano de referência.	• Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).	$\frac{\text{Número de nascidos vivos, por idade da parturiente, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de nascidos vivos, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Faixa etária	• Município
FRP.7.02	Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer por idade gestacional no momento do parto	Proporção de nascidos vivos (NVs) com peso ao nascer inferior a 2.500 gramas, por idade gestacional no momento do parto, filhos de parturientes residentes em um local e ano de referência.	• Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).	$\frac{\text{Número de nascidos vivos com peso inferior a 2.500g, por idade gestacional no momento do parto, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de nascidos vivos, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Faixa etária • Tempo de gestação	• Município
FRP.7.03	Prevalência de nascidos vivos com anomalias congênitas	Número de nascidos vivos (NVs) com menção a, pelo menos, uma anomalia congênita, em relação ao total de NVs registrados em um local e ano de referência, por 10 mil NVs.	• Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).	$\frac{\text{Número de nascidos vivos com anomalias congênitas, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de nascidos vivos, em um local e ano de referência}} \times 10.000$	• Faixa etária	• Município
FRP.8.01	Prevalência de violências contra mulheres com 18 anos ou mais de idade (PNS)	Prevalência de algum tipo de violência (psicológica, física ou sexual) referida por mulheres com 18 anos ou mais de idade, como tendo ocorrido nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência.	• Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de mulheres de 18 anos ou mais de idade que sofreram pelo menos algum dos tipos de violência referidos nas questões da pesquisa, nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência}}{\text{Número de mulheres de 18 anos ou mais de idade entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Faixa etária • Renda domiciliar <i>per capita</i> • Situação do domicílio • Escolaridade	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP.8.02	Prevalência de violências contra meninas de 13 a 17 anos de idade (PeNSE)	Prevalência de violência sexual contra meninas de 13 a 17 anos de idade que referiram ter sofrido alguma vez na vida violência sexual, em um local e ano de referência.	• Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE).	$\frac{\text{Número de meninas de 13 a 17 anos de idade que relataram ter sofrido violência sexual alguma vez na vida, em um local e ano de referência}}{\text{Número de meninas de 13 a 17 anos de idade entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Faixa etária	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO (FRP)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
FRP 9.01	Índice CPO-D (número de dentes cariados, perdidos e obturados) aos 12 anos de idade	Número médio de dentes permanentes cariados, perdidos (extraídos devido à cárie dentária) e obturados (restaurados), aos 12 anos de idade, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil).	$\frac{\text{Número de dentes cariados, perdidos e obturados de indivíduos examinados aos 12 anos de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de crianças examinadas aos 12 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	Não se aplica	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
FRP 9.02	Proporção de criança de 5 a 6 anos de idade livres de cárie (índice ceo-d igual a 0)	Percentual de crianças de 5 a 6 anos de idade com índice ceo-d (número de dentes decíduos cariados, com extração indicada ou perdidos devido a cárie, e obturados) igual a zero, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil).	$\frac{\text{Número de crianças examinadas de 5 e 6 anos de idade com resultado ceo - d = 0, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de crianças examinadas de 5 e 6 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	Não se aplica	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

COBERTURA (COB)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
COB.1.01	Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Primária à Saúde por 100 habitantes	Razão do número de consultas médicas no Sistema Único de Saúde (SUS) realizadas em estabelecimentos da Atenção Primária à Saúde (APS), por 100 habitantes, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informação da Atenção Básica (SISAB). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número total de consultas médicas (SUS) realizadas na APS, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Faixa etária detalhada - Sexo	Município
COB.1.02	Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Especializada em Saúde por 100 habitantes	Razão do número de consultas médicas no Sistema Único de Saúde (SUS) realizadas na Atenção Especializada em Saúde, por 100 habitantes, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número total de consultas médicas (SUS) realizadas na Atenção Especializada em Saúde, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e ano de referência}} \times 100$	Especialidades médicas	Município
COB.1.03	Razão de consultas médicas (saúde suplementar) por beneficiários de planos privados de saúde	Razão entre as consultas médicas realizadas por meio de operadoras de planos privados de saúde e os beneficiários de planos privados de saúde com cobertura ambulatorial residentes em um local e ano de referência.	- Sistema de Informações de Beneficiários (SIB). - Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS).	$\frac{\text{Número de consultas médicas pagas por operadoras de planos privados de saúde, em um local e ano de referência}}{\text{Número de beneficiários de planos de assistência médica com cobertura ambulatorial, em um local e ano de referência}}$	- Faixa etária - Faixa etária detalhada - Sexo	Município
COB.1.04	Proporção da população que referiu ter consultado médico nos últimos 12 meses (PNS)	Percentual da população que referiu ter consultado médico nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de pessoas que referiram ter consultado médico nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar per capita - Sexo - Situação do domicílio - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
COB.1.05	Proporção da população que referiu ter realizado consulta odontológica nos últimos 12 meses (PNS)	Proporção da população que referiu ter realizado consulta odontológica nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de pessoas que referiram ter realizado consulta odontológica nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar per capita - Sexo - Situação do domicílio - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

COBERTURA (COB)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
COB.1.06	Proporção da população que referiu nunca ter realizado consulta odontológica (PNS)	Proporção da população que referiu nunca ter realizado consulta odontológica, em um local e ano de referência.	• Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de pessoas que referiram nunca ter realizado consulta odontológica, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Faixa etária • Renda domiciliar <i>per capita</i>. • Sexo • Situação do domicílio • Escolaridade	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
COB.2.01	Taxa de internações hospitalares (SUS) por 100 habitantes	Número de internações hospitalares financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por 100 habitantes, na população residente, em um local e ano de referência.	• Sistema de Informações Hospitalares (SIH). • Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções.	$\frac{\text{Número de internações hospitalares financiadas pelo SUS, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Tipo de especialidade	• Município
COB.2.02	Taxa de internações hospitalares (saúde suplementar) por 100 beneficiários de planos privados de saúde	Taxa de internações hospitalares realizadas por meio de operadores de planos privados de saúde, por 100 beneficiários de planos privados de saúde com cobertura hospitalar, em um local e ano de referência.	• Sistema de Informações de Beneficiários (SIB). • Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS).	$\frac{\text{Número de internações hospitalares pagas por operadores de planos privados de saúde, em um local e ano de referência}}{\text{Número de beneficiários de planos privados de saúde com cobertura hospitalar, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Faixa etária • Faixa etária detalhada • Sexo • Tipo de internação	• Município
COB.2.03	Proporção da população que referiu internação hospitalar nos últimos 12 meses (PNS)	Proporção da população que referiu internação hospitalar por 24 horas ou mais nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência.	• Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de pessoas que referiram internação hospitalar por 24 horas ou mais nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Faixa etária • Renda domiciliar <i>per capita</i> • Sexo • Situação do domicílio • Escolaridade • Financiamento	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
COB.3.01.1	Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero há menos de três anos (PNS)	Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu realização do exame preventivo para câncer do colo do útero há menos de três anos, em um local e ano de referência.	• Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos que referiram de exame preventivo do câncer do colo de útero há menos de três anos, em um local e ano de referência}}{\text{Número de entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça • Faixa etária • Renda domiciliar <i>per capita</i> • Situação do domicílio • Escolaridade • Financiamento	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

COBERTURA (COB)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
COB3.012	Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do colo do útero há menos de três anos (Vigitel)	Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu realização do exame preventivo para câncer do colo do útero há menos de três anos, em um local e ano de referência.	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu a realização de exame preventivo do câncer de colo de útero, há menos de três anos, em um local e ano de referência}}{\text{Número de entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Faixa etária - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
COB3.021	Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero (PNS)	Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo para câncer do colo do útero, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiram nunca ter realizado exame preventivo do câncer de colo de útero, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Situação do domicílio - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
COB3.022	Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero (Vigitel)	Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu a realização do exame preventivo do câncer do colo do útero, em um local e ano de referência.	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiram nunca ter realizado exame preventivo do câncer de colo de útero, em um local e ano de referência}}{\text{Número de entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Faixa etária - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
COB3.031	Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de dois anos (PNS)	Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu a realização de mamografia há menos de dois anos, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiram ter realizado mamografia há menos de dois anos, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Situação do domicílio - Escolaridade - Financiamento	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
COB3.032	Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de 2 anos (Vigitel)	Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu a realização de mamografia há menos de dois anos, em um local e ano de referência.	Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiram ter realizado mamografia há menos de dois anos, em um local e ano de referência}}{\text{Número de entrevistadas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Faixa etária - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

COBERTURA (COB)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
COB3.04.1	Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia (PNS)	Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos que referiu nunca ter realizado mamografia, em um local e ano de referência.	• Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiram nunca ter realizado mamografia, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça da parturiente (a partir de 2012) • Renda domiciliar <i>per capita</i> • Situação do domicílio • Escolaridade	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
COB3.04.2	Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia (Vigitel)	Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia, em um local e ano de referência.	• Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).	$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiram nunca ter realizado mamografia, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Faixa etária • Escolaridade	• Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
COB.4.01	Proporção de nascidos vivos segundo o número de consultas de pré-natal	Distribuição percentual de nascidos vivos segundo o número de consultas de pré-natal das parturientes, em um local e ano de referência.	• Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).	$\frac{\text{Número de nascidos vivos, segundo o número de consultas de pré-natal da parturiente, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de nascidos vivos de parturientes, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça da parturiente (a partir de 2012) • Faixa etária da parturiente • Escolaridade da parturiente (até 2011) • Escolaridade da parturiente (a partir de 2012) • Número de consultas de pré-natal (até 2011) • Número de consultas de pré-natal (a partir de 2012) • Trimestre gestacional de início do pré-natal	• Município
COB4.02	Proporção de partos hospitalares	Proporção de nascidos vivos por parto hospitalar entre o total de nascidos vivos de parturientes residentes, em um local e ano de referência.	• Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).	$\frac{\text{Número de nascidos vivos, de parto hospitalar, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de nascidos vivos de parturientes residentes, em um local e ano de referência}} \times 100$	• Cor ou raça da parturiente (a partir de 2012) • Faixa etária da parturiente • Escolaridade da parturiente (até 2011) • Escolaridade da parturiente (a partir de 2012)	• Município

COBERTURA (COB)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
COB.4.03	Proporção de partos cesáreos	Proporção de partos cesáreos no total de partos, na população residente, em um local e ano de referência.	Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).	$\frac{\text{Número de nascidos vivos de partos cesáreos}}{\text{Número total de nascidos vivos de parturientes residentes, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça da parturiente - Faixa etária da parturiente - Escolaridade da parturiente (até 2011) - Escolaridade da parturiente (a partir de 2012)	Município
COB.4.04	Proporção da população do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiu uso de métodos contraceptivos (PNS)	Proporção da população do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiu ter tido relações sexuais nos últimos 12 meses antes da entrevista e fazia uso de métodos para evitar a gravidez, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiram relações sexuais nos últimos 12 meses antes da entrevista e que faziam uso de métodos para evitar a gravidez, em um local e ano de referência}}{\text{Número de entrevistadas do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiram relações sexuais nos últimos 12 meses antes da entrevista, excluídas aquelas que querem engravidar, estão grávidas, ligaram as trompas, o companheiro fez vasectomia, ou não têm relações sexuais com homens, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Situação do domicílio - Escolaridade	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal
COB.5.01	Proporção da população coberta por planos privados de assistência à saúde	Proporção da população coberta por planos privados de assistência à saúde, exceto exclusivamente odontológicos, em um local e ano de referência.	- Sistema de Informações de Beneficiários (SIB). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de vínculos de beneficiários de planos e seguros privados de saúde, exceto os exclusivamente odontológicos, em junho do ano de referência}}{\text{População total residente, ajustada para o meio do ano}} \times 100$	- Faixa etária - Sexo - Segmentação assistencial do plano	Município
COB.5.02	Proporção da população que referiu cobertura por planos de saúde (PNS)	Proporção da população que referiu cobertura por plano de saúde, médico e/ou odontológico, particular, de empresa ou órgão público, em um local e ano de referência.	Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).	$\frac{\text{Número de pessoas entrevistadas que referiram cobertura por plano de saúde, médico ou odontológico, particular, de empresa ou órgão público, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de pessoas entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Cor ou raça - Faixa etária - Sexo - Renda domiciliar <i>per capita</i> - Situação do domicílio - Escolaridade - Tipo de plano	Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal

RECURSOS (REC)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
REC.1.01	Trabalhadores da saúde por população	Razão entre o número de trabalhadores da saúde e a população residente, em um local e ano de referência. Abrange o conjunto de trabalhadores que atuam nos serviços de saúde, incluindo tanto a assistência direta quanto as atividades-méio essenciais ao funcionamento do sistema.	- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número total de trabalhadores da saúde, por categoria específica, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente em um local e ano de referência}} \times 1.000$	Ocupação	Município
REC.2.01	Leitos hospitalares por população	Razão entre o número de leitos hospitalares e a população, em um local e ano de referência.	- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade. - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).	$\frac{\text{Número de leitos hospitalares ativos, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, conforme tipo de leito, em um local e ano de referência}} \times 1.000$	- Esfera administrativa - Tipo de vínculo - Tipo de leito	Município
REC.2.02	Distribuição proporcional de leitos hospitalares segundo natureza jurídica	Distribuição percentual de leitos hospitalares, classificados de acordo com a natureza jurídica do estabelecimento hospitalar, em um local e ano de referência.	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).	$\frac{\text{Número de leitos hospitalares disponíveis, segundo a natureza jurídica dos estabelecimentos hospitalares, em um local e ano de referência}}{\text{Número de leitos hospitalares disponíveis, em um local e ano de referência}} \times 100$	- Tipo de vínculo - Tipo de leito	Município
REC.2.03	Equipamentos de imagem por população	Razão entre o número de equipamentos de imagem em uso e a população, em um local e ano de referência.	- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	$\frac{\text{Número de equipamentos de imagem em uso, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$ Nota: Para quantificar o número de equipamentos do indicador, considera-se a competência de julho de cada ano.	- Categoria do equipamento - Esfera administrativa	Município

RECURSOS (REC)					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS
REC.3.01	Valor médio de referência por atendimento ambulatorial no Sistema Único de Saúde	É a razão entre a soma dos valores monetários registrados para os atendimentos ambulatoriais classificados como de média e alta complexidade e o total de atendimentos dessa natureza, segundo os registros do Sistema Único de Saúde (SUS).	Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).	$\frac{\text{Total do valor pago para atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade, no SUS, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade, no SUS, em um local e ano de referência}}$ Nota: O valor total pago é em moeda corrente do ano.	- Grupo de procedimentos - Município
REC.3.02	Valor médio de referência por autorização de internação hospitalar	Razão entre a soma dos valores pagos pelo Ministério da Saúde para as internações hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS) e o número total de internações hospitalares realizadas no SUS, em um local e ano de referência. Corresponde à média dos valores pagos por Autorização de Internação Hospitalar (AIH), de acordo com os valores de referência estipulados na tabela SUS, por especialidade, em um local e ano de referência.	Sistema de Informações Hospitalares (SIH).	$\frac{\text{Valor total pago pelo Ministério da Saúde para hospitalizações (AIH), no SUS, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de hospitalizações (AIH), no SUS, em um local e ano de referência}}$ Nota: O valor total pago é expresso em moeda corrente do ano.	- Especialidade - Município

RECURSOS (REC)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
REC.3.03	Gasto em ações e serviços públicos de saúde como percentual do produto interno bruto	Proporção do Produto Interno Bruto (PIB) destinada a ações e serviços públicos de saúde (ASPS), em determinado ano de referência.	- Dados de despesas com ASPS federal: SICAP Brasil ou Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi). Critério: ID uso 6 para despesas com ASPS. Base de cálculo: despesas empenhadas. - Dados de despesas com ASPS estaduais e municipais: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Base de cálculo: despesas empenhadas de receitas próprias. - Dados do PIB: Sistema de Contas Nacionais (SCN).	Valor total de despesas empenhadas em ASPS, no SUS, pelas três esferas de governo, em determinado ano de referência $\frac{\text{Valor total do PIB, em determinado ano de referência}}{\text{Valor total de despesas empenhadas em ASPS, no SUS, pelas três esferas de governo, em determinado ano de referência}} \times 100$ Nota: O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.	Esfera de governo	Município
REC.3.04	Gasto em ações e serviços públicos de saúde <i>per capita</i>	Gasto com ações e serviços públicos de saúde (ASPS) por habitante, em um local e ano de referência.	- Dados de despesas com ASPS federal: SICAP Brasil ou Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi). Critério: ID uso 6 para despesas com ASPS. Base de cálculo: despesas empenhadas. - Dados de despesas com ASPS estaduais e municipais: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Base de cálculo: despesas empenhadas de receitas próprias. - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: Estimativas e projeções. - Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade.	Valor total de despesas empenhadas em ASPS, no SUS, pelas três esferas de governo, em um local e ano de referência $\frac{\text{População total, em um local e ano de referência}}{\text{Valor total de despesas empenhadas em ASPS, no SUS, pelas três esferas de governo, em um local e ano de referência}}$ Nota: O numerador é expresso em reais correntes do ano.	Esfera de governo	Município

RECURSOS (REC)					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS
REC.4.01	Despesa com saúde autorreferida como proporção da renda familiar	Percentual da renda familiar mensal despendida em gastos com saúde, ambos autorreferidos, em um local e ano de referência. Os gastos com saúde incluem despesas com planos de saúde, consultas, medicamentos, tratamentos, exames e outros serviços de assistência à saúde. Proporção da renda disponível bruta das famílias destinada ao gasto com bens e serviços de saúde, em um local e ano de referência. A renda disponível bruta das famílias considera os rendimentos recebidos (como salários, aposentadorias, transferências sociais, lucros e dividendos), descontadas as transferências líquidas pagas, como impostos e contribuições.	Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF).	Valor médio mensal da despesa familiar autorreferida com saúde, em um local e ano de referência $\times 100$ Valor médio da renda familiar total autorreferida, em um local e ano de referência Notas: - O numerador e o denominador são em reais correntes do ano. - A renda disponível familiar média mensal exclui impostos e contribuições.	- Renda domiciliar <i>per capita</i> - Item de despesa com assistência à saúde - Unidade da Federação
REC.4.02	Despesa com saúde estimada como proporção da renda familiar	Proporção da renda disponível bruta das famílias destinada ao gasto com bens e serviços de saúde, em um local e ano de referência. A renda disponível bruta das famílias considera os rendimentos recebidos (como salários, aposentadorias, transferências sociais, lucros e dividendos), descontadas as transferências líquidas pagas, como impostos e contribuições.	Conta-Satélite de Saúde (CSS).	Despesa de consumo final das famílias com bens e serviços de saúde, em um local e ano de referência $\times 100$ Renda nacional disponível bruta Nota: O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.	- Não se aplica - Brasil
REC.4.03	Gasto nacional com saúde como percentual do produto interno bruto	Corresponde à razão entre o total das despesas de consumo final de bens e serviços de saúde realizadas por todas as fontes de financiamento (governo, famílias, empresas e instituições sem fins lucrativos) e o valor do Produto Interno Bruto (PIB), expressa em percentual.	Retropolação da série de consumo final de bens e serviços de saúde em Conta-Satélite de Saúde (CSS).	Despesa de consumo final de bens e serviços de saúde, em um local e ano de referência $\times 100$ Valor do PIB, em um local e ano de referência Nota: O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.	- Sector - Brasil

RECURSOS (REC)

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS	GRANULARIDADE
REC.4.04	Gasto nacional per capita com saúde	Valor, em reais correntes, que corresponde ao gasto total (público e privado) com o consumo final de bens e serviços de saúde por habitante, em um local e ano de referência.	- Conta-Satélite de Saúde (CSS). - Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções.	$\frac{\text{Despesa de consumo final de bens e serviços de saúde, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente em um local, ajustada para o meio do ano de referência}} \times 100$ Nota: O numerador é expresso em reais correntes do ano.	Sector	Brasil
REC.4.05	Gasto federal com saúde como percentual do produto interno bruto	Percentual do Produto Interno Bruto (PIB) nacional que corresponde ao gasto público federal com saúde em um ano de referência.	- Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). - Sistema de Contas Nacionais (SCN).	$\frac{\text{Valor total da despesa federal com saúde, correspondente a itens de gasto, em um local e ano de referência}}{\text{Valor do PIB nacional em um local e ano de referência}} \times 100$ Nota: O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.	Item de gasto	Brasil
REC.4.06	Gasto federal com saúde como percentual do gasto federal total	Percentual do gasto público federal total que corresponde a despesas com saúde no ano de referência.	Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP).	$\frac{\text{Valor total da despesa federal com saúde no ano de referência}}{\text{Valor total das despesas federais no ano de referência}} \times 100$ Nota: O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.	Tipo de despesa federal com saúde	Brasil
REC.5.01	Gasto público com saneamento básico como percentual do produto interno bruto	Percentual do Produto Interno Bruto (PIB) que corresponde ao gasto público com saneamento básico, em um local e ano de referência.	- Dados de despesas para a União: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). - Dados de despesas estaduais, distritais e municipais: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). - Dados do PIB: Sistema de Contas Nacionais (SCN)	$\frac{\text{Valor total da despesa do setor público com saneamento básico, em um local e ano de referência}}{\text{Valor do PIB, em um local e ano de referência}} \times 100$ Nota: O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.	Esfera de governo	Município
REC.5.02	Gasto federal com saneamento básico como percentual do produto interno bruto	Percentual do Produto Interno Bruto (PIB) nacional que corresponde ao gasto público federal com saneamento básico no ano considerado.	- Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). - Sistema de Contas Nacionais (SCN).	$\frac{\text{Valor total da despesa federal com saneamento básico, no ano de referência}}{\text{Valor do PIB, no ano de referência}} \times 100$ Nota: O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.	Não se aplica	Brasil

RECURSOS (REC)					
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	CONCEITO	FONTES	FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIÁVEIS
REC.5.03	Gasto federal com saneamento básico como percentual do gasto federal total	Percentual do gasto público federal total que corresponde a despesas com saneamento básico no ano considerado.	Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP).	$\frac{\text{Valor total da despesa federal com saneamento básico no país e ano de referência}}{\text{Valor total das despesas federais no país e ano de referência}} \times 100$ Nota: O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.	Não se aplica
REC.6.01	Proporção das importações de bens e serviços de saúde na oferta nacional	Indica a participação das importações de bens e serviços de saúde no total da oferta nacional destes produtos, em um ano de referência. A oferta total de bens e serviços de saúde corresponde à soma de produção nacional e das importações.	Conta-Satélite de Saúde (CSS).	$\frac{\text{Valor de importação, por produto, no ano de referência}}{\text{Valor da oferta total, por produto, no ano de referência}} \times 100$ Nota: O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.	Item de importação
					Brasil
					Brasil



CAPÍTULO 3

FICHAS DE QUALIFICAÇÃO
DE INDICADORES (FQIs)



INDICADORES DEMOGRÁFICOS (DEM)

Indicadores demográficos (DEM)

O Comitê Gestor de Indicadores Demográficos (CGI Demográfico) tem a função de definir as populações de referência para os indicadores de saúde da Ripsa, assim como indicar as principais fontes de dados a serem utilizadas. Também integra suas atribuições descrever os indicadores populacionais essenciais que caracterizam diferentes populações.

Os indicadores populacionais desempenham papel fundamental na gestão das políticas de saúde, pois permitem conhecer a estrutura e a dinâmica da população atendida. Assim, constituem insumos indispensáveis para a tomada de decisão, o planejamento e a avaliação de resultados das ações e programas na área de saúde.

Enquanto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trabalhava para divulgar as Projeções das Populações do Brasil e Unidades da Federação, que incluíam os dados do Censo Demográfico 2022, e que viriam a ser a principal fonte de dados populacionais na Ripsa, o CGI Demográfico se reunia semanalmente com o objetivo de revisar, alterar ou incluir as fichas dos indicadores relacionados à população.

Em decorrência da revisão realizada, além de atualizações conceituais e das fontes de dados, também foram feitas três alterações nos indicadores que haviam sido elencados na última versão do livro (de 2012), em outros comitês gestores: a inclusão dos indicadores de cobertura das notificações de óbitos, no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), e de nascimentos, no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc); e a transferência do indicador sobre distribuição percentual de óbitos por idade para o CGI Mortalidade. A atualização do indicador de grau de urbanização ocorrerá oportunamente.

Em função da demanda dos diversos gestores municipais por indicadores de saúde relacionados às suas populações, concomitantemente ao trabalho do CGI, formou-se, em abril de 2024, no âmago desse grupo, o Comitê Temático Interdisciplinar (CTI) de Estimativas Municipais. Esse CTI foi formado por demógrafos integrantes do CGI, além de pesquisadores convidados, a fim de se debater uma metodologia para desagregação das populações anuais dos estados brasileiros, em populações municipais, por idade e sexo. As reuniões foram quinzenais, com discussões enriquecedoras, que culminaram nas estimativas dessas populações. Tais estimativas foram, então, discutidas metodologicamente em fórum de especialistas, calculadas por consultores contratados e orientados pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS), com dados básicos do IBGE.



Dimensão 1 – População

- DEM.1.01 – População residente
- DEM.1.02 – Razão de sexo
- DEM.1.03 – Taxa de crescimento anual da população
- DEM.1.04 – Proporção de menores de 5 anos de idade na população
- DEM.1.05 – Proporção de pessoas idosas na população
- DEM.1.06 – Índice de envelhecimento
- DEM.1.07 – Razão de dependência

Dimensão 2 – Fecundidade e natalidade

- DEM.2.01 – Taxas específicas de fecundidade
- DEM.2.02 – Taxa de fecundidade total
- DEM.2.03 – Taxa bruta de natalidade

Dimensão 3 – Mortalidade

- DEM.3.01 – Taxas específicas de mortalidade por idade e sexo
- DEM.3.02 – Taxa bruta de mortalidade
- DEM.3.03 – Taxa de mortalidade padronizada por idade
- DEM.3.04 – Esperança de vida ao nascer
- DEM.3.05 – Esperança de vida aos 60 anos de idade

Dimensão 4 – Cobertura dos sistemas de informações de nascidos vivos e de mortalidade do Ministério da Saúde

- DEM.4.01 – Cobertura do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)
- DEM.4.02 – Cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)

Demográfico



DEM.1.01 – População residente

DEM.1.01 – Resident population

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de pessoas residentes, desagregado por idade e sexo, em um local e na data de 1º de julho do ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a magnitude da população residente, segundo idade e sexo, em um local e na data de 1º de julho do ano de referência.

USOS

- Prover o denominador para o cálculo de taxas de base populacional.
- Dimensionar a população-alvo para ações e serviços.
- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição da população.
- Contribuir para o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas públicas relacionadas a saúde, educação, trabalho, previdência e assistência social para os diversos segmentos de idade e sexo.
- Orientar a alocação de recursos públicos, por exemplo, no financiamento de serviços em base *per capita*.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de alcance social.

LIMITAÇÕES

- Imprecisões inerentes à metodologia utilizada na elaboração de estimativas e projeções populacionais para todos os níveis geográficos, principalmente para os municípios, com desagregação por sexo e idade.
- Projeções populacionais do Brasil e Unidades da Federação (UFs) tendem a perder precisão à medida que se distanciam do último levantamento censitário.
- Estimativas populacionais dos municípios tendem a perder precisão à medida que se distanciam do último levantamento censitário, e quando utilizadas por idade simples e sexo. Sugere-se agregar os grupos etários de interesse para utilização da população estimada.

FONTES DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções¹.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade².

FÓRMULA DE CÁLCULO

- Não se aplica.

MÉTODO DE CÁLCULO

- As projeções da população do Brasil e das UFs¹ foram elaboradas pelo método das componentes demográficas, que considera uma população de partida, os nascimentos e os óbitos (registrados e ajustados por sub-registro, quando necessário), além de hipóteses sobre a migração interna e internacional.
- As populações das UFs, desagregadas por idade e sexo, estão disponíveis para o período de 2000 a 2070.
- As estimativas municipais, desagregadas por idade e sexo², são obtidas pelo método de relação de coortes de Dushesne³, que utiliza como pontos de referência as populações recenseadas em 2000, 2010 e 2022, desagregadas por idade e sexo, ajustadas conforme metodologia específica.
- As populações municipais estão compatibilizadas com as projeções para as UFs do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)¹.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 1 em 1 ano; e
- 80 anos ou mais.

Nota:

- Para as UFs, a faixa etária é desagregada até 89 anos (de 1 em 1 ano), com o último grupo sendo 90 anos ou mais. Para municípios, utiliza-se a agregação apresentada acima (até 79 anos, com último grupo de 80 anos ou mais).

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).
- Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS).

NOTA

- Não se aplica.

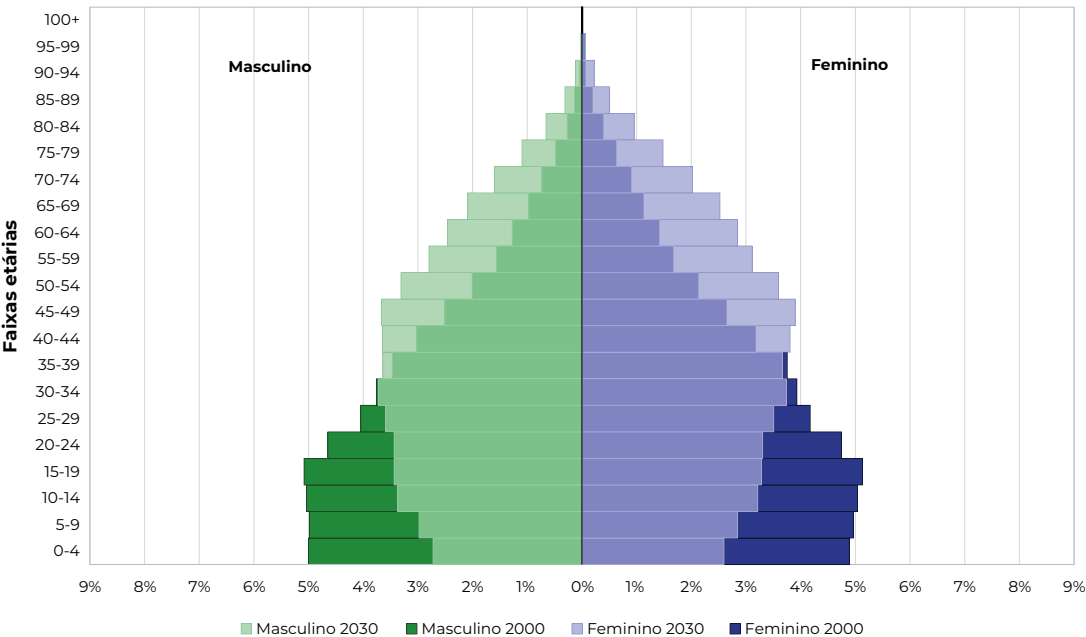
ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

De acordo com os dados analisados, o período entre os anos de 2000 e 2030, a composição etária da população brasileira continuará sofrendo mudanças significativas. Estas mudanças se iniciaram em meados dos anos de 1940, inicialmente com declínio da mortalidade, e posteriormente, em 1970, com o declínio dos níveis de fecundidade⁴.

Em 2000, o grupo etário dos menores de 5 anos de idade, a base da pirâmide etária, representava 9,6% da população total, e, no grupo dos maiores de 80 anos de idade, o percentual de participação era de 1,1%. Em 2030, estes mesmos percentuais passarão a ser de 5,3% e de 2,9%, respectivamente.

Essas mudanças refletem o envelhecimento populacional que vem ocorrendo na composição etária da população brasileira, gerando o estreitamento da base e o alargamento do topo da pirâmide etária (Gráfico 1).

Gráfico 1 – População residente distribuída (%) segundo sexo e faixa etária. Brasil, 2000 e 2030



REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
2. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/> doi:10.5281/zenodo.17990183

3. Duchesne L. Método de projecciones de población por sexo y edad para áreas intermedias y menores, Método de relación de cohortes [Internet]. CELADE. Santiago: CELADE; 1987 [citado 11 de junho de 2025]. Disponível em: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ba233a39-ec49-4073-928c-bfc18c66cfdb/content>
4. Rigotti JIR, Campos J, Hadad RM. Migrações internas no Brasil: (des) continuidades regionais à luz do Censo Demográfico 2010. Revista Geografias. 2017; p.8-24.

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.1.01 – População residente [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18248750



Demográfico



DEM.1.02 – Razão de sexo

DEM.1.02 – Sex ratio

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- A razão de sexo mede a proporção entre homens e mulheres em uma população, considerando-se o número de homens para cada grupo de 100 mulheres, na população residente, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a relação quantitativa entre os sexos. Quando igual a 100, o número de homens e de mulheres é equivalente; valores acima de 100 indicam predominância de homens, enquanto valores abaixo indicam predominância de mulheres.
- É influenciada por taxas de migração e mortalidade diferenciadas por sexo e idade.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição da população por sexo.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, segurança e emprego.
- Auxiliar na compreensão de fenômenos sociais relacionados a essa distribuição, como migrações, mercado de trabalho, organização familiar e morbimortalidade.
- Identificar a necessidade de estudos de diferenciais de sexo sobre os fatores que condicionam as variações encontradas.

LIMITAÇÕES

- Imprecisões na base de dados utilizada para o cálculo do indicador, relacionadas à coleta de dados demográficos ou à metodologia empregada na elaboração de estimativas e projeções populacionais, especialmente para municípios de pequeno porte populacional e para recortes demográficos específicos. Essas imprecisões não são mensuráveis.
- O indicador refere-se ao sexo biológico binário (masculino e feminino).

FONTES DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções¹.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População residente do sexo masculino, em um local e ano de referência}}{\text{População residente do sexo feminino, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: População residente do sexo masculino.
- Denominador: População residente do sexo feminino.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 1 em 1 ano; e
- 80 anos ou mais.

Nota:

- Para Unidades da Federação, a faixa etária é desagregada até 89 anos (de 1 em 1 ano), com o último grupo sendo 90 anos ou mais. Para municípios, utiliza-se a agregação apresentada acima (até 79 anos, com o último grupo de 80 anos ou mais).

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).
- Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A população brasileira é predominantemente composta por pessoas do sexo feminino, e essa tendência tem se intensificado ao longo do tempo. Esse fenômeno está associado à maior mortalidade dos homens em todos os grupos etários, especialmente entre jovens e adultos, devido à alta incidência de óbitos por causas violentas³⁻⁵. Esse padrão se repete em todas as regiões do país, exceto na região Norte, onde o número de homens é maior que o de mulheres. Isso se deve a fatores socioeconômicos que levam ao predomínio da mão de obra masculina em setores econômicos locais^{6,7} (Tabela 1).

Tabela 1 – Razão de sexo (homens por 100 mulheres). Brasil e regiões, 2000, 2010, 2020 e 2024

Brasil e regiões	2000	2010	2020	2024
Brasil	96,3	95,7	95,4	95,2
Norte	102,0	101,4	101,3	101,0
Nordeste	95,8	95,2	94,7	94,4
Sudeste	95,0	94,4	94,1	93,9
Sul	97,2	96,3	96,0	95,7
Centro-Oeste	99,3	98,4	97,8	97,4

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

2. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

3. Siviero PCL, Turra CM, Rodrigues RN. Diferenciais de mortalidade por sexo: notas para estudo. Textos para Discussão Cedeplar-UFMG [Internet]. 2010 [citado 9 de agosto de 2025]. Disponível em: <https://cedeplar.ufmg.br/408-diferenciais-de-mortalidade-por-sexo-notas-para-estudo>

4. Siveiro PCL, Turra CM, Rodrigues R do N. Diferenciais de mortalidade: níveis e padrões segundo o sexo no município de São Paulo de 1920 a 2005. Rev Bras Estud Popul [Internet]. 2011 [citado 9 de agosto de 2025];28(2). Disponível em: <https://www.rebep.org.br/revista/article/view/67>

5. Grupo de Foz. Métodos demográficos: uma visão desde os países de língua portuguesa [Internet]. Editora Blucher. São Paulo: Editora Blucher; 2021 [citado 9 de agosto de 2025]. 1-1030 p. Disponível em: https://www.blucher.com.br/metodos-demograficos-uma-visao-desde-os-paises-de-lingua-portuguesa_9786555500837

6. Camarano AA, Abramovay R. Êxodo rural, envelhecimento e masculinização no Brasil: panorama dos últimos 50 anos: Texto para Discussão (TD) 621 [Internet]. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); 1999 [citado 9 de agosto de 2025]. 1-23 p. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/entities/publication/b456ff51-a456-48f3-b9e9-083b9d7c7674>

7. Carvalho RC, Rigotti JIR. As migrações nas cidades médias de Minas Gerais e seus impactos no crescimento e na composição por sexo e idade da população no período 1980-2010. Rev Bras Estud Popul [Internet]. 2015 [citado 9 de agosto de 2025];32(2):235-56. Disponível em: <https://rebep.org.br/revista/article/view/713>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.1.02 – Razão de sexo [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18157474



Demográfico



DEM.1.03 – Taxa de crescimento anual da população

DEM.1.03 – Annual population growth rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual de variação média anual da população total residente, em um local e período de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Indica o ritmo de crescimento populacional.
- A variação do volume populacional é determinada pela dinâmica da fecundidade, da mortalidade e das migrações.

USOS

- Subsidiar análises das variações geográficas e temporais do crescimento populacional.
- Realizar estimativas e projeções populacionais para períodos curtos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas específicas, como o dimensionamento de infraestrutura, previsão de recursos humanos e financeiros e atualização de metas.

LIMITAÇÕES

- As estimativas populacionais utilizadas como base para o cálculo do indicador podem apresentar imprecisões relacionadas à coleta de dados ou à metodologia empregada na sua elaboração.
- As estimativas e projeções populacionais perdem precisão à medida que se distanciam do ano do último levantamento censitário e, com isso, as taxas de crescimento anual podem não refletir a dinâmica populacional mais recente.

FONTES DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções¹.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\left(\sqrt[n]{\frac{P_{t+n}}{P_t}} - 1 \right) \times 100$$

Nota:

- Cálculo de utilização direta de base de dados.

MÉTODO DE CÁLCULO

- As estimativas da taxa de crescimento médio anual da população são realizadas pelo método geométrico. Em termos técnicos, para se obter a taxa de crescimento (r), subtrai-se 1 da raiz enésima do quociente entre a população final (P_{t+n}) e a população no começo do período considerado (P_t), multiplicando-se o resultado por 100, sendo “ n ” igual ao número de anos no período.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).
- Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O Brasil apresenta historicamente queda em suas taxas de crescimento populacional, em decorrência da queda na fecundidade, ao longo do tempo, e da redução do número de nascimentos. Todas as regiões apresentam redução em seu crescimento, embora com diferenças regionais marcantes.

No nível subnacional, além da redução da fecundidade, as tendências de emigração e imigração são importantes condutores do crescimento populacional. As regiões Norte e Centro-Oeste possuíam as maiores taxas de crescimento do país no período entre 2020 e 2024 (Tabela 1). Ambas iniciaram tardiamente o declínio da fecundidade em relação às demais regiões¹, e a região Centro-Oeste, como uma tradicional área agrícola e pecuária, tem tendência de atração populacional³.

As regiões Sudeste e Nordeste apresentaram as menores taxas anuais médias de crescimento populacional do país entre 2020 e 2024, refletindo baixas taxas de fecundidade e saldos migratórios pequenos. A região Sul, apesar de possuir historicamente baixas taxas de fecundidade em relação às demais regiões, vem registrando aumento no saldo migratório regional, de maneira que apresentou menor redução da taxa média anual de crescimento ao longo de todo o período analisado.

Tabela 1 – Taxa média geométrica (%) de crescimento anual da população residente. Brasil e regiões, 2000–2010, 2010–2020 e 2020–2024

Brasil e regiões	2000–2010 %	2010–2020 %	2020–2024 %
Brasil	1,09	0,72	0,41
Norte	1,93	1,16	0,73
Nordeste	0,92	0,52	0,26
Sudeste	1,00	0,61	0,24
Sul	0,91	0,83	0,64
Centro-Oeste	1,75	1,30	1,01

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
2. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/> doi:10.5281/zenodo.17990183
3. Rigotti JIR, Campos J, Hadad RM. Migrações internas no Brasil: (des)continuidades regionais à luz do Censo Demográfico 2010. Revista Geografias [Internet]. 17 de outubro de 2017 [citado 20 de maio de 2025];8–24. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/geografias/article/view/13444>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.1.03 – Taxa de crescimento anual da população [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18257722



Demográfico



DEM.1.04 – Proporção de menores de 5 anos de idade na população

DEM.1.04 – Proportion of children under five years of age in the population

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de pessoas com menos de 5 anos de idade na população total residente, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a participação relativa do segmento populacional de menores de 5 anos de idade no total da população.
- Está associado aos níveis de fecundidade e natalidade, que repercutem na estrutura etária da população.
- Regiões com taxas de fecundidade reduzidas apresentam menor proporção de pessoas com menos de 5 anos de idade.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição de pessoas com menos de 5 anos de idade.
- Contribuir para o planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas à saúde, educação e assistência social de pessoas menores de 5 anos de idade, bem como para políticas que visem atender às necessidades específicas desse grupo etário, como a vacinação e o acesso à educação infantil.

LIMITAÇÕES

- Imprecisões da base de dados utilizada para o cálculo do indicador, relacionadas a falhas na declaração da idade nos levantamentos estatísticos ou à metodologia empregada para elaborar estimativas e projeções populacionais, especialmente para municípios de pequeno porte populacional e para recortes demográficos específicos.
- Como toda proporção, a variação do indicador pode não estar relacionada a mudanças na categoria em estudo, mas sim à alteração das demais categorias.

FONTES DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções¹.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População residente com menos de 5 anos de idade, em um local e ano de referência}}{\text{População residente total, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: População residente de menores de 5 anos de idade.
- Denominador: População residente total.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).
- Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A proporção de crianças menores de 5 anos na população brasileira e nas regiões, entre 2000 e 2024, mostra uma tendência de declínio contínuo em todo o país, refletindo a queda nos níveis de fecundidade.

Essa proporção é menor nas regiões Sudeste e Sul, que iniciaram o processo de transição demográfica antes das demais regiões (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) de menores de 5 anos de idade na população.
Brasil e regiões, 2000, 2010, 2020 e 2024

Brasil e regiões	2000	2010	2020	2024
Brasil	9,9	7,7	6,9	6,1
Norte	13,3	10,4	8,6	7,8
Nordeste	10,9	8,5	7,1	6,4
Sudeste	8,9	6,9	6,4	5,6
Sul	8,8	6,7	6,5	5,9
Centro-Oeste	10,3	8,0	7,4	6,7

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
2. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.1.04 – Proporção de menores de 5 anos de idade na população [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18258269



Demográfico



DEM.1.05 – Proporção de pessoas idosas na população

DEM.1.05 – Proportion of older persons in the population

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de pessoas com 60 anos ou mais de idade, na população total residente, em um local e ano de referência.
- A legislação brasileira estabelece como pessoa idosa aquela com idade igual ou superior a 60 anos¹. Outros países podem adotar outro recorte de idade para a definição de pessoa idosa.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a participação relativa de pessoas idosas na população geral.
- Reflete o ritmo de envelhecimento da população.
- O crescimento da participação da população idosa está associado à dinâmica demográfica, podendo ser influenciado pelos seguintes fatores: (i) redução das taxas de fecundidade e de natalidade; (ii) aumento da esperança de vida; e (iii) migração diferenciada por idade.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição de pessoas idosas.
- Contribuir para o planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas à saúde, previdência e assistência social para pessoas idosas, bem como para políticas que visem atender às necessidades específicas das pessoas com 60 anos ou mais de idade em áreas como mobilidade urbana, acessibilidade e adequação de moradias.

LIMITAÇÕES

- Imprecisões na base de dados utilizada para o cálculo do indicador, relacionadas a falhas na declaração da idade nos levantamentos estatísticos ou à metodologia empregada para elaborar estimativas e projeções populacionais, especialmente para municípios de pequeno porte e para recortes demográficos específicos.
- Como toda proporção, a variação do indicador pode não estar relacionada às mudanças da categoria em estudo, mas sim à alteração das demais categorias.

FONTES DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções².
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População residente com mais de 60 anos de idade, em um local e ano de referência}}{\text{População residente total, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: População residente com mais de 60 anos de idade.
- Denominador: População residente total.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).
- Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A proporção de pessoas idosas na população vem apresentando tendência ascendente, em decorrência da redução dos níveis de fecundidade e do aumento da esperança de vida ao nascer.

As maiores proporções são encontradas nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Em todas as regiões, a proporção de mulheres idosas é maior que a de homens idosos (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) de pessoas idosas segundo sexo. Brasil e regiões, 2000, 2010, 2020 e 2024

Brasil e regiões	Masculino				Feminino				Ambos os sexos			
	2000	2010	2020	2024	2000	2010	2020	2024	2000	2010	2020	2024
Brasil	8,0	9,7	13,0	14,5	9,4	11,5	15,6	17,5	8,7	10,6	14,3	16,1
Norte	5,7	6,7	9,1	10,3	5,8	6,8	9,7	11,1	5,7	6,7	9,4	10,7
Nordeste	8,1	9,4	12,0	13,5	9,1	11,0	14,3	16,1	8,6	10,2	13,2	14,8
Sudeste	8,5	10,4	14,2	15,9	10,3	12,8	17,4	19,5	9,4	11,6	15,9	17,8
Sul	8,4	10,7	14,7	16,4	10,1	12,9	17,6	19,7	9,3	11,8	16,2	18,1
Centro-Oeste	6,8	8,4	11,3	12,7	6,8	8,9	12,8	14,7	6,8	8,7	12,1	13,7

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Lei nº 14.423, de 22 de julho de 2022. Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para substituir, em toda a Lei, as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. [Internet]. DOU. 2022 [citado 20 de maio de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14423.htm

2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

3. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/>. doi:10.5281/zenodo.17990183

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.1.05 – Proporção de pessoas idosas na população [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18260152



Demográfico



DEM.1.06 – Índice de envelhecimento

DEM.1.06 – Agin index

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- O índice de envelhecimento (IE) é uma medida da razão entre as pessoas consideradas idosas, aquelas de 60 anos ou mais de idade¹, e a população de pessoas menores de 15 anos de idade, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Indica quantas pessoas idosas há na população, para cada 100 pessoas de 15 anos ou menos de idade.
- Quanto maior o índice, mais envelhecida será a população. Valores acima de 100 indicam predominância de pessoas idosas em relação às faixas etárias de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.

USOS

- Acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento da população, comparativamente, entre áreas geográficas.
- Contribuir para a avaliação de tendências na dinâmica demográfica.
- Subsidiar a formulação, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, assistência social e previdência social.

LIMITAÇÃO

- Imprecisões na base de dados utilizada para o cálculo do indicador, relacionadas a falhas na declaração da idade em levantamentos estatísticos ou à metodologia empregada na elaboração de estimativas e projeções populacionais, especialmente para municípios de pequeno porte e para recortes demográficos específicos.

FONTES DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções².
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População residente com 60 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência}}{\text{População residente com menos de 15 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: População residente com 60 anos ou mais de idade.
- Denominador: População residente com menos de 15 anos de idade.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).
- Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS).

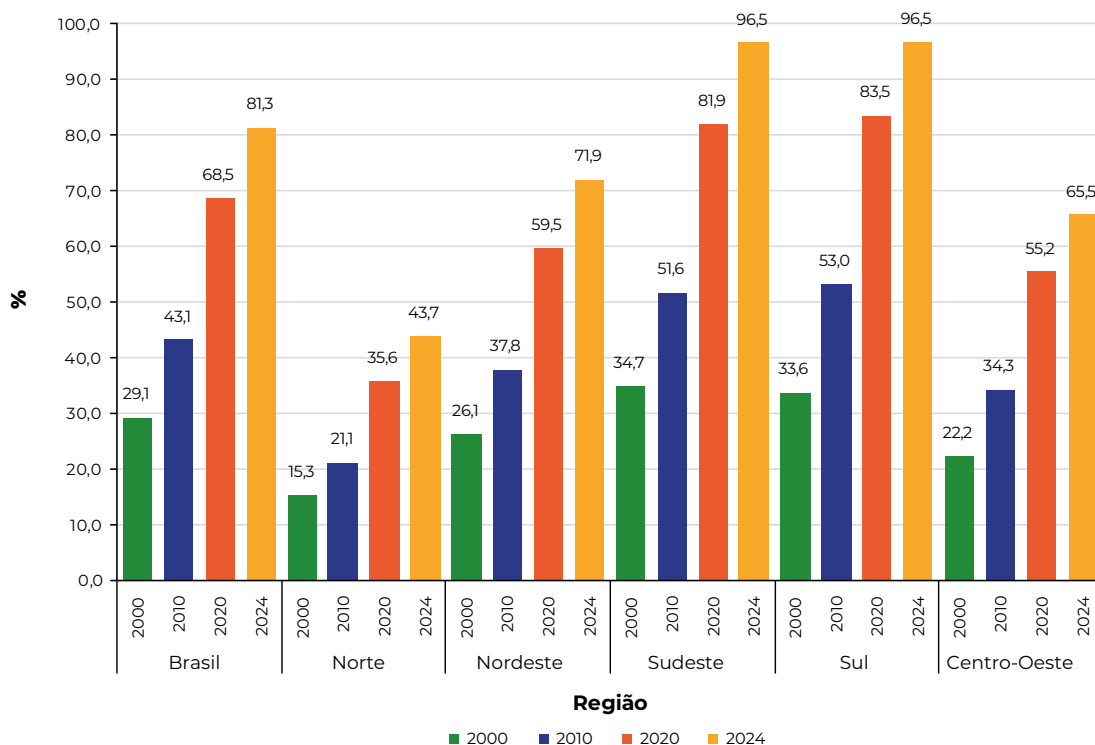
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Nos anos observados (Gráfico 1), constata-se um acelerado crescimento do índice de envelhecimento no Brasil e em todas as regiões. Esse aumento do número de pessoas idosas reflete a diminuição da participação das faixas etárias de idades menores de 15 anos, impulsionada pela queda nas taxas de fecundidade, e o aumento da expectativa de vida da população, indicando o avanço da transição demográfica.

As regiões Sul e Sudeste mantêm índices superiores à média nacional em todos os anos da série histórica analisada, reforçando o processo de envelhecimento populacional mais acentuado nessas regiões.

Gráfico 1 – Índice de envelhecimento. Brasil e regiões, 2000, 2010, 2020 e 2024

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Lei nº 14.423, de 22 de julho de 2022. Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para substituir, em toda a Lei, as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. [Internet]. DOU. 2022 [citado 20 de maio de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14423.htm
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
3. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.1.06 – Índice de envelhecimento [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18260330



Demográfico



DEM.1.07 – Razão de dependência

DEM.1.07 – Dependency ratio

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- A razão de dependência é a relação entre o segmento etário da população definido como potencialmente inativo (pessoas menores de 15 anos de idade e pessoas idosas de 60 anos ou mais) e o segmento etário potencialmente produtivo (pessoas entre 15 e 59 anos de idade), na população residente, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a relação entre o contingente populacional potencialmente inativo (de 0 a 14 anos de idade e 60 anos ou mais) e a população potencialmente produtiva (de 15 a 59 anos de idade).
- Valores em elevação indicam que a população em idade produtiva deverá sustentar uma porção cada vez maior de dependentes, daí resultando maiores gastos sociais e aumento da pressão sobre o orçamento público.

USOS

- Acompanhar a variação da relação entre os grandes grupos etários da população, ao longo do tempo ou entre diferentes regiões.
- Subsidiar a formulação de políticas nas áreas de trabalho, educação, saúde e previdência social.

LIMITAÇÃO

- Imprecisões na base de dados utilizada para o cálculo do indicador, relacionadas a falhas na declaração da idade nos levantamentos estatísticos ou à metodologia empregada na elaboração de estimativas e projeções populacionais.

FONTES DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções¹.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População residente de 0 a 14 anos de idade e de 60 anos ou mais, em um local e ano de referência}}{\text{População residente de 15 a 59 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: População residente de 0 a 14 anos de idade e de 60 anos ou mais.
- Denominador: População residente de 15 a 59 anos de idade.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).
- Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS).

NOTAS

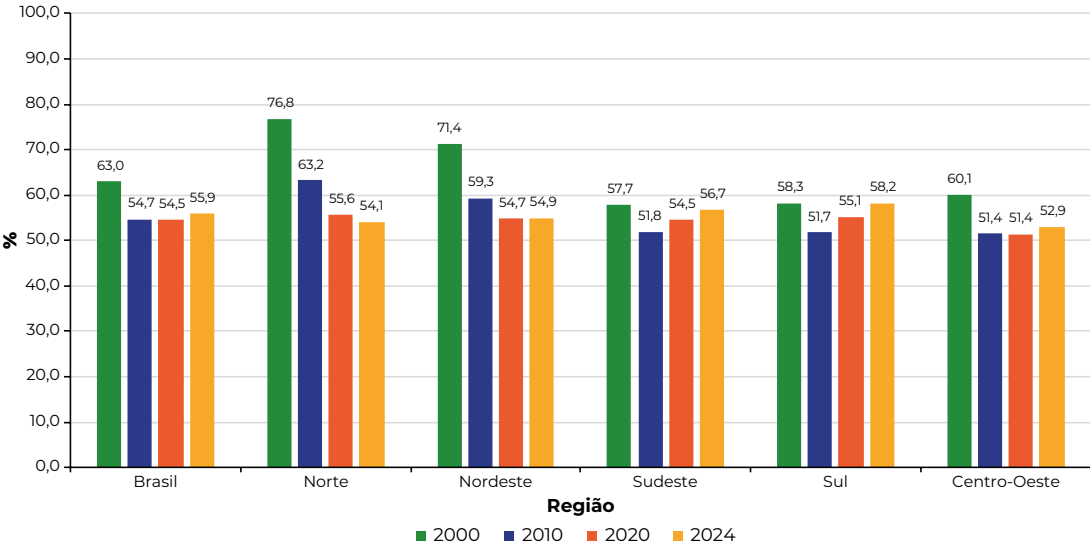
- A razão de dependência pode ser calculada separadamente para as duas faixas etárias identificadas como população dependente: pessoas menores de 15 anos de idade e pessoas idosas³.
- Para calcular a razão de dependência para pessoas menores de 15 anos de idade e a razão de dependência de pessoas idosas, devem-se considerar no numerador, respectivamente, apenas as pessoas menores de 15 anos de idade ou as de 60 anos ou mais. Em ambos os casos, o denominador será a população de 15 a 59 anos de idade.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, a razão de dependência total mostrou-se estável em 2010 e 2022, com leve aumento no ano de 2024. Essa estabilidade foi o resultado da redução do número de nascimentos ao longo do tempo, que se refletiu na população de 0-14 anos, e com o aumento da população acima dos 60 anos. Com o envelhecimento populacional, a tendência é que a razão de dependência aumente ainda mais ao longo do tempo, evidenciando uma relação crescente entre a população potencialmente não produtiva (e cada vez mais envelhecida) e aquela potencialmente produtiva.

As regiões com maiores proporções de população idosa serão aquelas que indicam aumento na razão de dependência desde 2010, como o Sudeste e o Sul. A região Norte, por sua vez, ainda apresentou redução do indicador no ano de 2024, devido à maior diminuição da população de 0-14 anos, relativamente ao aumento da população de 60 anos e mais de idade (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Razão de dependência. Brasil e regiões, 2000, 2010, 2020 e 2024



REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
2. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/> doi:10.5281/zenodo.17990183
3. Brasil. Lei nº 14.423, de 22 de julho de 2022. Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para substituir, em toda a Lei, as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. [Internet]. DOU. 2022 [citado 20 de maio de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14423.htm

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.1.07 – Razão de dependência [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18260445



Demográfico



DEM.2.01 – Taxas específicas de fecundidade

DEM.2.01 – Age-specific fertility rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- As taxas específicas de fecundidade (TEFs) correspondem ao número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher, por faixa etária específica do período reprodutivo, na população residente, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa o número médio de filhos que uma mulher teria em cada idade do período reprodutivo, em um local e ano de referência.
- Usualmente, utilizam-se grupos quinquenais de idade para o cálculo das TEFs.
- A taxa também pode ser apresentada por grupo de mil mulheres em cada faixa etária.
- A soma de todas as TEFs será igual à taxa de fecundidade total (TFT).

USOS

- Subsidiar análises sobre os perfis de concentração da fecundidade por faixa etária.
- Detectar variações nas taxas dos grupos etários.
- Calcular medidas sintéticas de fecundidade, como a TFT, a taxa bruta de reprodução e a taxa líquida de reprodução.
- Possibilitar o estudo dinâmico da fecundidade ao longo do tempo, diferenciando variações de efeitos de período e de coorte.
- Formular hipóteses de projeções populacionais.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação da atenção materno-infantil.

LIMITAÇÕES

- As imprecisões de cálculo das TEFs estão relacionadas à cobertura das bases de dados de nascimentos (e às correções aplicadas às mesmas), sejam elas as Estatísticas do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde (Sinasc/MS).
- Também estão sujeitas a imprecisões as estimativas elaboradas para calcular a população de mulheres expostas ao risco de ter filhos.

FONTE DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: indicadores implícitos¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de filhos nascidos vivos de mulheres de um grupo etário, em um local e ano de referência}}{\text{Total de mulheres do mesmo grupo etário, em um local e ano de referência}}$$

Notas:

- A taxa também pode ser apresentada por grupo de mil mulheres em cada faixa etária.
- Usualmente, calcula-se a TEF por grupos quinquenais de idade.
- O período reprodutivo compreende as idades de 10 a 54 anos.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Total de nascidos vivos, segundo faixa etária específica da mãe.
- Denominador: Total de mulheres na mesma faixa etária.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 10 a 54 anos, de 5 em 5 anos.

GRANULARIDADE

- Unidade da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).

NOTA

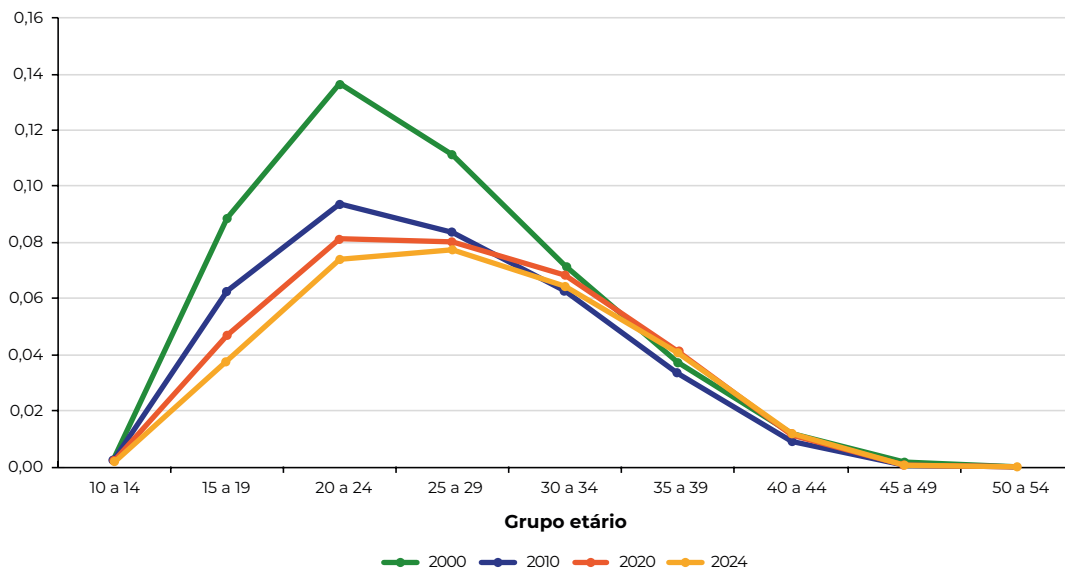
- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A partir da análise das TEFs para o Brasil, verifica-se que houve uma queda expressiva do nível correspondente aos grupos etários de 15 a 29 anos de idade entre os anos de 2000 e 2010 (Gráfico 1). Comparando-se os anos de 2010, 2020 e 2024, a queda das taxas nesses grupos etários ainda acontece, porém em proporções mais reduzidas. Por outro lado, percebe-se, entre 2010 e 2024, uma suave elevação das taxas correspondente às idades a partir de 25 anos.

Ao longo do período analisado, as curvas apontam para um progressivo envelhecimento da fecundidade nacional. A maior taxa específica, para os anos de 2000 e 2010, corresponde ao grupo etário de 20 a 24 anos de idade, enquanto em 2024 o grupo de 25 a 29 anos apresenta taxa ligeiramente maior do que o grupo de 20 a 24 anos.

Gráfico 1 – Taxas específicas de fecundidade. Brasil, 2000, 2010, 2020 e 2024



REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: 2000-2070 - Indicadores Implícitos [Internet]. IBGE. [citado 24 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.2.01 – Taxas específicas de fecundidade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18260601



Demográfico



DEM.2.02 – Taxa de fecundidade total

DEM.2.02 – Total fertility rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- A taxa de fecundidade total (TFT) é o número médio de filhos nascidos vivos que uma mulher sobrevivente ao final de seu período reprodutivo teria, caso ela experimentasse, ao longo de sua vida, o nível de fecundidade apresentado por todas as coortes de mulheres, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa o número médio de filhos que uma mulher, pertencente a uma coorte hipotética, teria se estivesse sujeita às taxas específicas de fecundidade por idade, observadas na população em estudo, em um local e ano de referência.
- É uma medida síntese do nível de fecundidade de uma população.
- Essa medida não é afetada pela estrutura etária da população e, dessa forma, pode ser comparada entre diversos países ou populações.
- TFTs abaixo de 2,1 indicam que a fecundidade está abaixo do nível de reposição da população, ou seja, que as próximas gerações serão menores que as gerações anteriores, que as geraram.
- A redução histórica das TFTs, observada em muitos países, possui como determinantes fatores diversos, como a urbanização da população, a maior escolaridade das mulheres, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e o acesso a métodos contraceptivos.

USOS

- Avaliar tendências da dinâmica demográfica e realizar estudos comparativos entre diferentes áreas geográficas e grupos sociais.
- Realizar projeções de população, levando-se em conta hipóteses sobre tendências de comportamento futuro da fecundidade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, trabalho e previdência social, utilizando-se projeções demográficas que orientem o redimensionamento da oferta de serviços, entre outras aplicações.

LIMITAÇÕES

- As imprecisões de cálculo das taxas de fecundidade total (TFTs) estão relacionadas à cobertura das bases de dados de nascimentos (e às correções aplicadas às mesmas), sejam elas as Estatísticas do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde (Sinasc/MS).
- Também estão sujeitas a imprecisões as estimativas elaboradas para o cálculo da população de mulheres exposta ao risco de ter filhos.

FONTE DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: indicadores implícitos¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$TFT = 5 \times \sum_{x=10-14}^{50-54} TEF_x$$

Nota:

- Na fórmula, TEF_x é a taxa específica de fecundidade do grupo etário quinquenal x .

MÉTODO DE CÁLCULO

- A TFT é obtida pelo somatório das TEFs das mulheres residentes que estão no período reprodutivo, na faixa etária de 10 a 54 anos de idade.
- As TEFs, por sua vez, expressam o número de filhos nascidos vivos por mulher em cada idade do período reprodutivo.
- Usualmente, grupos de idade quinquenais são utilizados no cálculo das TEFs. Caso o grupo quinquenal seja utilizado, deve-se multiplicar o somatório das taxas específicas por 5.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Unidade da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No período analisado, observa-se uma tendência de declínio das TFTs, tanto para o Brasil como para cada uma das suas cinco regiões (Tabela 1). No Brasil, estima-se que, em 2000, as mulheres tinham em média 2,3 filhos, enquanto em 2024 os dados indicam o total de 1,5 filho por mulher. Verifica-se que a queda ocorreu com maior intensidade nas regiões Norte e Nordeste, que entraram mais tardiamente no processo de transição da fecundidade².

Em 2000, enquanto na região Norte as mulheres tinham, em média, mais de 3 filhos ao final do seu período reprodutivo, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste já apresentavam patamar de fecundidade similar ao nível de reposição (2,1 filhos por mulher). Em 2024, observa-se que as TFTs, para todas as regiões, estavam abaixo de 2,0, com valores que indicam uma tendência de convergência no comportamento da fecundidade entre as diferentes regiões do Brasil.

Tabela 1 – Taxa de fecundidade total. Brasil e regiões, 2000, 2010, 2020 e 2024

Brasil e regiões	2000	2010	2020	2024
Brasil	2,3	1,7	1,7	1,5
Norte	3,2	2,2	2,0	1,8
Nordeste	2,6	1,8	1,7	1,5
Sudeste	2,1	1,6	1,6	1,5
Sul	2,1	1,6	1,6	1,5
Centro-Oeste	2,1	1,7	1,8	1,7

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: 2000-2070 - Indicadores Implícitos - [Internet]. IBGE. [citado 24 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

2. Quaresma Gonçalves G, Alberto Magno de Carvalho J, Lídia Rodríguez Wong L, Maldonado Turra C. A transição da fecundidade no Brasil ao longo do século XX – uma perspectiva regional. R Bras Est Pop, v [Internet]. 2019 [citado 20 de maio de 2025];36:1–34. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.20947/S0102-3098a0098>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.2.02 – Taxa de fecundidade total [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18260876



Demográfico



DEM.2.03 – Taxa bruta de natalidade

DEM.2.03 – Crude birth rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- A taxa bruta de natalidade (TBN) é o número de nascidos vivos, por mil habitantes, na população residente, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a intensidade da natalidade em uma determinada população, no ano de referência.
- Em geral, taxas elevadas estão associadas a condições socioeconômicas precárias e a aspectos culturais da população.

USOS

- Possibilitar o cálculo do crescimento vegetativo ou natural da população, subtraindo-se a taxa bruta de mortalidade (TBM) da TBN.
- Contribuir para a estimativa do componente migratório da variação demográfica, correlacionando o crescimento vegetativo com o crescimento total da população.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas, sobretudo as relativas à atenção materno-infantil.

LIMITAÇÕES

- Devido à subenumeração de dados de nascimentos em muitas áreas do país, o número de nascidos vivos obtido de sistemas de registro contínuo – como as Estatísticas do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde (Sinasc/MS) – está sujeito a correções.
- As estimativas populacionais utilizadas para o cálculo do indicador podem apresentar imprecisões relacionadas à coleta de dados ou à metodologia empregada em sua elaboração.
- As estimativas e projeções populacionais perdem precisão à medida que se distanciam do ano do último levantamento censitário.
- A TBN é influenciada pela estrutura da população quanto à idade e ao sexo. Por isso, não deve ser usada para comparações temporais ou entre espaços geográficos.
- A TBN não expressa o nível de fecundidade de uma população, pois a fecundidade é medida a partir do número de nascimentos em relação às mulheres em idade reprodutiva.

FONTE DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número total de nascidos vivos de residentes, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e no meio do ano de referência}} \times 1.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Total de nascidos vivos de residentes.
- Denominador: População total residente.
- Multiplicador: 1.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Unidade da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).

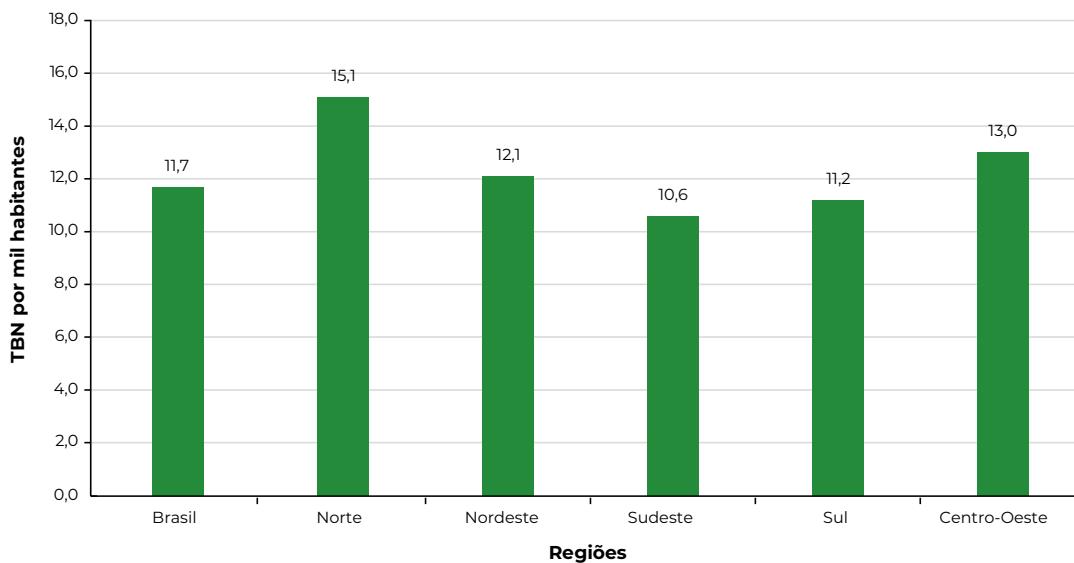
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No ano analisado (2024), a TBN para o Brasil corresponde a 11,7 nascimentos por mil habitantes (Gráfico 1). Os resultados por região do Brasil indicam que a maior taxa é de 15,1 nascimentos para cada mil habitantes, na região Norte, e a menor corresponde a 10,6, na região Sudeste.

É importante salientar que a TBN não deve ser considerada para comparação do nível de fecundidade (número médio de filhos por mulher) de uma população. Para esse objetivo, deve-se utilizar a taxa de fecundidade total.

Gráfico 1 – Taxa bruta de natalidade. Brasil e regiões, 2024

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação. Estimativas e Projeções [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.2.03 – Taxa bruta de natalidade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18260978



Demográfico



DEM.3.01 – Taxas específicas de mortalidade por idade e sexo

DEM.3.01 – Specific mortality rates for age and sex

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de óbitos ocorridos por idade e sexo, em relação à população média na mesma idade, sexo e ano de referência. A população média, usualmente estimada no meio do ano de análise, representa o número total de anos-pessoa vividos em exposição ao risco de morte, segundo idade e sexo, no ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima o risco ou a intensidade de morte, em uma determinada idade, considerando-se o sexo e o ano de referência.

USOS

- Analisar e comparar a estrutura de mortalidade por idade e sexo da população em um determinado ano de referência, entre diferentes populações, áreas geográficas distintas ou ao longo do tempo.
- Construir tábuas de vida ou de mortalidade de período.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relativas à atenção à saúde da população, em diferentes grupos etários e sexos.

LIMITAÇÕES

- Devido às dificuldades de obter o tempo total em que as pessoas estiveram expostas ao risco de morte, por idade e sexo, em um determinado período de referência (denominadores das taxas), utiliza-se a população estimada para o meio do ano de análise. Tal aproximação é razoável sob a hipótese de que os óbitos, segundo idade e sexo, ocorrem uniformemente, do início ao fim do ano de análise.
- Em função da subenumeração dos registros de óbitos diferenciados por idade e sexo em muitas áreas do país, o número de óbitos, obtidos de sistemas de registro contínuo – como as Estatísticas do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS) –, está sujeito a correções ou ajustes, em especial nas idades mais avançadas.
- A população de referência, denominador da taxa específica de mortalidade, pode também conter erros de declaração e subenumeração, diferenciados por idade e sexo.

- As taxas específicas de mortalidade podem apresentar grandes flutuações quando se observa um pequeno número de óbitos, limitando a análise comparativa.

FONTE DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: tábuas de mortalidade¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos nas idades de } x \text{ a } x + n \text{ do sexo } s \text{ no ano } t \text{ de referência} \times \text{fator de correção}}{\text{População no meio do ano } t \text{ de referência nas idades de } x \text{ a } x + n \text{ do sexo } s}$$

Nota:

- Na fórmula, n determina o tamanho do intervalo etário de análise, x determina a idade inferior do intervalo etário, e s , o sexo.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Devido às limitações dos dados de óbitos e população nas idades mais avançadas, para o cálculo das taxas específicas de mortalidade, adota-se o método sugerido pelo IBGE na revisão das tábuas de mortalidade por Unidade da Federação, de acordo com as projeções das populações do Brasil e Unidades da Federação, revisão 2024. Até a idade de 64 anos, as taxas de mortalidade são calculadas com os óbitos ajustados pelo nível de sub-registro. A partir de 65 anos, são utilizados outros métodos para ajustar o padrão das taxas de mortalidade. Para detalhes sobre o método, podem-se consultar as notas metodológicas das projeções da população do Brasil e Unidades da Federação².

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 79 anos, de 5 em 5 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Unidade da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).

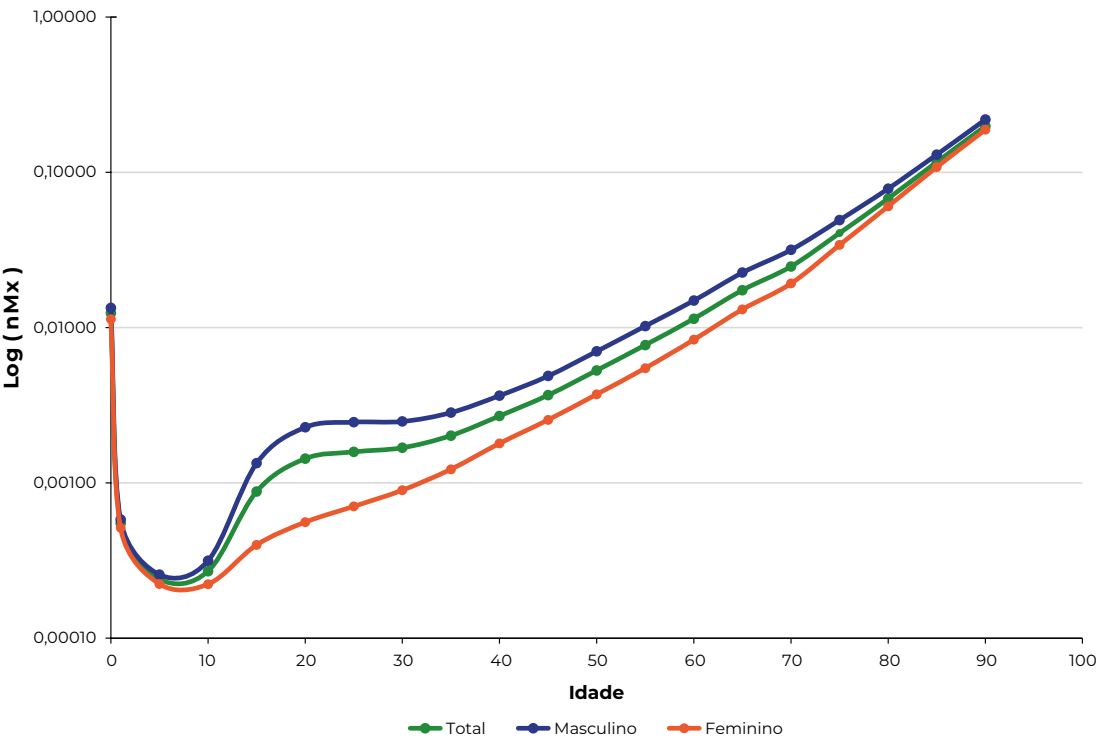
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

As taxas específicas de mortalidade fornecem o nível e o padrão de mortalidade. O logaritmo das taxas específicas de mortalidade acentua as diferenças das taxas por idade, permitindo a análise do diferencial da curva entre os diversos grupos etários. No Gráfico 1, é possível verificar a maior taxa de mortalidade de 0 a 1 ano de idade para ambos os sexos, que se reduz até os 10 anos de idade, quando começa a crescer. Observa-se maior mortalidade dos homens em relação às mulheres em todos os grupos etários, especialmente entre 15 e 29 anos de idade, faixa etária afetada por mortes de causas não naturais. A partir dessas idades, as taxas específicas crescem de acordo com o aumento da idade, em ambos os sexos.

Gráfico 1 – Taxas específicas de mortalidade por sexo e idade, em escala logarítmica. Brasil, 2024



REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: 2000-2070 - Tábuas de Mortalidade [Internet]. IBGE. 2024 [citado 20 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=resultados>

2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da população: Brasil e Unidades da Federação: estimativas e projeções: revisão 2024. IBGE [Internet] 2025. 87 p. (Relatórios metodológicos, ISSN 0101-2843, v. 40). Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102219.pdf>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.3.01 – Taxas específicas de mortalidade por idade e sexo [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18261271



Demográfico



DEM.3.02 – Taxa bruta de mortalidade

DEM.3.02 – Crude death rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- A taxa bruta de mortalidade (TBM) é calculada pelo número total de óbitos, por mil habitantes, na população residente, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a intensidade da mortalidade em uma determinada população, em um ano de referência.
- Taxas elevadas podem estar associadas a baixas condições socioeconômicas ou refletir elevada proporção de pessoas idosas na população total.

USOS

- Possibilitar o cálculo do crescimento vegetativo ou natural da população, subtraindo-se, da taxa bruta de natalidade (TBN), a TBM.
- Contribuir para estimar o componente migratório da variação demográfica, correlacionando-se o crescimento vegetativo com o crescimento total da população.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relativas à atenção à saúde da população.

LIMITAÇÕES

- A TBM pode apresentar grandes flutuações quando se observa pequeno número de óbitos, limitando a análise.
- Em função do sub-registro de óbitos diferenciado por idade e sexo e de erros na informação de idade das pessoas, em muitas áreas do país, o número de óbitos obtidos de sistemas de registro contínuo – como as Estatísticas do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS) – está sujeito a correções ou ajustes, em especial nas idades mais avançadas.
- A população de referência, denominador da TBM, pode também conter erros de subenumeração, diferenciados por idade e sexo.
- As estimativas populacionais utilizadas para o cálculo do indicador podem apresentar imprecisões inerentes à coleta de dados ou à metodologia empregada para sua elaboração.

- As estimativas e projeções populacionais perdem precisão à medida que se distanciam do ano do último levantamento censitário.
- Como a taxa é fortemente influenciada pela estrutura etária da população, a análise comparada entre populações de composição etária distinta exige a padronização dessas estruturas. As taxas padronizadas devem ser utilizadas apenas para análises comparativas (ver indicador de TBM padronizada).

FONTE DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número total de óbitos de residentes, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e no meio do ano de referência}} \times 1.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Óbitos totais.
- Denominador: População residente total.
- Multiplicador: 1.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Unidade da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No período apresentado (Tabela 1), observam-se valores decrescentes da TBM para todas as regiões brasileiras até o ano de 2010. O aumento em 2020, para taxas brutas próximas ou superiores às do início do período, em todas as regiões, é um indício do impacto da pandemia ocorrida nos anos de 2020 e 2021².

Entretanto, para efeitos de comparação temporal ou entre regiões, essas taxas precisam ser padronizadas, conforme argumentos apresentados nas limitações desta ficha.

Ademais, indicadores de mortalidade específicos por idade devem ser considerados para uma análise mais detalhada dos níveis de mortalidade.

Tabela 1 – Taxas brutas de mortalidade. Brasil e regiões, 2000, 2010, 2020 e 2024

Brasil e regiões	2000	2010	2020	2024
Brasil	6,42	6,19	7,58	7,10
Norte	5,55	4,69	6,11	5,29
Nordeste	6,84	6,14	7,60	6,97
Sudeste	6,59	6,56	8,11	7,66
Sul	6,10	6,54	7,40	7,40
Centro-Oeste	5,29	5,28	6,59	6,05

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102219>
2. Lima EEC, Vilela EA, Peralta A, Rocha M, Queiroz BL, Gonzaga MR, et al. Investigating regional excess mortality during 2020 COVID-19 pandemic in selected Latin American countries. Genus [Internet]. 1º de dezembro de 2021 [citado 11 de junho de 2025];77(1):1–20. Disponível em: <https://genus.springeropen.com/articles/10.1186/s41118-021-00139-1>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.3.02 – Taxa bruta de mortalidade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18261326



Demográfico



DEM.3.03 – Taxa de mortalidade padronizada por idade

DEM.3.03 – Age-standardized death rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número total de óbitos esperado por mil habitantes, em um local e ano de referência, caso a população em estudo tenha a mesma estrutura etária de uma população-padrão.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a intensidade da mortalidade em uma determinada população, em um local e ano de referência, caso a estrutura dessa população, por sexo e idade, seja igual à de uma população-padrão.
- Uma vez que a taxa bruta de mortalidade (TBM) é influenciada pela estrutura da população quanto à idade e ao sexo, a padronização por uma população-padrão é uma solução para comparações temporais ou entre espaços geográficos.

USOS

- Analisar as variações geográficas e temporais da mortalidade em situações em que as estruturas das populações por idade e sexo, em estudo, são diferentes.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relativas à atenção à saúde da população.

LIMITAÇÕES

- Em função da subenumeração dos registros em muitas áreas do país, o número de óbitos obtido a partir de sistemas de registro contínuo – como as Estatísticas do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS) – está sujeito a correções.
- As taxas de mortalidade padronizadas por idade devem ser utilizadas apenas para análises comparativas, quando o objetivo for eliminar o efeito que diferentes estruturas etárias podem ter sobre as TBMs. Elas não expressam o valor verdadeiro das taxas brutas ou específicas de um local e período de referência.
- O cálculo do indicador taxa de mortalidade padronizada por idade demanda o conhecimento das taxas específicas de mortalidade por idade.

FONTE DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\sum_{x=0}^w n \text{TEM}_x^s \times n N_x}{\sum_{x=0}^w n N_x}$$

Nota:

- Na fórmula, $n \text{TEM}_x^s$ representa a taxa específica de mortalidade da população em análise, por sexo (s), no grupo etário (x); e $n N_x$ representa a população escolhida como padrão, no grupo etário (x), onde n representa o número de anos do intervalo etário, x é a idade exata do limite inferior do intervalo etário e w a idade máxima de vida na população.

MÉTODO DE CÁLCULO

- A taxa de mortalidade padronizada por idade é obtida pelo somatório da multiplicação das taxas específicas de mortalidade da população em análise, de cada grupo etário, por sexo, pelos mesmos grupos etários da população tomada como padrão, dividido pela população-padrão total.
- Recomenda-se que as taxas específicas de mortalidade utilizadas sejam previamente ajustadas em função de sub-registros de óbitos ou outros tipos de erros, conforme apresentado na TBM.
- Para o cálculo das taxas padronizadas, utilizou-se, como padrão, a população do Brasil por grupos de idade, do ano de 2022, de acordo com a projeção das populações, revisão 2024, divulgada pelo IBGE¹.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Unidade da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No período apresentado, diferentemente do que ocorre com a TBM, observam-se valores decrescentes das taxas padronizadas para as regiões brasileiras entre 2000 e 2024 (Tabela 1). Os dados padronizados indicam níveis de mortalidade mais elevados nas regiões Nordeste e Norte, na maioria dos anos analisados.

No período de 2010 a 2020, o ritmo de declínio nas taxas padronizadas foi menor, ou aumentou em algumas regiões, o que pode indicar um efeito da pandemia para o nível geral de mortalidade².

Entretanto, indicadores de mortalidade específicos por idade (como a esperança de vida) devem ser considerados para uma análise mais detalhada dos níveis de mortalidade.

Tabela 1 – Taxas brutas de mortalidade (TBMs) e taxas de mortalidade padronizada (TMPs).
Brasil e regiões, 2000, 2010, 2020 e 2024

Brasil e regiões	2000		2010		2020		2024	
	TBMs	TMPs	TBMs	TMPs	TBMs	TMPs	TBMs	TMPs
Brasil	6,42	9,41	6,19	7,93	7,58	7,90	7,10	6,83
Norte	5,55	9,79	4,69	7,92	6,11	8,92	5,29	7,02
Nordeste	6,84	9,51	6,14	7,80	7,60	8,14	6,97	6,92
Sudeste	6,59	9,39	6,56	7,94	8,11	7,82	7,66	6,80
Sul	6,10	9,09	6,54	8,03	7,40	7,22	7,40	6,62
Centro-Oeste	5,29	9,18	5,28	7,96	6,59	8,05	6,05	6,74

Nota:

- Para o cálculo das taxas padronizadas, utilizou-se como padrão a população do Brasil por grupos de idade, do ano de 2022, obtida da projeção das populações, revisão 2024¹, divulgada pelo IBGE.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
2. Lima EEC, Vilela EA, Peralta A, Rocha M, Queiroz BL, Gonzaga MR, et al. Investigating regional excess mortality during 2020 COVID-19 pandemic in selected Latin American countries. Genus [Internet]. 1º de dezembro de 2021 [citado 11 de junho de 2025];77(1):1–20. Disponível em: <https://genus.springeropen.com/articles/10.1186/s41118-021-00139-1>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.3.03 – Taxa de mortalidade padronizada por idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18261416



Demográfico



DEM.3.04 – Esperança de vida ao nascer

DEM.3.04 – Life expectancy at birth

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- A esperança de vida ao nascer, também conhecida como expectativa de vida, é o número médio de anos que se espera que um recém-nascido viva, mantidas constantes as taxas de mortalidade observadas na população residente, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa o número médio de anos que se espera que um recém-nascido viva nessa população, a partir de seu nascimento, mantidas constantes as taxas de mortalidade observadas naquele momento.
- Representa uma medida sintética da mortalidade, não sendo afetada pelos efeitos da estrutura etária da população, como acontece com a taxa bruta de mortalidade.
- Trata-se de uma medida útil para comparação dos níveis de mortalidade entre populações ou de uma mesma população ao longo do tempo.
- O aumento da esperança de vida ao nascer sugere melhoria das condições de vida e de saúde da população.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais nos níveis de mortalidade da população.
- Contribuir para a avaliação das condições de vida e de saúde da população.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas de saúde e de previdência social, entre outras, relacionadas ao aumento da expectativa de vida ao nascer (oferta de serviços, atualização de metas, cálculos atuariais).

LIMITAÇÕES

- Imprecisões relacionadas à cobertura do registro de óbitos e da população, assim como falhas na declaração da idade nos levantamentos estatísticos ou na metodologia empregada para elaborar estimativas e projeções populacionais na base de dados utilizada para o cálculo do indicador.
- Para o cálculo da esperança de vida, são exigidas informações confiáveis sobre óbitos por idade.
- Quando a precisão dos dados dos sistemas de registro contínuo não é satisfatória, correções devem ser realizadas.

FONTE DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: tábuas de mortalidade¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

- Não se aplica.

MÉTODO DE CÁLCULO

- A esperança de vida ao nascer é calculada a partir de tábuas de vida (ou tábuas de mortalidade), construídas com base nas taxas específicas de mortalidade para cada ano e região geográfica.
- A partir de uma série de taxas específicas de mortalidade por idade, calculam-se as várias funções da tábua de vida (ou de mortalidade), incluindo-se a esperança de vida.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Unidade da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).

NOTA

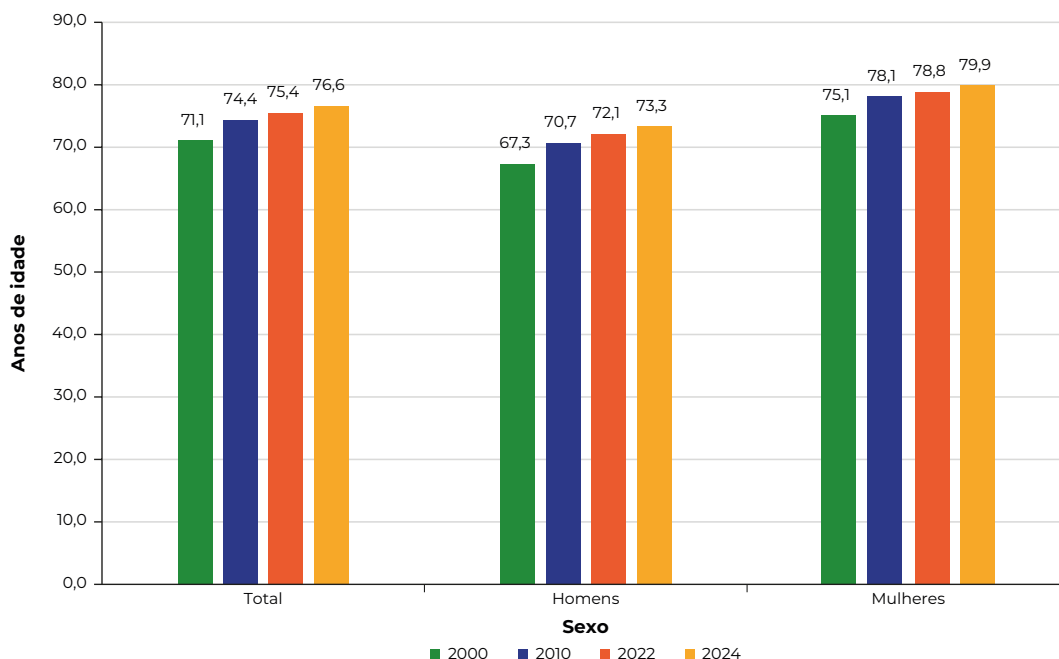
- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A esperança de vida ao nascer vem aumentando no Brasil, tanto para homens, quanto para mulheres.

Em 2000, para a média de ambos os sexos, um recém-nascido sujeito à lei de mortalidade da época, ao longo de sua vida, esperaria viver em média 71,1 anos. Por sua vez, em 2024, ele esperaria viver em média 76,6 anos, verificando-se um acréscimo de 5,5 anos neste período de 24 anos.

As mulheres têm expectativa de vida nitidamente mais elevada, devido à sobremortalidade masculina em todos os grupos de idade (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Esperança de vida ao nascer, segundo sexo. Brasil, 2000, 2010, 2022 e 2024

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: 2000-2070 – Tábuas de Mortalidade [Internet]. IBGE. 2024 [citado 20 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=resultados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.3.04 – Esperança de vida ao nascer [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18261641



Demográfico



DEM.3.05 – Esperança de vida aos 60 anos de idade

DEM.3.05 – Life expectancy at age 60

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número médio de anos de vida esperados para uma pessoa ao completar 60 anos de idade, mantidas constantes as taxas de mortalidade observadas na população residente, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa o número médio de anos que se espera que uma pessoa de 60 anos de idade viva a partir dessa idade, mantidas constantes as taxas de mortalidade observadas naquele momento.
- Representa uma medida sintética da mortalidade, não sendo afetada pelos efeitos da estrutura etária da população, como acontece com a taxa bruta de mortalidade.
- Trata-se de uma medida útil para a comparação dos níveis de mortalidade entre populações ou de uma mesma população ao longo do tempo.
- O aumento da esperança de vida aos 60 anos de idade sugere melhoria das condições de vida e de saúde da população.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais nos níveis de mortalidade da população.
- Contribuir para a avaliação das condições de vida e de saúde da população.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas de saúde e de previdência social, entre outras, relacionadas ao aumento da expectativa de vida aos 60 anos de idade (oferta de serviços, atualização de metas, cálculos atuariais).

LIMITAÇÕES

- Imprecisões relacionadas à cobertura do registro de óbitos e da população, assim como falhas na declaração da idade nos levantamentos estatísticos ou na metodologia empregada para elaborar estimativas e projeções populacionais na base de dados utilizada para o cálculo do indicador.
- Para o cálculo da esperança de vida, são exigidas informações confiáveis sobre óbitos por idade. Quando a precisão dos dados dos sistemas de registro contínuo não é satisfatória, correções devem ser realizadas.

FONTE DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: tábuas de mortalidade¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

- Não se aplica.

MÉTODO DE CÁLCULO

- A esperança de vida aos 60 anos de idade é calculada com base em tábuas de vida (ou tábuas de mortalidade) construídas a partir das taxas específicas de mortalidade, para cada local e ano de referência.
- A partir de uma série de taxas específicas de mortalidade por idade, calculam-se as várias funções da tábua de vida (ou de mortalidade), incluindo-se a esperança de vida.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Unidade da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A esperança de vida aos 60 anos de idade vem aumentando em todas as regiões do Brasil e em ambos os sexos. Um indivíduo de 60 anos de idade que, em 2000, esperaria viver em média 20,1 anos, em 2024, esperaria viver 22,6 anos, em média, representando um acréscimo de 2,5 anos.

Os maiores ganhos são observados na região Sul (2,9 anos) e os menores na região Nordeste (2,3 anos) (Tabela 1).

Tabela 1 – Esperança de vida aos 60 anos de idade, por sexo. Brasil e regiões, 2000 e 2024

Brasil e regiões	Masculino		Feminino		Total	
	2000	2024	2000	2024	2000	2024
Brasil	18,4	20,8	21,7	24,2	20,1	22,6
Norte	18,7	21,1	21,1	23,9	19,8	22,5
Nordeste	19,2	21,1	21,7	24,3	20,5	22,8
Sudeste	18,0	20,6	21,8	24,0	20,0	22,4
Sul	17,7	20,7	21,7	24,3	19,7	22,6
Centro-Oeste	18,9	20,9	21,7	24,4	20,2	22,7

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: 2000-2070 - Tábuas de Mortalidade [Internet]. IBGE. 2024 [citado 20 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=resultados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.3.05 – Esperança de vida aos 60 anos de idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18261677



Demográfico



DEM.4.01 – Cobertura do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)

DEM.4.01 – Coverage of the Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos (Sinasc)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Razão entre o número de notificações de nascidos vivos no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) em relação ao número estimado de nascidos vivos, em um local e ano de referência.
- “Nascido vivo” é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como produto de concepção, que, após a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, tal como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendido da placenta¹.
- As estimativas de nascidos vivos são produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nas projeções da população, que utiliza, a partir do ano de 2015, o resultado do estudo de pareamento entre as bases de dados das estatísticas do Registro Civil e do Sinasc e aplicação do método de captura-recaptura².

INTERPRETAÇÃO

- Quanto mais próxima de 100% for a cobertura, melhor será a qualidade das informações sobre nascimentos, ou seja, maior será a coincidência entre o número de nascidos vivos notificados ao Sinasc e o total de nascimentos estimados.

USOS

- Descrever variações geográficas e temporais da cobertura do Sinasc.
- Indicar áreas geográficas com baixas coberturas e contribuir para o desenvolvimento de ações de busca ativa e o direcionamento de ações voltadas para a redução da subnotificação de nascidos vivos.
- Possibilitar o cálculo de fatores de correção para o número de nascidos vivos notificados no Sinasc.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação do Sinasc.

LIMITAÇÕES

- Limites de acurácia inerentes às metodologias utilizadas nas estimativas do total de nascimentos, que compõem o denominador, podem comprometer a validade do indicador.

- O comprometimento da validade do indicador é maior no caso de pequeno número de eventos, o que ocorre principalmente nos municípios de pequeno porte populacional.
- Projeções populacionais perdem precisão à medida que se distanciam do último levantamento censitário.
- O cálculo da cobertura do Sinasc para os municípios, conforme divulgado pelo IBGE, está disponível apenas a partir do ano de 2015.

FONTES DE DADOS

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções³.
- Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos através do método de captura e recaptura⁴.
- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de nascidos vivos informado no Sinasc, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de nascidos vivos, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de nascidos vivos informados no Sinasc, conforme local de residência da mãe.
- Denominador: (i) Para as Unidades da Federação, o número estimado de nascidos vivos é obtido a partir das projeções da população do Brasil e Unidades da Federação³; e (ii) Para os municípios, a série histórica se inicia em 2015. O número estimado de nascidos vivos é obtido a partir da estimativa de sub-registro, que utiliza a técnica de captura-recaptura⁴.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Unidade da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Quanto maior a cobertura do Sinasc, menor será a subnotificação de nascidos vivos nesse sistema. Coberturas próximas a 100% apontam o caráter praticamente universal da notificação de nascidos vivos (Tabela 1).

Tabela 1 – Cobertura (%) de nascidos vivos¹ informados ao Sinasc. Brasil e regiões, 2017 e 2022

Brasil e regiões	2017		2022	
	Total estimado de nascidos vivos	Cobertura do Sinasc	Total estimado de nascidos vivos	Cobertura do Sinasc
Brasil	2.949.798	99,1	2.574.556	99,5
Norte	319.439	97,9	291.168	99,3
Nordeste	828.242	98,6	714.317	99,2
Sudeste	1.156.702	99,6	982.972	99,7
Sul	398.797	99,7	360.589	99,8
Centro-Oeste	246.493	99,2	225.404	99,5

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Declaração de Nascido Vivo: Manual de instruções para preenchimento [Internet]. 4.ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2022 [citado 11 de junho de 2025]. Disponível em: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_nascido_vivo_manual_4ed.pdf
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos: estimativas desagregadas dos totais de nascidos vivos e óbitos: 2016-2019. IBGE [Internet]. 2016 [citado 1º de abril de 2025]; 2022:1–36. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101927.pdf>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pareamento das Estatísticas do Registro Civil e dos Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos e Mortalidade (Sinasc e SIM): aplicação da Técnica de Captura-Recaptura para estimativa dos totais de nascidos vivos e óbitos. 2019. Nota metodológica n. 01. IBGE [Internet]. Dezembro de 2019 [citado 1º de abril de 2025];1. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3098/rc_sev_pe_2015_2016_2017.pdf
5. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.4.01 – Cobertura do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18261790



Demográfico



DEM.4.02 – Cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)

DEM.4.02 – Coverage of the Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Razão entre o número de notificações de óbitos no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)¹, em relação ao número estimado de óbitos, em um local e ano de referência.
- As estimativas do número de óbitos são produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base nas projeções da população², que utiliza, por sua vez, a partir do ano de 2015, além de outras metodologias, o resultado do estudo de pareamento entre as bases de dados da Pesquisa Estatísticas do Registro Civil e do SIM e aplicação do método de captura-recaptura³.

INTERPRETAÇÃO

- Quanto maior a cobertura do SIM, menor será a subnotificação de óbitos nesse sistema. Coberturas próximas a 100% apontam o caráter universal da notificação de óbitos.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais da cobertura do SIM.
- Indicar áreas geográficas com baixas coberturas e contribuir para o desenvolvimento de ações de busca ativa e diminuição da subnotificação de óbitos.
- Possibilitar o cálculo de fatores de correção para os óbitos coletados pelo SIM.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação do SIM.

LIMITAÇÕES

- Imprecisões inerentes às metodologias utilizadas nas estimativas do total de óbitos.
- Limites de acurácia inerentes às metodologias utilizadas nas estimativas do total de óbitos, que compõem o denominador, podem comprometer a validade do indicador.
- O comprometimento da validade do indicador é maior no caso de pequeno número de eventos, o que ocorre principalmente nos municípios de pequeno porte populacional, bem como no recorte demográfico dos óbitos de menores de 1 ano de idade.
- Projeções populacionais perdem precisão à medida que se distanciam do último levantamento censitário.
- O cálculo da cobertura dos óbitos para os municípios, conforme divulgado pelo IBGE², está disponível apenas a partir do ano de 2015.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)¹.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções².
- Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos através do método de captura e recaptura³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de notificações de óbitos no SIM, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de óbitos, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de notificações de óbitos informados pelo SIM¹.
- Denominador: (i) Para as Unidades da Federação, o número estimado de óbitos é obtido a partir das projeções da população do Brasil e Unidades da Federação²; (ii) Para os municípios, a série histórica se inicia em 2015. O número estimado de óbitos é obtido a partir da aplicação do método de captura-recaptura³; (iii) Atenção para o fato de que a soma dos números estimados dos óbitos dos municípios não coincide com as estimativas dos números de óbitos para as respectivas Unidades da Federação, porque se trata de metodologias de estimação distintas. O detalhamento de cada metodologia consta nas referências desta ficha; e (iv) Os óbitos notificados e estimados são considerados segundo local de residência da pessoa que faleceu.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menores de 1 ano; e
- 1 ano ou mais de idade.

Nota:

- Para os municípios, não é possível a desagregação por idade.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Unidade da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Entre os anos de 2017 e 2022, a cobertura do SIM aumentou. Em 2022, a cobertura foi de 98,9% para o Brasil, enquanto nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste as coberturas foram maiores que 99%.

A evolução das coberturas evidencia o aprimoramento da captação da notificação de óbitos no SIM, em todas as regiões brasileiras, mas com necessidade de esforços para aumento das notificações, especialmente nas regiões Norte e Nordeste (Tabela 1).

Tabela 1 – Cobertura (%) de óbitos informados ao Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).
Brasil e regiões, 2017 e 2022

Brasil e regiões	2017		2022	
	Total estimado de óbitos	Cobertura do SIM	Total estimado de óbitos	Cobertura do SIM
Brasil	1.331.048	98,6	1.561.339	98,9
Norte	85.188	96,9	97.594	98,6
Nordeste	362.865	97,2	411.218	98,2
Sudeste	596.856	99,4	701.179	99,2
Sul	199.101	99,4	246.576	99,5
Centro-Oeste	87.037	99,0	104.560	99,2

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pareamento das Estatísticas do Registro Civil e dos Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos e Mortalidade (Sinasc e SIM): aplicação da Técnica de Captura-Recaptura para estimativa dos totais de nascidos vivos e óbitos. 2019. Nota metodológica n. 01. IBGE [Internet]. Dezembro de 2019 [citado 1º de abril de 2025];1. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3098/rc_sev_pe_2015_2016_2017.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Demográficos. DEM.4.02 – Cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18261803





INDICADORES SOCIOECONÔMICOS (SOC)

Indicadores socioeconômicos (SOC)

Os indicadores escolhidos pelo Comitê Gestor de Indicadores Socioeconômicos (CGI Socioeconômico) têm como objetivo oferecer um panorama amplo das condições de vida da população brasileira, trazendo informações indispensáveis para subsidiar o diagnóstico, a implementação, o monitoramento e a avaliação de políticas em saúde.

Com a participação de representantes de cerca de 30 instituições, o CGI Socioeconômico adotou como ponto de partida a revisão dos oito indicadores definidos nas edições anteriores (de 2002 e 2008), que já cobriam temas essenciais, como educação, mercado de trabalho, pobreza, desigualdade e desenvolvimento econômico. Todos esses temas foram mantidos e aprofundados. Os indicadores já existentes passaram por atualizações de suas fontes de dados, bem como por revisões metodológicas e conceituais, de modo a refletirem os padrões nacionais e internacionais mais recentes, e novos indicadores foram introduzidos para caracterização desses temas em nível mais detalhado, sobretudo no que se refere ao mercado de trabalho brasileiro. Além disso, o CGI Socioeconômico incorporou dois outros temas cruciais para as condições de saúde e de bem-estar da população: saneamento básico, representado por três indicadores; e segurança alimentar, expressa por um indicador baseado na Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA).

O resultado é um painel de indicadores (*dashboard*) que permite uma apreciação abrangente da heterogeneidade das condições sociais da população brasileira e a identificação de grupos mais vulneráveis e com maior exposição a riscos. Para isso, os indicadores foram calculados em nível nacional e desagregados tanto por critérios geográficos quanto por critérios socioeconômicos, conforme a disponibilidade de informações, oferecendo subsídios para a formulação e implementação de intervenções direcionadas à redução das desigualdades em saúde.



Dimensão 1 – Educação

- SOC.1.01 – Proporção de analfabetismo na população
- SOC.1.02 – Proporção da população sem educação básica

Dimensão 2 – Ocupação da força de trabalho

- SOC.2.01 – Proporção de desocupação na população
- SOC.2.02 – Proporção da população com força de trabalho subutilizada
- SOC.2.03 – Proporção da população ocupada sem contribuição para a previdência social
- SOC.2.04 – Proporção de jovens que não estudam e não trabalham
- SOC.2.05 – Proporção da população de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil

Dimensão 3 – Renda

- SOC.3.01 – Rendimento domiciliar *per capita* a preços correntes
- SOC.3.02 – Proporção da população abaixo da linha de pobreza
- SOC.3.03 – Coeficiente de Gini da distribuição da renda domiciliar *per capita*
- SOC.3.04 – Razão entre a renda total dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres
- SOC.3.05 – Produto interno bruto *per capita*

Dimensão 4 – Saneamento

- SOC.4.01 – Proporção da população urbana sem acesso seguro à água
- SOC.4.02 – Proporção da população urbana sem instalações sanitárias adequadas
- SOC.4.03 – Proporção da população sem coleta direta ou indireta de lixo

Dimensão 5 – Segurança alimentar

- SOC.5.01 – Proporção da população em situação de insegurança alimentar moderada ou grave



SOC.1.01 – Proporção de analfabetismo na população

SOC.1.01 – Illiteracy rate in the population

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população com 15 anos ou mais de idade em condição de analfabetismo.
- Consideram-se analfabetas as pessoas que não sabem ler e escrever ao menos um bilhete simples no idioma que conhecem¹. A informação é declarada pela própria pessoa ou por outro morador do domicílio ao entrevistador da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)².

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a proporção de pessoas analfabetas na população com 15 anos ou mais de idade, na data da entrevista da PNADC, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência.
- A proporção de pessoas analfabetas, também conhecida como taxa de analfabetismo, deveria ser próxima de zero.
- A Constituição Federal³ estabelece o ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade, e a erradicação do analfabetismo é o primeiro objetivo dos Planos Nacionais de Educação (PNEs). Logo, a alfabetização deveria ocorrer antes dos 15 anos de idade, permanecendo analfabetas apenas as pessoas com impedimentos cognitivos severos.
- O indicador manifesta a dificuldade de acesso das pessoas à educação formal e, consequentemente, à informação e, geralmente, expõe baixos níveis de desenvolvimento social e econômico em um espaço geográfico e/ou a desigualdade entre grupos definidos pelas categorias de análise.

USOS

- Monitorar o cumprimento do que estabelece a Constituição Federal quanto ao ensino obrigatório e à erradicação do analfabetismo.
- Subsidiar análises relativas ao acesso universal à educação básica.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas à educação.
- Comparar populações ou grupos específicos quanto ao acesso à educação básica no tempo e no espaço.

LIMITAÇÕES

- Desde sua proposição pela Comissão de População das Nações Unidas, em 1948, este indicador tem sido criticado pela definição de alfabetização utilizada, a qual considera todos os indivíduos que declaram saber ler e escrever um bilhete simples. Essa conceituação pouco revela sobre o domínio funcional da leitura e escrita (letramento), bem como sobre o da matemática (numeracia), tampouco sobre a suficiência das competências para uma participação social plena.
- O indicador é bastante influenciado pela falta de oportunidades educacionais do passado. A maior longevidade da população, incluindo os grupos mais vulneráveis e menos escolarizados, dilui o efeito positivo sobre o indicador do aumento da escolarização entre as novas coortes de nascimentos. Por esta razão, as análises do indicador segundo faixas etárias devem ser consideradas.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de analfabetos com 15 anos de idade ou mais, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População com 15 anos de idade ou mais, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que as taxas de aproveitamento da coleta foram prejudicadas pela pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos. O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita, conforme a prática do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)⁴.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022⁵.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo IBGE para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.

- Este indicador não precisa dos dados de educação do suplemento do 2º trimestre. Ele pode ser calculado a partir dos dados trimestrais da pesquisa, mas a desagregação por faixa de renda domiciliar por pessoa só pode ser feita a partir das bases de dados anuais da 1ª ou da 5ª visita.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

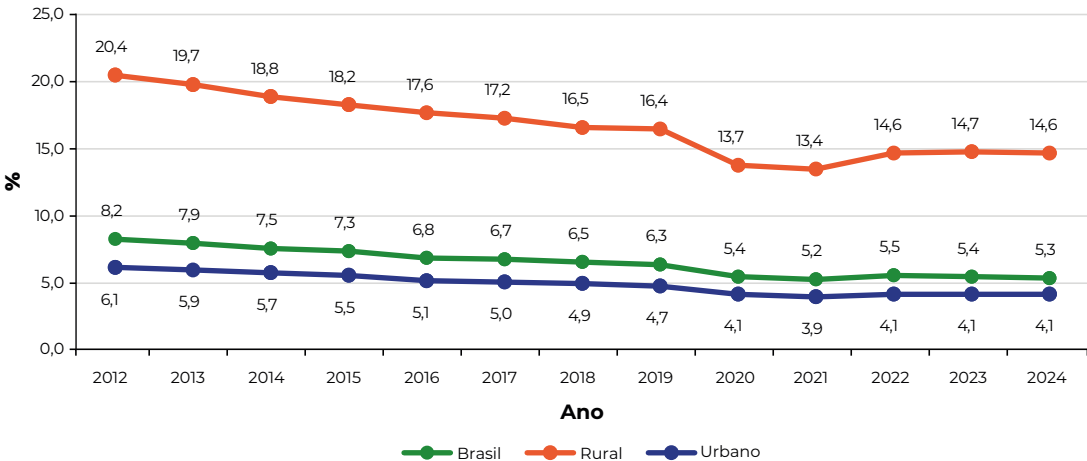
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Houve queda na proporção de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais no Brasil entre 2012 e 2024. No país como um todo, a taxa caiu de 8,2%, em 2012, para 5,3% em 2024. Nas áreas rurais, o indicador foi consistentemente mais alto em comparação com as áreas urbanas. Em 2024, a proporção de pessoas analfabetas nas áreas urbanas foi de 4,1%, enquanto, nas áreas rurais, atingiu 14,6% (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Proporção (%) de analfabetismo na população, por situação do domicílio. Brasil, 2012 a 2024



Notas:

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 2014- 2016. [Internet]. Inep. 2016 [citado 28 de outubro de 2025]. p. 1–590. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/plano_nacional_de_educacao/relatorio_do_primeiro_ciclo_de_monitoramento_das_metas_do_pne_bienio_2014_2016.pdf

2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>
3. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil [Internet]. Diário Oficial da União. 1998 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sobre os Rendimentos de Todas as Fontes. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua. Nota Técnica 01/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102176>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.1.01 – Proporção de analfabetismo na população [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18301638



Socioeconômico



SOC.1.02 – Proporção da população sem educação básica

SOC.1.02 – Proportion of the population without basic education

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população com 25 anos ou mais de idade sem educação básica.
- A Constituição Federal¹ estabelece o ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade, o que inclui o ensino médio público e gratuito. Logo, a conclusão do ensino médio deveria ocorrer até os 18 anos de idade, permanecendo sem educação básica apenas pessoas com impedimentos cognitivos.
- Aos 25 anos de idade, a maior parte das pessoas já encerrou sua trajetória educacional. A população adulta sem educação básica reúne pessoas que nunca frequentaram escola e aquelas que frequentaram, mas não concluíram com aprovação o último ano do ensino médio.
- Considera-se como pessoa sem educação básica aquela que não concluiu com aprovação o último ano do ensino médio, ou seu equivalente, incluindo-se os indivíduos que nunca frequentaram escola ou que não chegaram a frequentar o ensino médio ou equivalente. A informação é declarada pela própria pessoa ou por outro morador do domicílio ao entrevistador da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)².

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a proporção de pessoas sem educação básica na população com 25 anos ou mais de idade, na data da entrevista da PNADC, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência.
- Inobstante, jovens que não conseguem completar o ensino médio no tempo adequado podem optar pela educação de jovens e adultos (EJA), uma modalidade regular de ensino provida gratuitamente.
- A proporção de pessoas adultas (25 anos ou mais de idade) sem educação básica deveria ser próxima de zero.

USOS

- Monitorar o cumprimento do que estabelece a Constituição Federal quanto ao ensino básico obrigatório.
- Subsidiar análises relativas ao acesso universal à educação básica.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas à educação.

- Comparar populações ou grupos específicos quanto ao acesso à educação básica no tempo e no espaço.

LIMITAÇÕES

- O indicador é bastante influenciado pela falta de oportunidades educacionais no passado. A maior longevidade da população, incluindo-se os grupos mais vulneráveis e menos escolarizados, dilui o efeito positivo sobre o indicador do aumento da escolarização entre as novas coortes de nascimentos. Por esta razão, as análises do indicador segundo faixas etárias devem ser consideradas.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População sem educação básica, com 25 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População com 25 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que as taxas de aproveitamento da coleta foram prejudicadas pela pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos. O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita, conforme a prática do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)³.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022⁴.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo IBGE para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.
- Este indicador não precisa dos dados de educação do suplemento do 2º trimestre. Ele pode ser calculado a partir dos dados trimestrais da pesquisa, mas a desagregação por faixa de renda domiciliar por pessoa só pode ser feita a partir das bases de dados anuais da 1ª ou da 5ª visita.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 25 a 29 anos;
- 30 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios de que não são capitais de UF's nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

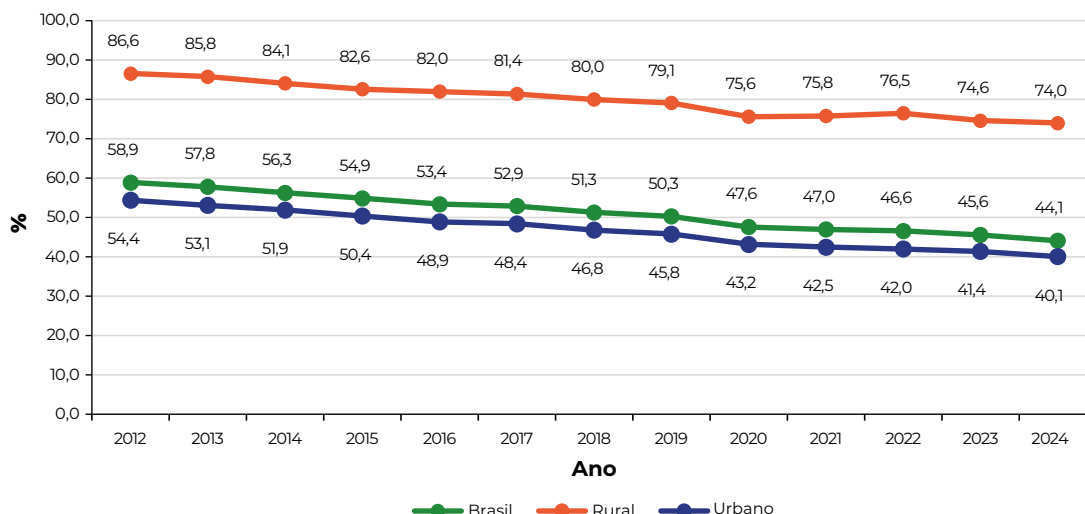
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A proporção da população sem educação básica apresenta uma tendência geral de queda ao longo dos anos, tendo passado de 58,9%, em 2012, para 44,1% da população adulta em 2024. A queda se apresenta contínua nas áreas urbana e rural, mas é na zona rural que os valores se revelam mais altos, pois, em 2012, 86,6% dos adultos em áreas rurais não tinham educação básica, e, apesar da redução, em 2024, ainda representavam quase três quartos da população adulta rural (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Proporção (%) da população sem educação básica, por situação do domicílio. Brasil, 2012 a 2024



Notas:

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 [Internet]. Brasília: Presidência da República; 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>

3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sobre os Rendimentos de Todas as Fontes. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua. Nota Técnica 01/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102176>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.1.02 – Proporção da população sem educação básica [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18301918



Socioeconômico



SOC.2.01 – Proporção de desocupação na população

SOC.2.01 – Proportion of unemployment in the population

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de pessoas desocupadas na força de trabalho.
- A população na força de trabalho é composta pelas pessoas em idade de trabalhar, ou seja, com 14 anos ou mais de idade, e que estavam ocupadas ou desocupadas na semana de referência da entrevista realizada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)^{1,2}.
- A população ocupada é composta pelas pessoas que trabalharam ao menos uma hora na semana de referência, com ou sem remuneração, ou que estavam temporariamente afastadas de trabalho remunerado na semana de referência.
- A população desocupada é composta pelas pessoas não ocupadas na semana de referência que tomaram alguma providência efetiva para obter trabalho no período de referência de 30 dias e que estavam disponíveis para começar a trabalhar na semana de referência. Também são considerados desocupados os indivíduos não ocupados e disponíveis para trabalhar na semana de referência, mas que não tomaram providência efetiva por já terem obtido trabalho previsto para começar após a semana de referência.
- A semana de referência é a semana de domingo a sábado anterior à semana da entrevista da PNADC.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a proporção de pessoas desocupadas na força de trabalho na semana de referência da entrevista, segundo as categorias de análise, em um local e semana de referência.
- Expressa a participação das pessoas desocupadas na força de trabalho, também conhecida como taxa de desemprego.
- O conceito de desocupação da força de trabalho difere do antigo conceito de desocupação da população economicamente ativa (PEA), pois não inclui as pessoas que estavam desocupadas buscando um trabalho, contudo, não tinham disponibilidade para início imediato.
- Níveis elevados de desocupação podem estar associados a piores condições socioeconômicas.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises relativas ao acesso à ocupação e à renda.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas ao mercado de trabalho.

- Comparar populações ou grupos específicos quanto ao acesso à ocupação no tempo e no espaço.

LIMITAÇÕES

- A desocupação é apenas uma das formas de subutilização da força de trabalho. Não inclui as pessoas que estavam desocupadas e procurando um trabalho sem estarem disponíveis para começar imediatamente; tampouco as desalentadas, aquelas que não estavam ocupadas nem procurando, mas estavam disponíveis para trabalhar.
- Por ser uma estatística anual, não permite analisar variações sazonais da desocupação.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTES DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População desocupada com 14 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População na força de trabalho com 14 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que as taxas de aproveitamento da coleta foram prejudicadas pela pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos. O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita, conforme a prática do IBGE³.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022⁴.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.
- Este indicador pode ser calculado a partir dos dados trimestrais da pesquisa, mas a desagregação por faixa de renda domiciliar por pessoa só pode ser feita a partir das bases de dados anuais da 1ª ou da 5ª visita.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 14 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

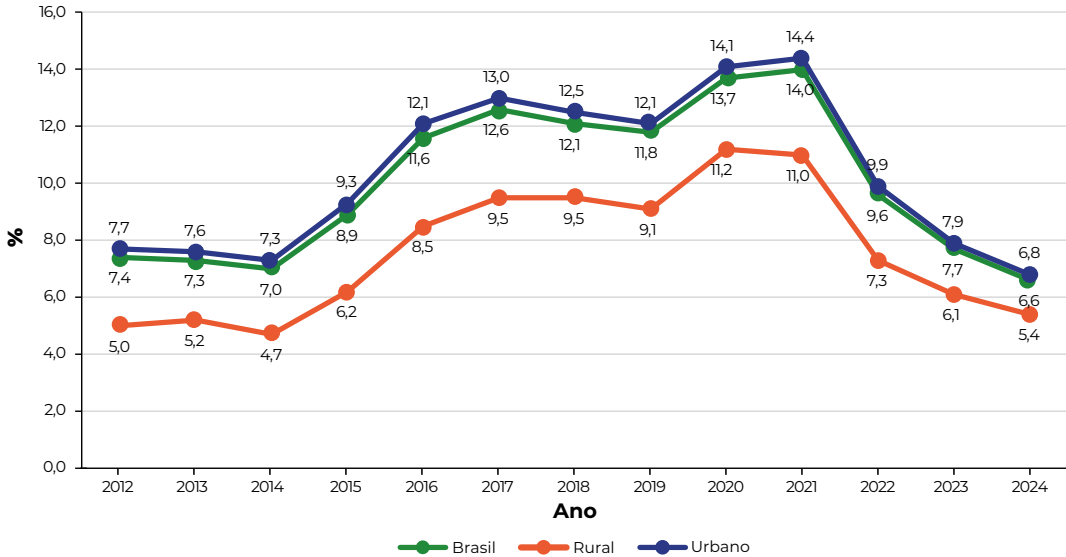
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O indicador mostra uma tendência geral de alta, na maioria das categorias, entre 2012 e 2021, com queda nos últimos anos. Para o Brasil, a parcela desocupada da força de trabalho era de 7,4%, em 2012, atingiu um pico de 14,0%, em 2021, e depois caiu para 6,6% em 2024 (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Proporção (%) de desocupação na população, por situação do domicílio. Brasil, 2012 a 2024



Notas:

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Glossário – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Mensal/glossario_pnadc_mensal.pdf
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sobre os Rendimentos de Todas as Fontes. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua. Nota Técnica 01/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102176>

4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.2.01 – Proporção de desocupação na população [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18303191



Socioeconômico



SOC.2.02 – Proporção da população com força de trabalho subutilizada

SOC.2.02 – Proportion of the population with underutilized labor

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de pessoas cuja força de trabalho estava subutilizada na força de trabalho ampliada.
- A subutilização considera as situações em que a pessoa pode aumentar sua jornada de trabalho ou ser incorporada à população ocupada, uma vez que está disponível e/ou buscando trabalho.
- O conjunto de pessoas com subutilização da força de trabalho inclui pessoas subocupadas por insuficiência de horas, pessoas desocupadas e pessoas na força de trabalho potencial¹, conforme especificado a seguir.
 - › São classificadas como subocupadas por insuficiência de horas as pessoas que, na semana de referência, tinham 14 anos ou mais de idade, trabalhavam habitualmente menos de 40 horas semanais, gostariam de trabalhar mais horas e estavam disponíveis para trabalhar mais horas no período de 30 dias, contados a partir do início da semana de referência.
 - › São classificadas como desocupadas: (i) as pessoas com 14 anos ou mais de idade, não ocupadas na semana de referência, que tomaram alguma providência efetiva para obter trabalho no período de referência de 30 dias e que estavam disponíveis para começar a trabalhar na semana de referência; e (ii) as pessoas com 14 anos ou mais de idade, não ocupadas, mas disponíveis para trabalhar na semana de referência, e que não tomaram providência efetiva por já terem obtido trabalho previsto para começar após a semana de referência.
 - › A força de trabalho potencial é composta: (i) pelas pessoas com 14 anos ou mais de idade que não estavam ocupadas e que tomaram providência efetiva para conseguir trabalho, mas que não estavam disponíveis para começar a trabalhar na semana de referência; e (ii) pelas pessoas com 14 anos ou mais de idade não ocupadas, que não tomaram providência efetiva para conseguir trabalho, mas que gostariam de ter um trabalho e estavam disponíveis para trabalhar na semana de referência.
- A força de trabalho ampliada é composta por pessoas na força de trabalho e na força de trabalho potencial.
- A semana de referência é a semana de domingo a sábado anterior à semana da entrevista da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)².

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a proporção de pessoas com força de trabalho subutilizada na força de trabalho ampliada, na semana de referência da entrevista realizada pela PNADC, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência.
- Representa a parcela da força de trabalho ampliada que está disponível para iniciar um trabalho ou aumentar sua carga horária.
- Níveis elevados de subutilização indicam baixa demanda por trabalho.
- Nas divulgações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o indicador é apresentado como “taxa composta de subutilização da força de trabalho ampliada”.

USOS

- Monitorar o indicador, a fim de subsidiar as análises relativas à dinâmica de inserção no mercado de trabalho e à renda da população.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas ao mercado de trabalho.
- Comparar populações ou grupos específicos quanto ao acesso ao mercado de trabalho, no tempo e no espaço.

LIMITAÇÕES

- Por ser uma estatística anual, não permite analisar variações sazonais da subutilização.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População com força de trabalho subutilizada com 14 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População na força de trabalho ampliada com 14 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que as taxas de aproveitamento da coleta foram prejudicadas pela pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos. O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita, conforme a prática do IBGE³.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022⁴.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo IBGE para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.
- O indicador pode ser calculado a partir dos dados trimestrais da pesquisa, mas a desagregação por faixa de renda domiciliar por pessoa só pode ser feita a partir das bases de dados anuais da 1ª ou da 5ª visita.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 14 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;

- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

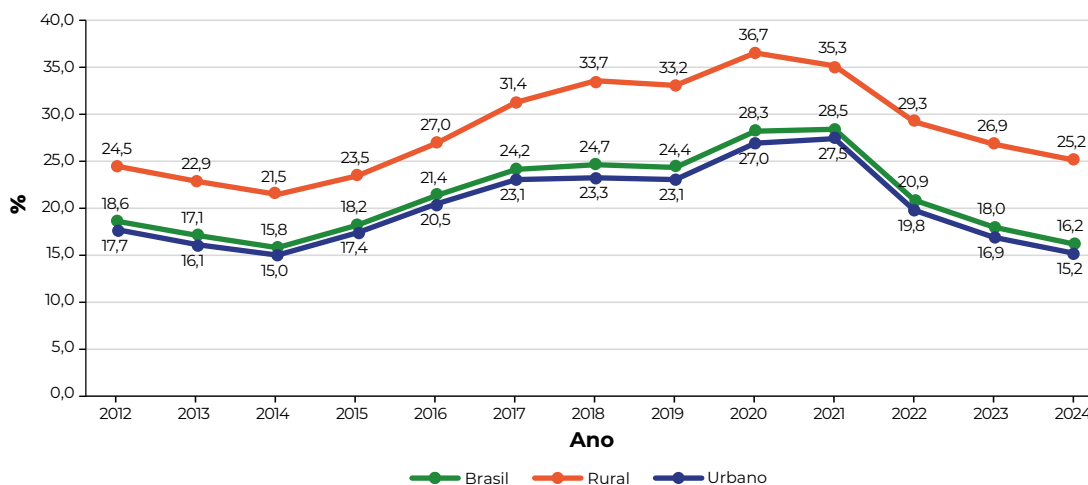
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A subutilização da força de trabalho no Brasil cresceu entre 2014 e 2021, atingindo o pico de 28,5% neste último ano e apresentando tendência de queda a partir de então. Em 2024, o indicador nacional estava em 16,2%, valor inferior ao observado no início da série em 2012 (18,6%), porém ainda pouco acima do piso histórico observado em 2014 (15,8%). Em termos de nível, destaca-se a maior subutilização da força de trabalho nas áreas rurais (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Proporção (%) da população com força de trabalho subutilizada, por situação do domicílio. Brasil, 2012 a 2024



Notas:

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Divulgação Especial – Medidas de Subutilização da Força de Trabalho no Brasil – 1º trimestre de 2024 [Internet]. IBGE. 2024 [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Trimestral/Novos_Indicadores_Sobre_a_Forca_de_Trabalho/pnadc_202401_trimestre_novos_indicadores.pdf
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sobre os Rendimentos de Todas as Fontes. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua. Nota Técnica 01/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102176>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.2.02 – Proporção da população com força de trabalho subutilizada [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18303355





SOC.2.03 – Proporção da população ocupada sem contribuição para a previdência social

SOC.2.03 – Proportion of the employed population not contributing to social security

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de pessoas ocupadas na força de trabalho que não contribuíam para a previdência social.
- A força de trabalho é composta pelas pessoas em idade de trabalhar, com 14 anos ou mais de idade, que estavam ocupadas ou desocupadas na semana de referência da entrevista realizada pela Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios Contínua (PNADC)¹.
- A pessoa é considerada ocupada se trabalhou ao menos uma hora na semana de referência, com ou sem remuneração, ou se estava temporariamente afastada de trabalho remunerado na semana de referência².
- As pessoas ocupadas podem ser classificadas como contribuintes ou não de instituto de previdência social oficial. Consideram-se contribuintes as pessoas ocupadas na semana de referência como trabalhadores por conta própria, empregadores, empregados ou trabalhadores domésticos que contribuíam por esse trabalho para instituto de previdência oficial federal (Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou Plano de Seguridade Social da União); estadual (instituto de previdência estadual, incluindo-se os servidores das forças auxiliares estaduais); ou municipal (instituto de previdência municipal, incluindo-se os servidores das forças auxiliares municipais)³.
- A semana de referência é a semana de domingo a sábado anterior à semana da entrevista da PNADC.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a proporção de pessoas ocupadas na força de trabalho, na semana de referência da entrevista, que não contribuíam para a previdência social, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência.
- Mede a parcela das pessoas ocupadas que não participam do sistema contributivo de proteção social, sejam empregadores, trabalhadores por conta própria ou empregados.
- Quanto menor a taxa, maior a participação dos trabalhadores no sistema de proteção social contributiva.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises relativas à dinâmica da participação dos trabalhadores no sistema de proteção social contributiva.

- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas à previdência social.
- Comparar populações ou grupos específicos quanto ao acesso à proteção social contributiva, no tempo e no espaço.

LIMITAÇÕES

- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais; além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- O indicador se refere exclusivamente à não contribuição ao instituto de previdência oficial federal, estadual ou municipal, não considerando contribuições à previdência privada.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População ocupada com 14 anos ou mais de idade que não contribuía para a previdência, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População ocupada com 14 anos ou mais de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que as taxas de aproveitamento da coleta foram prejudicadas pela pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos. O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita, conforme a prática do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)⁴.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022⁵.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo IBGE para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.
- O indicador pode ser calculado a partir dos dados trimestrais da pesquisa, mas a desagregação por faixa de renda domiciliar por pessoa só pode ser feita a partir das bases de dados anuais da 1ª ou da 5ª visita.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 14 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

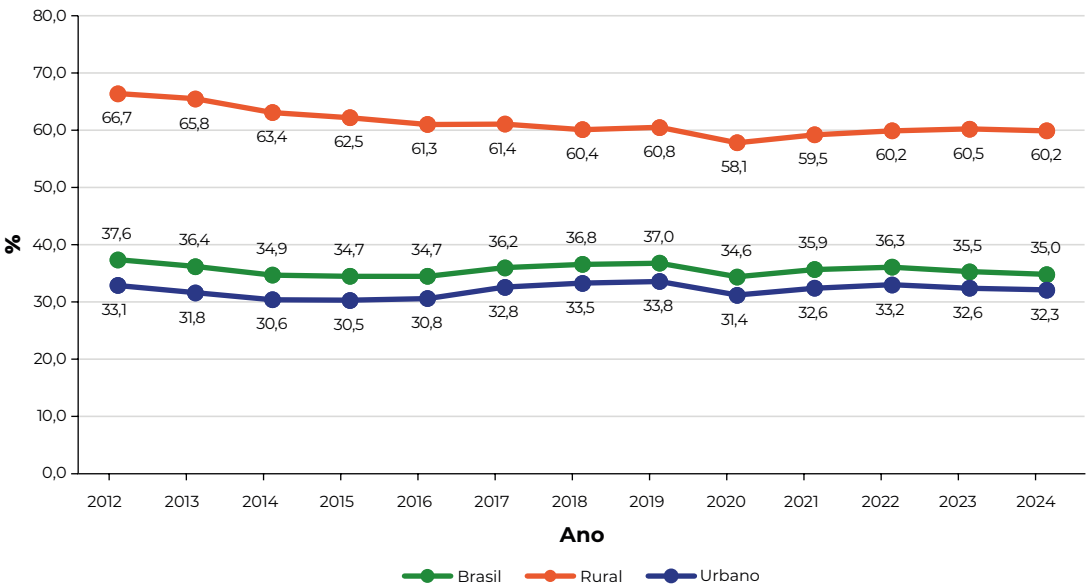
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A proporção de ocupados que não contribuíam para instituto de previdência social oficial variou pouco entre 2012 e 2024, não apresentando nenhuma tendência clara no país. O maior valor da série foi observado em 2012 (37,6%), e o menor, em 2020 (34,6%). Independentemente dos diferentes momentos do ciclo econômico vivenciados nesses anos, portanto, sempre houve pouco mais de um terço da força de trabalho ocupada não coberta pela previdência social oficial. O indicador é consideravelmente maior nas áreas rurais, onde apresentou tendência de queda entre 2012 e 2020. Em 2012, 66,7% dos ocupados residentes no meio rural não eram contribuintes da previdência, o dobro da proporção observada nas áreas urbanas. Em 2024, esse valor caiu para 60,2%, enquanto nas áreas urbanas só recuou levemente, para 32,3% (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Proporção (%) da população ocupada sem contribuição para a previdência social, por situação do domicílio. Brasil, 2012 a 2024



Notas:

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Glossário – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://ftp.ibge.gov.br/>

- Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Mensal/glossario_pnadc_mensal.pdf
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Notas técnicas – Versão 1.15 [Internet]. IBGE. 2023 [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102044_notas_tecnicas.pdf
 4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sobre os Rendimentos de Todas as Fontes. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua. Nota Técnica 01/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102176>
 5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.2.03 – Proporção da população ocupada sem contribuição para a previdência social [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18303450



Socioeconômico



SOC.2.04 – Proporção de jovens que não estudam e não trabalham

SOC.2.04 – Proportion of youth neither in education nor employment

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de pessoas de 15 a 29 anos de idade que não estudam e não trabalham.
- De acordo com o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013)¹, são consideradas jovens as pessoas entre 15 e 29 anos de idade, que têm direito a uma educação de qualidade, inclusive as que a ela não tiveram acesso na idade adequada.
- Partindo desse pressuposto, considera-se jovem que não estuda aquele que não frequenta: (i) curso de ensino básico, de educação de jovens e adultos ou supletivo; (ii) curso de ensino superior ou de pós-graduação; (iii) curso técnico de nível médio ou normal (magistério); (iv) curso de extensão ou capacitação de nível superior; (v) curso de qualificação profissional; e (vi) curso pré-vestibular.
- No caso do jovem que não trabalha, será considerado aquele que não estava ocupado na semana de referência da entrevista realizada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)². São classificadas como ocupadas as pessoas que trabalharam ao menos uma hora na semana de referência, com ou sem remuneração, ou que estavam temporariamente afastadas de trabalho remunerado na semana de referência³.
- A semana de referência é a semana de domingo a sábado anterior à semana da entrevista da PNADC.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a proporção da população de jovens de 15 a 29 anos de idade que não estudam e não estão ocupados, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência.
- Expressa o nível de inatividade educacional e ocupacional entre os jovens, que pode decorrer da falta de motivação, da ausência de oportunidades ou de outras circunstâncias.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises relativas à dinâmica da inatividade educacional e ocupacional dos jovens.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas à educação e à ocupação de jovens.
- Comparar populações ou grupos específicos quanto ao acesso à educação e ao mercado de trabalho no tempo e no espaço.

LIMITAÇÕES

- Não considera o trabalho doméstico, nem permite inferir se a inatividade é decorrente de efeitos duradouros ou se consiste em *status* temporário resultante da transição do sistema de ensino para o mundo do trabalho.
- Não mede os aspectos que conduziram à condição: falta de oportunidade de emprego, doença, gravidez, necessidade de cuidar de outros parentes etc.
- Há também limitações das fontes de dados: alguns tipos de treinamento profissional não são considerados como frequência à escola, e o trabalho informal intermitente pode não ser captado adequadamente.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População jovem de 15 a 29 anos de idade que não estudava e não trabalhava, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População jovem de 15 a 29 anos de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais do 2º trimestre, no qual se aplica um questionário suplementar que coleta dados sobre a frequência a cursos técnicos, de pré-vestibular, de extensão ou de qualificação profissional. Os dados não estão disponíveis para 2020 e 2021, anos em que a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- No momento de elaboração desta ficha, os pesos atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022 ainda não estavam disponíveis para os microdados anuais do 2º trimestre.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.
- Este indicador precisa dos dados de educação do suplemento do 2º trimestre. A desagregação por faixa de renda domiciliar *per capita* usa dados imputados pelo IBGE para domicílios nas visitas 2, 3 e 4.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 15 a 17 anos;
- 18 a 24 anos; e
- 25 a 29 anos.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

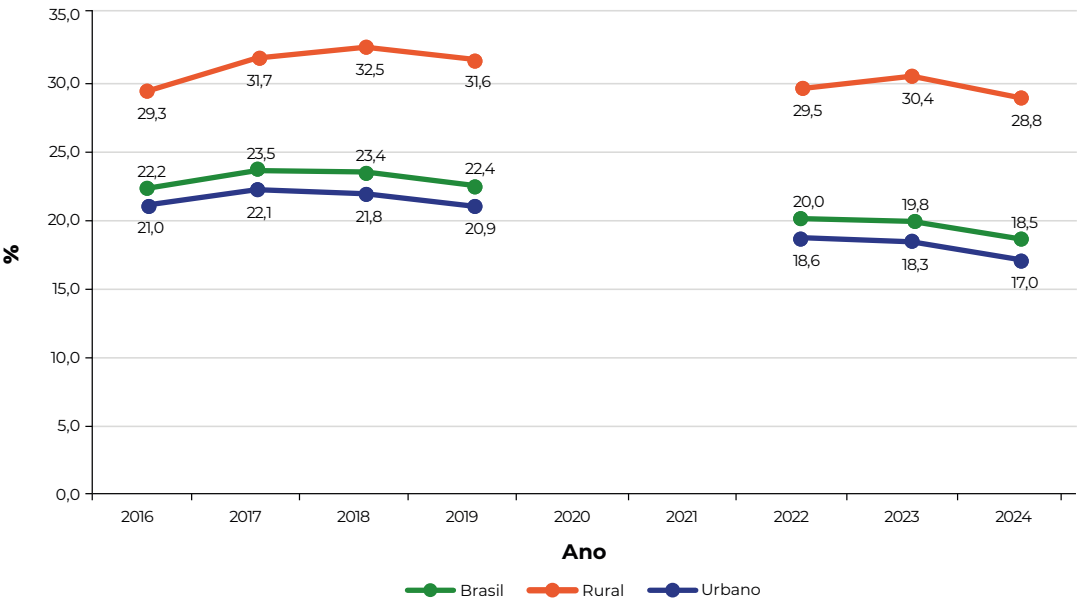
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A proporção de jovens que não estudam nem trabalham apresentou um ligeiro crescimento entre 2016 e 2017, e queda a partir de então, especialmente em 2023 e 2024. Esse padrão de crescimento inicial e queda posterior foi verificado nas áreas urbanas e rurais (Gráfico 1). Em termos de nível, o indicador é consideravelmente mais alto no meio rural, oscilando em torno de 30%.

Gráfico 1 – Proporção (%) de jovens que não estudam e não trabalham, por situação do domicílio. Brasil, 2016 a 2024



Notas:

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais do 2º trimestre, no qual se aplica um questionário suplementar que coleta dados sobre a frequência a cursos técnicos, de pré-vestibular, de extensão ou de qualificação profissional.
- Os dados não estão disponíveis para 2020 e 2021, quando a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

- Brasil. Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE [Internet]. Diário Oficial da União. 2013 [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm

2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Glossário – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Mensal/glossario_pnadc_mensal.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.2.04 – Proporção de jovens que não estudam e não trabalham [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18303611





SOC.2.05 – Proporção da população de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil

SOC.2.05 – Proportion of the population aged 5 to 17 in child labour

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil.
- O trabalho infantil compreende as seguintes situações:
 - › Crianças de 5 a 13 anos de idade em qualquer tipo de trabalho¹;
 - › Adolescentes de 14 e 15 anos em qualquer trabalho, salvo como aprendizes formais²; e
 - › Adolescentes de 16 e 17 anos de idade em trabalho informal, ou trabalhando mais de 44 horas semanais, ou em ocupação na lista de trabalho infantil perigoso, ou na produção para o próprio consumo².
- A informação é declarada à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)³.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência.
- Considera-se a parcela da população de crianças e adolescentes envolvidas em atividades laborais em desconformidade com a legislação brasileira.
- A Organização Internacional do Trabalho (OIT)⁴ considera o trabalho infantil “perigoso e prejudicial para a saúde”, bem como para o “desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças”.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises relativas à dinâmica do trabalho infantil no território nacional.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas ao combate e à eliminação do trabalho infantil.
- Mapear regiões de maior prevalência de trabalho infantil, e apoiar ações de conscientização e repressão do crime de trabalho infantil.
- Comparar populações ou grupos específicos quanto ao trabalho infantil no tempo e no espaço.

LIMITAÇÕES

- A exploração do trabalho infantil, por ser criminosa, é costumeiramente clandestina e pode não ser captada pelas fontes.

- Em alguns contextos culturais, o trabalho de crianças e adolescentes, ainda que em condições de informalidade, pode ser altamente valorizado ou incentivado no ambiente familiar ou comunitário, o que pode afetar a declaração das informações e a interpretação do indicador.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População de 5 a 17 anos de idade, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados das visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 5ª visita (disponíveis a partir de 2016), quando é aplicado o questionário suplementar sobre trabalho infantil. Os dados não estão disponíveis para 2020 e 2021, quando a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022⁵.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.
- Este indicador só pode ser calculado a partir das bases de dados anuais da 5ª visita.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 5 a 13 anos;
- 14 a 15 anos; e
- 16 a 17 anos.

Renda domiciliar per capita:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE _____

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

NOTA _____

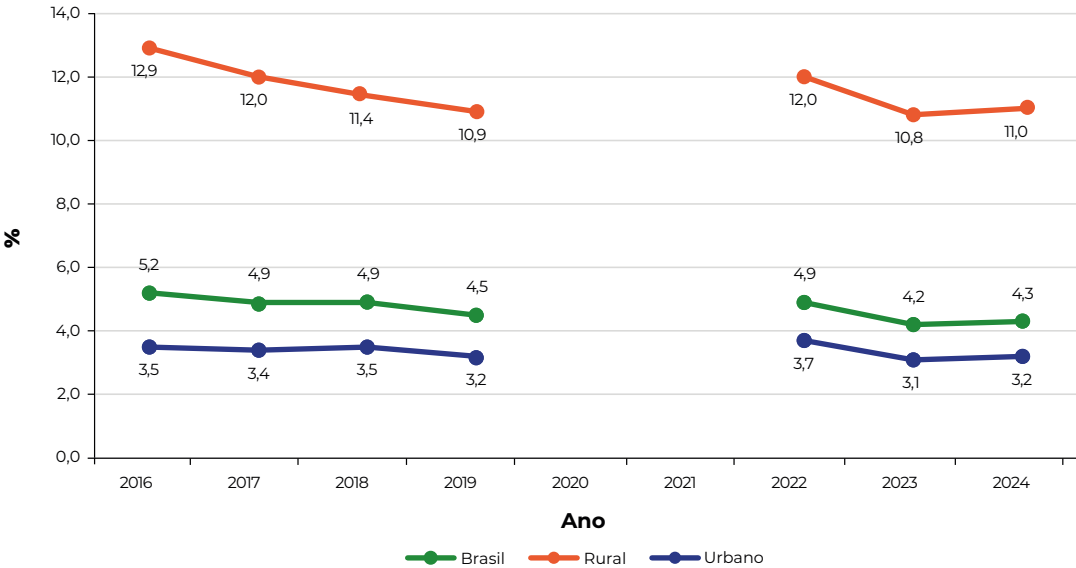
- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR _____

O indicador apresenta leve queda entre 2016 e 2019 e um ligeiro aumento no intervalo de 2019 a 2022, com recuo mais rápido em 2023 e estabilidade em 2024. A proporção de crianças e

adolescentes que trabalham em desconformidade com a legislação é muito superior nas áreas rurais, onde é mais de três vezes maior do que nas áreas urbanas, durante todo o período em questão, embora tenha caído (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Proporção (%) da população de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil e por situação do domicílio. Brasil, 2016 a 2024



Notas:

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados das visitas.
- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 5ª visita (disponíveis a partir de 2016), quando é aplicado o questionário suplementar sobre trabalho infantil.
- Os dados não estão disponíveis para 2020 e 2021, quando a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. International Labour Organization. Convention C138 – Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) [Internet]. ILO. 1973 [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
2. Brasil. Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho – OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil [Internet]. Diário Oficial da União. 2019 [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10088.htm
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>
4. International Labour Organization. Trabalho Infantil [Internet]. ILO. 2018 [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://www.ilo.org/pt-pt/resource/trabalho-infantil>

5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.2.05 – Proporção da população de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18303804



Socioeconômico

SOC.3.01 – Rendimento domiciliar *per capita* a preços correntes

SOC.3.01 – Average household income per capita at current prices

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- O indicador corresponde à média da renda domiciliar *per capita* na população.
- A renda domiciliar *per capita* é calculada, para cada domicílio, pela soma dos rendimentos mensais individuais dos moradores dividida pelo número de moradores, de acordo com as informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)¹.
- A soma dos rendimentos mensais individuais inclui os rendimentos habituais do trabalho – isto é, a remuneração do trabalho, excluindo-se acréscimos extraordinários ou descontos esporádicos – e os rendimentos efetivos de outras fontes recebidos pelos moradores do domicílio².
- Pessoas que sejam pensionistas ou empregados domésticos residentes e seus parentes não são consideradas neste indicador, por não fazerem parte da distribuição intradomiciliar de renda e para evitar dupla contagem, uma vez que parte de sua renda é paga ou recebida do domicílio.
- Os rendimentos são expressos em valores correntes na data da entrevista da PNADC, sem aplicações de deflatores.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a renda domiciliar *per capita* a preços correntes, na data da entrevista da PNADC, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência.
- Mede a capacidade de aquisição de bens e serviços dos moradores do domicílio.
- Valores muito baixos assinalam, em geral, a existência de segmentos sociais com precárias condições de vida.
- É uma característica da unidade domiciliar que é atribuída para cada uma das pessoas nela residente.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises relativas à dinâmica das condições de vida dos domicílios no território nacional.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas às condições de vida da população.

- Mapear regiões de maior prevalência de condições precárias de vida, e apoiar ações para o seu enfrentamento.

LIMITAÇÕES

- A renda média oculta uma distribuição desigual. A distribuição de renda é assimétrica e, em geral, mais da metade das pessoas têm renda abaixo da média.
- Ao dividir a renda domiciliar igualmente entre todos os membros do domicílio, o indicador desconsidera desigualdades intradomiciliares referentes ao controle dessa renda.
- O poder de compra da renda varia segundo o custo de vida de cada região ou localidade.
- A série histórica de valores correntes desconsidera a inflação. Assim, parte do aumento da renda se dá com a elevação dos preços, ou seja, nem todo aumento é valorização real, isto é, ampliação efetiva do poder de compra.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

Soma da renda domiciliar *per capita* de todas as pessoas, exceto os pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência

População, exceto pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que as taxas de aproveitamento da coleta foram prejudicadas pela pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos. O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita, conforme a prática do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)³.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022⁴.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo IBGE para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.

- Os dados de renda dos trimestres não foram deflacionados para o meio do ano ou corrigidos de forma alguma.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

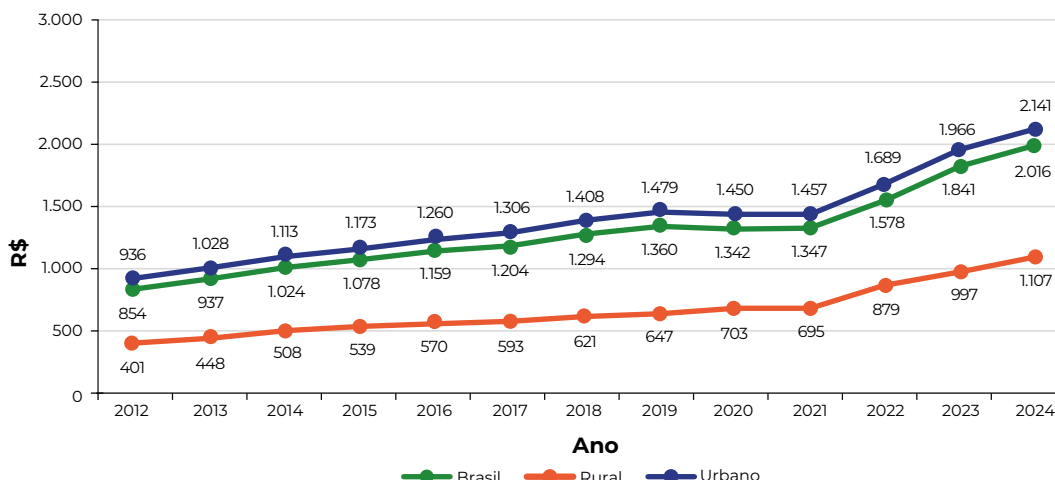
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A média da renda domiciliar por pessoa, a preços correntes, apresenta crescimento no período considerado, o que é de se esperar, em função do não deflacionamento dos valores monetários e do aumento do nível de preços observado nesses anos. O único ano para o qual esse crescimento não se verifica é 2020, primeiro ano da pandemia de COVID-19. No meio rural, a queda da renda decorrente da pandemia foi mais tardia, tendo ocorrido em 2021. Em termos de nível, a renda média dos residentes de áreas rurais é, em geral, inferior a 50% da renda em áreas urbanas, mas observa-se uma trajetória tímida de convergência no período em questão (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Rendimento domiciliar *per capita* a preços correntes (R\$), por situação do domicílio. Brasil, 2012 a 2024



Notas:

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Glossário – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Mensal/glossario_pnadc_mensal.pdf
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sobre os Rendimentos de Todas as Fontes. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua. Nota Técnica 01/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102176>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.3.01 – Rendimento domiciliar *per capita* a preços correntes [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18303935





SOC.3.02 – Proporção da população abaixo da linha de pobreza

SOC.3.02 – Proportion of the population below the poverty line

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- A pobreza é caracterizada quando a renda domiciliar *per capita* é inferior à linha de pobreza.
- A renda domiciliar *per capita* é calculada, para cada domicílio, pela soma dos rendimentos mensais individuais dos moradores dividida pelo número de moradores, de acordo com as informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)¹.
- A soma dos rendimentos mensais individuais inclui os rendimentos habituais do trabalho – isto é, a remuneração do trabalho, excluindo-se acréscimos extraordinários ou descontos esporádicos – e os rendimentos efetivos de outras fontes recebidos pelos moradores do domicílio².
- Pessoas que sejam pensionistas ou empregados domésticos residentes e seus parentes não são consideradas neste indicador, por não fazerem parte da distribuição intradomiciliar de renda e para evitar dupla contagem, uma vez que parte de sua renda é paga ou recebida do domicílio.
- Foram consideradas as três linhas internacionais de pobreza definidas pelo Banco Mundial³:
 - › A – US\$ 3,00 diários *per capita* em dólares internacionais de 2021 (linha para países extremamente pobres);
 - › B – US\$ 4,20 diários *per capita* em dólares internacionais de 2021 (linha para países pobres); e
 - › C – US\$ 8,30 diários *per capita* em dólares internacionais de 2021 (linha para países de renda média-alta).
- A conversão de dólares para reais é feita pelo fator paridade do poder de compra (PPC) estimado para o Brasil em 2021, levando-se em conta a inflação acumulada entre o ano de referência do fator PPC e o trimestre de realização da entrevista da PNADC. O fator PPC expressa quantos reais eram necessários para comprar no Brasil, em 2021, o mesmo que um dólar comprava nos Estados Unidos.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a parcela da população em situação de pobreza segundo critérios monetários, isto é, com renda abaixo do valor considerado adequado para satisfazer minimamente as necessidades básicas de sobrevivência e bem-estar, de acordo com padrões de vida socialmente aceitos.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises relativas à dinâmica da parcela da população com renda abaixo da linha da pobreza.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas à inclusão, redistribuição de renda e erradicação da pobreza.
- Comparar populações ou grupos específicos quanto ao acesso à renda considerada adequada para satisfazer minimamente suas necessidades.

LIMITAÇÕES

- Como o cálculo deste indicador depende de várias escolhas e possíveis arredondamentos, podem existir diferenças de valores entre fontes. Por exemplo, o Banco Mundial realiza uma “harmonização” das bases de dados brasileiras com as de outros países da América Latina, o que gera indicadores com valores distintos dos publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Síntese de Indicadores Sociais. Outras escolhas, como o conceito de renda do trabalho, o deflator e o método de deflação, também podem afetar o resultado.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais; além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População com renda domiciliar } \textit{per capita} \text{ inferior à linha de pobreza, exceto os pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}}{\text{População, exceto pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, segundo as categorias de análise, em um local e ano de referência}} \times 100$$

Nota:

- Foram consideradas as três linhas internacionais de pobreza definidas pelo Banco Mundial:
 - › A – US\$ 3,00 diários *per capita* em dólares internacionais de 2021 (linha para países extremamente pobres);
 - › B – US\$ 4,20 diários *per capita* em dólares internacionais de 2021 (linha para países pobres); e
 - › C – US\$ 8,30 diários *per capita* em dólares internacionais de 2021 (linha para países de renda média-alta).

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que as taxas de aproveitamento da coleta foram prejudicadas pela pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos. O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita, conforme a prática do IBGE⁴.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022⁵.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo IBGE para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.
- Os valores das linhas de pobreza são expressos em dólares internacionais por pessoa, por dia. A conversão em reais é feita em duas etapas.
 1. As linhas são convertidas em valores mensais e multiplicadas pelo fator PPC para o Brasil em 2021 (2,4498632).
 2. Aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para deflacionar esses valores, tendo como referência a média aritmética do IPCA, nos trimestres de realização da PNADC, e a média aritmética do IPCA no ano de referência do fator PPC (2021).

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação;
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e

- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

NOTA

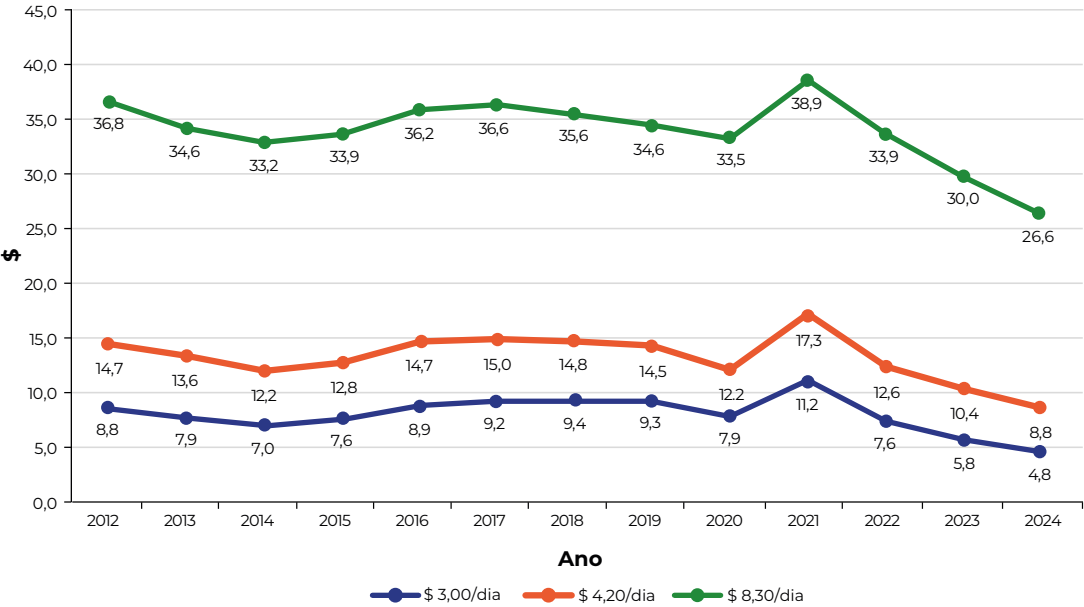
- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Embora o nível varie enormemente, a trajetória da pobreza foi razoavelmente semelhante para as três linhas internacionais (Gráfico 1). A proporção de pobres na população caiu entre 2012 e 2014, mas regrediu ao patamar inicial com o aumento registrado entre 2014 e 2017. Houve relativa estabilidade no fim dos anos 2010, seguida por mudanças abruptas durante a pandemia de COVID-19. Para as três linhas, a pobreza atingiu os piores níveis da série histórica em 2021, devido à retração do Auxílio Emergencial no auge da pandemia.

Por fim, a recuperação econômica e a expansão dos benefícios sociais desde 2021 provocaram forte redução na proporção de pobres, que em 2024 alcançou os menores valores das séries históricas para as três linhas. Para a linha mais baixa (US\$ 3 diários *per capita*, cerca de R\$ 280 mensais, em reais de meados de 2025), a proporção de pobres diminuiu mais de 6 pontos percentuais (p.p.) em três anos, caindo de 11,2% para apenas 4,8%. Para a linha mais elevada (US\$ 8,30 diários *per capita*, cerca de R\$ 775 mensais, em reais de meados de 2025), a redução foi de mais de 12 p.p., mas pouco mais de um quarto dos brasileiros ainda são pobres, segundo este critério.

Gráfico 1 – Proporção (%) da população abaixo da linha de pobreza, segundo as três linhas de pobreza internacionais definidas pelo Banco Mundial. Brasil, 2012 a 2024



Notas:

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.
- Os valores das linhas internacionais são estimados pelo Banco Mundial e expressos em dólares internacionais de 2021. Para a conversão em reais, aplica-se o fator PPC, fornecido pelo Banco Mundial. Para o deflacionamento, foi empregado o IPCA.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Glossário – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Mensal/glossario_pnadc_mensal.pdf
3. Elizabeth Foster, Dean Jolliffe, Gabriel Lara Ibarra, Christoph Lakner, Samuel Tetteh-Baah. Global Poverty Revisited Using 2021 PPPs and New Data on Consumption [Internet]. World Bank Policy Research Working Paper n. 11137. 2025 [citado 30 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099503206032533226/pdf/IDU-e2e09dcf-0af2-481a-a60a-64adf28171d0.pdf>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sobre os Rendimentos de Todas as Fontes. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua. Nota Técnica 01/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102176>

5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.3.02 – Proporção da população abaixo da linha de pobreza [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18304355





SOC.3.03 – Coeficiente de Gini da distribuição da renda domiciliar *per capita*

SOC.3.03 – Gini coefficient of the distribution of household income per capita

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- O coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, no início do século XX, amplamente utilizada em estudos sobre distribuição de renda.
- O coeficiente mede o quanto uma distribuição difere de um padrão perfeitamente igualitário, sendo definido matematicamente como a razão entre a área entre a linha hipotética de igualdade perfeita e a curva de Lorenz, dividida pela área total sob a linha hipotética de igualdade perfeita.
- A curva de Lorenz de uma distribuição é uma representação gráfica que descreve a distribuição acumulada de uma variável em uma dada população. Em uma população ordenada de forma crescente pela renda, as coordenadas da curva de Lorenz são dadas pelo percentual acumulado da população, no eixo horizontal, e pelo percentual acumulado da renda, no eixo vertical. A linha hipotética de igualdade perfeita equivale a uma distribuição em que todos possuem exatamente a mesma renda, correspondendo visualmente a uma diagonal.
- O coeficiente de Gini apresenta várias propriedades desejáveis. Em especial, atende ao princípio de transferências de Pigou-Dalton, isto é, diminui sempre que há uma transferência de uma pessoa mais rica para uma mais pobre, desde que as posições relativas das duas não se alterem, e vice-versa.
- A renda domiciliar *per capita* é calculada para cada domicílio como a soma dos rendimentos mensais individuais dos moradores dividida pelo número de moradores, de acordo com as informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)¹.
- A soma dos rendimentos mensais individuais inclui os rendimentos habituais do trabalho – isto é, a remuneração do trabalho, excluindo-se acréscimos extraordinários ou descontos esporádicos – e os rendimentos efetivos de outras fontes recebidos pelos moradores do domicílio².
- Pessoas que sejam pensionistas ou empregados domésticos residentes e seus parentes não são consideradas neste indicador, por não fazerem parte da distribuição intradomiciliar de renda e para evitar dupla contagem, uma vez que parte de sua renda é paga ou recebida do domicílio.

INTERPRETAÇÃO

- O coeficiente de Gini varia entre zero e 1. Quanto maior o valor, maior a desigualdade.
- Hipoteticamente, se todas as pessoas tivessem exatamente a mesma renda, ou seja, se todas recebessem a renda média, o valor do indicador seria zero.

- A desigualdade máxima ocorre se uma única pessoa em uma população infinita recebe toda a renda. Nesse caso, o indicador seria igual a 1.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises relativas à dinâmica da desigualdade de renda no território nacional.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas à desigualdade de renda na população.
- Realizar comparações espaciais e temporais quanto à desigualdade de renda da população ou de grupos específicos.

LIMITAÇÕES

- O coeficiente de Gini é pouco sensível à redistribuição no topo e na base da distribuição de renda, e mais sensível a mudanças que ocorrem no meio da distribuição. É recomendável que seja complementado por outras medidas de desigualdade.
- O coeficiente de Gini não é uma medida de desigualdade adequada à decomposição por grupos.
- Embora sejam comuns, comparações internacionais devem ser feitas de forma cuidadosa: para muitos países, o coeficiente de Gini é calculado a partir de dados de consumo, o que gera valores mais baixos que os dos países que medem a desigualdade de renda.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$1 - \sum_{i=2}^n (x_i - x_{i-1}) (y_i + y_{i+1})$$

Notas:

- Na fórmula, x é uma variável que armazena o *ranking* relativo de cada indivíduo na população distribuída em ordem ascendente da renda, em um local e ano de referência; e
- y é uma variável que armazena a renda relativa acumulada até um indivíduo na população distribuída em ordem ascendente da renda, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que as taxas de aproveitamento da coleta foram prejudicadas pela pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos. O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita, conforme a prática do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)³.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022⁴.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo IBGE para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.
- Os dados de renda dos trimestres não foram deflacionados para o meio do ano ou corrigidos de qualquer forma, mas o eventual deflacionamento não afetaria as estimativas.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

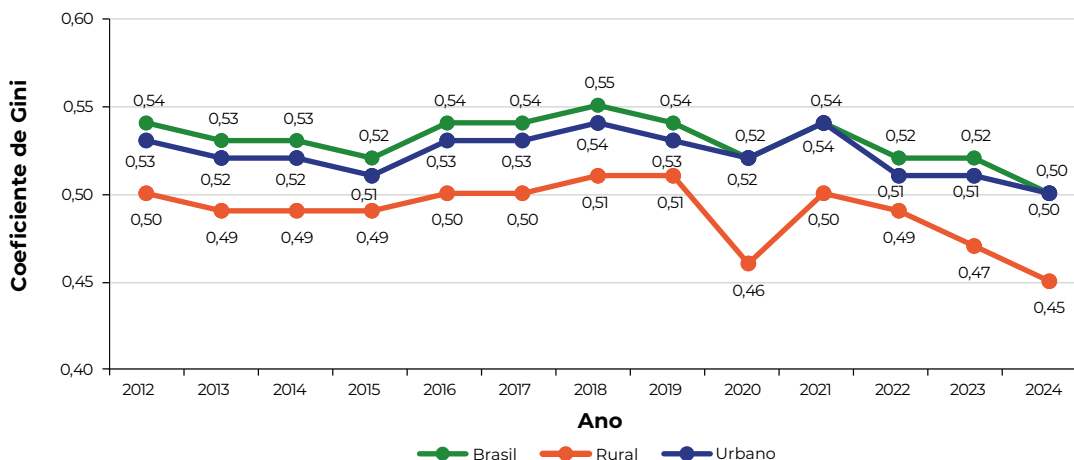
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O coeficiente de Gini do Brasil é elevado, o que indica haver muita desigualdade na distribuição da renda entre as pessoas (Gráfico 1). Entre 2012 e 2015, o indicador estava em queda, passando de 0,54 para 0,52. Contudo, voltou a subir de 2015 a 2018. Em 2020, a desigualdade diminuiu abruptamente, graças ao Auxílio Emergencial, mas toda a redução foi revertida no ano de 2021, devido à retração precoce do Auxílio, no auge da pandemia. Desde então, a retomada econômica e a expansão dos benefícios sociais provocaram redução no coeficiente de Gini, que declinou de 0,54 para 0,50, atingindo o menor valor da série histórica. Embora haja diferenças de nível, a trajetória da desigualdade foi semelhante em áreas urbanas e rurais.

Gráfico 1 – Coeficiente de Gini da distribuição da renda domiciliar *per capita*, por situação do domicílio. Brasil, 2012 a 2024



Notas:

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Glossário – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Mensal/glossario_pnadc_mensal.pdf
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sobre os Rendimentos de Todas as Fontes. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua. Nota Técnica 01/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102176>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.3.03 – Coeficiente de Gini da distribuição da renda domiciliar *per capita* [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18304581



Socioeconômico



SOC.3.04 – Razão entre a renda total dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres

SOC.3.04 – Ratio of the total income of the richest 10% to that of the poorest 40%

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Razão entre a renda total dos 10% mais ricos da população e a renda total dos 40% mais pobres, também conhecida como Razão de Palma.
- Os 10% mais ricos e os 40% mais pobres são definidos a partir da distribuição da renda domiciliar *per capita*, calculada para cada domicílio como a soma dos rendimentos mensais individuais dos moradores dividida pelo número de moradores, de acordo com as informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)¹.
- A soma dos rendimentos mensais individuais inclui os rendimentos habituais do trabalho – isto é, a remuneração do trabalho, excluindo-se acréscimos extraordinários ou descontos esporádicos – e os rendimentos efetivos de outras fontes recebidos pelos moradores do domicílio².
- Pessoas que sejam pensionistas ou empregados domésticos residentes e seus parentes não são consideradas neste indicador, por não fazerem parte da distribuição intradomiciliar de renda e para evitar dupla contagem, uma vez que parte de sua renda é paga ou recebida do domicílio.

INTERPRETAÇÃO

- A razão entre a renda dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres também é conhecida como Razão de Palma, e funciona como medida da desigualdade de renda.
- Quanto maior a razão, maior é a desigualdade e a distância entre a renda dos mais ricos e dos mais pobres.
- O Razão de Palma pode ser considerado um indicador complementar ao coeficiente de Gini, por ser mais sensível ao que acontece nos extremos da distribuição.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises relativas à dinâmica da desigualdade de renda no território nacional.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas à desigualdade de renda na população.
- Realizar comparações espaciais e temporais quanto à desigualdade de renda da população ou de grupos específicos.

LIMITAÇÕES

- A razão entre a renda dos mais ricos e dos mais pobres não responde a mudanças que ocorrem no meio da distribuição.
- Idealmente, análises da desigualdade devem considerar outros indicadores e representações gráficas da distribuição.
- A razão entre rendas não é uma medida de desigualdade adequada à decomposição por grupos.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

Soma da renda domiciliar *per capita* de todas as pessoas, exceto os pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, que pertenciam aos 10% mais ricos, em um local e ano de referência

Soma da renda domiciliar *per capita* de todas as pessoas, exceto os pensionistas, empregados domésticos residentes e seus parentes, que pertenciam aos 40% mais pobres, em um local e ano de referência

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que as taxas de aproveitamento da coleta foram prejudicadas pela pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos. O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita, conforme a prática do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)³.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022⁴.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo IBGE para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.
- Os dados de renda dos trimestres não foram deflacionados para o meio do ano ou corrigidos de forma alguma, mas o eventual deflacionamento não afetaria as estimativas.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

NOTA

- Não se aplica.

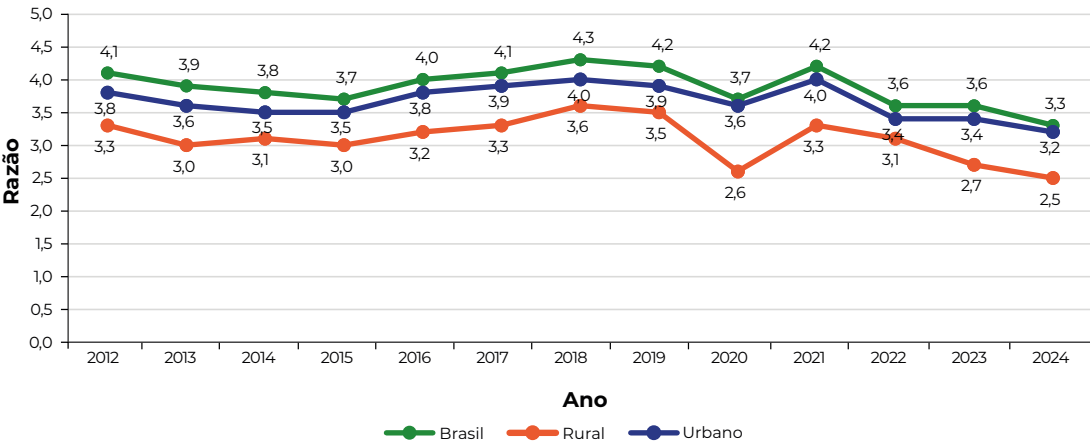
ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Para o Brasil, em 2012, o montante recebido pelos 10% mais ricos era 4,1 vezes maior do que toda a renda dos 40% mais pobres (Gráfico 1). Como este último grupo é quatro vezes maior, isso implica

que, naquele ano, a renda média no décimo mais rico era 16,4 vezes maior do que a média dos 40% mais pobres.

A evolução do indicador seguiu o comportamento de outros indicadores baseados na renda domiciliar *per capita*, como o coeficiente de Gini. Houve redução da desigualdade no período entre 2012 e 2015, posteriormente revertida na segunda metade da década, anos marcados por uma grande recessão e lenta retomada econômica. A pandemia de COVID-19 trouxe mudanças abruptas, com queda da desigualdade em 2020 e aumento súbito em 2021. Nos últimos anos, contudo, a recuperação do mercado de trabalho e a ampliação dos programas de transferência de renda se traduziram em novo período de redução da desigualdade. Em 2024, a renda total dos 10% mais ricos era 3,3 vezes maior do que a dos 40% mais pobres, alcançando o menor valor da série histórica, quase 20% mais baixo do que em 2012. A desigualdade nas áreas rurais e urbanas registrou trajetória semelhante à do Brasil como um todo.

Gráfico 1 – Razão entre a renda dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres, por situação do domicílio. Brasil, 2012 a 2024



Notas:

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, exceto para 2020, 2021 e 2022, anos em que a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador para estes anos foi calculado a partir dos microdados anuais da 5ª visita.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Glossário – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 29 de outubro de 2025]. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Mensal/glossario_pnadc_mensal.pdf
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sobre os Rendimentos de Todas as Fontes. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua. Nota Técnica 01/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102176>

4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.3.04 – Razão entre a renda total dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18304748





SOC.3.05 – Produto interno bruto *per capita*

SOC.3.05 – *Gross Domestic Product per capita*

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- O Produto Interno Bruto (PIB) *per capita* é o valor total anual, em moeda corrente (R\$) e a preços de mercado, dos bens e serviços finais produzidos em um local, dividido por sua população total no ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Usado como indicador do desenvolvimento econômico, mede a produção anual do conjunto dos setores da economia por habitante.
- Indica o nível de produção econômica em um território, em relação ao seu contingente populacional.
- Valores muito baixos assinalam, em geral, a existência de segmentos sociais com precárias condições de vida.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises das condições de vida no território nacional.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas às condições de vida na população.
- Realizar comparações espaciais e temporais quanto às condições de vida da população ou de grupos específicos.

LIMITAÇÕES

- O PIB *per capita*, embora amplamente utilizado como indicador do desenvolvimento econômico, apresenta limitações importantes. Ele reflete apenas o valor médio por habitante dos bens e serviços finais produzidos no país, não captando as desigualdades na distribuição dentro de uma população. Além disso, não considera aspectos qualitativos do desenvolvimento, como saúde, educação, segurança e bem-estar social.
- Esse indicador também ignora atividades não remuneradas, como trabalho doméstico e voluntário, e não reflete os impactos ambientais ou a sustentabilidade do crescimento econômico.
- Assim, o PIB *per capita* oferece uma visão limitada e incompleta do desenvolvimento, devendo ser complementado por outros indicadores mais abrangentes e multidimensionais.

- Como o indicador é calculado a partir de valores correntes da moeda, comparações intertemporais somente podem ser feitas mediante correção dos valores, utilizando-se índice monetário adequado para essa finalidade.
- Os PIBs regionais são divulgados com dois anos de defasagem.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Contas Nacionais (SCN)¹.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Produto interno bruto, em um local e ano de referência}}{\text{População total, em um local e ano de referência}}$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Baixar o pacote de Tabelas Especiais das Tabelas Completas do PIB, pela ótica da produção (2010-2022), da página do Sistema de Contas Regionais, e descompactar a tabela tab01.xls;
- Baixar a tabela de população, por sexo e grupos quinquenais, das projeções de população 2024 da página de Projeções de População (tabela projecoes_2024_tab2_grupo_quinquenal.xlsx);
- Organizar as tabelas usando planilha eletrônica, pacote estatístico ou linguagem de programação; e
- Para obter o indicador para o Brasil ou outra unidade geográfica em um ano qualquer, multiplicar o PIB do ano por 1.000.000 e dividir pela população correspondente.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Unidade da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A Tabela 1 mostra a evolução do PIB *per capita* nominal do Brasil e das regiões entre 2010 e 2022. Em nível nacional, o PIB *per capita* aumentou de R\$ 19.953,10 anuais, em 2010, para R\$ 47.802,00, em 2022, refletindo crescimento médio anual de 7,6%.

No entanto, parte desse aumento é influenciada pela inflação, que impacta os valores nominais. Por isso, a comparação entre as regiões é mais relevante. Entre 2010 e 2022, a região Centro-Oeste apresentou o melhor desempenho, com crescimento médio de 8,3% ao ano, enquanto a região Sudeste registrou o pior desempenho, com crescimento médio anual de 7,2%. Com isso, o Centro-Oeste se tornou a região com maior PIB *per capita* desde 2016.

As disparidades regionais ainda são pronunciadas. Em 2010, o PIB *per capita* na região mais pobre (Nordeste) equivalia a 37% do PIB *per capita* na região mais rica (Sudeste). Em 2022, esse percentual era quase idêntico: o PIB *per capita* na região Nordeste alcançou somente 38% do PIB *per capita* na região Centro-Oeste.

Tabela 1 – Produto interno bruto *per capita* em reais (R\$). Brasil e regiões, 2010 a 2022

Brasil e Regiões	Anos												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brasil	19.953,10	22.310,40	24.357,50	26.761,60	28.778,10	29.622,90	30.751,30	32.091,20	33.913,60	35.541,70	36.380,90	42.893,80	47.802,00
Norte	12.816,70	14.719,90	15.616,30	17.398,90	18.095,20	18.604,70	19.352,50	20.899,10	21.792,10	23.394,70	26.364,20	30.869,60	31.226,30
Nordeste	9.736,40	10.806,30	12.029,20	13.271,40	14.666,00	15.371,60	16.191,40	17.108,10	17.947,20	18.619,50	19.094,80	21.918,80	24.416,70
Sudeste	26.412,10	29.546,70	32.179,00	34.983,60	37.396,00	37.882,60	38.743,70	40.251,80	42.798,60	44.829,20	45.030,10	53.546,30	60.934,90
Sul	22.220,40	24.778,90	27.017,10	30.831,20	32.929,20	34.685,10	36.407,60	37.955,80	40.108,90	42.310,00	43.140,10	51.092,10	54.537,40
Centro-Oeste	24.617,60	27.425,70	30.070,10	32.408,70	35.715,20	37.631,90	40.558,40	41.754,30	43.430,10	45.135,50	48.245,30	56.254,20	63.919,50

Nota:

- Valores correntes em reais (R\$).

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Contas Nacionais Brasil [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; [citado 18 de fevereiro de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9052-sistema-de-contas-nacionais-brasil.html>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.3.05 – Produto interno bruto *per capita* [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18304865





SOC.4.01 – Proporção da população urbana sem acesso seguro à água

SOC.4.01 – Proportion of the urban population without safe water access

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de pessoas em áreas urbanas residentes em domicílios sem acesso seguro à sua principal fonte de abastecimento de água.
- O acesso à água é seguro se a pessoa reside em domicílio urbano cuja principal fonte de água é a rede geral de distribuição, com fornecimento ininterrupto nos 30 dias anteriores à entrevista da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)¹. Outras formas de acesso são consideradas inseguras.

INTERPRETAÇÃO

- Presume-se não haver acesso seguro à água quando o domicílio não conta com fornecimento ininterrupto da rede geral de distribuição.
- As pessoas sem acesso seguro à água: (i) têm acesso à rede com interrupções no fornecimento; (ii) utilizam outras fontes de abastecimento com possíveis problemas de disponibilidade e/ou potabilidade; ou (iii) não têm acesso à água no domicílio.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises relativas ao acesso à água potável no território nacional.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas ao acesso da população à água potável.
- Realizar comparações espaciais e temporais quanto ao acesso da população ou de grupos específicos à água potável.

LIMITAÇÕES

- O indicador pode estar subestimado, porque a PNADC não avalia a qualidade da água fornecida pela rede geral (turbidez, contaminação, cor, odor)².
- Embora outras fontes de abastecimento possam ter água de boa qualidade e disponibilidade, a fonte de dados não permite essa verificação. Por isso, o indicador considera apenas domicílios urbanos.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais; além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População sem acesso seguro à água em domicílios urbanos, em um local e ano de referência}}{\text{População em domicílios urbanos, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, que não foram disponibilizados para 2020 e 2021, quando a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022³.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Renda domiciliar per capita:

- Até ¼ do salário mínimo;
- Mais de ¼ até ½ salário mínimo;
- Mais de ½ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

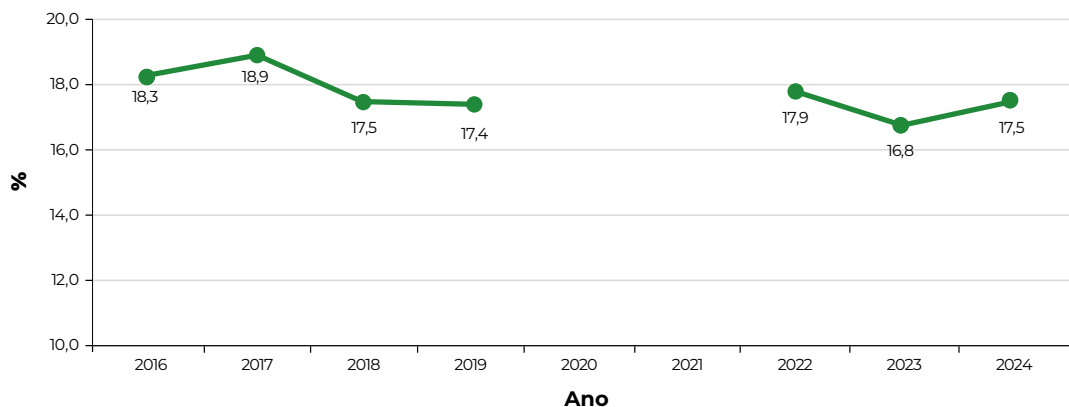
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O acesso seguro à água oscilou muito pouco no período, não apresentando uma tendência clara. Nas áreas urbanas do Brasil, cerca de 18% da população reside em domicílios que não têm a rede geral de distribuição como principal forma de abastecimento de água ou que têm acesso à rede, mas não receberam água diariamente nos últimos 30 dias (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Proporção (%) da população urbana sem acesso seguro à água. Brasil, 2016 a 2024



Notas:

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas.
- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, que não foram disponibilizados para 2020 e 2021, quando a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>
2. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 – Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de pot... [Internet]. Diário Oficial da União nº 85. 2021 [citado 31 de outubro de 2025]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_24_05_2021_rep.html
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.4.01 – Proporção da população urbana sem acesso seguro à água [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18304933



Socioeconômico



SOC.4.02 – Proporção da população urbana sem instalações sanitárias adequadas

SOC.4.02 – Proportion of urban population lacking adequate sanitation facilities

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de pessoas em domicílios urbanos sem banheiro de uso exclusivo dos moradores que tenha coleta de esgoto por rede geral ou pluvial.
- São classificados como inadequados os domicílios que: (i) não possuem banheiro de uso exclusivo dos moradores; e (ii) têm banheiro exclusivo sem conexão à rede de esgoto, de acordo com as informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)¹.
- O banheiro é um cômodo delimitado por paredes, contando com chuveiro ou banheira e vaso sanitário ou privada.
- Em áreas urbanas, o banheiro, com ou sem fossa séptica, deve estar conectado à rede geral ou pluvial para a coleta do esgoto.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a parcela da população sem instalações sanitárias adequadas, incluindo domicílios: (i) apenas com sanitário ou buraco para dejetos; (ii) com banheiro compartilhado entre domicílios; e (iii) com banheiro exclusivo, mas sem conexão à rede coletora de esgoto.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises relativas ao saneamento básico no território nacional.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas ao saneamento básico na população.
- Realizar comparações espaciais e temporais quanto ao acesso ao saneamento básico da população ou de grupos específicos.

LIMITAÇÕES

- O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab)² considera adequada apenas a coleta de esgoto por rede seguida de tratamento, aspecto que não pode ser verificado em pesquisas domiciliares. Embora a fossa séptica não ligada à rede seja usualmente considerada uma forma adequada de escoamento de esgoto, entre 2016 e 2018, a PNADC não distinguia entre fossa séptica e rudimentar.

- Esta distinção foi introduzida apenas em 2019. Até 2018, as categorias eram: rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede; e fossa não ligada à rede. A partir de 2019, passaram a ser: rede geral/pluvial; fossa séptica ligada à rede; fossa séptica não ligada à rede; e fossa rudimentar. Apesar da mudança, é improvável que a fossa rudimentar seja ligada à rede, e a série histórica permite assumir que as fossas ligadas à rede antes de 2019 eram sépticas.
- Para manter a compatibilidade da série desde 2016, considera-se inadequado o banheiro sem escoadouro para rede. Em áreas rurais, embora a fossa séptica sem ligação seja aceitável, não é possível identificar esta situação entre 2016 e 2018, razão pela qual o indicador contempla apenas domicílios urbanos.
- Quanto ao registro de instalações, em 2016 a pesquisa levantava a quantidade de banheiros, sanitários ou buracos para dejeção. A partir de 2017, passou a registrar apenas a quantidade de banheiros, mudança que não afeta o indicador, devido à baixa probabilidade de sanitários e buracos terem escoadouro de esgoto para rede.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais; além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População sem banheiro de uso exclusivo dos moradores com escoadouro de esgoto por rede de captação, em domicílios urbanos, em um local e ano de referência}}{\text{População em domicílios urbanos, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, que não foram disponibilizados para 2020 e 2021, quando a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022³.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

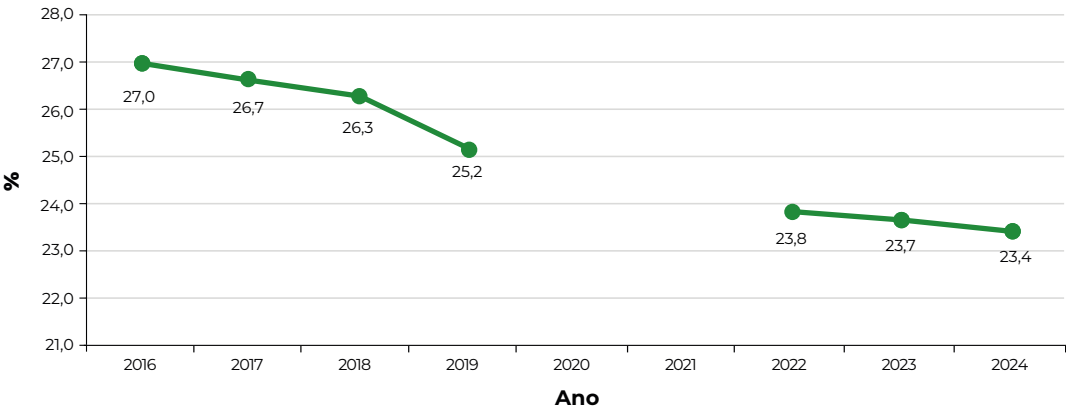
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Embora a série histórica seja curta, houve alguma redução na proporção de pessoas residindo em domicílios sem banheiro de uso exclusivo ou sem esgotamento sanitário por rede, nas áreas urbanas do Brasil (Gráfico 1). Em 2016, o percentual estava em 27%, com diminuição para 23,4% em 2024. No entanto, o progresso concentrou-se no período de 2018 a 2022, com poucas mudanças nos outros anos.

Gráfico 1 – Proporção (%) da população urbana sem instalações sanitárias adequadas. Brasil, 2016 a 2024



Notas:

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas.
- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, que não foram disponibilizados para 2020 e 2021, quando a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticas/operacoes-estatisticas/B5>
2. Ministério das Cidades. Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB [Internet]. Ministério das Cidades. 2014 [citado 31 de outubro de 2025]. Disponível em: https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/plano-nacional-de-saneamento-basico-plansab/arquivos/plansab_texto_editado_para_download.pdf
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.4.02 – Proporção da população urbana sem instalações sanitárias adequadas [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18305031





SOC.4.03 – Proporção da população sem coleta direta ou indireta de lixo

SOC.4.03 – Proportion of the population without waste collection services

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de pessoas que vivem em domicílios sem coleta direta ou indireta de lixo.
- Consideram-se sem coleta de lixo as pessoas que residem em domicílios sem coleta direta ou indireta do lixo domiciliar, de acordo com as informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)¹.
- Nestes domicílios, o lixo é enterrado, queimado, jogado em terrenos baldios, ou tem outra destinação inadequada.

INTERPRETAÇÃO

- A ausência de serviço de limpeza que realize a coleta do lixo domiciliar favorece o acúmulo de resíduos sólidos e líquidos nas proximidades, e a proliferação de vetores de doenças, como mosquitos. Também contribui para a degradação ambiental, contaminando o solo e os cursos d'água, prejudicando ecossistemas locais.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises relativas ao saneamento básico no território nacional.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas ao saneamento básico na população.
- Realizar comparações espaciais e temporais quanto ao acesso da população ou de grupos específicos ao saneamento básico.

LIMITAÇÕES

- O indicador avalia apenas a existência de coleta de lixo, sem serem considerados aspectos importantes, como o tratamento dos resíduos ou a disponibilidade de coleta seletiva.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais; além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População sem coleta de lixo direta ou indireta, em um local e ano de referência}}{\text{População em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Os dados anuais da pesquisa são disseminados em bases que agregam dados de visitas. O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, que não foram disponibilizados para 2020 e 2021, quando a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- O indicador foi calculado com os pesos de pessoas atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022².
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até ¼ do salário mínimo;
- Mais de ¼ até ½ salário mínimo;
- Mais de ½ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

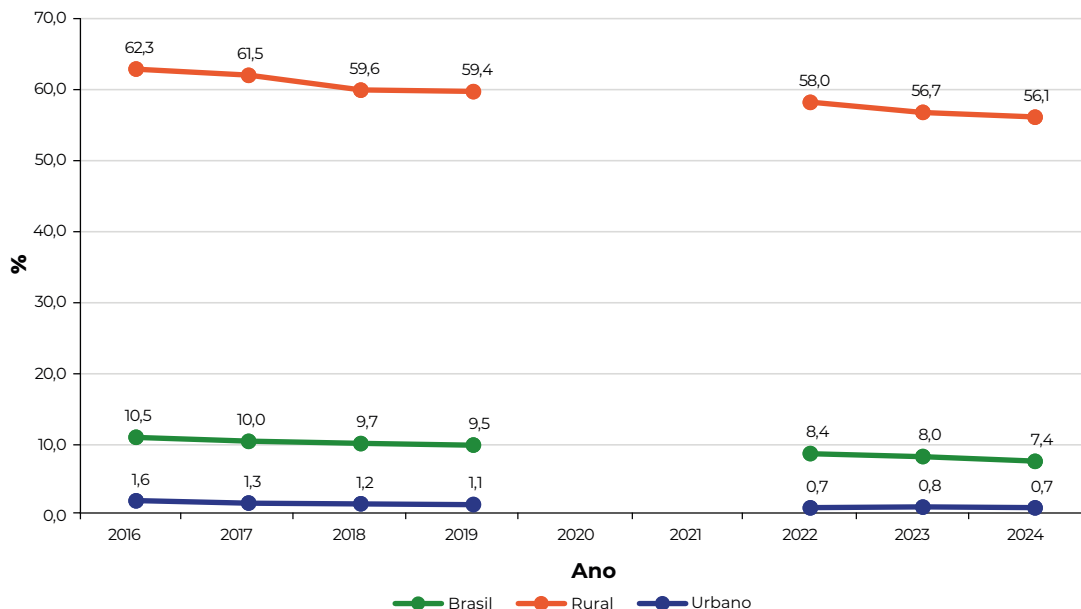
NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, a proporção da população sem coleta direta ou indireta de lixo apresenta uma tendência de suave declínio, tendo passado de 10,5%, em 2016, para 7,4% em 2024. Contudo, há diferenças marcantes segundo a situação do domicílio. Nas áreas rurais do Brasil, em 2024, mais da metade da população não contava com coleta de lixo, enquanto no Brasil urbano a parcela sem coleta era menor que 1% (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Proporção (%) da população sem coleta direta ou indireta de lixo, por situação do domicílio. Brasil, 2016 a 2024



Notas:

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais da 1ª visita, que não foram disponibilizados para 2020 e 2021, quando a pandemia de COVID-19 afetou a coleta de dados da pesquisa.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualização das estimativas populacionais para cálculo dos pesos da PNAD Contínua e reponderação da série histórica em 2025. PNAD Contínua. Nota Técnica 02/2025 [Internet]. IBGE. 2025 [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102194>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.4.03 – Proporção da população sem coleta direta ou indireta de lixo [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18305098





SOC.5.01 – Proporção da população em situação de insegurança alimentar moderada ou grave

SOC.5.01 – Proportion of the population in moderate or severe food insecurity

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de pessoas em situação de insegurança alimentar moderada ou grave.
- O grau de insegurança alimentar dos domicílios é medido pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA). A EBIA é uma escala psicométrica que representa a percepção sobre o acesso e a regularidade da disponibilidade de alimentos para os moradores do domicílio¹. A insegurança é classificada nos níveis descritos a seguir.
 - (i) Sem insegurança alimentar: os moradores do domicílio têm acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente.
 - (ii) Insegurança alimentar leve: comprometimento da qualidade da alimentação, buscando-se a manutenção da quantidade percebida como adequada.
 - (iii) Insegurança alimentar moderada: modificações nos padrões usuais da alimentação entre os adultos, com restrição na quantidade de alimentos entre estes.
 - (iv) Insegurança alimentar grave: quebra do padrão usual da alimentação, com comprometimento da qualidade e redução da quantidade de alimentos de todos os membros da família, inclusive das crianças residentes no domicílio, podendo ainda incluir a experiência de fome.
- O indicador considera as pessoas em insegurança alimentar moderada e grave, de acordo com as informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)².

INTERPRETAÇÃO

- Insegurança alimentar significa não haver acesso regular a alimentos em quantidade suficiente para o atendimento das necessidades alimentares, o que ocasiona privação ou ruptura nos padrões de consumo do domicílio.

USOS

- Monitorar o indicador e subsidiar as análises relativas à saúde e à alimentação no território nacional.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas relacionadas à saúde e à alimentação da população.
- Realizar comparações espaciais e temporais quanto à saúde e alimentação da população ou de grupos específicos.

LIMITAÇÕES

- Não permite avaliar a adequação nutricional dos alimentos dos domicílios, ou seja, o acesso aos alimentos em termos de qualidade, na perspectiva de uma alimentação saudável e adequada.
- A EBIA capta a percepção sobre o acesso aos alimentos na quantidade e qualidade que o entrevistado compreende como adequados para si.
- Para a avaliação da adequação nutricional, são necessários outros indicadores e métodos.
- Por se utilizar a PNADC, que é uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais; além disso, é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNADC não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{População com insegurança alimentar moderada ou grave, em um local e ano de referência}}{\text{População em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais do 4º trimestre, no qual se aplica um questionário suplementar, que inclui as questões da EBIA. O tema só está disponível na PNADC a partir de 2023.
- O intervalo de confiança das estimativas deve ser calculado usando-se os pesos de pessoas fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 200 replicações da amostra produzidas por *bootstrapping*.
- No momento de elaboração desta ficha, os pesos atualizados conforme as novas estimativas populacionais baseadas no Censo Demográfico de 2022 ainda não estavam disponíveis para os microdados anuais do 4º trimestre.
- A desagregação por faixa de renda domiciliar por pessoa usa dados imputados pelo IBGE para domicílios na 2ª, 3ª e 4ª visitas.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;

- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Renda domiciliar per capita:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbana; e
- Rural.

Tipo de município:

- Capital: Municípios que são capitais de Unidades da Federação (UFs);
- Região Metropolitana (RM) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma RM, exceto a capital;
- Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) sem capital: Municípios de uma UF que integram uma Ride, exceto a capital; e
- Resto da Unidade da Federação (UF): Municípios que não são capitais de UFs nem integrantes de RM ou Ride.

GRANULARIDADE _____

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

NOTA _____

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Em 2023, primeiro ano em que a PNADC investigou a segurança alimentar e nutricional por meio da EBIA, estimou-se que 9,5% da população estava em insegurança alimentar moderada ou grave, isto é, sofriam restrições no acesso a alimentos, considerando-se sua qualidade e quantidade reduzidas para adultos e crianças (Tabela 1). As disparidades regionais são enormes: o percentual estimado para a região Norte é quase quatro vezes maior do que na região Sul.

Tabela 1 – Proporção (%) da população em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, segundo região e situação do domicílio. Brasil, 2023

Brasil e regiões	2023
Brasil	9,5
Norte	17,4
Nordeste	14,6
Sudeste	6,6
Sul	4,7
Centro-Oeste	7,6
Situação de domicílio	
Urbano	8,9
Rural	13,7

Notas:

- O indicador foi computado a partir dos microdados anuais do 4º trimestre, no qual se aplica um questionário suplementar, que inclui as questões da EBIA.
- O tema só está disponível na PNADC a partir de 2023.
- Os intervalos de confiança das estimativas foram omitidos para facilitar a visualização.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Segurança alimentar – 2023 [Internet]. IBGE. 2024 [citado 31 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102084.pdf>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. IBGE. [citado 28 de outubro de 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-estatisticas/B5>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores Socioeconômicos. SOC.5.01 – Proporção da população em situação de insegurança alimentar moderada ou grave [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18305199





INDICADORES DE MORTALIDADE (MRT)

Indicadores de mortalidade (MRT)

A construção dos indicadores de mortalidade apresentados nesta edição resultou de um processo de trabalho colaborativo, envolvendo análises técnicas, pactuação metodológica e revisões sucessivas realizadas pelos grupos temáticos e pelo Comitê Gestor Interagencial (CGI). Esse processo compreendeu a atualização das definições operacionais, a revisão das fontes de dados, o controle das séries históricas e a incorporação de recomendações provenientes das instâncias de vigilância, assistência e produção estatística. Cada indicador foi elaborado com base em critérios de consistência, comparabilidade e relevância para a análise da situação de saúde no país, assegurando coerência tanto com o marco conceitual da Ripsa quanto com as demandas contemporâneas de monitoramento e avaliação em saúde pública.

No cenário atual da saúde no Brasil e, especialmente, no Sistema Único de Saúde (SUS), os indicadores de mortalidade desempenham papel central na identificação de desigualdades, na definição de prioridades e no direcionamento de políticas públicas. Eles permitem acompanhar tendências epidemiológicas, avaliar a efetividade das ações de vigilância, monitorar o impacto de doenças e agravos e orientar intervenções voltadas à redução de mortes. Exemplos importantes incluem a razão de mortalidade materna, que auxilia na compreensão das condições de atenção obstétrica e de acesso aos serviços; a taxa de mortalidade infantil, que reflete condições de vida, nutrição e cuidado materno-infantil; e as taxas de mortalidade por doenças infecciosas, que ganharam destaque no contexto da pandemia de COVID-19, pela necessidade de respostas oportunas, vigilância qualificada e planejamento integrado para emergências sanitárias. Esses exemplos ilustram como diferentes indicadores permitem interpretar dinâmicas específicas e subsidiar decisões estratégicas em saúde.

Os indicadores apresentados são, portanto, fruto de um rigoroso processo colaborativo e constituem ferramentas centrais para a identificação de desigualdades e o direcionamento de políticas públicas no SUS. Eles permitem interpretar dinâmicas específicas da saúde da população e subsidiar decisões estratégicas fundamentadas.



Dimensão 1 – Mortalidade infantil e na infância

- MRT.1.01 – Taxa de mortalidade infantil
- MRT.1.02 – Taxa de mortalidade neonatal precoce
- MRT.1.03 – Taxa de mortalidade neonatal tardia
- MRT.1.04 – Taxa de mortalidade pós-neonatal
- MRT.1.05 – Taxa de mortalidade em menores de 5 anos

Dimensão 2 – Mortalidade materna

- MRT.2.01 – Razão de mortalidade materna
- MRT.2.02 – Mortalidade materna segundo grupos de causa

Dimensão 3 – Mortalidade geral

- MRT.3.01 – Mortalidade proporcional por causas
- MRT.3.02 – Proporção de óbitos por causas mal definidas

Dimensão 4 – Mortalidade por causas externas

- MRT.4.01 – Taxa de mortalidade por agressão
- MRT.4.02 – Taxa de mortalidade por lesão autoprovocada
- MRT.4.03 – Taxa de mortalidade por lesão de trânsito
- MRT.4.04 – Taxa de mortalidade por causas acidentais

Dimensão 5 – Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis

- MRT.5.01 – Taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis
- MRT.5.02 – Taxa de mortalidade por neoplasias malignas
- MRT.5.03 – Taxa de mortalidade por diabetes *mellitus*
- MRT.5.04 – Taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares
- MRT.5.05 – Taxa de mortalidade por doenças respiratórias crônicas
- MRT.5.06 – Probabilidade de morte prematura por doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes *mellitus* e doenças respiratórias crônicas

Dimensão 6 – Mortalidade por doenças transmissíveis

- MRT.6.01 – Taxa de mortalidade específica por doenças infecciosas e parasitárias



MRT.1.01 – Taxa de mortalidade infantil

MRT.1.01 – Infant mortality rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de óbitos de menores de 1 ano de idade, por mil nascidos vivos, de mães residentes em um local e ano de referência. É expressa por mil nascidos vivos.

INTERPRETAÇÃO

- Importante indicador de saúde e das condições de vida de uma população.
- Estima o risco de um nascido vivo morrer antes de completar o primeiro ano de vida.
- A taxa de mortalidade infantil é um indicador de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, sofrendo influência direta de fatores como escolaridade e cor ou raça da mãe, renda, insegurança alimentar e nutricional, saneamento básico e meio ambiente^{1,2}.
- Reflete também o acesso aos serviços de saúde e a qualidade dos recursos disponíveis para a atenção à saúde materna e infantil.
- A mortalidade infantil é dividida nos componentes neonatal (precoce e tardio) e pós-neonatal, apresentados em seção específica³.
- O risco de morte, a composição de causas e fatores de risco variam entre os componentes.

USOS

- Analisar as variações da mortalidade infantil em diferentes grupos populacionais, regiões geográficas e ao longo do tempo, identificando-se desigualdades e padrões de ocorrência que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir na avaliação das condições de saúde e de desenvolvimento socioeconômico, prestando-se a comparações nacionais e internacionais.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas tanto para o desenvolvimento econômico e social como para a atenção pré-natal, ao parto, ao nascimento, e à proteção da saúde infantil.

LIMITAÇÕES

- Para os anos de 2000 a 2014, o cálculo do indicador requer correção da subenumeração de óbitos e de nascidos vivos, dos registros provenientes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), especialmente em Unidades da Federação (UFs) das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

- De forma geral, o uso de estimativas pode envolver dificuldades metodológicas e limites de acurácia que são inerentes à técnica utilizada.
- O cálculo da taxa de mortalidade infantil, em nível municipal, apresenta desafios, uma vez que pequenas variações absolutas podem resultar em grande instabilidade dos coeficientes. Dessa forma, os resultados por município não são disponibilizados.
- Nos anos de 2015 em diante, o cálculo do indicador demanda o uso de estimativas de óbitos e de nascidos vivos obtidas a partir de dados do SIM, do Sinasc e do Registro Civil, utilizando-se a técnica de captura e recaptura⁴. Esse método é empregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Saúde para o referido período.

FONTES DE DADOS

- De 2000 a 2014, os nascidos vivos estimados e óbitos estimados que constam nos indicadores implícitos na projeção da população (IBGE)⁵.
- De 2015 em diante, os nascidos vivos estimados e óbitos infantis estimados que constam das Estimativas de sub-registro de nascimentos e óbitos (IBGE)⁶, construídas a partir de insumos derivados do pareamento entre os dados do SIM e do Sinasc e dados da pesquisa do Registro Civil (IBGE), e aplicação do método de captura e recaptura.
- Para operacionalizar os cálculos com base nos dados diretos dos sistemas SIM e Sinasc, dispensando pesquisa nas fontes mencionadas acima, o Ministério da Saúde publica, anualmente, fatores de correção atualizados para cada UF, para aplicar ao resultado dos cálculos com dados diretos para todo o período a partir de 2000, de acordo com a fórmula e o método de cálculo descritos abaixo. Estes fatores de correção são divulgados nas páginas do Ministério da Saúde e nos Indicadores e Dados Básicos (IDB) da Ripsa.

FÓRMULAS DE CÁLCULO

1. Para uso com dados diretos do SIM e Sinasc.

$$\frac{\text{Número de óbitos de residentes menores de 1 ano de idade obtidos diretamente do SIM, em local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de residentes obtidos diretamente do Sinasc, em um local e ano de referência}} \times 1.000 \times \text{F.C.TMI}^*$$

Nota:

- *F.C.TMI = fatores de correção para a taxa de mortalidade infantil divulgados pelo Ministério da Saúde.

2. Para uso com dados estimados.

$$\frac{\text{Número de óbitos estimados de residentes menores de 1 ano de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos estimados de residentes, em um local e ano de referência}} \times 1.000$$

MÉTODOS DE CÁLCULO

Existem duas alternativas que levam aos mesmos resultados, conforme explicitado a seguir.

1. Usando dados diretos do SIM e do Sinasc e aplicando fatores de correção.

Para operacionalizar o cálculo da taxa de mortalidade infantil para todo o período, usando dados diretos do SIM e Sinasc, deve-se dividir o número de óbitos de menores de 1 ano obtidos diretamente do SIM (numerador) pelo número de nascidos vivos obtidos diretamente do Sinasc (denominador), e o resultado deve ser multiplicado por 1.000, e em seguida pelo fator de correção para a taxa de mortalidade infantil divulgado pelo Ministério da Saúde.

2. Usando dados estimados.

Para o cálculo da taxa de mortalidade infantil de 2000 até 2014, deve-se extrair o número de nascidos vivos estimados (denominador) e o número de óbitos de menores de 1 ano de idade estimados (numerador), dos indicadores implícitos na projeção da população, edição 2024, publicados pelo IBGE⁵.

Para o cálculo da taxa de mortalidade infantil de 2015 em diante, deve-se extrair o número de nascidos vivos estimados (denominador) e o número de óbitos de menores de 1 ano de idade estimados (numerador), das Estimativas de sub-registro de nascimentos e óbitos, publicadas pelo IBGE⁶.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Unidades da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

Exemplo para calcular a TMI do Brasil em 2023:

1. Com dados diretos do SIM e do Sinasc.

- Numerador: Número de óbitos infantis obtido diretamente do SIM: 32.017.
- Denominador: Número de nascidos vivos obtido diretamente do Sinasc: 2.537.576.
- Fator de correção (publicado no IDB Ripsa): 1,0114.
- Fórmula de cálculo da TMI: $((32.017/2.537.576) \times 1.000) \times 1,0114$.

TMI = 12,8 por 1.000 nascidos vivos.

2. Com dados estimados.

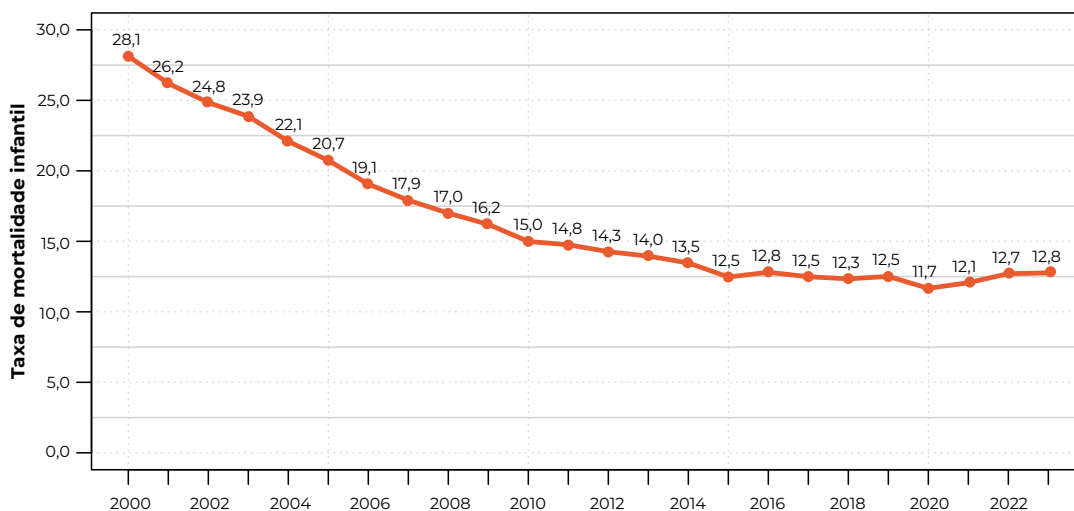
- **Numerador:** Número de óbitos infantis estimados: 32.521.
- **Denominador:** Número de nascidos vivos estimados: 2.548.509.
- **Fator de correção:** Não se aplica.
- **Fórmula de cálculo da TMI:** $(32.521/2.548.509) \times 1.000$.

TMI = 12,8 por 1.000 nascidos vivos.

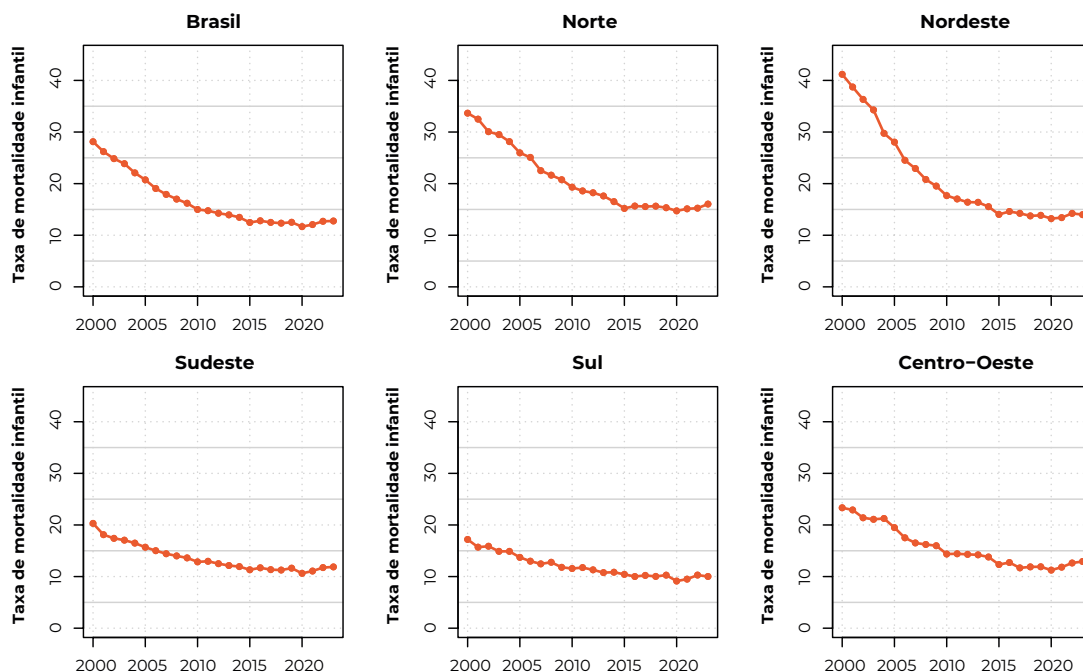
ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A taxa de mortalidade infantil no Brasil diminuiu acentuadamente no período de 2000 a 2015, passando de 28,1 para 12,5 óbitos por mil nascidos vivos. Em 2016, houve aumento em comparação com o ano anterior, relacionado à epidemia do vírus Zika. De 2017 a 2019, a taxa de mortalidade infantil manteve-se estável, com valores próximos de 12,5 óbitos por mil nascidos vivos. Em 2020, declinou para 11,7 por mil nascidos vivos. A partir de 2021, com a pandemia da COVID-19, a taxa voltou a aumentar, alcançando 12,8 óbitos por mil nascidos vivos em 2023 (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos. Brasil, 2000 a 2023



No período de 2000 a 2023, entre as regiões brasileiras, o Norte e o Nordeste exibiram os declínios mais acentuados das taxas de mortalidade infantil, de 33,7 e 41,2 para 16,0 e 14,0 óbitos infantis por mil nascidos vivos, respectivamente. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, as taxas diminuíram de 20,3, 17,2 e 23,3 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 11,9, 10,0 e 12,9 por mil nascidos vivos, em 2023, respectivamente (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Taxa de mortalidade infantil, por mil nascidos vivos. Brasil e regiões, 2000 a 2023

REFERÊNCIAS

1. Rebouças P, Goes E, Pescarini J, Ramos D, Ichihara MY, Sena S, et al. Ethnoracial inequalities and child mortality in Brazil: a nationwide longitudinal study of 19 million newborn babies. *Lancet Glob Health* [Internet]. 1º de outubro de 2022 [citado 3 de julho de 2025];10(10):e1453–62. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36113530/>
2. Ebrahim NB, Atteraya MS. Inequalities of Infant Mortality in Ethiopia. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 1º de junho de 2023 [citado 3 de julho de 2025];20(12). Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37372655/>
3. United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. CME Info – Child Mortality Estimates [Internet]. 2024 [citado 3 de julho de 2025]. Disponível em: <https://childmortality.org/all-cause-mortality/data?indicator=MRY0&refArea=MMR>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos: Estimativas desagregadas dos totais de nascidos vivos e óbitos: 2016-2019. IBGE [Internet]. 2016 [citado 1º de abril de 2025]; 2022:1–36. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101927.pdf>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores Implícitos – Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: 2000-2070 [Internet]. IBGE. [citado 24 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Estatísticas Vitais – Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos [Internet]. [citado 3 de julho de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.1.01 – Taxa de mortalidade infantil [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18376908





MRT.1.02 – Taxa de mortalidade neonatal precoce

MRT.1.02 – Early neonatal mortality rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de óbitos de crianças com menos de 7 dias de vida, por mil nascidos vivos, de mães residentes em um local e ano de referência. É expressa por mil nascidos vivos.

INTERPRETAÇÃO

- Trata-se de um dos componentes da mortalidade infantil.
- Estima o risco de morte de um nascido vivo antes de este completar 7 dias de vida.
- Reflete, de maneira geral, as condições sociais, econômicas, ambientais, os fatores maternos, congênitos e genéticos, bem como questões relacionadas à atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido¹.
- A primeira semana de vida é o período de maior risco de morte, entre os menores de 1 ano.

USOS

- Analisar as variações da mortalidade neonatal precoce em diferentes grupos populacionais, áreas geográficas e ao longo do tempo, identificando-se desigualdades e padrões de ocorrência que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir para a avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico, prestando-se a comparações nacionais e internacionais.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à atenção à mulher, ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

LIMITAÇÕES

- Para os anos de 2000 a 2014, o cálculo do indicador requer a correção da subnumeração de óbitos e de nascidos vivos (neste último caso, em menor escala) dos registros provenientes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), especialmente nas Unidades da Federação (UFs) das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
- De forma geral, o uso de estimativas pode envolver dificuldades metodológicas e limites de acurácia que são inerentes à técnica utilizada.
- O cálculo das taxas de mortalidade neonatal precoce em nível municipal apresenta desafios, pois variações absolutas mínimas resultam em grande instabilidade dos coeficientes. Dessa forma, os resultados por município ainda não são disponibilizados.

- Nos anos de 2015 em diante, o cálculo do indicador demanda o uso de estimativas de óbitos e de nascidos vivos obtidas a partir de dados do SIM, do Sinasc e do Registro Civil, utilizando-se a técnica de captura e recaptura². Esse método é empregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Saúde no referido período.

FONTES DE DADOS

- De 2000 a 2014, os nascidos vivos estimados e óbitos infantis estimados que constam nos indicadores implícitos na projeção da população³. O número de óbitos neonatais precoces estimados é calculado a partir da proporção de óbitos neonatais precoces obtida do total de óbitos infantis observada no SIM para o recorte territorial e o ano definidos.
- De 2015 em diante, os nascidos vivos estimados e óbitos infantis estimados que constam nas estimativas de sub-registro de nascimentos e óbitos², construídas a partir de insumos derivados do pareamento entre os dados do SIM e do Sinasc e dados da pesquisa do Registro Civil (IBGE), e aplicação do método de captura e recaptura. O número de óbitos neonatais precoces estimados é calculado a partir da proporção de óbitos neonatais precoces obtida do total de óbitos infantis observada no SIM para o recorte territorial e o ano definidos.
- Para operacionalizar os cálculos com base nos dados diretos dos sistemas SIM e Sinasc, dispensando pesquisa nas fontes mencionadas acima, o Ministério da Saúde publica, anualmente, fatores de correção atualizados para cada UF, para aplicar ao resultado dos cálculos com dados diretos para todo o período a partir de 2000, de acordo com a fórmula e o método de cálculo descritos abaixo. Estes fatores de correção são divulgados nas páginas do Ministério da Saúde e nos Indicadores e Dados Básicos (IDB) da Ripsa.

FÓRMULAS DE CÁLCULO

- Para uso com dados diretos do SIM e Sinasc.

$$\frac{\text{Número de óbitos de residentes com 0 a 6 dias de idade, obtido diretamente do SIM, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de residentes, obtido diretamente do Sinasc, em um local e ano de referência}} \times 1.000 \times \text{F.C.TMNP}^*$$

Nota:

- *F.C.TMNP = fatores de correção para taxas de mortalidade neonatal precoce divulgados pelo Ministério da Saúde.

- Para uso com dados estimados.

$$\frac{\text{Número de óbitos estimados de residentes com 0 a 6 dias de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de nascidos vivos, de residentes, em um local e ano de referência}} \times 1.000$$

MÉTODOS DE CÁLCULO

Existem duas alternativas que levam aos mesmos resultados, conforme explicitado a seguir.

1. Usando dados diretos do SIM e do Sinasc e aplicando fatores de correção.

Para operacionalização do cálculo da taxa de mortalidade neonatal precoce para todo o período, usando dados diretos do SIM e do Sinasc, deve-se dividir o número de óbitos de recém-nascidos com 0 a 6 dias de idade do SIM (numerador) pelo número de nascidos vivos do Sinasc (denominador), e o resultado deve ser multiplicado por 1.000, e, em seguida, pelo fator de correção para a taxa de mortalidade neonatal precoce divulgado pelo Ministério da Saúde.

2. Usando dados estimados.

A fórmula clássica da taxa de mortalidade neonatal precoce está apresentada na subseção em que consta a fórmula de cálculo para uso com dados estimados. Contudo, uma vez que a taxa de mortalidade neonatal precoce é estimada a partir de uma taxa de mortalidade infantil previamente calculada, torna-se necessária a aplicação da formulação alternativa abaixo descrita.

Para o cálculo da taxa de mortalidade neonatal precoce, multiplica-se a taxa de mortalidade infantil pela proporção de óbitos de recém-nascidos com 0 a 6 dias de idade, em relação ao total de óbitos de menores de 1 ano informados no SIM (excluídos os óbitos de idade ignorada).

$$TMNP_{t,s} = TM I_{t,s} \times \left(\frac{D_{0-6,t,s}}{D_{<1,t,s}} \right)$$

Onde:

- $TMNP_{t,s}$ = taxa de mortalidade neonatal precoce no ano t e no espaço s ;
- $TM I_{t,s}$ = taxa de mortalidade infantil no ano t e no espaço s , calculada conforme a ficha MRT.1.01;
- $D_{0-6,t,s}$ = número de óbitos ocorridos entre zero e 6 dias de vida, no ano t e no espaço s , obtido da base de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM);
- $D_{<1,t,s}$ = número de óbitos de menores de 1 ano de idade, excluídos os óbitos com idade ignorada, no ano t e no espaço s , obtido do SIM.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Unidades da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

Exemplo para calcular a TMNP do Brasil em 2023:

1. Com dados diretos do SIM e do Sinasc.

- Numerador: Número de óbitos de crianças de 0 a 6 dias obtido diretamente do SIM: 15.933.
- Denominador: Número de nascidos vivos obtido diretamente do Sinasc: 2.537.576.
- Fator de correção (publicado no IDB Ripsa): 1,0114.
- Fórmula de cálculo da TMNP: $((15.933/2.537.576) \times 1.000) \times 1,0114$.

TMNP = 6,4 por 1.000 nascidos vivos.

2. Com dados estimados.

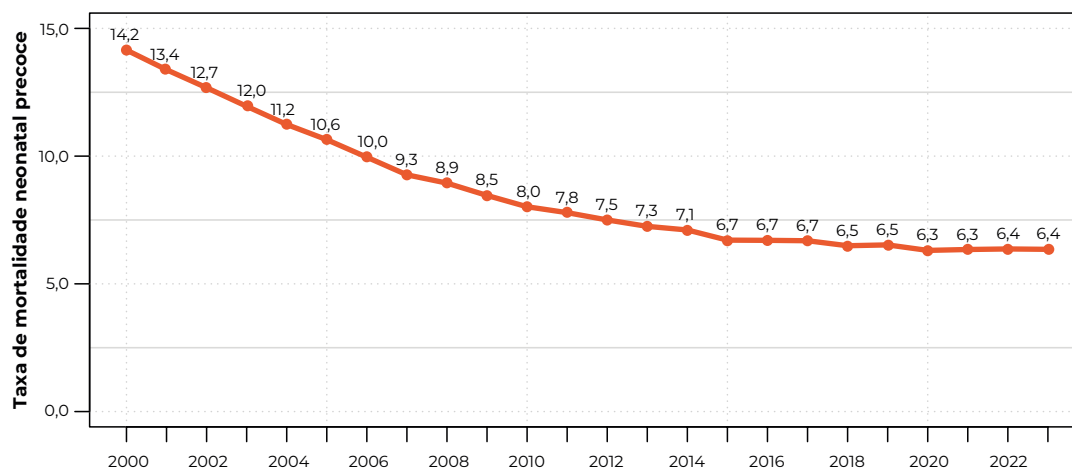
- Numerador: Número de óbitos de crianças de 0 a 6 dias estimados: 16.185.
- Denominador: Número de nascidos vivos estimados: 2.548.509.
- Fator de correção: Não se aplica.
- Fórmula de cálculo da TMNP: $(16.185/2.548.509) \times 1.000$.

TMNP = 6,4 por 1.000 nascidos vivos.

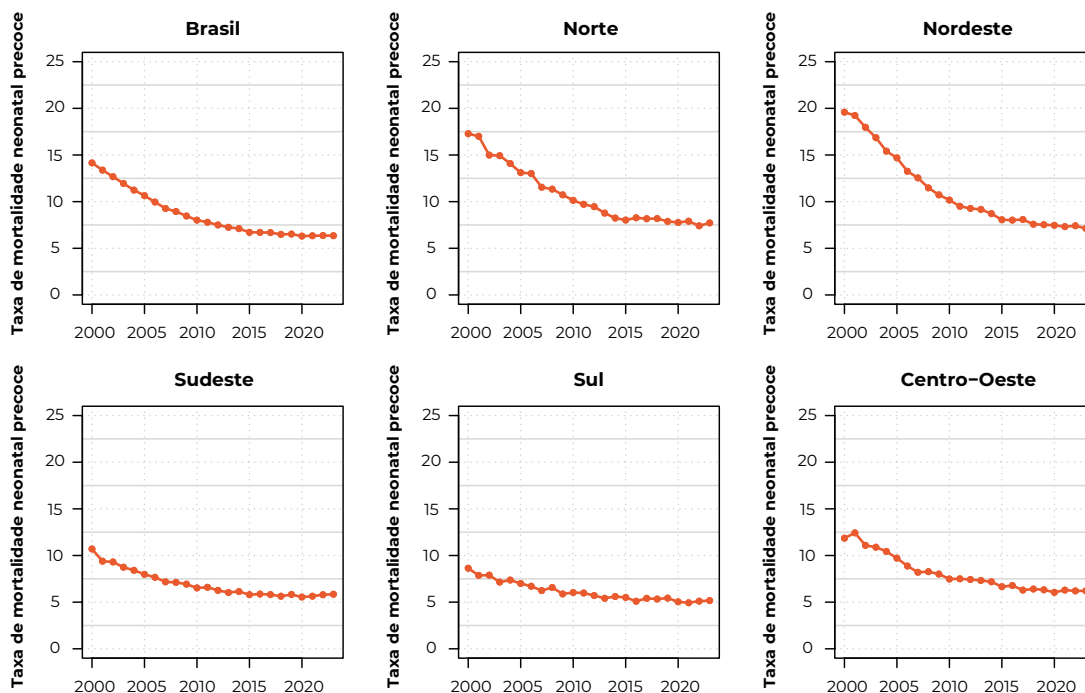
ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A taxa de mortalidade neonatal precoce do Brasil diminuiu de 14,2 óbitos por mil nascidos vivos, no ano 2000, para 6,3 óbitos por mil nascidos vivos, no ano 2020 e, nos anos seguintes, manteve-se praticamente estável nesse valor, semelhante às taxas registradas no período da pandemia (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Taxa de mortalidade neonatal precoce por mil nascidos vivos. Brasil, 2000 a 2023



Entre as regiões do Brasil, o Norte e o Nordeste exibiram os maiores decréscimos, de 17,3 e 19,6 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 7,7 e 7,1 óbitos por mil nascidos vivos, em 2023, respectivamente. Na região Sul, houve redução de 8,6 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 5,1 por mil nascidos vivos, em 2016, seguida por estabilidade (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Taxa de mortalidade neonatal precoce, por mil nascidos vivos. Brasil e regiões, 2000 a 2023

REFERÊNCIAS

1. Tamir TT, Mohammed Y, Kassie AT, Zegeye AF. Early neonatal mortality and determinants in sub-Saharan Africa: Findings from recent demographic and health survey data. PLoS One [Internet]. 1º de junho de 2024 [citado 3 de julho de 2025];19(6):e0304065. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0304065>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Estatísticas Vitais – Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos [Internet]. [citado 3 de julho de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores Implícitos – Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: 2000-2070 [Internet]. IBGE. [citado 24 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.1.02 – Taxa de mortalidade neonatal precoce [Internet] Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18377049



Mortalidade



MRT.1.03 – Taxa de mortalidade neonatal tardia

MRT.1.03 – Late neonatal mortality rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de óbitos de crianças de 7 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos de mães residentes, em um local e ano de referência. É expressa por mil nascidos vivos.

INTERPRETAÇÃO

- Trata-se de um dos componentes da mortalidade infantil.
- Estima o risco de morte dos 7 aos 27 dias de vida.
- Reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, bem como o acesso aos serviços de saúde e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e infantil.
- Os óbitos neonatais ocorrem, em sua maioria, por causas evitáveis, especialmente por falta da adequada atenção à gestante e ao recém-nascido¹.

USOS

- Analisar as variações da mortalidade neonatal tardia em diferentes grupos populacionais, regiões geográficas e ao longo do tempo, identificando-se desigualdades e padrões de ocorrência que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir para a avaliação das condições de saúde e de desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população, prestando-se a comparações nacionais e internacionais.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas à atenção pré-natal, ao parto e ao nascimento, bem como à proteção da saúde infantil.

LIMITAÇÕES

- Para os anos de 2000 a 2014, o cálculo do indicador requer a correção da subenumeração de óbitos e de nascidos vivos (neste último caso, em menor escala) dos registros provenientes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), especialmente nas Unidades da Federação (UFs) das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
- De forma geral, o uso de estimativas pode envolver dificuldades metodológicas e limitações de acurácia inerentes à técnica utilizada.
- O cálculo da taxa de mortalidade neonatal tardia em nível municipal apresenta desafios, uma vez que pequenas variações absolutas podem resultar em grande instabilidade dos coeficientes. Dessa forma, os resultados por município não são disponibilizados.

- Nos anos de 2015 em diante, o cálculo do indicador demanda o uso de estimativas de óbitos e de nascidos vivos obtidas a partir de dados do SIM, do Sinasc e do Registro Civil, utilizando-se a técnica de captura e recaptura². Esse método é empregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Saúde para o referido período.

FONTES DE DADOS

- De 2000 a 2014, as estimativas de nascidos vivos e de óbitos infantis que constam nos indicadores implícitos na projeção da população³. O número de óbitos neonatais tardios estimados é calculado a partir da proporção de óbitos neonatais tardios obtida do total de óbitos infantis observado no SIM para o recorte territorial e o ano definidos.
- De 2015 em diante, os nascidos vivos estimados e óbitos infantis estimados que constam nas Estimativas de sub-registro de nascimentos e óbitos², construídas a partir de insumos derivados do pareamento entre os dados do SIM e do Sinasc e dados da pesquisa do Registro Civil (IBGE), e aplicação do método de captura e recaptura. O número de óbitos neonatais tardios estimados é calculado a partir da proporção de óbitos neonatais tardios obtida do total de óbitos infantis observado no SIM para o recorte territorial e o ano definidos.
- Para operacionalizar os cálculos com base nos dados diretos dos sistemas SIM e Sinasc, dispensando pesquisa nas fontes mencionadas acima, o Ministério da Saúde publica, anualmente, fatores de correção atualizados para cada UF, para aplicação ao resultado dos cálculos com dados diretos para todo o período a partir de 2000, de acordo com a fórmula e o método de cálculo descritos abaixo. Estes fatores de correção são divulgados nas páginas do Ministério da Saúde e nos Indicadores e Dados Básicos (IDB) da Ripsa.

FÓRMULAS DE CÁLCULO

- Para uso com dados diretos do SIM e Sinasc.

$$\frac{\text{Número de óbitos de residentes de 7 a 27 dias de idade, obtido diretamente do SIM, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de residentes, obtido diretamente do Sinasc, em um local e ano de referência}} \times 1.000 \times \text{F.C.TMNT}^*$$

Nota:

- *F.C.TMNT = fatores de correção para taxa de mortalidade neonatal tardia divulgados pelo Ministério da Saúde.

- Para uso com dados estimados.

$$\frac{\text{Número de óbitos estimados, de residentes de 7 a 27 dias de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de nascidos vivos, de residentes, em um local e ano de referência}} \times 1.000$$

MÉTODOS DE CÁLCULO

Existem duas alternativas que levam aos mesmos resultados, conforme explicitado a seguir.

1. Usando dados diretos do SIM e do Sinasc e aplicando fatores de correção.

Para operacionalizar o cálculo da taxa de mortalidade neonatal tardia para todo o período, usando dados diretos do SIM e do Sinasc, deve-se dividir o número de óbitos de recém-nascidos com 7 a 27 dias de idade do SIM (numerador) pelo número de nascidos vivos do Sinasc (denominador), e o resultado deve ser multiplicado por 1.000, e, em seguida, pelo fator de correção para a taxa de mortalidade neonatal tardia divulgado pelo Ministério da Saúde.

2. Usando dados estimados.

A fórmula clássica da taxa de mortalidade neonatal tardia está apresentada na subseção referente à fórmula de cálculo para uso com dados estimados. Contudo, uma vez que a taxa de mortalidade neonatal tardia é estimada a partir de uma taxa de mortalidade infantil previamente calculada, torna-se necessária a aplicação da formulação alternativa abaixo descrita.

Para o cálculo da taxa de mortalidade neonatal tardia, multiplica-se a taxa de mortalidade infantil pela proporção de óbitos de recém-nascidos com 7 a 27 dias de idade, em relação ao total de óbitos de menores de 1 ano informados no SIM (excluídos os óbitos de idade ignorada).

$$TMNT_{t,s} = TMI_{t,s} \times \left(\frac{D_{7-27,t,s}}{D_{<1,t,s}} \right)$$

Onde:

- $TMNT_{t,s}$ = taxa de mortalidade neonatal tardia no ano t e no espaço s ;
- $TMI_{t,s}$ = taxa de mortalidade infantil no ano t e no espaço s , calculada conforme a ficha MRT.1.01;
- $D_{7-27,t,s}$ = número de óbitos ocorridos entre 7 e 27 dias de vida, no ano t e no espaço s , obtido da base de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM);
- $D_{<1,t,s}$ = número de óbitos de menores de um 1 de idade, excluídos os óbitos com idade ignorada, no ano t e no espaço s , obtido do SIM.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Unidades da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

Exemplo para calcular a TMNT do Brasil em 2023:

1. Com dados diretos do SIM e do Sinasc.

- Numerador: Número de óbitos de crianças de 7 a 27 dias obtido diretamente do SIM: 5.649.
 - Denominador: Número de nascidos vivos obtido diretamente do Sinasc: 2.537.576.
 - Fator de correção (publicado no IDB Ripsa): 1,0114.
 - Fórmula de cálculo da TMNT: $((5.649/2.537.576) \times 1.000) \times 1,0114$.
- TMNT = 2,3 por 1.000 nascidos vivos.

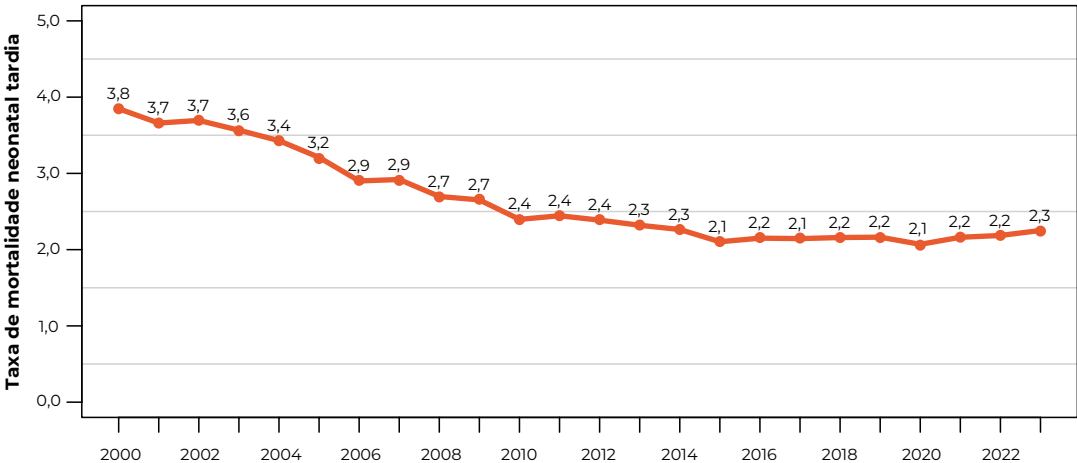
2. Com dados estimados.

- Numerador: Número de óbitos de crianças de 7 a 27 dias estimados: 5.738.
 - Denominador: Número de nascidos vivos estimados: 2.548.509.
 - Fator de correção: Não se aplica.
 - Fórmula de cálculo da TMNT: $(5.738/2.548.509) \times 1.000$.
- TMNT = 2,3 por 1.000 nascidos vivos.

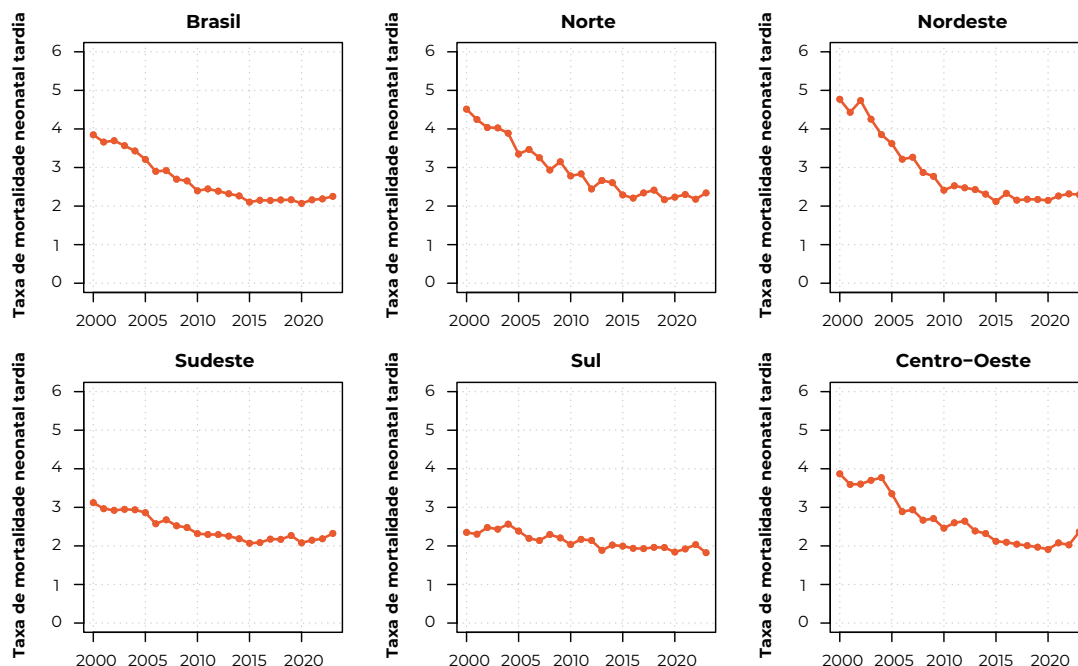
ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A taxa de mortalidade neonatal tardia do Brasil diminuiu, de 3,8 óbitos por mil nascidos vivos, no ano 2000, para 2,1 óbitos por mil nascidos vivos, no ano de 2015. Manteve-se praticamente estável até 2020, e subiu nos três anos seguintes, chegando a 2,3 óbitos por mil nascidos vivos em 2023 (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Taxa de mortalidade neonatal tardia, por mil nascidos vivos. Brasil, 2000 a 2023



Entre as regiões do Brasil, as maiores reduções das taxas de mortalidade neonatal tardia ocorreram no Norte e no Nordeste, de 4,5 e 4,8 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 2,3 e 2,3 óbitos por mil nascidos vivos, em 2023, respectivamente. Em todas as regiões, exceto o Centro-Oeste, houve declínio da taxa até aproximadamente 2015, seguida por estabilidade até 2020, e aumento nos anos seguintes. Na região Centro-Oeste, a diminuição estendeu-se até 2020, mas também houve crescimento da taxa de 2021 a 2023 (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Taxa de mortalidade neonatal tardia, por mil nascidos vivos. Brasil e regiões, 2000 a 2023

REFERÊNCIAS

1. Gaiva MAM, Fujimori E, Sato APS. Mortalidade neonatal: análise das causas evitáveis [Neonatal mortality: analysis of preventable causes]. Revista Enfermagem UERJ [Internet]. 19 de maio de 2015 [citado 3 de julho de 2025];23(2):247–53. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/enfermagemuerj/article/view/5794/18245>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Estatísticas Vitais – Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos [Internet]. [citado 3 de julho de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores Implícitos – Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: 2000-2070 [Internet]. IBGE. [citado 24 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.1.03 – Taxa de mortalidade neonatal tardia [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18377156



Mortalidade



MRT.1.04 – Taxa de mortalidade pós-neonatal

MRT.1.04 – Post-neonatal mortality rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de óbitos de 28 a 364 dias de vida completos, por mil nascidos vivos de mães residentes, em um local e ano de referência. É expressa por mil nascidos vivos.

INTERPRETAÇÃO

- Trata-se de um dos componentes da mortalidade infantil.
- Estima o risco de morte dos 28 aos 364 dias de vida.
- De modo geral, altos valores da taxa de mortalidade pós-neonatal expressam circunstâncias ambientais e socioeconômicas precárias, que condicionam a ocorrência de doenças infecciosas e desnutrição infantil¹.
- O acesso aos serviços de saúde e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e infantil são também determinantes da mortalidade nesse grupo etário¹.

USOS

- Analisar as variações da mortalidade pós-neonatal em diferentes grupos populacionais, regiões geográficas e ao longo do tempo, identificando-se desigualdades e padrões de ocorrência que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir na avaliação das condições de saúde e de desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população, prestando-se a comparações nacionais e internacionais.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas à atenção pré-natal, ao parto e ao nascimento, bem como à proteção da saúde infantil.

LIMITAÇÕES

- Para os anos de 2000 a 2014, o cálculo do indicador requer a correção da subenumeração de óbitos e de nascidos vivos (neste último caso, em menor escala) dos registros provenientes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), especialmente nas Unidades da Federação (UFs) das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
- De forma geral, o uso de estimativas pode envolver dificuldades metodológicas e limites de acurácia que são inerentes à técnica utilizada.
- O cálculo das taxas de mortalidade pós-neonatal em nível municipal apresenta desafios, pois variações absolutas mínimas resultam em grande instabilidade dos coeficientes. Dessa forma, os resultados por município ainda não são disponibilizados.

- Nos anos de 2015 em diante, o cálculo do indicador demanda o uso de estimativas de óbitos e de nascidos vivos obtidas a partir de dados do SIM, do Sinasc e do Registro Civil, utilizando-se a técnica de captura e recaptura². Esse método é empregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Saúde no referido período.

FONTES DE DADOS

- De 2000 a 2014, as estimativas de nascidos vivos e de óbitos infantis que constam nos indicadores implícitos na projeção da população³. O número de óbitos pós-neonatais estimados é calculado a partir da proporção de óbitos pós-neonatais obtida do total de óbitos infantis observado no SIM para o recorte territorial e o ano definidos.
- De 2015 em diante, os nascidos vivos estimados e óbitos infantis estimados que constam nas Estimativas de sub-registro de nascimentos e óbitos², construídas a partir de insumos derivados do pareamento entre os dados do SIM e do Sinasc e dados da pesquisa do Registro Civil (IBGE), e aplicação do método de captura e recaptura. O número de óbitos pós-neonatais estimados é calculado a partir da proporção de óbitos pós-neonatais obtida do total de óbitos infantis observado no SIM para o recorte territorial e o ano definidos.
- Para operacionalizar os cálculos com base nos dados diretos dos sistemas SIM e Sinasc, dispensando pesquisa nas fontes mencionadas acima, o Ministério da Saúde publica, anualmente, fatores de correção atualizados para cada UF, para aplicação ao resultado dos cálculos com dados diretos para todo o período a partir de 2000, de acordo com a fórmula e o método de cálculo descritos abaixo. Estes fatores de correção são divulgados nas páginas do Ministério da Saúde e nos Indicadores e Dados Básicos (IDB) da Ripsa.

FÓRMULAS DE CÁLCULO

- Para uso com dados diretos do SIM e Sinasc.

$$\frac{\text{Número de óbitos de residentes com 28 a 364 dias de idade, obtido diretamente do SIM, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de residentes, obtido diretamente do Sinasc, em um local e ano de referência}} \times 1.000 \times \text{F.C.TMPN}^*$$

Nota:

- *F.C.TMPN = fatores de correção para taxa de mortalidade pós-neonatal divulgados pelo Ministério da Saúde.

- Para uso com dados estimados.

$$\frac{\text{Número estimado de óbitos, de residentes com 28 a 364 dias de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de nascidos vivos, de residentes, em um local e ano de referência}} \times 1.000$$

MÉTODOS DE CÁLCULO

Existem duas alternativas que levam aos mesmos resultados, conforme explicitado a seguir.

1. Usando dados diretos do SIM e do Sinasc e aplicando fatores de correção.

Para operacionalizar o cálculo da taxa de mortalidade pós-neonatal para todo o período, usando dados diretos do SIM e do Sinasc, deve-se dividir o número de óbitos de crianças com 28 a 364 dias de idade do SIM (numerador) pelo número de nascidos vivos do Sinasc (denominador), e o resultado deve ser multiplicado por 1.000, e, em seguida, pelo fator de correção para a taxa de mortalidade pós-neonatal divulgado pelo Ministério da Saúde.

2. Usando dados estimados.

A fórmula clássica da taxa de mortalidade pós-neonatal está apresentada na subseção referente à fórmula de cálculo para uso com dados estimados. Contudo, uma vez que a taxa de mortalidade pós-neonatal é estimada a partir de uma taxa de mortalidade infantil previamente calculada, torna-se necessária a aplicação da formulação alternativa abaixo descrita.

Para o cálculo da taxa de mortalidade pós-neonatal, multiplica-se a taxa de mortalidade infantil pela proporção de óbitos de crianças com 28 a 364 dias de idade, em relação ao total de óbitos de menores de 1 ano informados no SIM (excluídos os óbitos de idade ignorada).

$$TMPN_{t,s} = TM I_{t,s} \times \left(\frac{D_{28-364,t,s}}{D_{<1,t,s}} \right)$$

Onde:

- $TMPN_{t,s}$ = taxa de mortalidade pós-neonatal no ano t e no espaço s ;
- $TM I_{t,s}$ = taxa de mortalidade infantil no ano t e no espaço s , calculada conforme a ficha MRT.1.01;
- $D_{28-364,t,s}$ = número de óbitos ocorridos entre 28 e 364 dias de vida, no ano t e no espaço s , obtido da base de dados do SIM;
- $D_{<1,t,s}$ = número de óbitos de menores de 1 ano de idade (excluídos os óbitos com idade ignorada), no ano t e no espaço s , obtido do SIM.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Unidades da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

Exemplo para calcular a TMPN do Brasil em 2023:

1. Com dados diretos do SIM e do Sinasc.

- Numerador: Número de óbitos de crianças de 28 a 364 dias obtido diretamente do SIM: 10.434.
- Denominador: Número de nascidos vivos obtido diretamente do Sinasc: 2.537.576.
- Fator de correção (publicado no IDB Ripsa): 1,0114.
- Fórmula de cálculo da TMPN: $((10.434/2.537.576) \times 1.000) \times 1,0114$.

TMPN = 4,2 por 1.000 nascidos vivos.

2. Com dados estimados.

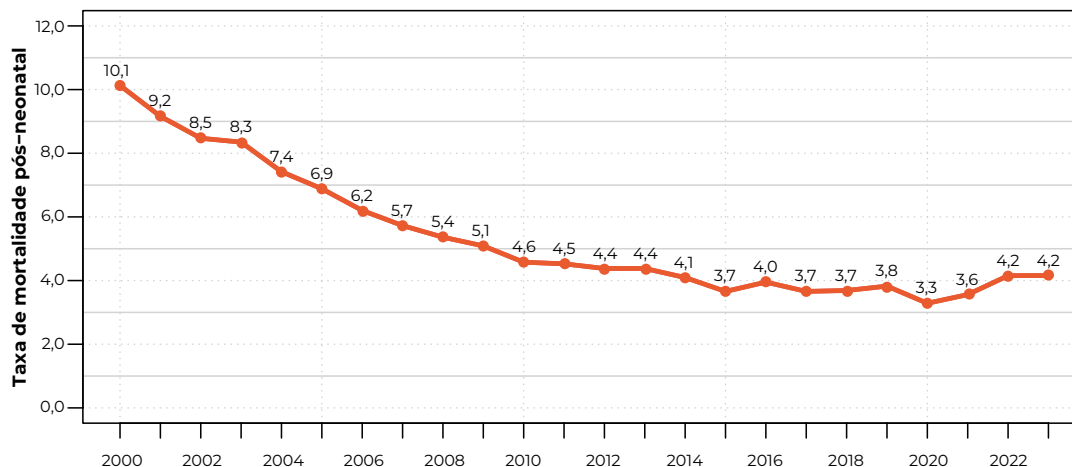
- Numerador: Número de óbitos de crianças de 28 a 364 dias estimados: 10.599.
- Denominador: Número de nascidos vivos estimados: 2.548.509.
- Fator de correção: Não se aplica.
- Fórmula de cálculo da TMPN: $(10.599/2.548.509) \times 1.000$.

TMPN = 4,2 por 1.000 nascidos vivos.

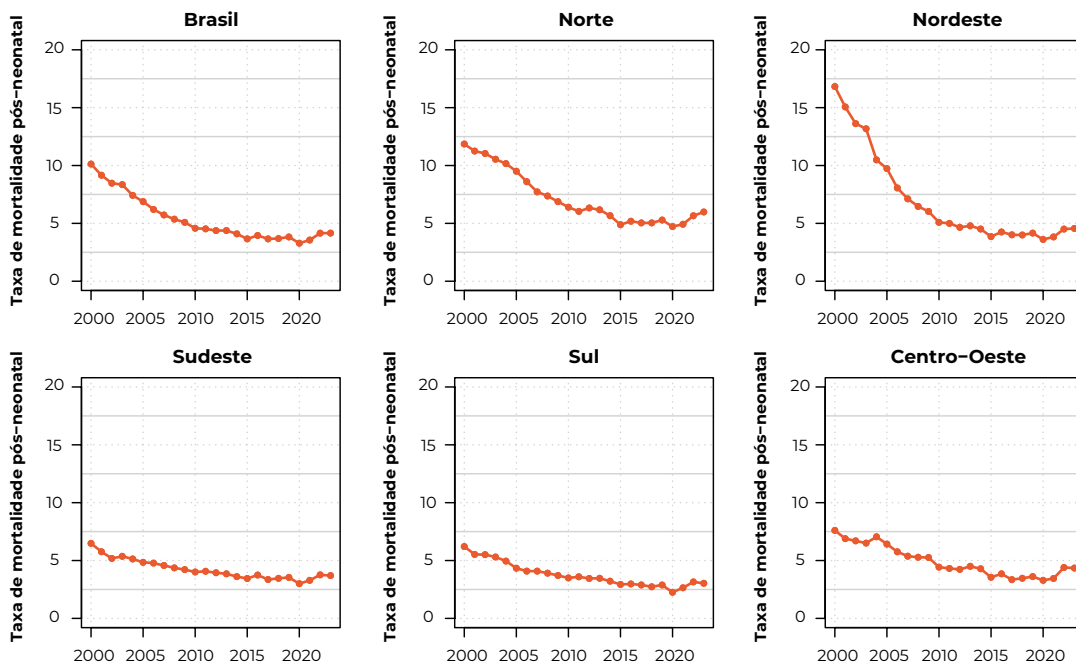
ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A taxa de mortalidade pós-neonatal do Brasil diminuiu sensivelmente, de 10,1, no ano 2000, para 3,3, no ano de 2020. Nos dois anos seguintes, aumentou para 4,2, e praticamente manteve esse valor em 2023 (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Taxa de mortalidade pós-neonatal, por mil nascidos vivos. Brasil, 2000 a 2023



Entre as regiões do Brasil, as maiores diminuições ocorreram no Norte e no Nordeste, que passaram de 11,9 e 16,8, em 2000, para 6,0 e 4,6, em 2023, respectivamente. Em todas as regiões, houve declínio da taxa de mortalidade pós-neonatal até o ano de 2020, primeiro ano da pandemia de COVID-19, seguido por aumentos em 2021 e 2022 (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Taxa de mortalidade pós-neonatal, por mil nascidos vivos. Brasil e regiões, 2000 a 2023

REFERÊNCIAS

1. Rebouças P, Falcão IR, Barreto ML. Social inequalities and their impact on children's health: a current and global perspective. J Pediatr (Rio J) [Internet]. 1º de março de 2022 [citado 3 de julho de 2025];98(Suppl 1):S55–65. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34951980/>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Estatísticas Vitais – Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos [Internet]. [citado 3 de julho de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores Implícitos – Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: 2000-2070 [Internet]. IBGE. [citado 24 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.1.04 – Taxa de mortalidade pós-neonatal [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18377382



Mortalidade



MRT.1.05 – Taxa de mortalidade em menores de 5 anos

MRT.1.05 – Under-five child mortality rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de óbitos de menores de 5 anos de idade, por mil nascidos vivos, de mães residentes em um local e ano de referência. É expressa por mil nascidos vivos.

INTERPRETAÇÃO

- Importante indicador de saúde e condições de vida de uma população.
- Estima o risco de morte durante os 5 primeiros anos de vida.
- Reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, bem como o acesso aos serviços de saúde e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e infantil: ou seja, mais que um indicador de saúde, é um indicador social, pois sofre influência direta de diversos fatores, como escolaridade e cor ou raça da mãe, insegurança alimentar e nutricional, saneamento básico e meio ambiente^{1,2}.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade de menores de 5 anos, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir na avaliação das condições de saúde e de desenvolvimento socioeconômico e ambiental da população, prestando-se a comparações nacionais e internacionais.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas – sobretudo na área ambiental – e de ações de saúde voltadas à atenção pré-natal e ao parto, bem como à proteção da saúde na infância.

LIMITAÇÕES

- Para os anos de 2000 a 2014, o cálculo do indicador requer correção da subnumeração de óbitos e de nascidos vivos (neste último caso, em menor escala), dos registros provenientes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), especialmente em Unidades da Federação (UFs) das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
- Nos anos de 2015 em diante, o cálculo do indicador demanda o uso de estimativas de óbitos e de nascidos vivos obtidas a partir de dados do SIM, do Sinasc e do Registro Civil, utilizando-se a técnica de captura e recaptura³. Esse método é empregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Saúde para o referido período.

- De forma geral, o uso de estimativas pode envolver dificuldades metodológicas e limites de acurácia que são inerentes à técnica utilizada. A validade do indicador é restringida para pequenas populações, especialmente quando se refere a eventos de pequenas dimensões.

FONTES DE DADOS

- De 2000 a 2014, os nascidos vivos constam nos indicadores implícitos na projeção da população⁴.
- De 2000 a 2014, os óbitos foram obtidos reconstruindo-se as tábuas de mortalidade obtidas da projeção da população, edição 2024, publicadas pelo IBGE⁵.
- De 2015 em diante, os nascidos vivos e óbitos em menores de 5 anos constam das Estimativas de sub-registro de nascimentos e óbitos (IBGE)³, construídas a partir de insumos derivados do pareamento entre os dados do SIM e do Sinasc e dados da pesquisa do Registro Civil (IBGE), e aplicação do método de captura e recaptura.
- Para operacionalizar os cálculos com base nos dados diretos dos sistemas SIM e Sinasc, dispensando pesquisa nas fontes mencionadas acima, o Ministério da Saúde publica, anualmente, fatores de correção atualizados para cada UF, para aplicar ao resultado dos cálculos com dados diretos para todo o período a partir de 2000, conforme fórmula e método de cálculo descritos abaixo. Estes fatores de correção são divulgados nas páginas do Ministério da Saúde e nos Indicadores e Dados Básicos (IDB) da Ripsa.

FÓRMULAS DE CÁLCULO

1. Para uso com dados diretos do SIM e Sinasc.

$$\frac{\text{Número de óbitos de residentes com 0 a 4 anos de idade obtido diretamente do SIM, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de residentes obtido diretamente do Sinasc, em um local e ano de referência}} \times 1.000 \times \text{F.C.TM}<5^*$$

Nota:

- *F.C.TM<5 = fatores de correção para taxa de mortalidade de menores de 5 anos divulgados pelo Ministério da Saúde.

2. Para uso com dados estimados.

$$\frac{\text{Número estimado de óbitos de residentes com 0 a 4 anos de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de nascidos vivos de residentes, em um local e ano de referência}} \times 1.000$$

MÉTODOS DE CÁLCULO

Existem duas alternativas que levam aos mesmos resultados, conforme explicitado a seguir.

1. Usando dados diretos do SIM e do Sinasc e aplicando fatores de correção.

Para operacionalização do cálculo da taxa de mortalidade de menores de 5 anos para todo o período, usando dados diretos do SIM e do Sinasc, deve-se dividir o número de óbitos de crianças de 0 a 4 anos do SIM (numerador) pelo número de nascidos vivos do Sinasc (denominador), e o resultado deve ser multiplicado por 1.000, e, em seguida, pelo fator de correção para menores de 5 anos específico para o recorte territorial e o ano definidos.

2. Usando dados estimados.

Para o cálculo da taxa de mortalidade em menores de 5 anos, no período de 2000 até 2014, primeiro deve-se extrair o número de nascidos vivos (denominador) dos indicadores implícitos na projeção da população, edição 2024, publicados pelo IBGE⁴. Em seguida, deve-se obter o número de óbitos em menores de 5 anos de idade (numerador) a partir das tábuas de mortalidade obtidas da projeção da população, edição 2024, publicadas pelo IBGE⁵.

Para se calcular a taxa de mortalidade em menores de 5 anos de 2015 em diante, deve-se extrair o número de nascidos vivos (denominador) e o número de óbitos em menores de 5 anos de idade (numerador) das Estimativas de sub-registro de nascimentos e óbitos, publicadas pelo IBGE³.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Unidades da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

Exemplo para calcular a TM < 5 do Brasil em 2023:

1. Com dados diretos do SIM e do Sinasc.

- Numerador: Número de óbitos de crianças de 0 a 4 anos obtido diretamente do SIM: 37.952.
- Denominador: Número de nascidos vivos obtido diretamente do Sinasc: 2.537.576.
- Fator de correção (publicado no IDB Ripsa): 1,0109.
- Fórmula de cálculo da TM < 5: $((37.952/2.537.576) \times 1.000) \times 1,0109$.

TM < 5 = 15,1 por 1.000 nascidos vivos.

2. Com dados estimados.

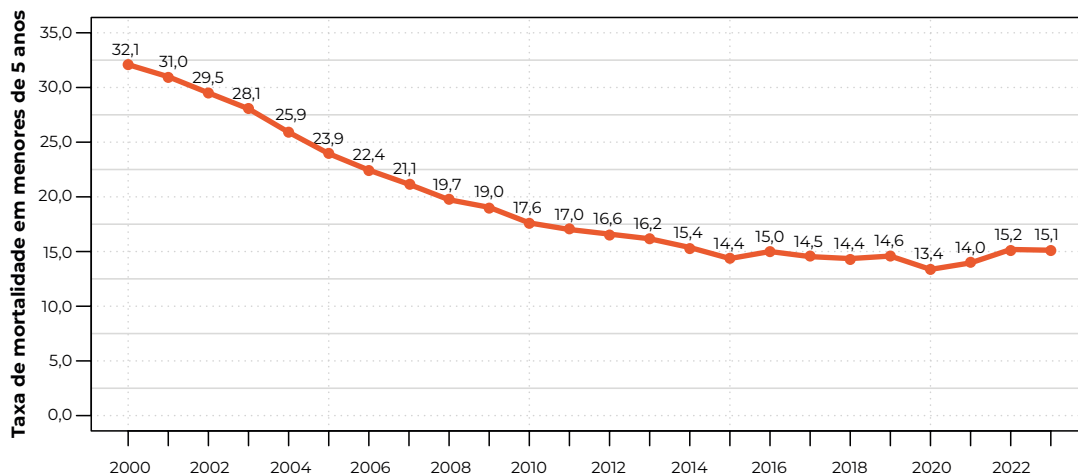
- Numerador: Número de óbitos de crianças de 0 a 4 anos estimados: 38.533.
- Denominador: Número de nascidos vivos estimados: 2.548.509.
- Fator de correção: Não se aplica.
- Fórmula de cálculo da TM<5: $(38.533/2.548.509) \times 1.000$.

TM < 5 = 15,1 por 1.000 nascidos vivos.

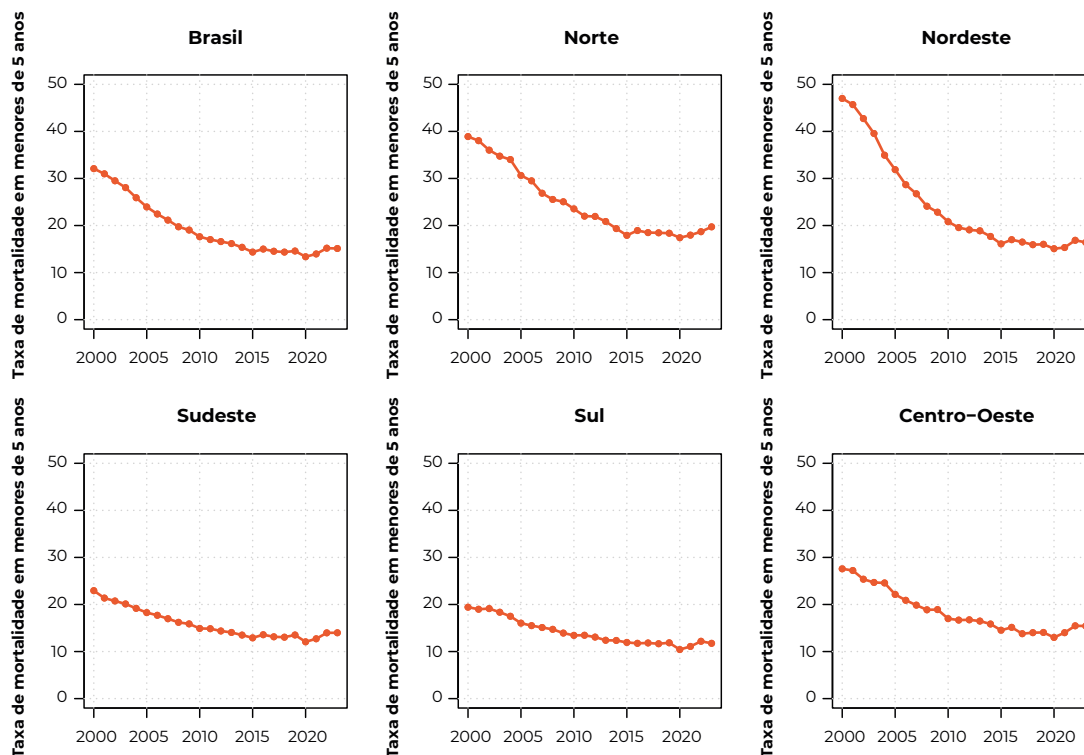
ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A taxa de mortalidade em menores de 5 anos no Brasil diminuiu acentuadamente do ano 2000 até o ano de 2015, passando de 32,1 para 14,4 por mil nascidos vivos. De 2015 a 2019, a taxa manteve-se estável. Em 2020, houve redução para 13,4 óbitos por mil nascidos vivos, seguida por aumento com a pandemia, passando a 15,2, em 2022, e 15,1, em 2023 (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Taxa de mortalidade em menores de 5 anos, por mil nascidos vivos. Brasil, 2000 a 2023



Entre as regiões brasileiras, um padrão de série temporal semelhante ao Brasil foi observado no Norte e no Nordeste, onde a taxa de mortalidade em menores de 5 anos diminuiu de 38,9 e 47,0, em 2000, para 19,7 e 16,4 óbitos por mil nascidos vivos, em 2023, respectivamente. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, as taxas diminuíram de 22,9, 19,4 e 27,6 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 14, 11,7 e 15,4 óbitos por mil nascidos vivos, em 2023, respectivamente (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Taxa de mortalidade em menores de 5 anos, por mil nascidos vivos. Brasil e regiões, 2000 a 2023

REFERÊNCIAS

1. Rebouças P, Goes E, Pescarini J, Ramos D, Ichihara MY, Sena S, et al. Ethnoracial inequalities and child mortality in Brazil: a nationwide longitudinal study of 19 million newborn babies. *Lancet Glob Health* [Internet]. 1º de outubro de 2022 [citado 3 de julho de 2025];10(10):e1453–62. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36113530/>
2. Ebrahim NB, Atteraya MS. Inequalities of Infant Mortality in Ethiopia. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 1º de junho de 2023 [citado 3 de julho de 2025];20(12). Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37372655/>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Estatísticas Vitais – Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos [Internet]. [citado 3 de julho de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores Implícitos – Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: 2000-2070 [Internet]. IBGE. [citado 24 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tábuas de Mortalidade – Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: 2000-2070 [Internet]. IBGE. 2024 [citado 20 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=resultados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.1.05 – Taxa de mortalidade em menores de 5 anos [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18377449



Mortalidade



MRT.2.01 – Razão de mortalidade materna

MRT.2.01 – Maternal mortality ratio

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Razão entre o número de óbitos maternos e o de nascidos vivos, de mães residentes em um local e ano de referência. É expressa por 100 mil nascidos vivos.
- A morte materna é definida como a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração e da localização da gravidez, por qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém, não por causas acidentais ou incidentais¹.

INTERPRETAÇÃO

- Número de óbitos femininos, ocorridos durante a gravidez ou até 42 dias após o término da gravidez, atribuídos a causas ligadas à gravidez, ao parto e ao puerpério, a cada 100 mil nascidos vivos. O número de nascidos vivos é adotado como uma aproximação do total de mulheres grávidas.
- Em grande parte, as mortes maternas são consideradas evitáveis e relacionadas à qualidade da atenção à saúde da mulher. Nesse sentido, níveis elevados de mortalidade materna refletem a insatisfatória prestação de serviços de saúde a esse grupo – desde o planejamento familiar e a assistência pré-natal, até o parto e o puerpério, passando pelas complicações obstétricas, incluindo-se o aborto.

USOS

- Analisar as diferenças na mortalidade materna entre diferentes grupos populacionais, regiões geográficas e ao longo do tempo, identificando-se desigualdades e tendências que necessitam de ações e estudos específicos.
- Realizar comparações nacionais e internacionais, para o que se adota a definição internacional de morte materna, ocorrida até 42 dias após o término da gestação. Para determinadas análises no âmbito nacional, utiliza-se o conceito de mortalidade materna tardia (ver Notas).
- Contribuir para a avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à atenção pré-natal, ao parto, ao aborto e ao puerpério.

LIMITAÇÕES

- A subnotificação e a classificação incorreta da causa da morte de mulheres em idade fértil podem levar a uma subenumeração das mortes maternas, o que demanda a utilização de métodos de correção.

- Dados sobre investigações dos óbitos maternos realizadas pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, usados nos métodos de correção, podem não ser suficientes para representar a magnitude real das mortes maternas em um determinado território.
- Os fatores de correção devem ser aplicados com cautela, pois, em algumas regiões, os dados obtidos diretamente do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) podem já estar, em alguma medida, corrigidos por investigação sistemática dos óbitos de mulheres em idade fértil.
- O acesso aos dados de anos mais recentes está limitado ao prazo descrito na Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009², do Ministério da Saúde, segundo a qual os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade devem ser divulgados até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência, em caráter oficial.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)³.
- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)⁴.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos maternos entre mães residentes em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de mães residentes em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de mortes com causas básicas classificadas no capítulo XV da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10), com exceção dos códigos O96 e O97 (morte materna tardia e morte por seqüela de causa obstétrica direta), em um local e ano de referência.

Algumas doenças que não constam no capítulo XV também devem ser consideradas, a saber: tétano obstétrico (A34, cap. I), osteomalácia puerperal (M83.0, cap. XIII), transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério (F53, cap. V), necrose pós-parto da hipófise (E23.0, cap. IV), mola hidatiforme maligna (D39.2, cap. II) e doenças causadas pelo vírus da imunodeficiência humana (B20 a B24, cap. I). Nos últimos três casos, deve ficar comprovada a relação com o estado gravídico-puerperal, e o óbito deve ter ocorrido até 42 dias após o parto, conforme notificado ao SIM e registrado nestas variáveis da Declaração de Óbito (DO): “causa básica”, “óbito na gravidez” e “óbito no puerpério”.

- **Denominador:** Número de nascidos vivos de mães residentes no mesmo local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.000.

Aplicação de fatores de correção: devido a problemas de subnotificação, no período de 2009 a 2023, o numerador da razão de mortalidade materna (RMM) é corrigido, dando origem à chamada *RMM vigilância*. Essa correção é aplicada apenas nas Unidades da Federação (UFs) em que a variação percentual no número de óbitos maternos declarados ao SIM, antes

e depois da investigação de óbito de mulher em idade fértil, for menor que 34,3% (valor de referência). Os fatores de correção são calculados para cada ano. UFs sujeitas à correção em um ano podem não ser as mesmas de anos anteriores.

Ressalte-se que não se utiliza fator de correção no denominador, apenas no numerador. Detalhes sobre a correção estão descritas na publicação do Saúde Brasil 2017, no capítulo sobre mortalidade materna⁵.

Os fatores de correção estão discriminados nos quadros 1 e 2, de acordo com o período e a unidade de análise considerada.

Quadro 1 – Fator de correção para razão de morte materna. Brasil, 2000 a 2023

Período	Método	Granularidade
2009 a 2023	Fator de correção calculado utilizando-se a metodologia da vigilância de óbitos de mulher em idade fértil	Brasil
2008	Foi utilizado o fator de correção de 1,2	Brasil
2000 a 2007 ⁶	Foi utilizado o fator de correção de 1,4	Brasil

Quadro 2 – Fator de correção para razão de morte materna. Unidades da Federação, 2000 a 2023

Período	Método	Granularidade
2009 a 2023	Fator de correção calculado utilizando-se a metodologia da vigilância de óbitos de mulher em idade fértil	Todas as Unidades da Federação (UFs)
2000 a 2008	RMM calculada sem fator de correção para as UFs que atingiram índice final (cobertura e regularidade do SIM) igual ou superior a 80% e cobertura do Sinasc igual ou superior a 90%	Calculados , sem fator de correção, apenas para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Unidades da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- A CID-10 define morte materna como a “morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais”.
- As mortes maternas são causadas por afecções do capítulo XV da CID-10 – Gravidez, parto e puerpério (com exceção das mortes fora do período do puerpério de 42 dias – códigos O96 e O97) e por afecções classificadas em outros capítulos da CID, especificamente as listadas a seguir.
 - (i) Tétano obstétrico (A34), transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério (F53) e osteomalácia puerperal (M83.0), nos casos em que a morte ocorreu até 42 dias após o término da gravidez (campo 44 da DO assinalado “sim”) ou nos casos sem informação do tempo transcorrido entre o término da gravidez e a morte (campo 44 da DO em branco ou assinalado “ignorado”).
 - (ii) Doença causada pelo HIV (B20 a B24), mola hidatiforme maligna ou invasiva (D39.2) e necrose hipofisária pós-parto (E23.0) serão consideradas mortes maternas, desde que a mulher estivesse grávida no momento da morte ou tivesse estado grávida até 42 dias antes da morte. Para isso, devem ser considerados os casos em que o campo 43 da DO (morte durante gravidez, parto e aborto) esteja marcado “sim”, ou o campo 44 (morte durante o puerpério) assinalado “sim, até 42 dias”.
 - (iii) Para os óbitos por aids, até 2020, serão considerados os códigos B20 a B24. A partir de 2021, usar o código O98.7.
- A CID-10 estabelece ainda os conceitos de: morte materna tardia, decorrente de causa obstétrica, ocorrida após 42 dias e menos de um ano depois do parto (código O96); e morte materna por sequela de causa obstétrica direta, ocorrida um ano ou mais após o parto (código O97). Estes casos também não são incluídos para o cálculo da RMM¹.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Entre 2010 e 2019, a RMM no Brasil apresentou redução, ainda que com oscilações regionais persistentes. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste mantiveram valores mais elevados ao longo do período, refletindo desigualdades no acesso à atenção pré-natal, ao parto e ao puerpério, além de diferenças estruturais e socioeconômicas entre os territórios.

A partir de 2020, observa-se um aumento expressivo da RMM em todo o país, com pico em 2021, fortemente associado ao impacto da pandemia de COVID-19. Esse cenário decorreu tanto do aumento direto de óbitos maternos por COVID-19 quanto de efeitos indiretos, como a sobrecarga dos serviços de saúde, a interrupção de linhas de cuidado e as barreiras de acesso à atenção obstétrica. A ampliação da vacinação contra a COVID-19 a partir de 2021 – incluindo-se a recomendação para gestantes e puérperas – foi um fator central para a redução do risco e a proteção desse grupo no período subsequente.

Em 2022 e 2023, verifica-se queda acentuada da RMM em nível nacional, com aproximação dos patamares observados no período pré-pandemia, resultado da reorganização dos serviços de saúde, da retomada do cuidado materno-infantil e da efetividade da estratégia de vacinação. As reduções expressivas observadas em estados como Sergipe e Piauí, entre 2022 e 2023, devem ser interpretadas com cautela, uma vez que envolvem pequeno número absoluto de óbitos maternos, o que torna o indicador sensível a flutuações anuais e a melhorias pontuais na qualidade da informação, não havendo, até o momento, registro de intervenções específicas isoladas que expliquem integralmente essa variação (Tabela 1).

Tabela 1 – Razão de mortalidade materna, por 100 mil nascidos vivos.
Brasil, regiões e Unidades da Federação, 2010 a 2023

Brasil, regiões e UFs	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brasil	68,9	61,8	59,3	62,1	63,8	62,0	64,4	64,5	59,1	57,9	74,7	117,4	57,7	55,3
Norte	78,4	74,7	73,2	83,8	93,6	76,0	84,5	88,9	80,8	82,5	98,9	153,9	82,0	80,2
Acre	48,8	33,7	53,9	58,6	46,7	58,9	69,7	48,9	54,4	49,1	33,0	95,5	48,3	55,3
Amapá	26,8	53,3	54,1	119,7	66,0	110,8	141,7	45,5	88,3	32,6	102,5	93,4	80,8	92,7
Amazonas	119,5	84,6	85,0	81,6	120,8	78,8	84,7	75,6	108,4	84,8	101,8	155,5	82,7	88,0
Pará	69,7	73,8	78,9	86,7	96,4	72,9	86,4	107,4	81,4	96,1	107,1	131,3	79,7	77,7
Rondônia	83,2	58,3	64,1	94,2	87,7	57,7	56,4	87,3	47,8	59,6	78,1	188,7	52,2	50,2
Roraima	13,8	67,5	38,0	74,5	60,4	96,4	52,7	59,6	100,6	91,9	146,4	309,3	160,4	129,7
Tocantins	76,8	112,6	53,3	61,2	60,1	85,6	92,2	96,3	31,6	71,4	79,2	227,4	102,0	82,1
Nordeste	83,3	77,9	72,7	82,4	77,9	75,3	78,0	73,2	67,1	63,6	91,8	115,0	67,3	63,7
Alagoas	74,4	66,8	56,3	71,6	104,1	59,1	51,9	37,7	49,5	58,2	82,7	110,6	65,6	68,8
Bahia	87,3	80,6	70,0	80,6	81,0	75,4	72,6	76,9	60,8	64,0	93,1	106,2	63,3	65,2
Ceará	70,6	68,4	69,4	74,5	65,3	49,1	63,4	65,7	68,4	58,1	97,6	107,3	56,1	45,9
Maranhão	133,7	109,8	96,1	123,8	100,9	116,5	122,2	101,8	90,6	80,6	108,9	158,3	91,9	97,7
Paraíba	61,8	61,7	61,5	70,9	63,0	81,8	99,9	67,8	53,2	62,8	97,7	126,7	47,2	56,3
Pernambuco	61,9	57,5	56,0	64,3	63,4	67,6	58,1	63,3	59,2	48,0	70,8	73,7	46,0	61,1
Piauí	125,0	107,1	126,0	130,2	86,8	103,6	108,5	88,6	105,8	98,1	101,0	160,9	108,9	59,3
Rio Grande do Norte	36,6	68,6	66,0	54,5	74,8	68,4	77,2	77,9	58,6	70,4	78,1	149,7	79,9	55,8
Sergipe	71,1	83,0	70,4	67,2	66,9	51,6	55,9	56,1	58,8	36,7	97,5	83,3	98,2	41,4
Sudeste	56,0	48,7	46,5	50,1	53,9	54,3	55,8	62,3	53,2	53,5	65,1	104,8	50,3	48,0
Espírito Santo	65,6	60,8	64,4	59,6	109,2	73,1	48,7	71,6	63,9	56,2	68,8	99,1	54,1	40,2
Minas Gerais	50,5	40,3	36,6	47,6	49,0	47,0	46,9	45,2	51,2	44,4	51,0	94,6	46,8	41,9
Rio de Janeiro	83,6	74,3	80,8	80,3	71,9	67,1	71,6	84,7	61,7	74,5	95,4	168,5	69,3	73,2
São Paulo	47,6	42,0	36,8	39,3	44,2	50,8	54,4	60,6	50,0	49,7	60,1	87,0	44,9	42,9
Sul	62,8	50,4	54,5	36,6	41,7	43,7	44,2	38,5	38,2	38,3	45,6	111,9	40,0	38,0
Paraná	65,4	52,7	38,4	41,7	41,3	51,7	50,3	31,7	38,4	45,5	52,6	131,7	46,9	45,1
Rio Grande do Sul	75,6	60,5	78,3	34,2	49,7	43,4	46,0	44,5	40,3	39,9	48,3	99,6	38,9	33,9
Santa Catarina	38,1	30,7	45,4	31,4	30,2	30,9	31,5	40,7	35,1	30,6	31,7	98,4	31,6	33,1
Centro-Oeste	77,2	68,2	64,3	62,5	60,2	65,9	67,3	56,9	64,9	59,0	77,0	140,6	57,1	56,2
Distrito Federal	60,7	61,8	49,4	60,3	51,0	43,7	64,6	49,4	54,3	21,2	53,4	94,6	44,5	42,2
Goiás	69,1	50,9	70,5	56,7	53,8	56,6	56,5	56,4	64,7	60,7	90,5	153,9	59,1	52,3
Mato Grosso	76,9	83,9	58,5	71,6	63,7	82,9	78,5	61,1	58,0	64,6	91,8	145,2	49,9	66,6
Mato Grosso do Sul	113,8	92,4	73,1	66,7	79,3	88,2	80,1	60,3	84,9	64,5	48,8	147,0	74,1	62,1

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html
3. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
4. Ministério da Saúde. Nascidos Vivos – desde 1994 [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>
5. Ministério da Saúde. Mortalidade materna nas unidades da Federação, regiões e no Brasil: uma análise de 2000 a 2015. Em: Saúde Brasil 2017: uma análise da situação de saúde e os desafios para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2018 [citado 3 de agosto de 2025]. p. 39–58. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/publicacoes/saude-brasil/saude-brasil-2017-analise-situacao-saude-desafios-objetivos-desenvolvimento-sustentavel.pdf>
6. Laurenti R, Jorge MHP de M, Gotlieb SLD. A mortalidade materna nas capitais brasileiras: algumas características e estimativa de um fator de ajuste. Revista Brasileira de Epidemiologia [Internet]. dezembro de 2004 [citado 3 de agosto de 2025];7(4):449–60. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/HbTsjc3kb367HZtTrcFDr7y/>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.2.01 – Razão de mortalidade materna [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18377550



Mortalidade



MRT.2.02 – Mortalidade materna segundo grupos de causas

MRT.2.02 – Maternal mortality according to type of cause

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Distribuição proporcional de óbitos maternos, por grupo de causas obstétricas diretas, indiretas e inespecíficas, em um local e ano de referência. É expressa em percentual.
- A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10) define morte materna como a “morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais¹.
- As definições de morte materna direta, indireta e inespecíficas estão descritas abaixo²:
 - › Causas obstétricas diretas: aquelas que resultam de complicações obstétricas na gravidez, parto ou puerpério devidas a intervenções, omissões, tratamento incorreto ou a uma cadeia de eventos resultantes de quaisquer das causas acima mencionadas.
 - › Causas obstétricas indiretas: aquelas que resultam de doenças existentes antes da gravidez ou de doenças que se desenvolveram durante a gravidez não devidas a causas obstétricas diretas, mas que foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez.
 - › Causas obstétricas inespecíficas: aquelas em que a causa básica da morte não pode ser claramente determinada como obstétrica direta ou indireta, geralmente devido à insuficiência de informações clínicas, laboratoriais ou circunstanciais disponíveis, impossibilitando a correta classificação da morte materna.
 - › Os códigos da CID-10 correspondentes às causas de morte materna que compõem cada um dos grupos considerados estão elencadas no Quadro 1, na seção Método de cálculo desta ficha.

INTERPRETAÇÃO

- Dimensiona a participação proporcional dos grupos de causas obstétricas diretas, indiretas e inespecíficas em relação ao total dos óbitos maternos, em um local e ano de referência.
- As causas diretas são associadas à qualidade da assistência obstétrica; as causas indiretas refletem tanto a assistência obstétrica quanto o cuidado vinculado às demais doenças e agravos não relacionados à gestação, parto e puerpério.
- As causas inespecíficas refletem a falta de informação suficiente para classificar o óbito materno, decorrente de falha de preenchimento de dados clínicos, laboratoriais e/ou circunstanciais, bem como falta de acesso a serviços de saúde.

USOS

- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde, visando à adoção de medidas de promoção da saúde da mulher, assim como prevenção, assistência e vigilância relativas a cada grupo de causas de óbito materno.

LIMITAÇÕES

- O indicador pode ser afetado pela subnotificação de mortes maternas no Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM (ver FQI MRT.2.01 – Razão de Mortalidade Materna).
- A proporção de óbitos em cada grupo de causas é afetada pela acurácia da causa de morte constante na Declaração de Óbito (DO).
- O acesso aos dados está limitado ao prazo descrito na Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009³, do Ministério da Saúde, que estabelece a publicação, em caráter oficial, da base final do SIM até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos maternos de residentes por grupo de causa, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de óbitos maternos de residentes, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de óbitos maternos de residentes, por grupos de causa, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número total de óbitos maternos de residentes em um local e ano de referência, com causas básicas classificadas no Capítulo XV da CID-101, com exceção dos códigos O96 e O97 (morte materna tardia e morte por seqüela de causa obstétrica direta), em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.
- As mortes maternas são causadas por afecções do capítulo XV da CID-10 – Gravidez, parto e puerpério (com exceção das mortes fora do período do puerpério de 42 dias – códigos O96 e O97) e por afecções classificadas em outros capítulos da CID-10, especificamente conforme especificado a seguir.
 - › Tétano obstétrico (A34), transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério (F53) e osteomalácia puerperal (M83.0), nos casos em que a morte ocorreu até 42 dias após o término da gravidez ou nos casos sem informação do tempo transcorrido entre o término da gravidez e a morte.
 - › Doença causada pelo HIV (B20 a B24), mola hidatiforme maligna ou invasiva (D39.2) e necrose hipofisária pós-parto (E23.0) serão consideradas mortes maternas, desde que a mulher esteja grávida no momento da morte ou tiver estado grávida até 42 dias antes da morte.

- › Os códigos da CID-10 referentes às causas de óbito que compõem os grupos de causas estão elencados no Quadro 1.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Quadro 1 – Grupos de causa de óbito materno*

Grupo	Classificação	Códigos CID-10
Causas obstétricas diretas	Todos os códigos da CID-10 considerados na definição de morte materna	O00-O08; O11-O23; O24.4; O26-O92; A34; D39.2; E23.0; F53; M83.0
	Hipertensão	O11, O13-O16
	Hemorragia	O20; O44-O46; O67; O71.0-O71.1; O72
	Infecção puerperal	O85-O86
	Gravidez que termina em aborto	O00-O08
	Outras complicações relacionadas predominantemente com o puerpério	O87-O92
	Outras complicações do trabalho de parto e do parto	O60-O66; O68-O70; O71.2-O71.9; O73-O75
	Transtornos mentais do puerpério	F53
	Outros transtornos maternos relacionados predominantemente à gravidez	O21-O23; O24.4; O26-O29
	Tétano obstétrico	A34
	Outras causas obstétricas diretas	O12; O30-O43; O47-O48; O80-O84; D39.2; E23.0; M83.0
Causas obstétricas indiretas	Todos os códigos	O10; O24.0-O24.3; O24.9, O25; O98-O99; B20-B24
	Doenças hipertensivas preexistentes	O10
	Doenças do aparelho circulatório	O99.4
	Doenças do aparelho respiratório	O99.5
	Doenças do aparelho digestivo	O99.6
	Doenças do sistema nervoso	O99.3
	Anemia e outras doenças do sangue	O99.0-O99.1
	Diabetes e outras doenças endócrinas complicadas na gravidez	O24.0-O24.3; O24.9, O25, O99.2
	Doenças infecciosas e parasitárias	O98; B20-B24 Para a análise da doença causada pelo HIV na mortalidade materna, devem ser considerados os códigos B20 a B24 até o ano de 2020. A partir de 2021, deve ser utilizado o código O98.7, conforme atualização da classificação.
	Outras doenças específicas complicadas na gravidez, parto e puerpério	O99.7-O99.8
Causas obstétricas inespecíficas	Morte obstétrica de causa inespecífica	O95

Notas:

- *Segundo a CID-10.
- Nos anos de 2015, 2016, 2019 e 2021, três óbitos foram codificados indevidamente como O94. Ressalta-se que o código O94 corresponde à categoria de morbidade na CID-10, destinada ao registro de sequelas de complicações da gravidez, parto e puerpério, não sendo recomendado para codificação de causa básica de óbito. Excepcionalmente, estamos considerando estes casos como óbitos maternos, classificando-os em "Causas obstétricas inespecíficas".

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 10 a 19 anos;
- 20 a 34 anos; e
- 35 anos ou mais.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- No cálculo da mortalidade proporcional por causas, a presença de pequenos números está sujeita a flutuações aleatórias, podendo comprometer a estabilidade do indicador; recomenda-se, portanto, a utilização e apresentação prioritária de números absolutos, especialmente em eventos raros.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Em 2024, foram registrados 1.326 óbitos maternos no Brasil, sendo a maioria atribuída a causas obstétricas diretas, que corresponderam a 70,1% (n=929) do total. Entre essas causas, destacaram-se a hipertensão, responsável por 21,1% dos óbitos maternos, e a hemorragia, com 13,7%, seguidas por outras complicações predominantes no puerpério (8,6%), gravidez que termina em aborto (7,8%), outras complicações do trabalho de parto e parto (7,0%) e infecção puerperal (5,9%). As demais causas diretas apresentaram participação menor, como outros transtornos maternos relacionados predominantemente com a gravidez (4,1%) e outras causas diretas (1,8%), não havendo registro de óbitos por transtornos mentais do puerpério ou tétano obstétrico.

As causas obstétricas indiretas responderam por 27,5% (n=365) dos óbitos maternos, com maior contribuição das doenças do aparelho circulatório (6,5%), das doenças infecciosas e parasitárias (6,0%) e das doenças do aparelho respiratório (4,4%), seguidas por outras doenças específicas complicadas na gravidez, parto e puerpério (4,4%). As demais causas indiretas – incluindo doenças do aparelho digestivo (2,0%), do sistema nervoso (1,1%), anemia e outras doenças do sangue (1,1%), doenças hipertensivas preexistentes (1,0%), e diabetes e outras doenças endócrinas complicadas na gravidez (0,9%) – apresentaram percentuais inferiores a 2%. Por fim, as causas obstétricas inespecíficas corresponderam a 2,4% (n=32) dos óbitos maternos, representando uma proporção reduzida, porém relevante para a qualificação da informação sobre a causa básica do óbito (Tabela 1).

Tabela 1 – Mortalidade materna por grupos de causas. Brasil, 2024

Causas de óbito materno	2024	
	n	%
Causas obstétricas diretas	929	70,1
Hipertensão	280	21,1
Hemorragia	182	13,7
Infecção puerperal	78	5,9
Gravidez que termina em aborto	103	7,8
Outras complicações predominantes no puerpério	114	8,6
Outras complicações do trabalho de parto e parto	93	7,0
Transtornos mentais do puerpério	0	0,0
Outros transtornos maternos relacionados predominantemente com a gravidez	55	4,1
Tétano obstétrico	0	0,0
Outras causas obstétricas diretas	24	1,8
Causas obstétricas indiretas	365	27,5
Doenças hipertensivas preexistentes	13	1,0
Doenças do aparelho circulatório	86	6,5
Doenças do aparelho respiratório	59	4,4
Doenças do aparelho digestivo	27	2,0
Doenças do sistema nervoso	15	1,1
Anemia e outras doenças do sangue	14	1,1
Diabetes e outras doenças endócrinas complicadas na gravidez	12	0,9
Doenças infecciosas e parasitárias	80	6,0
Outras doenças específicas complicadas na gravidez, parto e puerpério	59	4,4
Causas obstétricas inespecíficas	32	2,4
Total	1.326	100,0

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Organização Mundial da Saúde. The WHO application of ICD-10 to deaths during pregnancy, childbirth and puerperium: IDC MM. Guideline. 20 de junho de 2012.
3. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 11 fev. 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html. Acesso em: 20 de maio de 2025.
4. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.2.02 – Mortalidade materna segundo grupos de causas [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18406378



Mortalidade



MRT.3.01 – Mortalidade proporcional por causas

MRT.3.01 – Proportional mortality by causes

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Distribuição proporcional de óbitos por grupos de causas definidas, na população residente em um local e ano de referência. É expressa em percentual.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a participação relativa dos principais grupos de causas de morte no total de óbitos com causas definidas.
- De modo geral, as proporções de óbitos por grupos de causas são influenciadas por fatores que contribuem para aumentar ou diminuir determinadas causas, alterando a distribuição proporcional das demais, a saber: condições socioeconômicas, perfil demográfico, infraestrutura de serviços públicos, qualidade dos serviços de saúde e acesso a eles.

USOS

- Identificar os principais grupos de causas de morte definidas.
- Analisar a estrutura da mortalidade e comparar grupos populacionais.
- Analisar diferenças e desigualdades na mortalidade proporcional por sexo, idade e cor ou raça.
- Analisar mudanças no tempo e lugar.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento de determinados grupos de causas de óbito.

LIMITAÇÕES

- Apresenta restrição de uso sempre que ocorrer uma elevada proporção de óbitos sem assistência médica ou por causas mal definidas.
- Depende da composição da população por idade e sexo, que condiciona a frequência de óbitos por causas em segmentos demográficos específicos.
- Não reflete o risco de morte, pois indica a importância relativa de um grupo de causas no conjunto de óbitos, sem se levar em conta a população.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos de residentes por grupo de causas definidas, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de óbitos de residentes, com causas definidas, no mesmo local e período de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número total de mortes segundo o grupo de causas que se deseja analisar, exceto aquelas classificadas no capítulo XVIII – Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)², entre residentes em um local e ano de referência.
- **Denominador:** Número total de óbitos, excluídos aqueles por causas mal definidas, entre residentes em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e

Grupos de causas:

O grupo de causas pode ser definido conforme interesse do gestor ou pesquisador. Toma-se como exemplo os grupos dos capítulos da CID-10, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Capítulos da CID-10, como exemplos de grupos de causas de morte para cálculo da mortalidade proporcional por causas

Grupos de causas	Capítulos e códigos da CID-10*
Doenças do aparelho circulatório	IX: I00 - I99
Neoplasias (tumores)	II: C00 - D48
Doenças do aparelho respiratório	X: J00 - J99
Causas externas	XX: V01 - Y98
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	IV: E00 - E90
Doenças do aparelho digestivo	XI: K00 - K93
Algumas doenças infecciosas e parasitárias	I: A00 - B99
Demais causas definidas**	

Notas:

- *Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão.
- **Os capítulos XIX e XXI não são utilizados como causa básica de óbito.

GRANULARIDADE

- Unidades da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- O acesso aos dados mais recentes segue o prazo estabelecido pela Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministério da Saúde. Conforme essa norma, os dados preliminares sobre óbitos devem ser divulgados entre 30 de junho e 30 de agosto do ano seguinte ao evento, e os dados definitivos, até 30 de dezembro do mesmo ano³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A Tabela 1 apresenta a mortalidade proporcional por causa no ano de 2023, em relação ao total de 1.394.482 mortes por causa definida. Observa-se um padrão típico de uma população em estágio avançado da transição epidemiológica, em que as doenças crônicas não transmissíveis correspondem à maior parte dos óbitos. As enfermidades cardiovasculares e os tumores respondem por quase metade das mortes, com impacto significativo na saúde pública. As doenças respiratórias também têm participação expressiva, o que reforça a importância do controle de doenças crônicas e infecciosas.

As causas externas correspondem a mais de um décimo das mortes, o que aponta para os desafios relacionados a acidentes, violência e outros fatores evitáveis. Grupos como as doenças endócrinas, digestivas e algumas doenças infecciosas, embora com menor proporção, contribuem para o cenário complexo da mortalidade, sugerindo a necessidade de abordagens diversificadas na prevenção e no tratamento. A proporção de óbitos cujas causas foram agrupadas em "demais causas definidas" (13,5%) ressalta a heterogeneidade das condições que também impactam a mortalidade.

Apesar da predominância de doenças crônicas, o panorama da mortalidade abrange múltiplas causas. Em suma, o perfil refletido pela tabela destaca as prioridades para intervenções em saúde pública, com foco no controle das doenças crônicas, na prevenção das causas externas e na atenção às condições infecciosas e metabólicas.

Tabela 1 – Mortalidade proporcional por causas*. Brasil, 2023

Capítulo CID-10**	N	%
Doenças do aparelho circulatório	388.177	27,8
Neoplasias (tumores)	255.037	18,3
Doenças do aparelho respiratório	170.132	12,2
Causas externas	154.197	11,1
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	87.967	6,3
Doenças do aparelho digestivo	76.872	5,5
Algumas doenças infecciosas e parasitárias	73.442	5,3
Demais causas definidas**	188.658	13,5
Total de óbitos	1.394.482	100,0

- Notas:**
- *Em relação ao total de mortes por causas definidas. Os capítulos XIX e XXI não são utilizados como causa básica de óbito.
 - **Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
2. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
3. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.3.01 – Mortalidade proporcional por causas [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18389175





MRT.3.02 – Proporção de óbitos por causas mal definidas

MRT.3.02 – Proportion of deaths from ill-defined causes

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de óbitos por causas mal definidas na população residente em um local e ano de referência. É expressa em percentual.

INTERPRETAÇÃO

- Reflete a qualidade da informação que permite identificar a causa básica da morte na Declaração de Óbito (DO).
- A qualidade da informação da causa básica de óbito, por sua vez, reflete a disponibilidade de infraestrutura assistencial e de condições para o diagnóstico de doenças, bem como a capacitação profissional para preenchimento das DOs. As dificuldades para o preenchimento dessas declarações estão, em geral, associadas ao uso de diagnósticos imprecisos.
- Quanto maior a proporção de óbitos por causas mal definidas, mais prejudicada é a interpretação dos padrões de mortalidade e, conseqüentemente, mais limitada é a capacidade dos indicadores de mortalidade para subsidiarem as políticas de saúde voltadas ao enfrentamento das principais causas de óbitos¹.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade por causas mal definidas, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir na avaliação da qualidade das estatísticas de mortalidade e, subsidiariamente, das condições de prestação de serviços de saúde, servindo para comparações nacionais e internacionais.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas, visando à adoção de medidas relativas à atenção à saúde e aos sistemas de informação em saúde.

LIMITAÇÕES

- Tende a estar subestimado em áreas com baixa cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)².
- É necessária a análise para além do capítulo XVIII da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10), considerando-se a necessidade de análise das causas indeterminadas, que são todas as causas pouco úteis, para análise de situação de saúde, contidas nos demais capítulos da CID-10³.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos por causas mal definidas de residentes, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de óbitos de residentes, no mesmo local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Somatório das mortes por causas mal definidas, classificadas no capítulo XIII – Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não classificados em outra parte (códigos R00-R99), da CID-10³.
- Denominador: Total dos óbitos ocorridos no local e no ano de referência.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- O acesso aos dados mais recentes segue o prazo estabelecido pela Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministério da Saúde. Conforme essa norma, os dados preliminares sobre óbitos devem ser divulgados entre 30 de junho e 30 de agosto do ano seguinte ao evento, e os dados definitivos, até 30 de dezembro do mesmo ano⁴.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A proporção de óbitos por causas mal definidas no Brasil exibe redução geral e consistente, de 2000 a 2023, tendo passado de 14,3% para 4,9% nesse período. Essa melhora reflete avanços nos sistemas de informação em saúde, como maior qualificação na notificação e investigação dos óbitos. Contudo, existem disparidades marcantes entre as regiões. Norte e Nordeste apresentam taxas historicamente mais elevadas, apesar da tendência de declínio, indicando persistentes desafios estruturais, como menor cobertura e qualidade dos registros em áreas remotas e vulneráveis. Em contraste, as regiões Sul e Centro-Oeste exibem os menores percentuais, sinalizando melhores condições de registro e monitoramento da mortalidade.

Entre as Unidades da Federação (UFs), algumas diferenças também são notáveis. Estados como Acre, Amazonas e Pará mantêm proporções superiores à média nacional, enquanto São Paulo, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul apresentam proporções bem inferiores. Essas variações reforçam a necessidade de políticas regionais específicas para aprimoramento da qualidade dos dados, especialmente em áreas com maior proporção de causas mal definidas, garantindo-se assim uma base mais confiável para análises epidemiológicas e o planejamento em saúde pública (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção de óbitos por causas mal definidas (%). Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2000 a 2023

Brasil, regiões e UFs	2000	2001	2002	2006	2007	2008	2015	2016	2017	2021	2022	2023
Brasil	14,3	14,1	13,7	8,3	7,7	7,4	5,7	5,8	5,5	5,1	5,3	4,9
Norte	24,0	22,7	21,6	15,0	12,8	12,7	7,9	7,8	7,1	6,3	6,9	6,3
Acre	31,2	28,8	23,5	8,3	7,4	12,3	6,6	6,5	3,6	10,6	7,8	5,8
Amapá	14,9	12,8	12,4	15,4	16,4	13,9	10,2	7,7	7,6	5,0	5,2	5,6
Amazonas	25,2	24,8	25,2	20,6	17,6	16,2	12,1	12,4	12,4	7,5	8,2	7,8
Pará	27,6	25,9	26,3	17,7	14,4	14,2	7,7	7,5	6,7	6,8	7,4	6,6
Rondônia	12,9	12,5	11,1	7,8	7,6	8,2	5,7	6,1	5,7	5,1	7,5	6,9
Roraima	9,1	6,2	4,4	5,6	5,1	3,2	4,2	4,9	3,0	3,1	4,3	3,6
Tocantins	21,2	19,8	11,8	3,0	3,6	4,5	2,9	2,2	1,5	2,2	2,4	2,7
Nordeste	28,4	27,5	26,8	9,5	8,1	7,9	7,2	7,2	6,4	5,9	6,0	5,1
Alagoas	29,1	28,0	28,2	10,4	7,0	6,7	4,9	4,5	4,0	6,0	6,4	4,5
Bahia	29,7	26,7	25,4	14,9	14,1	14,5	13,8	13,7	12,8	9,9	9,6	8,2
Ceará	20,2	21,5	25,5	6,2	5,1	5,0	5,6	6,1	3,7	2,8	2,3	2,2
Maranhão	36,1	39,5	40,3	10,3	8,1	7,5	5,0	5,2	5,3	4,6	5,5	5,4
Paraíba	46,5	45,1	40,5	11,2	8,2	7,6	5,8	6,3	5,8	5,0	5,7	4,5
Pernambuco	22,8	21,0	19,0	5,9	5,3	5,2	4,2	4,0	3,2	5,0	5,3	3,6

Brasil, regiões e UFs	2000	2001	2002	2006	2007	2008	2015	2016	2017	2021	2022	2023
Piauí	30,7	29,6	25,9	6,5	4,3	3,0	3,7	3,8	4,4	4,9	4,8	4,5
Rio Grande do Norte	27,6	28,0	27,0	5,0	3,6	3,4	3,5	4,1	3,0	3,2	3,4	3,4
Sergipe	29,7	26,4	23,5	8,2	7,2	6,6	7,0	6,3	6,9	6,9	7,4	6,9
Sudeste	9,8	9,6	9,1	8,2	8,0	7,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,8	5,4
Espírito Santo	17,6	16,4	11,8	3,5	3,0	2,4	1,0	1,0	0,7	0,8	1,3	0,7
Minas Gerais	14,2	13,7	13,1	11,7	11,2	11,3	8,1	8,1	7,7	5,9	6,9	6,6
Rio de Janeiro	11,5	11,2	10,8	9,0	9,1	7,6	5,7	5,6	6,8	9,2	9,1	8,1
São Paulo	6,6	6,7	6,5	6,5	6,4	6,3	4,8	5,1	4,7	4,5	4,2	4,1
Sul	6,3	6,3	6,3	5,8	5,5	5,1	3,4	3,9	3,5	3,1	3,5	3,2
Paraná	5,4	5,1	4,6	4,9	4,7	4,9	3,0	3,5	2,4	2,2	2,2	2,2
Rio Grande do Sul	4,4	4,9	5,7	5,1	4,9	4,2	4,3	4,7	4,7	4,3	4,9	4,4
Santa Catarina	12,6	12,0	11,3	9,1	8,6	7,7	2,5	2,9	2,9	2,4	2,8	2,4
Centro-Oeste	8,5	7,9	6,6	4,9	4,3	4,1	3,0	3,1	2,9	2,3	2,7	2,6
Distrito Federal	4,7	5,1	4,6	2,2	2,4	2,0	0,7	1,9	2,1	1,9	2,5	2,2
Goiás	10,2	9,5	8,0	7,0	6,6	6,1	2,5	2,4	2,4	1,1	1,5	1,4
Mato Grosso	7,9	8,9	8,2	5,9	3,5	3,4	6,6	5,9	5,9	4,5	4,8	4,7
Mato Grosso do Sul	8,5	5,5	3,2	1,6	1,7	1,7	1,8	2,5	1,6	2,7	3,3	3,4

Nota:

- Os capítulos XIX e XXI da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10) não são utilizados como causa básica de óbito.

REFERÊNCIAS

1. Abbafati C, Abbas KM, Abbasi M, Abbasifard M, Abbasi-Kangevari M, Abbastabar H, et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet [Internet]. 17 de outubro de 2020 [citado 9 de agosto de 2025];396(10258):1204–22. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30925-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30925-9/fulltext)
2. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
3. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
4. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.3.02 – Proporção de óbitos por causas mal definidas [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18389472



Mortalidade



MRT.4.01 – Taxa de mortalidade por agressão

MRT.4.01 – Mortality rate due to assault

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Taxa de mortalidade específica por agressão na população, em um local e ano de referência. A taxa é calculada por 100 mil habitantes.
- As causas de óbito incluídas neste indicador, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹, englobam o seguinte: agressão (CID: X85 a Y09).

INTERPRETAÇÃO

- Estima o risco populacional de morte por agressão, permitindo dimensionar a magnitude desse agravo como problema de saúde pública.
- Reflete aspectos culturais e de desenvolvimento socioeconômico, particularmente associados à inclusão social e combate às desigualdades sociais e políticas de promoção da cultura da paz, além de legislações específicas e medidas que minimizem a impunidade em uma população.
- Este indicador pode refletir perdas relevantes de anos potenciais de vida, o que impacta a expectativa de vida de uma população, já que as mortes por agressões ocorrem principalmente entre homens adultos jovens.

USOS

- Descrever a distribuição no espaço e as tendências, ao longo do tempo, da taxa de mortalidade por agressão, contribuindo para a análise de desigualdades e de tendências históricas que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas, particularmente de promoção da cultura da paz, bem como de legislações específicas.
- Contribuir para a avaliação do desenvolvimento econômico, da inclusão social e do combate às desigualdades sociais em uma população.

LIMITAÇÕES

- A validade do indicador é afetada pela cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A cobertura do SIM apresentou melhora ao longo dos anos, alcançando 98,9% em 2022². No entanto, merecem atenção as estimativas para municípios com coberturas abaixo do ideal e para anos mais distantes na série histórica analisada.

- A validade do indicador é afetada pela qualidade do registro da causa básica de morte no SIM. Proporções elevadas de causas de morte mal definidas e/ou inespecíficas podem subestimar o indicador de mortalidade em questão.
 - › O acesso aos dados dos anos mais recentes está limitado ao prazo descrito na Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministério da Saúde, a saber: os dados do SIM devem ser divulgados até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência, em caráter oficial³.
 - › A taxa de mortalidade não padronizada por idade pode estar sujeita a influências decorrentes de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e períodos distintos.
 - › A taxa de mortalidade padronizada é um valor ajustado para a estrutura etária de uma população-padrão hipotética, e não reflete diretamente o risco de morte na população observada, podendo ser maior ou menor que a taxa bruta, a depender da população-padrão escolhida.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁵.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁶.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos por agressão, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de óbitos por agressão, em um local e ano de referência⁴.
- Denominador: População residente, em um local e ano de referência⁶.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 49 anos;
- 50 a 69 anos; e
- 70 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Grupos de causas:

- Meios utilizados:
- Arma de fogo: X93-X95;
 - Arma branca, objeto pérfuro/cortante/contundente: X99, Y00;
 - Estrangulamento: X91;
 - Força corporal: Y04;
 - Demais meios especificados: X85-X90, X92, X96-X98, Y01-Y03, Y05-Y08; e
 - Meios não especificados: Y09.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes e Promoção da Cultura de Paz do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGVIVA/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- Quando o objetivo principal é comparar as taxas de mortalidade em diferentes locais e/ou períodos de tempo, recomenda-se utilizar a taxa padronizada por idade, pois esse indicador ajusta as diferenças nas estruturas etárias das populações comparadas, conforme apresentado no apêndice.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, 43.443 óbitos por agressão foram registrados no SIM, o que corresponde a 28,2% do total de mortes por causas externas (154.199). A taxa de mortalidade por agressão declinou de 26,0 para 20,5 óbitos por 100 mil habitantes no período de 2000 a 2023 (variação de -21,0%) (Tabela 1).

O sexo masculino teve redução de 21,2%, de 2000 para 2023: de 48,5 para 38,2 mortes por 100 mil homens. O mesmo aconteceu com o sexo feminino, que apresentou redução de 4,2 para 3,6 óbitos por 100 mil mulheres (variação de -14,8%), no mesmo período de análise.

Tabela 1 – Número de óbitos e taxa bruta de mortalidade por agressão, por 100 mil habitantes, segundo sexo. Brasil, 2000 e 2023*

Variável e categoria		2000			2023		
Sexo	Óbitos	Taxa	População	Óbitos	Taxa	População	
Feminino	3.743	4,2	88.975.229	3.887	3,6	108.443.605	
Masculino	41.585	48,5	85.720.706	39.459	38,2	103.251.553	
Total	45.360	26,0	174.695.935	43.443	20,5	211.695.158	

Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴ e Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade para o período 2000-2024⁵. As causas de morte incluídas, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)², foram codificadas como X85 a Y09. O total do Brasil inclui registros com a variável sexo não informada. Por esta razão, o total não corresponde exatamente à soma para o sexo masculino e o feminino. Em 2000, foram identificados 32 óbitos com sexo ignorado, e, em 2023, 97 óbitos.

APÊNDICE

TAXA PADRONIZADA

A fórmula geral para a taxa de mortalidade padronizada por idade, pelo método de padronização direta, é a seguinte:

$$\text{Taxa padronizada pelo método direto} = \frac{\sum P P_i \times \left(\frac{O_i}{P_i} \right)}{P P_t} \times 100.000$$

Onde:

- O_i é o número de óbitos na faixa etária i ;
- P_i é a população na faixa etária i ;
- $P P_i$ é a população-padrão na faixa etária i ; e
- $P P_t$ é a população-padrão total.
- A taxa padronizada por idade é o somatório dos produtos das taxas de mortalidade específicas por idade (taxas observadas) e da população-padrão na mesma idade – o que resulta nos óbitos esperados –, dividido pela população-padrão total. Para maior detalhamento, consultar a nota técnica⁷.

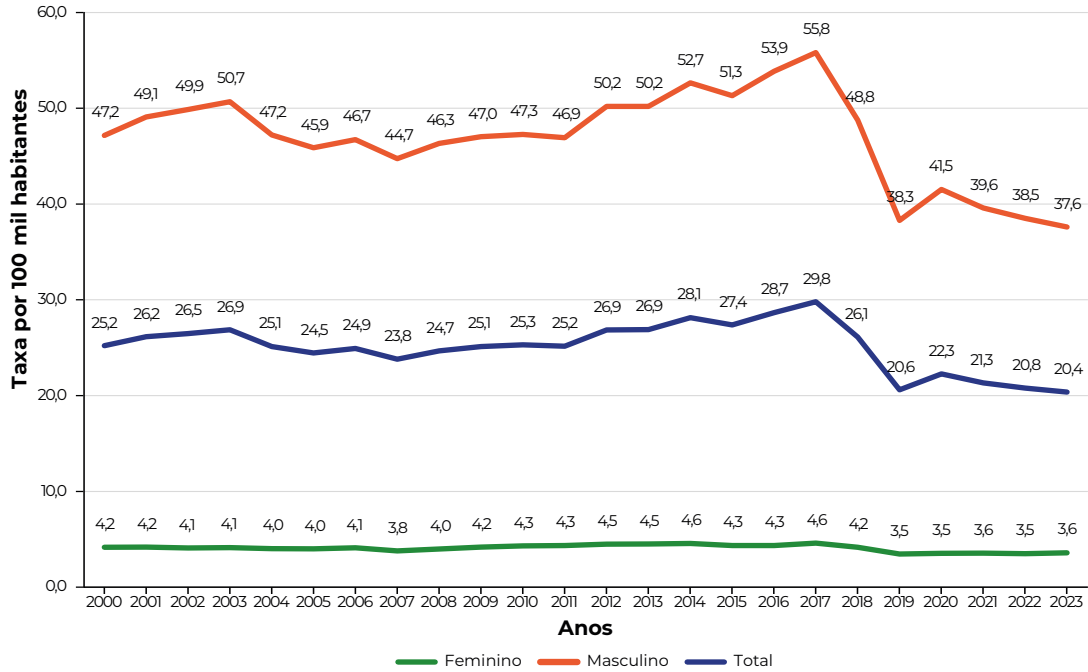
ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

As agressões foram responsáveis por 43.443 óbitos, no Brasil, no ano de 2023, representando 28,2% do total de mortes por causas externas (154.199).

No país, no período de 2000 a 2023, a taxa padronizada de mortalidade por agressão declinou de 25,2 para 20,4 óbitos por 100 mil habitantes (variação de -19,2%) (Gráfico 1).

No ano 2000, o risco de morte no sexo masculino foi 11,3 vezes maior que no sexo feminino, ao passo que, em 2023, este risco foi 10,4 vezes maior que no sexo feminino. O sexo masculino teve redução de 20,3% de 2000 para 2023: de 47,2 para 37,6 mortes por 100 mil homens, respectivamente. Por seu turno, o sexo feminino apresentou redução do indicador de 4,2 para 3,6 óbitos por 100 mil mulheres (variação de -13,5%), no mesmo período de análise.

Gráfico 1 – Taxa padronizada de mortalidade por agressão, por 100 mil habitantes, segundo sexo. Brasil, 2000 a 2023*



Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴, Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁶ e Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade para o período 2000-2024⁵. Taxa padronizada de mortalidade por 100 mil habitantes. As causas de morte incluídas, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)², foram codificadas como X85 a Y09.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas de Sub-Registro – Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos [Internet]. IBGE. 2022 [citado 7 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html?edicao=39639&t=resultados>
3. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, o fluxo e a periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos aos Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html
4. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

6. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
7. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas. Nota Técnica nº 51/2025-CGIAE/DAENT/SVSA/MS [Internet]. Brasília; 2025 [citado 19 de agosto de 2025]. Disponível em: https://www.ripsa.org.br/wp-content/uploads/2025/08/SEI_0049780814_Nota_Tecnica_51.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.4.01 – Taxa de mortalidade por agressão [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18389751



Mortalidade



MRT.4.02 – Taxa de mortalidade por lesão autoprovocada

MRT.4.02 – Self-inflicted injury mortality rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Taxa de mortalidade específica por lesão autoprovocada, na população de 5 anos e mais de idade, residente em um local e ano de referência. A taxa é calculada por 100 mil habitantes desta faixa etária.
- As causas de morte incluídas nesse indicador são codificadas como X60 a X84, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Estima o risco de morte por lesão autoprovocada em uma população, e permite dimensionar a magnitude desse agravo como problema de saúde pública.
- Reflete aspectos culturais, ambientais, de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população, sendo sensível aos níveis de desigualdade e vulnerabilidade socioeconômica, à disponibilidade de métodos letais, à organização e à qualidade dos serviços de saúde, às políticas de promoção da saúde mental e de proteção social, entre outros.

USOS

- Descrever a distribuição no espaço e as tendências, ao longo do tempo, da taxa de mortalidade por lesão autoprovocada, contribuindo para análises de desigualdades e de tendências históricas que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde, particularmente a promoção da saúde mental.
- Contribuir para a avaliação da situação de saúde mental de uma população.

LIMITAÇÕES

- A validade do indicador é afetada pela cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A cobertura do SIM apresentou melhora ao longo dos anos, alcançando 98,9% em 2022². No entanto, merecem atenção as estimativas para municípios com coberturas abaixo do ideal e para anos mais distantes na série histórica analisada.
- A validade do indicador é afetada pela qualidade do registro da causa básica de morte no SIM. Proporções elevadas de causas de morte mal definidas e inespecíficas resultam em subestimação do indicador.

- O acesso aos dados dos anos mais recentes está limitado ao prazo descrito na Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministério da Saúde, a saber: os dados do SIM devem ser divulgados até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência, em caráter oficial³.
- A taxa de mortalidade não padronizada por idade pode estar sujeita a influências de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e períodos distintos.
- A taxa de mortalidade padronizada gera um valor ajustado para a estrutura etária de uma população-padrão hipotética, que não reflete diretamente o risco de morte na população observada, podendo ser maior ou menor que a taxa bruta, a depender da população-padrão escolhida.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁵.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁶.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos por lesão autoprovocada, de pessoas com 5 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, na mesma faixa etária, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de óbitos por lesão autoprovocada, de pessoas com 5 anos ou mais de idade, residentes em um local e ano de referência⁴.
- Denominador: População residente, na mesma faixa etária, em um local e ano de referência⁵.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 5 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 49 anos;
- 50 a 69 anos; e
- 70 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Grupos de causas:

Meios utilizados para o óbito por lesão autoprovocada:

- Envenenamento/intoxicação: X60-X69;
- Enforcamento: X70;
- Arma de fogo: X72-X74;
- Precipitação de local elevado: X80;
- Outros meios especificados: X71, X75-X77, X78, X79, X81-X83; e
- Meios não especificados: X84.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes e Promoção da Cultura de Paz do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGVIVA/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- Quando o objetivo principal é comparar as taxas de mortalidade em diferentes locais e/ou períodos de tempo, recomenda-se utilizar a taxa padronizada por idade, pois esse indicador ajusta as diferenças nas estruturas etárias das populações comparadas, conforme apresentado no apêndice.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, 17.002 óbitos por lesão autoprovocada na população de 5 anos e mais de idade foram registrados no SIM, o que corresponde a 11% do total de mortes por causas externas (154.199). A taxa de mortalidade por lesão autoprovocada em pessoas de 5 e mais anos de idade, em 2023, foi de 8,6 óbitos por 100 mil habitantes, equivalente ao dobro daquela registrada em 2000 (4,3/100 mil) (Tabela 1).

Em 2000 e 2023, a taxa bruta de mortalidade por lesão autoprovocada, na faixa etária de 5 anos e mais, entre homens, foi de 7,0 e de 13,7 mortes por 100 mil. Nos mesmos anos, entre mulheres, as taxas foram de 1,7 e de 3,7 óbitos por 100 mil, respectivamente.

Tabela 1 – Número de óbitos e taxa bruta de mortalidade por lesão autoprovocada na população de 5 anos e mais de idade, por 100 mil habitantes, segundo sexo. Brasil, 2000 e 2023*

Variável e categoria		2000		2023		
Sexo	Óbitos	Taxa	População	Óbitos	Taxa	População
Feminino	1.382	1,7	80.432.915	3.758	3,7	101.890.015
Masculino	5.398	7,0	85.720.706	13.244	13,7	96.383.901
Total	6.780	4,3	174.695.935	17.002	8,6	198.273.916

Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴ e estimativas populacionais para o Brasil, na faixa etária (5 anos e mais), sexo e anos de análise (2000 e 2023)⁵. As causas de morte incluídas neste indicador são codificadas como X60 a X84, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)².

APÊNDICE

TAXA PADRONIZADA

A fórmula geral para a taxa de mortalidade padronizada por idade, pelo método de padronização direta, é a seguinte:

$$\text{Taxa padronizada pelo método direto} = \frac{\sum P P_i \times \left(\frac{O_i}{P_i} \right)}{P P_t} \times 100.000$$

Onde:

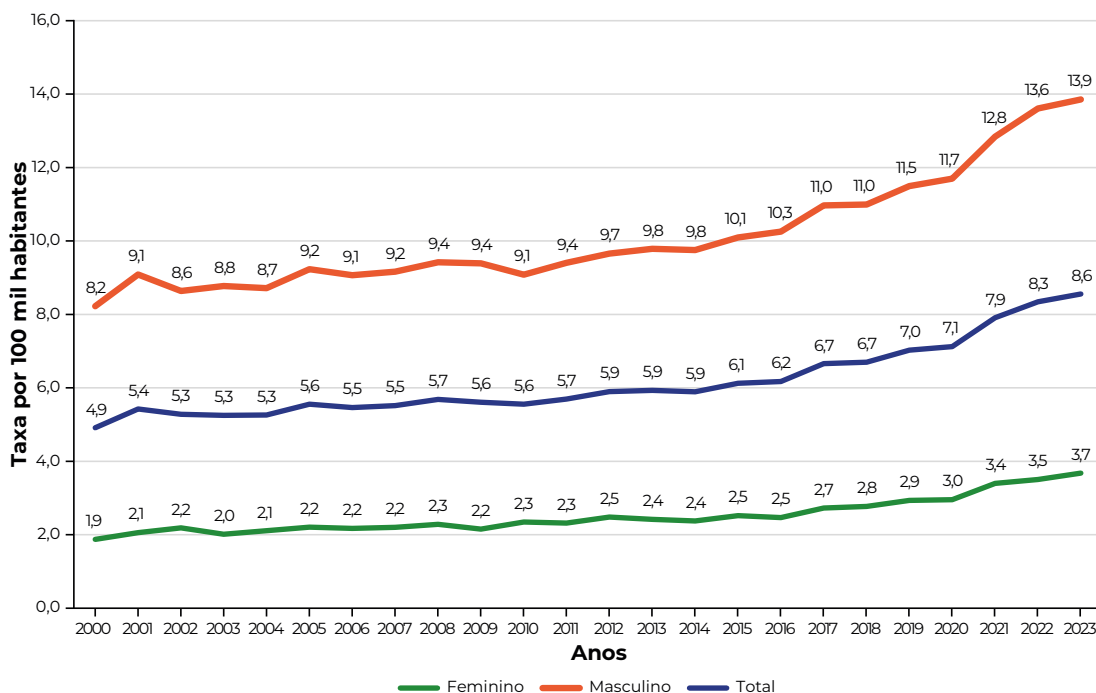
- O_i é o número de óbitos na faixa etária i ;
- P_i é a população na faixa etária i ;
- $P P_i$ é a população-padrão na faixa etária i ; e
- $P P_t$ é a população-padrão total.
- A taxa padronizada por idade é o somatório dos produtos das taxas de mortalidade específicas por idade (taxas observadas) e a população-padrão na mesma idade – o que resulta nos óbitos esperados –, dividido pela população-padrão total. Para maior detalhamento, consultar a nota técnica⁷.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, as lesões autoprovocadas, na população de 5 e mais anos, foram responsáveis por 17.002 óbitos, representando 11% do total de mortes por causas externas (154.199). No período de 2000 a 2023, a taxa de mortalidade por lesão autoprovocada nesta faixa aumentou de 4,9 para 8,6 óbitos por 100 mil habitantes (variação de 74,2%) (Gráfico 1).

No ano 2000, o risco de morte por lesão autoprovocada em homens com 5 anos e mais foi 4,4 vezes maior que entre mulheres, na mesma faixa etária; em 2023, este risco foi 3,8 vezes maior no sexo masculino. Mesmo com risco maior entre os homens, no período, a variação percentual foi de 68,5%, de 2000 para 2023, de 8,2 para 13,9 mortes por 100 mil homens com 5 anos e mais, respectivamente. No mesmo período, entre mulheres, a variação percentual foi maior ainda (96,3%), com as taxas variando de 1,9 para 3,7 óbitos por 100 mil mulheres com 5 anos e mais de idade.

Gráfico 1 – Taxa padronizada de mortalidade por lesão autoprovocada na população de 5 anos e mais de idade, por 100 mil habitantes, segundo sexo. Brasil, 2000 a 2023*



Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴, projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação⁶ e estimativas populacionais para o Brasil, na faixa etária (5 anos e mais), para os sexos e os anos de análise (2000 e 2023)⁵. As causas de morte incluídas neste indicador são codificadas como X60 a X84, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas de Sub-Registro – Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos [Internet]. IBGE. 2022 [citado 7 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html?edicao=39639&t=resultados>
3. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html
4. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
5. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade

- [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
 7. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas. Nota Técnica nº 51/2025-CGIAE/DAENT/SVSA/MS [Internet]. Brasília; 2025 [citado 19 de agosto de 2025]. Disponível em: https://www.ripsa.org.br/wp-content/uploads/2025/08/SEI_0049780814_Nota_Tecnica_51.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.4.02 – Taxa de mortalidade por lesão autoprovocada [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18389980



Mortalidade



MRT.4.03 – Taxa de mortalidade por lesão de trânsito

MRT.4.03- Traffic injury mortality rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Taxa de mortalidade específica por lesão de trânsito na população em um local e ano de referência. A taxa é calculada por 100 mil habitantes.
- As causas de óbito incluídas nesse indicador são codificadas como V01 a V89, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Estima o risco populacional de morte por lesão de trânsito, permitindo dimensionar a magnitude desse agravo como problema de saúde pública.
- Reflete aspectos culturais e de desenvolvimento socioeconômico, particularmente associados às políticas de promoção da paz no trânsito, na infraestrutura e no ordenamento urbano, além de legislações específicas e medidas que minimizem a impunidade em uma população.
- Este indicador pode refletir perdas relevantes de anos potenciais de vida, o que impacta a expectativa de vida de uma população, já que as mortes por lesão de trânsito incidem mais frequentemente entre adultos e adultos jovens.

USOS

- Descrever a distribuição no espaço e as tendências no tempo da taxa de mortalidade por lesão de trânsito, contribuindo para a análise de desigualdades e tendências históricas que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde.
- Contribuir para a avaliação do desenvolvimento de políticas que promovam a paz no trânsito, na infraestrutura e no ordenamento urbano, além de legislações específicas e medidas que minimizem a impunidade relacionada a infrações de trânsito em uma população.

LIMITAÇÕES

- A validade do indicador é afetada pela cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A cobertura do SIM apresentou melhora ao longo dos anos, alcançando 98,9% em 2022². No entanto, merecem atenção as estimativas para municípios com coberturas abaixo do ideal e para anos mais distantes na série histórica analisada.

- A validade do indicador é afetada pela qualidade do registro da causa básica de morte no SIM. Proporções elevadas de causas mal definidas e inespecíficas de morte resultam em subestimação do indicador.
- O acesso aos dados dos anos mais recentes está limitado ao prazo descrito na Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministério da Saúde, a saber: os dados do SIM devem ser divulgados até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência, em caráter oficial³.
- Trata-se de um indicador específico por grupo de causas (agravos). A taxa de mortalidade não padronizada por idade pode estar sujeita à influência de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e períodos distintos.
- Por outro lado, a taxa de mortalidade padronizada gera um valor ajustado para a estrutura etária de uma população-padrão hipotética que não reflete diretamente o risco de morte na população observada, podendo ser maior ou menor que a taxa bruta, a depender da população-padrão escolhida.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁵.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁶.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos por lesão de trânsito, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de óbitos por lesão de trânsito, em um local e ano de referência.
- Denominador: População residente, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 49 anos;
- 50 a 69 anos; e
- 70 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Grupos de causas:

Segundo condição da vítima:

- Pedestre: V01-V09;
- Ciclista: V10-V19;
- Motociclista e ocupante de triciclo: V20-V39;
- Ocupante de automóveis, veículo de transporte pesado (VTP) e ônibus: V40-V79;
- Ocupante de demais veículos: V80-V86; e
- Ocupante de veículo não especificado: V87-V89.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes e Promoção da Cultura de Paz do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGVIVA/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- Quando o objetivo principal é comparar as taxas de mortalidade em diferentes locais e/ou períodos de tempo, recomenda-se utilizar a taxa padronizada por idade, pois esse indicador ajusta as diferenças nas estruturas etárias das populações comparadas, conforme apresentado no apêndice.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, 34.881 óbitos por lesão de trânsito foram registrados no SIM, representando 22,6% do total de mortes por causas externas (154.199). No período de 2000 a 2023, a taxa de mortalidade por lesão de trânsito foi, respectivamente, de 16,6 e 16,5 óbitos por 100 mil habitantes (Tabela 1).

Os homens apresentaram risco de morte por lesão de trânsito marcadamente superior às mulheres. Em 2000 e 2023, a taxa de mortalidade entre homens foi de 27,3 e 27,9 óbitos por 100 mil, respectivamente. Entre mulheres, a taxa foi de 6,3 para 5,6 óbitos por 100 mil, no mesmo período de análise.

Tabela 1 – Número de óbitos e taxa bruta de mortalidade por lesão de trânsito, por 100 mil habitantes, segundo sexo. Brasil, 2000 e 2023*

Variável e categoria		2000			2023	
Sexo	Óbitos	Taxa	População	Óbitos	Taxa	População
Feminino	5.580	6,3	88.975.229	6.024	5,6	108.443.605
Masculino	23.395	27,3	85.720.706	28.843	27,9	103.251.553
Total	28.995	16,6	174.695.935	34.881	16,5	211.695.158

Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴ e estimativas populacionais do Brasil por sexo, para os anos de análise (2000 e 2023)⁵. As causas de morte incluídas neste indicador são codificadas como V01 a V89, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹. O total do Brasil inclui registros com a variável sexo não informado; assim, em 2000, foram 20 óbitos com sexo ignorado, e em 2023, 14 óbitos.

APÊNDICE

TAXA PADRONIZADA

A fórmula geral para a taxa de mortalidade padronizada por idade, pelo método de padronização direta, é a seguinte:

Taxa padronizada pelo método direto = $\frac{\sum P P_i \times \left(\frac{O_i}{P_i}\right)}{P P_t} \times 100.000$

Onde:

- O_i é o número de óbitos na faixa etária *i*;
- P_i é a população na faixa etária *i*;
- P P_i é a população-padrão na faixa etária *i*; e
- P P_t é a população-padrão total.
- A taxa padronizada por idade é o somatório dos produtos das taxas de mortalidade específicas por idade (taxas observadas) e a população-padrão na mesma idade – o que resulta nos óbitos esperados –, dividido pela população-padrão total. Para maior detalhamento, consultar a nota técnica⁷.

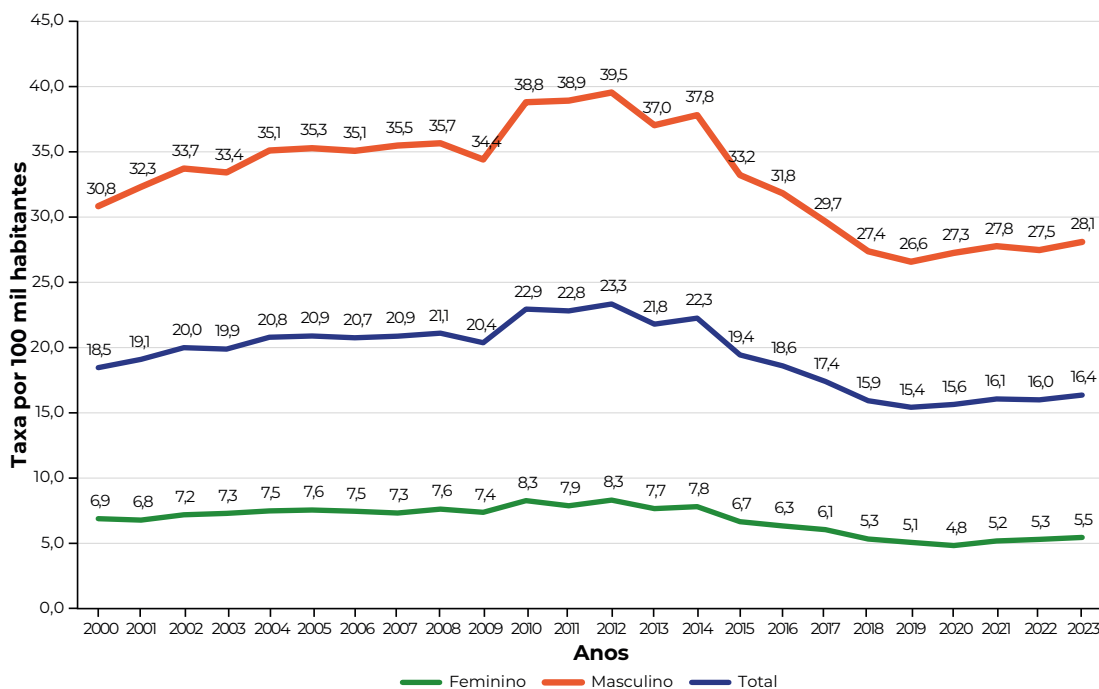
ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, as lesões de trânsito foram responsáveis por 34.881 óbitos, representando 22,6% do total de mortes por causas externas (154.199). No período de 2000 a 2023, a taxa de mortalidade por lesão de trânsito declinou de 18,5 para 16,4 óbitos por 100 mil habitantes (variação de -11,4%) (Gráfico 1).

No ano 2000, o risco de morte para homens foi 4,5 vezes maior que entre mulheres, e, em 2023, este risco foi 5,2 vezes maior que no sexo feminino. A variação percentual das taxas foi de -8,9%

de 2000 para 2023: de 30,8 para 28,1 mortes por 100 mil homens, respectivamente. Por sua vez, entre mulheres, houve maior redução do indicador – de 6,9 para 5,5 óbitos por 100 mil mulheres (variação de -20,9%) –, no mesmo período de análise.

Gráfico 1 – Taxa padronizada de mortalidade por lesão de trânsito, por 100 mil habitantes, segundo sexo. Brasil, 2000 a 2023*



Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴, projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação⁶ e estimativas populacionais do Brasil por sexo, para os anos de análise⁵. As causas de morte incluídas neste indicador são codificadas como V01 a V89, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas de Sub-Registro – Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos [Internet]. IBGE. 2022 [citado 7 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html?edicao=39639&t=resultados>
3. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html

4. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
6. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
7. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas. Nota Técnica nº 51/2025-CGIAE/DAENT/SVSA/MS [Internet]. Brasília; 2025 [citado 19 de agosto de 2025]. Disponível em: https://www.ripsa.org.br/wp-content/uploads/2025/08/SEI_0049780814_Nota_Tecnica_51.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.4.03 – Taxa de mortalidade por lesão de trânsito [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18390188



Mortalidade



MRT.4.04 – Taxa de mortalidade por causas acidentais

MRT.4.04 – Mortality rate from accidental causes

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Taxa de mortalidade específica por causas acidentais na população em um local e ano de referência. A taxa é calculada por 100 mil habitantes.
- As causas de óbito incluídas neste indicador, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10), são W00 a X59, referentes a outras causas externas de traumatismos acidentais, um grupo que abrange uma vasta gama de acidentes não relacionados a transporte, incluindo quedas, afogamentos, queimaduras, exposição a substâncias, forças da natureza (como raios), esforços excessivos e outros fatores acidentais não especificados.

INTERPRETAÇÃO

- Estima o risco populacional de morte por causas acidentais, permitindo dimensionar a magnitude desse agravo como problema de saúde pública.
- A mortalidade por causas acidentais, em geral, está associada à gravidade da lesão resultante, ao tempo de socorro, ao atendimento de urgência e emergência, bem como à qualidade da assistência, nos casos de lesões que não são imediatamente fatais.
- Reflete aspectos culturais e de desenvolvimento socioeconômico.

USOS

- Descrever a distribuição no espaço e as tendências, ao longo do tempo, da taxa de mortalidade por causas acidentais, contribuindo para a análise de desigualdades e de tendências históricas que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- Contribuir para a avaliação do desenvolvimento de políticas relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência, bem como à assistência às pessoas que sofrem lesões por causas acidentais.

LIMITAÇÕES

- A validade do indicador é afetada pela cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A cobertura do SIM apresentou melhora ao longo dos anos, alcançando 98,9% em 2022². No entanto, merecem atenção as estimativas para municípios com coberturas abaixo do ideal e para anos mais distantes na série histórica analisada.

- A validade do indicador é afetada pela qualidade do registro da causa básica de morte no SIM. Proporções elevadas de causas mal definidas e/ou inespecíficas de morte podem subestimar o indicador de mortalidade em questão.
- O acesso aos dados dos anos mais recentes está limitado ao prazo descrito na Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministério da Saúde, a saber: os dados do SIM devem ser divulgados até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência, em caráter oficial³.
- A taxa de mortalidade não padronizada por idade pode estar sujeita à influência de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e períodos distintos.
- Por outro lado, a taxa de mortalidade padronizada é um valor ajustado para a estrutura etária de uma população-padrão hipotética, e não reflete diretamente o risco de morte na população observada, podendo ser maior ou menor que a taxa bruta, a depender da população-padrão escolhida.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁵.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁶.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos por causas acidentais, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de óbitos por causas acidentais, em um local e ano de referência.
- Denominador: População residente, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 49 anos;
- 50 a 69 anos; e
- 70 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Grupos de causas:

- Queda (W00-W19);
- Arma de fogo (W32-W34);
- Afogamento e submersão acidentais (W65-W74);
- Outros riscos acidentais à respiração (W75-W84);
- Queimadura (X00-X19);
- Contato com animais e plantas venenosos (X20-X29);
- Envenenamento acidental por e exposição a substâncias nocivas (X40-X49); e
- Demais causas acidentais – W20-W31, W35-W64, W85-W99, X30-X39, X50-X59.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes e Promoção da Cultura de Paz do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGVIVA/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- Quando o objetivo principal é comparar as taxas de mortalidade em diferentes locais e/ou períodos de tempo, recomenda-se utilizar a taxa padronizada por idade, pois esse indicador ajusta as diferenças nas estruturas etárias das populações comparadas, conforme apresentado no apêndice.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, 38.746 óbitos por causas acidentais foram registrados no SIM, representando 25,1% do total de mortes por causas externas (154.199). A taxa de mortalidade por causas acidentais variou de 13,3 para 18,3 óbitos por 100 mil habitantes, no período de 2000 a 2023 (Tabela 1).

No sexo masculino, de 2000 para 2023, variou de 21,0 para 23,9 mortes por 100 mil homens. Entre pessoas do sexo feminino, variou de 5,8 para 13,0 óbitos por 100 mil mulheres, no mesmo período de análise.

Tabela 1 – Número de óbitos e taxa bruta de mortalidade por causas acidentais, segundo sexo. Brasil, 2000 e 2023*

Variável e categoria		2000			2023	
Sexo	Óbitos	Taxa	População	Óbitos	Taxa	População
Feminino	5.135	5,8	88.975.229	14.088	13,0	108.443.605
Masculino	18.033	21,0	85.720.706	24.637	23,9	103.251.553
Total	23.185	13,3	174.695.935	38.746	18,3	211.695.158

Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴ e estimativas populacionais para o Brasil, sexo e anos de análise (2000 e 2023)⁵. As causas de morte incluídas neste indicador são codificadas como W00 a X59, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹. O total de mortes para o Brasil inclui registros com a variável sexo não informada. Por essa razão, este total não corresponde exatamente à soma dos valores para os sexos masculino e feminino. Em 2000, foram registrados 17 óbitos com sexo ignorado, e em 2023, 21 óbitos.

APÊNDICE

TAXA PADRONIZADA

A fórmula geral para a taxa de mortalidade padronizada por idade, pelo método de padronização direta, é a seguinte:

Taxa padronizada pelo método direto =
$$\frac{\sum P P_i \times \left(\frac{O_i}{P_i}\right)}{P P_t} \times 100.000$$

Onde:

- Oi é o número de óbitos na faixa etária i;
- Pi é a população na faixa etária i;
- P Pi é a população-padrão na faixa etária i; e
- P Pt é a população-padrão total.
- A taxa padronizada por idade é o somatório dos produtos das taxas de mortalidade específicas por idade (taxas observadas) e a população-padrão na mesma idade – o que resulta nos óbitos esperados –, dividido pela população-padrão total. Para maior detalhamento, consultar a nota técnica⁷.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

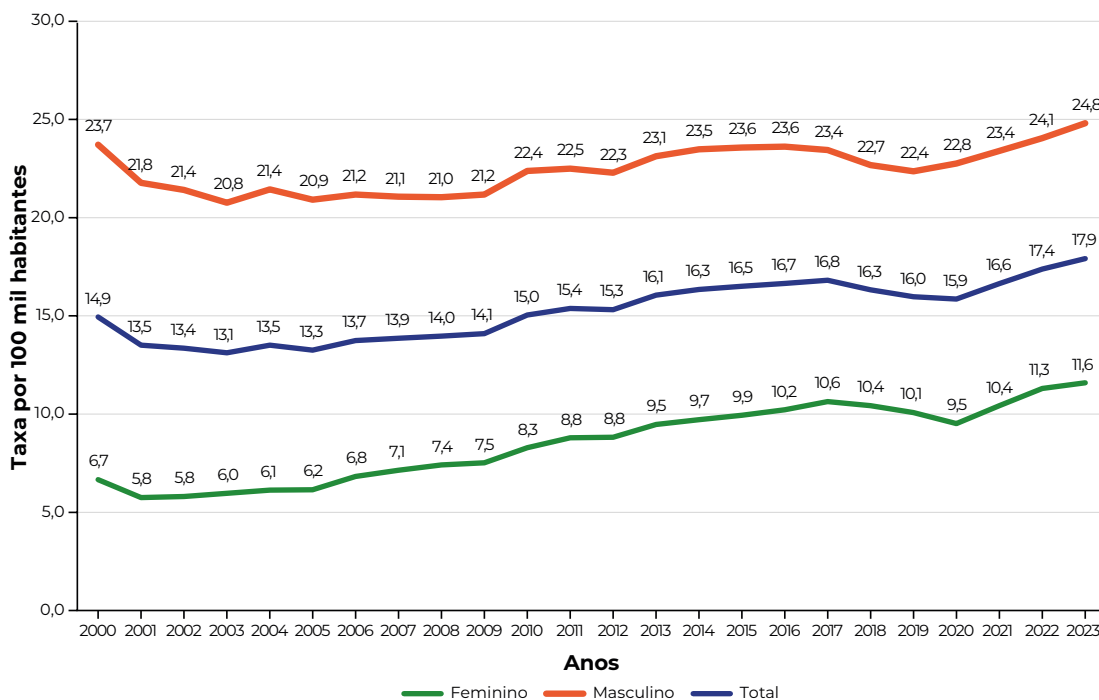
No Brasil, em 2023, as causas acidentais foram responsáveis por 38.746 óbitos, representando 25,1% do total de mortes por causas externas (154.199).

No período de 2000 a 2023, a taxa padronizada de mortalidade por causas acidentais aumentou de 14,9 para 17,9 óbitos por 100 mil habitantes (variação de 19,9%) (Gráfico 1).

No ano 2000, o risco de morte no sexo masculino foi 3,6 vezes maior que no sexo feminino, e, em 2023, este risco foi 2,1 vezes maior que no sexo feminino. O sexo masculino teve aumento de 4,6%

de 2000 para 2023: de 23,7 para 24,8 mortes por 100 mil homens, respectivamente. Por seu turno, o sexo feminino apresentou aumento de 6,7 para 11,6 óbitos por 100 mil mulheres (variação de 74,0%), no mesmo período de análise.

Gráfico 1 – Taxa padronizada de mortalidade por causas acidentais, por 100 mil habitantes, segundo sexo. Brasil, 2000 a 2023*



Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴, projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação⁶ e estimativas populacionais para o Brasil, os sexos e os anos de análise (2000 e 2023)⁵. As causas de morte incluídas neste indicador são codificadas como W00 a X59, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas de Sub-Registro – Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos [Internet]. IBGE. 2022 [citado 7 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html?edicao=39639&t=resultados>
3. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html

4. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
6. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
7. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas. Nota Técnica nº 51/2025-CGIAE/DAENT/SVSA/MS [Internet]. Brasília; 2025 [citado 19 de agosto de 2025]. Disponível em: https://www.ripsa.org.br/wp-content/uploads/2025/08/SEI_0049780814_Nota_Tecnica_51.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.4.04 – Taxa de mortalidade por causas acidentais [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18392336



Mortalidade



MRT.5.01 – Taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis

MRT.5.01 – Premature mortality rate from chronic non-communicable diseases

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Taxa de mortalidade específica por doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) na faixa etária de 30 a 69 anos e por um grupo de causas de óbitos, que compreende as doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes *mellitus* e doenças respiratórias crônicas, em um local e ano de referência, por 100 mil habitantes da mesma faixa etária.
- Mortalidade prematura é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como aquela que ocorre entre 30 e 69 anos de idade¹.
- As causas de óbito incluídas neste indicador, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10^a Revisão (CID-10)² são as seguintes: doenças cardiovasculares (I00-I99), neoplasias malignas (C00-C97), diabetes *mellitus* (E10-E14) e doenças respiratórias crônicas (J30-J35; J37-J98).

INTERPRETAÇÃO

- Estima o risco de morte prematura por doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes *mellitus* e doenças respiratórias crônicas, e dimensiona a sua magnitude como problema de saúde pública.
- Reflete a mortalidade majoritariamente associada a fatores de risco modificáveis, como estilo de vida (tabagismo, consumo de álcool, inatividade física, alimentação inadequada – excesso de sódio, alimentos ultraprocessados etc.) e fatores metabólicos (como Índice de Massa Corporal – IMC elevado, hipercolesterolemia, hipertensão), além de poluição do ar e estresse, entre outros.
- Expressa as condições de atenção relativas à promoção da saúde, assim como à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento dessas doenças.
- A análise da evolução desse indicador, ao longo do tempo, pode revelar melhorias ou agravamentos no cuidado dessas doenças, na faixa etária analisada, bem como seus condicionantes ambientais e comportamentais.
- Este indicador pode refletir perdas relevantes de anos potenciais de vida devido a essas causas, o que impacta a expectativa de vida de uma população, já que as mortes incidem antes dos 70 anos de idade.

USOS

- Descrever a distribuição no espaço e as tendências no tempo da taxa de mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, contribuindo para a análise de desigualdades e tendências históricas que demandem ações e estudos específicos.

- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- Levantar hipóteses a serem exploradas em pesquisas epidemiológicas e clínicas, e apoiar a identificação de fatores de risco para essas causas de mortes na faixa etária de 30 a 69 anos.
- Sensibilizar a população e os formuladores de políticas sobre a importância e a necessidade de ações preventivas, terapêuticas e de promoção de saúde.
- Indicador a ser monitorado no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) no Brasil 2021-2030³.

LIMITAÇÕES

- A validade do indicador é afetada pela cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A cobertura do SIM apresentou melhora ao longo dos anos, alcançando 98,9%⁴, em 2022. No entanto, merecem atenção as estimativas feitas para municípios com coberturas abaixo do ideal e para anos mais distantes na série histórica analisada.
- A validade do indicador é afetada pela qualidade do SIM. As proporções de causas mal definidas e de causas inespecíficas de morte podem subestimar o indicador de mortalidade em questão.
- O acesso aos dados de anos mais recentes está limitado ao prazo descrito na Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministério da Saúde, segundo a qual os dados do SIM devem ser divulgados até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência, em caráter oficial⁵.
- Trata-se de um indicador específico por grupo de causas e idade. Ainda assim, devido à amplitude do grupo etário incluído (30 a 69 anos), a taxa de mortalidade não padronizada por idade pode estar sujeita à influência de alguma variação na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e para períodos distintos.
- A taxa de mortalidade padronizada gera um valor ajustado que não reflete diretamente o risco de morte de uma população, podendo ser maior ou menor que a taxa bruta, a depender da população-padrão escolhida.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁶.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁷.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁸.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos prematuros (30 a 69 anos de idade) por doenças crônicas não transmissíveis, em um local e ano de referência}}{\text{População residente de 30 a 69 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de óbitos por DCNTs – doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes *mellitus* e doenças respiratórias crônicas⁶.
- Denominador: Total de residentes na faixa etária de 30 a 69 anos da população⁷.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 30 a 39 anos;
- 40 a 49 anos;
- 50 a 59 anos; e
- 60 a 69 anos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Grupos de causas:

- Doenças cardiovasculares (I00 a I99);
- Neoplasias malignas (C00 a C97);
- Diabetes *mellitus* (E10-E14); e
- Doenças respiratórias crônicas (J30-J35 e J37-J98).

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- Quando o objetivo principal é comparar as taxas de mortalidade em diferentes locais e/ou períodos de tempo, o indicador padronizado por idade é recomendado, a fim de se levar em conta a diferença nas estruturas etárias nessas comparações, ou seja, ajustar por idade, conforme apresentado no apêndice.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no ano de 2023, o conjunto das DCNTs foi responsável por 322.859 óbitos entre as pessoas de 30 a 69 anos de idade, representando 55,6% do total de mortes nesse grupo de idade

(581.084). Entre 2000 e 2023, a taxa de mortalidade prematura por DCNTs diminuiu de 333,9 para 302,5 óbitos por 100 mil pessoas de 30 a 69 anos de idade (variação de -9,4%) (Tabela 1).

Em 2000, o risco de morte para pessoas do sexo masculino foi 1,4 vez maior em comparação ao feminino, e, em 2023, também foi 1,4 vez maior. O sexo masculino apresentou redução deste indicador, de 391,2 para 353,6 óbitos por 100 mil homens entre 30 e 69 anos de idade (variação de -9,6%), entre 2000 e 2023, respectivamente. De maneira semelhante, o sexo feminino apresentou também redução do indicador, de 279,9 para 255,3 óbitos por 100 mil mulheres de 30 a 69 anos de idade (variação de -8,8%), no mesmo período de análise.

Tabela 1 – Número de óbitos e taxa bruta de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, segundo sexo. Brasil, 2000 e 2023*

Variável e categoria		2000			2023	
Sexo	Óbitos	Taxa	População	Óbitos	Taxa	População
Feminino	96.693	279,9	34.542.716	141.751	255,3	55.519.082
Masculino	126.978	391,2	32.458.902	181.094	353,6	51.213.004
Total	223.724	333,9	67.001.618	322.859	302,5	106.732.086

Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁶ e Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade para o período 2000-2024.⁷ Mortalidade prematura se refere aos óbitos ocorridos na faixa etária de 30 a 69 anos de idade. As causas de morte incluídas são, de acordo com os códigos da CID-10²: doenças cardiovasculares (I00-I99); neoplasias malignas (C00-C97), diabetes mellitus (E10-E14) e doenças respiratórias crônicas (J30-J35; J37-J98). O total do Brasil inclui registros com a variável sexo não informada, por isso, não corresponde exatamente à soma de masculino e feminino. Em 2000, foram registrados 53 óbitos com sexo ignorado, e, em 2023, 14 óbitos.

APÊNDICE

TAXA PADRONIZADA

A fórmula geral para a taxa de mortalidade padronizada por idade, pelo método de padronização direta, é a seguinte:

$$\text{Taxa padronizada pelo método direto} = \frac{\sum P P_i \times \left(\frac{O_i}{P_i} \right)}{P P_t} \times 100.000$$

Onde:

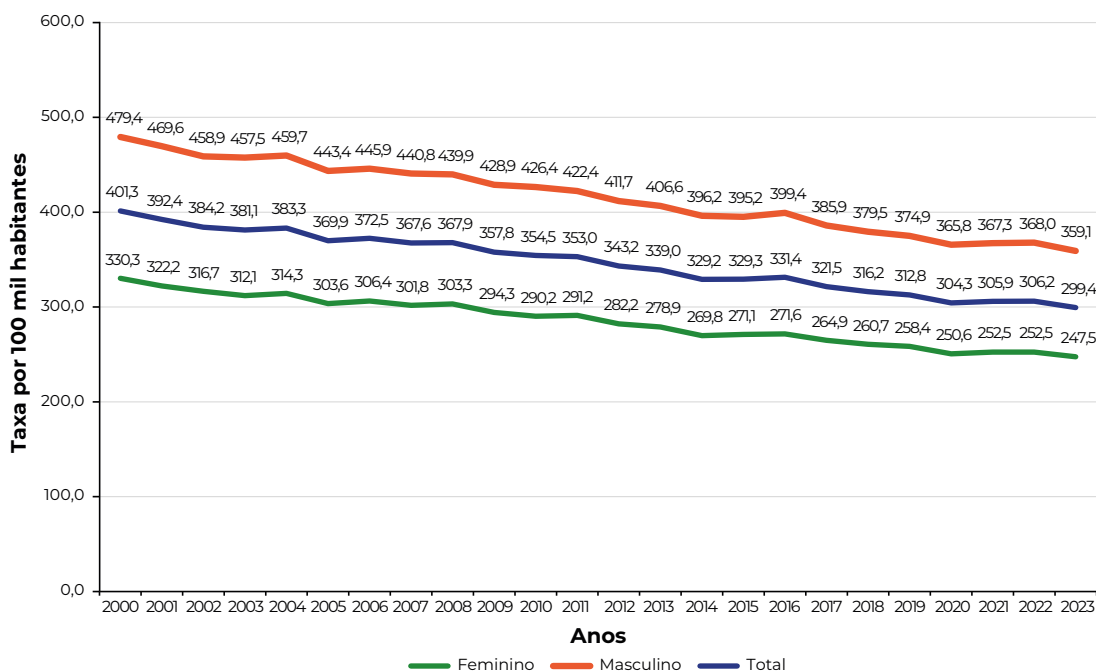
- O_i é o número de óbitos na faixa etária i ;
- P_i é a população na faixa etária i ;
- $P P_i$ é a população-padrão na faixa etária i ; e
- $P P_t$ é a população-padrão total.
- A taxa padronizada por idade é o somatório dos produtos das taxas de mortalidade específicas por idade (taxas observadas) e a população-padrão na mesma idade – o que resulta nos óbitos esperados –, dividido pela população-padrão total. Para maior detalhamento, consultar a nota técnica⁹.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no ano de 2023, o conjunto das doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes *mellitus* e doenças respiratórias crônicas foi responsável por 322.859 óbitos entre pessoas de 30 a 69 anos de idade, representando 55,6% do total de mortes nesse grupo de idade (581.084). No período de 2000 a 2023, a taxa padronizada de mortalidade prematura por esse conjunto de doenças declinou de 401,3 para 299,4 óbitos, por 100 mil pessoas de 30 a 69 anos de idade, no Brasil (variação de -25,1%) (Gráfico 1).

O risco de morte para pessoas do sexo masculino foi 1,5 vez maior em comparação ao feminino em 2000, e novamente, 1,5 vez maior em 2023. O sexo masculino apresentou redução deste indicador, de 479,4 para 359,1 óbitos por 100 mil homens entre 30 e 69 anos de idade (variação de -25,1%), entre 2000 e 2023, respectivamente. De maneira semelhante, o sexo feminino apresentou também redução do indicador, de 330,3 para 247,5 óbitos por 100 mil mulheres de 30 a 69 anos de idade (variação de -25,1%), no mesmo período de análise.

Gráfico 1 – Taxa padronizada de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, segundo sexo. Brasil, 2000 a 2023*



Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁶, Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁸ e Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade para o período 2000-2024⁷. Mortalidade prematura se refere aos óbitos ocorridos na faixa etária de 30 a 69 anos de idade. As causas de morte incluídas são, de acordo com os códigos da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10^a Revisão (CID-10)²: doenças cardiovasculares (I00-I99); neoplasias malignas (C00-C97), diabetes *mellitus* (E10-E14); e doenças respiratórias crônicas (J30-J35; J37-J98).

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases 2010 [Internet]. World Health Organization. 2011 [citado 6 de agosto de 2025]. p. 1-164. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/44579>

2. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
3. Ministério da Saúde. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil, 2021-2030 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2021 [citado 7 de maio de 2025]. 1-118 p. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-2022_2030.pdf/view
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas de Sub-Registro – Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos [Internet]. IBGE. 2022 [citado 7 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html?edicao=39639&t=resultados>
5. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html
6. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
7. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
8. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/> doi:10.5281/zenodo.17990183
9. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas. Nota Técnica nº 51/2025-CGIAE/DAENT/SVSA/MS [Internet]. Brasília; 2025 [citado 19 de agosto de 2025]. Disponível em: https://www.ripsa.org.br/wp-content/uploads/2025/08/SEI_0049780814_Nota_Tecnica_51.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.5.01 – Taxa de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18392482





MRT.5.02 – Taxa de mortalidade por neoplasias malignas

MRT.5.02 – Mortality rate due to malignant neoplasms

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Taxa de mortalidade específica por neoplasias malignas, em um local e ano de referência. A taxa é expressa por 100 mil habitantes.
- As causas de óbito incluídas neste indicador, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10), são¹ as neoplasias malignas (CID: C00 a C97).

INTERPRETAÇÃO

- Estima o risco de morte por neoplasias malignas e dimensiona a sua magnitude como problema de saúde pública.
- Expressa as condições de atenção relativas à promoção da saúde, assim como à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento dessas doenças.
- Retrata a ocorrência da mortalidade potencialmente associada ao envelhecimento precoce e a fatores de risco específicos, tais como condicionantes de padrões alimentares e comportamentais, assim como fatores ambientais e genéticos.

USOS

- Descrever a distribuição no espaço e as tendências no tempo da taxa de mortalidade por neoplasias malignas, contribuindo para a análise de tendências históricas que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde, concernentes às neoplasias malignas.
- Sensibilizar a população e os formuladores de políticas sobre a relevância das neoplasias malignas e a necessidade de ações preventivas, terapêuticas e de promoção da saúde.
- Levantar hipóteses a serem exploradas em pesquisas epidemiológicas e clínicas, e apoiar a identificação de fatores de risco para essas causas de morte.

LIMITAÇÕES

- A validade do indicador é afetada pela cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A cobertura do SIM apresentou melhora ao longo dos anos, alcançando 98,9%², em 2022. No entanto, merecem atenção as estimativas feitas para municípios com coberturas abaixo do ideal e para anos mais distantes na série histórica analisada.

- A validade do indicador é afetada pela qualidade do SIM. As proporções de causas mal definidas e de causas inespecíficas de morte podem subestimar o indicador de mortalidade em questão.
- O acesso aos dados de anos mais recentes está limitado ao prazo descrito na Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009³, do Ministério da Saúde, segundo a qual os dados do SIM devem ser divulgados até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência, em caráter oficial.
- A taxa de mortalidade padronizada gera um valor estimado que não reflete diretamente o risco de morte de uma população, podendo ser maior ou menor que a taxa bruta, a depender da população-padrão escolhida.
- Por tratar-se de um indicador específico por grupo de causas (neoplasias malignas), a taxa de mortalidade não padronizada por idade pode estar sujeita à influência de alguma variação na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e para períodos distintos.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁵.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁶.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos por neoplasia, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de óbitos por neoplasias malignas, em um local e ano de referência.
- Denominador: População residente, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Grupos de causas:

- Neoplasia dos órgãos digestivos: C15-C26;
- Neoplasia de mama feminina: C50;
- Neoplasia de colo de útero: C53;

- Neoplasia de pulmão, traqueia e brônquios: C33 e C34;
- Neoplasia da próstata: C61; e
- Demais localizações: C00-C14; C27-C32; C35-C49; C51; C52; C54-C60; C62-C97.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- Quando o objetivo principal é comparar as taxas de mortalidade em diferentes locais e/ou períodos de tempo, o indicador padronizado por idade é recomendado, a fim de se levar em conta a diferença nas estruturas etárias nessas comparações, ou seja, ajustar por idade, conforme apresentado no apêndice.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, o conjunto das neoplasias malignas foi responsável por 249.942 óbitos. Nos anos de 2000 e 2023, a taxa bruta de mortalidade por neoplasias malignas passou de 68,2 para 118,1 óbitos por 100 mil pessoas (Tabela 1). O sexo masculino apresentou taxas de 75,1 e 124,6 óbitos por 100 mil homens, em 2000 e 2023, respectivamente; e o sexo feminino apresentou taxas de 61,5 e 111,9 óbitos por 100 mil mulheres, no mesmo período de análise.

Tabela 1 – Número de óbitos e taxa bruta de mortalidade por neoplasias malignas, segundo sexo. Brasil, 2000 e 2023*

Variável e categoria		2000			2023	
Sexo	Óbitos	Taxa	População	Óbitos	Taxa	População
Feminino	54.734	61,5	88.975.229	121.323	111,9	108.443.605
Masculino	64.336	75,1	85.720.706	128.611	124,6	103.251.553
Total	119.091	68,2	174.695.935	249.942	118,1	211.695.158

Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴ e estimativas populacionais para o Brasil, sexo e os anos de análise (2000 e 2023).⁵ As causas de morte incluídas são, de acordo com os códigos da CID-105, as neoplasias malignas (C00 a C97). O total do Brasil inclui registros com a variável sexo não informado; por isso, não corresponde exatamente à soma de *masculino* e *feminino*. Em 2000, foram registrados 21 óbitos com sexo ignorado, e, em 2023, 8 óbitos.

APÊNDICE

TAXA PADRONIZADA

A fórmula geral para a taxa de mortalidade padronizada por idade, pelo método de padronização direta, é a seguinte:

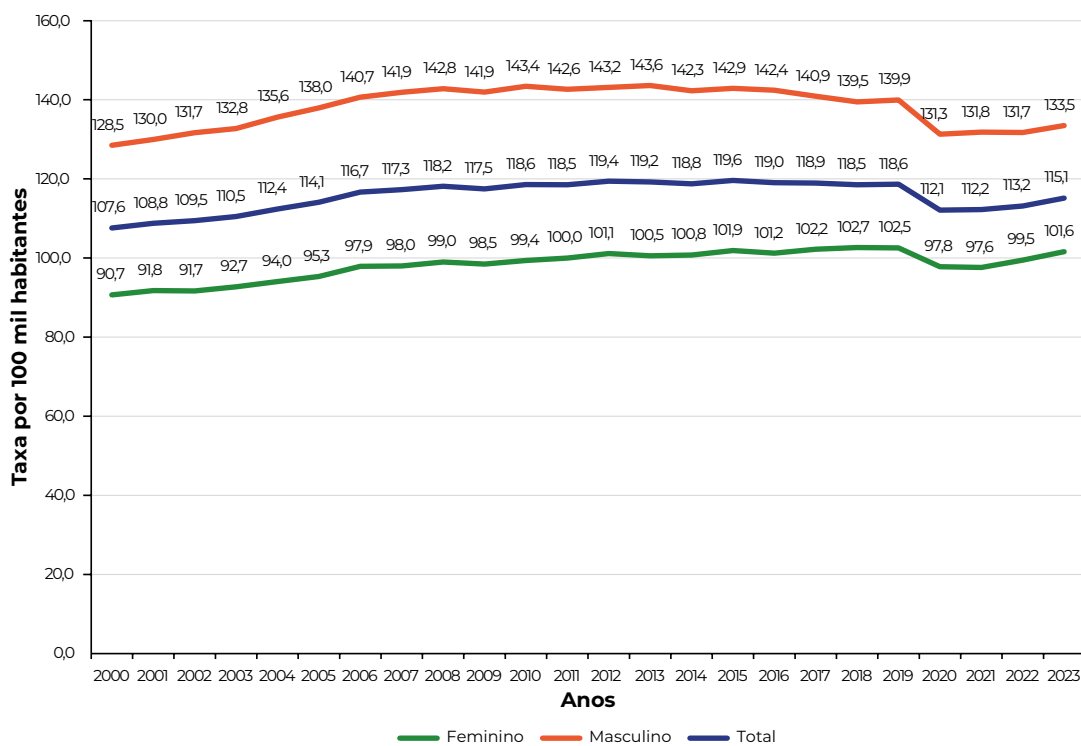
$$\text{Taxa padronizada pelo método direto} = \frac{\sum P P_i \times \left(\frac{O_i}{P_i} \right)}{P P_t} \times 100.000$$

Onde:

- O_i é o número de óbitos na faixa etária i ;
- P_i é a população na faixa etária i ;
- $P P_i$ é a população-padrão na faixa etária i ; e
- $P P_t$ é a população-padrão total.
- A taxa padronizada por idade é o somatório dos produtos das taxas de mortalidade específicas por idade (taxas observadas) e a população-padrão na mesma idade – o que resulta nos óbitos esperados –, dividido pela população-padrão total. Para maior detalhamento, consultar a nota técnica⁷.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, o conjunto das neoplasias malignas foi responsável por 249.941 óbitos. No período de 2000 a 2023, a taxa padronizada de mortalidade por neoplasias malignas aumentou de 107,6 para 115,1 óbitos por 100 mil pessoas (variação de 7,0%) (Gráfico 1). O risco de morte entre o sexo masculino foi 1,4 vez maior em comparação ao feminino, em 2000, e 1,3 vez maior em 2023. O sexo masculino apresentou aumento deste indicador, de 128,5 para 133,5 óbitos por 100 mil homens (variação de 3,9%), entre 2000 e 2023. Registrou-se maior aumento no risco entre pessoas do sexo feminino, tendo havido aumento do indicador de 90,7 para 101,6 óbitos por 100 mil mulheres (variação de 12,1%), no mesmo período de análise.

Gráfico 1 – Taxa padronizada de mortalidade por neoplasias malignas, segundo sexo. Brasil, 2000 a 2023***Nota:**

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴, projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação⁶ e estimativas populacionais para o Brasil, sexo e os anos de análise (2000 e 2023)⁵. As causas de morte incluídas neste indicador são codificadas como C00 a C97, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas de Sub-Registro – Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos [Internet]. IBGE. 2022 [citado 7 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html?edicao=39639&t=resultados>
3. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html
4. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>

5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
6. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
7. Ministério da Saúde. Nota Técnica no 51/2025-CGIAE/DAENT/SVSA/MS. [Brasília]: Ministério da Saúde; 2025.

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.5.02 – Taxa de mortalidade por neoplasias malignas [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18392574



Mortalidade



MRT.5.03 – Taxa de mortalidade por diabetes *mellitus*

MRT.5.03 – Mortality rate due to diabetes mellitus

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Taxa de mortalidade específica por diabetes *mellitus*, em um local e ano de referência. Exclui o diabetes gestacional. Este indicador é calculado por 100 mil habitantes.
- As causas de óbito incluídas neste indicador, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças (10ª versão), referem-se¹ ao diabetes *mellitus* (CID: E10-E14).

INTERPRETAÇÃO

- Estima o risco de morte por diabetes *mellitus*, exceto o gestacional, e dimensiona a magnitude da mortalidade por esta causa como problema de saúde pública.
- Reflete a mortalidade associada a fatores de risco modificáveis, tais como estilo de vida (tabagismo, consumo de álcool, inatividade física, alimentação inadequada – excesso de sódio, alimentos ultraprocessados, entre outros) e fatores metabólicos (Índice de Massa Corporal – IMC elevado, hipercolesterolemia, hipertensão etc.), além de poluição do ar e estresse, entre outros.
- Expressa as condições de atenção relativas à promoção da saúde, assim como à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento do diabetes *mellitus*, uma vez que as complicações agudas dessa doença são causas evitáveis de óbito.
- A análise da evolução desse indicador, ao longo do tempo, pode revelar melhorias ou agravamentos no cuidado do diabetes *mellitus*, bem como seus condicionantes ambientais e comportamentais.

USOS

- Descrever a distribuição no espaço e as tendências no tempo da taxa de mortalidade por diabetes *mellitus*, contribuindo para a análise de desigualdades e tendências históricas que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- Levantar hipóteses a serem exploradas em pesquisas epidemiológicas e clínicas, e apoiar a identificação de fatores de risco para essas causas de morte.
- Sensibilizar a população e os formuladores de políticas sobre a importância do diabetes *mellitus* na mortalidade e a necessidade de políticas de saúde voltadas para a promoção da saúde, prevenção e controle dessa doença.

LIMITAÇÕES

- A validade do indicador é afetada pela cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A cobertura do SIM apresentou melhora ao longo dos anos, alcançando 98,9%², em 2022. No entanto, merecem atenção as estimativas feitas para municípios com coberturas abaixo do ideal e para anos mais distantes na série histórica analisada.
- A validade do indicador é afetada pela qualidade do SIM. As proporções de causas mal definidas e de causas inespecíficas de morte podem subestimar o indicador de mortalidade em questão.
- O acesso aos dados de anos mais recentes está limitado ao prazo descrito na Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009³, do Ministério da Saúde, segundo a qual os dados do SIM devem ser divulgados até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência, em caráter oficial.
- A taxa de mortalidade não padronizada por idade pode estar sujeita à influência de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e períodos distintos.
- Por outro lado, a taxa de mortalidade padronizada é um valor ajustado para a estrutura etária de uma população-padrão hipotética, e não reflete diretamente o risco de morte na população observada, podendo ser maior ou menor que a taxa bruta, a depender da população-padrão escolhida.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁵.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁶.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos por diabetes mellitus, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de óbitos por diabetes *mellitus*, em um local e ano de referência.
- Denominador: População residente, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;

- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- Quando o objetivo principal é comparar as taxas de mortalidade em diferentes locais e/ou períodos de tempo, recomenda-se utilizar a taxa padronizada por idade, pois esse indicador ajusta as diferenças nas estruturas etárias das populações comparadas, conforme apresentado no apêndice.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, o diabetes *mellitus* foi responsável por 70.377 óbitos. Nos anos de 2000 e 2023, a taxa bruta de mortalidade por diabetes *mellitus* foi de 20,2 e 33,2 óbitos por 100 mil pessoas, respectivamente (Tabela 1). O sexo masculino teve taxa de mortalidade de 17,3 e 31,5 mortes por 100 mil homens, em 2000 e 2023; o sexo feminino apresentou 22,9 e 34,9 óbitos por 100 mil mulheres, nos mesmos anos.

Tabela 1 – Número de óbitos e taxa bruta de mortalidade de diabetes *mellitus*, segundo sexo. Brasil, 2000 e 2023*

Variável e categoria		2000			2023	
Sexo	Óbitos	Taxa	População	Óbitos	Taxa	População
Feminino	20.409	22,9	88.975.229	37.877	34,9	108.443.605
Masculino	14.864	17,3	85.720.706	32.498	31,5	103.251.553
Total	35.284	20,2	174.695.935	70.377	33,2	211.695.158

Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁶ e Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade para o período 2000-2024.⁵ As causas de morte incluídas são, de acordo com os códigos da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)⁵, as diabetes *mellitus* (E10-E14). O total do Brasil inclui registros com a variável sexo não informada; por isso, os dados não correspondem exatamente à soma de *masculino* e *feminino*. Em 2000, foram registrados 11 óbitos com sexo ignorado, e, em 2023, foram registrados 2 óbitos.

APÊNDICE

TAXA PADRONIZADA

A fórmula geral para a taxa de mortalidade padronizada por idade, pelo método de padronização direta, é a seguinte:

Taxa padronizada pelo método direto = $\frac{\sum P P_i \times \left(\frac{O_i}{P_i}\right)}{P P_t} \times 100.000$

Onde:

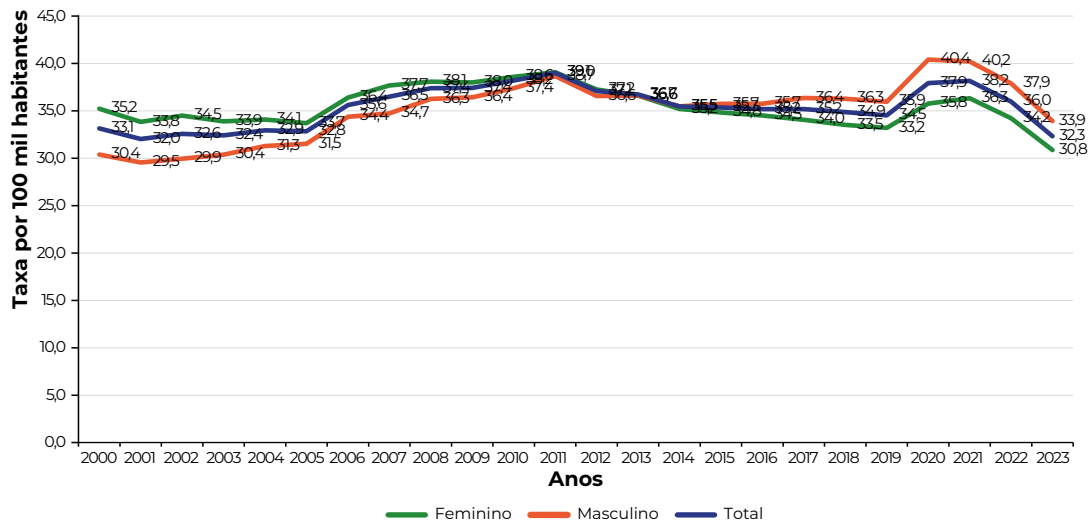
- O_i é o número de óbitos na faixa etária i ;
- P_i é a população na faixa etária i ;
- $P P_i$ é a população-padrão na faixa etária i ; e
- $P P_t$ é a população-padrão total.
- A taxa padronizada por idade é o somatório dos produtos das taxas de mortalidade específicas por idade (taxas observadas) e a população-padrão na mesma idade – o que resulta nos óbitos esperados –, dividido pela população-padrão total. Para maior detalhamento, consultar a nota técnica⁷.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, o diabetes *mellitus* foi responsável por 70.377 óbitos. No período de 2000 a 2023, a taxa padronizada de mortalidade por diabetes *mellitus* declinou de 33,1 para 32,3 óbitos por 100 mil pessoas (variação de -2,5%) (Gráfico 1).

O risco de morte em 2000 foi maior para pessoas do sexo feminino (35,2 por 100 mil) que para pessoas do sexo masculino (30,4 por 100 mil). Mas, em 2023, isto se inverteu: o sexo masculino teve 1,1 vez maior risco de morte que o sexo feminino. O sexo masculino teve aumento do risco de morte de 11,6%, de 2000 para 2023: de 30,4 para 33,9 mortes por 100 mil homens, respectivamente. Para pessoas do sexo feminino, houve redução do risco de morte de 35,2 para 30,8 óbitos por 100 mil mulheres (variação de -12,4%), no mesmo período de análise.

Gráfico 1 – Taxa padronizada de mortalidade por diabetes *mellitus*, segundo sexo. Brasil, 2000 a 2023*



Nota:

*Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴, projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação⁶ e estimativas populacionais para o Brasil, os sexos e os anos de análise (2000 e 2023)⁵. As causas de morte incluídas neste indicador são codificadas como E10 a E14, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas de Sub-Registro – Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos [Internet]. IBGE. 2022 [citado 7 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html?edicao=39639&t=resultados>
3. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html
4. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
6. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
7. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas. Nota Técnica no 51/2025-CGIAE/DAENT/SVSA/MS [Internet]. Brasília; 2025 [citado 19 de agosto de 2025]. Disponível em: https://www.ripsa.org.br/wp-content/uploads/2025/08/SEI_0049780814_Nota_Tecnica_51.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.5.03 – Taxa de mortalidade por diabetes *mellitus* [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18392723



Mortalidade



MRT.5.04 – Taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares

MRT.5.04 – Mortality rate from cardiovascular diseases

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Taxa de mortalidade específica por doenças cardiovasculares, em um local e ano de referência. A taxa é expressa por 100 mil habitantes.
- Mortalidade prematura é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como aquela que ocorre entre 30 e 69 anos de idade¹.
- As causas de óbito incluídas neste indicador são codificadas como I00 a I99, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)².

INTERPRETAÇÃO

- Estima o risco de morte por doenças cardiovasculares e dimensiona a sua magnitude como problema de saúde pública.
- Reflete a mortalidade associada a fatores de risco modificáveis, tais como estilo de vida (tabagismo, consumo de álcool, inatividade física, alimentação inadequada – excesso de sódio, alimentos ultraprocessados, entre outros) e fatores metabólicos (Índice de Massa Corporal – IMC elevado, hipercolesterolemia, hipertensão etc.), além de poluição do ar e estresse, entre outros.
- Expressa as condições de atenção relativas à promoção da saúde, assim como à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento dessas doenças.
- A análise da evolução desse indicador, ao longo do tempo, pode revelar melhorias ou agravamentos no cuidado das doenças cardiovasculares, bem como seus condicionantes ambientais e comportamentais.

USOS

- Descrever a distribuição no espaço e as tendências no tempo da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares, contribuindo para a análise de desigualdades e tendências históricas que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- Levantar hipóteses a serem exploradas em pesquisas epidemiológicas e clínicas, e apoiar a identificação de fatores de risco para essas causas de morte.

- Sensibilizar a população e os formuladores de políticas sobre a importância das doenças cardiovasculares na mortalidade e a necessidade de políticas de saúde voltadas para a promoção da saúde, prevenção e controle dessas doenças.

LIMITAÇÕES

- A validade do indicador é afetada pela cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A cobertura do SIM apresentou melhora ao longo dos anos, alcançando 98,9% em 2022³. No entanto, merecem atenção as estimativas feitas para municípios com coberturas abaixo do ideal e para anos mais distantes na série histórica analisada.
- A validade do indicador é afetada pela qualidade do SIM. As proporções de causas mal definidas e de causas inespecíficas de morte podem subestimar o indicador de mortalidade em questão.
- O acesso aos dados de anos mais recentes está limitado ao prazo descrito na Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministério da Saúde, segundo a qual os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade devem ser divulgados até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência, em caráter oficial⁴.
- A taxa de mortalidade padronizada gera um valor fictício que não reflete diretamente o risco de morte de uma população, podendo ser maior ou menor que a taxa bruta, a depender da população-padrão escolhida.
- Por se tratar de um indicador específico por grupo de causas (doenças cardiovasculares), sua taxa de mortalidade não padronizada por idade pode estar sujeita à influência de alguma variação na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e para períodos distintos.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁵.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁶.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁷.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos por doenças cardiovasculares, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de óbitos por doenças cardiovasculares, em um local e ano de referência.
- Denominador: Total de residentes, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Grupos de causas:

- Doenças isquêmicas do coração (códigos I20-I25);
- Doenças cerebrovasculares (códigos I60-I69); e
- Demais causas (Códigos I00-I19, I26-I59 e I70-I99).

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- Quando o objetivo principal é comparar as taxas de mortalidade em diferentes locais e/ou períodos de tempo, o indicador padronizado por idade é recomendado, a fim de se levar em conta a diferença nas estruturas etárias nessas comparações, ou seja, ajustar por idade.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O conjunto das doenças cardiovasculares foi responsável por 388.177 óbitos no Brasil, em 2023. Nos anos de 2000 e 2023, as taxas brutas de mortalidade por doenças cardiovasculares foram de 149,2 e 183,4 óbitos por 100 mil pessoas, respectivamente (Tabela 1). O risco de morte de pessoas do sexo masculino foi 1,2 vez maior em comparação ao do feminino, tanto em 2000 quanto em 2023. O sexo masculino apresentou taxas de 160,2 e de 198,7 óbitos por 100 mil homens, em 2000 e 2023, respectivamente. De maneira semelhante, o sexo feminino apresentou taxas de 138,5 e de 168,7 óbitos por 100 mil mulheres, nos mesmos anos.

Tabela 1 – Número de óbitos e taxa bruta de mortalidade por doenças cardiovasculares, segundo sexo. Brasil, 2000 e 2023*

Variável e categoria		2000			2023	
Sexo	Óbitos	Taxa	População	Óbitos	Taxa	População
Feminino	123.195	138,5	88.975.229	182.997	168,7	108.443.605
Masculino	137.339	160,2	85.720.706	205.159	198,7	103.251.553
Total	260.603	149,2	174.695.935	388.177	183,4	211.695.158

Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴ e estimativas populacionais para o Brasil, os sexos e os anos de análise (2000 e 2023)⁵. As causas de morte incluídas neste indicador são codificadas como I00 a I99, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)². O total de mortes para o Brasil inclui registros com a variável sexo não informada. Por essa razão, este total não corresponde exatamente à soma dos valores para os sexos masculino e feminino. Em 2000, foram registrados 69 óbitos com sexo ignorado; e em 2023, 21 óbitos.

APÊNDICE

TAXA PADRONIZADA

A fórmula geral para a taxa de mortalidade padronizada por idade, pelo método de padronização direta, é a seguinte:

Taxa padronizada pelo método direto =
$$\frac{\sum P P_i \times \left(\frac{O_i}{P_i}\right)}{P P_t} \times 100.000$$

Onde:

- O_i é o número de óbitos na faixa etária *i*;
- P_i é a população na faixa etária *i*;
- P P_i é a população-padrão na faixa etária *i*; e
- P P_t é a população-padrão total.
- A taxa padronizada por idade é o somatório dos produtos das taxas de mortalidade específicas por idade (taxas observadas) e a população-padrão na mesma idade – o que resulta nos óbitos esperados –, dividido pela população-padrão total. Para maior detalhamento, consultar a nota técnica⁸.

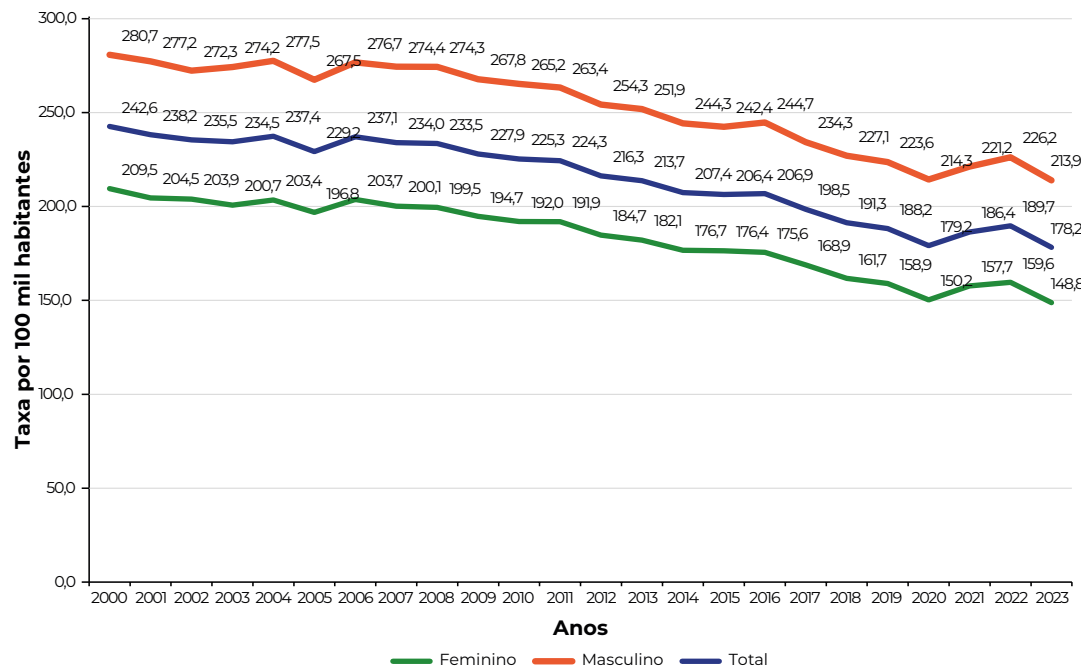
ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, o conjunto das doenças cardiovasculares foi responsável por 388.177 óbitos. No período de 2000 a 2023, a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares diminuiu de 242,6 para 178,2 óbitos por 100 mil pessoas (variação de -26,5%) (Gráfico 1).

O risco de morte entre pessoas do sexo masculino foi 1,3 vez maior em comparação ao feminino, em 2000, e 1,4 vez maior em 2023. O sexo masculino apresentou redução deste indicador, de 280,7 para 213,9 óbitos por 100 mil homens (variação de -23,8%), entre 2000 e 2023, respectivamente. De

maneira semelhante, o sexo feminino apresentou também redução do indicador, de 209,5 para 148,8 óbitos por 100 mil mulheres (variação de -29,0%), no mesmo período de análise.

Gráfico 1 – Taxa padronizada de mortalidade por doenças cardiovasculares, segundo sexo. Brasil, 2000 a 2023*



Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴ e estimativas populacionais municipais de 2000 a 2024; Rede Interagencial de Indicadores de Saúde (Ripsa); e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As causas de morte incluídas neste indicador são codificadas como I00 a I99, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases 2010 [Internet]. World Health Organization. 2011 [citado 6 de agosto de 2025]. p. 1-164. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/44579>
2. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas de Sub-Registro – Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos [Internet]. IBGE. 2022 [citado 7 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html?edicao=39639&t=resultados>
4. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html

5. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
7. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
8. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas. Nota Técnica nº 51/2025-CGIAE/DAENT/SVSA/MS [Internet]. Brasília; 2025 [citado 19 de agosto de 2025]. Disponível em: https://www.ripsa.org.br/wp-content/uploads/2025/08/SEI_0049780814_Nota_Tecnica_51.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.5.04 – Taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18392821



Mortalidade



MRT.5.05 – Taxa de mortalidade por doenças respiratórias crônicas

MRT.5.05 – Mortality rate due to chronic respiratory diseases

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Taxa de mortalidade específica por doenças respiratórias crônicas, em um local e ano de referência. Taxa calculada por 100 mil habitantes.
- As causas de óbito incluídas neste indicador, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹, são as doenças respiratórias crônicas (códigos J30 a J35 e J37 a J98).

INTERPRETAÇÃO

- Estima o risco de morte por um conjunto de doenças respiratórias crônicas – tais como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar – e dimensiona a sua magnitude como problema de saúde pública.
- Reflete a mortalidade majoritariamente associada a fatores de risco modificáveis, tais como os relacionados ao tabagismo, exposição à poluição do ar e fatores de risco ocupacionais, entre outros.
- Expressa as condições de atenção relativas à promoção da saúde, assim como à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento dessas doenças.
- A análise da evolução desse indicador, ao longo do tempo, pode revelar melhorias ou agravamentos no cuidado das doenças respiratórias crônicas na faixa etária analisada, bem como de seus condicionantes ambientais e comportamentais.

USOS

- Descrever a distribuição, no espaço e no tempo, da taxa de mortalidade por doenças respiratórias crônicas, contribuindo para a análise de desigualdades e tendências históricas que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde relacionadas às doenças respiratórias crônicas, como programas de controle do tabagismo, melhorias na qualidade do ar e acesso a cuidados de saúde de alta qualidade.
- Levantar hipóteses a serem exploradas em pesquisas epidemiológicas e clínicas, e apoiar a identificação de fatores de risco para essas causas.
- Sensibilizar a população e os formuladores de políticas sobre a importância das doenças respiratórias crônicas na mortalidade e a necessidade de políticas voltadas para a promoção da saúde, a prevenção e o controle dessas doenças.

LIMITAÇÕES

- A validade do indicador é afetada pela cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A cobertura do SIM apresentou melhora ao longo dos anos, alcançando 98,9%, em 2022². No entanto, merecem atenção as estimativas feitas para municípios com coberturas abaixo do ideal e para anos mais distantes na série histórica analisada.
- A validade do indicador é afetada pela qualidade do SIM. As proporções de causas mal definidas e de causas inespecíficas de morte podem subestimar o indicador de mortalidade em questão.
- O acesso aos dados de anos mais recentes está limitado ao prazo descrito na Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministério da Saúde, segundo a qual os dados do SIM devem ser divulgados até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência, em caráter oficial³.
- A taxa de mortalidade padronizada gera um valor estimado que não reflete diretamente o risco de morte de uma população, podendo ser maior ou menor que a taxa bruta, a depender da população-padrão escolhida.
- Trata-se de um indicador específico por grupo de causas (doenças respiratórias crônicas). Assim, a taxa de mortalidade não padronizada por idade pode estar sujeita à influência de alguma variação na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e para períodos distintos.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁵.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁶.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos por doenças respiratórias crônicas, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de óbitos por doenças respiratórias crônicas, em um local e ano de referência.
- Denominador: Total de residentes, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Grupo de causas:

- Doenças das vias aéreas superiores (códigos J30-J39, exceto J36);
- Doenças crônicas das vias aéreas inferiores (códigos J40-J70);
- Doenças pulmonares devido a agentes externos (códigos J60-J70);
- Outras doenças respiratórias que afetam principalmente o interstício (códigos J80-J84);
- Afecções necróticas e supurativas das vias aéreas inferiores (códigos J85-J86);
- Outras doenças da pleura (códigos J90-J94); e
- Outras doenças do aparelho respiratório (códigos J95-J98).

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- Quando o objetivo principal é comparar as taxas de mortalidade em diferentes locais e/ou períodos de tempo, o indicador padronizado por idade é recomendado, a fim de se levar em conta a diferença nas estruturas etárias nessas comparações, ou seja, ajustar por idade, conforme apresentado no apêndice.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, as doenças respiratórias crônicas analisadas foram responsáveis por 81.102 óbitos. Nos anos de 2000 e 2023, as taxas de mortalidade por doenças respiratórias crônicas foram de 33,2 e de 38,3 óbitos por 100 mil habitantes (Tabela 1). O sexo masculino apresentou taxas de 38,7 e de 40,6 óbitos por 100 mil homens, nos anos de 2000 e 2023, respectivamente. Para o sexo feminino, as taxas foram de 27,9 e 36,1 óbitos por 100 mil mulheres, no mesmo período de análise.

Tabela 1 – Número de óbitos e taxas brutas de mortalidade por doenças respiratórias crônicas, segundo sexo. Brasil, 2000 e 2023*

Variável e categoria		2000			2023	
Sexo	Óbitos	Taxa	População	Óbitos	Taxa	População
Feminino	24.793	27,9	88.975.229	39.148	36,1	108.443.605
Masculino	33.156	38,7	85.720.706	41.947	40,6	103.251.553
Total	57.977	33,2	174.695.935	81.102	38,3	211.695.158

Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴ e estimativas populacionais para o Brasil, os sexos e os anos de análise (2000 e 2023).⁵ As causas de morte incluídas, conforme a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)⁵, são as doenças respiratórias crônicas (códigos J30 a J35 e J37 a J98). O total do Brasil inclui registros com a variável sexo não informada; por isso, não corresponde exatamente à soma de masculino e feminino. Em 2000, foram registrados 28 óbitos com sexo ignorado; e em 2023, registraram-se 7.

APÊNDICE

TAXA PADRONIZADA

A fórmula geral para a taxa de mortalidade padronizada por idade, pelo método de padronização direta, é a seguinte:

$$\text{Taxa padronizada pelo método direto} = \frac{\sum P P_i \times \left(\frac{O_i}{P_i} \right)}{P P_t} \times 100.000$$

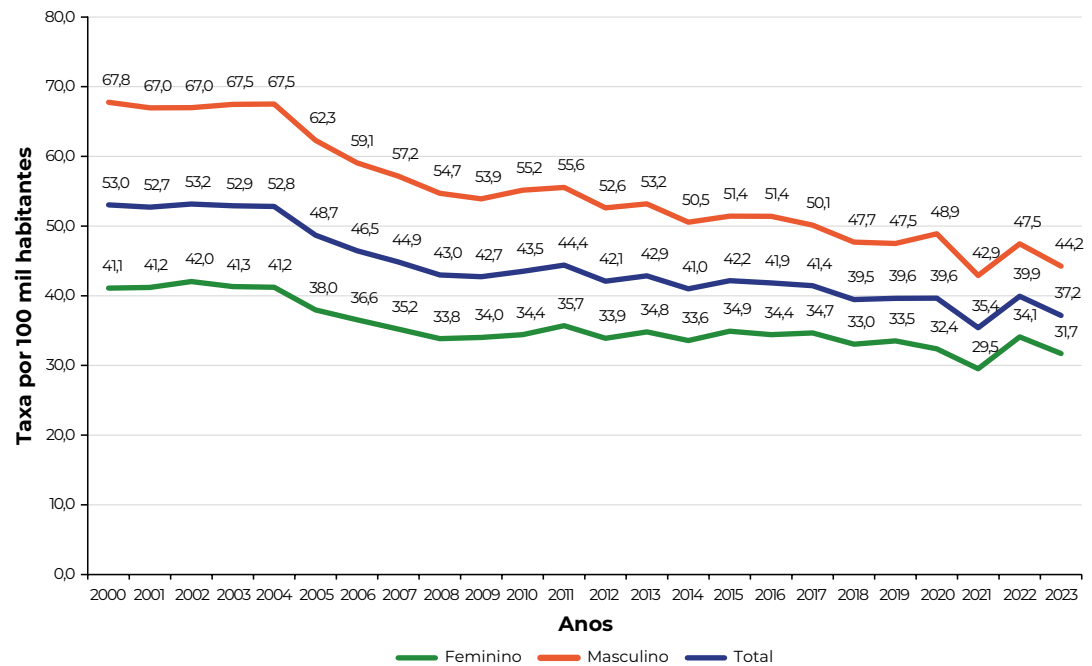
Onde:

- O_i é o número de óbitos na faixa etária i ;
- P_i é a população na faixa etária i ;
- $P P_i$ é a população-padrão na faixa etária i ; e
- $P P_t$ é a população-padrão total.
- A taxa padronizada por idade é o somatório dos produtos das taxas de mortalidade específicas por idade (taxas observadas) e a população-padrão na mesma idade – o que resulta nos óbitos esperados –, dividido pela população-padrão total. Para maior detalhamento, consultar a nota técnica⁷.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2023, o conjunto das doenças respiratórias crônicas foi responsável por 81.102 óbitos. No período de 2000 a 2023, a taxa padronizada de mortalidade por doenças respiratórias crônicas diminuiu de 53,0 para 37,2 óbitos por 100 mil pessoas (variação de -29,9%) (Gráfico 1). O risco de morte entre o sexo masculino foi 1,6 vez maior em comparação ao feminino, em 2000, e 1,4 vez maior em 2023. O sexo masculino apresentou redução deste indicador, de 67,8 para 44,2 óbitos por 100 mil homens (variação de -34,7%) entre 2000 e 2023, respectivamente. Para o sexo feminino, o risco de morte se reduziu de 41,1 para 31,7 óbitos por 100 mil mulheres (variação de -22,9%), no mesmo período de análise.

Gráfico 1 – Taxa padronizada de mortalidade por doenças respiratórias crônicas, segundo sexo. Brasil, 2000 a 2023*



Nota:

- *Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁴, projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação⁶ e estimativas populacionais para o Brasil, os sexos e os anos de análise (2000 e 2023)⁵. As causas de morte incluídas neste indicador são codificadas como J30 a J35 e J37 a J98, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas de Sub-Registro – Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos [Internet]. IBGE. 2022 [citado 7 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html?edicao=39639&t=resultados>
3. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html
4. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

6. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
7. Ministério da Saúde. Nota Técnica no 51/2025-CGIAE/DAENT/SVSA/MS. [Brasília]: Ministério da Saúde; 2025.

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.5.05 – Taxa de mortalidade por doenças respiratórias crônicas [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18393012



Mortalidade



MRT.5.06 – Probabilidade de morte prematura por doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes *mellitus* e doenças respiratórias crônicas

MRT.5.06 – Probability of premature death from cardiovascular diseases, malignant neoplasms, diabetes mellitus, and chronic respiratory diseases

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Probabilidade de morte, entre as idades de 30 a 69 anos, por qualquer doença cardiovascular, neoplasia maligna, diabetes *mellitus* e doença respiratória crônica, em um local e ano de referência. O indicador é calculado como percentual.
- Mortalidade prematura é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como aquela que ocorre entre 30 e 69 anos de idade¹.
- As causas de óbitos incluídas neste indicador, segundo os códigos da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª revisão (CID-10)², são: doenças cardiovasculares (I00-I99); neoplasias malignas (C00-C97), diabetes *mellitus* (E10-E14) ou doenças respiratórias crônicas (J30-J35; J37-J98).

INTERPRETAÇÃO

- Expressa o percentual de pessoas com 30 anos de idade que provavelmente morrerão antes de completar 70 anos por qualquer doença cardiovascular, neoplasia maligna, diabetes *mellitus* ou doença respiratória crônica, presumindo que elas estarão expostas às taxas de mortalidade atuais em cada idade, e que não morreriam por outras causas (como causas externas ou doenças transmissíveis).
- A probabilidade de morrer por qualquer doença cardiovascular, neoplasia maligna, diabetes *mellitus* ou doença respiratória crônica, na população com idade de 30 a 69 anos, está associada a fatores de risco modificáveis, como estilo de vida (tabagismo, consumo de álcool, inatividade física, alimentação inadequada – excesso de sódio, alimentos ultraprocessados etc.); fatores metabólicos (como Índice de Massa Corporal – IMC elevado, hipercolesterolemia, hipertensão); além de poluição do ar e estresse, entre outros.
- A diminuição do valor do percentual, ao longo do tempo, demonstra progresso no indicador, e pode revelar melhorias na atenção às pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), bem como melhorias nos indicadores relacionados ao estilo de vida.

USOS

- Indicador 3.4.1. Probabilidade de morte prematura por doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes *mellitus* e doenças respiratórias crônicas, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)³.

- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- Indicador a ser monitorado no Plano de Ação Global para a Prevenção e Controle de Doenças Não Transmissíveis 2013-2020⁴.
- Indicador a ser monitorado no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) no Brasil 2021-2030⁵.
- Subsidiar a construção de normativas técnico-científicas orientadas para o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde.

LIMITAÇÕES

- A validade do indicador é afetada pela cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A cobertura do SIM apresentou melhora ao longo da série histórica analisada, sendo que, em 2022, atingiu 98,9%⁶. No entanto, merecem atenção as estimativas feitas para municípios que permanecem com coberturas abaixo do ideal e para anos mais distantes da série histórica.
- A validade do indicador é afetada pela qualidade do SIM. As proporções de causas mal definidas e de causas inespecíficas de morte podem subestimar o indicador de mortalidade em questão.
- O acesso aos dados de anos mais recentes está limitado ao prazo descrito na Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministério da Saúde, segundo a qual os dados do SIM devem ser divulgados até 30 de dezembro do ano subsequente ao ano de ocorrência, em caráter oficial⁷.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁸.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁹.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade¹⁰.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$1 - \prod \text{probabilidades específicas por faixa de idade}$$

Notas:

- Na fórmula, $\prod$ é o produto das probabilidades específicas por faixa de idade.
- São considerados os óbitos classificados com os seguintes códigos da CID-102: I00-I99, C00-C97, E10-E14, J30-J35 e J37-J98.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Afere-se a probabilidade de morrer por doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes *melittus* e doenças respiratórias crônicas¹¹, em um local e ano de referência, de acordo com registros nos seguintes códigos da CID-102: I00-I99; C00-C97; E10-E14; J30-J35; e J37-J98.
- Inicialmente, para cada grupo de idade de 5 anos entre 30 e 69 anos, da seguinte forma: (taxa de mortalidade $\times$ 5) / (1 + taxa de mortalidade $\times$ 2.5).

- A probabilidade de morrer entre os 30 e 69 anos é obtida a partir da seguinte fórmula: $\{1 - [(1 - \text{probabilidade de morrer dos 30 a 34 anos}) * (1 - \text{probabilidade de morrer dos 35 a 39 anos}) * (\dots) * (1 - \text{probabilidade de morrer dos 65 a 69 anos})]\} (x100)$.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Unidades da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

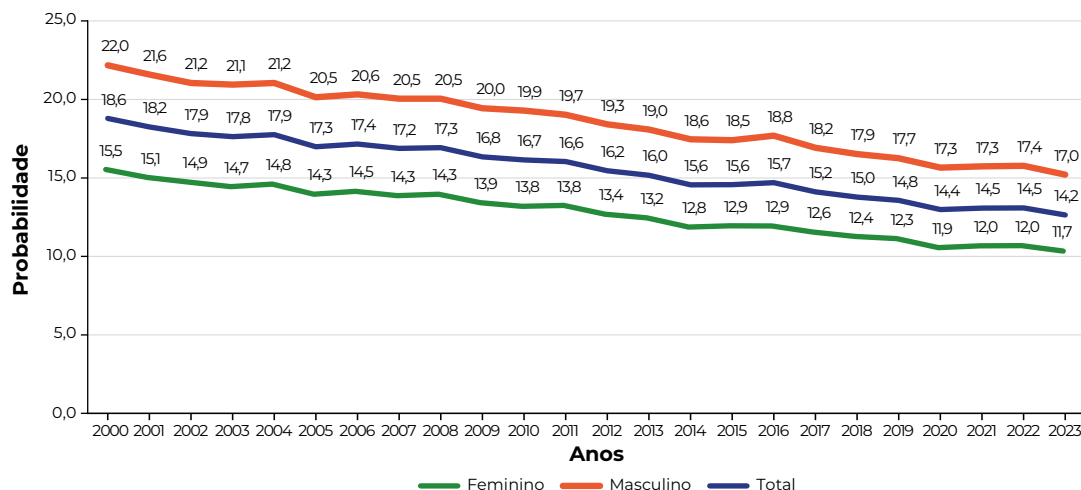
NOTA

- Indicador 3.4.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, a probabilidade de morte prematura por doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes *mellitus* e doenças respiratórias crônicas, no período de 2000 a 2023, apresentou redução de 23,8%, passando de 18,6% para 14,2%. Entre as mulheres, a redução foi maior do que a nacional (-24,3%); por seu turno, entre os homens, a variação foi de -22,9%. Em 2023, a probabilidade de morte prematura para o total dos dois sexos foi de 14,2%; para o masculino, foi de 17%, e para o sexo feminino, de 11,7%, conforme apresentado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Probabilidade de morte prematura por doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes *mellitus* e doenças respiratórias crônicas, segundo sexo. Brasil, 2000 a 2023*



Nota:

- *Mortalidade prematura se refere aos óbitos ocorridos na faixa etária de 30 a 69 anos de idade. Dados originados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)⁹ e das Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade para o período 2000-2024¹⁰. As causas de morte incluídas, de acordo com os códigos da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10^a Revisão (CID-10)², são as seguintes: I00-I99; C00-C97; E10-E14; J30-J35; e J37-J98².

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases 2010 [Internet]. World Health Organization. 2011 [citado 6 de agosto de 2025]. p. 1-164. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/44579>
2. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Indicador 3.4.1 – Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, tumores malignos, diabetes *mellitus* e doenças crônicas respiratórias [Internet]. IBGE. [citado 11 de maio de 2025]. Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/objetivo3/indicador341>
4. World Health Organization. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases, 2013-2020 [Internet]. World Health Organization; 2013 [citado 7 de maio de 2025]. 0-55 p. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241506236>
5. Ministério da Saúde. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil, 2021-2030 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2021 [citado 7 de maio de 2025]. 1-118 p. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-2022_2030.pdf/view
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas de Sub-Registro – Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos [Internet]. IBGE. 2022 [citado 7 de maio de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html?edicao=39639&t=resultados>

7. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html
8. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
9. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
10. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
11. Ministério da Saúde. Caderno de Indicadores do Plano de Dant 2021-2030 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 11 de maio de 2025]. 1–85 p. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/caderno-de-indicadores-do-plano-de-dant-2021-2030.pdf>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.5.06 – Probabilidade de morte prematura por doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, diabetes *mellitus* e doenças respiratórias crônicas [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18393122



Mortalidade



MRT.6.01 – Taxa de mortalidade específica por doenças infecciosas e parasitárias

MRT.6.01 – Cause-specific mortality rate for infectious and parasitic diseases

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de óbitos por doenças infecciosas e parasitárias, por 100 mil habitantes, na população residente em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima o risco de morte pelo conjunto das doenças infecciosas e parasitárias consideradas e dimensiona a sua magnitude como problema de saúde pública.
- Retrata a ocorrência dessas doenças em segmentos populacionais vulneráveis, associada às condições de desenvolvimento socioeconômico e de infraestrutura ambiental.
- Expressa a distribuição de doenças infecciosas e parasitárias.
- Reflete também a efetividade de medidas de prevenção, vigilância e controle, bem como as condições de diagnóstico e da assistência à saúde dispensada.
- A taxa de mortalidade específica não padronizada por idade pode estar sujeita à influência de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e para períodos distintos.

USOS

- Subsidiar a análise das variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias em segmentos populacionais, identificando-se situações de desigualdades e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir na avaliação dos níveis de saúde, de desenvolvimento socioeconômico e de infraestrutura ambiental.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde, concernentes às doenças infecciosas e parasitárias.
- Subsidiar a articulação intersetorial entre o setor da saúde e demais políticas públicas, ao serem oferecidas evidências qualificadas sobre a distribuição e a persistência da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias.

LIMITAÇÕES

- Sua validade pode ser comprometida nas situações em que há elevada proporção (mais que 10%) de óbitos por causas mal definidas ou inespecíficas.

- Sua validade também é afetada pela cobertura do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). A cobertura do SIM apresentou melhora ao longo dos anos, alcançando 98,9%, em 2023. No entanto, merecem atenção as estimativas feitas para municípios com coberturas abaixo do ideal (menor que 90%) e para anos mais distantes na série histórica analisada.
- O acesso aos dados mais recentes segue o prazo estabelecido pela Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministério da Saúde, segundo a qual os dados preliminares sobre óbitos devem ser divulgados entre 30 de junho e 30 de agosto do ano seguinte ao evento, e os dados definitivos, até 30 de dezembro do mesmo ano².

FONTES DE DADOS

- Sistema de informação sobre mortalidade (SIM)³.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁴.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de óbitos por doenças infecciosas e parasitárias de residentes, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Somatório, na população residente em um local e ano de referência, dos óbitos por doenças infecciosas e parasitárias, classificados nos códigos A00-B99 do Capítulo I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias; G00-G03 do Capítulo VI – Doenças do sistema nervoso; J00-J22 do Capítulo X – Doenças do aparelho respiratório; O98 do Capítulo XV – Gravidez, parto e puerpério; e P35-P39 do Capítulo XVI – Algumas afecções originadas no período perinatal, da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)⁶.
- Denominador: População residente no mesmo local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Grupos de doenças (CID-10):

- Infecções respiratórias: J00-J22;
- COVID-19: B34.2 com ou (sem) menção de U07.1 ou U07.2 ou U92.1; O98.5 + B34.2 + U07.1 ou U07.2 ou U92.1
- Aids: B20-B24;
- Hepatites virais: B15-B19;
- Arboviroses: A83; A84; A85.2; A90-A91, A92, A93, A94, A95;
- Tuberculose: A15-A19;
- Meningites: A39, A87, G00-G03;
- Doenças infecciosas intestinais: A00-A09;
- Septicemias (exceto neonatal): A40-A41;
- Doenças infecciosas maternas: O98;
- Infecções do período perinatal: P35-P39;
- Algumas doenças imunopreveníveis: A36 (difteria); A37 (coqueluche); A33-A35 (tétano); A80 (poliomielite aguda); B01 (varicela); B05 (sarampo); B06 (rubéola); B26 (caxumba);
- Outras doenças transmitidas por vetores, exceto arboviroses: A20; A44; A75-79; B50-B54; B55; B56; B57; B74.0-B74.9; e
- Demais doenças infecciosas e parasitárias não incluídas nos grupos acima descritos: A10-A14; A21-A28; A30-A32; A38; A42-A43; A46; A48-A49; A50-A64; A65-A69; A70-A74; A82; A96-A99; B00-B04; B07-B14; B25; B27-B49; B58-B73; B75-B83; B85-B89; B90-B94; B95-B99.

Observações**(i) Para a COVID-19**

Devem-se considerar para o cálculo os registros com causa básica de óbito B34.2 (infecção pelo coronavírus de localização não especificada), acompanhada ou não de um desses marcadores: U07.1 – COVID-19, vírus identificado; U07.2 – COVID-19, vírus não identificado ou U92.1 – reincidência de COVID-19. Todos são códigos da CID-10.

Essa regra evita subenumeração, pois muitos registros – especialmente aqueles mais próximos do início da pandemia – são incompletos: apresentam B34.2 sem U07 ou U92.1 e, ainda assim, correspondem a óbitos por COVID-19.

Para óbitos maternos por COVID-19, usar a causa básica O98.5 (outras doenças virais complicando a gravidez, o parto e o puerpério), na seguinte composição: O98.5+B34.2+U071 (COVID-19, vírus identificado); ou O98.5+B34.2+U07.2 (COVID-19, vírus não identificado) ou O98.5+U09.1 (reincidência de COVID-19)

(ii) Para a análise de arboviroses, a partir do ano de óbito 2025

A partir das análises referentes ao ano de 2025, a codificação dos casos e óbitos por dengue passa a utilizar exclusivamente a categoria A97 – Dengue, conforme a versão atualizada da CID-10. Nesta atualização, houve inclusão de nova categoria e exclusão de categorias anteriores, substituindo-se os códigos A90 e A91, que foram excluídos.

Assim, a partir de 2025, todos os registros de dengue devem ser tabulados sob o código A97, garantindo-se a padronização das análises. Para séries históricas, recomenda-se destacar que, até 2024, a dengue estava distribuída entre os códigos A90 e A91, e, a partir de 2025, passa a ser registrada exclusivamente como A97.

(iii) Infecções do período perinatal (P35-39).

As infecções do período perinatal (P35-P39) incluem todas as condições infecciosas que acometem o recém-nascido, como rubéola congênita, citomegalovírus, infecções

por estreptococos do grupo B e outras septicemias neonatais, podendo resultar em morbimortalidade significativa.

- (iv) As doenças infecciosas e parasitárias maternas (O98) abrangem infecções que complicam a gravidez, o parto ou o puerpério, incluindo HIV, rubéola, dengue, hepatites e outras doenças infecciosas, com impacto direto na saúde materna e potencial transmissão vertical. Para aids, utiliza-se B20 a B24, até o ano de 2020. A partir de 2021, será considerado o código O98.7 (Doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] complicando a gravidez, o parto e o puerpério).

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Para fins de comparações adequadas entre populações com estrutura etária distinta, sugere-se a padronização de taxas. Essa técnica permite corrigir as diferenças, para que se possam comparar as taxas de mortalidade (ou outras) de forma mais precisa.
- Pode-se consultar a Nota Técnica nº 51/2025-CGIAE/Daent/SVSA/MS para melhor entendimento sobre a padronização de taxas⁷.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A Tabela 1 apresenta a evolução da taxa bruta de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias no período de 2010 a 2023, evidenciando, nos anos iniciais da série, um crescimento gradual entre 2010 e 2016, quando a taxa passou de 56,6 para 72,0 óbitos por 100 mil habitantes. Esse aumento progressivo indica uma elevação da magnitude da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias ao longo da primeira metade da década, possivelmente influenciada por fatores demográficos, pela persistência de agravos endêmicos e por limitações estruturais no controle de determinadas infecções.

Entre 2017 e 2019, observa-se um período de relativa estabilidade, com pequenas oscilações em torno de 68 a 70 óbitos por 100 mil habitantes. Esse comportamento sugere que, apesar da manutenção de níveis elevados de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, não houve alterações significativas no risco geral nesse intervalo, o que pode refletir um equilíbrio temporário entre ações de prevenção, acesso aos serviços de saúde e o perfil epidemiológico vigente antes de grandes eventos sanitários.

A partir de 2020, a série histórica apresenta uma elevação abrupta e excepcional, com a taxa atingindo 163,0 óbitos por 100 mil habitantes, em 2020, e alcançando seu pico em 2021 (267,3

óbitos por 100 mil habitantes), resultado fortemente associado à pandemia de COVID-19 e aos seus impactos diretos e indiretos sobre a mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias. Nos anos subsequentes, 2022 e 2023, verifica-se uma redução expressiva das taxas, que caem para 107,8 e 78,5 óbitos por 100 mil habitantes, respectivamente, indicando um processo de arrefecimento do impacto pandêmico e uma aproximação gradual dos níveis observados no período pré-pandemia, embora ainda superiores aos do início da série.

Tabela 1 – Taxa bruta* de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, por 100 mil habitantes. Brasil, 2010 a 2023

Ano	Taxa bruta
2010	56,6
2011	58,7
2012	59,3
2013	63,7
2014	64,3
2015	68,4
2016	72,0
2017	68,4
2018	68,1
2019	70,4
2020	163,0
2021	267,3
2022	107,8
2023	78,5

Nota:

- *Taxas não padronizadas.

APÊNDICE

TAXA PADRONIZADA

A fórmula geral para taxa de mortalidade padronizada por idade, pelo método de padronização direta, é apresentada a seguir:

$$\text{Taxa padronizada pelo método direto} = \frac{\sum PP_i \times \left(\frac{O_i}{P_i}\right)}{PP_t} \times 100.000$$

Onde:

- O_i é o número de óbitos na faixa etária i ;
- P_i é a população na faixa etária i ;

- PPI é a população-padrão na faixa etária i ; e
- PPT é a população-padrão total.
- A taxa padronizada por idade é o somatório dos produtos das taxas de mortalidade específicas por idade (taxas observadas) e a população-padrão na mesma idade, o que resulta nos óbitos esperados; dividido pela população-padrão total. Para maior detalhamento, favor consultar a nota técnica⁷.

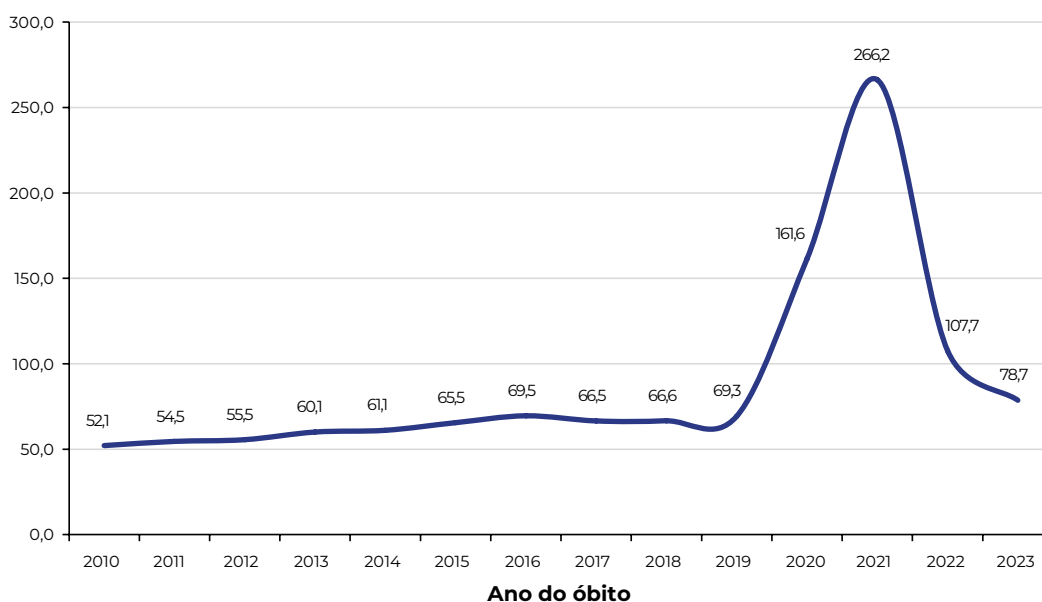
ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O Gráfico 1 apresenta a evolução da taxa padronizada de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias entre 2010 e 2023, evidenciando um crescimento lento e contínuo no período inicial da série, de 2010 até aproximadamente 2016. Nessa fase, a taxa aumenta de forma gradual, passando de pouco mais de 50 para cerca de 70 óbitos por 100 mil habitantes, o que indica um incremento progressivo da mortalidade por esses agravos, ao longo da primeira metade da década.

Entre 2017 e 2019, observa-se um comportamento relativamente estável, com pequenas oscilações em torno de um patamar semelhante, sem tendência clara de queda ou aumento acentuado. Esse padrão sugere a manutenção de níveis elevados de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias no período imediatamente anterior à pandemia, refletindo um cenário epidemiológico relativamente constante.

A partir de 2020, os resultados revelam uma mudança abrupta e marcante, com forte elevação da taxa em 2020 e um pico expressivo em 2021. Esse aumento excepcional é compatível com o impacto da pandemia de COVID-19 sobre a mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias. Nos anos seguintes, 2022 e 2023, observa-se uma redução acentuada da taxa, indicando arrefecimento do impacto pandêmico e uma tendência de retorno a níveis mais próximos aos observados no período pré-pandemia, embora ainda superiores aos do início da série histórica.

Gráfico 1 – Taxa padronizada de mortalidade específica por doenças infecciosas e parasitárias. Brasil, 2010 a 2023



REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. SCORE for Health Data Technical Package: Assessment Methodology. Geneva: World Health Organization, 2020. Annex C, Table C2.3 – Response and score for “Quality of cause-of-death data”.
2. Ministério da Saúde. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009. Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. [Internet]. Brasília; 2009. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html
3. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
5. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
6. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
7. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças não Transmissíveis, Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas. Nota Técnica N° 51/2025-CGIAE/DAENT/SVSA/MS: Padronização de taxas brutas. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2025 [acesso em 18 ago 2025]. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Mortalidade. MRT.6.01 – Taxa de mortalidade específica por doenças infecciosas e parasitárias [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 7p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18393665





INDICADORES DE
MORBIDADE (MRB)

Indicadores de morbidade (MRB)

Os indicadores de morbidade da Ripsa desempenham papel fundamental na análise da situação de saúde da população brasileira. Sua mensuração possibilita o monitoramento, e sua interpretação não apenas revela a ocorrência de doenças, agravos e condições de saúde relevantes, mas possibilita o aperfeiçoamento da vigilância em saúde e da organização dos serviços, bem como a formulação, o acompanhamento e a avaliação de políticas públicas no âmbito do SUS.

No contexto da transição epidemiológica incompleta, que representa um desafio para o SUS, importa reconhecer a coexistência de doenças transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, agravos relacionados ao trabalho e eventos decorrentes de causas externas. Por isso, indicadores de morbidade são ferramentas essenciais, e sua análise possibilita a identificação de padrões epidemiológicos temporais e espaciais, a detecção oportuna de surtos e epidemias, a avaliação da carga das doenças e a orientação de ações de prevenção, controle e cuidado. Esses indicadores são instrumentos úteis para evidenciar desigualdades regionais, sociais e populacionais, contribuindo para o direcionamento de intervenções equitativas e efetivas.

O conjunto de indicadores de morbidade está organizado em seis dimensões, estruturadas a partir de diferentes sistemas e fontes de informação em saúde. Essas dimensões abrangem desde a incidência e a prevalência de doenças transmissíveis – incluindo agravos imunopreveníveis, doenças emergentes e infecções de relevância sanitária – até condições crônicas não transmissíveis, acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, e a morbidade hospitalar. De forma integrada, essas dimensões permitem uma visão abrangente da carga de adoecimento da população, bem como da resposta do sistema de saúde, em seus diferentes níveis de atenção.

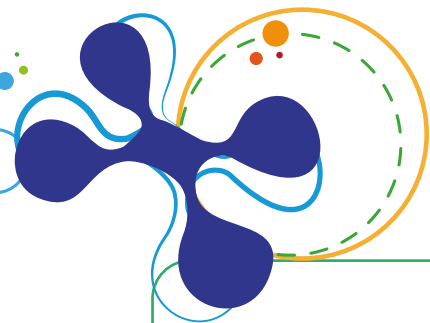


Dimensão 1 – Incidência de doenças transmissíveis

- MRB.1.01 – Incidência de sarampo
- MRB.1.02 – Incidência de rubéola
- MRB.1.03 – Incidência de síndrome da rubéola congênita
- MRB.1.04 – Incidência de difteria
- MRB.1.05 – Incidência de coqueluche
- MRB.1.06 – Incidência de tétano neonatal
- MRB.1.07 – Incidência de tétano acidental
- MRB.1.08 – Incidência de febre amarela
- MRB.1.09 – Incidência de raiva humana
- MRB.1.10 – Incidência de cólera
- MRB.1.11 – Incidência de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika
- MRB.1.12 – Incidência de Zika em gestante
- MRB.1.13 – Incidência de doença meningocócica
- MRB.1.14 – Incidência de meningite não meningocócica
- MRB.1.15 – Incidência de leptospirose
- MRB.1.16 – Incidência de febre maculosa
- MRB.1.17 – Incidência de esquistossomose mansoni não grave
- MRB.1.18 – Incidência de doença de Chagas aguda

Dimensão 2 – Taxa de incidência de doenças transmissíveis

- MRB.2.01 – Taxa de incidência de aids
- MRB.2.02 – Taxa de incidência de sífilis congênita
- MRB.2.03 – Taxa de incidência de hepatite B
- MRB.2.04 – Taxa de incidência de hepatite C
- MRB.2.05 – Taxa de incidência de tuberculose
- MRB.2.06 – Taxa de incidência de hanseníase
- MRB.2.07 – Taxa de incidência de hanseníase na população menor de 15 anos
- MRB.2.08 – Taxa de incidência de leishmaniose tegumentar
- MRB.2.09 – Taxa de incidência de leishmaniose visceral
- MRB.2.10 – Taxa de incidência de toxoplasmose adquirida durante a gestação
- MRB.2.11 – Taxa de incidência de toxoplasmose congênita



MRB.2.12 – Taxa de incidência parasitária anual de malária

MRB.2.13 – Taxa de incidência de dengue

MRB.2.14 – Taxa de incidência de dengue grave

MRB.2.15 – Taxa de incidência de chikungunya

MRB.2.16 – Taxa de incidência de Zika

MRB.2.17 – Taxa de incidência da síndrome respiratória
aguda grave por COVID-19

Dimensão 3 – Prevalência de exposição em doenças transmissíveis

MRB.3.01 – Proporção de categoria de exposição de aids

Dimensão 4 – Morbidade hospitalar

MRB.4.01 – Taxa de internação hospitalar (SUS) por causas externas

MRB.4.02 – Taxa de internação hospitalar (SUS) por condições
sensíveis à atenção primária



MRB.1.01 – Incidência de sarampo

MRB.1.01 – Measles incidence

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de sarampo, em um local e ano de referência.
- Os casos de sarampo são codificados como B05 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos de sarampo, em um local e ano de referência.
- A ocorrência de casos autóctones indica a persistência de fatores favoráveis à transmissão do vírus do sarampo, em especial a existência de segmentos populacionais com cobertura vacinal insuficiente.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos de sarampo, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Investigar e identificar grupos populacionais mais expostos e fatores de risco para o sarampo, sendo oferecidos subsídios para a elaboração de estratégias de controle.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à prevenção, ao controle e à eliminação do sarampo, no contexto das doenças evitáveis por imunização.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de sarampo.
- Devido à menor circulação do vírus do sarampo no país, nas últimas décadas, a doença apresenta maior probabilidade de ser confundida com outras doenças exantemáticas, o que pode resultar em subnotificação de casos.
- Crianças vacinadas, mas que não tomaram a dose de reforço, podem apresentar um quadro atenuado de sarampo que se confunda com outras doenças exantemáticas da infância, resultando em subnotificação de casos.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de sarampo, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum$) do número de casos incidentes confirmados de sarampo, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Situação vacinal:

- Vacinado;
- Não vacinado; e
- Não Informada.

Tipo do caso:

- Importado;
- Autóctone; e
- Indeterminado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Vigilância Epidemiológica do Departamento do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DPNI/SVSA/MS).

NOTAS

- A definição de caso confirmado de sarampo baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.
- O Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) o Certificado de País Livre da Circulação do Vírus do Sarampo em 2016, perdeu-o em 2019, devido ao ressurgimento de casos, e foi recertificado em novembro 2024, após o controle sustentado da transmissão⁴.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no período de 2014 a 2024, foram notificados 40.911 casos confirmados de sarampo (Tabela 1). Houve um pico de casos em 2019 (21.944 casos), precedido por anos de ascensão em 2014 (838 casos) e 2018 (9.333 casos) e seguido por declínio progressivo: 2020, com 7.882 casos; 2021, com 663 casos; 2022, com 36 casos; 2023, com apenas 4 casos; e discreto aumento em 2024, para 9 casos.

A região Sudeste concentrou o maior número de casos (20.968), seguida pelo Norte (15.411). As regiões Sul (2.667 casos), Nordeste (1.700 casos) e Centro-Oeste (57 casos) apresentaram menor incidência. Entre as Unidades da Federação (UFs), o estado de São Paulo concentrou o maior número absoluto de casos (18.974), seguido por Amazonas (8.802 casos) e Pará (5.471 casos).

O padrão temporal indica controle da transmissão a partir de 2021, e 2023 foi o ano com melhor controle epidemiológico. A retomada de casos em 2024, ainda que em número reduzido, concentrou-se nas regiões Nordeste (4 casos) e Sudeste (4 casos).

Tabela 1 – Número de casos confirmados de sarampo, por ano dos primeiros sintomas. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	838	197	1	4	9.333	21.944	7.882	663	36	4	9	40.911
Norte	-	1	-	1	9.153	506	5.087	636	27			15.411
Acre	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Amapá	-	-	-	-	-	2	313	510	24	-	-	849
Amazonas	-	-	-	-	8.791	5	6	-	-	-	-	8.802
Pará	-	-	-	-	85	497	4.761	126	2	-	-	5.471
Rondônia	-	-	-	-	2	1	6	-	1	-	-	10
Roraima	-	1	-	1	274	1	-	-	-	-	-	277
Tocantins	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Nordeste	825	193	1	3	12	565	78	15	1	3	4	1.700
Alagoas	-	-	-	-	-	35	3	11	-	-	-	49
Bahia	-	-	-	1	3	68	6	-	-	-	1	79
Ceará	808	190	-	-	-	18	8	3	-	-	-	1.027
Maranhão	-	-	-	-	-	8	17	-	-	-	-	25
Paraíba	-	-	-	-	-	67	1	-	-	-	-	68
Pernambuco	17	3	1	2	4	350	32	1	-	2	1	413
Piauí	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	7
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	7	3	-	1	1	2	14
Sergipe	-	-	-	-	4	6	8	-	-	-	-	18
Sudeste	13	3	-	-	28	18.777	2.123	11	8	1	4	2.968
Espírito Santo	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
Minas Gerais	2	1	-	-	-	161	34	-	-	1	1	200
Rio de Janeiro	3	-	-	-	20	499	1.262	3	2	-	1	1.790
São Paulo	8	2	-	-	8	18.113	827	8	6	-	2	18.974
Sul	-	-	-	-	48	2.047	571	-	-	-	1	2.667
Paraná	-	-	-	-	1	1.634	442	-	-	-	-	2.077
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	47	107	32	-	-	-	1	187
Santa Catarina	-	-	-	-	-	306	97	-	-	-	-	403
Centro-Oeste	-	-	-	-	2	32	22	1	-	-	-	57
Distrito Federal	-	-	-	-	1	11	8	-	-	-	-	20
Goiás	-	-	-	-	-	17	3	1	-	-	-	21
Mato Grosso	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	4	10	-	-	-	-	14
Ignorado/exterior	-	-	-	-	90	17	1	-	-	-	-	108

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

Cabe ressaltar que o sarampo foi historicamente uma das principais causas de morbidade e mortalidade na infância, principalmente entre menores de 1 ano de idade⁵. Tal situação se manteve até a década de 1980; porém, a partir de 1990, esta situação foi revertida, em virtude da elevação expressiva das coberturas vacinais, que, a partir de 1999, e por longo período, se mantiveram acima de 95%. No entanto, a partir de 2016, passamos a enfrentar uma queda significativa das coberturas vacinais, fato que explica as epidemias ocorridas entre 2018 e 2022, em boa parte do território nacional. A OMS estima que o imunizante contra o sarampo evitou 57 milhões de mortes globalmente, nos últimos 20 anos⁶.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
3. Ministério da Saúde. Sarampo. Em: Ministério da Saúde, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília; 2024 [citado 28 de abril de 2025]. p. 261–84. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao>
4. World Health Organization. Sarampo [Internet]. 2024 [citado 9 de setembro de 2025]. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles>
5. Domingues CMAS, Pereira MCCQ, Santos ED, Siqueira MM, Ganter B. A evolução do sarampo no Brasil e a situação atual. Inf Epidemiol SUS [Internet]. 1997 [citado 2025 Set 9];6(1):7-19. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-16731997000100002
6. Ministério da Saúde. Brasil recebe recertificação de país livre do sarampo [Internet]. 2024 [citado 9 de setembro de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/novembro/brasil-recebe-recertificacao-de-pais-livre-do-sarampo>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.01 – Incidência de sarampo [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18636743



Morbidade



MRB.1.02 – Incidência de rubéola

MRB.1.02 – Rubella incidence

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de rubéola, em um local e ano de referência.
- Os casos de rubéola são codificados como B06 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos de rubéola, em um local e ano de referência.
- A ocorrência de casos autóctones de rubéola aponta a persistência de fatores favoráveis à transmissão da doença, em especial a existência de grupos populacionais com cobertura vacinal insuficiente.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos novos confirmados de rubéola, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para o monitoramento, a avaliação e a orientação das ações de controle da rubéola.
- Investigar e identificar grupos populacionais mais expostos e fatores de risco para a rubéola, sendo oferecidos subsídios para a elaboração de estratégias de controle.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas ao diagnóstico, à prevenção, ao controle e à eliminação da rubéola, assim como à prevenção e ao controle da síndrome da rubéola congênita (SRC).

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de rubéola.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de rubéola, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum$) do número de casos incidentes confirmados de rubéola, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Situação vacinal:

- Vacinado;
- Não vacinado; e
- Não Informada.

Tipo do caso:

- Importado;
- Autóctone; e
- Indeterminado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Grupo Técnico Exantemática da Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis do Departamento do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGVDI/DPNI/SVSA/MS).

NOTAS

- A definição de caso confirmado de rubéola baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.
- A importância epidemiológica da rubéola está representada pela sua alta capacidade de transmissão e risco de abortos, natimortos e possibilidade de ocorrência de anomalias congênitas associadas à SRC. Medidas imediatas de investigação epidemiológica são requeridas para o controle da doença.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no período de 2014 a 2024, foram confirmados 168 casos de rubéola (Tabela 1), com distribuição temporal irregular. O ano de 2014 registrou 22 casos, seguindo-se elevação em 2015 (34 casos) e reduções subsequentes até 2018 (9 casos). Em 2019, observou-se elevação para 17 casos, mantendo-se relativamente estável em 2020 (16 casos) e 2021 (13 casos), seguida de redução acentuada em 2022 (6 casos), 2023 (6 casos) e discreta elevação em 2024 (8 casos).

A distribuição geográfica foi marcadamente heterogênea. A região Norte apresentou apenas 4 casos durante todo o período analisado, registrados principalmente no Pará (1 caso), Rondônia (1 caso) e Tocantins (2 casos). A região Nordeste concentrou a maior proporção de casos (70 casos; 41,7% do total), com destaque para Rio Grande do Norte (23 casos), Bahia (17 casos) e Pernambuco (15 casos). A região Sudeste registrou 58 casos (34,5% do total), com concentração em Minas Gerais (36 casos) e Rio de Janeiro (20 casos). A região Centro-Oeste apresentou 29 casos (17,3% do total), distribuídos principalmente em Goiás (18 casos) e Mato Grosso (10 casos). A região Sul registrou 6 casos (3,6% do total), sendo 3 no Paraná e 3 no Rio Grande do Sul.

O ano de 2015 destaca-se por apresentar o maior número de casos de rubéola, com notificações concentradas nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, sugerindo possível circulação mais ampla do vírus naquele período. Os dados evidenciam baixa incidência da doença no país, com distribuição espacial concentrada nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, indicando a necessidade de vigilância epidemiológica contínua para manutenção da eliminação da rubéola no território nacional.

Tabela 1 – Número de casos confirmados de rubéola, por ano dos primeiros sintomas. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	22	34	20	17	9	17	16	13	6	6	8	168
Norte	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	4
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Nordeste	11	14	8	6	5	5	5	7	1	4	4	70
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	1	4	2	-	1	1	2	2	-	1	3	17
Ceará	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Maranhão	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Paraíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	2	5	2	2	-	-	-	2	-	2	-	15
Piauí	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Rio Grande do Norte	3	2	1	4	3	3	3	1	1	1	1	23
Sergipe	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Sudeste	8	18	7	5	1	10	5	3	-	-	1	58
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minas Gerais	7	18	7	4	-	-	-	-	-	-	-	36
Rio de Janeiro	1	-	-	1	-	10	4	3	-	-	1	20
São Paulo	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
Sul	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	6
Paraná	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	2	2	4	5	3	1	6	2	3	-	1	29
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	2	1	4	5	1	-	3	-	2	-	-	18
Mato Grosso	-	1	-	-	2	1	3	2	1	-	-	10
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ignorado/externo	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Ministério da Saúde. Rubéola. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 4 de maio de 2025]. p. 285–304. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.02 – Incidência de rubéola [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18636781





MRB 1.03 – Incidência da síndrome da rubéola congênita

MRB.1.03 – Incidence of congenital rubella syndrome

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados clinicamente, laboratorialmente ou por vínculo epidemiológico de síndrome da rubéola congênita (SRC), em um local e ano de referência.
- Os casos da SRC são codificados como P35.0 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos confirmados de SRC, em um local e ano de referência.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos confirmados de SRC, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença.
- Contribuir para a orientação, o monitoramento e a avaliação das ações relacionadas à vacinação contra rubéola. A SRC é a principal razão para a vacinação contra a rubéola. Deste modo, a vigilância da SRC está vinculada às metas para vacinação contra rubéola, incluindo monitoramento do progresso, para se alcançar e manter a eliminação da doença no território nacional.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à manutenção da eliminação da rubéola.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos da doença.
- Devido à eliminação da circulação do vírus da rubéola no país, a partir de 2009, a síndrome apresenta uma reduzida probabilidade de suspeita diagnóstica, o que pode resultar em subnotificação de casos.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Notas:

- Na fórmula, $\sum x$ significa a soma do número de casos da SRC, em um local e ano de referência.
- São incluídos casos confirmados clinicamente, laboratorialmente ou por vínculo epidemiológico, segundo o ano de detecção dos primeiros sintomas.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum x$) do número de casos incidentes confirmados clinicamente, laboratorialmente ou por vínculo epidemiológico de SRC, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIA DE ANÁLISE**Sexo:**

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DPNI/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso confirmado de SRC baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No período de 2012 a 2024, foram notificados 24 casos confirmados de SRC no Brasil. De 2017 a 2024, observou-se notificação contínua de casos, com destaque para a região Nordeste, que concentrou 12 casos (50% do total), sendo a Bahia e o Rio Grande do Norte os estados mais afetados, com 3 e 5 casos, respectivamente. A região Sudeste registrou 6 casos no período, distribuídos entre São Paulo (3), Rio de Janeiro (2) e Minas Gerais (1). Em 2024, foram notificados 6 casos, o maior número em um único ano desde a certificação de eliminação, com ocorrências registradas nas regiões Nordeste (5) e Centro-Oeste (1) (Tabela 1).

Tabela 1 – Incidência da síndrome da rubéola congênita, segundo ano dos primeiros sintomas. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2012 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	-	-	2	3	-	2	2	2	2	2	2	1	6	24
Norte	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordeste	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	5	12
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3
Bahia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Ceará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Maranhão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	5
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudeste	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	6
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
São Paulo	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Mato Grosso	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
3. Ministério da Saúde. Síndrome da rubéola congênita. Em: Guia de vigilância em saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 4 de maio de 2025]. p. 305–24. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.03 – Incidência de síndrome da rubéola congênita [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18636807





MRB.1.04 – Incidência de difteria

MRB.1.04 – Diphtheria incidence

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de difteria, em um local e ano de referência.
- Os casos de difteria são codificados como A36 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos de difteria, em um local e ano de referência.
- A ocorrência de casos indica que há susceptíveis na população, o que pode representar a existência de grupos populacionais com cobertura vacinal insuficiente.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos incidentes de difteria, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a formulação de hipóteses de prováveis determinantes da difteria, inclusive modificações nas estratégias de vigilância da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas ao diagnóstico, à prevenção e ao controle da difteria.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de difteria.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de difteria, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum$) do número de casos incidentes confirmados de difteria, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Evolução:

- Cura;
- Óbito pelo agravo;
- Óbito por outra causa; e
- Não informada.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Grupo Técnico de Difteria, Tétano e Coqueluche da Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis do Departamento do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (GT-DTP/CGVDI/DPNI/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso confirmado de difteria baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no período de 2018 a 2024, foram notificados 21 casos confirmados de difteria (Tabela 1), com distribuição temporal caracterizada por oscilações irregulares entre 1 e 7 casos por ano. Todos os anos da série analisada tiveram pelo menos uma notificação de caso confirmado de difteria. A região Sudeste concentrou a maioria dos registros, somando 12 casos no período, o que representa 57,1% do total. Nessa região, merece destaque o estado de São Paulo, que notificou 11 casos, sendo 6 apenas no ano de 2024.

Tabela 1 – Número de casos confirmados de difteria, por ano dos primeiros sintomas. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2018 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	1	4	2	1	2	4	8	22
Norte	-	1	-	-	-	-	1	2
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-	-	-
Rondônia	-	1	-	-	-	-	1	2
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordeste	1	1	1	-	-	-	-	3
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceará	-	-	1	-	-	-	-	1
Maranhão	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	1	1	-	-	-	-	-	2
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-

Brasil, regiões e UFs	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Sudeste	-	2	-	-	1	3	7	13
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	1	1
Minas Gerais	-	1	-	-	-	-	-	1
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
São Paulo	-	1	-	-	1	3	6	11
Sul	-	-	1	-	-	1	-	2
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	1	-	-	1	-	2
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	-	-	-	1	1	-	-	2
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	1	-	-	1
Mato Grosso	-	-	-	1	-	-	-	1
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
3. Ministério da Saúde. Difteria. Em: Ministério da Saúde, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de abril de 2025]. p. 217–35. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.04 – Incidência de difteria [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi:10.5281/zenodo.18636839





MRB.1.05 – Incidência de coqueluche

MRB.1.05 – Pertussis incidence

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de coqueluche, em um local e ano de referência.
- Os casos de coqueluche são codificados como A37 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos de coqueluche, em um local e ano de referência.
- A ocorrência de casos indica que há susceptíveis na população, o que pode representar a existência de grupos populacionais com cobertura vacinal insuficiente.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos incidentes de coqueluche, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a formulação de hipóteses de prováveis determinantes da coqueluche, inclusive modificações nas estratégias de vigilância da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas ao diagnóstico, à prevenção, ao controle e à eliminação da coqueluche.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica e laboratorial, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para confirmação dos casos de coqueluche.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de coqueluche, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum$) do número de casos incidentes de coqueluche, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Evolução:

- Cura;
- Óbito pelo agravo;
- Óbito por outra causa; e
- Não informada.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DPNI/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso incidente de coqueluche baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no período de 2014 a 2024, foram confirmados 27.594 casos de coqueluche, com marcada variabilidade temporal (Tabela 1). Observam-se dois anos com elevados valores para esse indicador: o ano de 2014, com 8.622 casos (31,25% do total); e o ano de 2024, com 7.743 casos (28,06%) – incremento, nesse último ano, de 3,372% em relação a 2023. Além disso, foram observados dois anos com decréscimo importante no número de casos, a saber, o ano de 2020 (com 455 casos) e o ano de 2021 (com 159 casos), período que coincide com a pandemia de COVID-19 e as medidas de distanciamento social. As oscilações observadas no número de casos possivelmente se relacionam à ciclicidade natural da coqueluche (intervalos de 3 a 5 anos), à retomada das interações sociais pós-pandemia e à melhoria do diagnóstico laboratorial, com introdução de técnicas biomoleculares (RT-PCR) em alguns Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens), a partir de 2024.

A distribuição geográfica revela heterogeneidade regional, com predomínio das regiões Sudeste (10.205 casos, 36,98%), Sul (7.368; 26,70%) e Nordeste (6.828; 24,74%). O estado de São Paulo destaca-se com o maior número de casos confirmados de coqueluche no período de análise (5.918 casos, 21,45% do total nacional), seguido por Paraná (4.737; 17,17%) e Pernambuco (3.443; 12,48%). Esse padrão de ressurgência, após períodos de baixa incidência, reforça a importância do fortalecimento contínuo das ações de vigilância epidemiológica da coqueluche em todo o território nacional.

Tabela 1 – Número de casos confirmados de coqueluche, por ano dos primeiros sintomas. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	8.622	3.113	1.335	1.901	2.172	1.633	231	159	238	223	7.743	27.370
Norte	481	235	100	99	81	75	16	10	3	4	41	1.145
Acre	80	16	0	5	3	3	0	0	0	0	0	107
Amapá	48	5	5	7	2	0	0	1	0	0	0	68
Amazonas	68	115	63	42	17	15	4	4	1	1	26	356
Pará	104	26	4	6	32	20	5	3	0	1	6	207
Rondônia	78	27	7	6	5	4	1	0	1	2	3	134
Roraima	9	4	5	21	5	21	0	0	0	0	4	69
Tocantins	94	42	16	12	17	12	6	2	1	0	2	204

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Nordeste	2.938	967	339	395	691	785	78	71	129	83	275	6.751
Alagoas	221	34	19	14	36	24	1	3	5	2	1	360
Bahia	621	132	34	37	153	81	10	11	19	4	105	1.207
Ceará	184	68	15	20	15	41	16	0	2	2	22	385
Maranhão	160	83	12	14	26	24	2	1	1	4	5	332
Paraíba	56	17	0	9	1	5	0	1	3	0	2	94
Pernambuco	1.217	410	198	253	408	542	43	53	85	65	126	3.400
Piauí	364	151	31	30	27	32	2	0	1	0	0	638
Rio Grande do Norte	95	68	30	15	22	35	4	2	10	3	12	296
Sergipe	20	4	0	3	3	1	0	0	3	3	2	39
Sudeste	2.920	1.072	558	736	808	465	82	41	38	82	3.327	10.129
Espírito Santo	285	167	106	92	73	31	3	0	1	7	155	920
Minas Gerais	360	257	112	181	233	192	26	15	14	14	873	2.277
Rio de Janeiro	111	91	79	50	40	55	15	7	5	8	588	1.049
São Paulo	2.164	557	261	413	462	187	38	19	18	53	1.711	5.883
Sul	1.477	539	274	590	417	206	42	26	50	42	3.663	7.326
Paraná	973	294	118	150	178	104	26	9	5	17	2.837	4.711
Rio Grande do Sul	260	128	110	320	168	71	8	13	39	23	455	1.595
Santa Catarina	244	117	46	120	71	31	8	4	6	2	371	1.020
Centro-Oeste	804	296	62	81	175	101	13	11	18	12	432	2.005
Distrito Federal	243	99	31	35	75	54	5	8	7	5	263	825
Goiás	220	71	8	22	32	31	1	3	4	0	96	488
Mato Grosso	160	72	17	6	31	11	3	0	7	2	39	348
Mato Grosso do Sul	181	54	6	18	37	5	4	0	0	5	34	344
Ignorado/exterior	2	4	2	0	0	1	0	0	0	0	5	14

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>

3. Ministério da Saúde. Coqueluche. Em: Ministério da Saúde, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de abril de 2025]. p. 201–14. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.05 – Incidência de coqueluche [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18636860



Morbidade



MRB 1.06 – Incidência de tétano neonatal

Incidence of neonatal tetanus

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de tétano neonatal no período neonatal (até 28 dias após o nascimento), em um local e ano de referência.
- Os casos de tétano neonatal são codificados como A33 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos confirmados de tétano neonatal, em um local e ano de referência.
- Indica fragilidades na qualidade da atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido, que favorecem a infecção pelo *Clostridium tetani*. Essas fragilidades estão relacionadas, principalmente, à vacinação de gestantes contra o tétano e às práticas de assepsia no parto e no cuidado com o coto umbilical, sendo mais frequentes em contextos de maior vulnerabilidade socioeconômica.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos confirmados da doença, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença.
- Contribuir para a avaliação da qualidade da atenção pré-natal, ao parto e ao puerpério.
- Contribuir para a orientação, o monitoramento e a avaliação das ações relacionadas à vacinação contra o tétano.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à saúde da mulher e da criança, em especial ao aprimoramento e elevação da cobertura dos serviços de pré-natal, incluindo-se a vacinação de gestantes contra o tétano e o aprimoramento dos cuidados ao parto e ao puerpério.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de tétano neonatal.

- Casos de tétano neonatal têm baixa probabilidade de serem detectados e notificados, devido à ocorrência em situações nas quais há dificuldades no acesso a serviços de saúde, como partos no domicílio, geralmente em áreas rurais e áreas sem cobertura de saúde da família ou em outros vazios assistenciais, com falta de cuidados adequados ao recém-nascido.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de casos incidentes confirmados de tétano neonatal, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum x$) do número de casos incidentes confirmados de tétano neonatal, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DPNI/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso confirmado de tétano neonatal baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O Brasil, no ano de 2003, alcançou a meta de eliminação do tétano neonatal como um problema de saúde pública (incidência menor de 1 caso por 1.000 nascidos vivos nos municípios do país). Desde então, raros casos têm sido confirmados e notificados. No período de análise, de 2014 a 2024, foram confirmados 3 casos da doença, sendo um na região Norte, um na região Sudeste, um na região Sul e nenhum caso notificado nas regiões Nordeste Centro-Oeste (Tabela 1).

Tabela 1 – Incidência de tétano neonatal. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Norte	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordeste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maranhão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudeste	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minas Gerais	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sul	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de Vigilância em Saúde: volume 1 [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024.

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.06 – Incidência de tétano neonatal [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18636891



Morbidade



MRB.1.07 – Incidência de tétano acidental

MRB.1.07 – Accidental tetanus incidence

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes de tétano acidental, em um local e ano de referência.
- Os casos de tétano acidental são codificados como A35 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos de tétano acidental, em um local e ano de referência.
- A ocorrência de casos indica que há susceptíveis na população, o que pode representar a existência de grupos populacionais com cobertura vacinal insuficiente.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos incidentes de tétano acidental, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à prevenção e ao controle do tétano acidental.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica e laboratorial, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para confirmação de casos de tétano acidental.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes de tétano acidental, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum$) do número de casos incidentes de tétano acidental, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DPNI/SVSA/MS).

NOTAS

- A definição de caso incidente de tétano acidental baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.
- Indivíduos com esquema completo de vacinação necessitam de um reforço da vacina contra difteria e tétano a cada 10 anos.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no período de 2014 a 2024, foram confirmados 2.396 casos da doença. Observou-se redução de 266 casos, em 2014, para 172 e 173 casos, em 2020 e 2021, respectivamente, período coincidente com a pandemia de COVID-19. Nos anos subsequentes, verificou-se oscilação nos valores (com 193 casos, em 2022; 212, em 2023; e 212, em 2024), que se mantiveram, contudo, em patamares inferiores aos observados no início da série histórica.

A distribuição geográfica revela heterogeneidade regional, com predomínio das regiões Nordeste (787 casos, 32,8%), Sul (509; 21,2%) e Sudeste (525; 21,9%). As regiões Norte e Centro-Oeste apresentam menores números absolutos, com 327 (13,6%) e 247 casos (10,3%), respectivamente. Entre as Unidades da Federação (UFs), destacam-se os estados de Minas Gerais (239 casos, 10,0% do total nacional), Rio Grande do Sul (226 casos; 9,4%), Bahia (181; 7,6%), Pará (170; 7,1%), São Paulo (167; 7,0%) e Paraná (166; 6,9%). O tétano acidental é doença evitável por vacina, e sua persistência evidencia a necessidade de fortalecimento contínuo das estratégias de vigilância epidemiológica (Tabela 1).

Tabela 1 – Número de casos confirmados de tétano acidental, por ano dos primeiros sintomas. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	266	286	236	223	198	225	172	173	193	212	212	2.396
Norte	39	44	34	34	28	24	20	24	28	23	29	327
Acre	-	2	3	1	3	-	3	1	3	-	1	17
Amapá	1	3	1	2	1	-	1	4	-	2	2	17
Amazonas	8	13	8	3	3	3	5	7	8	5	4	67
Pará	25	22	21	21	12	14	8	8	15	11	13	170
Rondônia	5	4	1	7	7	6	3	3	2	2	6	46
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	2	1	-	1	-	3	3	10
Nordeste	95	88	81	62	60	85	53	52	71	77	63	787
Alagoas	9	5	7	2	4	-	5	4	2	2	4	44
Bahia	18	24	19	12	9	25	11	11	15	23	14	181
Ceará	18	17	19	13	9	13	8	11	12	16	9	145
Maranhão	12	19	12	10	17	13	11	10	16	8	13	141
Paraíba	8	2	7	4	4	8	-	1	8	8	5	55
Pernambuco	16	8	4	8	9	12	8	8	7	6	5	91
Piauí	5	5	3	4	3	6	4	6	5	2	4	47

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Rio Grande do Norte	8	6	4	3	2	4	1	-	2	5	6	41
Sergipe	1	2	6	6	3	4	5	1	4	7	3	42
Sudeste	62	67	47	54	47	49	41	30	33	42	53	525
Espírito Santo	3	3	1	2	3	5	4	1	5	5	1	33
Minas Gerais	28	29	25	26	22	22	21	17	9	14	26	239
Rio de Janeiro	13	12	6	8	7	13	4	2	6	4	11	86
São Paulo	18	23	15	18	15	9	12	10	13	19	15	167
Sul	43	55	51	54	49	48	45	44	34	46	40	509
Paraná	12	20	12	23	17	17	13	13	13	16	10	166
Rio Grande do Sul	22	23	28	20	18	17	23	20	13	20	22	226
Santa Catarina	9	12	11	11	14	14	9	11	8	10	8	117
Centro-Oeste	27	32	23	19	14	19	12	23	27	24	27	247
Distrito Federal	1	2	-	1	-	1	-	-	3	-	-	8
Goiás	10	8	11	6	1	8	6	9	12	11	6	88
Mato Grosso	10	15	10	11	10	5	5	10	9	11	16	112
Mato Grosso do Sul	6	7	2	1	3	5	1	4	3	2	5	39
Ignorado/exterior	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Ministério da Saúde. Tétano acidental. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília; 2024 [citado 25 de maio de 2025]. p. 325–36. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.07 – Incidência de tétano acidental [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi:10.5281/zenodo.18636905



Morbidade



MRB.1.08 – Incidência de febre amarela

MRB.1.08 – Incidence of yellow fever

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de febre amarela na população provável de infecção, residente em um local e ano de referência.
- Os casos de febre amarela são codificados como A95 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Avalia a carga de morbidade e a magnitude da febre amarela, numa determinada população, em um intervalo de tempo determinado.
- Estima o risco de ocorrência de casos novos de febre amarela.
- A febre amarela, em sua forma silvestre (casos atualmente diagnosticados no Brasil), está relacionada com a exposição de indivíduos suscetíveis (não imunizados) à picada de mosquitos silvestres dos gêneros *Haemagogus* e *Sabethes*, infectados pelo vírus da febre amarela. O principal hospedeiro vertebrado do vírus é o macaco, sendo acidental a participação do homem no ciclo de transmissão silvestre.
- As taxas de detecção não padronizadas por idade estão sujeitas à influência de variações na composição etária da população, o que exige cautela nas comparações entre áreas e para períodos distintos.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos confirmados de febre amarela, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas intersetoriais e ações de saúde para a prevenção, vigilância e atenção à saúde, nos locais prováveis de infecção dos casos de febre amarela.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de febre amarela.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de febre amarela em residentes, em determinado ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório do número de casos incidentes confirmados de febre amarela em um local provável de infecção, dentro do território brasileiro, em um ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância das Arboviroses do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGARB/DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A febre amarela é endêmica na região de influência do bioma amazônico no Brasil. De tempos em tempos, o vírus reemerge na região Extra-Amazônica, onde se manifesta de forma epizootica e epidêmica, com importantes impactos à saúde pública e à biodiversidade. O padrão temporal de ocorrência é sazonal, com a maior parte dos casos incidindo entre dezembro e maio. Surtos ocorrem quando o vírus encontra condições favoráveis para a transmissão, como elevadas temperaturas, alta densidade de vetores e hospedeiros primários, baixas coberturas vacinais e baixa sensibilidade para a vigilância de primatas não humanos (PNH).

No período entre 2014 e 2024, uma grande reemergência do vírus na região Extra-Amazônica foi documentada, com registros a partir de 2014 na região Centro-Oeste, com dispersão nos anos seguintes para as regiões Nordeste (Bahia), Sudeste e Sul. Outra linhagem do vírus reemergiu a partir de 2020 na região Centro-Oeste e se dispersou para a região Sudeste. Os surtos produzidos durante essas reemergências não têm precedentes na história da febre amarela silvestre no Brasil. No período, foram confirmados 2.313 casos humanos e 794 óbitos pela doença, com letalidade de 34,3% (Tabela 1).

Tabela 1 – Incidência de febre amarela. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	1	9	51	807	1.308	90	18	11	4	6	8
Norte	1	2	2	10	1	5	1	3	3	3	3
Acre	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	2	1	1	1	-	-	-	2	2
Pará	1	2	-	8	-	4	-	3	1	-	1
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Tocantins	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Nordeste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maranhão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudeste	-	-	46	793	1.307	71	-	-	1	3	5
Espírito Santo	-	-	-	255	3	-	-	-	-	-	-
Minas Gerais	-	-	43	434	520	-	-	-	-	-	2
Rio de Janeiro	-	-	-	28	279	-	-	-	-	-	-
São Paulo	-	-	3	76	505	71	-	-	1	3	3
Sul	-	-	-	-	-	14	17	8	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	2	17	8	-	-	-
Centro-Oeste	-	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso do Sul	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Notas:**
- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.
 - Todos os casos decorrem do ciclo silvestre de transmissão.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
3. Ministério da Saúde. Febre Amarela. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 5 de agosto de 2025]. p. 797-830. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.08 – Incidência de febre amarela [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18636939



Morbidade



MRB.1.09 – Incidência de raiva humana

MRB.1.09 – Human rabies incidence

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de raiva humana, em um local e ano de referência.
- Os casos de raiva humana são codificados como A82 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a magnitude de raiva humana, ou seja, a intensidade com que a doença acomete a população.
- Essa doença é decorrente da infecção pelo vírus da raiva (gênero *Lyssavirus*), sendo transmitida por animais infectados por meio de mordedura e arranhadura de pele ou lambedura de mucosas.
- Sua magnitude deve ser quantificada, porque ela é uma das doenças mais graves de que se tem conhecimento, com taxa de letalidade aproximada de 100%. Nenhuma outra doença infecciosa tem taxa de letalidade tão elevada.
- A vigilância desse indicador permite identificar deficiências das ações dirigidas à atenção aos indivíduos expostos ao risco de doença, incluindo-se oportuno tratamento profilático humano e diagnóstico de animais agressores; além disso, possibilita indicar deficiências das ações preventivas dirigidas à população animal, principalmente vacinação de cães e gatos domésticos, controle de animais de rua e controle da população de morcegos hematófagos.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais do número de casos incidentes de raiva humana, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a avaliação e orientação das ações de tratamento profilático antirrábico e de controle das fontes de infecção (observação, captura e diagnóstico de animais suspeitos, vacinação de animais domésticos e controle da população de morcegos hematófagos).
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas ao controle da raiva humana e animal.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de raiva humana.

- A ocorrência de casos em áreas remotas e de difícil acesso, particularmente na Região Amazônica, pode dificultar a detecção oportuna, a notificação e a investigação epidemiológica, assim como o acesso à profilaxia pós-exposição pelas populações vulneráveis.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes de raiva humana, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum$) do número de casos incidentes de raiva humana, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Espécie do animal agressor:

- Canina;
- Felina;
- Quiróptera (morcego);
- Primata (macaco);
- Herbívoro doméstico;
- Outros; e
- Não informada.

Situação do domicílio:

- Urbano;
- Rural;
- Periurbano; e
- Não informado.

Situação vacinal do animal agressor:

- Vacinado;
- Não vacinado; e
- Não informada.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DPNI/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso incidente de raiva humana baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no período de 2014 a 2024, foram notificados 96 casos confirmados de raiva humana, com marcada variabilidade temporal e geográfica (Tabela 1). Observa-se concentração de casos em 2018 (42 casos, 43,8% do total), ano em que o estado do Pará registrou surto da doença com 39 casos confirmados, representando a maior ocorrência, em um único ano e estado, registrada na série histórica analisada. Por essa mesma razão, a região Norte (57 casos, 59,4% do total) é a que apresenta maior número de casos de raiva humana no período de análise, seguida pelas regiões Sudeste (n=12), Nordeste (n=12) e Centro-Oeste (n=12). Destaca-se que, em 2019, não foram notificados casos de raiva humana no território nacional. Nos demais anos da série, o número de casos anuais da doença variou entre 3 e 15.

Tabela 1 – Número de casos confirmados de raiva humana, por ano dos primeiros sintomas. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	3	9	3	15	42	-	6	3	6	3	6	96
Norte	-	-	3	12	39	-	-	-	-	-	3	57
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Amazonas	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Pará	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	39
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tocantins	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	6
Nordeste	-	-	-	-	-	-	3	3	-	3	3	12
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Maranhão	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
Paraíba	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudeste	3	3	-	-	-	-	3	-	3	-	-	12
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
São Paulo	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Sul	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Paraná	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Rio Grande do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	-	6	-	3	-	-	-	-	3	-	-	12
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Goiás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Mato Grosso do Sul	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
3. Ministério da Saúde. Raiva. Em: Ministério da Saúde, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de abril de 2025]. p. 1091–122. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-3-6a-edicao/view>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.09 – Incidência de raiva humana [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18636956





MRB.1.10 – Incidência de cólera

MRB.1.10 – Cholera incidence

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de cólera, em um local e ano de referência.
- Os casos de cólera são codificados como A00 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos de cólera, em um local e ano de referência.
- Devem ser levados em conta a residência e o local de infecção dos casos, ou seja, deve-se investigar se são casos autóctones ou importados, pois indicam situações epidemiológicas distintas.
- Considerando-se que o Brasil não é área endêmica de cólera, a ocorrência de um único caso autóctone pode ser considerada um surto epidêmico.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos incidentes de cólera, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Subsidiar o desenvolvimento de processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e intervenções de saúde pública, com foco na prevenção e controle da cólera e de outras doenças infecciosas de transmissão hídrica ou por alimentos, especialmente doenças diarreicas agudas.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de cólera.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes de cólera, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum$) do número de casos incidentes de cólera, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Tipo do caso:

- Importado;
- Autóctone; e
- Indeterminado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso incidente de cólera baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no período de 2014 a 2024, foram confirmados 3 casos novos de cólera: 1 no Rio Grande do Sul, em 2016, importado de Moçambique; 1 no Rio Grande do Norte, em 2018, importado da Índia; e 1 na Bahia, em 2024, autóctone de Salvador⁴. Esse último caso foi detectado por vigilância ativa laboratorial e, após investigação epidemiológica, não foi constatada evidência de transmissão

secundária, tendo sido o primeiro caso registrado no Brasil após 18 anos sem notificação de casos autóctones da doença. Os últimos casos autóctones anteriores registrados haviam ocorrido em Pernambuco, nos anos de 2004 e 2005. Considerando-se que o Brasil não constitui área endêmica de cólera, este caso isolado ocorre em contexto global, no qual 31 países registraram casos ou declararam surtos da doença em 2024⁵. Esses achados reforçam a necessidade de manutenção da vigilância epidemiológica sensível, da prontidão para resposta rápida e do fortalecimento das ações de prevenção e controle, conforme preconizado pelo *Guia de Vigilância em Saúde* (Tabela 1).

Tabela 1 – Número de casos confirmados de cólera, por ano dos primeiros sintomas. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3
Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordeste	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ceará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maranhão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paraíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudeste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espírito Santo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio de Janeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sul	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Paraná	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Rio Grande do Sul	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Santa Catarina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Goiás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mato Grosso do Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Ministério da Saúde. Cólera. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília; 2024 [citado 25 de maio de 2025]. p. 375–88. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao>
- Agência Brasil. Brasil confirma caso autóctone de cólera em Salvador. Agência Brasil [Internet]. EBC. 2024 [citado 29 de setembro de 2025]. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-04/brasil-confirma-caso-autoctone-de-colera-em-salvador>
- World Health Organization. Multi-country outbreak of cholera, External situation report #12 – [Internet]. WHO. 2024 [citado 29 de setembro de 2025]. Disponível em: <https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-cholera--external-situation-report--12---14-march-2024>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.10 – Incidência de cólera [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi:10.5281/zenodo.18636983





MRB 1.11 – Incidência de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika

MRB.1.11 – Incidence of congenital syndrome associated with Zika virus infection

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika (SCZ), em um local e ano de referência.
- Os casos da SCZ são codificados como P35.4 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos confirmados de SCZ, em um local e ano de referência.
- A ocorrência de casos indica a circulação do vírus Zika no país e deficiências na atenção à saúde da mulher no período pré-natal, quando as ações de prevenção da ocorrência da infecção gestacional pelo vírus Zika devem ser oportunamente realizadas.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos confirmados de SCZ, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à assistência, diagnóstico e acompanhamento clínico dos casos de SCZ.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos da doença.
- Devido à baixa circulação do vírus Zika no país, a partir de 2018, a síndrome apresenta uma reduzida probabilidade de suspeita diagnóstica, o que pode resultar em subnotificação de casos.

FONTE DE DADOS

- Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP-Microcefalia)².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de casos incidentes confirmados de SCZ, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum x$) do número de casos incidentes confirmados de SCZ, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIA DE ANÁLISE

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAET/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso confirmado da SCZ baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Para monitorar a ocorrência de casos de SCZ no Brasil e qualificar a atenção às crianças acometidas, foi estabelecida, em 2015, a vigilância epidemiológica dessa condição. Desde então, até 2025, foram notificados 1.874 casos de SCZ no país, com ocorrências em todas as Unidades da Federação (UFs) e concentração na região Nordeste (N=1.407) (Tabela 1). A maioria dos casos (N = 1.781) ocorreu de 2015 a 2017, durante o período de vigência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), com pico em 2015 (N=1.038). Após o período da ESPIN, houve redução considerável de casos de SCZ. Em 2025, foi notificado 1 caso no Brasil, no estado da Bahia.

Tabela 1 – Incidência de casos de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, segundo ano da notificação. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2015 a 2025

Brasil, regiões e UFs	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Brasil	1.038	691	52	45	19	12	4	3	7	2	1	1.874
Norte	11	37	7	3	1	2	1	-	1	1	-	64
Acre	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Amapá	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Amazonas	-	13	3	3	1	2	1	-	1	1	-	25
Pará	5	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
Rondônia	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Roraima	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tocantins	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Nordeste	916	433	14	25	10	4	1	1	1	1	1	1.407
Alagoas	12	30	4	6	1	-	-	-	-	-	-	53
Bahia	168	119	-	-	1	1	-	-	1	1	1	292
Ceará	47	52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Maranhão	31	31	1	1	1	-	-	-	-	-	-	65
Paraíba	106	56	1	8	3	-	1	-	-	-	-	175
Pernambuco	355	102	7	4	3	-	-	-	-	-	-	471
Piauí	50	12	-	6	1	3	-	-	-	-	-	72
Rio Grande do Norte	52	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	64
Sergipe	95	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
Sudeste	80	127	11	7	4	4	1	-	2	-	-	236
Espírito Santo	1	26	5	2	1	1	1	-	1	-	-	38
Minas Gerais	4	13	4	1	1	2	-	-	1	-	-	26
Rio de Janeiro	45	74	1	2	-	1	-	-	-	-	-	123
São Paulo	30	14	1	2	2	-	-	-	-	-	-	49
Sul	4	3	1	3	1	-	-	1	1	-	-	14
Paraná	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
Rio Grande do Sul	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	8
Santa Catarina	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
Centro-Oeste	27	91	19	7	3	2	1	1	2	-	-	153
Distrito Federal	2	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	11
Goiás	8	63	15	6	2	2	-	1	2	-	-	99
Mato Grosso	16	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	38
Mato Grosso do Sul	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5

Nota:

- Dados originados do Registro de Eventos em Saúde Pública – RESP-Microcefalia² (a partir de 2015).

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Painel do Registro de Eventos em Saúde Pública – RESP (Microcefalia). Disponível em: <http://www.resp.saude.gov.br/microcefalia#/painel>. Acesso em: 20 jan. 2026.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de Vigilância em Saúde: volume 2 [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024.

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.11 – Incidência de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi:10.5281/zenodo.18637002





MRB.1.12 – Incidência de Zika em gestante

MRB.1.12 – Zika incidence in pregnant women

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos confirmados de Zika em gestante, em um local e ano de referência. Inclui casos de Zika em gestante, notificados conforme o Código U06 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a ocorrência de casos novos confirmados de Zika em um grupo populacional específico, o de mulheres gestantes.
- A ocorrência de casos deve ser monitorada, pois a infecção por Zika durante a gravidez pode levar a uma série de complicações graves para o feto, incluídas no espectro da síndrome congênita do Zika vírus (SCZV).

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição dos casos confirmados de Zika em gestantes, como parte do conjunto de ações de vigilância em saúde epidemiológica da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas interdisciplinares e ações de saúde direcionadas para a promoção, prevenção e tratamento da Zika e de outras doenças transmitidas pelo *Aedes aegypti*.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância em saúde epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de Zika.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos confirmados de Zika em gestante residente em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum$) do número de casos confirmados de Zika em gestante, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Trimestre gestacional no momento da infecção:

- 1º trimestre;
- 2º trimestre; e
- 3º trimestre.

Semana epidemiológica:

- Semanas epidemiológicas (SEs) 1 a 52.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância das Arboviroses do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGARB/DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Entre 2015 e 2016, o Brasil enfrentou uma grande epidemia de Zika. Em 2015, foram notificados 215 casos de Zika em gestantes; em 2016, foram 12.044 casos. A partir de 2017, o número de casos declinou, refletindo os esforços de controle e prevenção.

A região Nordeste teve os maiores números em 2016, com 9.329 casos, com destaque para Alagoas (850), Bahia (642) e Pernambuco (459). Na região Centro-Oeste, houve 1.981 casos em 2016, com destaque para Mato Grosso (1.163) e Goiás (515).

Na região Norte, o número aumentou de 1 caso, em 2015, para 1.493, em 2016, com o Amazonas (928) liderando os casos. A região Sudeste registrou 726 casos em 2016, com destaque para Rio de Janeiro (4.442 casos considerando todo o período). A região Sul teve poucos registros, com apenas 47 casos em 2016, sendo o Paraná o estado mais afetado.

Um dos maiores riscos de Zika em gestantes é a possibilidade de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o bebê durante a gestação. Isso pode causar síndromes congênitas graves, como a SCZV, que inclui microcefalia, alterações neurológicas e problemas no desenvolvimento da criança. Esse impacto tornou a epidemia ainda mais preocupante, principalmente entre 2015 e 2016.

A partir de 2017, os casos diminuíram em todo o país. Em 2024, foram registrados 83 casos, o que mostra que as ações de controle foram efetivas. Mesmo assim, é essencial manter a vigilância ativa, tendo em vista a magnitude da doença em gestantes (Tabela 1).

Tabela 1 – Incidência de Zika em gestante*. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	6	215	12.044	1.062	479	555	236	181	188	149	83
Norte	-	1	1.493	112	64	288	44	14	17	14	11
Acre	-	-	12	1	4	1	2	1	-	3	1
Amapá	-	-	18	1	1	2	5	-	-	-	-
Amazonas	-	-	928	16	23	9	5	2	-	-	-
Pará	-	-	324	72	31	263	32	9	4	1	6
Rondônia	-	1	125	20	1	-	8	5	-	-	-
Roraima	-	-	1	5	-	2	-	-	-	-	-
Tocantins	-	-	156	16	5	5	1	1	13	9	2
Nordeste	1	-	9.329	512	166	165	84	62	115	64	29
Alagoas	-	-	85	15	9	4	10	12	15	39	7
Bahia	-	-	642	26	1	2	513	22	28	11	8
Ceará	-	-	112	14	5	6	11	11	5	-	6
Maranhão	-	-	1	11	6	-	-	-	1	1	-
Paraíba	1	-	62	54	25	5	7	41	19	1	-
Pernambuco	-	1	459	2	11	17	6	11	2	-	-
Piauí	-	-	5	8	4	4	-	2	5	-	-

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rio Grande do Norte	-	-	17	6	8	12	7	31	42	8	14
Sergipe	-	1	15	1	-	2	6	2	5	10	-
Sudeste	-	165	726	145	34	3	84	31	16	21	8
Espírito Santo	-	1	167	61	14	9	67	-	-	18	5
Minas Gerais	1	4	235	50	24	44	13	5	4	2	1
Rio de Janeiro	-	157	4.442	173	179	206	155	6	2	-	-
São Paulo	-	6	796	18	4	9	1	2	-	1	-
Sul	-	-	47	2	2	1	9	5	2	-	1
Paraná	-	-	41	2	1	1	9	2	-	-	-
Rio Grande do Sul	-	-	4	-	1	-	4	3	2	-	-
Santa Catarina	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste	1	49	1.981	293	215	72	22	31	14	12	22
Distrito Federal	-	4	26	5	1	6	1	-	-	-	-
Goiás	-	4	515	112	12	5	2	4	2	5	4
Mato Grosso	1	38	1.163	114	44	14	285	8	9	14	22
Mato Grosso do Sul	-	3	265	49	15	2	-	2	1	1	-

Notas:

- *Casos confirmados de Zika em gestante.
- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
3. Ministério da Saúde. Dengue, chikungunya e Zika. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 5 de agosto de 2025]. p. 727–82. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.12 – Incidência de Zika em gestante [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637016



Morbidade



MRB.1.13 – Incidência de doença meningocócica

MRB.1.13 – Meningococcal disease incidence

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de doença meningocócica, em um local e ano de referência.
- Os casos de doença meningocócica são codificados como A39.0 e A39.2 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos confirmados de doença meningocócica, em um local e ano de referência.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos incidentes confirmados da doença meningocócica, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a identificação de situações suspeitas de surtos epidêmicos.
- Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para a assistência, a prevenção e o controle da doença meningocócica.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais da rede assistencial para identificar e notificar, e do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos suspeitos de doença meningocócica.
- Deficiências laboratoriais para identificação da etiologia da meningite sob investigação podem acarretar maior número de doenças classificadas como “meningites não especificadas” ou “meningite bacteriana não especificada”.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de doença meningocócica, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum$) do número de casos incidentes confirmados de doença meningocócica, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Forma clínica:

- Meningococemia;
- Meningite meningocócica; e
- Meningite meningocócica com meningococemia.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DPNI/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no período de 2014 a 2024, foram notificados 10.114 casos novos confirmados de doença meningocócica (Tabela 1). A análise evidencia declínio importante desse indicador, de 1.613 casos novos notificados em 2014, para 254 casos em 2021, consistente com incrementos da cobertura da vacina meningocócica C conjugada, implementada desde novembro de 2010, e do distanciamento social ocorrido durante a epidemia de COVID-19, nos anos de 2020 e 2021. A partir de 2022, há retomada gradual da incidência da doença no Brasil, com 515 casos novos em 2022, 755 em 2023 e 846 em 2024.

A região Sudeste concentrou a maioria de casos novos confirmados de doença meningocócica (58,6%; 5.924) no período de análise, destacando-se o estado de São Paulo, com 4.060 casos (40,1% do total nacional). Seguem, em número de casos, as regiões Sul (1.593), Nordeste (1.403), Norte (705) e Centro-Oeste (482). O estado do Pará apresentou aumento expressivo no ano de 2024, com 99 casos novos notificados, um incremento de 312,5% em comparação aos 24 casos notificados em 2023. A persistência de casos novos da doença e a ocorrência de surtos reforçam a importância da manutenção de coberturas vacinais elevadas e vigilância epidemiológica sensível aos casos incidentes da doença meningocócica no Brasil.

Tabela 1 – Número de casos confirmados de doença meningocócica, por ano dos primeiros sintomas. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	1.613	1.307	1.119	1.138	1.133	1.064	370	254	515	755	846	10.114
Norte	85	83	67	68	88	75	26	24	24	44	121	705
Acre	3	1	1	7	2	3	1	2	2	1	1	24
Amapá	2	2	1	2	2	2	-	-	-	-	1	12
Amazonas	40	32	20	17	10	8	7	12	6	15	13	180
Pará	28	42	40	35	63	53	15	6	13	24	99	418
Rondônia	7	2	4	3	8	3	1	2	-	1	2	33
Roraima	3	3	1	2	1	1	-	-	2	-	2	15
Tocantins	2	1	-	2	2	5	2	2	1	3	3	23
Nordeste	202	166	159	133	153	184	72	32	58	120	124	1.403
Alagoas	22	16	19	11	12	12	4	5	10	36	22	169
Bahia	66	53	38	34	31	42	9	3	14	29	47	366

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Ceará	26	23	20	37	29	53	23	10	4	7	6	238
Maranhão	7	10	7	9	30	25	5	3	6	8	6	116
Paraíba	4	3	6	1	5	1	1	1	2	3	8	35
Pernambuco	48	29	42	17	35	39	24	8	13	24	17	296
Piauí	6	7	14	11	3	6	3	1	2	6	5	64
Rio Grande do Norte	18	19	9	10	3	4	2	-	2	4	12	83
Sergipe	5	6	4	3	5	2	1	1	5	3	1	36
Sudeste	1.079	790	649	635	600	563	223	148	320	457	460	5.924
Espírito Santo	23	13	8	10	13	8	6	4	21	28	22	156
Minas Gerais	92	74	66	70	73	74	28	16	57	41	51	642
Rio de Janeiro	230	149	145	114	99	90	33	30	43	66	67	1.066
São Paulo	734	554	430	441	415	391	156	98	199	322	320	4.060
Sul	174	200	188	221	230	188	31	38	96	109	118	1.593
Paraná	58	63	55	56	57	67	9	5	34	34	37	475
Rio Grande do Sul	82	106	94	104	84	68	15	19	36	45	53	706
Santa Catarina	34	31	39	61	89	53	7	14	26	30	28	412
Centro-Oeste	73	67	55	81	61	54	17	12	16	25	21	482
Distrito Federal	15	9	14	23	23	23	2	1	4	3	5	122
Goiás	30	28	19	39	24	18	8	6	7	14	9	202
Mato Grosso	19	17	12	14	10	6	3	4	4	7	2	98
Mato Grosso do Sul	9	13	10	5	4	7	4	1	1	1	5	60
Ignorado/externor	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	2	7

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Ministério da Saúde. Doença meningocócica. Em: Ministério da Saúde, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de abril de 2025]. p. 107–22. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.13 – Incidência de doença meningocócica [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637041





MRB.1.14 – Incidência de meningite não meningocócica

MRB.1.14 – Non-meningococcal meningitis incidence

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de meningites bacterianas (exceto a meningite meningocócica) e outras meningites causadas por vírus, fungos e outros agentes, em um local e ano de referência.
- Os casos de meningite não meningocócica são codificados como G00, G01, G02, G03 e A87 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos de meningite não meningocócica, em um local e ano de referência.
- As meningites bacterianas e as causadas por vírus são as mais frequentes e importantes em saúde pública, devido à sua magnitude e ao potencial de produzir surtos.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos incidentes confirmados de meningite não meningocócica, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para identificar situações suspeitas de surtos epidêmicos.
- Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para a assistência, a prevenção e o controle das meningites.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais da rede assistencial para identificar e notificar, e do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos, para a confirmação diagnóstica e etiológica dos casos de meningites.
- Deficiências laboratoriais para identificar a etiologia da meningite sob investigação podem acarretar maior número de doenças classificadas como “meningites não especificadas” ou “meningite bacteriana não especificada”.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de meningite não meningocócica, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum$) do número de casos incidentes confirmados de meningite não meningocócica, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE**Cor ou raça:**

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Etiologia:

- Meningite tuberculosa;
- Meningite por outras bactérias;
- Meningite não especificada;
- Meningite asséptica (viral);
- Meningites por outras etiologias;
- Meningites por hemófilos; e
- Meningite por pneumococos.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento do Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DPNI/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no período 2014 a 2024, foram notificados 148.109 casos confirmados de meningites não meningocócicas, abrangendo meningites bacterianas (exceto meningocócica), virais, fúngicas e de outras etiologias. O período de 2014 a 2019 apresentou relativa estabilidade no número de casos da doença, variando entre 14,5 mil e 16,4 mil casos por ano. Porém, quedas acentuadas foram observadas nos anos de 2020 e 2021, com a notificação de 6.758 e 6.689 casos, respectivamente, coincidente com o período da pandemia de COVID-19. Após esse período, nota-se recuperação gradual, com 12.264 casos, em 2022, alcançando 15.920, em 2023, e 13.257 em 2024. A região Sudeste concentra 53,4% dos casos notificados no período, no Brasil (79.064), com o estado de São Paulo respondendo por 39,7% (58.745) de todos os casos. Seguem as regiões Sul (32.888 casos; 22,2%), Nordeste (22.472; 15,2%), Norte (7.085; 4,8%) e Centro-Oeste (6.492; 4,4%). O estado do Paraná é o segundo em número de casos confirmados e notificados de meningite não meningocócica (14.746), seguido por Rio Grande do Sul (10.203), Rio de Janeiro (9.330) e Minas Gerais (9.179) (Tabela 1).

Tabela 1 – Número de casos confirmados de meningite não meningocócica*, por ano dos primeiros sintomas. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	16.074	14.765	14.517	15.851	16.421	15.593	6.758	6.689	12.264	15.920	13.257	148.109
Norte	658	774	734	824	758	684	405	401	563	623	661	7.085
Acre	12	12	13	20	28	23	7	16	16	13	16	176
Amapá	12	11	4	10	14	10	3	9	6	8	10	97
Amazonas	154	156	150	191	147	150	92	106	120	127	110	1.503
Pará	338	445	418	471	448	387	216	190	304	327	334	3.878
Rondônia	52	75	54	64	55	36	30	40	51	75	116	648
Roraima	14	21	20	20	7	22	19	26	36	46	40	271
Tocantins	76	54	75	48	59	56	38	14	30	27	35	512

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Nordeste	2.659	2.391	1.953	2.202	2.143	2.352	1.076	1.031	1.998	2.439	2.228	22.472
Alagoas	109	93	66	75	111	111	43	44	54	85	70	861
Bahia	728	640	494	477	426	432	174	177	450	453	450	4.901
Ceará	318	244	260	347	396	475	227	204	322	476	332	3.601
Maranhão	128	134	132	144	118	113	60	97	129	156	149	1.360
Paraíba	68	48	34	54	36	39	31	24	71	90	100	595
Pernambuco	954	871	729	838	767	868	397	308	633	785	754	7.904
Piauí	215	188	146	134	157	149	54	72	121	150	122	1.508
Rio Grande do Norte	108	147	68	98	112	127	67	84	182	210	208	1.411
Sergipe	31	26	24	35	20	38	23	21	36	34	43	331
Sudeste	8.902	7.427	8.167	8.311	9.445	8.308	3.289	3.162	6.719	8.552	6.782	79.064
Espírito Santo	156	155	151	283	136	150	60	80	228	204	207	1.810
Minas Gerais	980	934	854	1.034	960	929	462	436	713	916	961	9.179
Rio de Janeiro	967	840	895	1.016	978	932	350	444	842	985	1.081	9.330
São Paulo	6.799	5.498	6.267	5.978	7.371	6.297	2.417	2.202	4.936	6.447	4.533	58.745
Sul	3.120	3.415	2.927	3.844	3.503	3.613	1.638	1.736	2.453	3.708	2.931	32.888
Paraná	1.294	1.475	1.232	1.630	1.618	1.764	792	887	1.140	1.568	1.346	14.746
Rio Grande do Sul	1.074	1.180	1.024	1.261	1.092	924	467	482	762	1.112	825	10.203
Santa Catarina	752	760	671	953	793	925	379	367	551	1.028	760	7.939
Centro-Oeste	729	747	723	655	562	620	348	355	519	590	644	6.492
Distrito Federal	101	121	97	95	80	128	62	82	87	106	92	1.051
Goiás	302	306	264	194	202	213	137	126	204	234	308	2.490
Mato Grosso	201	152	150	174	149	143	61	51	97	123	112	1.413
Mato Grosso do Sul	125	168	212	192	131	136	88	96	131	127	132	1.538
Ignorado/exterior	6	11	13	15	10	16	2	4	12	8	11	108

Notas:

- *Refere-se às meningites bacterianas (exceto a meningite meningocócica) e a outras meningites causadas por vírus, fungos e outros agentes (códigos G00, G01, G02, G03, A87 da CID-10).
- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>

3. Ministério da Saúde. Outras meningites. Em: Ministério da Saúde, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de abril de 2025]. p. 123–57. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.14 – Incidência de meningite não meningocócica [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637062



Morbidade



MRB.1.15 – Incidência de leptospirose

MRB.1.15 – Leptospirosis incidence

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de leptospirose, em um local e ano de referência.
- Os casos de leptospirose são codificados como A27 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos de leptospirose, em um local e ano de referência.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos incidentes de leptospirose, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas ao diagnóstico, prevenção e controle da leptospirose.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica da doença.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de leptospirose, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório (Σ) do número de casos incidentes confirmados de leptospirose, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Situação do domicílio:

- Urbano;
- Rural;
- Periurbano; e
- Não informado.

Ambiente de infecção:

- Domicílio;
- Trabalho;
- Lazer;
- Outros; e
- Não informado.

Área provável de infecção:

- Urbana;
- Rural;
- Periurbana; e
- Não informada.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso suspeito e de caso confirmado de leptospirose baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no período de 2014 a 2024, foram notificados 36.352 casos confirmados de leptospirose. A série temporal evidencia declínio, partindo de 4.676 casos da doença, em 2014, para 3.001 casos em 2017. O ano de 2019 se apresenta de forma relativamente atípica nessa série histórica, com 3.713 casos confirmados de leptospirose. Os anos seguintes, 2020 (n=1.853) e 2021 (n=1.806), indicam queda importante do indicador, coincidente com as medidas de restrição da pandemia de COVID-19. A partir de 2021, aumento expressivo de casos confirmados de leptospirose pode ser notado: 3.256 casos, em 2022; 3.430, em 2023; e 4.143 casos em 2024. As regiões Sul (12.472 casos; 34,31%) e Sudeste (10.725; 29,5%) concentram 63,8% de todos os casos da série analisada, seguidas pelas regiões Norte (6.626; 18,2%), Nordeste (5.812; 16,0%) e Centro-Oeste (699; 1,9%). O estado de São Paulo destaca-se, com 5.761 casos notificados (15,8% do total), seguido por Rio Grande do Sul (5.553; 15,3%), Paraná (3.737; 10,3%), Acre (3.554; 9,8%) e Santa Catarina (3.182; 8,8%). O estado do Acre destaca-se na região Norte, sendo responsável pela notificação de 53,6% dos casos regionais (n=3.554 casos), no período de análise (Tabela 1).

Tabela 1 – Número de casos confirmados de leptospirose, por ano dos primeiros sintomas. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	4.676	4.340	3.066	3.001	3.068	3.713	1.853	1.806	3.256	3.430	4.143	36.352
Norte	1.707	1.295	485	509	490	513	286	287	317	363	374	6.626
Acre	1.196	947	184	221	161	214	142	133	88	164	104	3.554
Amapá	72	47	79	59	76	59	20	38	34	22	43	549
Amazonas	99	82	52	75	63	53	31	40	49	38	51	633
Pará	146	134	128	129	148	150	71	58	111	94	131	1.300
Rondônia	187	83	39	20	28	25	19	12	18	26	29	486
Roraima	4	1	0	2	2	3	1	4	6	2	3	28
Tocantins	3	1	3	3	12	9	2	2	11	17	13	76
Nordeste	564	422	327	471	469	639	281	330	999	658	652	5.812
Alagoas	69	34	16	72	53	58	31	28	86	56	39	542

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Bahia	117	126	54	78	72	99	62	66	138	130	149	1.091
Ceará	50	29	49	28	51	114	45	44	105	92	94	701
Maranhão	33	19	16	22	29	37	12	16	32	43	55	314
Paraíba	16	11	9	11	18	21	19	8	21	30	30	194
Pernambuco	222	140	160	221	211	254	79	140	562	235	220	2.444
Piauí	1	2	1	0	1	16	9	2	5	13	8	58
Rio Grande do Norte	14	21	4	4	13	12	9	11	10	20	27	145
Sergipe	42	40	18	35	21	28	15	15	40	39	30	323
Sudeste	1.266	960	980	911	1.016	1.093	679	602	1.072	1.110	1.036	10.725
Espírito Santo	232	76	58	66	71	99	5	38	52	63	84	844
Minas Gerais	124	116	161	134	181	190	216	160	169	207	161	1.819
Rio de Janeiro	154	136	169	166	239	224	116	104	350	309	334	2.301
São Paulo	756	632	592	545	525	580	342	300	501	531	457	5.761
Sul	1.077	1.586	1.199	1.054	1.025	1.389	551	547	812	1.237	1.995	12.472
Paraná	247	510	418	257	324	407	175	202	317	447	433	3.737
Rio Grande do Sul	481	523	409	493	448	698	224	196	292	481	1.308	5.553
Santa Catarina	349	553	372	304	253	284	152	149	203	309	254	3.182
Centro-Oeste	62	77	74	55	66	77	56	40	52	59	81	699
Distrito Federal	18	27	28	8	18	21	17	7	16	13	24	197
Goiás	22	27	30	26	21	14	15	23	20	25	26	249
Mato Grosso	4	10	7	12	19	31	15	7	12	10	20	147
Mato Grosso do Sul	18	13	9	9	8	11	9	3	4	11	11	106
Ignorado/externor	0	0	1	1	2	2	0	0	4	3	5	18

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Ministério da Saúde. Leptospirose. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília; 2024 [citado 25 de maio de 2025]. p. 1053–176. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-3-6a-edicao/view>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.15 – Incidência de leptospirose [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637077



Morbidade



MRB.1.16 – Incidência de febre maculosa

MRB.1.16 – Spotted fever incidence

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de febre maculosa, em um local e ano de referência.
- Os casos de febre maculosa são codificados como A77 – rickettsioses transmitidas por carrapatos, A77.0 – febre maculosa brasileira e A77.9 – febre maculosa não especificada, na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos confirmados de febre maculosa, em um local e ano de referência.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos confirmados de febre maculosa, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a avaliação e orientação das ações de prevenção e tratamento de indivíduos infectados.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à prevenção, ao diagnóstico e ao controle da febre maculosa.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de febre maculosa.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de febre maculosa, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum$) do número de casos incidentes confirmados de febre maculosa, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Ambiente de infecção:

- Domicílio;
- Trabalho;
- Lazer;
- Outro; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Grupo Técnico de Doenças Relacionadas a Roedores e Entomologia, Coordenação-Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGZV/DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso confirmado de febre maculosa baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, de 2014 a 2024, a incidência de febre maculosa apresentou crescimento, de 183 para 418 casos notificados, respectivamente, um aumento de 128,4% no período (Tabela 1). Em 2024, a região Sudeste concentrou o maior número absoluto de casos notificados de febre maculosa (284), seguida pela região Sul (100). O Nordeste (15 casos), o Centro-Oeste (14) e o Norte (5) notificaram apenas casos esporádicos de febre maculosa.

Entre as Unidades da Federação (UFs), merece destaque o estado de São Paulo – onde foi notificado o maior número de casos –, tendo sido superado por Minas Gerais em apenas três anos da série histórica analisada. No ano de 2024, esses dois estados notificaram 68 e 116 casos novos de febre maculosa, respectivamente. Na região Sul, o estado de Santa Catarina merece destaque, por ter apresentado crescimento expressivo, de 51 casos notificados de febre maculosa, no ano de 2014, para 71 casos em 2024.

Nas UFs das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, na maioria dos anos, não houve notificação de casos, à exceção do estado do Ceará, no Nordeste, onde foram notificados casos de febre maculosa, continuamente, em todos os anos da série histórica analisada.

Tabela 1 – Incidência de febre maculosa. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024*

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Brasil	183	186	153	182	256	287	178	238	218	363	418	2.662
Norte	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	5	12
Acre	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Amapá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pará	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4
Rondônia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roraima	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5
Tocantins	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Nordeste	5	5	4	3	3	2	3	12	16	15	15	83
Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Bahia	-	-	1	-	1	-	-	4	3	5	3	17
Ceará	5	5	3	3	2	2	3	7	7	9	10	56
Maranhão	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Paraíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernambuco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Piauí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rio Grande do Norte	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Sergipe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Sudeste	122	146	112	136	199	207	112	168	147	272	284	1.905
Espírito Santo	4	9	7	4	1	6	1	6	25	36	54	153
Minas Gerais	13	19	23	44	76	90	24	56	30	82	116	573
Rio de Janeiro	21	13	14	18	11	35	11	21	32	18	46	240
São Paulo	84	105	68	70	111	76	76	85	60	136	68	939
Sul	55	29	30	41	52	70	58	54	51	74	100	614
Paraná	3	6	3	10	6	19	10	1	8	11	24	101
Rio Grande do Sul	1	-	-	3	1	2	-	-	2	4	5	18
Santa Catarina	51	23	27	28	45	49	48	53	41	59	71	495
Centro-Oeste	1	6	7	2	2	7	4	2	2	1	14	48
Distrito Federal	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Goiás	-	2	2	2	1	4	3	-	1	-	10	25
Mato Grosso	1	1	2	-	-	1	1	2	1	1	3	13
Mato Grosso do Sul	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	1	8

Notas:

- *Ano dos primeiros sintomas.
- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
3. Ministério da Saúde. Febre maculosa brasileira e outras rickettsioses. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília; 2024 [citado 25 de maio de 2025]. p. 1019–38. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-3-6a-edicao/view>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.16 – Incidência de febre maculosa [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi:10.5281/zenodo.18637087



Morbidade



MRB.1.17 – Incidência de esquistossomose mansoni não grave

MRB.1.17 – Incidence of non-severe Schistosomiasis mansoni

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados não graves de esquistossomose, em um local e ano de referência.
- Os casos de esquistossomose não grave são codificados como B65 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹, e não incluem as formas clínicas hepatointestinal e hepatoesplênica.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica dos casos confirmados de esquistossomose não grave, em um local e ano de referência.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos confirmados, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença.
- Contribuir para o debate sobre ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de indivíduos com esquistossomose não grave.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à prevenção, ao diagnóstico e ao controle da esquistossomose.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos da doença.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de x número de casos incidentes não graves de esquistossomose, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum x$) do número de casos incidentes não graves de esquistossomose, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral da Hanseníase e Doenças em Eliminação do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGHDE/DEDT/SVSA/MS).

NOTAS

- A definição de caso não grave confirmado de esquistossomose baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país³.
- Considera-se, portanto, caso não grave, todo indivíduo que apresente ovos de *S. mansoni* em amostras de fezes, tecidos ou outros materiais orgânicos ou formas agudas de esquistossomose, exceto as formas clínicas hepatointestinal e hepatoesplênica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A esquistossomose mansoni não grave apresenta distribuição geográfica heterogênea no Brasil, com maior intensidade nas Unidades da Federação (UFs) que concentram áreas de transmissão endêmica, especialmente na região Nordeste (Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão e Sergipe) e na região Sudeste (com destaque para Minas Gerais e Espírito Santo). Áreas de transmissão focal também são observadas em UFs das regiões Norte, Sul e Centro-Oeste, incluindo Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal.

Entre 2014 e 2023, o Brasil notificou 24.066 casos de esquistossomose, com importante redução no período, de 3.658 casos, em 2014, para 1.464 em 2023 (queda de 60,0%). O menor número foi registrado em 2020 (1.057 casos). A região Sudeste concentrou 77,3% dos casos (18.611), com destaque para Minas Gerais (13.930). O Nordeste registrou 4.611 casos, principalmente na Bahia e em Pernambuco. Em 2023, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Pernambuco lideraram as notificações, mantendo a concentração histórica no Sudeste e no Nordeste (Tabela 1).

Tabela 1 – Incidência de esquistossomose mansoni não grave. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2023

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Brasil	3.658	3.878	3.535	2.837	2.794	2.196	1.057	1.290	1.357	1.464	24.066
Norte	46	34	30	49	33	24	14	18	38	10	296
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Amapá	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Amazonas	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	5
Pará	23	9	5	10	5	12	4	7	14	4	93
Rondônia	20	22	25	38	27	12	10	7	21	5	187
Roraima	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Tocantins	3	-	-	-	-	-	-	2	1	1	7
Nordeste	812	740	522	584	411	305	229	287	289	432	4.611
Alagoas	18	17	35	36	55	32	13	20	15	25	266
Bahia	523	438	221	234	163	114	92	91	89	288	2.253
Ceará	17	25	9	17	23	18	4	15	14	5	147
Maranhão	5	7	7	74	37	8	1	6	12	10	167
Paraíba	56	48	80	56	18	17	28	39	53	20	415
Pernambuco	158	159	82	96	59	61	74	70	44	40	843
Piauí	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	7
Rio Grande do Norte	4	5	18	11	3	7	-	3	5	8	64
Sergipe	30	41	70	60	52	48	16	42	56	34	449
Sudeste	2.714	3.047	2.917	2.133	2.286	1.798	777	946	996	997	18.611
Espírito Santo	270	287	229	245	358	362	-	-	-	-	1.751

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Minas Gerais	1.920	2.345	2.296	1.478	1.567	1.176	658	796	824	870	13.930
Rio de Janeiro	57	61	32	49	18	28	6	18	28	28	325
São Paulo	467	354	360	361	343	232	113	132	144	99	2.605
Sul	39	26	27	38	47	38	11	18	15	17	276
Paraná	26	16	26	32	39	35	8	6	8	10	206
Rio Grande do Sul	1	1	1	-	1	-	-	2	-	-	6
Santa Catarina	12	9	0	6	7	3	3	10	7	7	64
Centro-Oeste	47	31	39	33	17	31	25	21	19	7	270
Distrito Federal	7	2	4	6	5	6	4	5	4	1	44
Goiás	13	12	8	7	7	3	11	7	5	1	74
Mato Grosso	21	17	24	18	2	16	8	8	8	4	126
Mato Grosso do Sul	6	-	3	2	3	6	2	1	2	1	26
Ignorado/exterior	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Ministério da Saúde. Esquistossomose mansoni. Em: SVSA, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de novembro de 2025]. p. 957–70. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.17 – Incidência de esquistossomose mansoni não grave [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi:10.5281/zenodo.18637104





MRB.1.18 – Incidência de doença de Chagas aguda

MRB.1.18 – Incidence of acute Chagas disease

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de doença de Chagas aguda, em um local e ano de referência.
- Os casos de doença de chagas aguda são codificados como B57.0 e B57.1 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos confirmados de doença de chagas aguda, em um local e ano de referência.
- A incidência pode estar relacionada com a exposição a determinados fatores de risco especificamente associados à transmissão da doença de chagas, tais como os seguintes: contato com o vetor em áreas de risco, transmissão vertical (binômio mãe-filho), consumo de alimentos contaminados, transfusão de sangue, transplante de órgãos e acidentes².

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos de doença de chagas aguda, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a avaliação e orientação das ações, inclusive na detecção e investigação de surtos, possibilitando ações de vigilância sanitária, ambiental, de vetores e reservatórios, de forma integrada com as ações de vigilância epidemiológica.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à prevenção, ao controle e à eliminação da doença de chagas aguda.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de doença de Chagas aguda.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)³.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\sum x$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de x número de casos incidentes confirmados de doença de Chagas aguda, em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Somatório ($\sum$) do número de casos incidentes confirmados de doença de Chagas aguda, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE**Faixa etária:**

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Grupo Técnico de Doenças de Chagas da Coordenação-Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGZV/DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso confirmado de doença de Chagas aguda baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁴.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, de 2014 a 2024, a incidência de doença de Chagas aguda aumentou de 209 para 520 casos, respectivamente. Vale destacar a redução expressiva de notificações observada no ano de 2020, com apenas 168 casos, coincidente com o ano de início da pandemia de COVID-19.

A região Norte concentra o maior número de notificações, sendo que, no ano de 2024, foram 501 casos incidentes de doença de Chagas aguda, representando 96,3% do total de casos notificados no Brasil (n=520) nesse mesmo ano. O Pará é o estado com maior número de notificações; no ano de 2024, apresentou 436 casos incidentes de doença de Chagas aguda, representando 83,8% de todos os casos do Brasil, nesse mesmo ano (Tabela 1).

Tabela 1 – Incidência de doença de Chagas aguda. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	209	288	359	338	384	385	168	340	415	543	520
Norte	204	269	355	332	355	350	162	324	387	526	501
Acre	2	6	22	2	7	20	1	4	8	4	17
Amapá	12	8	7	23	18	33	5	46	24	41	40
Amazonas	19	10	3	13	16	28	7	9	24	14	7
Pará	165	241	321	294	296	258	148	264	331	463	436
Rondônia	1	0	0	0	1	1	1	1	0	3	0
Roraima	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Tocantins	5	2	2	0	16	9	0	0	0	1	1
Nordeste	1	19	3	1	29	32	1	9	16	9	15
Alagoas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bahia	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	6
Ceará	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3
Maranhão	1	10	1	1	25	2	0	2	1	0	2
Paraíba	0	0	0	0	3	0	0	3	9	4	1
Pernambuco	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	1
Piauí	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1
Rio Grande do Norte	0	9	2	0	0	0	0	1	1	0	1
Sergipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sudeste	1	0	1	2	0	0	4	1	7	3	1
Espírito Santo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Minas Gerais	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Rio de Janeiro	0	0	0	0	0	0	3	0	5	2	0
São Paulo	1	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sul	1	0	0	0	0	0	0	4	2	4	1
Paraná	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0
Rio Grande do Sul	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1
Santa Catarina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centro-Oeste	2	0	0	3	0	3	1	2	3	1	2
Distrito Federal	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Goiás	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Mato Grosso	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	2
Mato Grosso do Sul	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0

Nota:

- Dados originados do Sinan³ e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. Doença de Chagas. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. 2024 [citado 25 de maio de 2025]. p. 851–84. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao/view>
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico. Doença de Chagas. Secretaria de Vigilância em Saúde [Internet]. 2021 [citado 25 de maio de 2025]. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2021/boletim_especial_chagas_14abr21_b.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.1.18 – Incidência de doença de Chagas aguda [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637127



Morbidade



MRB.2.01 – Taxa de incidência de aids

MRB.2.01 – AIDS incidence rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (*acquired immunodeficiency syndrome – aids*), diagnosticados na população residente, em um local e ano de referência.
- Os casos de aids são codificados como B20-B24 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude da doença. A análise de série temporal desse indicador permite avaliar a evolução temporal e a distribuição geográfica da taxa de incidência de aids, em um local e ano de referência.
- Indica a existência de condições favoráveis à transmissão da doença, por via sexual, sanguínea ou por transmissão vertical.
- Não reflete a situação atual de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (*human immunodeficiency virus – HIV*) no período de referência, e sim a da doença (*aids*), cujos sinais e sintomas surgem, em geral, após longo período de infecção assintomática (em média, oito anos), no qual o indivíduo permanece infectante.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição da taxa de incidência de aids, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a avaliação e orientação das ações de controle da aids.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para o controle da transmissão do HIV/aids em áreas e populações específicas.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica da aids.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².
- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)³.
- Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel)⁴.
- Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom)⁵.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados de aids, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos incidentes confirmados de aids, em um local provável de infecção e ano de referência.
- Denominador: População total estimada de residentes para o meio do ano, em um local de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 5 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Vigilância Epidemiológica do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DATHI/SVSA/MS).

NOTAS

- A definição de caso confirmado de aids baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientar as ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁶.
- Além das informações constantes nos boletins epidemiológicos⁷, publicados anualmente, os dados específicos para cada um dos 5.570 municípios brasileiros podem ser visualizados por meio dos painéis de indicadores epidemiológicos disponíveis *online*, no endereço <http://indicadores.aids.gov.br/>.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No período de 2014 a 2024, observou-se redução da taxa de incidência de aids no Brasil, que passou de 19,90 para 17,38 casos por 100 mil habitantes, com queda mais acentuada em 2020 e posterior estabilização em patamares inferiores aos do início da série. Regionalmente, persistem importantes diferenças, com taxas historicamente mais elevadas nas regiões Norte e Sul. A região Norte apresentou crescimento expressivo no período mais recente, alcançando 27,60 em 2024, com destaque para Roraima (41,30) e Amazonas (35,18), enquanto a região Sul, apesar da redução em relação a 2014, manteve níveis elevados, especialmente no Rio Grande do Sul (23,55) e em Santa Catarina (22,87). O Sudeste apresentou declínio, sobretudo em São Paulo e Minas Gerais, embora o Rio de Janeiro tenha permanecido com taxas superiores à média regional. No Nordeste e no Centro-Oeste, observam-se variações ao longo da série, com alguns estados apresentando retomada do crescimento nos últimos anos, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O cenário evidencia avanços nacionais no enfrentamento da aids, mas reforça a necessidade de estratégias diferenciadas, levando-se em conta as territorialidades, para redução das desigualdades regionais e fortalecimento das ações de prevenção, diagnóstico oportuno e cuidado contínuo (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de aids, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	19,90	19,31	18,67	18,36	18,27	18,07	14,33	16,70	17,33	17,73	17,38
Norte	24,97	23,97	25,28	23,75	25,72	26,75	20,27	27,28	27,14	27,08	27,60
Acre	8,83	8,35	7,05	6,99	12,57	8,98	5,56	12,55	14,33	15,06	14,65
Amapá	24,87	19,54	29,86	29,52	27,56	25,40	22,79	28,20	28,66	26,03	28,40
Amazonas	36,97	30,78	31,47	28,89	29,96	34,47	28,83	41,27	33,12	32,85	35,18
Pará	23,04	24,55	26,49	23,67	26,96	28,58	20,02	25,55	28,10	27,12	27,41
Rondônia	23,97	22,14	20,00	21,75	19,51	18,69	15,44	20,12	21,50	22,87	20,39

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Roraima	23,44	25,26	30,46	29,79	38,64	37,05	20,28	28,70	35,19	38,40	41,30
Tocantins	15,11	15,50	14,27	17,08	16,07	11,61	11,05	14,34	14,96	18,19	16,67
Nordeste	15,78	15,85	15,77	16,13	16,56	16,38	12,71	14,72	15,50	16,33	16,15
Alagoas	14,56	13,99	15,81	18,98	19,12	18,17	16,36	18,46	18,49	19,70	18,91
Bahia	13,23	13,01	13,15	12,42	13,26	14,16	11,10	13,04	13,69	14,28	14,46
Ceará	14,59	15,27	14,80	14,13	15,11	15,67	11,70	12,47	14,15	16,50	18,45
Maranhão	18,67	20,96	19,41	20,90	19,81	17,85	12,52	15,87	19,06	19,66	18,26
Paraíba	13,16	13,94	11,55	13,51	13,82	14,83	12,13	11,60	12,76	13,55	13,90
Pernambuco	20,79	19,37	20,26	19,92	20,06	19,67	14,78	17,38	16,14	17,29	16,11
Piauí	15,06	13,61	13,73	13,42	12,63	14,04	10,46	13,74	14,09	13,25	13,24
Rio Grande do Norte	16,55	14,87	16,10	20,36	21,83	17,95	13,73	16,87	17,65	17,23	16,71
Sergipe	13,68	17,14	16,88	16,00	18,28	16,69	16,90	18,72	18,69	18,10	15,10
Sudeste	18,81	18,08	17,32	16,88	16,25	15,50	13,01	14,47	15,10	15,22	14,59
Espírito Santo	21,17	19,38	17,10	16,37	16,94	17,48	13,89	14,25	16,66	16,12	15,28
Minas Gerais	13,94	13,87	12,79	12,71	12,13	11,50	9,30	10,57	10,68	11,55	10,91
Rio de Janeiro	28,27	27,46	25,75	25,21	24,10	23,06	18,55	22,17	23,66	24,19	22,20
São Paulo	17,23	16,31	16,20	15,67	15,10	14,31	12,55	13,39	13,79	13,48	13,38
Sul	28,68	27,60	25,09	23,68	23,23	22,72	17,34	19,99	20,69	21,03	20,60
Paraná	19,03	18,74	16,53	16,84	17,21	16,52	12,35	14,59	15,72	16,73	16,25
Rio Grande do Sul	37,81	33,87	31,55	29,51	27,96	28,16	21,84	24,07	24,19	24,29	23,55
Santa Catarina	29,50	31,77	28,52	25,39	25,36	24,10	18,28	22,19	23,10	22,79	22,87
Centro-Oeste	18,32	17,71	16,96	17,60	17,64	19,46	14,87	17,53	18,32	19,13	18,85
Distrito Federal	21,09	20,39	17,71	16,21	15,86	17,14	13,97	16,30	15,72	15,40	12,74
Goiás	13,31	14,69	13,87	14,18	14,46	15,36	12,68	15,42	16,91	17,61	15,69
Mato Grosso	24,07	19,41	20,35	21,67	21,80	25,03	18,99	18,05	19,89	21,73	23,38
Mato Grosso do Sul	20,73	20,32	19,67	22,46	22,21	25,06	16,03	23,45	22,53	23,42	27,15

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>

3. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Manual de utilização do sistema de controle de exames laboratoriais (SISCEL). Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sistema_controle_exames_laboratoriais_carga_viral_manual_utilizacao.pdf
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM). Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/sistemas-de-informacao/siclom>
6. Ministério da Saúde. Aids. Em: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de novembro de 2025]. p. 511–20. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>
7. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico HIV e Aids 2023. Brasília: [s.n.]. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2023/hiv-aids/boletim-epidemiologico-hiv-e-aids-2023.pdf/view>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.01 – Taxa de incidência de aids [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637141



Morbidade



MRB.2.02 – Taxa de incidência de sífilis congênita

MRB.2.02 – Incidence rate of congenital syphilis

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de sífilis congênita em menores de 1 ano, diagnosticados no ano, sobre o número de nascidos vivos de mães residentes em um mesmo local e ano de referência.
- Os casos de sífilis congênita em menores de 1 ano são codificados como A50 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos confirmados de sífilis congênita, em um local e ano de referência.
- Pode representar deficiências na atenção à saúde da mulher, especialmente no cuidado do pré-natal, quando as gestantes infectadas podem ser oportunamente diagnosticadas e tratadas.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos incidentes de sífilis congênita, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a avaliação e orientação das ações de eliminação da sífilis congênita.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento dos casos de sífilis congênita, bem como à prevenção e ao controle de doenças de transmissão vertical.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica da sífilis em gestantes, parturientes, puérperas e em recém-nascidos.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².
- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)³.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados de sífilis congênita em menores de 1 ano, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos, em um local e ano de referência}} \times 1.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos incidentes confirmados de sífilis congênita em menores de 1 ano, em um local e ano de referência.
- Denominador: População de nascidos vivos de mães residentes, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 1.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIA DE ANÁLISE**Faixa etária:**

- 0 a 6 dias;
- 7 a 27 dias; e
- 28 a 364 dias.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Vigilância Epidemiológica do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DATHI/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso confirmado de sífilis congênita baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁴.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, de 2014 a 2024, observou-se crescimento na taxa de incidência de sífilis congênita – diagnosticada até menos de 1 ano de idade –, que passou de 5,52 para 9,87 casos por mil nascidos

vivos, respectivamente (Tabela 1). Em 2024, a região Sudeste foi a que apresentou a maior taxa (11,48 por mil nascidos vivos), seguida pela região Nordeste (11,16). Neste mesmo ano, as regiões Norte (10,03), Sul (8,73) e Centro-Oeste (7,95) apresentaram valores para este indicador inferiores à média nacional (Tabela 1). Em relação às Unidades da Federação (UFs), apresentaram valores de incidência de sífilis congênita por mil nascidos vivos acima da média nacional, em 2024, as seguintes: Tocantins (17,80), Rio de Janeiro (15,60), Amapá (14,80), Pernambuco (14,70), Espírito Santo (12,90), Rio Grande do Sul (12,70), Roraima (12,80), Rio Grande do Norte (12,50), Ceará (11,60) e Pará (11,50) (Tabela 1). Além das informações constantes nos boletins epidemiológicos, publicados anualmente, os dados específicos para cada um dos 5.570 municípios brasileiros podem ser visualizados por meio dos painéis de indicadores epidemiológicos⁵.

Tabela 1 – Taxa de incidência de sífilis congênita diagnosticada até menos de 1 ano de idade, por 1 mil nascidos vivos. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	5,52	6,57	7,51	8,65	9,08	8,87	8,55	10,09	10,30	10,15	9,87
Norte	3,84	4,45	5,68	7,03	7,02	7,13	5,90	7,36	8,35	9,67	10,03
Acre	5,25	4,00	4,25	4,71	5,92	4,73	5,55	9,24	6,63	5,70	4,60
Amapá	2,52	2,60	4,51	4,94	5,86	8,14	9,98	18,68	11,38	11,40	14,80
Amazonas	2,01	3,90	6,52	10,35	9,96	9,06	5,65	4,96	5,65	5,80	6,70
Pará	4,82	4,66	5,45	5,84	5,73	6,85	6,09	7,53	9,95	9,10	11,50
Rondônia	2,65	3,33	3,35	4,15	4,17	3,00	1,01	1,38	3,01	2,10	2,00
Roraima	1,53	1,23	1,93	2,13	4,35	4,58	4,22	10,00	10,77	16,00	12,80
Tocantins	6,41	9,24	10,35	11,51	11,11	9,73	9,61	10,86	11,71	17,60	17,80
Nordeste	6,14	7,18	7,54	8,61	9,50	8,77	8,78	10,49	10,27	11,34	11,16
Alagoas	8,04	7,39	6,77	6,89	8,53	6,99	7,84	7,87	7,08	10,30	8,60
Bahia	4,52	5,65	6,94	6,73	7,50	6,29	6,96	7,89	7,19	7,30	8,00
Ceará	8,50	8,72	9,15	10,23	9,61	8,41	8,79	13,08	13,21	12,80	11,60
Maranhão	2,51	3,73	4,00	3,87	7,23	6,22	4,72	5,20	5,77	6,40	7,60
Paraíba	4,38	5,43	1,53	6,89	6,54	6,29	6,26	7,78	7,60	6,10	7,20
Pernambuco	9,00	9,41	11,68	14,25	14,63	13,53	14,02	17,57	16,95	14,00	14,70
Piauí	3,30	8,08	8,02	8,96	10,14	8,37	5,84	6,26	7,22	7,60	8,20
Rio Grande do Norte	6,30	9,74	8,55	10,54	12,62	14,22	12,36	13,54	13,09	13,20	12,50
Sergipe	11,09	10,57	9,68	9,36	9,63	14,80	17,21	16,70	15,85	13,00	10,90
Sudeste	6,11	7,03	8,27	9,57	10,03	10,21	9,94	11,74	11,78	12,78	11,48
Espírito Santo	6,72	9,08	11,23	11,59	9,93	7,99	7,18	9,96	11,89	14,30	12,90
Minas Gerais	3,60	5,39	5,90	7,08	9,42	9,08	7,29	9,00	9,64	9,80	9,00
Rio de Janeiro	12,35	12,68	16,03	19,76	20,08	21,84	23,02	27,17	22,91	18,50	15,60
São Paulo	4,80	5,42	6,19	6,74	6,66	6,78	6,69	7,61	8,83	8,50	8,40

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sul	4,83	6,87	8,05	9,04	8,98	8,50	8,25	9,75	9,70	9,23	8,73
Paraná	2,94	4,05	4,71	5,59	5,56	5,73	5,20	6,26	6,29	7,00	6,80
Rio Grande do Sul	8,17	11,20	13,19	14,37	14,20	13,75	14,00	16,59	15,83	14,00	12,70
Santa Catarina	2,95	4,94	5,84	6,90	6,99	5,61	5,14	6,07	7,04	6,70	6,70
Centro-Oeste	3,89	4,59	5,28	5,84	6,05	5,88	5,41	5,65	7,36	7,73	7,95
Distrito Federal	3,91	4,38	5,05	6,33	8,76	7,00	7,37	9,31	11,58	8,90	7,70
Goiás	3,43	3,90	4,44	4,55	5,55	6,31	6,06	6,66	8,71	8,70	8,40
Mato Grosso	3,24	3,74	3,72	4,50	3,58	3,59	2,82	1,88	3,73	4,90	6,20
Mato Grosso do Sul	5,77	7,45	9,36	9,86	7,75	6,93	5,64	5,34	5,85	8,40	9,50

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Ministério da Saúde. Nascidos Vivos – desde 1994 [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>
- Ministério da Saúde. Sífilis congênita. Em: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de novembro de 2025]. p. 511–20. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>
- Ministério da Saúde. Indicadores e dados básicos de sífilis nos municípios brasileiros [Internet]. SVSA. [citado 10 de novembro de 2025]. Disponível em: <http://indicadoressifilis.aids.gov.br/>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.02 – Taxa de incidência de sífilis congênita [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637181



Morbidade



MRB.2.03 – Taxa de incidência de hepatite B

MRB.2.03 – Incidence rate of Hepatitis B

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes diagnosticados de infecção pelo vírus de hepatite B, em um local e ano de referência.
- Os casos de hepatite B são codificados como B16, B18.0 e B18.1 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos de hepatite B, em um local e ano de referência.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos incidentes diagnosticados de hepatite B, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas interdisciplinares e ações de saúde direcionadas para a promoção, a prevenção e o tratamento da hepatite B, no contexto das doenças preveníveis por vacinação.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e confirmar casos de hepatites virais.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções³.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁴.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes de infecção pelo vírus da hepatite B, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de residentes, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de casos incidentes diagnosticados de infecção pelo vírus da hepatite B, em um local e ano de referência.
- **Denominador:** População total estimada para a metade do ano, residente em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Vigilância Epidemiológica do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DATHI/SVSA/MS).

NOTAS

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁵.

- Além das informações constantes nos boletins epidemiológicos, publicados anualmente, os dados específicos para cada um dos 5.570 municípios brasileiros podem ser visualizados por meio dos painéis de indicadores epidemiológicos^{6,7}.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, de 2012 a 2024, houve declínio da taxa de incidência de hepatite B (por 100 mil habitantes), de 7,93 para 5,25, com pico em 2013 (8,32). Em 2024, entre as regiões, o Norte apresentou a maior taxa, de 10,26 casos por 100 mil habitantes, seguido pelo Sul (9,54). No mesmo ano, as taxas (por 100 mil habitantes) nas demais regiões foram as seguintes: 5,80 no Centro-Oeste; 3,87 no Sudeste; e 3,26 no Nordeste. Entre as Unidades da Federação (UFs), destacam-se o Acre (33,95), Rondônia (24,85), o Amazonas (13,64), Mato Grosso (12,17), Roraima (11,72) e Santa Catarina (11,49), com taxas superiores a 10 casos por 100 mil habitantes, em 2024 (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de hepatite B, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2012 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	7,93	8,32	8,12	7,27	7,03	6,79	7,00	6,97	3,73	4,68	5,27	5,46	5,25
Norte	13,31	19,00	16,68	12,15	11,79	12,18	12,69	13,84	6,30	7,96	8,85	9,24	10,26
Acre	81,85	109,60	74,92	40,89	45,32	43,46	38,29	36,25	11,00	25,34	33,35	29,55	33,95
Amapá	3,65	4,01	3,40	3,35	6,74	6,40	5,18	1,28	0,76	0,89	1,51	1,13	1,49
Amazonas	13,86	28,86	27,41	15,50	13,82	16,39	17,54	22,66	10,80	9,62	10,43	10,92	13,64
Pará	3,29	3,59	3,40	3,59	3,55	4,08	4,38	5,43	2,28	3,66	4,46	4,58	4,77
Rondônia	33,34	43,70	39,77	38,99	36,66	33,22	33,02	31,18	15,09	19,89	20,23	23,73	24,85
Roraima	23,89	16,96	21,51	16,28	20,79	15,25	20,43	24,91	15,60	15,57	12,18	14,10	11,72
Tocantins	7,64	8,19	8,17	7,07	4,24	6,21	9,19	6,56	2,86	4,52	4,69	4,79	5,64
Nordeste	2,93	3,06	3,13	2,79	2,76	3,04	3,70	4,06	2,14	2,76	3,17	3,20	3,26
Alagoas	2,66	2,28	3,40	3,17	3,83	5,42	5,66	5,89	2,83	3,60	3,45	3,88	4,72
Bahia	3,48	4,02	4,03	4,51	3,83	4,28	4,76	5,12	2,73	3,39	3,82	3,61	3,61
Ceará	2,23	1,77	1,92	1,88	1,84	1,93	2,06	1,77	1,29	1,45	2,24	2,49	2,36
Maranhão	3,05	3,05	3,09	3,02	2,97	3,05	4,50	4,87	2,08	3,95	4,33	4,30	4,71
Paraíba	4,59	5,05	3,64	1,60	1,52	1,96	2,97	3,10	1,45	1,98	2,17	1,70	1,83
Pernambuco	2,21	2,68	2,83	1,73	2,36	2,22	3,16	4,61	2,90	2,82	3,21	3,54	3,23
Piauí	1,49	1,80	2,16	1,14	1,47	1,73	2,33	2,53	0,78	1,02	1,13	1,66	1,18
Rio Grande do Norte	2,31	1,86	2,21	1,20	1,59	1,79	2,16	2,06	0,91	1,37	1,34	1,95	2,09
Sergipe	5,31	4,66	4,94	5,22	4,69	5,20	6,15	5,98	2,97	4,77	6,20	4,38	5,54
Sudeste	6,67	6,25	5,75	5,73	5,47	5,29	5,15	4,65	2,65	3,48	4,13	4,15	3,87
Espírito Santo	15,35	13,80	12,36	9,55	8,89	9,40	8,41	6,90	2,97	4,94	5,55	4,98	4,29
Minas Gerais	3,51	3,92	4,31	4,80	4,31	3,96	4,31	3,86	1,94	2,60	2,67	3,16	2,92

Brasil, regiões e UFs	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rio de Janeiro	4,79	4,12	2,99	3,05	3,01	3,08	2,69	3,48	1,84	2,20	2,97	3,12	3,28
São Paulo	8,13	7,51	6,91	6,85	6,65	6,40	6,18	5,27	3,26	4,24	5,12	4,92	4,49
Sul	17,57	17,56	19,16	17,20	15,98	14,53	15,23	14,96	8,26	8,93	9,94	10,63	9,54
Paraná	17,67	18,13	18,96	16,77	16,60	15,06	15,93	15,22	7,59	7,78	8,96	9,17	8,30
Rio Grande do Sul	12,95	13,16	14,85	14,22	12,86	12,15	13,20	13,10	7,59	8,30	9,49	10,45	9,43
Santa Catarina	25,15	23,87	26,51	22,69	19,95	17,42	17,26	17,38	10,30	11,60	12,07	13,03	11,49
Centro-Oeste	8,87	9,48	8,84	7,69	8,64	7,64	6,88	7,05	3,74	6,24	5,81	6,40	5,80
Distrito Federal	4,81	6,91	5,68	5,58	9,92	3,02	4,45	4,38	3,39	4,53	3,49	3,13	2,72
Goiás	5,51	5,95	5,74	5,11	6,10	6,45	5,15	5,02	2,48	6,84	5,35	5,37	4,78
Mato Grosso	20,87	20,69	20,16	17,82	16,42	16,34	13,78	15,63	8,03	9,44	10,64	13,97	12,17
Mato Grosso do Sul	6,62	7,00	5,77	3,66	3,87	4,49	4,99	3,96	1,75	2,37	3,08	2,43	3,14

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
- Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
- Ministério da Saúde. Hepatites virais. Em: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de novembro de 2025]. p. 483–98. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>
- Ministério da Saúde. Indicadores e dados básicos das hepatites nos municípios brasileiros [Internet]. SVSA. [citado 10 de novembro de 2025]. Disponível em: <https://indicadoreshepatites.aids.gov.br/>
- Ministério da Saúde. Painel Hepatites Virais [Internet]. Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica. [citado 10 de novembro de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/painel-hepatites-virais>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.03 – Taxa de incidência de hepatite B [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637193





MRB.2.04 – Taxa de incidência de hepatite C

MRB.2.04 – Incidence rate of Hepatitis C

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes diagnosticados de infecção pelo vírus da hepatite C, em um local e ano de referência.
- Os casos de hepatite C são codificados como B17.1 e B18.2 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos da hepatite C, em um local e ano de referência.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos incidentes diagnosticados como hepatite C, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas interdisciplinares e ações de saúde direcionadas para a promoção, a prevenção e o tratamento da hepatite C.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e confirmar casos de hepatites virais.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções³.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁴.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes de infecção pelo vírus da hepatite C, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de residentes, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos incidentes diagnosticados de infecção pelo vírus da hepatite C, em um local e ano de referência.
- Denominador: População total estimada para a metade do ano, residente em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Vigilância Epidemiológica do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DATHI/SVSA/MS).

NOTAS

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁵.

- Além das informações constantes nos boletins epidemiológicos, publicados anualmente, os dados específicos para cada um dos 5.570 municípios brasileiros podem ser visualizados por meio dos painéis de indicadores epidemiológicos^{6,7}.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, as taxas de incidência de hepatite C (por 100 mil habitantes) apresentaram valores estáveis no período de 2012 (6,37) a 2014 (5,82), incremento importante de 2015 (12,70) a 2019 (11,28), e queda no ano de 2020, passando a 6,11 casos por 100 mil habitantes. A partir de 2021, este indicador apresentou discreto aumento, com 9,10 casos por 100 mil habitantes em 2024.

No ano de 2024, a maior taxa de incidência de hepatite C (por 100 mil habitantes) foi observada na região Sul (17,63), seguida da região Sudeste (10,92). Merecem destaque as seguintes Unidades da Federação (UFs), com valores para a taxa de incidência de hepatite C acima da média nacional (9,10 por 100 mil habitantes) em 2024: Acre (18,51), Rondônia (11,85), São Paulo (14,89), Rio Grande do Sul (28,69) e Santa Catarina (14,57) (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de hepatite C, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2012 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	6,37	6,18	5,83	12,70	12,51	11,86	12,19	11,28	6,11	7,24	8,53	9,10	9,10
Norte	2,61	3,07	2,36	6,00	6,14	6,55	6,44	5,95	2,83	4,05	4,42	5,02	5,72
Acre	16,42	14,93	9,69	19,84	15,78	18,00	13,74	12,94	4,63	7,37	10,20	14,37	18,51
Amapá	1,97	2,90	1,63	4,02	4,62	5,62	3,88	5,00	1,02	2,28	1,38	2,00	1,99
Amazonas	2,67	4,98	3,82	7,28	6,49	7,46	8,31	7,56	3,69	4,57	5,02	4,79	5,56
Pará	1,05	0,75	0,39	3,04	3,89	4,10	3,98	4,31	1,96	3,03	3,31	3,55	3,73
Rondônia	5,93	7,09	6,42	12,48	12,08	12,12	12,63	7,88	3,89	5,72	7,72	10,00	11,85
Roraima	0,20	0,99	1,54	11,04	14,23	11,70	11,74	10,52	8,74	12,06	5,64	8,20	8,65
Tocantins	0,77	0,56	1,44	3,13	3,37	3,47	3,18	3,21	1,56	2,07	2,95	3,06	3,74
Nordeste	1,51	1,53	1,33	3,19	3,09	3,37	3,95	4,10	1,98	2,54	2,88	3,31	3,57
Alagoas	1,05	0,85	1,10	2,99	2,70	4,23	4,03	5,49	2,12	2,61	2,45	2,64	3,07
Bahia	2,19	2,26	1,89	4,89	4,45	5,07	6,35	6,61	3,05	3,79	4,02	4,63	4,60
Ceará	1,08	1,09	1,30	2,69	2,69	2,24	2,96	2,46	1,33	1,99	2,84	2,57	2,83
Maranhão	1,33	0,93	0,65	2,21	1,89	1,99	2,96	2,59	0,88	1,43	2,13	2,40	2,60
Paraíba	0,73	1,83	1,54	2,54	2,63	3,64	3,69	3,47	1,82	2,20	2,65	2,47	3,04
Pernambuco	1,21	1,31	0,66	2,47	2,79	3,12	2,59	3,55	1,96	2,33	2,34	3,76	4,36
Piauí	0,97	0,81	0,93	2,12	1,77	1,40	1,54	1,99	1,05	1,16	1,13	1,84	1,84
Rio Grande do Norte	1,45	1,65	1,70	2,59	3,23	3,10	3,70	3,24	1,97	2,43	2,65	3,11	3,71
Sergipe	3,67	2,61	2,59	3,94	3,78	3,80	5,30	4,73	2,53	3,53	4,18	3,46	3,58

Brasil, regiões e UFs	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sudeste	9,51	8,62	7,63	15,98	15,82	15,01	15,42	13,71	7,51	9,02	11,37	11,69	10,92
Espírito Santo	2,75	2,74	2,40	6,26	7,34	7,99	6,58	5,24	2,37	4,00	3,68	4,37	5,09
Minas Gerais	2,73	3,20	3,36	7,40	7,76	7,50	7,62	7,32	3,82	3,81	4,42	5,15	5,12
Rio de Janeiro	9,39	8,21	5,59	10,82	10,38	9,49	9,86	8,64	4,69	6,47	6,99	9,14	8,91
São Paulo	13,29	11,79	10,84	22,78	22,37	21,21	21,91	19,33	10,72	12,85	16,91	16,33	14,89
Sul	10,35	11,40	12,88	28,46	27,16	24,62	25,07	23,68	13,04	13,70	14,96	16,50	17,63
Paraná	6,33	5,40	5,48	15,37	14,21	13,05	12,44	11,73	6,94	6,88	7,73	8,13	9,20
Rio Grande do Sul	13,97	17,78	21,56	47,21	46,16	41,43	43,27	40,97	21,79	22,94	24,49	28,14	28,69
Santa Catarina	10,92	10,69	10,77	19,43	17,73	16,66	16,87	16,06	9,36	10,51	12,07	12,43	14,57
Centro-Oeste	3,02	2,93	2,62	6,28	7,34	6,51	5,84	6,03	3,76	5,47	5,51	6,08	6,25
Distrito Federal	3,33	3,37	2,35	8,52	12,43	5,12	5,98	7,07	5,37	7,05	5,66	6,27	5,87
Goiás	1,95	2,17	2,13	5,94	6,64	6,85	5,10	5,22	3,50	6,45	6,22	7,00	7,03
Mato Grosso	4,25	2,95	2,90	6,52	5,92	6,50	5,79	6,48	3,85	3,85	5,13	5,40	5,14
Mato Grosso do Sul	3,84	4,33	3,78	4,49	5,55	7,14	7,61	6,41	2,60	3,46	4,06	4,45	6,13

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
4. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
5. Ministério da Saúde. Hepatites virais. Em: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de novembro de 2025]. p. 483–98. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>
6. Ministério da Saúde. Indicadores e dados básicos das hepatites nos municípios brasileiros [Internet]. SVSA. [citado 10 de novembro de 2025]. Disponível em: <https://indicadoreshepatites.aids.gov.br/>

7. Ministério da Saúde. Painel Hepatites Virais [Internet]. Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica. [citado 10 de novembro de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cnie/painel-hepatites-virais>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.04 – Taxa de incidência de hepatite C [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637337



Morbidade



MRB.2.05 – Taxa de incidência de tuberculose

MRB.2.05 – Incidence rate of tuberculosis

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de tuberculose (todas as formas), em um local e ano de referência.
- Os casos de tuberculose são codificados, na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10), como: A15 a A19; J65; K93.0; M49.0; M90.0; N74.0; N74.1; O98.0; e P37.0¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos confirmados de tuberculose, numa determinada população, em um local e ano de referência.
- Estima a força de morbidade por tuberculose em uma população e um intervalo de tempo determinados.
- Taxas elevadas estão geralmente associadas a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico e à insuficiência nas ações de vigilância e atenção à saúde voltadas ao diagnóstico e tratamento adequado e oportuno, ao acompanhamento dos casos e à investigação de contatos.
- Dentre os fatores individuais associados ao adoecimento por tuberculose, destacam-se a infecção pelo HIV, tratar-se de indivíduo em situação de rua ou privado de liberdade.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição dos casos incidentes confirmados de tuberculose, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Monitorar o progresso no alcance da meta “Reduzir a taxa de incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035”, do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública², assim como do indicador “3.3.2 – Taxa de Incidência de tuberculose por 100.000 habitantes” dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável³.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas interdisciplinares e ações de saúde direcionadas para a promoção da prevenção e do tratamento da tuberculose.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e confirmar casos de tuberculose.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)⁴.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁵.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁶.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados de tuberculose, em um local e ano de referência}}{\text{Número total residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos incidentes confirmados de Tuberculose, em um local e ano de referência.
- Denominador: População total estimada para a metade do ano, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos e mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Vigilância Epidemiológica do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DATHI/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁷.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, de 2012 a 2024, houve crescimento da taxa de incidência de tuberculose, de 35,98 para 40,42 casos por 100 mil habitantes. Existem diferenças marcantes na distribuição da doença entre as regiões. Em 2024, a região Norte apresentou taxa de 63,32 casos por 100 mil habitantes. No mesmo ano, as taxas nas demais regiões foram as seguintes: 44,21, no Sudeste; 37,08, no Nordeste; 30,59, no Sul; e 24,82, no Centro-Oeste. Entre as Unidades da Federação (UFs), destacam-se Amazonas (94,30), Rio de Janeiro (74,97), Pará (62,89), Roraima (62,22), Acre (59,62) e Amapá (55,30), com taxas superiores a 50 casos por 100 mil habitantes, em 2024.

A tuberculose permanece como um importante problema de saúde pública no Brasil, com alta carga de doença nas regiões Norte e Sudeste, além de crescimento expressivo em partes do Centro-Oeste. O período de 2020 a 2021 foi marcado por uma queda geral na notificação, possivelmente por subdiagnóstico e dificuldades de acesso aos serviços durante a pandemia. Contudo, o aumento consistente entre 2022 e 2023 reforça a necessidade de reorganização da rede de atenção, fortalecimento da busca ativa de sintomáticos respiratórios, ampliação do diagnóstico precoce e garantia de adesão ao tratamento, com foco especial nos territórios prioritários (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de tuberculose, por 100 mil habitantes.
Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2012 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	35,98	35,73	34,88	34,49	34,59	36,00	37,43	37,09	33,04	34,63	38,41	39,96	40,42
Norte	43,90	45,53	44,37	44,20	45,66	48,33	49,34	54,68	47,98	52,14	57,78	59,46	63,32
Acre	44,21	43,67	48,19	36,05	45,32	49,85	50,38	59,33	61,71	60,34	61,66	59,78	59,62
Amapá	28,38	25,42	22,42	24,23	30,65	33,05	28,99	37,33	33,74	42,11	51,04	49,30	55,30
Amazonas	64,96	70,17	70,25	74,14	71,43	76,65	77,57	79,13	68,26	75,50	87,62	89,37	94,30
Pará	44,20	45,11	43,12	42,39	44,21	46,44	48,29	55,92	48,98	51,95	56,04	56,88	62,89
Rondônia	34,57	34,41	34,08	31,26	36,01	35,29	32,02	35,27	27,40	31,68	32,69	40,40	40,77
Roraima	23,69	30,18	24,59	28,44	25,90	34,75	40,00	46,43	44,78	48,40	60,59	69,76	62,22
Tocantins	13,18	13,12	11,47	10,74	11,78	10,68	13,10	13,97	12,09	15,37	14,83	14,29	13,25
Nordeste	35,48	34,81	33,51	32,61	33,07	34,55	36,45	35,96	31,35	33,48	37,18	37,51	37,08
Alagoas	34,89	34,12	33,63	27,91	32,31	31,94	34,12	31,35	25,63	26,97	29,39	32,53	31,49
Bahia	34,68	33,27	32,53	29,96	29,48	30,17	31,03	31,06	25,21	27,81	29,73	29,71	30,32

Brasil, regiões e UFs	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ceará	39,69	38,05	36,61	37,32	37,33	38,26	41,14	40,88	33,72	35,64	39,29	38,75	37,72
Maranhão	28,64	29,20	26,65	28,40	30,30	30,81	33,02	32,42	29,98	33,40	36,77	38,70	40,27
Paraíba	29,47	28,88	26,42	25,38	24,81	26,97	30,89	28,68	25,36	27,91	30,78	33,24	32,47
Pernambuco	50,13	48,26	47,52	48,37	47,56	51,33	50,50	52,01	45,20	49,84	55,95	56,42	55,24
Piauí	22,20	22,29	19,75	17,63	19,44	20,09	21,83	20,48	19,67	21,51	21,66	24,75	24,68
Rio Grande do Norte	29,49	31,26	29,10	27,06	28,84	32,98	38,96	34,13	39,59	32,26	39,76	33,23	32,09
Sergipe	24,07	28,66	29,71	28,41	29,98	30,87	36,15	37,34	32,12	32,50	41,61	40,67	34,87
Sudeste	38,46	37,81	37,51	37,65	37,69	39,47	40,57	38,82	35,74	37,22	41,11	43,40	44,21
Espírito Santo	33,68	31,57	29,63	30,72	27,20	29,17	31,50	0,63	29,26	31,95	35,52	40,41	40,64
Minas Gerais	17,90	17,75	17,62	16,58	16,48	16,67	17,24	17,63	15,57	15,64	18,46	19,34	20,20
Rio de Janeiro	66,81	63,41	61,97	62,88	63,89	66,45	70,11	71,31	63,84	69,68	72,78	74,42	74,97
São Paulo	37,47	37,78	38,00	38,33	38,37	40,60	40,90	39,63	35,00	35,42	40,18	43,18	44,15
Sul	31,10	30,92	30,17	29,58	28,48	28,94	30,54	31,10	26,22	26,41	29,43	30,56	30,59
Paraná	20,15	20,95	19,99	19,24	19,03	18,03	20,40	20,17	18,71	17,13	19,12	20,39	20,33
Rio Grande do Sul	43,87	42,72	42,17	42,40	39,87	42,48	44,64	46,59	38,55	39,32	42,89	43,98	43,88
Santa Catarina	27,85	27,78	27,17	25,66	25,52	25,04	24,74	24,60	19,40	21,59	25,51	26,64	27,14
Centro-Oeste	23,80	25,28	23,39	21,76	21,62	21,58	23,37	23,32	20,43	20,61	23,50	25,99	24,82
Distrito Federal	13,80	11,74	13,46	12,59	12,15	10,84	12,73	12,62	10,20	10,18	10,64	13,68	15,05
Goiás	14,38	14,45	13,22	14,58	13,63	14,81	15,03	14,48	13,10	13,32	14,71	15,88	13,90
Mato Grosso	41,33	50,38	45,45	35,88	35,09	34,63	33,55	35,70	29,54	28,09	31,04	32,55	35,29
Mato Grosso do Sul	36,04	35,27	31,69	31,63	34,64	33,29	42,53	40,87	37,76	40,11	49,15	55,63	48,69

Nota:

- Dados originados do Sinan⁴ e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. Brasil Livre da Tuberculose [Internet]. Ministério da Saúde. [citado 10 de novembro de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose/brasil-livre>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Brasil [Internet]. IBGE. [citado 20 de março de 2025]. Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=3>
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>

5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
6. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
7. Ministério da Saúde. Tuberculose. Em: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de novembro de 2025]. p. 549–604. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.05 – Taxa de incidência de tuberculose [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637356



Morbidade



MRB.2.06 – Taxa de incidência de hanseníase

MRB.2.06 – Leprosy incidence rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes de hanseníase, em relação à população residente em um local e ano de referência. Inclui casos de hanseníase, notificados conforme o Código A30 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Avalia a carga de morbidade e de magnitude da hanseníase, numa determinada população, em um intervalo de tempo determinado, sendo uma proxy de incidência da doença.
- Estima o risco de ocorrência de casos novos de hanseníase, em qualquer de suas formas clínicas, indicando exposição ao bacilo *Mycobacterium leprae*.
- No Brasil, adota-se a seguinte classificação das taxas de incidência de casos novos por 100 mil habitantes/ano: hiperendêmica (> 40,0); muito alta (20,00 a 39,99); alta (10,00 a 19,99); média (2,00 a 9,99); e baixa (< 2,00)².
- Taxas elevadas estão geralmente associadas a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico e a insatisfatórias condições assistenciais para o diagnóstico, o tratamento padronizado, o acompanhamento dos casos e a investigação de contatos.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos novos diagnosticados de hanseníase, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a elaboração de estratégias de prevenção e controle de casos de hanseníase, bem como na avaliação de programas de controle.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas interdisciplinares e ações de saúde direcionadas para a promoção, a prevenção e o tratamento da hanseníase.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e confirmar casos de hanseníase.
- Os sinais e sintomas iniciais da hanseníase costumam ser pouco expressivos e valorizados, e surgem após longo período de incubação. Em virtude disso, há dificuldade de diagnóstico precoce, o que exige cautela na análise dos dados do indicador.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)³.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁴.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁵.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes de hanseníase, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de residentes, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos incidentes de hanseníase, em um local e ano de residência.
- Denominador: População total residente em um local e ano de referência, estimada para a metade do mesmo ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Grau de incapacidade física no momento do diagnóstico:

- Grau 0;
- Grau 1; e
- Grau 2.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país^{6,7}.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A taxa de detecção geral de casos incidentes de hanseníase mede a força de morbidade, magnitude e tendência da endemia⁸. De 2014 a 2019, houve uma redução de 15,0% na taxa de incidência, que passou de 16,34 casos novos por 100 mil habitantes/ano, em 2014, para 13,89 casos novos por 100 mil habitantes em 2019. Essa redução foi ainda maior no período de 2019 a 2021, com uma diminuição de 37,3%, provavelmente, devido ao efeito da pandemia de COVID-19 nas ações para o diagnóstico de casos novos da doença.

No período de 2014 a 2024, a região Centro-Oeste apresentou taxa de incidência que oscilou de "muito alta" a "hiperendêmica", atingindo 35,00 em 2024. A maior redução ocorreu na região Norte, de 35,76 casos novos por 100 mil habitantes, em 2014, para 17,34 casos novos por 100 mil habitantes em 2024, o que representa uma redução de 51,5%. Em 2024, a taxa de detecção do Brasil foi de 10,41 casos novos por 100 mil habitantes. Mato Grosso e Tocantins apresentaram as maiores taxas de detecção: 121,83 casos novos por 100 mil habitantes, e 57,76 casos novos por 100 mil habitantes, respectivamente, configurando parâmetros hiperendêmicos. O Rio Grande do Sul apresentou baixa endemicidade, com taxa de 0,68 caso novo por 100 mil habitantes. Assim, destaca-se a importância de fortalecer ações para detecção de novos casos, como a busca ativa de contatos, com vistas à detecção precoce (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de hanseníase, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	16,34	14,88	12,97	13,70	14,40	13,89	8,59	8,71	9,32	10,80	10,41
Norte	35,76	30,74	28,76	29,30	32,50	29,15	17,92	17,98	17,38	19,17	17,34
Acre	16,80	16,09	14,47	14,80	15,62	12,94	9,96	12,67	16,04	13,92	19,30
Amapá	16,58	14,46	11,76	13,45	13,85	14,75	7,77	4,55	7,42	6,01	4,98
Amazonas	14,64	13,45	11,27	11,32	10,40	9,99	5,82	8,34	8,26	7,57	6,21
Pará	42,66	37,21	30,36	31,22	30,91	30,09	19,39	19,10	17,25	17,85	16,86
Rondônia	43,83	35,27	28,03	30,80	43,60	28,38	20,49	21,51	20,75	25,46	19,93
Roraima	15,18	14,78	14,96	22,87	17,70	13,91	6,08	8,09	7,57	7,91	5,86
Tocantins	71,28	57,43	88,66	83,21	112,32	98,68	54,04	47,79	49,05	65,53	57,76
Nordeste	27,26	25,35	21,72	23,25	22,90	22,38	13,52	14,14	15,69	16,10	15,05
Alagoas	10,97	11,29	8,69	9,71	11,22	9,01	6,87	7,92	8,79	11,99	9,88
Bahia	18,54	17,84	14,33	15,37	14,84	14,84	9,70	10,39	11,53	11,49	11,33
Ceará	23,18	20,86	19,09	17,36	18,85	17,21	12,42	13,19	12,40	13,67	13,30
Maranhão	55,43	52,60	49,43	46,75	46,57	46,41	27,44	28,22	33,82	34,10	28,34
Paraíba	14,93	13,71	11,04	12,11	13,05	14,88	9,15	8,81	9,33	11,18	10,35

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pernambuco	28,05	25,81	20,07	25,73	24,10	26,71	16,74	16,32	19,53	18,52	17,94
Piauí	71,36	63,49	55,36	65,22	61,26	52,01	16,67	20,37	22,58	21,18	20,83
Rio Grande do Norte	8,31	8,19	5,80	7,44	7,61	5,57	5,69	5,97	5,11	5,56	6,30
Sergipe	19,04	16,68	13,83	16,59	14,37	14,14	10,91	11,39	11,17	13,58	14,01
Sudeste	5,37	4,84	4,38	4,38	4,21	4,25	2,96	3,33	3,55	4,00	4,18
Espírito Santo	16,26	16,20	11,08	12,47	11,68	12,77	7,87	7,99	9,58	11,14	11,26
Minas Gerais	5,94	5,64	5,44	5,38	5,03	5,23	3,58	4,12	4,91	5,64	6,07
Rio de Janeiro	7,37	6,60	5,30	5,54	5,46	5,33	3,34	3,88	3,65	3,49	3,39
São Paulo	3,39	2,80	2,94	2,76	2,70	2,64	2,10	2,34	2,35	2,79	2,98
Sul	3,60	3,51	2,83	2,67	2,65	2,68	1,91	2,09	2,10	2,21	1,97
Paraná	6,80	6,63	5,16	4,96	4,98	5,01	3,43	3,57	3,37	3,97	3,44
Rio Grande do Sul	1,22	1,06	0,94	0,99	0,96	0,79	0,59	0,79	0,78	0,65	0,68
Santa Catarina	2,29	2,41	2,10	1,68	1,62	1,93	1,56	1,76	2,10	1,79	1,60
Centro-Oeste	40,64	36,82	30,68	34,29	41,85	40,26	23,74	20,69	22,46	35,00	35,00
Distrito Federal	10,06	7,98	6,27	5,82	4,83	6,21	7,15	4,59	5,45	4,45	3,65
Goiás	29,13	25,71	21,61	20,13	21,33	20,49	13,10	13,02	13,18	11,70	11,78
Mato Grosso	90,90	92,11	81,45	101,86	135,62	124,49	69,21	57,33	64,47	123,23	121,83
Mato Grosso do Sul	38,83	25,59	15,16	14,25	12,89	17,75	9,26	9,25	8,72	9,59	11,23

Nota:

- Dados originados do Sinan³ e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da Hanseníase como problema de saúde pública: manual técnico-operacional. 2016 [citado 5 de agosto de 2025];1-58. Disponível em: <https://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/diretrizes-vigilancia-atencao-eliminacao-hanseniase.pdf>
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
- Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

6. Ministério da Saúde. Hanseníase. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 5 de agosto de 2025]. p. 531–48. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>
7. Ministério da Saúde. Portaria SCTIE/MS nº 67, de 7 de julho de 2022. Torna pública a decisão de aprovar, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase. [Internet]. 2022. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2022/prt0067_11_07_2022.html
8. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico – Hanseníase – 2024 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 5 de agosto de 2025]. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2024/be_hansen-2024_19jan_final.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.06 – Taxa de incidência de hanseníase [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637369



Morbidade



MRB.2.07 – Taxa de incidência de hanseníase na população menor de 15 anos

MRB.2.07 – Leprosy incidence rate in children under 15 years

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes de hanseníase em menores de 15 anos, em relação à população residente menor de 15 anos em um local e ano de referência. Inclui casos de hanseníase, notificados conforme o Código A30 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a força da transmissão recente da endemia e sua tendência, na população de menores de 15 anos de idade, residente em um local e ano de referência.
- Taxas elevadas de incidência de hanseníase nesse grupo etário refletem, em geral, infecção recente, e indicam transmissão contínua entre seus contatos. Também indicam baixos níveis de condições de vida, de desenvolvimento socioeconômico e de atenção à saúde, assim como problemas operacionais dos serviços de saúde, para diagnosticar, tratar e investigar contatos.
- No Brasil, as taxas são classificadas em: hiperendêmica ($\geq 10,00$ por 100 mil habitantes); muito alta (5,00 a 9,99 por 100 mil habitantes); alta (2,50 a 4,99 por 100 mil habitantes); média (0,50 a 2,49 por 100 mil habitantes); e baixa ($< 0,5$ por 100 mil habitantes)².

USOS

- Medir força da transmissão recente da endemia e sua tendência.
- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição dos casos novos de hanseníase, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a avaliação e prevenção de casos de hanseníase.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas interdisciplinares e ações de saúde direcionadas para a promoção da prevenção e do tratamento da hanseníase.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e confirmar casos de hanseníase.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)³.

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁴.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁵.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes de hanseníase em menores de 15 anos de idade, em um local e ano de referência}}{\text{População residente de menores de 15 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos incidentes de hanseníase em menores de 15 anos de idade, em um local e ano de referência.
- Denominador: População total de menores de 15 anos de idade residentes em um local e ano de referência, estimada para a metade do mesmo ano.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE**Sexo:**

- Masculino; e
- Feminino.

Grau de incapacidade física no momento do diagnóstico:

- Grau 0;
- Grau 1; e
- Grau 2.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país^{6,7}.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Verifica-se que, no grupo etário de menores de 15 anos de idade, a taxa de incidência de hanseníase diminuiu de 5,40 casos por 100 mil habitantes, em 2014, para 2,19 casos por 100 mil habitantes em 2024, resultando em uma mudança de parâmetro de "muito alto" para "médio" no Brasil. Esse indicador apresentou redução em todas as regiões do país.

A maior diminuição foi observada na região Norte, onde a taxa declinou de 13,26 casos por 100 mil habitantes, em 2014, para 4,10 casos por 100 mil habitantes em 2024, redução de 69,1%. Em 2024, o país apresentou taxa de incidência em menores de 15 anos considerada "média", enquanto Tocantins (17,22) e Mato Grosso (21,16) foram classificados com taxas "hiperendêmicas". Pernambuco (5,49), Pará (4,49), Acre (4,41) e Maranhão (7,62) apresentaram taxas com parâmetro variando de "médio" a "alto". Rio de Janeiro (0,55), Santa Catarina (0,26), Paraná (0,13), São Paulo (0,67) e Rio Grande do Sul (0,05) apresentaram taxas com parâmetro de endemidade "baixo"³.

A tendência de queda da taxa de incidência em menores de 15 anos já vinha sendo observada, e, com a pandemia, essa queda se acentuou, o que sugere ter havido, nesse período, uma diminuição operacional, e não da transmissão da doença. A ocorrência da hanseníase em pessoas menores de 15 anos é um importante indicador epidemiológico de determinação do grau de transmissão e da magnitude da doença no território, sinalizando a necessidade de reforço nas ações de vigilância, sobretudo no âmbito domiciliar⁸ (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de hanseníase em menores de 15 anos de idade, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	5,40	4,85	3,94	3,98	3,98	3,62	1,99	1,74	1,95	2,23	2,19
Norte	13,26	10,57	9,14	8,43	9,82	8,04	4,62	4,08	3,91	4,28	4,10
Acre	4,17	4,21	4,26	3,93	4,79	0,00	2,47	3,34	1,27	1,73	4,41
Amapá	4,25	5,13	2,58	3,47	3,06	2,64	1,77	0,45	2,25	0,00	1,86
Amazonas	5,78	5,19	3,86	2,86	4,13	3,12	1,70	3,32	3,09	1,56	0,79
Pará	18,30	14,06	11,79	10,14	11,53	10,14	6,60	4,45	3,81	4,94	4,49
Rondônia	10,06	8,50	5,25	6,03	7,07	3,44	3,48	4,01	3,03	3,83	1,03
Roraima	4,15	0,59	6,43	9,24	3,38	4,33	0,53	0,00	1,02	1,00	3,43
Tocantins	25,06	20,60	22,63	24,14	31,17	26,73	8,87	9,21	12,30	15,70	17,22
Nordeste	9,03	9,03	6,87	7,27	6,81	6,25	3,34	2,76	3,56	3,44	3,36
Alagoas	3,20	3,03	2,72	3,28	3,58	2,33	1,71	0,93	1,75	3,15	1,67
Bahia	5,69	6,58	3,48	4,59	4,03	3,89	1,68	1,44	1,70	1,18	2,10
Ceará	6,52	4,77	4,63	2,99	3,27	3,19	2,14	1,55	1,72	2,27	2,14
Maranhão	18,64	20,06	16,99	17,08	17,31	15,17	9,52	8,13	11,07	10,26	7,62

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Paraíba	2,88	2,81	3,17	2,99	2,23	3,26	2,04	1,49	1,62	1,87	1,42
Pernambuco	11,88	11,15	8,13	9,08	7,17	7,62	3,83	3,54	4,67	3,95	5,49
Piauí	20,84	19,05	14,89	18,02	16,16	13,02	3,41	2,77	3,52	4,01	2,91
Rio Grande do Norte	2,08	4,48	1,07	1,22	1,23	0,83	1,11	1,13	0,72	1,45	1,33
Sergipe	4,82	3,56	3,79	3,65	5,62	4,10	1,97	0,80	1,82	1,44	1,88
Sudeste	1,07	0,88	0,95	0,82	0,86	0,86	0,49	0,57	0,55	0,60	0,75
Espírito Santo	4,05	4,78	2,88	2,17	3,02	3,87	1,70	1,09	1,34	1,59	1,72
Minas Gerais	1,34	1,07	1,35	1,47	1,46	1,08	0,71	0,94	1,24	0,81	0,89
Rio de Janeiro	1,89	1,40	1,60	1,12	1,19	1,01	0,49	0,72	0,51	0,67	0,55
São Paulo	0,38	0,26	0,36	0,31	0,29	0,44	0,29	0,30	0,19	0,39	0,67
Sul	0,32	0,19	0,10	0,32	0,19	0,27	0,17	0,17	0,19	0,15	0,14
Paraná	0,50	0,21	0,13	0,25	0,30	0,34	0,09	0,26	0,26	0,17	0,13
Rio Grande do Sul	0,14	0,09	0,09	0,33	0,10	0,24	0,19	0,00	0,05	0,05	0,05
Santa Catarina	0,29	0,29	0,07	0,43	0,14	0,21	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26
Centro-Oeste	10,48	8,50	6,93	7,30	7,10	7,03	3,82	3,21	3,32	6,49	5,83
Distrito Federal	4,00	1,08	0,94	1,10	0,48	0,96	0,81	0,16	0,67	0,51	0,00
Goiás	5,53	5,54	3,99	3,79	3,05	3,12	1,97	1,29	0,82	0,75	0,89
Mato Grosso	26,07	23,36	20,31	22,89	23,87	21,90	11,60	10,82	11,53	24,57	21,16
Mato Grosso do Sul	8,90	4,04	2,79	1,70	1,39	2,62	0,77	0,46	0,62	0,77	1,55

Nota:

- Dados originados do Sinan³ e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da Hanseníase como problema de saúde pública: manual técnico-operacional. 2016 [citado 5 de agosto de 2025];1–58. Disponível em: <https://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/diretrizes-vigilancia-atencao-eliminacao-hanseniase.pdf>
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

5. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
6. Ministério da Saúde. Hanseníase. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 5 de agosto de 2025]. p. 531–48. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>
7. Ministério da Saúde. Portaria SCTIE/MS nº 67, de 7 de julho de 2022. Torna pública a decisão de aprovar, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase. [Internet]. 2022. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2022/prt0067_11_07_2022.html
8. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico – Hanseníase – 2024 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 5 de agosto de 2025]. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2024/be_hansen-2024_19jan_final.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.07 – Taxa de incidência de hanseníase na população menor de 15 anos [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637387





MRB.2.08 – Taxa de incidência de leishmaniose tegumentar

MRB.2.08 – Cutaneous leishmaniasis incidence rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de leishmaniose tegumentar, por local provável de infecção, na população residente em um local e ano de referência.
- Os casos de leishmaniose tegumentar são codificados como B55.1 e B55.2 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos confirmados de leishmaniose tegumentar, numa determinada população em um intervalo de tempo determinado.
- Taxas elevadas de incidência de leishmaniose tegumentar refletem intensa exposição de indivíduos à picada de fêmeas de flebotomíneos infectados com protozoários do gênero *Leishmania*. São influenciadas por condições socioambientais propícias à proliferação dos flebotomíneos.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição dos casos incidentes confirmados de leishmaniose tegumentar, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença.
- Contribuir para a avaliação e orientação das medidas de controle dirigidas à população humana, ao vetor e aos cães.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas ao controle da leishmaniose tegumentar.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica e laboratorial, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de leishmaniose tegumentar.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções³.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁴.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados de leishmaniose tegumentar, em um local e ano de referência}}{\text{População residente em um local e no ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos incidentes confirmados de leishmaniose tegumentar, em um local provável de infecção e ano de referência.
- Denominador: População residente total estimada para o meio do ano, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁵.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, de 2014 a 2023, houve redução na taxa de incidência de leishmaniose tegumentar, de 10,11 para 6,10 casos por 100 mil habitantes, respectivamente. Existem diferenças marcantes na distribuição da doença entre as regiões. Em 2023, a região Norte apresentou taxa de 33,39 casos por 100 mil habitantes. No mesmo ano, as taxas (por 100 mil habitantes) nas demais regiões foram as seguintes: 12,13 no Centro-Oeste; 5,43 no Nordeste; 1,50 no Sudeste; e 0,69 no Sul. Entre as Unidades da Federação (UFs), destacam-se Acre (75,18), Amapá (58,19), Roraima (49,76) e Rondônia (42,18) com as maiores taxas (por 100 mil habitantes) em 2023, evidenciando importante concentração de casos na Região Amazônica. No Centro-Oeste, Mato Grosso apresentou taxa de 40,49 casos por 100 mil habitantes em 2023.

De forma geral, a leishmaniose tegumentar no Brasil apresenta padrão geográfico marcadamente regionalizado, com os maiores riscos de infecção concentrados na região Norte e em pontos do Centro-Oeste. A redução da taxa nacional, ao longo da última década, sugere avanços importantes no controle da doença, mas os níveis ainda elevados em certos estados evidenciam a necessidade de estratégias específicas, com foco territorial, para vigilância, diagnóstico precoce, tratamento oportuno e controle vetorial (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de leishmaniose tegumentar, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2014 a 2023

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brasil	10,11	9,58	6,22	8,54	7,96	7,45	7,86	7,15	6,11	6,10
Norte	61,01	51,86	30,93	46,62	44,09	38,30	42,94	37,82	34,19	33,39
Acre	126,30	127,98	104,15	121,02	100,29	106,19	117,06	121,38	86,98	75,18
Amapá	130,18	70,28	95,25	76,28	89,68	33,87	87,71	82,31	55,19	58,19
Amazonas	47,42	42,63	21,46	47,10	42,08	29,48	38,77	27,07	19,12	30,73
Pará	54,13	44,40	20,25	39,57	36,91	37,05	35,64	29,26	33,90	27,41
Rondônia	69,50	62,63	54,70	62,13	56,94	45,84	45,10	39,49	39,89	42,18
Roraima	88,94	87,39	24,44	34,93	55,15	33,81	35,73	75,12	57,91	49,76
Tocantins	43,33	40,10	16,43	14,08	15,28	26,16	30,37	26,54	19,52	20,42
Nordeste	9,05	9,33	6,10	8,12	7,19	6,00	5,57	6,57	5,86	5,43
Alagoas	0,57	5,66	1,25	0,78	0,81	2,74	1,31	2,14	1,18	0,62
Bahia	13,87	15,03	12,17	18,51	12,96	8,58	7,99	9,66	6,12	5,52
Ceará	6,00	6,30	4,05	4,07	3,79	5,18	6,24	6,92	4,65	7,18
Maranhão	30,99	24,65	13,32	15,22	20,12	16,25	15,33	17,80	24,06	17,59
Paraíba	0,72	1,91	0,58	0,95	1,10	2,03	1,85	0,86	0,44	1,60

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pernambuco	2,16	4,49	2,61	3,17	2,95	3,20	1,94	2,65	1,75	1,45
Piauí	2,62	1,81	1,10	1,37	1,18	0,99	0,84	1,76	2,29	3,59
Rio Grande do Norte	0,24	0,09	0,06	0,18	0,15	0,09	0,06	0,12	0,32	1,11
Sergipe	0,18	0,32	0,09	0,18	0,31	0,58	0,13	0,09	0,18	0,04
Sudeste	1,72	2,06	1,69	2,13	2,29	2,68	2,88	2,58	1,61	1,50
Espírito Santo	2,35	2,79	2,40	3,23	1,96	3,88	6,07	3,20	2,62	1,32
Minas Gerais	5,08	6,01	4,94	7,05	7,86	8,73	9,23	8,51	5,01	4,55
Rio de Janeiro	0,11	0,14	0,16	0,17	0,29	0,37	0,25	0,32	0,24	0,24
São Paulo	0,73	0,91	0,70	0,51	0,50	0,65	0,66	0,63	0,47	0,57
Sul	1,30	1,70	0,93	0,82	0,68	0,74	0,78	0,63	0,57	0,69
Paraná	3,18	4,31	2,25	1,86	1,61	1,74	1,83	1,39	1,12	1,28
Rio Grande do Sul	0,07	0,04	0,05	0,09	0,03	0,02	0,06	0,09	0,14	0,20
Santa Catarina	0,22	0,16	0,23	0,32	0,22	0,27	0,25	0,25	0,35	0,52
Centro-Oeste	20,00	19,06	13,64	16,51	14,31	16,19	16,57	11,45	9,73	12,13
Distrito Federal	1,30	1,61	1,17	1,33	1,01	0,83	1,51	1,26	1,19	1,18
Goiás	8,19	7,39	4,09	4,44	3,82	7,48	8,74	5,38	3,75	4,61
Mato Grosso	71,04	68,55	50,97	63,76	54,55	56,31	54,65	38,65	33,14	40,49
Mato Grosso do Sul	5,38	4,56	3,65	2,95	3,42	2,77	2,96	2,12	3,15	5,21

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
- Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
- Ministério da Saúde. Leishmaniose tegumentar americana. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente; 2023 [citado 15 de setembro de 2025]. p. 885–900. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_v2_6ed.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. RB.2.08 – Taxa de incidência de leishmaniose tegumentar [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637398



Morbidade



MRB.2.09 – Taxa de incidência de leishmaniose visceral

MRB.2.09 – Visceral leishmaniasis incidence rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de leishmaniose visceral, por local provável de infecção, na população residente em um local e ano de referência.
- Os casos de leishmaniose visceral são codificados como B55.0 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos confirmados de leishmaniose visceral, em um local e ano de referência.
- Taxas elevadas de incidência de leishmaniose visceral refletem intensa exposição de indivíduos à picada de fêmeas de flebotomíneos infectados com protozoários do gênero *Leishmania*. São influenciadas por condições socioambientais propícias à proliferação dos flebotomíneos e pela migração de populações humanas e caninas (o principal reservatório urbano é o cão) originárias de áreas endêmicas.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição dos casos incidentes confirmados de leishmaniose visceral, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença.
- Contribuir para a avaliação e orientação das medidas de controle dirigidas à população humana, ao vetor e aos cães.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas ao controle da leishmaniose visceral.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica e laboratorial, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de leishmaniose visceral.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções³.

- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁴.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados de leishmaniose visceral, em um local e ano de referência}}{\text{População residente, em um local e no ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos incidentes confirmados de leishmaniose visceral, em um local provável de infecção e ano de referência.
- Denominador: População total de residentes estimada para o meio do ano, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE**Faixa etária:**

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁵.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, de 2014 a 2024, houve redução na taxa de incidência de leishmaniose visceral, de 1,67, para 0,77 caso por 100 mil habitantes, respectivamente. Discreto pico de incidência foi observado no ano de 2017 (2,00 casos por 100 mil habitantes), seguido por um declínio progressivo do indicador ao longo dos anos subsequentes. Existem diferenças marcantes na distribuição da doença, com concentração nas regiões Norte e Nordeste, especialmente em alguns estados, como Tocantins, Maranhão e Piauí. A persistência de taxas de incidência elevadas em alguns locais reforça a necessidade de ações regionalizadas e integradas de controle da doença, especialmente naqueles com maior vulnerabilidade e transmissão ativa (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de leishmaniose visceral, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	1,67	1,59	1,53	2,00	1,68	1,22	0,92	0,80	0,80	0,69	0,77
Norte	2,37	2,76	3,35	4,68	4,42	2,78	1,85	1,60	1,41	1,30	1,29
Acre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23
Amapá	-	-	0,13	-	0,13	-	0,13	-	0,13	0,13	0,25
Amazonas	0,05	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,02	-	-	-	-
Pará	2,68	3,11	3,94	6,57	6,34	3,59	2,40	1,92	1,63	1,30	1,67
Rondônia	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	0,11	-
Roraima	2,69	2,81	6,20	6,21	2,89	1,94	2,34	2,75	2,08	2,01	2,93
Tocantins	11,74	14,14	15,21	16,35	15,74	12,00	7,54	7,10	6,74	7,15	4,50
Nordeste	3,99	3,51	2,96	3,59	3,54	2,55	1,96	1,65	1,59	1,35	1,68
Alagoas	1,32	1,29	0,72	1,38	3,22	2,03	1,87	1,71	0,96	0,71	0,47
Bahia	3,22	2,36	1,43	2,04	1,99	1,24	1,14	0,99	0,60	0,59	0,57
Ceará	6,10	5,19	3,60	3,82	3,82	3,26	2,16	2,06	2,39	2,69	2,51
Maranhão	5,93	6,75	8,52	9,49	9,17	5,50	4,71	3,59	3,37	2,24	4,39
Paraíba	1,23	1,09	0,71	1,08	1,10	1,11	0,62	0,61	0,88	0,82	0,53
Pernambuco	1,73	1,82	1,11	1,91	2,01	1,71	1,14	0,97	1,00	0,54	0,43
Piauí	11,88	8,72	7,43	8,67	6,54	4,85	3,60	2,48	2,53	2,38	4,53
Rio Grande do Norte	2,88	2,29	2,48	2,56	2,81	2,56	1,64	1,58	1,78	1,66	2,21
Sergipe	2,82	2,93	2,32	3,25	3,14	2,63	2,17	1,77	2,29	1,36	1,18
Sudeste	0,61	0,70	0,78	1,17	0,59	0,45	0,38	0,34	0,35	0,30	0,31
Espírito Santo	0,11	0,18	0,47	0,61	0,23	0,18	-	0,05	0,10	0,05	0,02
Minas Gerais	1,69	2,13	2,45	3,88	1,76	1,26	1,05	0,99	0,89	0,76	0,82

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rio de Janeiro	0,04	0,04	0,05	0,09	0,05	0,06	0,05	0,05	0,07	0,08	0,09
São Paulo	0,38	0,34	0,31	0,38	0,30	0,24	0,23	0,17	0,23	0,20	0,18
Sul	0,02	0,02	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,02	0,02	0,06	0,05
Paraná	0,02	0,04	0,12	0,04	0,08	0,06	0,02	0,02	0,01	0,05	0,11
Rio Grande do Sul	0,04	0,01	0,02	0,06	0,04	0,05	0,06	0,04	0,04	0,09	0,03
Santa Catarina	-	-	0,03	0,06	-	0,01	0,04	-	0,01	0,04	-
Centro-Oeste	1,59	1,33	1,38	1,58	1,04	1,16	0,87	0,91	1,20	0,98	0,83
Distrito Federal	1,52	1,22	1,70	1,68	0,90	1,07	0,55	0,71	0,30	0,24	0,27
Goiás	0,54	0,51	0,54	0,69	0,55	0,56	0,52	0,43	0,25	0,23	0,23
Mato Grosso	0,52	0,75	0,44	0,55	0,40	0,25	0,30	0,30	0,51	0,50	0,70
Mato Grosso do Sul	5,65	4,22	4,36	4,97	3,20	3,93	2,81	3,07	5,43	4,27	3,10

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
- Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/> doi:10.5281/zenodo.17990183
- Ministério da Saúde. Leishmaniose visceral. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente; 2023 [citado 15 de setembro de 2025]. p. 901–20. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_v2_6ed.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.09 – Taxa de incidência de leishmaniose visceral [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637427



Morbidade



MRB.2.10 – Taxa de incidência de toxoplasmose adquirida durante a gestação

MRB.2.10 – Incidence rate of toxoplasmosis acquired during pregnancy

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes de toxoplasmose adquirida durante a gestação, em gestantes residentes em um local e ano de referência.
- Os casos de toxoplasmose adquirida durante a gestação considerados são codificados como O98.6 (Doenças causadas por protozoários complicando a gravidez, o parto e o puerpério), P37.1 (Toxoplasmose congênita) e B58 (Toxoplasmose de mulher em idade fértil – 10 a 49 anos e gestante com ou sem idade gestacional especificada) na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos incidentes de toxoplasmose adquirida durante a gestação, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- A ocorrência de casos de toxoplasmose adquirida durante a gestação é um marcador de deficiências na qualidade da atenção ao pré-natal, e pode estar relacionada a falta de saneamento básico e acesso à água segura para consumo humano, consumo de frutas e verduras não higienizados adequadamente, consumo de carne crua ou malpassada, entre outros.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos confirmados de toxoplasmose adquirida durante a gestação, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a avaliação da qualidade da atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento da toxoplasmose adquirida durante a gestação.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica e laboratorial, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica da toxoplasmose em gestantes, parturientes, puérperas e em recém-nascidos.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².
- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)³.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes de toxoplasmose adquirida durante a gestação, em um local e ano de referência}}{\text{Número de gestantes na população residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos incidentes de toxoplasmose adquirida durante a gestação, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de gestantes na população residente, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 10 a 54 anos, de 5 em 5 anos.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Vigilância Epidemiológica do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DATHI/SVSA/MS).

NOTAS

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁴.

- Conforme indicado na Nota Técnica nº 133/2022-CGZV/DEDT/SVSA/MS⁵, que trata das informações que devem acompanhar a análise de dados das notificações de toxoplasmose adquirida na gestação e toxoplasmose congênita do Sinan nos canais de transparência ativa, destacam-se os aspectos a seguir.
 - › O período disponível para tabulação corresponde ao de pós-implantação da vigilância epidemiológica, ou seja, a partir de 2019. Não há dados que possam ser validados antes desse período.
 - › Considerou-se como notificação de toxoplasmose adquirida na gestação toda notificação com código da CID-10 "O98.6 – Doenças causadas por protozoários complicando a gravidez, o parto e o puerpério", "P37.1 – Toxoplasmose congênita" e "B58 – Toxoplasmose" de mulher em idade fértil (10 a 49 anos) e gestante (com ou sem idade gestacional especificada).
 - › Após três anos contados a partir do ano de notificação, o banco de dados é "congelado". Portanto, as alterações feitas localmente, após esse período, não serão consideradas para estatísticas nacionais (por exemplo, o banco de dados de 2020 foi congelado em 2023; assim, alterações feitas no banco de dados de 2020 foram consideradas se realizadas até 2022).

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, de 2019 a 2024, a taxa de incidência de toxoplasmose adquirida durante a gestação aumentou de 222,73 para 501,77 casos por 100 mil gestantes, respectivamente, um crescimento equivalente a 125,3%. Em 2024, a região Sul apresentou a maior taxa (686,16 casos por 100 mil gestantes), seguida pelas regiões Nordeste (561,37), Norte (480,67), Centro-Oeste (426,25) e Sudeste (413,11). Entre as Unidades da Federação (UFs), há concentração de casos em estados do Norte e do Centro-Oeste. Rondônia registrou a maior taxa de incidência de toxoplasmose em gestantes (1.049,92 casos por 100 mil gestantes), seguindo-se Rio Grande do Norte (966,90) e Tocantins (862,23). No Nordeste, destacaram-se o Rio Grande do Norte (966,90) e o Ceará (656,22), enquanto, no Sul, Rio Grande do Sul (843,84) e Santa Catarina (649,34) apresentaram as maiores taxas de incidência. O crescimento consistente e generalizado em todas as regiões, ao longo do período, pode indicar tanto o possível aumento na transmissão quanto a melhoria na vigilância epidemiológica e notificação dos casos (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de toxoplasmose em gestantes, por 100 mil gestantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2019 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	222,73	261,27	327,85	393,18	464,93	501,77
Norte	273,83	295,72	366,56	401,86	419,43	480,67
Acre	644,96	614,19	681,57	718,08	1.112,42	839,63
Amapá	6,51	41,00	366,84	389,28	223,97	438,06
Amazonas	82,45	115,03	138,93	170,99	183,10	228,96
Pará	88,19	130,89	246,48	207,81	263,97	409,05
Rondônia	1.224,66	953,56	766,54	939,72	1.032,57	1.049,92
Roraima	225,72	552,33	784,12	1.069,44	656,24	496,28
Tocantins	830,30	884,99	930,64	1.068,78	894,36	862,23

Brasil, regiões e UFs	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nordeste	183,79	212,41	312,89	421,31	537,64	561,37
Alagoas	170,67	165,49	290,94	358,53	541,43	585,44
Bahia	132,83	173,58	333,77	485,55	711,63	721,24
Ceará	282,54	366,68	535,48	512,88	686,82	656,22
Maranhão	154,43	163,09	167,48	262,34	309,65	374,30
Paraíba	123,05	173,82	194,47	212,21	384,23	401,00
Pernambuco	105,73	157,22	267,01	420,65	370,13	405,14
Piauí	173,16	174,67	210,97	492,34	360,67	382,90
Rio Grande do Norte	486,02	333,10	343,08	519,52	788,54	966,90
Sergipe	256,90	267,43	378,13	448,74	561,97	490,11
Sudeste	167,72	240,78	292,55	328,68	389,27	413,11
Espírito Santo	318,62	265,96	342,90	295,77	452,22	602,76
Minas Gerais	326,21	372,58	424,14	463,71	500,60	495,41
Rio de Janeiro	156,74	166,73	219,10	262,79	330,41	381,13
São Paulo	87,62	206,04	253,41	293,26	351,65	365,69
Sul	395,24	397,65	450,51	518,09	590,58	686,16
Paraná	435,92	427,91	472,62	477,83	524,19	577,74
Rio Grande do Sul	332,85	380,90	469,28	614,34	630,71	843,84
Santa Catarina	417,21	374,81	393,79	457,22	636,35	649,34
Centro-Oeste	261,74	251,22	286,89	374,01	420,06	426,25
Distrito Federal	146,15	231,19	186,67	217,10	188,46	273,42
Goiás	171,67	245,77	289,13	346,54	409,49	330,83
Mato Grosso	344,93	268,25	335,40	526,05	539,68	573,13
Mato Grosso do Sul	460,01	259,03	305,88	355,69	474,73	569,80

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Ministério da Saúde. Nascidos Vivos – desde 1994 [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>

4. Ministério da Saúde. Toxoplasmose adquirida na gestação e toxoplasmose congênita. Em: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de novembro de 2025]. p. 431–46. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao/view>
5. Ministério da Saúde. Nota técnica nº 133/2022-CGZV/DEDT/SVSA/MS – Trata-se de informações que devem acompanhar a análise de dados das notificações de toxoplasmose adquirida na gestação e toxoplasmose congênita do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) nos c... [Internet]. MS. 2022 [citado 10 de novembro de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-no-133-2022-cgzv-dedt-svsa-ms.pdf>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.10 – Taxa de incidência de toxoplasmose adquirida durante a gestação [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637435





MRB.2.11 – Taxa de incidência de toxoplasmose congênita

MRB.2.11 – Incidence rate of congenital toxoplasmosis

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes de toxoplasmose congênita, em relação ao número de nascidos vivos de gestantes residentes em um local e ano de referência.
- Os casos de toxoplasmose congênita são codificados como P37.1 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa o risco de ocorrência de casos novos de toxoplasmose congênita em um local e ano de referência.
- A ocorrência de casos de toxoplasmose congênita é um marcador de deficiências na qualidade da atenção ao pré-natal, relacionando-se também aos fatores de risco associados à infecção materna, que incluem falta de saneamento básico e acesso à água segura para consumo humano, consumo de frutas e verduras não higienizados adequadamente, consumo de carne crua ou malpassada, entre outros.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos incidentes de toxoplasmose congênita, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a avaliação da qualidade da atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas e ações de saúde direcionadas à assistência, ao diagnóstico de toxoplasmose na gestação e à prevenção e controle de doenças de transmissão vertical.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica e laboratorial, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica da toxoplasmose congênita.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².
- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)³.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes de toxoplasmose congênita, em um local e ano de referência}}{\text{Número de nascidos vivos de mães residentes, em um local e ano de referência}} \times 10.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos incidentes de toxoplasmose congênita, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de nascidos vivos de mães residentes, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 10.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE**Faixa etária:**

- 0 a 6 dias;
- 7 a 27 dias; e
- 28 a 364 dias.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Vigilância Epidemiológica do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DEDT/SVSA/MS).

NOTAS

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁴.
- Conforme indicado na Nota Técnica nº 133/2022-CGZV/DEDT/SVSA/MS⁵, que trata das informações que devem acompanhar a análise de dados das notificações de toxoplasmose adquirida na gestação e toxoplasmose congênita do Sinan nos canais de transparência ativa, podem-se destacar os aspectos delineados a seguir.

- › O período disponível para tabulação corresponde ao de pós-implantação da vigilância epidemiológica, ou seja, a partir de 2019. Não há dados que possam ser validados antes desse período.
- › Após três anos contados a partir do ano de notificação, o banco de dados é "congelado". Portanto, as alterações feitas localmente, após esse período, não serão consideradas para estatísticas nacionais (por exemplo, o banco de dados de 2020 foi congelado em 2023; assim, alterações feitas no banco de dados de 2020 foram consideradas se realizadas até 2022).

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, de 2019 a 2024, as taxas de incidência de toxoplasmose congênita aumentaram de 5,76 para 14,60 casos por 10 mil nascidos vivos. Em 2024, a maior taxa foi observada na região Norte (21,57 por 10 mil nascidos vivos), seguida pela região Sul (21,32). A região Centro-Oeste apresentou taxa de 17,55 por 10 mil nascidos vivos. Entre as Unidades da Federação (UFs), o Piauí exibiu a maior taxa (55,92 por 10 mil nascidos vivos), seguido por Roraima (43,84) e Tocantins (38,78). As regiões Sudeste e Nordeste exibiram as menores taxas de incidência de toxoplasmose congênita, 9,53 e 14,33 por 10 mil nascidos vivos, respectivamente. O crescimento das taxas e as variações, ao longo do período, podem refletir tanto o possível aumento na transmissão da doença quanto a melhoria na vigilância epidemiológica e notificação dos casos (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de toxoplasmose congênita, por 10 mil nascidos vivos. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2019 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	5,76	6,57	8,53	10,09	13,86	14,60
Norte	4,05	4,01	5,92	6,95	9,78	21,57
Acre	7,99	5,94	15,29	5,52	4,15	8,40
Amapá	0,00	0,00	3,66	8,08	13,90	15,41
Amazonas	1,55	1,06	1,27	1,38	3,69	3,64
Pará	0,87	0,83	1,68	1,95	1,74	27,58
Rondônia	8,51	8,92	12,58	10,44	14,63	24,87
Roraima	0,68	5,81	12,95	6,11	25,18	43,84
Tocantins	26,99	26,13	29,48	50,11	59,62	38,78
Nordeste	3,49	5,14	7,49	9,25	14,24	14,33
Alagoas	6,22	3,72	5,12	14,21	14,40	14,09
Bahia	1,06	3,33	5,01	6,27	9,57	9,37
Ceará	5,03	8,04	10,64	12,02	24,12	14,13
Maranhão	1,50	2,07	1,10	2,35	5,25	5,64
Paraíba	0,17	3,55	4,82	4,72	4,08	3,85
Pernambuco	3,30	5,68	12,60	11,41	22,90	16,24
Piauí	10,43	10,61	12,18	21,78	23,25	55,92
Rio Grande do Norte	8,86	10,57	13,59	10,24	7,61	23,76

Brasil, regiões e UFs	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sergipe	3,98	2,52	4,81	11,57	13,10	11,98
Sudeste	5,29	6,44	7,76	8,89	11,81	9,53
Espírito Santo	16,75	11,05	12,09	20,53	19,09	18,90
Minas Gerais	9,11	12,46	12,64	14,46	21,42	14,06
Rio de Janeiro	4,52	6,23	10,59	12,31	13,85	13,44
São Paulo	2,79	4,45	5,27	6,03	7,86	7,07
Sul	11,24	9,97	13,64	14,34	15,24	21,32
Paraná	9,77	9,16	8,66	10,59	12,80	14,65
Rio Grande do Sul	13,08	11,17	17,28	18,11	15,38	27,86
Santa Catarina	11,02	9,60	16,27	15,07	18,59	22,82
Centro-Oeste	8,96	9,81	10,79	15,16	24,23	17,55
Distrito Federal	8,72	11,69	12,09	15,31	18,28	17,13
Goiás	8,01	9,92	13,08	21,84	34,41	20,25
Mato Grosso	9,18	7,19	7,43	8,25	14,86	13,92
Mato Grosso do Sul	10,99	11,38	9,25	10,13	19,88	16,88

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Ministério da Saúde. Nascidos Vivos – desde 1994 [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>
- Ministério da Saúde. Toxoplasmose adquirida na gestação e toxoplasmose congênita. Em: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: MS; 2024 [citado 10 de novembro de 2025]. p. 431–46. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao/view>
- Ministério da Saúde. Nota técnica nº 133/2022-CGZV/DEDT/SVSA/MS – Trata-se de informações que devem acompanhar a análise de dados das notificações de toxoplasmose adquirida na gestação e toxoplasmose congênita do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) [Internet]. MS. 2022 [citado 10 de novembro de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-no-133-2022-cgzv-dedt-svsa-ms.pdf>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.11 – Taxa de incidência de toxoplasmose congênita [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637458



Morbidade



MRB.2.12 – Taxa de incidência parasitária anual de malária

MRB.2.12– Annual parasitic incidence rate of malaria

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de exames positivos de malária por população, no local provável de infecção e ano de diagnóstico de referência.
- Os casos de malária são codificados como B50 a B53 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude, a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de exames positivos de malária, numa determinada população, em um local e ano de referência.
- Taxas elevadas podem advir de diversos fatores, entre eles: (i) migrações internas decorrentes de implantação de assentamentos rurais; (ii) atividades econômicas extrativas; (iii) implantação de grandes empreendimentos econômicos, como a abertura de rodovias e a construção de hidrelétricas; (iv) garimpos ilegais; e (v) expansão urbana relacionada a crescimento populacional em áreas periurbanas e aldeias indígenas.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição da incidência parasitária de malária, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença, em um local e ano de referência.
- Identificar áreas de maior risco da positividade para malária e explorar os determinantes sociais e ambientais envolvidos na produção da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas interdisciplinares e ações de saúde direcionadas à prevenção da malária, incluindo-se diagnóstico, tratamento e acompanhamento clínico dos casos da doença.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar e investigar os exames positivos de malária.
- O indicador utiliza para o seu cálculo o número de exames positivos, e não o número de casos de malária, o que pode resultar em duplicidade de registro, tendo em vista que o paciente costuma realizar mais de um exame durante o período de adoecimento, a fim de verificar a eficácia do tratamento.
- Abrange o conjunto de formas clínicas de malária, sem identificar as espécies de plasmódio circulantes, que têm significação distinta na dinâmica de transmissão, no tratamento e na evolução da doença.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica – Malária (Sivep-Malária)².
- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)³.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁴.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁵.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\sum x}{y} \times 1.000$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de x número de exames positivos de malária, em um local provável de infecção e ano de diagnóstico de referência – exceto as lâminas de verificação de cura (LVCs), por estarem relacionadas a recidivas (recrudescências e recaídas) –, e y significa a população total residente estimada para o mesmo local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número total de exames positivos de malária, em um local provável de infecção e ano de diagnóstico de referência, exceto as LVCs, por estarem relacionadas a recidivas (recrudescências e recaídas).
- Denominador: População total residente estimada para a metade do ano, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 1.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Resultado por espécie parasitária:

- *Plasmodium vivax*;
- *P. falciparum*;
- *P. malariae*;
- *P. ovale*;
- Mista e
- Espécie não identificada.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Vigilância Epidemiológica do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país².

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, as taxas de incidência da positividade parasitária da malária apresentam padrões bastante distintos se analisados os estados da Região Amazônica e da Região Extra-Amazônica. Na Região Amazônica (área endêmica), todos os estados apresentam transmissão persistente da malária no período analisado. Destaca-se o estado do Acre, que apresentou redução importante de 38,05 para 6,26 casos de malária por mil habitantes, de 2014 para 2024, e, por outro lado, o estado de Roraima, que apresentou incremento de 11,02 para 42,81 casos de malária por mil habitantes, no mesmo período (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência da positividade parasitária da malária, por mil habitantes. Regiões Amazônica e Extra-Amazônica e Unidades da Federação (UFs), 2014 a 2024

Região Amazônica	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Acre	38,05	32,30	41,16	42,65	30,30	14,90	13,48	9,74	7,04	5,94	6,26
Amapá	17,50	17,53	15,37	18,93	18,53	12,77	4,21	5,14	3,53	6,13	6,38
Amazonas	17,65	19,30	12,78	20,88	18,29	16,05	14,31	14,72	13,27	13,83	14,98
Maranhão	0,09	0,03	0,02	0,05	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Mato Grosso	0,30	0,36	0,17	0,17	0,29	0,64	1,00	1,17	0,44	0,30	0,30
Pará	1,43	1,18	1,81	4,49	5,57	3,90	2,90	2,39	2,78	2,77	2,81
Rondônia	5,82	4,07	4,06	4,00	4,55	5,58	6,85	8,33	7,22	6,79	4,45
Roraima	11,02	11,59	10,46	19,87	31,26	32,98	45,93	39,80	39,11	49,76	42,81
Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Extra-Amazônica	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espírito Santo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mato Grosso do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Região Extra-Amazônica	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio Grande do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

- Dados originados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica – Malária (Sivep-Malária)²; Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)³ e e-SUS VS foram atualizados em outubro de 2025.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde (BR). Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica – Malária [Internet]. Brasília: MS; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/sivep-malaria>
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
- Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.12 – Taxa de incidência parasitária anual de malária. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637481



Morbidade



MRB.2.13 – Taxa de incidência de dengue

MRB.2.13 – Dengue incidence rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos prováveis de dengue, em relação à população residente em um local e ano de referência.
- Inclui casos novos de dengue clássica, dengue com sinais de alarme e dengue grave, notificados conforme os códigos A90 e A91 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a frequência com que casos novos de dengue surgem em uma população e ano de referência.
- Mensura o risco, ou probabilidade, de adoecer por dengue, mensurado pelo surgimento de casos prováveis de dengue na população.
- A ocorrência de casos prováveis de dengue indica a persistência de fatores favoráveis à transmissão do vírus, especialmente em áreas com elevada infestação do mosquito vetor e presença de população suscetível à infecção.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos prováveis de dengue, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas intersetoriais e ações de saúde para a prevenção, vigilância e atenção à saúde, nos locais onde há ocorrência de dengue.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica e laboratorial, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para confirmação dos casos de dengue.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².

- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções³.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁴.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\sum x}{\sum y} \times 100.000$$

Nota:

- Na fórmula, x é o número de casos prováveis de dengue (todas as formas), em um local e ano de referência, e y é a população residente em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos prováveis de dengue (todas as formas), em um local de residência e ano de referência.
- Denominador: População residente em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE**Cor ou raça:**

- Branca,
- Preta,
- Amarela,
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Faixa etária:

- 0 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância das Arboviroses do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGARB/DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁵.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

As taxas de incidência anuais de casos prováveis de dengue no Brasil, no período de 2014 a 2024, variaram amplamente, com valores entre 1,14 e 9.316,56 casos por 100 mil habitantes, refletindo surtos esporádicos e desigualdades regionais marcantes. A região Sudeste – especialmente os estados de Minas Gerais e São Paulo – concentrou algumas das maiores taxas observadas. Em 2024, por exemplo, Minas Gerais registrou uma taxa de 7.778,14, enquanto São Paulo alcançou 4.745,97 casos por 100 mil habitantes, sendo esse ano marcado por uma epidemia da doença no Brasil.

Por sua vez, a região Sul, tradicionalmente com baixas incidências, apresentou crescimento a partir de 2019. A maior taxa registrada no período foi registrada no Distrito Federal, com impressionantes 9.316,56 casos por 100 mil habitantes em 2024, evidenciando um surto localizado de grande magnitude.

A elevada incidência de dengue na região Sudeste pode ser explicada por uma combinação de fatores climáticos (temperaturas elevadas e alta pluviosidade), densidade populacional elevada, urbanização acelerada e condições propícias para a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*. Além disso, a circulação simultânea de diferentes sorotipos do vírus da dengue, juntamente com a baixa adesão da população às medidas de prevenção, contribuiu para a intensificação dos surtos, especialmente em anos como 2024 (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de dengue*, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	293,40	834,46	720,02	116,66	127,15	743,39	453,50	253,20	666,28	777,19	3.087,52
Norte	284,16	182,20	216,26	122,90	97,82	197,40	130,00	222,83	273,34	187,82	304,83
Acre	3.466,23	643,30	258,16	215,51	839,22	1.154,42	888,66	1.723,28	390,11	815,44	711,65
Amapá	297,60	441,34	236,61	116,12	96,53	23,09	7,77	35,40	36,83	153,92	1.331,65
Amazonas	175,38	98,26	190,90	98,05	58,11	94,64	145,18	200,14	129,53	149,79	202,89
Pará	55,92	95,91	130,02	94,00	44,76	64,19	41,72	60,28	71,47	68,22	243,00
Rondônia	120,17	132,58	459,80	124,85	31,08	57,05	228,59	134,13	822,76	616,35	300,59
Roraima	215,73	204,91	37,76	50,18	18,55	256,42	76,13	17,71	8,91	33,66	98,35
Tocantins	250,79	536,49	516,02	324,78	185,02	890,27	123,61	618,33	1.329,69	207,06	269,95

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nordeste	163,84	592,69	571,22	150,01	117,29	377,93	264,68	230,46	428,38	184,75	605,02
Alagoas	415,65	852,80	564,07	91,20	68,50	652,29	72,51	236,78	1.046,02	148,05	556,01
Bahia	95,94	381,52	454,90	66,57	65,55	460,03	562,46	169,72	242,66	321,62	1.565,09
Ceará	259,82	715,86	556,15	438,18	45,94	179,79	264,81	388,43	466,96	157,26	135,94
Maranhão	39,10	116,26	344,31	103,51	30,87	81,49	36,77	19,58	102,83	71,44	161,97
Paraíba	143,98	595,70	891,66	95,59	269,58	465,13	164,53	393,91	703,94	175,30	351,77
Pernambuco	114,58	1.203,64	642,71	83,65	119,13	402,01	212,61	384,89	169,63	83,66	233,04
Piauí	236,11	234,81	158,36	159,51	57,75	240,28	66,31	119,39	941,51	225,11	447,29
Rio Grande do Norte	348,60	683,32	1.691,09	218,41	697,67	935,82	201,96	112,33	1.228,60	223,44	507,16
Sergipe	104,24	418,88	153,30	26,35	10,28	265,96	81,85	33,73	228,98	126,29	83,67
Sudeste	367,01	1.224,92	966,13	60,88	82,76	1.161,19	340,92	207,99	523,93	1.051,73	4.829,01
Espírito Santo	497,64	924,35	1.071,77	172,41	257,88	1.619,90	182,28	0,79	273,72	3.343,053	334,07
Minas Gerais	285,96	941,72	2.539,03	125,40	139,22	2.280,16	389,63	105,52	421,94	1.913,24	7.778,14
Rio de Janeiro	45,70	432,70	499,26	63,05	86,05	185,77	25,79	16,53	64,46	290,19	1.754,98
São Paulo	516,96	1.686,15	408,42	20,54	40,15	974,56	451,57	345,90	766,22	734,72	4.745,97
Sul	79,83	177,81	239,05	8,52	5,68	161,45	920,64	213,26	1.005,44	1.261,08	3.880,86
Paraná	206,29	410,18	552,96	19,19	12,15	3.90,51	2.278,09	298,55	1.336,99	1.782,95	5.478,40
Rio Grande do Sul	1,39	15,33	28,26	1,58	1,14	14,86	35,58	96,88	599,72	344,90	2.001,45
Santa Catarina	2,07	64,46	71,83	2,49	2,52	28,30	156,55	254,30	1.092,361	784,28	4.155,75
Centro-Oeste	764,57	1.500,11	1.353,99	499,63	661,80	1.444,68	1.200,88	678,27	2.034,85	1.100,08	3.949,87
Distrito Federal	421,76	352,58	625,66	138,44	84,13	1.324,58	1.614,90	555,61	2.378,82	1.376,36	9.316,56
Goiás	1.437,01	2.525,09	1.910,97	932,99	1.317,05	1.714,99	890,08	893,94	2.894,59	978,86	4.551,52
Mato Grosso	218,69	648,59	589,98	268,81	206,35	309,29	965,29	609,82	950,21	757,04	1.119,83
Mato Grosso do Sul	130,84	1.215,33	1.687,60	84,51	201,99	2.343,44	1.854,92	350,89	923,98	1.571,95	650,92

- Notas:**
- *Casos prováveis de dengue.
 - Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.

2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>

3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

4. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
5. Ministério da Saúde. Dengue, chikungunya e Zika. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 5 de agosto de 2025]. p. 727–82. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.13 – Taxa de incidência de dengue [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi:10.5281/zenodo.18637496



Morbidade



MRB.2.14 – Taxa de incidência de dengue grave

MRB.2.14 – Severe dengue incidence rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos confirmados de dengue com sinais de alarme e dengue grave, em relação à população residente em um local e ano de referência.
- Inclui casos novos confirmados de dengue com sinais de alarme e dengue grave, notificados conforme os códigos A90 e A91 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a frequência com que casos novos de dengue com sinais de alarme e dengue grave surgem em uma população e ano de referência.
- Mensura o risco, ou probabilidade, de adoecer por dengue com sinais de alarme e dengue grave, mensurado pelo surgimento de casos prováveis de dengue na população.
- A ocorrência de casos de dengue com sinais de alarme e dengue grave indica a persistência de fatores favoráveis à transmissão do vírus, especialmente em áreas com elevada infestação do mosquito vetor e presença de população suscetível à infecção.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos confirmados de dengue com sinais de alarme e dengue grave, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas intersetoriais e ações de saúde para a prevenção, vigilância e atenção à saúde nos locais onde há ocorrência de dengue com sinais de alarme e dengue grave.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de dengue.
- Devido à semelhança dos sintomas iniciais da dengue com sinais de alarme e formas graves em relação a outras enfermidades febris agudas, há maior probabilidade de confusão diagnóstica, o que pode resultar em subnotificação e atraso no manejo adequado dos casos.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções³.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁴.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\sum x}{\sum y} \times 100.000$$

Nota:

- Na fórmula, x é o número de casos confirmados de dengue (com sinais de alarme e grave), em um local e ano de referência, e y é a população residente em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos confirmados de dengue com sinais de alarme e dengue grave, em um local de residência e ano de referência.
- Denominador: População residente em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância das Arboviroses do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGARB/DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁵.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

As taxas de incidência anuais de casos confirmados de dengue com sinais de alarme e dengue grave no Brasil, no período de 2014 a 2024, apresentaram variações consideráveis entre regiões e Unidades da Federação (UFs), refletindo surtos pontuais e desigualdades regionais marcantes. As taxas oscilaram de valores próximos de zero até 410,85 casos por 100 mil habitantes, como observado no Distrito Federal, no ano de 2024.

A região Centro-Oeste destacou-se, com algumas das maiores taxas ao longo do período. O Distrito Federal registrou aumento expressivo, atingindo 410,85, em 2024, o maior valor de toda a série. O estado de Goiás apresentou elevações relevantes, especialmente com 58,44, em 2015, e 118,18, em 2024.

No Nordeste, embora as taxas tenham sido geralmente mais baixas, houve picos localizados, como os que se registraram em Sergipe (25,12, em 2019), em Alagoas (19,63, em 2019), e na Bahia (46,03, em 2024), demonstrando surtos concentrados no tempo e no espaço.

Na região Norte, surtos importantes foram observados no Tocantins (28,59, em 2019; e 19,97, em 2022), e no Acre, que apresentou aumento expressivo a partir de 2018, atingindo 23,95 em 2021. Outros estados, como Amapá (48,70, em 2024) e Roraima (6,31, em 2019), também registraram elevações pontuais.

A região Sudeste, frequentemente associada às maiores incidências de dengue clássica, também apresentou elevações na incidência da dengue com sinais de alarme e dengue grave. O Espírito Santo teve pico expressivo com 89,89, em 2023, além de 63,16 em 2024. Minas Gerais destacou-se (com 79,90, em 2024), e São Paulo apresentou 62,33 em 2024, demonstrando surtos importantes.

A região Sul, historicamente com baixas taxas, passou a registrar aumentos a partir de 2019. O Paraná atingiu 118,11, em 2024, enquanto Santa Catarina, que mantinha taxas quase nulas até 2018, chegou a 82,55 casos por 100 mil habitantes em 2024. O Rio Grande do Sul também apresentou elevação, atingindo 27,23 em 2024.

Essas variações refletem fatores como condições climáticas favoráveis à proliferação dos mosquitos vetores, urbanização rápida, alta densidade populacional, falhas nas ações de controle vetorial e a circulação simultânea de diferentes sorotipos do vírus da dengue. Além disso, a subnotificação e a sensibilidade das redes de vigilância podem impactar os registros, especialmente nas formas mais graves da doença (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de dengue grave*, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2014 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	4,68	11,70	5,11	1,58	2,47	10,50	4,98	2,56	9,71	11,97	51,84
Norte	0,77	0,98	0,72	0,87	0,88	3,21	1,46	3,09	4,49	2,10	5,88
Acre	2,70	0,24	-	0,12	1,64	9,09	11,58	23,95	8,02	3,54	4,66
Amapá	1,90	6,43	2,77	1,70	0,52	0,13	-	0,13	0,38	1,00	48,70
Amazonas	0,39	0,31	0,33	0,40	0,32	0,22	1,02	1,73	1,48	1,46	2,52

Brasil, regiões e UFs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pará	0,37	0,64	0,55	0,15	0,14	0,12	0,25	0,35	0,53	0,42	5,02
Rondônia	0,67	1,14	1,37	0,30	0,24	0,18	1,16	0,75	19,25	9,19	2,12
Roraima	0,96	1,87	0,55	0,18	0,51	6,31	2,96	0,46	0,15	0,29	0,98
Tocantins	2,33	1,77	1,01	7,01	7,08	28,59	3,38	15,30	19,97	5,81	4,95
Nordeste	2,35	2,82	1,12	0,65	1,69	8,02	1,79	2,45	5,20	3,90	16,61
Alagoas	8,64	4,02	0,85	0,53	1,59	19,63	2,77	11,22	11,84	2,11	18,94
Bahia	1,00	0,57	0,16	0,13	0,22	12,94	2,69	0,45	2,28	8,73	46,03
Ceará	3,41	9,16	2,82	1,50	0,28	1,89	3,19	6,94	3,00	2,48	2,22
Maranhão	1,22	1,45	0,74	0,81	0,67	2,72	0,75	0,34	4,30	2,50	3,88
Paraíba	4,79	2,57	1,64	0,65	4,17	5,23	0,27	1,49	5,28	0,82	4,68
Pernambuco	0,85	1,99	0,92	0,70	1,22	3,91	0,64	1,13	1,88	0,83	2,74
Piauí	1,23	2,03	0,46	0,30	0,24	6,02	1,35	2,75	18,23	2,61	23,11
Rio Grande do Norte	5,00	2,47	3,08	0,95	14,72	8,31	1,50	1,23	13,74	2,71	5,86
Sergipe	0,88	0,32	0,09	0,09	0,27	25,12	0,67	0,18	8,00	7,23	5,46
Sudeste	7,61	19,55	5,25	0,58	0,93	11,81	3,42	1,28	5,20	12,51	60,38
Espírito Santo	11,20	22,90	15,14	4,46	12,37	62,24	6,57	-	6,79	89,89	63,16
Minas Gerais	3,54	5,79	10,68	0,72	0,79	15,53	1,80	0,33	3,35	10,90	79,90
Rio de Janeiro	0,71	3,13	2,69	0,53	0,33	0,40	0,11	0,13	1,27	8,24	30,35
São Paulo	11,84	31,93	2,87	0,21	0,22	10,00	5,14	2,15	7,39	7,99	62,33
Sul	1,22	2,84	2,58	0,06	0,11	2,87	10,80	2,10	16,64	27,90	76,10
Paraná	3,18	6,31	5,81	0,11	0,21	7,34	27,25	3,15	26,74	31,97	118,11
Rio Grande do Sul	0,01	0,10	0,37	0,01	0,01	0,10	0,25	1,02	3,46	5,25	27,23
Santa Catarina	0,01	1,64	0,91	-	-	0,12	1,29	2,10	20,48	53,93	82,55
Centro-Oeste	7,57	28,67	27,78	13,26	18,69	34,34	17,29	9,72	41,83	17,99	131,42
Distrito Federal	6,04	3,86	17,71	3,75	0,97	33,76	28,48	8,75	50,74	24,30	410,85
Goiás	13,56	58,44	52,18	28,37	41,71	49,26	16,32	12,34	63,27	17,05	118,18
Mato Grosso	0,76	2,46	0,74	0,55	0,66	3,89	12,29	8,21	14,27	14,69	25,36
Mato Grosso do Sul	2,75	13,27	11,32	1,44	2,44	36,44	14,50	6,07	14,47	18,21	17,95

Notas:

- *Dengue com sinais de alarme e dengue grave.
- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.

2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>

3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
4. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
5. Ministério da Saúde. Dengue, chikungunya e Zika. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 5 de agosto de 2025]. p. 727–82. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.14 – Taxa de incidência de dengue grave [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637514



Morbidade



MRB.2.15 – Taxa de incidência de chikungunya

MRB.2.15 – Chikungunya incidence rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos prováveis de chikungunya, em relação à população residente em um local e ano de referência. Inclui casos de chikungunya, notificados conforme o código A92 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a frequência com que casos novos de chikungunya surgem em uma população e ano de referência.
- Mensura o risco, ou probabilidade, de adoecer por chikungunya, mensurado pelo surgimento de casos prováveis dessa doença na população.
- A ocorrência de novos casos indica a persistência de fatores favoráveis à transmissão do vírus de chikungunya, em especial a existência de criadouros do mosquito vetor e a exposição de populações suscetíveis ao vírus.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos de chikungunya, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Investigar e identificar grupos populacionais mais expostos e fatores de risco para a chikungunya, oferecendo subsídios para a elaboração de estratégias de controle.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas intersetoriais e ações de saúde para a prevenção, vigilância e atenção à saúde, nos locais onde há ocorrência de chikungunya.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de chikungunya.
- Pode apresentar subnotificação, devido a dificuldades para identificação das formas clínicas leves e a diagnóstico diferencial prejudicado, em virtude da circulação de outros vírus com sintomatologia semelhante.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções³.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁴.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\sum x}{\sum y} \times 100.000$$

Nota:

- Na fórmula, x é o número de casos prováveis de chikungunya, em um local e ano de referência, e y é a população residente em um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos prováveis de chikungunya, em um local e ano de referência.
- Denominador: População residente em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância das Arboviroses do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGARB/DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁵.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

As taxas de incidência anual de casos prováveis de chikungunya no Brasil, entre os anos de 2017 e 2024, variaram de 0,38 a 1.277,89 casos por 100 mil habitantes. Os valores expressivos concentraram-se principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. A região Nordeste concentrou as maiores taxas de incidência ao longo do período analisado, com destaque para os estados do Ceará – que apresentou a maior taxa registrada em todo o país no ano de 2017 (1.277,89 casos por 100 mil habitantes), e 569,49 em 2022 –, Paraíba (461,44, em 2022), Rio Grande do Norte (401,89, em 2019) e Alagoas (340,11, em 2022).

Na região Centro-Oeste, destaca-se o estado de Mato Grosso, que atingiu 762,72 casos por 100 mil habitantes em 2018 e 568,50 em 2024, enquanto Mato Grosso do Sul apresentou aumento expressivo em 2023, com taxa de 93,64. Na região Norte, Roraima registrou uma das maiores taxas do país em 2017 (707,25), vindo em seguida o Pará (184,81, em 2018), e Tocantins (290,52, em 2023).

A região Sudeste apresentou um padrão com aumento significativo a partir de 2023, com picos importantes, como se verificou em Minas Gerais, em 2023 e 2024, com taxas de 473,84 e 782,15, respectivamente, e no Rio de Janeiro, em 2018 e 2019, com taxas de 467,98 e 503,95, respectivamente. Já a região Sul manteve-se com as menores taxas ao longo da série histórica, com valores que não ultrapassaram 16,06 casos por 100 mil habitantes.

O aumento das taxas a partir de 2017 pode estar relacionado à circulação estabelecida do vírus chikungunya no país, à baixa imunidade da população, à ampla presença do vetor *Aedes aegypti*, às condições climáticas favoráveis, à rápida disseminação em áreas urbanas densamente povoadas e à circulação simultânea de outros arbovírus. Esses fatores, aliados a desafios contínuos em termos de vigilância e controle, contribuíram para a consolidação da chikungunya como um problema de saúde pública relevante no Brasil (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de chikungunya*, por 100 mil habitantes.
Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2017 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	90,44	83,91	63,39	35,01	38,49	83,44	74,78	123,95
Norte	93,65	95,11	22,34	3,73	4,64	26,77	29,50	14,31
Acre	12,55	66,24	7,81	7,64	23,95	7,56	6,84	30,21
Amapá	28,61	45,55	3,72	1,27	9,61	3,77	6,13	36,87
Amazonas	6,23	3,78	2,26	0,90	2,93	4,07	5,73	2,43
Pará	104,69	184,81	41,69	4,65	1,36	3,64	5,52	11,32
Rondônia	12,06	7,05	6,01	6,09	4,22	9,92	3,45	13,06
Roraima	707,25	11,23	6,63	1,56	7,63	15,00	3,74	5,72
Tocantins	204,20	16,34	11,67	3,51	13,11	261,56	290,52	47,87

Brasil, regiões e UFs	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nordeste	255,15	39,29	60,31	104,56	84,85	260,99	59,03	51,57
Alagoas	14,94	12,19	55,51	5,54	16,38	340,11	27,12	13,23
Bahia	61,83	51,19	75,27	276,76	68,22	126,14	105,08	112,51
Ceará	1.277,89	33,71	14,22	12,04	14,44	569,49	23,15	11,71
Maranhão	92,42	19,66	10,90	3,03	2,60	32,55	42,28	14,19
Paraíba	43,68	49,70	41,14	49,05	226,68	461,44	34,77	41,47
Pernambuco	19,21	23,23	27,51	57,24	212,88	175,50	26,53	45,19
Piauí	194,23	37,07	26,62	5,79	6,81	321,98	127,90	26,01
Rio Grande do Norte	59,18	126,44	401,89	158,73	96,42	406,22	66,21	84,12
Sergipe	17,99	3,32	13,07	168,79	134,93	173,25	67,88	18,99
Sudeste	26,27	122,29	105,78	13,85	34,90	18,10	124,94	219,49
Espírito Santo	21,00	33,07	47,93	108,39	289,56	27,89	128,58	297,67
Minas Gerais	78,86	112,85	12,81	16,78	23,85	59,46	473,84	782,15
Rio de Janeiro	27,23	467,98	503,95	21,57	2,69	4,04	8,49	26,95
São Paulo	2,08	2,88	2,66	1,26	29,70	3,38	6,67	23,67
Sul	0,93	1,43	1,31	1,84	1,32	2,27	7,45	4,12
Paraná	1,39	2,06	1,92	3,61	0,94	2,59	16,06	6,77
Rio Grande do Sul	0,57	0,88	0,64	0,45	2,37	2,08	1,71	3,12
Santa Catarina	0,76	1,29	1,38	1,21	0,38	2,06	2,79	1,64
Centro-Oeste	24,72	172,74	6,26	4,46	4,71	35,81	38,34	208,46
Distrito Federal	4,56	4,59	7,45	4,76	3,81	19,51	23,02	14,55
Goiás	2,51	5,14	1,55	0,76	6,53	62,06	37,84	148,43
Mato Grosso	100,55	762,72	14,56	9,55	2,73	6,42	9,21	568,50
Mato Grosso do Sul	5,67	19,30	6,27	6,88	3,60	24,77	93,64	83,84

- Notas:**
- *Casos prováveis de chikungunya.
 - Dados sujeitos a revisão. Atualizados em abril de 2025.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

4. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
5. Ministério da Saúde. Dengue, chikungunya e Zika. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 5 de agosto de 2025]. p. 727–82. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.15 – Taxa de incidência de chikungunya [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637534



Morbidade



MRB.2.16 – Taxa de incidência de Zika

MRB.2.16 – Zika incidence rate

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos confirmados de Zika, em relação à população residente em um local e ano de referência. Inclui casos de Zika, notificados conforme o código U06 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a frequência com que casos confirmados de Zika surgem em uma população e ano de referência.
- Mensura o risco, ou probabilidade, de adoecer por Zika, mensurado pelo surgimento de casos confirmados dessa doença na população.
- A ocorrência de casos confirmados indica a persistência de fatores favoráveis à transmissão do vírus Zika, em especial a existência de criadouros do mosquito vetor e a exposição de populações suscetíveis ao vírus.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos confirmados de Zika, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença.
- Investigar e identificar grupos populacionais mais expostos e fatores de risco para Zika, oferecendo subsídios para a elaboração de estratégias de controle.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas interdisciplinares e ações de saúde direcionadas para a promoção da prevenção e do tratamento de Zika e de outras doenças transmitidas pelo *Aedes aegypti*.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância em saúde epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de casos de Zika.
- Demanda atenção na análise de séries históricas, já que, em situações epidêmicas, sobretudo durante epidemias de dengue, os casos leves e moderados de Zika – que constituem a maioria das ocorrências – tendem a ser confirmados somente em base clínico-epidemiológica, o que pode gerar subnotificação da doença, em decorrência da similaridade dos sintomas com os da dengue. Além disso, podem ocorrer reações cruzadas nos testes sorológicos, levando a diagnósticos incorretos ou confusos.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções³.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁴.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\sum x}{\sum y} \times 100.000$$

Nota:

- Na fórmula, x é o número de casos confirmados de Zika, em um local e ano de referência, e y é a população residente no local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos confirmados de Zika, em um local e ano de referência.
- Denominador: População residente em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância das Arboviroses do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGARB/DEDT/SVSA/MS).

NOTA

- A definição de caso baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁵.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

As taxas de incidência anual de casos confirmados de Zika no Brasil, em 2016 e 2024, variaram de 0,00 a 460,08 casos por 100 mil habitantes. A introdução do vírus no país gerou um aumento abrupto nas notificações a partir de 2015, com pico em 2016, quando diversas regiões apresentaram valores elevados. A região Centro-Oeste concentrou algumas das maiores taxas, especialmente o estado de Mato Grosso, que atingiu 460,08 casos por 100 mil habitantes em 2016. Goiás e Mato Grosso do Sul também registraram valores expressivos nesse ano, com 119,23 e 62,91, respectivamente.

Na região Nordeste, alguns estados se destacaram com elevações pontuais, como a Bahia, com 166,23 em 2016; Alagoas, com 122,43 no mesmo ano; e o Rio Grande do Norte, que apresentou 20,71 em 2022. A Paraíba também registrou alta taxa em 2021, com 35,72.

Na região Norte, Tocantins apresentou taxa elevada em 2016 (119,76) e novamente em 2023 (8,30), enquanto Roraima registrou a maior taxa de sua região em 2017 (34,93). Outros estados nortistas, como Acre, Amazonas e Amapá, apresentaram variações significativas, com destaque para o Amazonas em 2016 (107,88) e o Acre em 2021 (29,14).

A região Sudeste teve aumento expressivo em 2016, com destaque para o estado do Rio de Janeiro, que registrou 294,18 casos por 100 mil habitantes naquele ano. Espírito Santo (56,94) e Minas Gerais (46,13) também apresentaram picos em 2016, seguidos de redução nos anos seguintes. O estado de São Paulo manteve as taxas mais baixas em todo o período.

A região Sul teve as menores taxas de incidência ao longo da série histórica, com destaque para o Paraná, que apresentou 3,45 em 2016, ainda assim muito inferior aos valores das demais regiões.

O padrão observado nas taxas de incidência de Zika indica que a epidemia teve um caráter explosivo no ano de 2016 após sua introdução no Brasil. Fatores como ausência de imunidade populacional, ampla distribuição do vetor *Aedes aegypti*, dificuldades iniciais de diagnóstico e vigilância, além das incertezas associadas às complicações neurológicas e à microcefalia, contribuíram para o aumento expressivo dos casos confirmados, principalmente em regiões com menor infraestrutura de saúde pública (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência de Zika*, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2016 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	67,74	4,53	2,07	2,16	1,45	2,06	1,68	2,14	1,02
Norte	58,45	7,84	3,44	2,16	1,93	3,23	2,31	3,13	1,55
Acre	10,76	0,83	10,22	3,50	4,86	29,14	0,46	11,52	5,56
Amapá	50,99	0,91	1,94	1,41	0,13	6,20	2,51	2,00	1,99
Amazonas	107,88	9,83	7,86	1,37	1,12	2,45	5,52	5,21	1,80
Pará	36,32	3,83	0,91	0,54	2,08	0,28	0,47	0,17	0,32
Rondônia	33,45	4,02	2,00	3,33	4,12	2,89	1,50	2,30	4,29

Brasil, regiões e UFs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Roraima	30,46	34,93	1,53	3,56	0,47	4,27	0,59	8,20	3,21
Tocantins	119,76	26,29	4,90	11,02	0,72	5,42	6,36	8,30	1,33
Nordeste	64,12	4,01	1,68	2,78	3,24	5,46	4,51	3,05	2,48
Alagoas	122,43	5,32	4,12	15,71	3,58	5,07	18,36	1,86	1,96
Bahia	166,23	6,27	2,08	2,80	4,88	4,21	4,69	6,93	3,58
Ceará	26,18	6,90	0,42	0,32	1,83	2,02	0,33	0,10	0,01
Maranhão	58,63	5,81	0,74	1,01	1,38	0,29	0,67	1,51	2,70
Paraíba	17,99	1,71	6,59	6,59	5,22	35,72	6,92	2,40	1,57
Pernambuco	1,80	0,04	0,52	1,20	0,29	0,90	0,29	0,03	-
Piauí	1,90	1,22	1,03	1,45	0,36	0,63	1,01	0,74	0,36
Rio Grande do Norte	6,16	0,39	1,87	3,01	8,63	6,00	20,71	5,47	8,71
Sergipe	1,55	0,54	0,18	1,03	8,34	14,92	6,47	9,60	0,83
Sudeste	77,07	3,23	2,05	2,31	0,43	0,11	0,04	1,17	0,15
Espírito Santo	56,94	8,12	5,11	12,75	2,07	-	-	23,87	2,15
Minas Gerais	46,13	2,72	0,39	1,21	0,70	0,17	0,10	0,25	0,20
Rio de Janeiro	294,18	10,46	7,93	6,86	0,77	0,26	0,07	0,01	0,01
São Paulo	10,03	0,29	0,30	0,17	0,03	0,04	0,01	0,01	0,01
Sul	1,76	0,03	0,02	0,05	0,17	0,21	0,33	0,11	0,02
Paraná	3,45	0,05	0,04	0,05	0,07	0,02	-	-	0,03
Rio Grande do Sul	0,77	0,02	0,02	0,04	0,37	0,40	0,53	0,11	0,01
Santa Catarina	0,64	0,01	0,01	-	0,01	-	0,04	-	0,01
Centro-Oeste	162,94	18,06	5,86	1,98	2,49	1,53	1,11	4,78	2,68
Distrito Federal	6,37	0,74	0,35	2,28	0,34	0,07	0,07	-	0,13
Goiás	119,23	19,16	6,00	0,65	0,20	0,11	0,43	1,64	0,37
Mato Grosso	460,08	42,61	11,52	4,48	9,63	5,92	3,65	12,33	10,04
Mato Grosso do Sul	62,91	2,47	4,08	1,84	1,32	0,95	0,60	2,81	1,41

Notas:

- *Casos confirmados de Zika.
- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>

3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
4. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/>. doi:10.5281/zenodo.179901835
5. Ministério da Saúde. Dengue, Chikungunya e Zika. Em: Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 5 de agosto de 2025]. p. 727–82. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.16 – Taxa de incidência de Zika [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637547



Morbidade



MRB 2.17 – Taxa de incidência da síndrome respiratória aguda grave por COVID-19

MRB 2.17 – Incidence rate of severe acute respiratory syndrome due to COVID-19

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de casos incidentes confirmados de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) relativa à infecção pelo SARS-CoV-2, na população residente, em um local e ano de referência.
- Os casos de SRAG são codificados como U-04 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a magnitude da doença. A análise de série temporal permite avaliar a evolução temporal e a distribuição geográfica, em número de casos novos confirmados de SRAG por COVID-19, em um local e ano de referência.
- Taxas elevadas podem decorrer de diversos fatores, entre os quais se podem citar: intensa circulação do vírus na comunidade; falhas na cobertura vacinal; baixa adesão às medidas preventivas; e baixa efetividade das políticas públicas de saúde, particularmente as dirigidas às populações mais vulneráveis, tais como idosos e pessoas com comorbidades.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos confirmados da SRAG por COVID-19, bem como das suas taxas de incidência, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas à assistência, ao diagnóstico e ao acompanhamento clínico dos casos da SRAG por COVID-19.

LIMITAÇÕES

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica e das instituições hospitalares de assistência à saúde, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica de infecção pelo vírus SARS-CoV-2.
- A vigilância da COVID-19 considera como preliminares os dados relacionados às últimas quatro semanas epidemiológicas, devido ao tempo de evolução dos casos e à digitação da ficha no sistema de informação.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe)².
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções³.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁴.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados da SRAG pelo vírus SARS-CoV-2, em um local e ano de referência}}{\text{População residente em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de casos incidentes confirmados de SRAG por COVID-19, em um local e ano de referência.
- Denominador: População total residente estimada para o meio do ano, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância da Covid-19, Influenza e Outros Vírus Respiratórios, do Departamento de Doenças Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde (CGCOVID/DEDT/SVSA/MS).

NOTAS

- A definição de caso confirmado da SRAG associada à infecção pelo SARS-CoV-2 baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para a orientação das ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁵.
- Além do cálculo de incidência, recomenda-se a utilização de análises complementares, como o *nowcasting*⁶, para aprimoramento da interpretação dos dados da SRAG por COVID-19. O *nowcasting* permite corrigir atrasos de notificação, fornecendo estimativas mais precisas sobre a evolução recente da epidemia, contribuindo para decisões oportunas em saúde pública. Uma iniciativa relevante nesse contexto no Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), é o InfoGripe, que monitora e apresenta níveis de alerta para casos reportados de SRAG do Sivep-Gripe. Pode-se acompanhar a evolução nos Boletins epidemiológicos: Boletins Infogripe⁷.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Observa-se que as taxas de incidência da SRAG relativa à COVID-19 foram mais elevadas nos primeiros anos da pandemia de COVID-19 (2020 e 2021), com declínio progressivo nos anos subsequentes. No ano de 2020, as Unidades da Federação (UFs) que apresentaram maiores taxas de incidência foram o Ceará (184,31), Amazonas (367,17) e São Paulo (287,05), refletindo a alta carga da doença nesse período inicial. Em 2021, foram São Paulo (488,16), Goiás (525,6), Mato Grosso do Sul (516,43), Distrito Federal (488,87), Rio Grande do Sul (476,46) e Paraná (443,5). Esse padrão indica a continuidade da transmissão do vírus SARS-CoV-2 e seus impactos na saúde pública.

A partir de 2022, observa-se queda expressiva e contínua das taxas, declínio que se consolida em 2023, 2024 e 2025. Em 2025, o Brasil apresentou uma taxa de incidência de 5,05 casos por 100 mil habitantes, evidenciando redução substancial em relação aos anos críticos da pandemia, em grande parte associada ao avanço da vacinação e às medidas de controle adotadas (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de incidência da síndrome respiratória aguda grave por COVID-19, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs) de residência, 2020 a 2025

Brasil, regiões, UFs	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brasil	208,51	395,43	55,09	12,25	8,13	5,05
Norte	222,90	273,44	30,92	6,02	5,30	3,93
Acre	99,46	144,07	39,65	13,46	11,81	9,20
Amapá	225,71	314,34	27,91	9,01	11,46	7,47
Amazonas	367,17	323,41	40,88	8,09	6,52	4,65

Brasil, regiões, UFs	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pará	188,35	243,70	26,09	4,42	3,65	2,57
Rondônia	186,45	326,49	33,21	5,40	5,04	4,81
Roraima	191,58	374,98	19,75	4,03	5,44	4,88
Tocantins	148,26	252,24	29,60	5,04	4,56	3,23
Nordeste	146,80	219,81	32,45	6,88	3,55	2,84
Alagoas	167,57	281,37	36,73	7,05	2,73	2,30
Bahia	104,15	199,71	31,30	5,11	3,01	2,94
Ceará	184,31	265,18	42,82	10,49	6,32	3,87
Maranhão	81,39	129,63	12,12	2,33	1,13	1,34
Paraíba	149,40	286,12	40,62	8,05	4,95	5,79
Pernambuco	208,56	186,16	26,46	7,49	2,18	1,42
Piauí	189,40	265,72	35,72	5,44	3,58	2,67
Rio Grande do Norte	139,75	262,68	46,09	7,65	4,41	2,96
Sergipe	131,53	247,38	39,45	13,85	6,24	4,06
Sudeste	242,42	414,78	68,76	15,23	10,33	5,87
Espírito Santo	105,29	103,74	14,19	3,85	3,80	4,00
Minas Gerais	168,71	428,11	78,34	12,87	9,78	5,45
Rio de Janeiro	246,31	276,64	36,56	8,34	5,27	2,97
São Paulo	287,05	488,16	81,28	19,92	13,06	7,32
Sul	194,82	443,90	71,47	15,66	11,07	6,07
Paraná	185,87	443,50	69,86	14,63	11,44	7,29
Rio Grande do Sul	212,42	476,46	82,33	18,78	12,43	5,73
Santa Catarina	182,38	396,85	58,25	12,75	8,62	4,77
Centro-Oeste	248,88	481,67	66,50	15,32	9,71	7,54
Distrito Federal	365,58	488,87	84,07	26,35	13,81	14,11
Goiás	223,38	525,60	64,60	13,99	7,90	6,09
Mato Grosso	196,79	363,57	40,47	5,29	4,51	2,97
Mato Grosso do Sul	258,62	516,43	87,06	20,47	16,92	10,48

Nota:

- Dados originados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). Disponível em: <https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0>. Acesso em: 10 fev. 2026
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
4. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância integrada da COVID-19, influenza e outros vírus respiratórios de importância em saúde pública [recurso eletrônico]/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.146 p.: il.
6. Bastos et al. (2019). A modelling approach for correcting reporting delays in disease surveillance data. *Statistics in Medicine*. 2019;38:4363–4377. DOI: 10.1002/sim .8303. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40921#collapseExample>. Acesso em 28 de janeiro de 2024
7. Gomes MF. Boletins do InfoGripe [Internet]. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2025 Feb 03. Disponível em: <https://gitlab.fiocruz.br/marcelo.gomes/infogripe/-/tree/master/Boletins%20do%20InfoGripe>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.2.17– Taxa de incidência da síndrome respiratória aguda grave por COVID-19 [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi:10.5281/zenodo.18637566





MRB.3.01 – Proporção de categoria de exposição de aids

MRB.3.01 – Proportion of AIDS cases by exposure category

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual de casos confirmados de aids por categoria de exposição hierarquizada, na população residente em um local e ano de referência.
- Os casos de aids são codificados como B20-B24 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a ocorrência de cada categoria de exposição hierarquizada em casos confirmados de aids, em um local e ano de referência.

USOS

- Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos casos confirmados de aids segundo categoria de exposição, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica da doença.
- Contribuir para a avaliação e orientação das ações de controle da aids.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para o controle da transmissão de HIV/aids em áreas e populações específicas.

LIMITAÇÃO

- Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e realizar testes laboratoriais específicos para a confirmação diagnóstica da aids.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)².
- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)³.
- Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel)⁴.
- Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom)⁵.

Nota:

- Os dados do Sinan estão de acordo com o Observatório do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica (CNIE).

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de casos incidentes confirmados de aids segundo categoria de exposição hierarquizada, em um local provável de infecção e ano de referência}}{\text{Número de casos incidentes confirmados de residentes em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de casos incidentes confirmados de aids segundo categoria de exposição hierarquizada, em um local provável de infecção e ano de referência.
- **Denominador:** Número de casos incidentes confirmados de aids de residentes em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informado.

Faixa etária:

- Menor de 5 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Escolaridade:

- Analfabeto;
- Ensino fundamental incompleto;
- Ensino fundamental completo;
- Ensino médio completo;
- Ensino superior completo; e
- Ignorada.

Categoria de exposição:

- Sexual (heterossexual, homossexual e bissexual);
- Sanguínea (usuário de drogas injetáveis – UDI, transfusão sanguínea, hemofílico e acidente de trabalho); e
- Transmissão vertical.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Vigilância Epidemiológica do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DATHI/SVSA/MS).

NOTAS

- A definição de caso confirmado de aids baseia-se em critérios adotados pelo Ministério da Saúde para orientar as ações de vigilância epidemiológica da doença em todo o país⁶.
- Para a variável *categoria de exposição hierarquizada*, a fonte de informação é exclusiva do Sinan.
- Além das informações constantes nos boletins epidemiológicos⁷, publicados anualmente, os dados específicos para cada um dos 5.570 municípios brasileiros podem ser visualizados por meio dos painéis de indicadores epidemiológicos disponíveis *online*, no endereço <http://indicadores.aids.gov.br/>.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No período de 2014 a 2025, a distribuição das categorias de exposição, entre os casos confirmados de aids, evidencia a predominância da transmissão sexual, com aumento da participação da categoria *homossexual* (de 20,85% para 26,25%), enquanto a categoria *heterossexual*, embora ainda majoritária, apresentou redução ao longo da série histórica (de 53,20% para 49,56%), com leve retomada após 2022. As exposições por via sanguínea mantiveram baixa frequência, com destaque para o uso de drogas injetáveis, e pequena ocorrência para hemofilia, transfusão e acidente com material biológico. A transmissão vertical permaneceu relativamente estável, em torno de 1% a 1,6%, com discreta queda ao final do período. Em conjunto, os dados reforçam a centralidade da transmissão sexual na dinâmica da epidemia e a importância de estratégias específicas de prevenção e qualificação da vigilância (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) de categoria de exposição de aids. Brasil, 2014 a 2025

Categoria de exposição	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sexual												
Homossexual	20,85	22,19	23,16	24,62	24,97	25,08	26,06	27,20	26,08	25,50	25,98	26,25
Bissexual	5,19	5,18	5,34	5,69	5,74	5,66	5,95	5,94	6,44	6,02	6,15	6,03
Heterossexual	53,20	52,28	51,48	50,85	50,24	50,62	48,39	46,87	46,62	48,40	49,31	49,56
Sanguínea												
Uso de drogas injetáveis	2,45	2,43	2,14	1,91	2,10	1,96	1,79	1,83	1,85	1,79	1,70	1,81
Hemofílico	0,01	0,03	0,01	0,01	0,03	0,01	0,04	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03
Transfusão	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,02	0,04
Acidente com material biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00
Transmissão vertical	1,48	1,48	1,61	1,47	1,33	1,33	1,41	1,15	1,39	1,43	1,44	1,23
Ignorado/sem informação	16,79	16,39	16,24	15,44	15,56	15,32	16,35	17,00	17,60	16,82	15,39	15,06

Nota:

- Dados originados do Sinan² e compatibilizados com o Observatório do CNIE. Atualização: janeiro de 2026.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. SINAN – Notificação Individual [Internet]. [citado 16 de julho de 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
- Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Manual de utilização do sistema de controle de exames laboratoriais (SISCEL). Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sistema_controle_exames_laboratoriais_carga_viral_manual_utilizacao.pdf
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM). Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/sistemas-de-informacao/siclom>

6. Ministério da Saúde. Aids. Em: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, organizador. Guia de Vigilância em Saúde [Internet]. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2024 [citado 10 de novembro de 2025]. p. 511–20. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>
7. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico HIV e Aids 2023. Brasília: [s.n.]. Disponível em: <<https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2023/hiv-aids/boletim-epidemiologico-hiv-e-aids-2023.pdf/view>>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.3.01 – Proporção de categoria de exposição de aids [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637597



Morbidade



MRB.4.01 – Taxa de internação hospitalar (SUS) por causas externas

MRB.4.01 – Hospital admission rate (SUS) for external causes

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de internações hospitalares por causas externas, financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em relação à população residente em um local e ano de referência.
- Inclui internações por causas externas registradas nas Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) no Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), conforme os códigos V01 a Y98 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a intensidade de internações hospitalares por causas externas no sistema público de saúde em relação ao tamanho populacional. Sua magnitude é influenciada por aspectos culturais, ambientais, de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população. É sensível aos níveis de desigualdade e vulnerabilidade socioeconômica, à disponibilidade de meios letais, à organização e à qualidade dos serviços de saúde, especialmente os hospitalares, bem como às políticas de promoção da saúde e de enfrentamento dos determinantes dos acidentes, agressões, intoxicações e outros eventos classificados como causas externas.
- A análise de série temporal desse indicador permite avaliar a evolução temporal e a distribuição geográfica e representa sua magnitude como problema de saúde pública, em um local e ano de referência.
- Reflete as condições de utilização dos serviços hospitalares, o que, por sua vez, guarda relação com a oferta desses serviços no SUS.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição das taxas de internações hospitalares por causas externas, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir na realização de análises comparativas referentes à utilização de internações hospitalares por causas externas, para apoiar a avaliação da necessidade e concentração de recursos médico-hospitalares, especialmente da assistência médica de urgência e de reabilitação.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas, ações de prevenção e da assistência de urgência pré-hospitalar e hospitalar.

LIMITAÇÃO

- Como o indicador é influenciado pela oferta de serviços, as comparações entre seus valores precisam considerar a estrutura e o funcionamento dos serviços de saúde. Isso porque o indicador é também influenciado pela disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, bem como pelos critérios técnico-administrativos de pagamento de internações hospitalares adotados no âmbito do SUS.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informações Hospitalares (SIH)².
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções³.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁴.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\sum x}{\sum y} \times 100.000$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de internações hospitalares de residentes, por causas externas, pagas pelo SUS, em um local e ano de referência, e y significa a população residente estimada para um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de internações por causas externas pagas pelo SUS para a população residente, em um local e ano de referência.
- Denominador: População total estimada em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Grupos de causas:

- Acidentes de transporte terrestre – ATT (V01-V89);
- Quedas (W00-W19);
- Demais acidentes (V90-V99; W20-X59);
- Agressões e intervenções legais – homicídios (X85-Y09; Y35-Y36);
- Intoxicações (X00-X09; X40-X49);
- Lesões autoprovocadas voluntariamente (X60-X84);
- Eventos de intenção indeterminada (Y10-Y34); e
- Demais causas externas (Y40-Y98).

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Núcleo de Informações Estratégicas do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (NIE/DAHU/SAES/MS).

NOTAS

- As internações são categorizadas segundo o registro do diagnóstico principal da AIH – Tipo 1: internamento inicial.
- As internações são categorizadas segundo o diagnóstico primário. Não são consideradas as AIHs de continuidade – tipo 5.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, no período de 2015 a 2024, observou-se tendência geral de crescimento do indicador, que passou de 548,7, em 2015, para 748,2 em 2024. Até 2019, houve aumento gradual (600,7), seguido de redução em 2020 (573,2), possivelmente associada aos efeitos da pandemia de COVID-19 sobre a oferta e a demanda de serviços de saúde. A partir de 2021, verificou-se retomada progressiva, com crescimento contínuo até 2024, sendo superados os níveis pré-pandemia.

No último ano da série, as maiores taxas foram observadas na região Centro-Oeste (911,6), seguida das regiões Sul (870,9) e Norte (785,2). A menor taxa regional, em 2024, foi registrada no Sudeste (675,2). Todas as regiões apresentaram padrão semelhante ao nacional: redução em 2020 e crescimento consistente nos anos subseqüentes (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de internação hospitalar (SUS) por causas externas, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2015 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	548,7	553,5	564,8	582,2	600,7	573,2	603,4	645,0	701,7	748,2
Norte	581,7	573,1	573,5	591,2	605,3	595,6	622,2	665,1	729,9	785,2
Acre	541,1	564,2	491,5	509,2	486,1	533,0	482,1	480,5	525,2	556,9
Amapá	278,7	240,2	234,6	273,7	307,8	263,0	232,4	316,4	389,1	504,2
Amazonas	322,5	333,7	351,9	352,7	372,6	339,6	380,0	431,3	421,5	495,2
Pará	646,9	622,4	635,0	660,2	665,2	654,4	704,1	768,3	852,5	926,5
Rondônia	871,0	871,0	857,7	893,2	900,1	925,2	975,6	859,0	1,021,8	935,1
Roraima	649,2	765,2	744,8	749,3	633,2	555,6	362,8	540,5	635,3	589,4
Tocantins	725,6	698,8	654,9	651,2	773,2	810,8	814,7	847,1	895,7	989,2
Nordeste	504,0	513,5	520,0	541,0	558,3	526,3	570,8	603,2	670,2	733,5
Alagoas	465,2	537,8	525,6	507,3	521,8	501,6	546,3	572,8	595,1	691,4
Bahia	489,0	513,3	501,5	535,0	569,4	557,1	599,1	620,8	696,9	754,4
Ceará	543,4	525,0	499,1	540,6	544,3	514,5	561,0	590,6	665,1	721,6
Maranhão	553,5	525,6	561,8	602,7	590,4	550,0	603,8	665,0	693,8	752,5
Paraíba	369,3	316,7	354,8	361,4	385,1	343,6	422,6	406,4	538,5	591,8
Pernambuco	549,6	558,3	600,2	587,7	597,5	541,9	578,9	617,6	688,6	775,0
Piauí	678,2	727,7	715,4	710,5	730,8	632,3	672,4	743,1	797,3	874,1
Rio Grande do Norte	350,4	398,4	460,8	517,5	570,6	578,8	603,1	629,3	709,1	766,3
Sergipe	370,5	417,2	346,4	350,4	367,3	361,8	393,5	441,1	465,3	474,9
Sudeste	522,2	520,1	532,8	538,7	557,1	535,4	562,2	592,7	640,4	675,2
Espírito Santo	667,6	663,8	683,7	660,8	667,4	663,4	773,6	775,5	873,7	934,6
Minas Gerais	611,5	609,3	629,2	632,8	654,0	646,2	670,1	713,8	751,8	804,0
Rio de Janeiro	399,0	378,0	403,7	427,6	450,1	428,3	477,6	503,3	561,5	562,8
São Paulo	515,5	520,7	524,3	526,9	543,4	513,5	525,5	554,0	597,7	634,4
Sul	656,1	674,3	698,9	708,1	723,1	696,8	712,7	774,0	818,3	870,9
Paraná	733,3	771,2	824,4	856,0	866,7	832,1	836,5	920,4	969,3	1.023,6
Rio Grande do Sul	571,7	567,9	566,4	558,2	572,9	562,7	578,7	626,7	675,3	713,9
Santa Catarina	667,5	688,0	707,3	706,9	727,9	688,8	721,3	766,5	797,0	865,8
Centro-Oeste	616,8	631,1	637,9	717,7	750,1	684,4	711,8	803,9	883,9	911,6
Distrito Federal	43,5	32,7	98,7	501,1	575,8	542,7	579,0	600,0	649,1	679,5
Goiás	724,4	736,3	716,4	741,0	770,4	714,0	707,0	827,0	940,6	941,0
Mato Grosso	778,1	818,5	791,1	783,9	810,3	684,3	741,6	857,6	914,7	975,3
Mato Grosso do Sul	749,3	761,4	813,3	802,1	804,1	757,5	823,0	886,4	942,2	991,3

Nota:

- Dados originados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH)². Atualização: setembro de 2025.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil, 2021-2030 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2021 [citado 7 de maio de 2025]. 1-118 p. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-2022_2030.pdf/view
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
- Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.4.01 – Taxa de internação hospitalar (SUS) por causas externas [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi:10.5281/zenodo.18637634





MRB.4.02 – Taxa de internação hospitalar (SUS) por condições sensíveis à atenção primária

MRB.4.02 – Hospital admission rate (SUS) for ambulatory care sensitive conditions

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária (CSAP), financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em relação à população residente, em um local e ano de referência.
- Inclui internações por CSAP registradas nas Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) no Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), conforme a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10)¹, de acordo com os agrupamentos definidos pela Portaria nº 221/2008².

INTERPRETAÇÃO

- Indica a intensidade de internações hospitalares por CSAP em relação ao tamanho populacional. Sua magnitude reflete as oportunidades perdidas de resolução dos problemas de saúde no nível da atenção primária. Esse indicador é influenciado por aspectos culturais, ambientais, de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população. É também sensível à desigualdade e vulnerabilidade socioeconômica, à disponibilidade de meios letais, à organização e à qualidade da atenção primária, bem como às políticas de promoção da saúde e de enfrentamento dos seus determinantes.
- A análise de série temporal desse indicador permite avaliar a evolução temporal e a distribuição geográfica e representa sua magnitude como problema de saúde pública, em um local e ano de referência.
- Reflete as condições de utilização tanto da atenção primária como dos serviços hospitalares, o que, por sua vez, guarda relação com a oferta desses serviços no SUS.
- O indicador pode ser utilizado como instrumento de avaliação da Atenção Primária à Saúde ou do padrão de utilização dos serviços hospitalares, contribuindo para a análise do desempenho e da efetividade do sistema de saúde nos níveis nacional, estadual e municipal.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição das taxas de internações hospitalares por CSAP, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas, ações de prevenção e da assistência médico-hospitalar.

LIMITAÇÃO

- O indicador é influenciado pela oferta de serviços. Assim, reflete a disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, bem como os critérios técnico-administrativos de pagamento de internações hospitalares adotados no âmbito do SUS.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informações Hospitalares (SIH)³.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁴.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\sum x}{y} \times 100.000$$

Nota:

- Na fórmula, $\sum x$ significa a soma de internações hospitalares por CSAP pagas pelo SUS, de residentes em um local e ano de referência, e y significa a população residente estimada para um local e ano de referência.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de internações por CSAP pagas pelo SUS, na população residente em um local e ano de referência.
- Denominador: Total de população residente em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Faixa etária:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino;
- Feminino; e
- Não informado.

Grupos de causas:

- Grupo 1 – Doenças preveníveis por imunização e condições sensíveis (A15-A18; A19; A33-A37; A51-A53; A95; B26; B05-B06; B16; B50-B54; B77; G00.0; I00-I02);
- Grupo 2 – Gastroenterites infecciosas e complicações (A00-A09; E86);
- Grupo 3 – Anemia (D50);
- Grupo 4 – Deficiências nutricionais (E40-E46; E50-E64);
- Grupo 5 – Infecções de ouvido, nariz e garganta (H66; J00-J06; J31);
- Grupo 6 – Pneumonias bacterianas (J13-J14; J15.3-J15.4, J15.8-J15.9; J18.1);
- Grupo 7 – Asma (J45-J46);
- Grupo 8 – Doenças pulmonares (J20-J21; J40-J44; J47);
- Grupo 9 – Hipertensão (I10-I11);
- Grupo 10 – Angina (I20);
- Grupo 11 – Insuficiência cardíaca (I50);
- Grupo 12 – Doenças cerebrovasculares (I63-I67; I69; G45-G46);
- Grupo 13 – Diabetes *mellitus* (E10-E14);
- Grupo 14 – Epilepsias (G40-G41);
- Grupo 15 – Infecção no rim e trato urinário (N10-N12; N30; N34; N39.0);
- Grupo 16 – Infecção da pele e tecido subcutâneo (A46; L01-L04; L08);
- Grupo 17 – Doença inflamatória dos órgãos pélvicos femininos (N70-N76); esta taxa deve ser calculada apenas sobre a população feminina;
- Grupo 18 – Úlcera gastrointestinal (K25-K28; K92.0; K92.1-K92.2); e
- Grupo 19 – Doenças relacionadas ao pré-natal e parto (O23; A50; P35.0).

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Núcleo de Informações Estratégicas do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (NIE/DAHU/SAES/MS).

NOTAS

- As internações são categorizadas segundo o registro do diagnóstico principal da AIH – Tipo 1: internamento inicial.
- As internações são categorizadas segundo o diagnóstico primário. Não são consideradas as AIHs de continuidade – tipo 5.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, de 2015 a 2024, as taxas de internações por CSAP permaneceram relativamente estáveis, variando de 1.058,9 (2015) até 1.026,0 internações por 100 mil habitantes, no último ano. Em 2020, observou-se redução expressiva para 762,0 por 100 mil habitantes, coincidente com a pandemia de COVID-19. Esse fenômeno pode estar relacionado com a redução da oferta e da demanda

por internações por estas condições, alterando o uso habitual dos serviços. Nos anos seguintes, ocorreu um retorno gradativo aos níveis pré-pandemia, atingindo, em 2024, 1.026,0 internações por 100 mil habitantes. A expectativa de redução da taxa de internação devido à expansão do programa Estratégia Saúde da Família (ESF) não se confirmou na série histórica analisada.

No último ano do período estudado, as maiores taxas foram observadas na região Sul (1.204,2/100 mil habitantes) e na região Norte (1.119,4/100 mil habitantes). A região Centro-Oeste (1.007,7) teve taxa intermediária, enquanto a região Sudeste (936,5) apresentou a menor taxa em 2024. Entre as Unidades da Federação (UFs), Maranhão (1.581,2) e Alagoas (591,8) tiveram a maior e a menor taxa, respectivamente. A exemplo do observado para o Brasil, poucas variações ocorreram nas UFs, e a redução no período da pandemia de COVID-19 também se verificou (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de internação hospitalar (SUS) por condições sensíveis à atenção primária, por 100 mil habitantes. Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs), 2015 a 2024

Brasil, regiões e UFs	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	1.058,9	1.025,3	1.026,1	1.033,6	1.034,9	762,0	782,4	948,4	1.006,4	1.026,0
Norte	1.227,6	1.195,3	1.196,6	1.196,2	1.167,9	820,9	877,1	1.021,3	1.116,0	1.119,4
Acre	984,9	1.003,1	847,1	870,8	785,5	534,6	717,0	787,4	994,5	955,6
Amapá	557,1	515,4	607,3	709,4	708,8	465,2	600,6	686,8	821,1	971,6
Amazonas	862,2	815,9	839,1	899,4	899,9	667,0	804,7	939,7	1.048,3	1.045,5
Pará	1.467,2	1.444,8	1.421,7	1.392,0	1.329,9	922,4	927,1	1.067,1	1.151,7	1.145,3
Rondônia	1.552,0	1.436,4	1.504,3	1.533,4	1.530,2	1.054,2	1.084,3	1.293,4	1.397,0	1.441,6
Roraima	1.175,8	1.246,7	1.422,8	1.400,2	1.397,5	886,3	1.140,5	1.382,2	1.389,7	1.116,9
Tocantins	990,0	979,7	965,8	878,6	940,5	728,2	684,6	831,8	887,6	988,4
Nordeste	1.159,3	1.090,6	1.099,3	1.091,8	1.092,7	763,4	810,8	974,6	1.015,6	1.042,8
Alagoas	762,7	766,9	807,4	728,3	735,7	490,7	540,8	544,8	587,7	591,8
Bahia	1.366,0	1.190,7	1.153,8	1.116,1	1.122,4	787,5	777,8	913,8	984,1	1.038,6
Ceará	990,0	998,4	1.023,1	1.084,3	1.137,5	731,4	756,0	1.015,7	1.047,1	1.098,2
Maranhão	1.740,5	1.653,2	1.711,6	1.792,2	1.667,5	1.200,5	1.326,9	1.557,0	1.589,0	1.581,2
Paraíba	1.008,5	912,6	899,4	862,7	821,9	580,2	650,3	790,4	865,9	941,3
Pernambuco	913,6	895,2	953,6	929,6	981,6	695,8	795,4	977,0	986,1	986,7
Piauí	1.553,6	1.542,2	1.454,4	1.353,8	1.357,6	967,7	1.027,0	1.140,7	1.181,5	1.094,6
Rio Grande do Norte	741,3	677,2	649,7	661,9	658,9	505,3	536,1	624,7	626,3	676,0
Sergipe	588,7	614,4	688,4	666,6	665,0	473,1	486,8	626,2	672,4	726,5
Sudeste	892,6	874,3	871,0	882,6	886,7	695,3	715,3	869,5	922,7	936,5
Espírito Santo	1.120,7	1.137,3	1.117,4	1.135,3	1.091,9	831,1	932,5	1.059,8	1.119,9	1.158,4
Minas Gerais	1.178,1	1.158,0	1.158,8	1.183,0	1.193,9	927,5	907,5	1.125,6	1.193,0	1.238,2
Rio de Janeiro	652,4	614,0	594,2	637,6	650,7	516,0	567,2	742,8	779,3	736,6
São Paulo	832,9	820,0	822,3	815,0	816,4	643,8	663,1	781,7	833,7	851,6

Brasil, regiões e UFs	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sul	1.319,9	1.316,3	1.315,0	1.289,1	1.284,5	937,0	897,2	1.108,7	1.172,8	1.204,2
Paraná	1.345,6	1.341,2	1.373,1	1.360,6	1.361,6	1.043,4	925,1	1.127,6	1.220,6	1.273,9
Rio Grande do Sul	1.370,5	1.332,7	1.289,4	1.242,8	1.252,0	908,5	929,5	1.162,9	1.197,7	1.214,1
Santa Catarina	1.197,3	1.250,8	1.263,1	1.248,2	1.214,0	816,2	807,5	1.002,2	1.066,7	1.088,0
Centro-Oeste	940,3	888,9	886,7	993,5	1.023,4	725,7	725,0	901,2	989,3	1.007,7
Distrito Federal	97,8	56,2	151,4	935,9	1.066,8	676,5	804,1	947,2	1.004,0	996,1
Goiás	1.155,9	1.039,4	1.034,5	952,9	977,8	734,4	681,2	847,4	951,5	940,1
Mato Grosso	1.032,1	1.034,2	973,0	954,5	950,2	639,7	633,5	770,5	848,8	921,3
Mato Grosso do Sul	1.173,9	1.204,7	1.178,9	1.205,0	1.186,2	865,8	871,9	1.160,0	1.254,0	1.305,1

Nota:

- Dados originados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH)³. Atualização: setembro de 2025.

REFERÊNCIAS

- Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de Doenças: décima revisão (CID-10). Edusp. 1998;2(4):143.
- Ministério da Saúde. Portaria nº 221, de 17 de abril de 2008 [Internet]. Ministério da Saúde. 2008 [citado 4 de novembro de 2025]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0221_17_04_2008.html
- Ministério da Saúde. Produção Hospitalar (SIH/SUS) [Internet]. DATASUS. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-hospitalar-sih-sus/>
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
- Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Morbidade. MRB.4.02 – Taxa de internação hospitalar (SUS) por condições sensíveis à atenção primária [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18637645





INDICADORES DE FATORES
DE RISCO E PROTEÇÃO (FRP)

Indicadores de fatores de risco e proteção (FRP)

O CGI de Fatores de Risco e Proteção (FRP) foi criado em 2011, na 21ª Oficina de Trabalho Interagencial (OTI), instância máxima para deliberação das definições técnicas da Ripsa. A criação deste CGI foi fundamental para ampliar o monitoramento dos indicadores de FRP. Posteriormente, houve a separação dos indicadores de morbidade e fatores de risco. Em agosto de 2023, o CGI FRP foi recriado, com a participação de 36 instituições de ensino e pesquisa, sob coordenação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e relatoria do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DAENT/SVSA/MS).

Os indicadores do CGI FRP foram construídos a partir de dados extraídos de diferentes inquéritos nacionais e sistemas de informação em saúde, abrangendo distintas populações, metodologias e períodos de coleta. Foram utilizadas as seguintes fontes: Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), Pesquisa Industrial Anual-Produto (PIA-Produto), Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil), Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

Em 2025, foram organizados 36 indicadores, distribuídos nas seguintes dimensões: *doenças crônicas, tabagismo, uso de álcool, atividade física, consumo alimentar, estado nutricional, saúde bucal, violência e parto*. A matriz de indicadores, sustentada por fontes de dados de alta qualidade e por um método colaborativo e transparente, reafirma-se como um instrumento estratégico para o monitoramento da saúde da população, para o subsídio a políticas baseadas em evidências e para o fortalecimento do controle social. A garantia de sua sustentabilidade financeira e institucional e o contínuo aprimoramento das fontes de dados são fundamentais para que a informação em saúde cumpra seu papel de orientar a ação e promover o direito universal à saúde no Brasil.



Dimensão 1 – Doenças crônicas

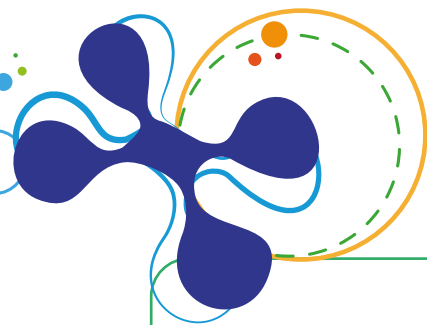
- FRP.1.01.1 – Prevalência de diabetes *mellitus* autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)
- FRP.1.01.2 – Prevalência de diabetes *mellitus* autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)
- FRP.1.02.1 – Prevalência de hipertensão arterial autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)
- FRP.1.02.2 – Prevalência de hipertensão arterial autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)

Dimensão 2 – Consumo de álcool

- FRP.2.01.1 – Prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas referido por indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)
- FRP.2.01.2 – Prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas referido por indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)
- FRP.2.02.1 – Prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade dirigindo veículos motorizados após consumo de bebidas alcoólicas (Vigitel)
- FRP.2.02.2 – Prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade dirigindo veículos motorizados após consumo de bebidas alcoólicas (PNS)
- FRP.2.03 – Consumo de álcool em litros de álcool puro *per capita* (entre pessoas com 15 anos ou mais de idade) por ano

Dimensão 3 – Tabagismo

- FRP.3.01.1 – Prevalência de fumantes atuais com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)
- FRP.3.01.2 – Prevalência de fumantes atuais com 18 anos ou mais de idade (PNS)
- FRP.3.02.1 – Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)
- FRP.3.02.2 – Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)
- FRP.3.02.3 – Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em escolares de 13 a 17 anos de idade (PeNSE)
- FRP.3.03.1 – Prevalência de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)
- FRP.3.03.2 – Prevalência de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade (PNS)



Dimensão 4 – Atividade física

- FRP.4.01.1 – Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)
- FRP.4.01.2 – Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)
- FRP.4.02.1 – Prevalência de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)
- FRP.4.02.2 – Prevalência de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)

Dimensão 5 – Estado nutricional

- FRP.5.01.1 – Prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)
- FRP.5.01.2 – Prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)
- FRP.5.02 – Prevalência de excesso de peso em crianças menores de 5 anos de idade
- FRP.5.03 – Prevalência de déficit ponderal para a idade em crianças menores de 5 anos de idade
- FRP.5.04 – Prevalência de déficit estatural para a idade em crianças menores de 5 anos de idade
- FRP.5.05 – Prevalência de dupla carga da má nutrição em crianças menores de 5 anos de idade

Dimensão 6 – Consumo alimentar

- FRP.6.01 – Prevalência de aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida
- FRP.6.02 – Prevalência de aleitamento materno continuado em crianças menores de 2 anos
- FRP.6.03 – Participação relativa diária *per capita* das calorias de frutas, verduras e legumes no total de calorias dos alimentos adquiridos no domicílio

Dimensão 7 – Parto

- FRP.7.01 – Proporção de nascidos vivos por idade da parturiente
- FRP.7.02 – Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer por idade gestacional no momento do parto
- FRP.7.03 – Prevalência de nascidos vivos com anomalias congênitas

Dimensão 8 – Violência

- FRP.8.01 – Prevalência de violências contra mulheres com 18 anos ou mais de idade (PNS)
- FRP.8.02 – Prevalência de violência sexual contra meninas de 13 a 17 anos de idade (PeNSE)

Dimensão 9 – Saúde bucal

- FRP.9.01 – Índice CPO-D (número de dentes cariados, perdidos e obturados) aos 12 anos de idade
- FRP.9.02 – Proporção de criança de 5 a 6 anos de idade livres de cárie (índice ceo-d igual a 0)

Fatores de risco e proteção



FRP.1.01.1 – Prevalência de diabetes *mellitus* autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)

FRP.1.01.1 – Self-reported Diabetes Mellitus prevalence in individuals aged 18 years and over (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de diabetes *mellitus*, por diagnóstico médico autorreferido, em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de diabetes *mellitus*, por diagnóstico médico autorreferido, na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, residente em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de diabetes *mellitus*, por diagnóstico médico autorreferido, na população brasileira com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao controle de diabetes.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida em entrevista telefônica.
- Reflete a frequência entre indivíduos que acessaram os serviços de saúde, tiveram a doença investigada e diagnosticada e foram informados acerca do resultado do diagnóstico.
- Por utilizar como fonte de dados o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Refere-se à população com 18 anos ou mais de idade residente nas capitais de Unidades da Federação (UFs) e no Distrito Federal.
- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).
- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada cidade. Nos anos de 2020 e 2021, houve redução da amostra para mil indivíduos em cada cidade, e, em 2023, para 800 indivíduos. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão. Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade, residentes em capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam positivamente à questão “Algum médico já lhe disse que o(a) Sr.(a) tem diabetes?”, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável peso_ake, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade, projetada para cada ano. Informações mais detalhadas podem ser encontradas nos relatórios oficiais do Ministério da Saúde³.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de casos é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes nas capitais brasileiras apresentou aumento de 5,7% (IC95% 5,3%; 6,1%), em 2006, para 10,2% (IC95% 9,4%; 11,1%), em 2023.

Esse aumento, no período de 2006 a 2023, ocorreu em ambos os sexos: de 4,8% (IC95% 4,2%; 5,3%) a 9,1% (IC95% 7,8%; 10,5%), no masculino; e de 6,4% (IC95% 5,9%; 7,0%) a 11,1% (IC95% 10,1%; 12,2%), no feminino (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência* de diabetes *mellitus* por diagnóstico médico autorreferido** entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, segundo sexo, residentes nas capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel). Brasil, 2006 a 2023***

Ano	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2006	5,7	5,3; 6,1	4,8	4,2; 5,3	6,4	5,9; 7,0
2007	5,7	5,3; 6,1	5,3	4,7; 5,8	6,1	5,6; 6,6
2008	6,2	5,8; 6,6	5,7	5,0; 6,3	6,7	6,2; 7,2
2009	6,3	5,9; 6,8	5,8	5,1; 6,5	6,7	6,1; 7,4
2010	6,8	6,4; 7,2	6,1	5,4; 6,7	7,4	6,8; 7,9
2011	6,3	5,9; 6,7	5,9	5,3; 6,5	6,6	6,1; 7,1
2012	7,4	6,9; 7,8	6,5	5,8; 7,2	8,1	7,5; 8,8

Ano	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2013	6,9	6,5; 7,3	6,5	5,8; 7,2	7,2	6,7; 7,7
2014	8,0	7,5; 8,5	7,3	6,5; 8,1	8,7	8,0; 9,4
2015	7,4	6,9; 7,9	6,9	6,2; 7,6	7,8	7,2; 8,4
2016	8,9	8,5; 9,4	7,8	7,1; 8,5	9,9	9,2; 10,5
2017	7,6	7,2; 8,1	7,1	6,4; 7,7	8,1	7,5; 8,7
2018	7,7	7,2; 8,1	7,1	6,5; 7,7	8,1	7,6; 8,7
2019	7,4	7,0; 7,9	7,1	6,4; 7,8	7,8	7,3; 8,3
2020	8,2	7,6; 8,8	7,3	6,3; 8,2	9,0	8,2; 9,8
2021	9,1	8,5; 9,8	8,6	7,6; 9,6	9,6	8,8; 10,5
2023	10,2	9,4; 11,1	9,1	7,8; 10,5	11,1	10,1; 12,2

Notas:

- *Percentual ponderado para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade, projetada para cada ano do levantamento.
- **Relato afirmativo do entrevistado acerca do diagnóstico médico de diabetes *mellitus*.
- ***Não houve coleta em 2022.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/download/Vigitel/>
2. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2006-2023: morbidade referida e autoavaliação de saúde: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de morbidade referida e autoavaliação de saúde nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2023 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2025 [citado 12 de agosto de 2025]. 1–57 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_2006_2023_morbidade_autoavaliacao.pdf
3. Ministério da Saúde. Acesse as Publicações do Ministério da Saúde sobre Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.1.01.1 – Prevalência de diabetes *mellitus* autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18329525



Fatores de risco e proteção



FRP.1.01.2 – Prevalência de diabetes *mellitus* autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)

FRP.1.01.2 – Self-reported Diabetes Mellitus prevalence in individuals aged 18 years and over (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de diabetes *mellitus*, por diagnóstico médico autorreferido, em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de diabetes *mellitus*, por diagnóstico médico autorreferido, na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, residente em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de diabetes *mellitus*, por diagnóstico médico autorreferido, na população brasileira com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao controle de diabetes *mellitus*.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida.
- Não é possível obter estimativas anuais, em virtude da periodicidade da pesquisa.
- Reflete a frequência entre indivíduos que acessaram os serviços de saúde, tiveram a doença investigada e diagnosticada e foram informados acerca do resultado do diagnóstico.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- Por se utilizar como fonte de dados a PNS, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados da PNS, que é um inquérito amostral de saúde, de base domiciliar e de âmbito nacional, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNS foi realizada nos anos de 2013² e 2019³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam positivamente à questão “Algum médico já lhe deu o diagnóstico de diabetes?”, excluídas as mulheres que referiram diagnóstico apenas durante a gravidez, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral do morador selecionado.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE**Cor ou raça:**

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Renda domiciliar per capita:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de casos é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes *mellitus* no Brasil aumentou de 6,2% (IC95% 5,9%; 6,6%), em 2013, para 7,7% (IC95% 7,4%; 8,0%), em 2019, na população total.

Esse aumento, entre os anos de 2013 e 2019, foi observado em ambos os sexos: de 5,3% (IC95% 4,8%; 5,8%) a 6,9% (IC95% 6,5%; 7,4%), no sexo masculino; e de 7,0% (IC95% 6,6%; 7,5%) a 8,4% (IC95% 8,0%; 8,9%), no sexo feminino, naqueles anos, respectivamente.

Em ambas as edições da PNS (2013 e 2019), verificou-se um aumento da prevalência de diabetes *mellitus* autorreferida com o aumento da faixa etária.

Em 2013, verificou-se menor prevalência entre os indivíduos de cor ou raça parda, o que não foi observado em 2019. Em 2019, a região Norte apresentou a menor prevalência de diabetes *mellitus* (5,5%, IC95% 5,0%; 6,0%), quando comparada às demais regiões brasileiras (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência de diabetes *mellitus* por diagnóstico médico autorreferido* entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em inquérito domiciliar (PNS), segundo sexo, cor ou raça, faixa etária e regiões. Brasil, 2013 e 2019

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Sexo				
Masculino	5,3	4,8; 5,8	6,9	6,5; 7,4
Feminino	7,0	6,6; 7,5	8,4	8,0; 8,9
Cor ou raça**				
Branca	6,7	6,2; 7,3	8,0	7,6; 8,5
Preta	7,3	6,1; 8,7	7,8	7,1; 8,7
Amarela	‡	‡	12,8	8,7; 18,5
Parda	5,5	5,0; 5,9	7,3	6,9; 7,7
Indígena	‡	‡	7,5	4,9; 11,2
Faixa etária				
18 a 24 anos	0,5	0,3; 0,9	0,7	0,5; 1,1
25 a 34 anos	0,8	0,6; 1,1	0,9	0,7; 1,2
35 a 44 anos	2,9	2,5; 3,5	3,1	2,7; 3,6
45 a 59 anos	8,4	7,6; 9,3	9,4	8,8; 10,1
60 anos ou mais	18,1	16,9; 19,4	20,2	19,3; 21,1
Brasil e regiões				
Brasil	6,2	5,9; 6,6	7,7	7,4; 8,0
Norte	4,3	3,6; 5,0	5,5	5,0; 6,0
Nordeste	5,4	4,9; 5,9	7,2	6,8; 7,6
Sudeste	7,1	6,4; 7,7	8,5	8,0; 9,1
Sul	6,2	5,5; 7,1	7,9	7,3; 8,6
Centro-Oeste	6,4	5,7; 7,1	7,2	6,5; 7,9

Notas:

- *Relato afirmativo do entrevistado acerca do diagnóstico médico de diabetes *mellitus*.
- **Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do software estatístico utilizado.

- ‡ Número de casos < 30 e/ou coeficiente de variação > 0,5. Estimativa suprimida conforme critérios descritos na seção “Notas”.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 de março de 2025]. 1–180 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 de março de 2025]. 1–113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.1.01.2 – Prevalência de diabetes *mellitus* autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18329729



Fatores de risco e proteção



FRP.1.02.1 – Prevalência de hipertensão arterial autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)

FRP.1.02.1 – Self-reported hypertension prevalence in individuals aged 18 years and over (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de hipertensão arterial, por diagnóstico médico autorreferido, em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de hipertensão arterial, por diagnóstico médico autorreferido, na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, residente em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de hipertensão arterial, por diagnóstico médico autorreferido, na população brasileira com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao controle de hipertensão arterial.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida em entrevista telefônica.
- Reflete a frequência entre indivíduos que acessaram os serviços de saúde, tiveram a doença investigada e diagnosticada e foram informados acerca do resultado do diagnóstico.
- Por utilizar como fonte de dados o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Refere-se à população com 18 anos ou mais de idade residente nas capitais das Unidades da Federação (UFs) e no Distrito Federal.
- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).
- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada cidade. Nos anos 2020 e 2021, houve redução da amostra para mil indivíduos em cada cidade, e, em 2023, para 800 indivíduos. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão. Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade residentes em capitais das UF's e no Distrito Federal².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de diabetes, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam positivamente à questão “Algum médico já lhe disse que o(a) Sr.(a) tem pressão alta?”, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável peso_*rake*, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade, projetada para cada ano.
- Informações mais detalhadas podem ser encontradas nos relatórios oficiais do Ministério da Saúde³.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de casos é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial nas capitais brasileiras apresentou aumento, de 22,5% (IC95% 21,8%; 23,2%), em 2006, para 27,9% (IC95% 26,6%; 29,2%) em 2023.

Esse aumento, entre 2006 e 2023, ocorreu em ambos os sexos: de 19,3% (IC95% 18,3%; 20,3%) para 26,4% (IC95% 24,4%; 28,4%), entre os indivíduos do sexo masculino; e de 25,2% (IC95% 24,3%; 26,2%) para 29,3% (IC95% 27,5%; 31,0%), no sexo feminino, respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência* de hipertensão arterial por diagnóstico médico autorreferido** entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, segundo sexo, residentes nas capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel). Brasil, 2006 a 2023***

Ano	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2006	22,5	21,8; 23,2	19,3	18,3; 20,3	25,2	24,3; 26,2
2007	23,5	22,8; 24,3	21,1	19,9; 22,2	25,7	24,7; 26,6
2008	25,3	24,6; 26,1	22,4	21,3; 23,6	27,8	26,8; 28,8
2009	25,4	24,6; 26,2	22,2	21,0; 23,4	28,2	27,2; 29,2
2010	24,3	23,5; 25,0	21,5	20,3; 22,6	26,6	25,7; 27,6
2011	24,3	23,6; 25,0	21,4	20,3; 22,4	26,9	25,9; 27,8
2012	24,3	23,6; 25,1	21,3	20,1; 22,5	26,9	25,9; 27,9

Ano	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2013	24,1	23,4; 24,8	21,5	20,4; 22,5	26,3	25,4; 27,3
2014	24,8	24,0; 25,6	22,5	21,3; 23,8	26,8	25,7; 27,8
2015	24,9	24,1; 25,6	22,0	20,8; 23,2	27,3	26,3; 28,3
2016	25,7	24,9; 26,5	23,6	22,4; 24,8	27,5	26,5; 28,5
2017	24,3	23,5; 25,0	21,7	20,6; 22,8	26,4	25,5; 27,4
2018	24,7	24,0; 25,5	22,1	21,0; 23,2	27,0	26,1; 28,0
2019	24,5	23,8; 25,3	21,2	20,0; 22,4	27,3	26,4; 28,3
2020	25,2	24,1; 26,4	24,1	22,2; 25,9	26,2	24,9; 27,6
2021	26,3	25,1; 27,6	25,4	23,4; 27,4	27,1	25,5; 28,7
2023	27,9	26,6; 29,2	26,4	24,4; 28,4	29,3	27,5; 31,0

Notas:

- *Percentual ponderado para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade, projetada para cada ano do levantamento.
- **Relato afirmativo do entrevistado acerca do diagnóstico médico de hipertensão arterial.
- ***Não houve coleta em 2022.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 de março de 2025]. 1–180 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 de março de 2025]. 1–113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.1.02.1 – Prevalência de hipertensão arterial autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18329786



Fatores de risco e proteção



FRP.1.02.2 – Prevalência de hipertensão arterial autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)

FRP.1.02.2 – Self-reported hypertension prevalence in individuals aged 18 years and over (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de hipertensão arterial, por diagnóstico médico autorreferido, em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de hipertensão arterial, por diagnóstico médico autorreferido, na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, residente em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de hipertensão arterial, por diagnóstico médico autorreferido, na população brasileira com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao controle de hipertensão arterial.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida.
- Não é possível obter estimativas anuais, em virtude da periodicidade da pesquisa.
- Reflete a frequência entre indivíduos que acessaram os serviços de saúde, tiveram a doença investigada e diagnosticada e foram informados acerca do resultado do diagnóstico.
- Por se utilizar como fonte de dados a PNS, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados da PNS, que é um inquérito amostral de saúde, de base domiciliar e de âmbito nacional, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNS foi realizada nos anos de 2013² e 2019³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam positivamente à questão “Algum(a) médico(a) já lhe deu o diagnóstico de hipertensão arterial (pressão alta)?”, excluídas as mulheres que referiram diagnóstico apenas na gravidez, em um local e ano de referência.
- **Denominador:** Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral do morador selecionado.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até ¼ do salário mínimo;
- Mais de ¼ até ½ salário mínimo;
- Mais de ½ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Na edição de 2013 da PNS, além da avaliação do diagnóstico autorreferido de hipertensão arterial, também foi realizada aferição de pressão arterial dos moradores selecionados. No entanto, nesta ficha, os dados usados no cálculo do indicador são, em ambos os anos, derivados de informações autorreferidas^{4,5}.
- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de casos é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial no Brasil aumentou de 21,4% (IC95% 20,8%; 22,0%), em 2013, para 23,9% (IC95% 23,4%; 24,4%) em 2019. Esse aumento, entre os anos de 2013 e 2019, foi observado em ambos os sexos: de 24,3% (IC95% 23,5%; 25,2%) para 26,4% (IC95% 25,8%; 27,2%), no sexo feminino: e de 18,1% (IC95% 17,3%; 18,9%) para 21,1% (IC95% 20,4%; 21,8%), no sexo masculino.

Em ambas as edições, verificou-se um aumento da prevalência de hipertensão autorreferida com o aumento da faixa etária. Adicionalmente, foi observada menor prevalência de hipertensão arterial na região Norte, com 14,4%, em 2013 (IC95% 13,4%; 15,5%), e 16,8% (IC95% 15,9%; 17,7%) em 2019 (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência de hipertensão arterial por diagnóstico médico autorreferido* entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em inquérito domiciliar (PNS), segundo sexo, cor ou raça, faixa etária e regiões. Brasil, 2013 e 2019

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Sexo				
Masculino	18,1	17,3; 18,9	21,1	20,4; 21,8
Feminino	24,3	23,5; 25,2	26,4	25,8; 27,2
Cor ou raça**				
Branca	22,1	21,2; 23,0	24,4	23,6; 25,2
Preta	24,2	22,3; 26,2	25,8	24,4; 27,2
Amarela	20,0	14,7; 26,6	29,0	23,4; 35,2
Parda	20,0	19,2; 20,8	22,9	22,2; 23,6
Indígena	19,4	13,3; 27,5	25,7	19,7; 32,7
Faixa etária				
18 a 24 anos	2,3	1,8; 2,9	2,3	1,8; 2,9
25 a 34 anos	5,6	5,0; 6,2	5,1	4,6; 5,7
35 a 44 anos	14,9	13,8; 16,1	13,5	12,5; 14,4
45 a 59 anos	30,9	29,6; 32,3	30,8	29,7; 31,9
60 anos ou mais	50,7	49,0; 52,4	55,0	53,9; 56,1
Brasil e regiões				
Brasil	21,4	20,8; 22,0	23,9	23,4; 24,4
Norte	14,4	13,4; 15,5	16,8	15,9; 17,7
Nordeste	19,5	18,4; 20,6	23,1	22,4; 23,8
Sudeste	23,3	22,2; 24,4	25,9	24,9; 26,9
Sul	22,8	21,3; 24,4	24,5	23,3; 25,7
Centro-Oeste	21,1	19,8; 22,3	21,9	20,7; 23,2

Notas:

- *Relato afirmativo do entrevistado acerca do diagnóstico médico de hipertensão arterial.
- **Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013 e 2019.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 de março de 2025]. 1–180 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 de março de 2025]. 1–113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>
4. Malta DC, Gonçalves RPF, Machado ÍE, Freitas MI de F, Azeredo C, Szwarcwald CL. Prevalência da hipertensão arterial segundo diferentes critérios diagnósticos, Pesquisa Nacional de Saúde. Revista Brasileira de Epidemiologia [Internet]. 29 de novembro de 2018 [citado 12 de agosto de 2025];21(1):e180021. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/rbepid/2018.v21suppl1/e180021/pt/>
5. Souza Júnior PRB de, Szwarcwald CL, Almeida W da S de, Damacena GN, Pedroso M de M, Sousa CAM de, et al. Comparison of sampling designs from the two editions of the Brazilian National Health Survey, 2013 and 2019. Cad Saúde Pública [Internet]. 2022 [citado 12 de agosto de 2025];38(suppl 1). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2022001304001&tlng=en

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.1.02.2 – Prevalência de hipertensão arterial autorreferida em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18329837



Fatores de risco e proteção



FRP.2.01.1 – Prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas referido por indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)

FRP.2.01.1 – Prevalence of heavy episodic drinking among individuals aged 18 years and over (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas, nos últimos 30 dias, em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência. Para fins epidemiológicos, a dose corresponde a 14g de álcool puro, cujo equivalente irá variar de bebida para bebida: por exemplo, uma dose de bebida alcoólica corresponde a uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de cachaça, uísque ou qualquer outra bebida alcoólica destilada.
- Considera-se consumo episódico pesado se o indivíduo ingeriu cinco ou mais doses (homem) ou quatro ou mais doses (mulher) em uma única ocasião, pelo menos uma vez nos últimos 30 dias¹.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas na população brasileira.

USOS

- Identificar distribuições populacionais, geográficas, sociodemográficas e temporais da prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas, em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, nas capitais de Unidades da Federação (UFs) e no Distrito Federal
- Subsidiar ações de intervenção, monitoramento e avaliação de políticas públicas de prevenção do consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida em entrevista telefônica.
- Por se utilizar como fonte de dados o Vigitel, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Refere-se à população com 18 anos ou mais de idade, residente nas capitais de UFs e no Distrito Federal.
- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).

- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada cidade. Nos anos 2020 e 2021, houve redução da amostra para mil indivíduos em cada cidade, e, em 2023, para 800 indivíduos. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão. Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)².

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade residentes em capitais das UF's e no Distrito Federal³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam positivamente à questão “Nos últimos 30 dias, o Sr. chegou a consumir cinco ou mais doses de bebida alcoólica em uma única ocasião?”, para homens, ou “Nos últimos 30 dias, a Sra. chegou a consumir quatro ou mais doses de bebida alcoólica em uma única ocasião?”, para mulheres, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- Uma dose de bebida alcoólica corresponde a uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de cachaça, uísque ou qualquer outra bebida alcoólica destilada¹.
- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável *peso_rake*, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade, projetada para cada ano.
- Informações mais detalhadas podem ser encontradas no relatório oficial do Ministério da Saúde⁴.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais das Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de casos é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas apresentou aumento, passando de 15,6% (IC95% 15,0%; 16,2%), em 2006, para 20,8%, em 2023 (IC95% 19,5%; 22,0%), entre pessoas com 18 anos ou mais de idade residentes em capitais das UF's e no Distrito Federal.

O aumento ocorreu em ambos os sexos, sendo maior a prevalência entre os homens, em todos os anos. Uma evidência interessante é o fato de a distância dessa prevalência entre o sexo masculino e o feminino vir decrescendo. A prevalência do sexo masculino era superior a três vezes a do sexo feminino, em 2006, e caiu para uma razão inferior a duas vezes em 2023, como consequência de incremento mais intenso desse indicador no sexo feminino, no período de análise (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência* de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas entre pessoas com 18 anos ou mais de idade, segundo sexo, residentes nas capitais de Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel). Brasil, 2006 a 2023**

Ano	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2006	15,6	15,0; 16,2	24,8	23,6; 26,0	7,7	7,2; 8,3
2007	16,6	16,0; 17,2	25,7	24,6; 26,9	8,8	8,2; 9,4
2008	17,2	16,6; 17,9	26,1	25,0; 27,3	9,6	9,0; 10,3
2009	18,5	17,8; 19,2	28,3	27,0; 29,6	10,0	9,4; 10,7
2010	18,1	17,4; 18,8	27,0	25,8; 28,3	10,5	9,8; 11,2
2011	16,5	15,9; 17,2	25,3	24,2; 26,5	9,0	8,4; 9,6
2012	18,4	17,7; 19,2	27,9	26,6; 29,3	10,3	9,6; 11,1
2013	16,4	15,7; 17,1	24,2	23,1; 25,4	9,7	9,0; 10,4
2014	16,5	15,7; 17,3	24,8	23,5; 26,2	9,4	8,7; 10,2
2015	17,2	16,4; 18,0	25,3	24,0; 26,7	10,2	9,5; 11,0
2016	19,1	18,4; 19,8	27,3	26,0; 28,6	12,1	11,3; 12,9
2017	19,1	18,3; 19,9	27,1	25,7; 28,5	12,2	11,4; 13,1
2018	17,9	17,2; 18,7	26,0	24,7; 27,4	11,0	10,3; 11,8
2019	18,8	18,0; 19,6	25,3	24,0; 26,7	13,3	12,4; 14,2
2020	20,9	19,6; 22,2	26,6	24,6; 28,8	16,0	14,5; 17,6
2021	18,4	17,1; 19,6	25,0	22,9; 27,1	12,7	11,3; 14,2
2023	20,8	19,5; 22,1	27,3	25,2; 29,5	15,2	13,8; 16,6

Notas:

- *Percentual ponderado para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade, projetada para cada ano do levantamento.
- **Não houve coleta em 2022.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2006-2023: tabagismo e consumo abusivo de álcool: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2023 [Internet]. 2023 [citado 19 de março de 2025]. p. 1-70. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel/vigitel-brasil-2006-2023-tabagismo-e-consumo-abusivo-de-alcool/view>
2. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/download/Vigitel/>

3. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2006-2023: morbidade referida e autoavaliação de saúde: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de morbidade referida e autoavaliação de saúde nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2023 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2025 [citado 12 de agosto de 2025]. 1–57 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_2006_2023_morbidade_autoavaliacao.pdf
4. Ministério da Saúde. Acesse as Publicações do Ministério da Saúde sobre Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.2.01.1 – Prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas referido por indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18329920



Fatores de risco e proteção



FRP.2.01.2 – Prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas referido por indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)

FRP.2.01.2 – Prevalence of heavy episodic drinking among individuals aged 18 years and over (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência. Para fins epidemiológicos, a dose corresponde a 14g de álcool puro, cujo equivalente irá variar de bebida para bebida: por exemplo, uma dose de bebida alcoólica corresponde a uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de cachaça, uísque ou qualquer outra bebida alcoólica destilada.
- Na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013¹, foi considerado consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas a ingestão de cinco ou mais doses (para homem) ou quatro ou mais doses (para mulher), em uma única ocasião, pelo menos uma vez nos últimos 30 dias.
- Na PNS 2019², considerou-se o consumo de cinco ou mais doses para homens e mulheres, em uma única ocasião, nos últimos 30 dias.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas na população brasileira com 18 anos ou mais de idade.

USOS

- Identificar distribuições populacionais, geográficas, sociodemográficas e temporais da prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas referido, na população adulta brasileira.
- Subsidiar ações de intervenção, monitoramento e avaliação de políticas públicas de prevenção do consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida.
- Não é possível obter estimativas anuais, em virtude da periodicidade da pesquisa.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- Por se utilizar como fonte de dados a PNS, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

- Como limitação, deve-se levar em conta que, na edição de 2013, o consumo abusivo de álcool era definido pelo consumo de cinco ou mais doses de bebida alcoólica, entre os homens, e quatro ou mais doses de bebida alcoólica, entre as mulheres, em uma única ocasião. Na edição de 2019, o consumo abusivo de álcool foi definido pelo consumo de cinco ou mais doses de bebida alcoólica, tanto para os homens como para as mulheres, em uma única ocasião.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)³.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados da PNS, que é um inquérito amostral de saúde, de base domiciliar e de âmbito nacional, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNS foi realizada nos anos de 2013¹ e 2019².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam positivamente às questões "Com que frequência o(a) Sr.(a) costuma consumir alguma bebida alcoólica?" e "Nos últimos 30 dias, o Sr.(a) chegou a consumir cinco ou mais doses de bebida alcoólica em uma única ocasião?", em um local e ano de referência.
- **Denominador:** Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

Notas:

- Uma dose de bebida alcoólica corresponde a uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de cachaça, uísque ou qualquer outra bebida alcoólica destilada.
- O cálculo deve considerar o desenho complexo da amostra do morador selecionado do domicílio, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral do morador selecionado.
- O critério de definição de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas para mulheres mudou entre 2013 e 2019. Na PNS 2013¹, foi considerado consumo episódico pesado para mulheres o consumo de quatro doses em uma única ocasião. Na PNS 2019², foi considerado consumo episódico pesado o consumo de cinco doses em uma única ocasião.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Renda domiciliar per capita:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação de domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE _____

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS _____

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de casos é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.

- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas apresentou aumento, passando de 13,6% (IC95% 13,1%; 14,2%), em 2013, para 17,1%, em 2019 (IC95% 16,6%; 17,6%), entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade. O aumento ocorreu em ambos os sexos, sendo maior a prevalência em homens, entre 2013 e 2019 (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência* de consumo pesado de álcool** entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em inquérito domiciliar (PNS), segundo sexo, cor ou raça, faixa etária e regiões. Brasil, 2013 e 2019

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Sexo				
Masculino	21,5	20,6; 22,4	26,0	25,2; 26,8
Feminino	6,6	6,1; 7,1	9,2	8,7; 9,7
Cor ou raça***				
Branca	12,3	11,6; 13,1	16,0	15,3; 16,8
Preta	16,6	15,0; 18,3	19,6	18,3; 20,9
Amarela	11,0	8,0; 15,1	12,7	9,4; 17,1
Parda	14,5	13,8; 15,2	17,5	16,8; 18,3
Indígena	12,9	8,8; 18,7	15,5	11,4; 20,8
Faixa etária				
18 a 24 anos	16,9	15,4; 18,4	22,9	21,2; 24,6
25 a 34 anos	19,6	18,4; 20,9	24,3	23,1; 25,5
35 a 44 anos	15,9	14,8; 17,0	20,8	19,8; 21,9
45 a 59 anos	11,4	10,6; 12,3	15,4	14,2; 16,5
60 anos ou mais	4,3	3,7; 4,9	5,8	5,2; 6,3
Brasil e regiões				
Brasil	13,6	13,1; 14,2	17,1	16,6; 17,6
Norte	14,3	13,1; 15,6	16,7	15,8; 17,7
Nordeste	15,5	14,7; 16,4	17,3	16,6; 18,1
Sudeste	12,8	11,9; 13,8	17,4	16,4; 18,3
Sul	11,1	10,0; 12,3	14,7	13,7; 15,7
Centro-Oeste	16,2	15,0; 17,5	19,6	18,4; 20,8

Notas:

- *Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.
- **O consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas, em 2013, era definido pelo consumo de cinco ou mais doses de bebida alcoólica, entre os homens, e quatro ou mais doses de bebida alcoólica, entre as mulheres, em uma única ocasião. Na edição de 2019, o consumo abusivo de álcool foi definido pelo consumo de cinco ou mais doses de bebida alcoólica, tanto para os homens como para as mulheres, em uma única ocasião.
- ***Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 de março de 2025]. 1–180 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 de março de 2025]. 1–113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.2.01.2 – Prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas referido por indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18330014



Fatores de risco e proteção



FRP.2.02.1 – Prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade dirigindo veículos motorizados após consumo de bebidas alcoólicas (Vigitel)

FRP.2.02.1 – Prevalence of driving under the influence of alcohol in individuals aged 18 years and over (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referem dirigir veículos motorizados após consumo de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas, em um local e ano de referência.
- Este indicador foi introduzido na edição do Vigitel 2012, e refere-se à direção após consumo de qualquer quantidade de bebida alcóolica, adequando-se ao monitoramento da Lei nº 11.705/2008¹ ("Lei Seca").

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de indivíduos que referem dirigir veículos motorizados, após consumo de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas, na população adulta brasileira com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de indivíduos que referem dirigir veículos motorizados após consumo de bebidas alcoólicas.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção do consumo de bebidas alcoólicas e direção de veículos motorizados.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida em entrevista telefônica.
- Por se utilizar como fonte de dados o Vigitel, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Refere-se à população com 18 anos ou mais de idade residente nas capitais de UFs e no Distrito Federal.
- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).

- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada cidade. Nos anos 2020 e 2021, houve redução da amostra para mil indivíduos em cada cidade, e, em 2023, para 800 indivíduos. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão. Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)³.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade, residentes em capitais das UF's e no Distrito Federal⁴.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram dirigir veículos motorizados após consumo de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de condutores de automóveis ou motocicletas, com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam positivamente à questão “Neste dia (ou em algum destes dias), o(a) Sr.(a) dirigiu logo depois de beber?” e todos os indivíduos que responderam sempre, algumas vezes ou quase nunca à questão “Independentemente da quantidade, o(a) Sr.(a) costuma dirigir depois de consumir bebida alcoólica?”, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número total de condutores de automóvel ou motocicleta com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável peso_rake, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade, projetada para cada ano.
- Informações mais detalhadas podem ser encontradas no relatório oficial do Ministério da Saúde⁵.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais das Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância e Prevenção das Violências e Acidentes e Promoção da Cultura de Paz do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGVIVA/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de adultos que referiram, nas capitais brasileiras, dirigir veículos motorizados após consumo de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas diminuiu de 15,7% (IC95% 14,6%; 16,6%), em 2011, para 12,4% (IC95% 11,1%; 13,8%), em 2023. A redução ocorreu em ambos os sexos, variando de 19,7% (IC95% 18,5%; 20,8%) a 15,6% (IC95% 13,7%; 17,6%), no sexo masculino, e de 7,4% (IC95% 6,5%; 8,4%) a 6,9% (IC95% 5,7%; 8,2%) no sexo feminino (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência* de direção de veículos motorizados após consumo de qualquer quantidade de bebida alcoólica, entre pessoas com 18 anos ou mais de idade, segundo sexo, residentes nas capitais de Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel). Brasil, 2012 a 2023**

Ano	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2011	15,7	14,9; 16,6	19,7	18,5; 20,8	7,4	6,5; 8,4
2012	15,5	14,6; 16,6	19,2	17,9; 20,6	8,2	6,9; 9,6
2013	11,3	10,5; 12,1	14,3	13,2; 15,4	5,5	4,5; 6,6
2014	13,3	12,3; 14,3	16,9	15,5; 18,3	6,3	5,2; 7,5
2015	12,0	11,1; 12,9	15,2	14,0; 16,6	6,0	5,2; 7,0
2016	15,1	14,2; 16,0	19,0	17,7; 20,3	7,9	7,0; 9,0
2017	14,3	13,3; 15,3	17,9	16,5; 19,3	8,0	6,9; 9,3
2018	11,4	10,6; 12,2	14,2	13,1; 15,5	6,3	5,4; 7,3
2019	12,1	11,2; 13,1	15,0	13,7; 16,4	6,9	6,0; 7,9
2020	11,8	10,5; 13,3	14,3	12,4; 16,3	7,3	5,6; 8,9
2021	12,1	10,8; 14,1	16,3	13,7; 18,9	5,1	3,9; 6,3
2023	12,4	11,1; 13,8	15,6	13,7; 17,6	6,9	5,6; 8,2

- Notas:**
- *Percentual ponderado para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da capital de UF ou do Distrito Federal, projetada para cada ano do levantamento.
 - **Não houve coleta em 2022.
 - IC95%: intervalo de confiança de 95%.
 - Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008 – Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ‘institui o Código de Trânsito Brasileiro’, e a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumíferos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4o do art. 220 da Constituição Federal, para inibir o consumo de bebida alcoólica por condutor de veículo automotor, e dá outras providências. [Internet]. Diário Oficial da União. 2008 [citado 29 de março de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11705.htm
2. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Vigitel Brasil – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aims.gov.br/download/Vigitel/>
3. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2023: Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2023 [citado 12 de agosto de 2025]. 1–133 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2023.pdf

4. Ministério da Saúde. Acesse as Publicações do Ministério da Saúde sobre Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.2.02.1 – Prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade dirigindo veículos motorizados após consumo de bebidas alcoólicas (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18330288



Fatores de risco e proteção



FRP.2.02.2 – Prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade dirigindo veículos motorizados após consumo de bebidas alcoólicas (PNS)

FRP.2.02.2 – Prevalence of driving under the influence of alcohol in individuals aged 18 years and over (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de condutores de automóvel ou motocicleta que dirigiram logo depois de consumir bebida alcoólica nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de indivíduos que referem dirigir veículos motorizados após consumo de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas, na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições populacionais, geográficas, sociodemográficas e temporais da prevalência de consumo episódico pesado de bebidas alcoólicas referido, na população adulta brasileira.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção do consumo abusivo de bebidas alcoólicas e direção de veículos motorizados.

LIMITAÇÕES

- Por se tratar de medida autorrelatada em pesquisa face a face sobre comportamento realizado dos últimos 12 meses, os resultados podem ser influenciados por viés de memória do entrevistado, bem como pela ocultação de comportamentos considerados socialmente reprováveis, podendo impactar em subestimativa da prevalência.
- Não é possível obter estimativas anuais, em virtude da periodicidade da pesquisa.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- Por se utilizar como fonte de dados a PNS, que se trata de uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados da PNS, que é um inquérito amostral de saúde, de base domiciliar e de âmbito nacional, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNS foi realizada nos anos de 2013² e 2019³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de condutores de automóvel ou motocicleta com 18 anos ou mais de idade que conduzem automóvel ou motocicleta e referiram dirigir logo após consumirem bebidas alcoólicas, nos 12 meses anteriores à pesquisa, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de condutores de automóvel ou motocicleta com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam positivamente à questão “Em algum destes dias em que consumiu bebida alcoólica, o(a) Sr(a) dirigiu logo depois de beber?; “Nos últimos doze meses, quando consumiu bebida alcoólica, o(a) Sr(a) dirigiu logo depois de beber?”. “Atualmente, o(a) Sr(a) dirige automóvel (inclusive táxi, aplicativos de transporte e similares)?” e/ou “Atualmente, o(a) Sr(a) dirige motocicleta?” em um local e ano de referência.
- **Denominador:** Número total de condutores de automóvel ou motocicleta com 18 anos de idade ou mais, em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra do morador selecionado do domicílio, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral do morador selecionado.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Renda domiciliar per capita:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação de domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE _____

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Coordenação-Geral de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes e Promoção da Cultura de Paz do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGVIVA/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS _____

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de adultos que referiram dirigir veículos motorizados após consumo de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas variou de 11,8% (IC95% 10,9%; 12,7%) a 12,1% (IC95% 11,4%; 12,8%) no sexo masculino e de 2,8% (IC95% 2,3%; 3,3%) a 3,6% (IC95% 3,0%; 4,1%) no sexo feminino, nas PNS de 2013 e 2019, respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência de indivíduos (18 anos ou mais de idade) que referem dirigir veículos motorizados após consumo de qualquer quantidade de bebida alcoólica, nos últimos 12 meses, em inquérito domiciliar (PNS), segundo sexo, cor ou raça, faixa etária e regiões. Brasil, 2013 e 2019

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Sexo				
Masculino	11,8	10,9; 12,7	12,1	11,4; 12,8
Feminino	2,8	2,3; 3,3	3,6	3,0; 4,1
Cor ou raça*				
Branca	8,5	7,6; 9,3	8,7	8,0; 9,4
Preta	10,4	7,8; 13,0	9,8	8,4; 11,1
Amarela	†	-	†	-
Parda	9,8	9,8; 8,8	10,0	9,0; 10,9
Indígena	†	-	†	-
Faixa etária				
18 a 24 anos	7,7	6,3; 9,2	9,1	7,7; 10,5
25 a 34 anos	12,1	10,7; 13,5	12,4	11,3; 13,5
35 a 44 anos	10,2	8,9; 11,5	10,1	9,1; 11,1
45 a 59 anos	7,3	6,3; 8,4	8,1	6,9; 9,3
60 anos ou mais	5,0	3,6; 6,3	5,3	4,4; 6,2
Brasil, regiões e UFs				
Brasil	9,1	8,4; 9,7	9,3	8,8; 9,8
Norte	8,6	6,9; 10,2	10,2	9,1; 11,3
Acre	6,5	4,3; 8,6	4,0	2,5; 5,6
Amapá	8,6	5,6; 11,5	9,0	5,5; 12,5
Amazonas	6,9	5,1; 8,8	9,1	7,0; 11,1
Pará	9,2	5,7; 12,6	10,7	8,6; 12,8
Rondônia	7,2	4,7; 9,7	7,9	6,2; 9,5
Roraima	10,8	8,2; 13,5	10,5	8,2; 12,9
Tocantins	10,8	8,1; 13,4	15,8	12,8; 18,9

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Nordeste	11,1	9,8; 12,5	11,0	10,2; 11,9
Alagoas	8,0	5,0; 11,1	7,1	4,5; 9,6
Bahia	12,0	8,0; 16,0	11,7	9,0; 14,4
Ceará	10,4	7,4; 13,3	11,0	9,1; 12,8
Maranhão	14,1	10,2; 18,1	13,0	11,2; 14,9
Paraíba	9,0	6,4; 11,6	12,8	10,5; 15,2
Pernambuco	8,2	6,1; 10,3	7,3	5,7; 8,9
Piauí	14,8	11,8; 17,9	14,1	11,6; 16,5
Rio Grande do Norte	12,7	9,8; 15,6	9,2	7,2; 11,3
Sergipe	10,2	7,1; 13,3	14,3	11,7; 16,8
Sudeste	7,5	6,4; 8,6	8,4	7,5; 9,4
Espírito Santo	5,2	3,1; 7,2	8,6	6,9; 10,3
Minas Gerais	10,8	7,4; 14,1	9,3	7,5; 11,0
Rio de Janeiro	6,4	4,5; 8,2	6,1	4,8; 7,4
São Paulo	6,7	5,4; 7,9	8,7	7,2; 10,1
Região Sul	9,7	8,1; 11,3	8,8	7,7; 9,9
Paraná	8,8	6,4; 11,2	9,8	7,6; 12,0
Santa Catarina	10,2	7,3; 13,0	9,1	7,6; 10,5
Rio Grande do Sul	10,4	7,4; 13,5	7,4	5,8; 9,1
Centro-Oeste	10,7	9,4; 12,1	9,6	8,4; 10,8
Distrito Federal	9,1	7,2; 11,1	7,2	5,2; 9,3
Goiás	11,6	9,1; 14,1	8,2	6,3; 10,1
Mato Grosso	10,9	7,8; 13,9	12,6	9,8; 15,5
Mato Grosso do Sul	10,0	8,0; 12,1	11,4	9,4; 13,4

Notas:

- *Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- ‡Número de casos < 30 e/ou coeficiente de variação > 0,5. Estimativa suprimida, conforme critério descrito na seção "Notas".
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 de março de 2025]. 1–180 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 de março de 2025]. 1–113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.2.02.2 – Prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade dirigindo veículos motorizados após consumo de bebidas alcoólicas (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18330342



Fatores de risco e proteção



FRP.2.03 – Consumo de álcool em litros de álcool puro *per capita* (entre pessoas com 15 anos ou mais de idade) por ano

FRP.2.03 – Per capita alcohol consumption in litres of pure alcohol (15+ years) per year

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Consumo de álcool em litros de álcool puro *per capita*, entre pessoas com 15 anos ou mais de idade, por ano.
- A informação baseia-se na produção nacional, importação (reimportação), exportação e volume de álcool (graduação), para cada categoria de bebida alcóolica (álcool registrado + não registrado), ajustado pelo consumo de turistas.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a quantidade de álcool consumida *per capita*, em litros de álcool puro, considerando-se a população total com 15 anos ou mais de idade, por ano.

USOS

- Identificar a quantidade de litros de álcool puro consumida *per capita* pela população de 15 anos ou mais de idade, durante o ano calendário.
- Subsidiar ações de intervenção, monitoramento e avaliação de políticas públicas de prevenção do consumo nocivo de bebidas alcoólicas.
- É um dos indicadores-chave para o monitoramento do consumo de bebidas alcóolicas, globalmente comparável.
- O indicador compõe a lista da Agenda 2030¹ do Desenvolvimento Sustentável, sendo calculado pela primeira vez no Brasil em 2022. Também é um dos indicadores do Plano de Ação Global sobre o Álcool 2022-2030 da Organização Mundial da Saúde (OMS)², do qual o Brasil participa, enquanto Estado-membro da OMS.

LIMITAÇÕES

- Os dados têm uma defasagem de dois anos. A série histórica deve ser corrigida anualmente, para o ano atual e os dois anos anteriores, conforme correção da Pesquisa Industrial Anual – Produto (PIA Produto).
- O indicador é baseado na quantidade de álcool produzida. Essa opção metodológica pode ser afetada pela importante variação dos estoques de bebidas alcoólicas. Por outro lado, basear o indicador na quantidade de álcool vendida poderia subestimar a magnitude do indicador no Brasil.

- A PIA só considera empresas produtores com 30 empregados ou mais.
- Os dados de consumo de álcool *per capita* não registrado e de consumo *per capita* por turistas são baseados em estimativas internacionais, da Organização das Nações Unidas (ONU) e da OMS³.
- Não há estimativas subnacionais.

FONTES DE DADOS

- Pesquisa Industrial Anual – Produto (PIA-Produto)⁴.
- Estatísticas de comércio exterior (Comex Stat)⁵.
- Estatísticas de turistas da ONU⁶.
- Estatísticas da OMS⁷.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁸.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Produção de bebidas alcoólicas} + \text{importação} - \text{exportação}}{\text{População total de 15 anos ou mais de idade}} + \text{Consumo de álcool } \textit{per capita} \text{ não registrado, ajustado pelo consumo de turistas}$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Valores em litros de álcool puro (volumes de produção, importação e exportação em litros, transformados em litros de álcool puro, com base na graduação alcoólica, para cada categoria de bebida).
- Denominador: Número de indivíduos de 15 anos ou mais de idade entrevistados.

Nota:

- Para acessar o link e para a descrição detalhada do método de cálculo do indicador de consumo de álcool *per capita* (APC) no Brasil, com uso de dados nacionais, consultar a referência (9) desta ficha⁹.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A população foi atualizada com base no Censo 2022, e os dados foram atualizados em julho de 2025. A série histórica apresenta estabilidade no consumo de álcool por pessoas de 15 anos ou mais de idade (litros de álcool puro *per capita*), no período de 2007 a 2023. Observou-se uma redução mais acentuada no ano de 2020, com retomada do aumento crescente do consumo de bebidas alcóolicas no país a partir de 2021. Este aumento vai de encontro às metas estabelecidas nos planos nacionais e globais de redução (Tabela 1).

Tabela 1 – Consumo de álcool em litros de álcool puro *per capita*, entre pessoas com 15 anos ou mais de idade, por ano. Brasil, 2007 a 2023

Ano	Litros de álcool etílico puro <i>per capita</i> por ano
2007	9,5
2008	9,9
2009	10,2
2010	10,1
2011	11,0
2012	10,3
2013	9,2
2014	9,3
2015	9,3
2016	9,8
2017	9,3
2018	9,5
2019	9,9
2020	9,1
2021	9,6
2022	10,1
2023	10,3

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Brasil [Internet]. IBGE. [citado 20 de março de 2025]. Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=3>
2. Organização Pan-Americana da Saúde. Plano de ação global sobre o álcool 2022-2030. Resumo dos indicadores a serem monitorados nas Américas. OPAS [Internet]. 2022 [citado 20 de março de 2025]; Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/56638>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Indicador 3-5-2: Consumo de álcool em litros de álcool puro *per capita* (com 15 anos ou mais) por ano [Internet]. IBGE. [citado 20 de março de 2025]. Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/objetivo3/indicador352>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Industrial Anual – PIA-Produto [Internet]. IBGE. 2022 [citado 20 de março de 2025]. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pia-produto/tabelas>
5. Ministério do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Serviços. ComexStat – Estatísticas de Comércio Exterior [Internet]. MDIC. [citado 20 de março de 2025]. Disponível em: <https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>
6. World Health Organization. Alcohol, tourist consumption (in litres of pure alcohol), three-year average [Internet]. WHO. [citado 2 de novembro de 2025]. Disponível em: [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/alcohol-tourist-consumption-\(in-litres-of-pure-alcohol\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/alcohol-tourist-consumption-(in-litres-of-pure-alcohol))
7. World Health Organization. Alcohol, unrecorded per capita (15+) consumption (in litres of pure alcohol), three-year average [Internet]. WHO. [citado 2 de novembro de 2025]. Disponível em: [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/alcohol-unrecorded-per-capita-\(15-\)-consumption-\(in-litres-of-pure-alcohol\)-with-95-ci](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/alcohol-unrecorded-per-capita-(15-)-consumption-(in-litres-of-pure-alcohol)-with-95-ci)
8. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População [Internet]. IBGE. 2024 [citado 20 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
9. Freitas PC, Silva LES, Oliveira PPV, Gouvêa E de CDP, Fronteira I, Machado IE, et al. Cálculo do indicador de consumo de álcool *per capita* no Brasil: uso de dados nacionais [Internet]. Rev Panam Salud Publica. 2024;48:e54. [citado 14 de agosto de 2025]. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/60460>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.2.03 – Consumo de álcool em litros de álcool puro *per capita* (entre pessoas com 15 anos ou mais de idade) por ano [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18330378



Fatores de risco e proteção



FRP.3.01.1 – Prevalência de fumantes atuais com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)

FRP.3.01.1 – Prevalence of current smokers aged 18 years and over (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de fumantes na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- Considera-se fumante o indivíduo que fuma atualmente, independentemente do produto, da quantidade, da frequência e da duração.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de fumantes atuais na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, residente em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de fumantes atuais na população brasileira com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e controle do tabagismo.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida em entrevista telefônica.
- Por se utilizar como fonte de dados o Vigitel, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Refere-se à população com 18 anos ou mais de idade residente nas capitais das Unidades da Federação (UFs) e no Distrito Federal.
- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).
- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada capital e no Distrito Federal. Nos anos 2020 e 2021, houve redução da amostra para mil indivíduos, e, em 2023, para 800 indivíduos. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão. Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade, residentes em capitais das UFs e no Distrito Federal².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram fumar atualmente, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam positivamente (“Sim, diariamente” ou “Sim, mas não diariamente”) à questão “Atualmente, o(a) Sr.(a) fuma?”, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável *peso_rake*, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta das capitais das UFs ou do Distrito Federal, projetada para cada ano.
- Informações mais detalhadas podem ser encontradas no relatório oficial do Ministério da Saúde³.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de fumantes na população brasileira com 18 anos ou mais de idade apresentou redução no período de 2006 a 2023, variando de 15,6% (IC95% 14,9%; 16,3%) para 9,3% (IC95% 8,4%; 10,1%), em relação à população total.

A redução ocorreu em ambos os sexos, sendo maior entre as pessoas do sexo masculino, para as quais a prevalência passou de 19,3% (IC95% 18,2%; 20,5%), em 2006, para 11,7% (IC95% 10,2%; 13,2%), em 2023.

Para as pessoas do sexo feminino, a prevalência diminuiu de 12,4% (IC95% 11,7%; 13,1%), em 2006, para 7,2% (IC95% 6,3%; 8,2%), em 2023. As maiores prevalências foram observadas no sexo masculino, em todos os anos (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência* de fumantes atuais** entre pessoas com 18 anos ou mais de idade, segundo sexo, residentes nas capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel). Brasil, 2006 a 2023***

Ano	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2006	15,6	14,9; 16,3	19,3	18,2; 20,5	12,4	11,7; 13,1
2007	15,7	15,0; 16,3	19,6	18,4; 20,8	12,3	11,6; 13,1
2008	14,8	14,1; 15,4	18,0	16,9; 19,2	12,0	11,2; 12,7
2009	14,3	13,6; 15,0	17,5	16,4; 18,7	11,5	10,8; 12,3
2010	14,1	13,4; 14,8	16,8	15,6; 18,0	11,7	11,0; 12,5
2011	13,4	12,7; 14,0	16,5	15,5; 17,6	10,7	9,9; 11,4
2012	12,1	11,4; 12,8	15,5	14,3; 16,7	9,2	8,5; 9,9
2013	11,3	10,6; 11,9	14,4	13,3; 15,5	8,6	7,9; 9,3
2014	10,8	10,1; 11,4	12,8	11,7; 14,0	9,0	8,2; 9,8
2015	10,4	9,7; 11,0	12,8	11,7; 14,0	8,3	7,5; 9,0
2016	10,2	9,5; 10,8	12,7	11,7; 13,7	8,0	7,3; 8,7
2017	10,1	9,5; 10,8	13,2	12,1; 14,3	7,5	6,8; 8,2
2018	9,3	8,6; 9,9	12,1	11,0; 13,2	6,9	6,2; 7,5
2019	9,8	9,2; 10,5	12,3	11,2; 13,5	7,7	7,1; 8,4
2020	9,5	8,5; 10,4	11,7	10,2; 13,3	7,6	6,4; 8,7
2021	9,1	8,2; 9,9	11,8	10,3; 13,3	6,7	5,8; 7,7
2023	9,3	8,4; 10,1	11,7	10,2; 13,2	7,2	6,3; 8,2

- Notas:**
- *Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da capital de UF e do Distrito Federal, projetada para cada ano do levantamento.
 - **Considera-se fumante o indivíduo que fuma atualmente, independentemente do produto, da quantidade, da frequência e da duração.
 - ***Não houve coleta em 2022.
 - IC95%: intervalo de confiança de 95%.
 - Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/download/Vigitel/>

2. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2006-2023: tabagismo e consumo abusivo de álcool: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito

- Federal entre 2006 e 2023 [Internet]. 2023 [citado 19 de março de 2025]. p. 1–70. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel/vigitel-brasil-2006-2023-tabagismo-e-consumo-abusivo-de-alcool/view>
3. Ministério da Saúde. Acesse as Publicações do Ministério da Saúde sobre Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.3.01.1 – Prevalência de fumantes atuais com 18 anos ou mais de idade (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18330485



Fatores de risco e proteção



FRP.3.01.2 – Prevalência de fumantes atuais com 18 anos ou mais de idade (PNS)

FRP.3.01.2 – Prevalence of current smokers aged 18 years and over (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de fumantes na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- Considera-se fumante o indivíduo que atualmente fuma produtos derivados do tabaco que emitem fumaça*, independentemente do produto, da quantidade, da frequência e da duração.

Nota:

- *Produtos derivados do tabaco que emitem fumaça, tais como cigarros industrializados, cigarros de palha, charutos, cigarrilhas, cachimbos, cigarros de cravo (ou de Bali) e narguilé (ou cachimbos d'água).

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de fumantes atuais na população brasileira com 18 anos ou mais de idade.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de fumantes na população brasileira com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar ações de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de prevenção e controle do tabagismo.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida.
- Não é possível obter estimativas anuais, em virtude da periodicidade da pesquisa.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- Por se utilizar como fonte de dados a PNS, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados da PNS, que é um inquérito amostral de saúde, de base domiciliar e de âmbito nacional, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNS foi realizada nos anos de 2013² e 2019³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram fumar atualmente, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam positivamente (“Sim, diariamente” ou “Sim, menos que diariamente”) à questão “Atualmente, o(a) Sr.(a) fuma algum produto do tabaco?”, em um local e ano de referência.
- **Denominador:** Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral do morador selecionado.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE**Cor ou raça:**

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Renda domiciliar per capita:

- Até ¼ do salário mínimo;
- Mais de ¼ até ½ salário mínimo;
- Mais de ½ até 1 salário mínimo;

- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade fumantes no Brasil passou de 14,7% (IC95% 14,2%; 15,2%), em 2013, para 12,6% (IC95% 12,2%; 13,0%) em 2019. Essa redução foi observada no mesmo período para ambos os sexos: de 18,8% (IC95% 18,0%; 19,6%) para 15,9% (IC95% 15,3%; 16,6%), no sexo masculino; e de 11,0% (IC95% 10,4%; 11,5%) para 9,6% (IC95% 9,2%; 10,1%), no sexo feminino, respectivamente. Em ambos os anos do inquérito, a prevalência de fumantes foi maior no sexo masculino.

Nos dois anos considerados, a prevalência de fumantes foi maior na faixa etária de 45 a 59 anos, variando de 20,2% (IC95% 19,1%; 21,4%), em 2013, para 13,5% (IC95% 12,4%; 14,7%), em 2019; e menor para a cor ou raça branca, sendo de 12,8% (IC95% 12,2%; 13,5%), em 2013, e de 11,6% (IC95% 11,1%; 12,3%) em 2019.

Adicionalmente, foi observada redução importante na prevalência de fumantes entre indivíduos de cor ou raça preta ou parda. Em 2019, as regiões Norte, com 10,5% (IC95% 9,7%; 11,3%), e Nordeste, com 10,8% (IC95% 10,2%; 11,4%), apresentaram menores prevalências de fumantes em relação às demais (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência de fumantes atuais* entre pessoas com 18 anos ou mais de idade, em inquérito domiciliar (PNS), segundo sexo, cor ou raça, faixa etária e regiões. Brasil, 2013 e 2019

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Sexo				
Masculino	18,8	18,0; 19,6	15,9	15,3; 16,6
Feminino	11,0	10,4; 11,5	9,6	9,2; 10,1
Cor ou raça**				
Branca	12,8	12,2; 13,5	11,6	11,1; 12,3
Preta	17,7	15,9; 19,7	13,5	12,4; 14,7
Amarela	11,2	7,8; 15,8	11,1	7,8; 15,6
Parda	16,1	15,3; 16,9	13,3	12,7; 13,9
Indígena	20,8	14,2; 29,6	15,3	10,9; 21,1
Faixa etária				
18 a 24 anos	10,5	9,3; 11,7	10,6	9,5; 11,8
25 a 34 anos	12,4	11,5; 13,4	11,8	11,0; 12,7
35 a 44 anos	15,2	14,1; 16,2	12,1	11,2; 13,0
45 a 59 anos	20,2	19,1; 21,4	15,5	14,6; 16,3
60 anos ou mais	12,6	11,5; 13,7	11,4	10,7; 12,1
Brasil e regiões				
Brasil	14,7	14,2; 15,2	12,6	12,2; 13,0
Norte	13,4	11,9; 14,8	10,5	9,7; 11,3
Nordeste	14,2	13,4; 15,0	10,8	10,2; 11,4
Sudeste	14,9	14,0; 15,7	13,3	12,5; 14,0
Sul	16,0	14,6; 17,3	14,7	13,7; 15,6
Centro-Oeste	13,4	12,4; 14,4	13,1	12,2; 14,0

Notas:

- *Considera-se fumante o indivíduo que atualmente fuma produtos derivados do tabaco que emitem fumaça, independentemente do produto, da quantidade, da frequência e da duração.
- **Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 de março de 2025]. 1–180 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 de março de 2025]. 1–113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.3.01.2 – Prevalência de fumantes atuais com 18 anos ou mais de idade (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18330577



Fatores de risco e proteção



FRP.3.02.1 – Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)

FRP.3.02.1 – Prevalence of current use of electronic smoking devices in individuals aged 18 years and older (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar (DEF) em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- São considerados DEF aparelhos eletrônicos com nicotina líquida ou folha de tabaco picado, tais como cigarro eletrônico, vape, narguilé eletrônico, cigarro aquecido ou outro dispositivo eletrônico para fumar ou vaporizar¹.
- Considera-se usuário de DEF o indivíduo que usa atualmente, independentemente do tipo do dispositivo eletrônico, da quantidade, da frequência e da duração.
- Este indicador é estimado a partir de dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade residentes em capitais das Unidades da Federação (UFs) e no Distrito Federal.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de uso atual de DEF na população brasileira com 18 anos ou mais de idade residente nas capitais das UFs e no Distrito Federal, em um ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de uso atual de DEF na população com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao controle do tabagismo.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida em entrevista telefônica.
- Por se utilizar como fonte de dados o Vigitel, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

- Refere-se à população com 18 anos ou mais de idade residente nas capitais de UFs e no Distrito Federal.
- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).
- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada capital de UF e no Distrito Federal. Nos anos 2020 e 2021, houve redução dessa amostra para mil indivíduos, e, em 2023, para 800 indivíduos. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão. Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram usar DEF atualmente, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam “Sim, diariamente” ou “Sim, menos do que diariamente” à questão “O(a) Sr.(a) usa aparelhos eletrônicos com nicotina líquida ou folha de tabaco picado (cigarro eletrônico, narguilé eletrônico, cigarro aquecido ou outro dispositivo eletrônico) para fumar ou vaporizar? (Não considere o uso de maconha)”, independentemente da quantidade, da frequência e da duração, em um local e ano de referência.
- **Denominador:** Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

Notas:

- No cálculo dos números que compõem o numerador e o denominador, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável `peso_rake`, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada capital de UF ou do Distrito Federal, projetada para cada ano.
- Mais informações estão disponíveis no relatório oficial do Ministério da Saúde¹.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;

- 45 a 54 anos;
- 55 a 64 anos; e
- 65 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação nos resultados.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de indivíduos que referiram uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar (diariamente ou ocasionalmente) manteve-se relativamente estável no período de 2019 a 2023 (Tabela 1). Situação semelhante foi observada em ambos os sexos, embora a prevalência tenha sido maior entre indivíduos do sexo masculino, em comparação ao feminino.

Tabela 1 – Prevalência (%) do uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade residentes em capitais de Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel), segundo sexo. Brasil, 2019 a 2023*

Ano	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2019	2,3	2,0; 2,7	3,3	2,7; 4,0	1,5	1,2; 1,9
2020	2,5	1,9; 3,3	3,7	2,7; 5,2	1,5	0,9; 2,5
2021	2,2	1,8; 2,8	2,8	2,2; 3,7	1,7	1,2; 2,4
2023	2,1	1,7; 2,5	2,9	2,2; 3,7	1,4	1,0; 1,9

Notas:

- *Os dados são do Vigitel; não houve coleta no ano de 2022.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança de 95% do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Percentual ponderado para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da capital de UF ou do Distrito Federal, projetada para cada ano do levantamento.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (BR). Vigitel Brasil 2006-2023: tabagismo e consumo abusivo de álcool: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2023 [Internet]. 2023 [citado 19 de março de 2025]. p. 1-70. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel/vigitel-brasil-2006-2023-tabagismo-e-consumo-abusivo-de-alcool/view>
2. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Vigitel Brasil – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/download/Vigitel/>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.3.02.1 – Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18330726



Fatores de risco e proteção



FRP.3.02.2 – Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)

FRP.3.02.2 – Prevalence of current use of electronic smoking devices in individuals aged 18 years and older (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar (DEF) em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- São considerados DEF aparelhos eletrônicos com nicotina líquida ou folha de tabaco picado, tais como cigarro eletrônico, vape, narguilé eletrônico, cigarro aquecido ou outro dispositivo eletrônico para fumar ou vaporizar.
- Considera-se usuário de DEF o indivíduo que usa atualmente, independentemente do tipo do dispositivo eletrônico, da quantidade, da frequência e da duração.
- Este indicador é estimado a partir de dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), que é um inquérito amostral de saúde, de base domiciliar e de âmbito nacional, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNS foi realizada nos anos de 2013¹ e 2019².

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de uso atual de DEF na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, residente em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de uso atual de DEF na população brasileira com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao controle do tabagismo.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida.
- Não é possível obter estimativas anuais, em virtude da periodicidade da pesquisa.
- Por questões metodológicas, a PNS permite a análise para as categorias de cor ou raça amarela e indígena somente para o Brasil e nas situações em que houver um número de entrevistas maior que 31 e coeficiente de variação menor que 15. Para a análise não estratificada por cor ou raça, foram considerados todos os indivíduos entrevistados.

- Por se utilizar como fonte de dados a PNS, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram usar DEF atualmente, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam “Sim, diariamente” ou “Sim, menos do que diariamente” à questão “Você usa cigarro eletrônico ou outros aparelhos eletrônicos com nicotina líquida ou folha de tabaco picado para fumar ou vaporizar?”, independentemente da quantidade, da frequência e da duração, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- No cálculo dos números que compõem o numerador e o denominador, deve-se considerar o desenho complexo da amostra, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral do morador selecionado.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Renda domiciliar per capita:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE _____

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS _____

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de casos é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No ano de 2019, a prevalência do uso atual de DEF, em indivíduos com 18 ou mais anos de idade, foi de 0,5%. A prevalência pontual foi mais alta entre os homens (0,7%), bem como entre pessoas de cor ou raça branca (0,6%) e adultos de 18 a 24 anos de idade (2,3%).

Esse percentual variou entre as regiões. A prevalência pontual de uso atual de DEF na região Centro-Oeste foi a mais elevada (1,1%), enquanto as regiões Norte e Nordeste exibiram as prevalências mais baixas (0,1%) (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%) de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar, em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em inquérito domiciliar (PNS), segundo sexo, cor ou raça, faixa etária e regiões. Brasil, 2019*

Variáveis e categorias	%	IC95%
Sexo		
Masculino	0,7	0,6; 0,9
Feminino	0,3	0,2; 0,5
Cor ou raça		
Branca	0,6	0,4; 0,8
Preta	0,6	0,3; 0,9
Amarela	‡	‡
Parda	0,4	0,3; 0,6
Indígena	‡	‡
Faixa etária		
18 a 24 anos	2,3	1,7; 2,9
25 a 34 anos	0,8	0,5; 1,1
35 a 44 anos	0,2	0,1; 0,2
45 a 59 anos	‡	‡
60 anos ou mais	‡	‡
Região		
Brasil	0,5	0,4; 0,6
Norte	‡	‡
Nordeste	0,1	0,1; 0,2
Sudeste	0,6	0,4; 0,8
Sul	0,9	0,6; 1,2
Centro-Oeste	1,1	0,8; 1,4

Notas:

- *Dados da PNS de 2019.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos IC95% do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

- Coeficiente de variação > 0,3. Estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão.
- ‡Número de casos < 30 e/ou coeficiente de variação > 0,5. Estimativa suprimida, conforme critério descrito na seção “Notas”.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 de março de 2025]. 1–180 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 de março de 2025]. 1–113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.3.02.2 – Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18331108



Fatores de risco e proteção



FRP.3.02.3 – Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em escolares de 13 a 17 anos de idade (PeNSE)

FRP.3.02.3 – Prevalence of current use of electronic smoking devices among schoolchildren aged 13 to 17 years (PeNSE)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência do uso de dispositivos eletrônicos para fumar (DEF) nos últimos 30 dias, em escolares de 13 a 17 anos de idade, em um local e ano de referência.
- Considera-se usuário de DEF o indivíduo que usou cigarro eletrônico nos últimos 30 dias, independentemente da quantidade, da frequência e da duração.
- Este indicador é estimado a partir de dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), que é um inquérito nacional de base escolar coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com o apoio do Ministério da Educação.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de uso atual de DEF em escolares de 13 a 17 anos de idade, que frequentam escolas públicas e privadas, em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de uso atual de DEF em escolares de 13 a 17 anos de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao controle do tabagismo.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida.
- Não é possível obter estimativas anuais, em virtude da periodicidade da pesquisa.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PeNSE não coleta informações em escolas localizadas em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- Por se utilizar como fonte de dados da PeNSE, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de escolares de 13 a 17 anos de idade que referiram usar cigarro eletrônico nos últimos 30 dias, em um local e ano de referência}}{\text{Número de escolares de 13 a 17 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número estimado de escolares de 13 a 17 anos de idade que responderam “Cigarro eletrônico (e-cigarette)” à questão “Nos últimos 30 dias, qual(is) desses outros produtos do tabaco você usou?”, independentemente da quantidade, da frequência e da duração, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número estimado de escolares de 13 a 17 anos de idade, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra do PeNSE.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 13 a 15 anos; e
- 16 a 17 anos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Trienal.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem as condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2019, a prevalência de uso atual de cigarro eletrônico, entre os escolares de 13 a 17 anos de idade, foi de 2,8%. A prevalência foi maior entre escolares do sexo masculino, em comparação com o feminino; e na faixa etária de 16 a 17 anos, em relação à de 13 a 15 anos. Entre as regiões brasileiras, as regiões Centro-Oeste e Sul exibiram as maiores prevalências, enquanto as regiões Norte e Nordeste, as menores (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%) de uso atual de cigarros eletrônicos, em escolares de 13 a 17 anos de idade, em inquérito escolar (PeNSE), segundo sexo, cor ou raça, faixa etária e regiões. Brasil, 2019*

Variáveis e categorias	%	IC95%
Sexo		
Masculino	3,3	3,0; 3,6
Feminino	2,3	2,1; 2,6
Cor ou raça		
Branca	3,3	3,0; 3,7
Preta	2,8	2,3; 3,3
Amarela	†	†
Parda	2,4	2,1; 2,7
Indígena	†	†
Faixa etária		
13 a 15 anos	2,3	2,1; 2,6

Variáveis e categorias	%	IC95%
16 a 17 anos	3,7	3,3; 4,2
Regiões		
Brasil	2,8	2,6; 3,0
Norte	1,6	1,4; 1,9
Nordeste	1,8	1,5; 2,1
Sudeste	3,3	2,8; 3,7
Sul	3,7	3,2; 4,4
Centro-Oeste	4,4	4,0; 4,8

- Notas:**
- *Dados da PeNSE de 2019.
 - IC95%: intervalo de confiança de 95%.
 - Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.
 - ‡Número de casos < 30 e/ou coeficiente de variação > 0,5: estimativa suprimida conforme critério descrito na seção “Notas”.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PeNSE – Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar [Internet]. IBGE. [citado 28 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/9134-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar.html?edicao=31442&t=downloads>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.3.02.3 – Prevalência de uso atual de dispositivos eletrônicos para fumar em escolares de 13 a 17 anos de idade (PeNSE) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18331302



Fatores de risco e proteção



FRP.3.03.1 – Prevalência de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)

FRP.3.03.1 – Prevalence of former smokers in individuals aged 18 years and over (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de ex-fumantes entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- Considera-se ex-fumante o indivíduo que fumou no passado e que não se autodeclarou fumante atual na data da entrevista, independentemente do produto, da quantidade, da frequência e do tempo em que deixou de fumar.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade, residentes em capitais de Unidades da Federação (UFs) e no Distrito Federal, que atualmente não fumam e que referiram ter fumado no passado.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de ex-fumantes na população brasileira com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de controle do tabagismo, especificamente em relação ao impacto de ações de cessação de tabagismo.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida em entrevista telefônica.
- Por se utilizar como fonte de dados o Vigitel, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Refere-se à população com 18 anos ou mais de idade residente nas capitais de UFs e no Distrito Federal.
- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa, e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).
- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada capital de UF e no Distrito Federal. Nos anos 2020 e 2021, houve redução da amostra para mil indivíduos, e, em 2023, para 800 indivíduos. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão. Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade, residentes em capitais de UFs e no Distrito Federal².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam negativamente à questão “Atualmente, o(a) Sr.(a) fuma?” e que responderam positivamente (“sim, diariamente” ou “sim, mas não diariamente”) à questão “No passado, o(a) Sr.(a) já fumou?”, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável *peso_rake*, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de capitais de UFs e do Distrito Federal, projetada para cada ano.
- Informações mais detalhadas podem ser encontradas nos relatórios oficiais do Ministério da Saúde³.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem as condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade residentes em capitais das UFs e no Distrito Federal diminuiu, passando de 22,3% (IC95% 21,5%; 23,0%), em 2006, para 20,1% (IC95% 19,0%; 21,3%) em 2023. Por outro lado, não foi observada redução relevante da prevalência de ex-fumantes, para ambos os sexos, entre 2006 e 2023.

A prevalência para o sexo masculino, em 2006, foi de 26,7% (IC95% 25,5%; 27,9%), e, em 2023, foi de 23,8% (IC95% 21,9%; 25,8%); a prevalência para o sexo feminino, em 2006, foi de 18,5% (IC95% 17,7%; 19,3%), e, em 2023, foi de 17,0% (IC95% 15,6%; 18,4%). A prevalência foi maior no sexo masculino, em todos os anos considerados (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%)* de ex-fumantes** entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, segundo sexo, residentes nas capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel). Brasil, 2006 a 2023***

Ano	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2006	22,3	21,5; 23,0	26,7	25,5; 27,9	18,5	17,7; 19,3
2007	22,9	22,2; 23,7	26,9	25,7; 28,2	19,5	18,7; 20,4
2008	22,3	21,6; 23,0	26,2	25,0; 27,4	18,9	18,1; 19,7
2009	22,4	21,7; 23,2	26,8	25,5; 28,1	18,7	17,9; 19,6
2010	22,6	21,9; 23,4	26,5	25,3; 27,7	19,3	18,4; 20,2

Ano	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2011	22,1	21,4; 22,8	25,8	24,7; 26,9	18,9	18,1; 19,8
2012	21,0	20,3; 21,8	24,5	23,3; 25,8	18,1	17,2; 19,0
2013	22,0	21,3; 22,7	25,6	24,4; 26,8	18,9	18,1; 19,8
2014	21,3	20,5; 22,1	25,6	24,3; 27,0	17,5	16,6; 18,5
2015	20,8	20,0; 21,5	23,8	22,6; 25,0	18,2	17,3; 19,1
2016	21,4	20,7; 22,1	25,8	24,6; 27,0	17,7	16,9; 18,5
2017	20,3	19,6; 21,0	24,2	23,0; 25,4	16,9	16,1; 17,8
2018	20,2	19,5; 20,9	24,2	23,0; 25,4	16,8	16,0; 17,7
2019	19,7	19,0; 20,5	24,2	22,9; 25,5	16,0	15,2; 16,8
2020	20,8	19,7; 22,0	25,5	23,6; 27,4	16,9	15,7; 18,2
2021	18,9	17,8; 20,0	23,1	21,3; 25,0	15,2	14,0; 16,6
2023	20,1	19,0; 21,3	23,8	21,9; 25,8	17,0	15,6; 18,4

- Notas:**
- *Percentual ponderado para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta das capitais de UFs e do Distrito Federal, projetada para cada ano do levantamento.
 - **Considera-se ex-fumante o indivíduo que fumou no passado e que não se autodeclarou fumante atual na data da entrevista, independentemente do produto, da quantidade, da frequência e do tempo em que deixou de fumar.
 - ***Não houve coleta em 2022.
 - IC95%: intervalo de confiança de 95%.
 - Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aims.gov.br/download/Vigitel/>
2. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2006-2023: tabagismo e consumo abusivo de álcool: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2023 [Internet]. 2023 [citado 19 de março de 2025]. p. 1-70. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel/vigitel-brasil-2006-2023-tabagismo-e-consumo-abusivo-de-alcool/view>
3. Ministério da Saúde. Acesse as Publicações do Ministério da Saúde sobre Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.3.03.1 – Prevalência de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18331338



Fatores de risco e proteção



FRP.3.03.2 – Prevalência de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade (PNS)

FRP.3.03.2 – Prevalence of former smokers in individuals aged 18 years and over (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de ex-fumantes entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- Considera-se ex-fumante o indivíduo que fumou produtos oriundos do tabaco que emitem fumaça*, no passado, e que não se autodeclarou fumante atual na data da entrevista, independentemente do produto, da quantidade, da frequência** e do tempo em que deixou de fumar.

Notas:

- *Produtos derivados do tabaco que emitem fumaça, tais como cigarros industrializados, cigarros de palha, charutos, cigarrilhas, cachimbos, cigarros de cravo (ou de Bali) e narguilé (ou cachimbos d'água).
- **Não importa se o usuário foi, no passado, fumante diário ou ocasional, mas é necessário que ele tenha fumado por pelo menos três meses ocasionalmente ou por pelo menos um mês diariamente.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais de idade, residentes em um local e ano de referência, que atualmente não fumam e que referiram ter fumado produtos derivados do tabaco no passado.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de ex-fumantes na população brasileira com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de controle do tabagismo, especificamente em relação ao impacto de ações de cessação de tabagismo.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida.
- Não é possível obter estimativas anuais, em virtude da periodicidade da pesquisa.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

- Por se utilizar como fonte de dados a PNS, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados da PNS, que é um inquérito amostral de saúde, de base domiciliar e de âmbito nacional, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNS foi realizada nos anos de 2013² e 2019³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que responderam negativamente à questão “Atualmente o(a) Sr.(a) fuma algum produto do tabaco?” e que responderam positivamente (“sim, diariamente” ou “sim, menos que diariamente”) à questão “E no passado, o(a) Sr.(a) fumou algum produto do tabaco?”, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral do morador selecionado.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Renda domiciliar per capita:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE _____

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS _____

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem as condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de casos é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de ex-fumantes entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, no Brasil, aumentou de 17,5% (IC95% 16,9%; 18,1%), em 2013, para 26,6% (IC95% 26,1%; 27,2%) em 2019. Esse aumento foi observado em ambos os sexos.

Em 2013, foi observada maior prevalência de ex-fumantes entre indivíduos do sexo masculino, correspondendo a 21,3% (IC95% 20,4%; 22,2%), em contraste com indivíduos do sexo feminino, que apresentaram prevalência de 14,1% (IC95% 13,5%; 14,8%).

Em 2019, as referidas prevalências, segundo sexo, foram muito semelhantes. Em ambos os anos, verificou-se aumento da prevalência de ex-fumantes com o aumento da faixa etária, e não se observaram diferenças relevantes de prevalências considerando-se as categorias de cor ou raça. Em 2019, as menores prevalências de ex-fumantes foram observadas nas regiões Norte e Centro-Oeste, equivalentes a 23,2% (IC95% 22,0%; 24,5%) e 23,5% (IC95% 22,2%; 24,8%), respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência de ex-fumantes (%)* entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em inquérito domiciliar (PNS), segundo sexo, cor ou raça e faixa etária. Brasil e regiões, 2013 e 2019

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Sexo				
Masculino	21,3	20,4; 22,2	26,8	26,0; 27,5
Feminino	14,1	13,5; 14,8	26,5	25,7; 27,2
Cor ou raça**				
Branca	17,8	17,0; 18,7	26,4	25,5; 27,3
Preta	16,0	14,4; 17,8	28,8	27,2; 30,5
Amarela	16,4	11,7; 22,4	25,4	20,6; 30,8
Parda	17,4	16,6; 18,2	26,2	25,5; 27,0
Indígena	20,2	14,2; 27,9	29,1	22,8; 36,2
Faixa etária				
18 a 24 anos	5,7	4,9; 6,6	18,6	17,1; 20,3
25 a 34 anos	11,0	10,0; 12,1	18,9	17,6; 20,3
35 a 44 anos	13,4	12,4; 14,6	19,2	18,3; 20,2
45 a 59 anos	23,6	22,5; 24,9	29,0	27,9; 30,2
60 anos ou mais	31,4	29,9; 32,9	42,2	41,1; 43,4
Brasil e regiões				
Brasil	17,5	16,9; 18,1	26,6	26,1; 27,2
Norte	16,7	15,5; 18,0	23,2	22,0; 24,5
Nordeste	18,1	17,2; 19,1	27,0	26,2; 27,8
Sudeste	17,2	16,2; 18,2	27,5	26,5; 28,6
Sul	18,3	16,9; 19,8	26,7	25,6; 27,9
Centro-Oeste	16,3	15,1; 17,5	23,5	22,2; 24,8

Notas:

- *Considera-se ex-fumante o indivíduo que fumou no passado produtos derivados do tabaco que emitem fumaça e que não se autodeclarou fumante atual na data da entrevista, independentemente do produto, da quantidade, da frequência e do tempo em que deixou de fumar.
- **Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 de março de 2025]. 1-180 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 de março de 2025]. 1-113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.3.03.2 – Prevalência de ex-fumantes com 18 anos ou mais de idade (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18331373



Fatores de risco e proteção



FRP.4.01.1 – Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)

FRP.4.01.1 – Prevalence of recommended levels of physical activity during leisure time in individuals aged 18 years and over (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre, entre indivíduos com 18 ou mais anos de idade, em um local e ano de referência.
- Considera-se como nível recomendado de atividade física no tempo livre a prática de no mínimo 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou no mínimo 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa¹⁻³.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de prática de atividade física no tempo livre em nível recomendado, na população com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência. A prevalência é estimada para o período de três meses anteriores à entrevista, no ano da realização do Vigitel.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de prática de atividade física no tempo livre de nível recomendado, na população com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para a promoção da prática de atividade física no tempo livre.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida em entrevista telefônica.
- Por se utilizar como fonte de dados o Vigitel, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Refere-se à população com 18 anos ou mais de idade, residente nas capitais de Unidades da Federação (UFs) e no Distrito Federal.
- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).
- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada capital de UF e no Distrito Federal. Nos anos de 2020 e 2021, houve redução dessa amostra

para mil indivíduos, e, em 2023, para 800 indivíduos. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão. Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)⁴.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade, residentes em capitais das UFs e no Distrito Federal⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram praticar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram praticar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, conforme as respostas dadas às seguintes questões: “Nos últimos três meses, o(a) Sr.(a) praticou algum tipo de exercício físico ou esporte?”, “Qual o tipo principal de exercício físico ou esporte que o(a) Sr.(a) praticou?”, “O(a) Sr.(a) pratica o exercício pelo menos uma vez por semana?”, “Quanto dias por semana o(a) Sr.(a) costuma praticar exercício físico ou esporte?” e “No dia que o(a) Sr.(a) pratica exercício ou esporte, quanto tempo dura essa atividade?”, em um local e ano de referência.
- **Denominador:** Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

Notas:

- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável *peso_rake*, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta das capitais de UFs e do Distrito Federal, projetada para cada ano.
- Informações mais detalhadas podem ser encontradas nos relatórios oficiais do Ministério da Saúde⁶.

Para o cálculo do indicador, deve-se proceder conforme especificado a seguir.

1. Definir a intensidade das atividades
 - a. Atividades de intensidade moderada: caminhada, caminhada em esteira, musculação, hidroginástica, ginástica em geral, natação, artes marciais e luta, ciclismo, voleibol/futevôlei, dança^{1,3}.

- c. Atividades de intensidade vigorosa: corrida, corrida em esteira, ginástica aeróbica, futebol/futsal, basquetebol, tênis^{1,3}.
2. Recodificar frequência
 - d. As categorias de frequência devem ser recodificadas em dias, de forma contínua.
3. Recodificar duração
 - a. As categorias de duração devem ser recodificadas em minutos, de forma contínua.
4. Criar uma variável contínua
 - a. Multiplicar a intensidade, a frequência e a duração da atividade física, para se obter uma variável contínua.
5. Criação da variável binária de tempo recomendado
 - a. Considerar como indivíduos que praticam atividade física no tempo recomendado aqueles que atingem pelo menos 150 minutos na variável contínua obtida no passo anterior².

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem as condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, de 2009 a 2023, a prevalência da prática de nível recomendado de atividade física no tempo livre, entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, apresentou aumento, passando de 30,3% (IC95% 29,5%; 31,1%) para 40,6% (IC95% 39,1%; 42,1%). Tal aumento ocorreu em ambos os sexos: de 39,8% (IC95% 38,4%; 41,1%) para 45,8% (IC95% 43,5%; 48,1%), no sexo masculino; e de 22,2% (IC95% 21,3%; 23,0%) para 36,2% (IC95% 34,3%; 38,1%), no feminino (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%)* de prática de atividade física no tempo livre em nível recomendado,** entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade residentes nas capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel), segundo sexo, 2009 a 2023***

Ano	Masculino		Feminino		Total	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2009	39,8	38,4; 41,1	22,2	21,3; 23,0	30,3	29,5; 31,1
2010	40,0	38,6; 41,4	22,4	21,6; 23,3	30,5	29,7; 31,4
2011	40,4	39,1; 41,7	24,1	23,2; 25,0	31,6	30,8; 32,4
2012	41,5	40,1; 43,0	26,5	25,5; 27,5	33,5	32,6; 34,3
2013	41,2	39,9; 42,5	27,4	26,5; 28,3	33,8	33,0; 34,6
2014	41,6	40,0; 43,2	30,0	28,8; 31,1	35,3	34,4; 36,3
2015	45,6	44,1; 47,1	30,8	29,7; 31,9	37,6	36,7; 38,5
2016	46,6	45,1; 48,0	29,9	28,9; 31,0	37,6	36,7; 38,5
2017	43,4	41,9; 44,9	31,5	30,4; 32,6	37,0	36,1; 37,9
2018	45,4	43,9; 46,8	31,8	30,8; 32,9	38,1	37,2; 39,0
2019	46,7	45,2; 48,3	32,4	31,3; 33,5	39,0	38,0; 39,9
2020	44,2	41,9; 46,4	30,5	29,0; 32,1	36,8	35,4; 38,1
2021	43,1	40,8; 45,5	31,3	29,5; 33,0	36,7	35,3; 38,2
2023	45,8	43,5; 48,1	36,2	34,3; 38,1	40,6	39,1; 42,1

Notas:

- *Percentual ponderado para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta das capitais de UFs e do Distrito Federal, projetada para cada ano do levantamento.
- **Indivíduos que praticam atividades de intensidade moderada, por pelo menos 150 minutos semanais, ou em atividades de intensidade vigorosa, por pelo menos 75 minutos semanais.

- ***Não houve coleta em 2022.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Med Sci Sports Exerc* [Internet]. agosto de 2007 [citado 23 de março de 2025];39(8):1423–34. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17762377/>
2. World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication [Internet]. 2010 [citado 23 de março de 2025];(Completo):1–58. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241599979>
3. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. Guia de Atividade Física para a População Brasileira [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2021 [citado 12 de agosto de 2025]. 1–54 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf
4. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Vigitel Brasil – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/download/Vigitel/>
5. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2006-2023: tabagismo e consumo abusivo de álcool: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2023 [Internet]. 2023 [citado 19 de março de 2025]. p. 1–70. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel/vigitel-brasil-2006-2023-tabagismo-e-consumo-abusivo-de-alcool/view>
6. Ministério da Saúde. Acesse as Publicações do Ministério da Saúde sobre Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.4.01.1 – Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18331446



Fatores de risco e proteção



FRP.4.01.2 – Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)

Prevalence of recommended levels of physical activity during leisure time in individuals aged 18 years and over (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre, entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- Considera-se como nível recomendado de atividade física no tempo livre a prática de no mínimo 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou no mínimo 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa¹⁻³.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de prática de atividade física no tempo livre, em nível recomendado, na população com 18 anos e mais de idade, em um local e ano de referência. A prevalência foi estimada para o período de três meses anteriores à entrevista, na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2013, e para 12 meses, na PNS realizada em 2019.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de prática de atividade física no tempo livre de nível recomendado, na população com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para a promoção da prática de atividade física no tempo livre.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida.
- Não é possível obter estimativas anuais, em virtude da periodicidade da pesquisa.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- Por se utilizar como fonte de dados a PNS, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)⁴.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados da PNS, que é um inquérito amostral de saúde, de base domiciliar e de âmbito nacional, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNS foi realizada nos anos de 2013⁵ e 2019⁶.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram praticar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade que referiram praticar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, conforme as respostas dadas às seguintes questões: “Nos últimos três (PNS-2013) ou doze meses (PNS-2019), o(a) Sr.(a) praticou algum tipo de exercício físico ou esporte?”, “Quantos dias por semana o(a) Sr.(a) costuma (costumava) praticar exercício físico ou esporte?”, “Em geral, no dia que o(a) Sr.(a) pratica (praticava) exercício físico ou esporte quanto tempo dura (durava) essa atividade?” e “Qual o exercício físico ou esporte que o(a) Sr.(a) pratica (praticava) com mais frequência?”, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral do morador selecionado.

Para o cálculo do indicador, deve-se proceder conforme especificado a seguir.

- Definir a intensidade das atividades
 - › Atividades de intensidade moderada: caminhada, caminhada em esteira, musculação, hidroginástica, ginástica em geral, natação, artes marciais e luta, ciclismo, voleibol/futevôlei, dança.
 - › Atividades de intensidade vigorosa: corrida, corrida em esteira, ginástica aeróbica, futebol/futsal, basquetebol, tênis.
- Recodificar frequência
 - › As categorias de frequência devem ser recodificadas em dias, de forma contínua.

- Recodificar duração
 - › As categorias de duração devem ser recodificadas em minutos, de forma contínua.
- Criar uma variável contínua
 - › Multiplicar a frequência (dias) pela duração (minutos) e pelo multiplicador de intensidade correspondente (1 para moderada; 2 para vigorosa), para se obter uma variável contínua.
- Criação da variável binária de tempo recomendado
 - › Considerar como indivíduos que praticam atividade física no tempo recomendado aqueles que atingem pelo menos 150 minutos na variável contínua obtida no passo anterior.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 a até salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem as condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de indivíduos com 18 anos ou mais que referiram praticar o nível recomendado de atividade física aumentou de 22,7% (IC95% 22,1%; 23,3%), em 2013, para 30,1% (IC95% 29,4%; 30,7%), em 2019, para a população total.

Esse aumento, entre os anos de 2013 e 2019, foi observado em ambos os sexos: de 27,3% (IC95% 26,4%; 28,3%) para 34,2% (IC95% 33,3%; 35,1%), no sexo masculino; e de 18,6% (IC95% 17,8%; 19,4%) para 26,4% (IC95% 25,6%; 27,1%), no sexo feminino, respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%) de prática de atividade física no tempo livre em nível recomendado*, entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em inquérito domiciliar (PNS), segundo sexo, cor ou raça**, Brasil e regiões, 2013 e 2019

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Sexo				
Masculino	27,3	26,4; 28,3	34,2	33,3; 35,1
Feminino	18,6	17,8; 19,4	26,4	25,6; 27,1
Cor ou raça**				
Branca	23,9	22,9; 24,8	31,6	30,6; 32,7
Preta	20,0	18,2; 21,8	29,4	27,9; 31,0
Amarela	29,2	22,7; 36,8	32,9	27,1; 39,4

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Parda	21,8	20,9; 22,7	28,7	27,9; 29,5
Indígena	26,8	20,0; 34,8	24,1	18,2; 31,2
Faixa etária				
18 a 24 anos	35,6	33,6; 37,7	41,0	39,0; 43,0
25 a 34 anos	27,2	25,8; 28,6	37,2	35,7; 38,6
35 a 44 anos	21,2	20,0; 22,5	31,0	29,7; 32,3
45 a 59 anos	18,2	17,0; 19,3	27,2	26,0; 28,3
60 anos ou mais	13,8	12,7; 14,9	19,8	18,8; 20,7
Brasil e regiões				
Brasil	22,7	22,1; 23,3	30,1	29,4; 30,7
Norte	22,2	20,8; 23,8	28,4	27,3; 29,6
Nordeste	22,4	21,3; 23,5	29,5	28,7; 30,4
Sudeste	22,9	21,8; 24,1	31,2	30,0; 32,4
Sul	22,1	20,5; 23,7	27,7	26,4; 29,0
Centro-Oeste	24,4	23,1; 25,7	31,8	30,3; 33,3

Notas:

- *Indivíduos que praticam atividades de intensidade moderada, por pelo menos 150 minutos semanais, ou atividades de intensidade vigorosa, por pelo menos 75 minutos semanais.
- **Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Med Sci Sports Exerc* [Internet]. agosto de 2007 [citado 23 de março de 2025];39(8):1423–34. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17762377/>
2. World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication [Internet]. 2010 [citado 23 de março de 2025];(Completo):1–58. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241599979>
3. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. Guia de Atividade Física para a População Brasileira [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2021 [citado 12 de agosto de 2025]. 1–54 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf

4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 de março de 2025]. 1–180 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf>
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 de março de 2025]. 1–113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.4.01.2 – Prevalência de prática de atividade física em nível recomendado no tempo livre em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18331548



Fatores de risco e proteção



FRP.4.02.1 – Prevalência de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)

FRP.4.02.1 – Prevalence of insufficient physical activity in individuals aged 18 years or older (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de prática de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- Considera-se insuficientemente ativo o indivíduo que não alcança pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou no mínimo 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, ou uma combinação equivalente de ambas, somando-se os minutos de atividade física nos três domínios: tempo livre, deslocamento ativo e atividade ocupacional¹⁻³.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de atividade física em nível insuficiente, considerando-se os três domínios – tempo livre, deslocamento ativo e atividade ocupacional –, na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência. A prevalência é estimada para o período de três meses anteriores à entrevista, no ano da realização do Vigitel.

USOS

- Identificar distribuições populacionais, geográficas, sociodemográficas e temporais na prevalência de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para a promoção da prática de atividade física em múltiplos contextos, como tempo livre, deslocamento e trabalho.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida em entrevista telefônica.
- Por se utilizar como fonte de dados o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Refere-se à população com 18 anos ou mais de idade residente nas capitais das Unidades da Federação (UFs) e no Distrito Federal.
- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).

- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada capital de UF e no Distrito Federal. Nos anos de 2020 e 2021, houve redução da amostra para mil indivíduos, e, em 2023, para 800 indivíduos. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão. Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)⁴.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade residentes em capitais das UFs e no Distrito Federal⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade cuja soma de minutos despendidos em atividades físicas no tempo livre, deslocamento para o trabalho/escola e na atividade ocupacional não alcança o equivalente a pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador:** Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade cuja soma dos minutos semanais despendidos em atividades físicas no tempo livre, no deslocamento para o trabalho e/ou escola e na atividade ocupacional não alcança o equivalente a pelo menos 150 minutos semanais de atividades de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividades de intensidade vigorosa, em um local e ano de referência.
- Denominador:** Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- Multiplicador:** 100.

Para atividade física no tempo livre, consideram-se as respostas dadas às seguintes questões:

“Nos últimos três meses, o(a) Sr.(a) praticou algum tipo de exercício físico ou esporte?”;

“Qual o tipo principal de exercício físico ou esporte que o(a) Sr.(a) praticou?”;

“O(a) Sr.(a) pratica o exercício pelo menos uma vez por semana?”;

“Quantos dias por semana o(a) Sr.(a) costuma praticar exercício físico ou esporte?”;

“No dia em que o(a) Sr.(a) pratica exercício ou esporte, quanto tempo dura essa atividade?”.

Para a prática de atividade física no deslocamento, são consideradas as questões sobre deslocamento para trabalho e/ou curso e/ou escola, conforme as questões a seguir.

“Para ir ou voltar ao seu trabalho, faz algum trajeto a pé ou de bicicleta?”;

“Quanto tempo o(a) Sr.(a) gasta para ir e voltar neste trajeto (a pé ou de bicicleta)?”;

“Atualmente, o(a) Sr.(a) está frequentando algum curso/escola ou leva alguém a algum curso/escola?”;

“Para ir ou voltar a este curso ou escola, faz algum trajeto a pé ou de bicicleta?”;

“Quanto tempo o(a) Sr.(a) gasta para ir e voltar neste trajeto (a pé ou de bicicleta)?”.

Em relação à prática de atividade física ocupacional, são consideradas as seguintes questões:

“Nos últimos três meses o(a) Sr.(a) trabalhou?”;

“No seu trabalho, você anda bastante a pé?”;

“No seu trabalho, o(a) Sr.(a) carrega peso ou faz outra atividade pesada?”;

“Em uma semana normal, em quantos dias o(a) Sr.(a) faz essas atividades no seu trabalho?”;

“Quando realiza essas atividades, quanto tempo costuma durar?”.

Para o cálculo do indicador, somam-se os minutos de atividade física praticados nos domínios de tempo livre, deslocamento (caminhada ou uso de bicicleta para ir ao trabalho/à escola) e atividade ocupacional.

Cálculo do indicador de atividade física insuficiente

1. Classificar a intensidade das atividades
 - b. Tempo livre
 - (i) Moderada: caminhada, caminhada em esteira, musculação, hidroginástica, ginástica em geral, natação, artes marciais/lutas, ciclismo, voleibol/futevôlei, dança^{1,3}.
 - (ii) Vigorosa: corrida, corrida em esteira, ginástica aeróbica, futebol/futsal, basquetebol, tênis^{1,3}.
 - c. Deslocamento ou ocupacional
 - (i) Classificar como moderada.
2. Atribuir multiplicador de intensidade
 - a. Atividade moderada → multiplicador 1.
 - b. Atividade vigorosa → multiplicador 2.
3. Recodificar as variáveis de frequência e duração
 - a. Frequência: converter para número contínuo de dias por semana.
 - b. Duração: converter para número contínuo de minutos por dia.
4. Calcular minutos equivalentes por domínio
 - a. Para cada domínio (tempo livre, deslocamento, ocupacional), calcular:
 - (i) Minutos equivalentes = Multiplicador de intensidade × Frequência (dias) × Duração (minutos)

5. Somar e avaliar recomendação

- b. Considerar como insuficientemente inativos os indivíduos com < 150 minutos equivalentes semanais na variável contínua obtida².

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável *peso_rake*, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta das capitais de UFs ou do Distrito Federal, projetada para cada ano⁵.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE**Faixa etária:**

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem as condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Nas capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal, de 2009 a 2023, a prevalência de atividade física insuficiente, entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, reduziu-se no período de 2013 a 2023, de 48,3% (IC95% 47,4%; 49,1%) para 37,0% (IC95% 35,5%; 38,4%). Essa redução foi observada em ambos os sexos: de 56,3% (IC95% 55,2%; 57,3%) para 43,1% (IC95% 41,2%; 45,0%), no feminino; e de 38,9% (IC95% 37,6%; 40,3%) para 29,8% (IC95% 27,7%; 32,1%), no masculino (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%)* de atividade física insuficiente** entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, residentes nas capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel), segundo sexo. Brasil, 2013 a 2023***

Ano	Masculino		Feminino		Total	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2013	38,9	37,6; 40,3	56,3	55,2; 57,3	48,3	47,4; 49,1
2014	38,9	37,3; 40,5	54,8	53,6; 56,1	47,5	46,5; 48,5
2015	36,3	34,9; 37,7	54,9	53,7; 56,0	46,3	45,4; 47,3
2016	33,1	31,8; 34,4	53,4	52,3; 54,6	44,1	43,2; 45,0
2017	36,9	35,5; 38,3	52,1	50,9; 53,2	45,1	44,2; 46,0
2018	34,5	33,1; 35,8	50,7	49,6; 51,9	43,2	42,3; 44,1
2019	35,5	34,1; 36,9	51,1	49,9; 52,3	43,9	43,0; 44,9
2020	36,5	34,3; 38,7	54,4	52,7; 56,2	46,2	44,8; 47,6
2021	38,3	36,0; 40,5	54,7	52,7; 56,7	47,1	45,6; 48,7
2023	29,8	27,7; 32,1	43,1	41,2; 45,0	37,0	35,5; 38,4

Notas:

- *Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.
- **A coleta do indicador teve início a partir de 2013.
- ***Não houve coleta em 2022.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Med Sci Sports Exerc* [Internet]. agosto de 2007 [citado 23 de março de 2025];39(8):1423–34. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17762377/>
2. World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication [Internet]. 2010 [citado 23 de março de 2025];(Completo):1–58. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241599979>
3. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. Guia de Atividade Física para a População Brasileira [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2021 [citado 12 de agosto de 2025]. 1–54 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf

4. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Vigitel – Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/download/Vigitel/>
5. Ministério da Saúde (BR). Vigitel Brasil 2006-2021: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de prática de atividade física nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2021: prática de atividade física [Internet]. Ministério da Saúde. 2022 [citado 23 de março de 2025]. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_atividade_fisica_2006_2021.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.4.02.1 – Prevalência de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18335604



Fatores de risco e proteção



FRP.4.02.2 – Prevalência de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)

FRP.4.02.2 – Prevalence of insufficient physical activity in individuals aged 18 years or older (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de prática de atividade física insuficiente entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- Considera-se insuficientemente ativo o indivíduo que não alcança pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou no mínimo 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, ou uma combinação equivalente de ambas, somando-se os minutos de atividade física nos três domínios: tempo livre, deslocamento ativo e atividade ocupacional¹⁻³.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de prática de atividade física em nível insuficiente, considerando-se os três domínios – tempo livre, deslocamento ativo e atividade ocupacional –, na população com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência. A prevalência é estimada para o período de três meses anteriores à entrevista, na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2013, e para 12 meses, na PNS realizada em 2019.

USOS

- Identificar distribuições populacionais, geográficas, sociodemográficas e temporais na prevalência de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para a promoção da prática de atividade física em múltiplos contextos, como tempo livre, deslocamento e trabalho.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida.
- Não é possível obter estimativas anuais, em virtude da periodicidade da pesquisa.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- Por se utilizar como fonte de dados a PNS, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)⁴.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados da PNS, um inquérito amostral de saúde, de base domiciliar e de âmbito nacional, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNS foi realizada nos anos de 2013⁵ e 2019⁶.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade cuja soma de minutos despendidos em atividades físicas no tempo livre, deslocamento para o trabalho/escola e na atividade ocupacional não alcança o equivalente a, pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, em um local e ano de referência}}{\text{Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade cuja soma dos minutos semanais despendidos em atividades físicas no tempo livre, no deslocamento para o trabalho e/ou escola e na atividade ocupacional não alcança o equivalente a pelo menos 150 minutos semanais de atividades de intensidade moderada, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividades de intensidade vigorosa, em um local e ano de referência.
- **Denominador:** Número estimado de indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

Para atividade física no tempo livre, consideram-se as respostas dadas às seguintes questões:

“Nos últimos três meses (PNS-2013) ou doze meses (PNS-2019), o(a) Sr.(a) praticou algum tipo de exercício físico ou esporte?”;

“Qual o tipo principal de exercício físico ou esporte que o(a) Sr.(a) praticou?”;

“O(a) Sr.(a) pratica o exercício pelo menos uma vez por semana?”;

“Quantos dias por semana o(a) Sr.(a) costuma praticar exercício físico ou esporte?”;

“No dia em que o(a) Sr.(a) pratica exercício ou esporte, quanto tempo dura essa atividade?”.

Para a prática de atividade física no deslocamento, são consideradas as questões sobre deslocamento para trabalho e/ou curso e/ou escola, conforme as questões a seguir.

“Para ir ou voltar ao seu trabalho, faz algum trajeto a pé ou de bicicleta?”;

“Quanto tempo o(a) Sr.(a) gasta para ir e voltar neste trajeto (a pé ou de bicicleta)?”;

“Nas suas atividades habituais (tais como ir a algum curso, escola ou clube ou levar alguém a algum curso, escola ou clube), quantos dias por semana o(a) Sr.(a) faz alguma atividade que envolva deslocamento a pé ou de bicicleta?”;

“No dia em que o(a) Sr.(a) faz essa(s) atividades, quanto tempo o(a) Sr.(a) gasta, no deslocamento a pé ou de bicicleta, considerando ida e volta?”.

Em relação à prática de atividade física ocupacional, são consideradas as seguintes questões:

“No seu trabalho, você anda bastante a pé?”;

“No seu trabalho, o(a) Sr.(a) faz faxina pesada, carrega peso ou faz outra atividade pesada que requer esforço físico intenso?”;

“Em uma semana normal, em quantos dias, (o) Sr.(a) anda bastante a pé ou faz essas atividades pesadas ou que requerem esforço físico no seu trabalho?”;

“Em um dia normal, quanto tempo o(a) Sr.(a) passa andando bastante a pé ou realizando essas atividades pesadas ou que requerem esforço físico no seu trabalho?”.

Para o cálculo do indicador, somam-se os minutos de atividade física praticados nos domínios de tempo livre, deslocamento (caminhada ou uso de bicicleta para ir ao trabalho/à escola) e atividade ocupacional⁷.

Cálculo do indicador de atividade física insuficiente:

1. Classificar a intensidade das atividades
 - b. Tempo livre:
 - (i) Moderada: caminhada, caminhada em esteira, musculação, hidroginástica, ginástica em geral, natação, artes marciais/lutas, ciclismo, voleibol/futevôlei, dança^{1,3}.
 - (ii) Vigorosa: corrida, corrida em esteira, ginástica aeróbica, futebol/futsal, basquetebol, tênis^{1,3}.
 - c. Deslocamento ou ocupacional:
 - (i) Classificar como moderada.
2. Atribuir multiplicador de intensidade
 - d. Atividade moderada → multiplicador 1.
 - e. Atividade vigorosa → multiplicador 2.
3. Recodificar as variáveis de frequência e duração
 - f. Frequência: converter para número contínuo de dias por semana.
 - g. Duração: converter para número contínuo de minutos por dia.
4. Calcular minutos equivalentes por domínio
 - h. Para cada domínio (tempo livre, deslocamento, ocupacional), calcular:
 - (i) Minutos equivalentes = Multiplicador de intensidade × Frequência (dias) × Duração (minutos)
5. Somar e avaliar recomendação
 - (i) Considerar como insuficientemente inativos os indivíduos com < 150 minutos equivalentes semanais na variável contínua obtida².

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral do morador selecionado.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem as condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, a prevalência de atividade física insuficiente, entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, reduziu-se de 45,7% (IC95% 44,9%; 46,5%), em 2013, para 40,3% (IC95% 39,6%; 40,9%) em 2019. Tal redução foi observada em ambos os sexos: de 39,3% (IC95% 38,2%; 40,4%) para 32,1% (IC95% 31,2%; 33,0%), no masculino; e de 51,3% (IC95% 50,3%; 52,4%) para 47,5% (IC95% 46,6%; 48,3%), no feminino. Em relação a cor ou raça, houve redução, entre 2013 e 2019, para indivíduos que se autodeclaravam como brancos (de 47,6% para 41,2%), pretos (de 41,9% para 36,3%) e pardos (de 44,5% para 40,3%), mas não para amarelos e indígenas. Quase todas as faixas etárias apresentaram declínio significativo, com destaque para adultos de 25 a 34 anos (de 41,2% para 33,2%) e de 35 a 44 anos (de 43,0% para 34,2%), e exceção para adultos de 60 anos e mais, faixa em que não houve diferenças. Quanto às regiões, houve redução significativa em quatro delas, a saber: Centro-Oeste (de 46,9% para 40,5%), Nordeste (de 47,5% para 43,1%), Sudeste (de 46,2% para 37,7%) e Sul (de 45,3% para 40,9%). Apenas na região Norte a diferença não foi significativa – de 44,2% para 43,5% (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%)* de atividade física insuficiente entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em inquérito domiciliar (PNS), segundo sexo, cor ou raça e faixa etária. Brasil e regiões, 2013 e 2019

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Sexo				
Masculino	39,3	38,2; 40,4	32,1	31,2; 33,0
Feminino	51,3	50,3; 52,4	47,5	46,6; 48,3
Cor ou raça**				
Branca	47,6	46,5; 48,8	41,2	40,2; 42,2
Preta	41,9	39,6; 44,2	36,3	34,7; 37,9
Amarela	40,6	33,5; 48,1	39,4	32,9; 46,4
Parda	44,5	43,4; 45,6	40,3	39,4; 41,2
Indígena	33,7	26,8; 41,5	43,1	35,4; 51,1
Faixa etária				
18 a 24 anos	36,6	34,7; 38,5	32,8	31,1; 34,6
25 a 34 anos	41,2	39,7; 42,7	33,2	31,8; 34,5

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
35 a 44 anos	43,0	41,5; 44,5	34,2	33,0; 35,4
45 a 59 anos	45,4	43,9; 46,9	37,8	36,7; 38,9
60 anos ou mais	62,4	60,8; 64,0	59,7	58,5; 60,8
Brasil e regiões				
Brasil	45,7	44,9; 46,5	40,3	39,6; 40,9
Norte	44,2	43,0; 45,5	43,5	42,1; 44,9
Nordeste	47,5	45,5; 49,5	43,1	42,2; 44,0
Sudeste	46,2	44,7; 47,6	37,7	36,4; 39,0
Sul	45,3	43,3; 47,2	40,9	39,5; 42,2
Centro-Oeste	46,9	45,3; 48,6	40,5	39,0; 42,0

Notas:

- *Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.
- **Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, et al. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Med Sci Sports Exerc* [Internet]. agosto de 2007 [citado 23 de março de 2025];39(8):1423–34. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17762377/>
2. World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication [Internet]. 2010 [citado 23 de março de 2025];(Completo):1–58. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241599979>
3. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. Guia de Atividade Física para a População Brasileira [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2021 [citado 12 de agosto de 2025]. 1–54 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 de março de 2025]. 1–180 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf>

6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 de março de 2025]. 1-113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>
7. Malta DC, da Silva AG, Gomes CS, Stopa SR, de Oliveira MM, Sardinha LMV, et al. Monitoramento das metas dos planos de enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 e 2019. Epidemiologia e Serviços de Saúde [Internet]. 2022 [citado 14 de agosto de 2025];31(Special issue 1):e2021364. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/rcncc4St7J6tBNpMGd45YRF/?format=html&lang=pt>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.4.02.2 – Prevalência de atividade física insuficiente em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 7p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18335710



Fatores de risco e proteção



FRP.5.01.1 – Prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel)

FRP.5.01.1 – Prevalence of overweight in individuals aged 18 years and over (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade em um local e ano de referência.
- O excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade é definido através do Índice de Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 25kg/m².
- O excesso de peso agrupa os dados de sobrepeso (IMC $\geq$ 25kg/m² e < 30kg/m²) e obesidade (IMC $\geq$ 30kg/m²).
- O IMC é definido como o peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros (peso/altura²)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de excesso de peso na população brasileira de 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de excesso de peso na população brasileira de 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao controle de excesso de peso.

LIMITAÇÕES

- O IMC é uma medida altamente correlacionada com o percentual de gordura corporal na população, embora não represente sua medida direta.
- Trata-se de informação autorreferida por meio de entrevista telefônica.
- Por se utilizar como fonte de dados o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- Refere-se à população com 18 anos ou mais de idade residente nas capitais de Unidades da Federação (UFs) e no Distrito Federal.

- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).
- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada capital de UF e no Distrito Federal. Nos anos de 2020 e 2021, houve redução da amostra para mil indivíduos, e, em 2023, para 800 indivíduos. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão. Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)².

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade, residentes em capitais de UFs e no Distrito Federal³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade com IMC maior ou igual a 25kg/m}^2, \text{ em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade com excesso de peso (IMC maior ou igual a 25kg/m²), em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- O IMC é calculado através do peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros (peso/altura²)¹.
- Devem ser utilizados para o cálculo os dados de peso e altura que passaram pelo processo de imputação.
- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável *peso_rake*, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de capitais de UFs e do Distrito Federal, projetada para cada ano.
- Informações mais detalhadas podem ser encontradas no relatório oficial do Ministério da Saúde⁴.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem as condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade, nas capitais brasileiras e no Distrito Federal, aumentou de 42% (IC95% 41,9%; 43,6%), em 2006, para 61,4% (IC95% 59,9%; 62,8%) em 2023. Esse aumento foi observado em ambos os sexos: de 38,5% (IC95% 37,5%; 39,6%), em 2006, para 59,6% (IC95% 57,7%; 61,5%), em 2023, entre os indivíduos do sexo feminino; e de 47,6% (IC95% 46,3%; 49,0%), em 2006, para 63,4% (IC95% 61,2%; 65,6%), em 2023, entre os indivíduos do sexo masculino. As maiores prevalências pontuais foram observadas no sexo masculino, em todo o período analisado (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência* de excesso de peso** entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, segundo sexo, residentes nas capitais de Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel). Brasil, 2006 a 2023***

Ano	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2006	42,7	41,9; 43,6	47,6	46,3; 49,0	38,5	37,5; 39,6
2007	43,3	42,5; 44,2	48,7	47,3; 50,1	38,7	37,6; 39,7
2008	44,9	44,0; 45,7	49,8	48,4; 51,2	40,7	39,6; 41,7
2009	45,9	45,0; 46,8	50,1	48,7; 51,6	42,3	41,2; 43,4
2010	48,2	47,3; 49,1	52,4	50,9; 53,8	44,6	43,5; 45,7
2011	48,8	48,0; 49,7	53,4	52,1; 54,7	44,9	43,8; 45,9
2012	51,0	50,1; 51,9	54,5	53,0; 55,9	48,1	46,9; 49,2
2013	50,8	49,9; 51,6	54,7	53,4; 56,1	47,4	46,3; 48,5
2014	52,5	51,5; 53,5	56,5	54,9; 58,1	49,1	47,9; 50,4
2015	53,9	53,0; 54,9	57,6	56,1; 59,1	50,8	49,6; 52,0
2016	53,8	52,9; 54,7	57,7	56,2; 59,1	50,5	49,4; 51,7
2017	54,0	53,1; 54,9	57,3	55,8; 58,8	51,2	50,0; 52,4
2018	55,7	54,8; 56,6	57,8	56,3; 59,3	53,9	52,7; 55,1
2019	55,4	54,4; 56,3	57,1	55,6; 58,7	53,9	52,7; 55,0
2020	57,5	56,1; 58,9	58,9	56,7; 61,2	56,2	54,5; 58,0
2021	57,2	55,7; 58,8	59,9	57,6; 62,2	55,0	53,0; 57,0
2023	61,4	59,9; 62,8	63,4	61,2; 65,6	59,6	57,7; 61,5

Notas:

- *Percentual ponderado para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da capital de UF ou do Distrito Federal, projetada para cada ano do levantamento.
- **IMC maior ou igual a 25kg/m², por dados de peso e altura autorreferidos.
- ***Não houve coleta em 2022.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consultation [Internet]. Geneva: WHO; 2000 [citado 14 de agosto de 2025]. 1–252 p. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/42330>
2. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aims.gov.br/download/Vigitel/>
3. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2006-2023:

morbidade referida e autoavaliação de saúde: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de morbidade referida e autoavaliação de saúde nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2023 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2025 [citado 12 de agosto de 2025]. 1–57 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_2006_2023_morbidade_autoavaliacao.pdf

4. Ministério da Saúde. Acesse as Publicações do Ministério da Saúde sobre Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.5.01.1 – Prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18335811



Fatores de risco e proteção



FRP.5.01.2 – Prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS)

FRP.5.01.2 – Prevalence of overweight in individuals aged 18 years and over (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de excesso de peso em indivíduos de 18 anos ou mais de idade, em um local e ano de referência.
- O excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade é definido através do Índice de Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 25kg/m^2 .
- O excesso de peso agrupa os dados de sobrepeso ($\text{IMC} \geq 25\text{kg/m}^2$ e $< 30\text{kg/m}^2$) e obesidade ($\text{IMC} \geq 30\text{kg/m}^2$).
- O IMC é definido como o peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros ($\text{peso}/\text{altura}^2$)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de excesso de peso na população brasileira com 18 anos ou mais de idade, residente em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de excesso de peso na população brasileira com 18 anos ou mais de idade.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao controle de excesso de peso.

LIMITAÇÕES

- O IMC é uma medida altamente correlacionada com o percentual de gordura corporal na população, embora não represente sua medida direta.
- Não é possível obter estimativas anuais, em virtude da periodicidade da pesquisa.
- A amostra da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013, para a qual foram obtidas medidas antropométricas, foi de 59.402 indivíduos com 18 anos ou mais de idade. Em 2019, as medidas antropométricas foram aferidas em uma subamostra de 6.571 indivíduos com 18 anos ou mais de idade,² o que resultou em maior imprecisão das estimativas das prevalências de excesso de peso, não permitindo estimativas para todas as Unidades da Federação (UFs) e para os municípios de capitais na edição de 2019.

- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- Por se utilizar como fonte de dados a PNS, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)³.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados da PNS, que é um inquérito amostral de saúde, de base domiciliar e de âmbito nacional, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNS foi realizada nos anos de 2013⁴ e 2019⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade com IMC maior ou igual a 25kg/m}^2, \text{ em um local e ano de referência}}{\text{Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade com excesso de peso (IMC maior ou igual a 25kg/m²), excluídas as mulheres grávidas, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de indivíduos com 18 anos ou mais de idade entrevistados, excluídas as mulheres grávidas, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- O IMC é calculado através do peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros (peso/altura²)¹.
- Devem ser utilizados para o cálculo os dados de peso e altura aferidos por meio de medidas antropométricas.
- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral do morador selecionado. Para a edição de 2019, deve ser utilizado o peso amostral do morador selecionado para a antropometria.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Renda domiciliar per capita:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE _____

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS _____

- Em ambas as edições da PNS (2013 e 2019), além da aferição das medidas antropométricas, também foram coletados dados de peso e altura autorreferidos dos moradores selecionados². No entanto, nesta ficha, os dados usados no cálculo do indicador são, em ambos os anos, derivados de medidas antropométricas aferidas.
- Se o número de observações (questionários) que satisfazem as condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o

resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.

- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade no Brasil aumentou de 57,0% (IC95% 56,2%; 57,8%), em 2013, para 60,3% (IC95% 58,2%; 62,4%) em 2019.

Esse aumento, entre os anos de 2013 e 2019, foi observado em ambos os sexos: de 58,3% (IC95% 57,3%; 59,3%) para 62,7% (IC95% 59,0%; 66,3%), no sexo feminino; e de 55,5% (IC95% 54,4%; 56,7%) para 57,6% (IC95% 54,7%; 60,4%), no sexo masculino (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência de excesso de peso* entre indivíduos com 18 anos ou mais de idade, em inquérito domiciliar (PNS), segundo sexo, cor ou raça, faixa etária e regiões. Brasil, 2013 e 2019

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Sexo				
Masculino	55,5	54,4; 56,7	57,6	54,7; 60,4
Feminino	58,3	57,3; 59,3	62,7	59,0; 66,3
Cor ou raça**				
Branca	59,1	58,1; 60,2	65,1	61,7; 68,3
Preta	56,2	53,8; 58,5	66,4	60,7; 71,7
Amarela	45,1	37,9; 52,6	‡	‡
Parda	54,9	53,8; 56,1	54,7	51,8; 57,6
Indígena	56,8	48,4; 64,7	‡	‡
Faixa etária				
18 a 24 anos	32,9	31,0; 34,8	33,9	27,6; 40,9
25 a 34 anos	52,1	50,6; 53,5	55,1	47,2; 62,7
35 a 44 anos	63,2	61,7; 64,7	64,1	60,1; 67,9
45 a 59 anos	67,4	66,0; 68,9	71,3	67,6; 74,7
60 anos ou mais	62,2	60,7; 63,8	64,5	60,6; 68,1
Brasil e regiões				
Brasil	57,0	56,2; 57,8	60,3	58,2; 62,4
Norte	53,7	51,9; 55,5	53,6	47,8; 59,3
Nordeste	53,4	51,9; 54,9	55,1	51,0; 59,1
Sudeste	58,5	57,1; 59,8	62,0	58,5; 65,3

Variáveis e categorias	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Sul	60,4	58,6; 62,1	68,3	63,3; 73,0
Centro-Oeste	57,2	55,7; 58,6	59,2	54,2; 64,1

- Notas:**
- *IMC maior ou igual a 25kg/m², por dados de peso e altura aferidos.
 - **Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
 - IC95%: intervalo de confiança de 95%.
 - Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.
 - ‡ Número de casos < 30 e/ou coeficiente de variação > 0,5. Estimativa suprimida, conforme critério descrito na seção “Notas”.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consultation [Internet]. Geneva: WHO; 2000 [citado 14 de agosto de 2025]. 1–252 p. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/42330>

2. Souza Júnior PRB de, Szwarcwald CL, Almeida W da S de, Damacena GN, Pedroso M de M, Sousa CAM de, et al. Comparison of sampling designs from the two editions of the Brazilian National Health Survey, 2013 and 2019. Cad Saude Publica [Internet]. 2022 [citado 12 de agosto de 2025];38(suppl 1). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2022001304001&tIng=en

3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>

4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 de março de 2025]. 1–180 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf>

5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 de março de 2025]. 1–113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.5.01.2 – Prevalência de excesso de peso em indivíduos com 18 anos ou mais de idade (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18341231



Fatores de risco e proteção



FRP.5.02 – Prevalência de excesso de peso em crianças menores de 5 anos de idade

FRP.5.02 – Prevalence of overweight in children under 5 years

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual de crianças menores de 5 anos de idade com excesso de peso, em um local e ano de referência.
- O excesso de peso de crianças menores de 5 anos de idade é definido pelo Índice de Massa Corporal (IMC) para idade com percentil maior que 97 ou escore-z maior que 2, de acordo com as curvas de crescimento infantil da Organização Mundial da Saúde – OMS (2006)¹. Tais curvas descrevem um padrão de crescimento infantil, ou seja, de crianças com acesso a cuidados de saúde e alimentação compatíveis com crescimento e desenvolvimento saudáveis.
- O IMC é definido como o peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros ($\text{peso}/\text{altura}^2$), sendo uma medida correlacionada com a adiposidade corporal, embora não represente sua medida direta, pois estima a massa, e não a composição corporal.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de excesso de peso, variável constituída a partir da agregação dos dados de sobrepeso e obesidade na população de crianças menores de 5 anos de idade, com representatividade nacional.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição da prevalência do excesso de peso, identificando-se grupos populacionais mais expostos. Estes grupos devem ser prioritários para as políticas públicas, tendo em vista que estão sob maior risco de desenvolvimento das doenças associadas ao excesso de peso, como dislipidemias, hipertensão e alterações no metabolismo da glicose e insulina, entre outras.
- Contribuir na análise de condições de saúde das crianças com predição do risco para doenças relacionadas ao excesso de peso na infância e na vida adulta. Ressalta-se que o excesso de peso na infância pode predizer o desenvolvimento da obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao tratamento do excesso de peso e das doenças associadas, na população de crianças menores de 5 anos de idade.

LIMITAÇÕES

- O indicador considera sobrepeso e obesidade agrupados, o que pode tornar pouco clara a condição prioritária destes problemas de saúde pública separadamente, nas diferentes regiões.
- Depende da realização de estudos amostrais de base populacional. Esses estudos têm elevado custo financeiro e apresentam dificuldades de operacionalização.
- Por utilizar como fonte de dados a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) 1989², a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 1996³ e 2006⁴ e o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) 2019⁵, que são pesquisas com representatividade nacional, mas com processos diferentes de seleção da amostra e amostragem, é necessário cautela na comparação das prevalências. Outra limitação é que, nos inquéritos de 1989² e 1996³, a região Norte não apresentou área rural, o que limita a comparação por desenho amostral diferente.
- Além disso, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais, e é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTES DE DADOS

- Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), 1989².
- Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996³ e 2006⁴.
- Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 2019⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de crianças menores de 5 anos com IMC para a idade com percentil maior que 97 ou escore-z maior que 2, em um local e ano de referência}}{\text{Número de crianças menores de 5 anos, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Quantitativo de crianças menores de 5 anos com excesso de peso para idade (percentil maior que 97 ou escore-z maior que 2, de acordo com as curvas de crescimento da OMS)¹. O escore-z/percentil deve ser calculado a partir dos seguintes dados da criança: idade em meses, IMC (razão entre o peso e a altura ao quadrado) e sexo.
- Denominador: Quantitativo total de crianças menores de 5 anos que tiveram peso e altura aferidos e a idade registrada.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- A rotina de análise, os bancos de dados e os respectivos dicionários podem ser encontrados no Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde⁶.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Notas:

- Essa variável refere-se à cor ou raça da mãe.
- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “ignorado”, “outros”, “não sabe”, ou “recusou-se a responder”.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Nota:

- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “ignorado”, “outros”, “não sabe”, ou “recusou-se a responder”.

Indicador Econômico Nacional (IEN):

- 1º quinto;
- 2º quinto;
- 3º quinto;
- 4º quinto; e
- 5º quinto.

Nota:

- O IEN é um índice domiciliar sintético que avalia condições socioeconômicas a partir de um conjunto de itens^{7,8}. Na análise do ENANI 2019, foi considerada a atualização do IEN⁸.

GRANULARIDADE

- Região do Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (CGAN/DEPPROS/SAPS/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de excesso de peso em crianças menores de 5 anos apresentou uma tendência de redução entre 1989 e 2006, seguida de um aumento até 2019, quando 10,1% das crianças apresentavam excesso de peso.

A região Sul apresentou maiores prevalências de excesso de peso para idade, exceto em 1996, quando se constatou uma prevalência mais elevada em crianças do Nordeste.

De forma semelhante, a região Centro-Oeste apresentou menores prevalências na maioria dos períodos avaliados, exceto em 2006, quando, na região Norte, foram observadas as menores prevalências de excesso de peso para idade (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%) de excesso de peso para idade em crianças menores de 5 anos. Brasil e regiões, 1989, 1996, 2006 e 2019

Ano e pesquisa	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
1989* PNSN	8,3	7,4; 9,2	8,1	6,4; 9,8	6,5	5,4; 7,6	9,0	7,0; 11,0	12,1	10,2; 14,0	6,1	4,7; 7,4
1996* PNDS	7,3	6,4; 8,2	6,8	4,2; 9,3	7,9	6,6; 9,2	7,5	5,8; 9,1	6,6	4,1; 9,2	5,4	3,2; 7,5
2006 PNDS	7,2	5,9; 8,4	5,9	4,1; 7,7	6,7	4,6; 8,7	7,3	5,0; 9,8	8,9	6,2; 11,6	6,6	4,4; 8,9
2019 ENANI	10,1	9,0; 11,1	7,8	6,1; 9,5	10,4	8,5; 12,3	10,5	8,5; 12,5	12,0	9,2; 14,7	7,1	5,5; 8,7

Notas:

- *Na região Norte, dados somente das áreas urbanas.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- PNSN: Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição; PNDS: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde; ENANI: Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil.
- O excesso de peso de crianças menores de 5 anos de idade é definido pelo Índice de Massa Corporal (IMC) para idade com percentil maior que 97 ou escore-z maior que 2, de acordo com as curvas de crescimento infantil da OMS (2006)¹.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Child growth standards [Internet]. [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.who.int/tools/child-growth-standards>
2. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), Fundação Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA). Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição PNSN – 1989. 1990. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv81879.pdf>
3. Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM), Programa de Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS) Macro International Inc. Pesquisa Nacional Sobre Demografia e Saúde 1996 [Internet]. 1997 [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr77/fr77.pdf>
4. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006: Dimensões do Processo Reprodutivo e da Saúde da Criança. 2009. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/pnds/>. Disponível: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/pnds/>

5. Ministério da Saúde. Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil: ENANI-2019 [Internet]. OpenDATASUS. [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://enani.nutricao.ufrj.br/enani-2019/>
6. Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde. Bancos para elaboração dos Indicadores de Fator de Risco e Proteção da Rede Interagencial de Informações para Saúde - Dimensão 5: Estado Nutricional. Disponível em: <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/ripsa-fator-de-risco-e-protecao-5-estado-nutricional>
7. Barros AJD, Victoria CG. Indicador econômico para o Brasil baseado no censo demográfico de 2000. Rev Saude Publica [Internet]. 2005 [citado 10 de agosto de 2025];39(4):523–9. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/xq8S4XZ7sfV97LYGJfPF3hG/>
8. Andrade PG, Schincaglia R, Farias DR, Castro IRR de, Anjos LA dos, Lacerda EM de A, et al. The National Wealth Score in the Brazilian National Survey on Child Nutrition (ENANI-2019). Cad Saude Publica [Internet]. 2023 [citado 10 de agosto de 2025];39(suppl 2). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2023001404001&tlng=en

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.5.02 – Prevalência de excesso de peso em crianças menores de 5 anos de idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18341478



Fatores de risco e proteção



FRP.5.03 – Prevalência de déficit ponderal para a idade em crianças menores de 5 anos de idade

FRP.5.03 – Prevalence of underweight for age in children under 5 years

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual de crianças menores de 5 anos de idade com déficit ponderal para a idade, em um local e ano de referência. Define-se como déficit ponderal a existência de valores abaixo do escore-z menor que -2 ou percentil menor que 3 do índice de peso para idade (P/I), de acordo com as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006)¹.
- O déficit ponderal inclui a identificação de muito baixo peso para idade e baixo peso para idade. Define-se muito baixo peso para idade quando as crianças menores de 5 anos apresentam P/I com escore-z menor que -3 ou percentil menor que 0,1. Define-se baixo peso para idade quando as crianças menores de 5 anos apresentam P/I contido no intervalo com escore-z maior ou igual a -3 e menor que -2, ou percentil maior ou igual a 0,1 e menor que 3.
- Ressalta-se que as curvas de crescimento da OMS (2006)¹ descrevem um padrão de crescimento infantil, ou seja, de crianças com acesso a cuidados de saúde e alimentação compatíveis com crescimento e desenvolvimento saudáveis.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de crianças menores de 5 anos de idade que apresentam peso corporal muito baixo ou baixo para a idade, com representatividade nacional. O déficit ponderal está associado à perda de peso, à deficiência de estatura ou a ambas.
- Em crianças menores de 5 anos, o déficit ponderal está frequentemente associado a baixos níveis socioeconômicos, a alimentação inadequada e a deficiente assistência materno-infantil. A contribuição dos fatores genéticos costuma ocorrer a partir dos 5 anos de idade.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição de crianças com déficit ponderal para a idade, identificando-se áreas e grupos populacionais de maior risco, que possam demandar ações e estudos específicos.
- Orientar a implementação e avaliação de intervenções alimentares e nutricionais.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao tratamento do déficit ponderal e das doenças associadas, na população de crianças menores de 5 anos de idade.

LIMITAÇÕES

- Não indica a origem do déficit ponderal (deficiência de estatura, de peso ou ambos), o que requer análise de comparação com outros indicadores. Nas crianças maiores de 2 anos, é importante a distinção entre peso baixo para a idade e peso baixo para a estatura.
- Depende da realização de estudos amostrais de base populacional. Esses estudos têm elevado custo financeiro e apresentam dificuldades de operacionalização.
- Por utilizar como fonte de dados a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) 1989², a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 1996³ e 2006⁴ e o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) 2019⁵, que são pesquisas com representatividade nacional, mas com processos diferentes de seleção de amostra e amostragem, é necessário cautela na comparação das prevalências. Outra limitação é que, nos inquéritos de 1989² e 1996³, a região Norte não apresentou área rural, o que limita a comparação por desenho amostral diferente.
- Além disso, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais, e é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTES DE DADOS

- Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), 1989².
- Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996³ e 2006⁴.
- Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 2019⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de crianças menores de 5 anos com percentil } < 3 \text{ ou escore-} z < -2 \text{ no índice de peso para a idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número de crianças menores de 5 anos, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Quantitativo de crianças menores de 5 anos com déficit ponderal para a idade (escore-z menor que -2 ou percentil menor que 3, de acordo com as curvas de crescimento da OMS)¹. O escore-z/percentil deve ser calculado a partir dos seguintes dados da criança: idade em meses, peso e sexo.
- **Denominador:** Quantitativo total de crianças menores de 5 anos que tiveram peso e altura aferidos e a idade registrada.
- **Multiplicador:** 100.

Nota:

- A rotina de análise, os bancos de dados e os respectivos dicionários podem ser encontrados no Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde⁶.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Notas:

- Essa variável refere-se à cor ou raça da mãe.
- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “ignorado”, “outros”, “não sabe”, ou “recusou-se a responder”.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Nota:

- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “ignorado”, “outros”, “não sabe”, ou “recusou-se a responder”.

Indicador Econômico Nacional (IEN):

- 1º quinto;
- 2º quinto;
- 3º quinto;
- 4º quinto; e
- 5º quinto.

Nota:

- O IEN é um índice domiciliar sintético que avalia condições socioeconômicas a partir de um conjunto de itens^{7,8}. Na análise do ENANI 2019, foi considerada a atualização do IEN⁸.

GRANULARIDADE

- Região do Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (CGAN/DEPPROS/SAPS/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de déficit ponderal em crianças brasileiras menores de 5 anos apresentou tendências de redução em mais da metade, entre 1989 e 2006.

Contudo, entre 2006 e 2019, observou-se uma tendência de aumento da prevalência, chegando a 2,9%, percentual inferior aos valores observados em 1989 e 1996.

Em todos os períodos avaliados, as regiões Norte e Nordeste apresentaram maiores prevalências, exceto em 2019. A região Sul, com exceção de 2006, apresentou as menores prevalências de déficit ponderal entre crianças menores de 5 anos (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%) de déficit ponderal para idade em crianças menores de 5 anos. Brasil e regiões, 1989, 1996, 2006 e 2019

Ano e pesquisa	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
1989* PNSN	5,4	4,7; 6,1	9,1	7,2; 11,0	9,6	8,3; 11,0	3,1	1,9; 4,3	1,6	0,9; 2,3	3,0	2,1; 4,0
1996* PNDS	4,2	3,6; 4,9	5,4	3,4; 7,4	6,3	5,0; 7,5	3,6	2,4; 4,8	**	-	**	-
2006 PNDS	1,9	1,3; 2,5	3,3	1,8; 4,7	2,2	1,1; 3,3	**	-	**	-	1,6	0,7; 2,4
2019 ENANI	2,9	2,0; 3,7	2,6	1,1; 4,2	3,2	2,1; 4,4	3,1	1,3; 4,9	1,8	1,0; 2,5	2,5	2,1; 2,9

Notas:

- *Na região Norte, dados somente das áreas urbanas.
- **Coeficiente de variabilidade 0,30, desconsiderar a estimativa.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- PNSN: Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição; PNDS: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde; ENANI: Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil.
- O déficit ponderal é definido pelo índice de peso para idade com escore-z menor que -2 ou percentil menor que 3, de acordo com as curvas de crescimento da OMS (2006)¹.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Child growth standards [Internet]. [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.who.int/tools/child-growth-standards>
2. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), Fundação Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA). Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição PNSN – 1989. 1990. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv81879.pdf>
3. Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM), Programa de Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS) Macro International Inc. Pesquisa Nacional Sobre Demografia e Saúde 1996 [Internet]. 1997 [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr77/fr77.pdf>
4. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006: Dimensões do Processo Reprodutivo e da Saúde da Criança. 2009. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/pnds/>

5. Ministério da Saúde. Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil Infantil: ENANI-2019 [Internet]. OpenDATASUS. [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://enani.nutricao.ufrj.br/enani-2019/>
6. Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde. Bancos para elaboração dos Indicadores de Fator de Risco e Proteção da Rede Interagencial de Informações para Saúde - Dimensão 5: Estado Nutricional. Disponível em: <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/ripsa-fator-de-risco-e-protecao-5-estado-nutricional>
7. Barros AJD, Victória CG. Indicador econômico para o Brasil baseado no censo demográfico de 2000. Rev Saude Publica [Internet]. 2005 [citado 10 de agosto de 2025];39(4):523–9. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/xq8S4XZ7sfV97LYGJfPF3hG/?lang=pt>
8. Andrade PG, Schincaglia R, Farias DR, Castro IRR de, Anjos LA dos, Lacerda EM de A, et al. The National Wealth Score in the Brazilian National Survey on Child Nutrition (ENANI-2019). Cad Saude Publica [Internet]. 2023 [citado 10 de agosto de 2025];39(suppl 2). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2023001404001&tlng=en

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.5.03 – Prevalência de déficit ponderal para a idade em crianças menores de 5 anos de idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18342441



Fatores de risco e proteção



FRP.5.04 – Prevalência de déficit estatural para a idade em crianças menores de 5 anos de idade

FRP.5.04 – Prevalence of stunting for age in children under 5 years

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual de crianças residentes menores de 5 anos de idade que apresentam déficit estatural para a idade, em um local e ano de referência. Em crianças menores de 2 anos de idade, mede-se o seu comprimento, em vez da altura. Para simplificar a interpretação deste indicador, adotou-se o termo estatura para esta situação. Define-se como déficit estatural valores abaixo do percentil 3 ou do escore-z -2 do índice de estatura para a idade (E/I), de acordo com as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006)¹.
- O déficit estatural inclui a identificação de muito baixa estatura para idade e baixa estatura para idade. Define-se muito baixa estatura para idade quando as crianças menores de 5 anos apresentam E/I com escore-z menor que -3 ou percentil menor que 0,1. Define-se baixa estatura para a idade quando as crianças menores de 5 anos apresentam E/I contido no intervalo com escore-z maior ou igual a -3 e menor que -2 ou percentil maior ou igual a 0,1 e menor que 3.
- Ressalta-se que as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006)¹ descrevem um padrão de crescimento infantil, ou seja, de crianças com acesso a cuidados de saúde e alimentação compatíveis com crescimento e desenvolvimento saudáveis.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de crianças menores de 5 anos de idade que apresentam estatura muito baixa e baixa para a idade, com representatividade nacional.
- Em crianças menores de 5 anos, o déficit estatural está associado a baixos níveis socioeconômicos e a deficiente assistência materno-infantil. A contribuição dos fatores genéticos costuma ocorrer a partir dos 5 anos de idade.
- O déficit estatural é indicador antropométrico de desnutrição crônica.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição de crianças com déficit estatural para a idade, identificando áreas e grupos populacionais de maior risco que possam demandar ações e estudos específicos.
- Orientar a implementação e avaliação de intervenções alimentares e nutricionais.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao tratamento do déficit estatural e das doenças associadas na população de crianças menores de 5 anos de idade.

LIMITAÇÕES

- Depende da realização de estudos amostrais de base populacional. Esses estudos têm elevado custo financeiro e apresentam dificuldades de operacionalização.
- Por se utilizar como fonte de dados a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) 1989², a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 1996³ e 2006⁴ e o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) 2019⁵, que são pesquisas com representatividade nacional, mas com processos diferentes de seleção da amostra e amostragem, é necessária cautela na comparação das prevalências. Outra limitação é que, nos inquéritos de 1989² e 1996³, a região Norte não apresentou área rural, o que limita a comparação por desenho amostral diferente.
- Além disso, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais, e é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTES DE DADOS

- Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), 1989².
- Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996³ e 2006⁴.
- Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 2019⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de crianças menores de 5 anos com percentil } < 3 \text{ ou escore-} z < -2 \text{ no índice de estatura para a idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número de crianças menores de 5 anos, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Quantitativo de crianças menores de 5 anos com déficit estatural para a idade (escore-z menor que -2 ou percentil menor que 3, de acordo com as curvas de crescimento da OMS)¹. O escore-z/percentil deve ser calculado a partir dos seguintes dados da criança: idade em meses, altura/comprimento e sexo.
- Denominador: Quantitativo total de crianças menores de 5 anos que tiveram peso e altura aferidos e a idade registrada.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- A rotina de análise, os bancos de dados e os respectivos dicionários podem ser encontrados no Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde⁶.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;

- Parda; e
- Indígena.

Notas:

- Essa variável refere-se à cor ou raça da mãe.
- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “ignorado”, “outros”, “não sabe”, ou “recusou-se a responder”.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Nota:

- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “ignorado”, “outros”, “não sabe”, ou “recusou-se a responder”.

Indicador Econômico Nacional (IEN):

- 1º quinto;
- 2º quinto;
- 3º quinto;
- 4º quinto; e
- 5º quinto.

Nota:

- O IEN é um índice domiciliar sintético que avalia condições socioeconômicas a partir de um conjunto de itens^{7,8}. Na análise do ENANI 2019, foi considerada a atualização do IEN⁸.

GRANULARIDADE

- Região do Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (CGAN/DEPPROS/SAPS/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência de déficit estatural em crianças menores de 5 anos apresentou uma redução entre 1989 (19,6%) e 2019 (7,0%), em mais da metade.

Contudo, entre 2006 e 2019, observou-se uma manutenção da prevalência em 7%. Entre os anos 1989 e 1996, as regiões Norte e Nordeste apresentaram as maiores prevalências de déficit estatural, que chegou ao dobro do observado nas demais regiões.

No entanto, ainda que, em 2006 e 2019, a região Norte tenha mantido a maior prevalência de crianças com déficit estatural, o Sul, em 2006, e o Sudeste, em 2019, ficaram em segundo lugar entre as regiões com maiores prevalências (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%) de déficit estatural para idade em crianças menores de 5 anos. Brasil e regiões, 1989, 1996, 2006 e 2019

Ano e pesquisa	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
1989* PNSN	19,6	18,4; 20,8	28,9	26,1; 31,9	32,9	30,8; 35,0	11,4	9,3; 13,6	11,9	10,0; 13,7	10,9	9,1; 12,6
1996* PNDS	13,4	12,3; 14,4	20,4	16,8; 24,6	22,1	20,0; 24,1	7,2	5,6; 8,9	7,0	4,3; 9,6	10,7	7,5; 13,9
2006 PNDS	7,0	5,7; 8,3	14,7	11,9; 17,6	5,8	4,0; 7,5	5,6	3,0; 8,3	8,5	5,9; 11,0	5,5	3,6; 7,5
2019 ENANI	7,0	6,0; 7,9	8,4	5,1; 11,6	6,2	4,3; 8,0	7,3	5,8; 8,8	7,0	4,5; 9,5	6,1	5,1; 7,1

Notas:

- *Na região Norte, os dados se referem somente a áreas urbanas.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- PNSN: Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição; PNDS: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde; ENANI: Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil.
- O déficit estatural é definido pelo índice de estatura para idade com escore-z menor que -2 ou percentil menor que 3, de acordo com as curvas de crescimento da OMS (2006)¹.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Child growth standards [Internet]. [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.who.int/tools/child-growth-standards>
2. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA). Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição PNSN – 1989. 1990. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv81879.pdf>
3. Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM), Programa de Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS) Macro International Inc. Pesquisa Nacional Sobre Demografia e Saúde 1996 [Internet]. 1997 [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr77/fr77.pdf>
4. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006: Dimensões do Processo Reprodutivo e da Saúde da Criança. 2009. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/pnds/>. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/pnds/>
5. Ministério da Saúde. Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil Infantil: ENANI-2019 [Internet]. OpenDATASUS. [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://enani.nutricao.ufrj.br/enani-2019/>
6. Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde. Bancos para elaboração dos Indicadores de Fator de Risco e Proteção da Rede Interagencial de Informações para Saúde

- Dimensão 5: Estado Nutricional. Disponível em: <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/ripsa-fator-de-risco-e-protecao-5-estado-nutricional>
7. Barros AJD, Victoria CG. Indicador econômico para o Brasil baseado no censo demográfico de 2000. *Rev Saude Publica* [Internet]. 2005 [citado 10 de agosto de 2025];39(4):523–9. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/xq8S4XZ7sfV97LYGJfPF3hG/?lang=pt>
 8. Andrade PG, Schincaglia R, Farias DR, Castro IRR de, Anjos LA dos, Lacerda EM de A, et al. The National Wealth Score in the Brazilian National Survey on Child Nutrition (ENANI-2019). *Cad Saude Publica* [Internet]. 2023 [citado 10 de agosto de 2025];39(suppl 2). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2023001404001&lng=en

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.5.04 – Prevalência de déficit estatural para a idade em crianças menores de 5 anos de idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18342532



Fatores de risco e proteção



FRP.5.05 – Prevalência de dupla carga da má nutrição em crianças menores de 5 anos de idade

FRP.5.05 – Prevalence of double burden of malnutrition in children under 5 years

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual de crianças menores de 5 anos de idade com dupla carga da má nutrição, em um local e ano de referência.
- A dupla carga da má nutrição em crianças menores de 5 anos é definida pela observação dos extremos do estado nutricional. Ou seja, Índice de Massa Corporal (IMC) para idade classificado como magreza acentuada/magreza ou sobrepeso/obesidade, de acordo com as curvas de crescimento infantil da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006)¹.
- Define-se magreza acentuada/magreza quando o IMC para idade apresenta percentil menor que 3 ou escore-z menor que -2. Define-se sobrepeso/obesidade quando o IMC para idade apresenta percentil maior que 97 ou escore-z maior que 2. O IMC é definido como o peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros ($\text{peso}/\text{altura}^2$), sendo uma medida correlacionada com a adiposidade corporal, embora não represente sua medida direta, pois estima a massa e não a composição corporal.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de dupla carga da má nutrição, sendo tanto sobrepeso/obesidade quanto magreza acentuada/magreza na população de crianças menores de 5 anos de idade, com representatividade nacional.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição da prevalência da dupla carga da má nutrição, a fim de se identificarem grupos populacionais mais expostos. Estes grupos devem ser prioritários para as políticas públicas, tendo em vista que tanto a magreza acentuada/magreza quanto o sobrepeso/obesidade são considerados um problema de saúde pública e estão interligados. Portanto, devem ser implementadas ações de dupla função, que abordem simultaneamente essas condições nutricionais.
- Contribuir na análise de condições de saúde das crianças com predição para a dupla carga da má nutrição, visando à reflexão sobre questões desafiadoras para o sistema de saúde e demais setores.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à prevenção e ao tratamento da dupla carga da má nutrição e das doenças associadas, na população de crianças menores de 5 anos de idade.

LIMITAÇÕES

- O indicador depende da realização de estudos amostrais de base populacional. Esses estudos têm custos elevados e apresentam dificuldades de operacionalização.
- O indicador considera sobrepeso e obesidade agrupados, o que pode tornar pouco clara a condição prioritária destes problemas de saúde pública separadamente, nas diferentes regiões.
- Por utilizar como fonte de dados a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) 1989², a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 1996³ e 2006⁴ e o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) 2019⁵, que são pesquisas com representatividade nacional, mas com processos diferentes de seleção da amostra e amostragem, é necessário cautela na comparação das prevalências. Outra limitação é que, nos inquéritos de 1989² e 1996³, a região Norte não apresentou área rural, o que limita a comparação por desenho amostral diferente.
- Além disso, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais, e é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTES DE DADOS

- Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), 1989².
- Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 1996³ e 2006⁴.
- Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 2019⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de crianças menores de 5 anos com magreza acentuada/magreza (IMC para a idade com percentil menor que 3 ou escore-z menor que -2) ou sobrepeso/obesidade (IMC para a idade com percentil maior que 97 ou escore-z maior que 2), em um local e ano de referência}}{\text{Número de crianças menores de 5 anos, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Quantitativo de crianças menores de 5 anos com magreza/magreza acentuada (IMC para idade com percentil <3 ou escore-z <-2) ou sobrepeso/obesidade (IMC para idade com percentil >97 ou escore-z >2), de acordo com as curvas de crescimento da OMS¹. O escore-z/percentil deve ser calculado a partir dos seguintes dados da criança: idade em meses, IMC (razão entre o peso e a altura ao quadrado) e sexo.
- **Denominador:** Quantitativo total de crianças menores de 5 anos que tiveram peso e altura aferidos e a idade registrada.
- **Multiplicador:** 100.

Nota:

- A rotina de análise, os bancos de dados e os respectivos dicionários podem ser encontrados no Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde⁶.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Notas:

- Essa variável refere-se à cor ou raça da mãe.
- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “ignorado”, “outros”, “não sabe”, ou “recusou-se a responder”.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Nota:

- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “ignorado”, “outros”, “não sabe”, ou “recusou-se a responder”.

Indicador Econômico Nacional (IEN):

- 1º quinto;
- 2º quinto;
- 3º quinto;
- 4º quinto; e
- 5º quinto.

Nota:

- O IEN é um índice domiciliar sintético que avalia condições socioeconômicas a partir de um conjunto de itens^{7,8}. Na análise do ENANI 2019, foi considerada a atualização do IEN⁸.

GRANULARIDADE

- Região do Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (CGAN/DEPPROS/SAPS/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A prevalência da dupla carga da má nutrição foi maior em 2019, 13,1%. Em todos os períodos analisados, a região Sul tendeu a apresentar maiores prevalências de dupla carga da má nutrição (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%) de dupla carga da má nutrição em crianças menores de 5 anos de idade. Brasil e regiões, 1989, 1996, 2006 e 2019

Ano e pesquisa	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
1989* PNSN	10,7	9,6; 11,7	11,1	9,1; 13,1	8,9	7,6; 10,2	11,7	9,4; 13,9	13,4	11,4; 15,3	8,4	6,8; 9,9
1996* PNDS	9,9	8,9; 10,9	8,4	5,6; 11,2	11,7	10,1; 13,3	9,7	7,8; 11,6	7,2	4,5; 9,9	8,8	5,9; 11,6
2006 PNDS	9,0	7,6; 10,4	6,3	4,5; 8,2	8,8	6,4; 11,1	9,4	6,7; 12,1	10,9	7,9; 13,9	7,7	5,4; 10,0
2019 ENANI	13,1	11,9; 14,2	8,7	7,2; 10,3	13,3	11,2; 15,4	14,0	11,8; 18,5	15,0	11,5; 18,5	10,4	8,6; 12,2

Notas:

- *Na região Norte, os dados são relativos somente a áreas urbanas.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- PNSN: Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição; PNDS: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde; ENANI: Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil.
- A dupla carga da má nutrição em crianças menores de 5 anos é definida pelo Índice de Massa Corporal (IMC) para idade, classificado como magreza acentuada/magreza ou sobrepeso/obesidade, de acordo com as curvas de crescimento infantil da OMS (2006)¹.
- Define-se magreza acentuada/magreza quando o IMC para idade apresenta percentil menor que 3 ou escore-z menor que -2. Define-se sobrepeso/obesidade quando o IMC para idade apresenta percentil maior que 97 ou escore-z maior que 2.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Child growth standards [Internet]. [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.who.int/tools/child-growth-standards>
2. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), Fundação Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA). Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição PNSN – 1989. 1980. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv81879.pdf>
3. Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM), Programa de Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS) Macro International Inc. Pesquisa Nacional Sobre Demografia e Saúde 1996 [Internet]. 1997 [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr77/fr77.pdf>
4. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006: Dimensões do Processo Reprodutivo e da Saúde da Criança. 2009. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/pnds/>

5. Ministério da Saúde. Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil Infantil: ENANI-2019 [Internet]. OpenDATASUS. [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://enani.nutricao.ufrj.br/enani-2019/>
6. Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde. Bancos para elaboração dos Indicadores de Fator de Risco e Proteção da Rede Interagencial de Informações para Saúde - Dimensão 5: Estado Nutricional. Disponível em: <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/ripsa-fator-de-risco-e-protecao-5-estado-nutricional>
7. Barros AJD, Victória CG. Indicador econômico para o Brasil baseado no censo demográfico de 2000. Rev Saude Publica [Internet]. 2005 [citado 10 de agosto de 2025];39(4):523–9. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/xq8S4XZ7sfV97LYGJfPF3hG/>
8. Andrade PG, Schincaglia R, Farias DR, Castro IRR de, Anjos LA dos, Lacerda EM de A, et al. The National Wealth Score in the Brazilian National Survey on Child Nutrition (ENANI-2019). Cad Saude Publica [Internet]. 2023 [citado 10 de agosto de 2025];39(suppl 2). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2023001404001&tlng=en

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.5.05 – Prevalência de dupla carga da má nutrição em crianças menores de 5 anos de idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18342613



Fatores de risco e proteção



FRP.6.01 – Prevalência de aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida

FRP.6.01 – Exclusive breastfeeding prevalence during the first 6 months of life

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual de crianças residentes de 0 a 5 meses e 29 dias (0 a 179 dias) que estão sendo alimentadas exclusivamente com leite materno, em um local e ano de referência.
- O conceito de aleitamento materno exclusivo (AME) pressupõe que a criança receba apenas o leite materno, sem adição de água, chás, sucos e outros líquidos ou sólidos (exceto gotas ou xaropes de vitaminas, suplementos minerais ou outros medicamentos)^{1,2}.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência da prática do AME nos primeiros 6 meses de vida (de 0 a 5 meses e 29 dias; de 0 a 3 meses e 29 dias; e, de 4 a 5 meses e 29 dias), com representatividade nacional.
- Elevadas prevalências estão associadas a boas condições gerais de saúde e de nutrição da população infantil, considerando-se o potencial papel protetor do leite humano.
- Os principais benefícios do aleitamento materno são a redução dos riscos de distúrbios nutricionais, como desnutrição, excesso de peso e anemia ferropriva, e a proteção contra as doenças infecciosas e alergias, como diarreia, pneumonia e dermatite atópica. Além disso, a amamentação efetiva contribui com o melhor desempenho cognitivo e com a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis ao longo da vida.
- A meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030 prevê que 70% das crianças menores de 6 meses estejam em amamentação exclusiva.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição da prevalência do AME, identificando-se grupos populacionais com menores prevalências e que devem ser prioritários para as políticas públicas.
- Contribuir para análises das condições de saúde e nutrição dos lactentes e orientar medidas oportunas de intervenção, para que a maioria das crianças sejam mantidas em aleitamento materno até completarem 6 meses de vida, segundo as normas nacionais¹.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para a saúde da criança e da mulher.

LIMITAÇÕES

- As principais pesquisas nacionais são realizadas sem periodicidade definida, como a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), com suas edições em 1996, 2006 e 2023. Uma periodicidade regular e alinhamento com outros inquéritos, a exemplo do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) 2019, possibilitariam melhor avaliação do indicador.
- Embora existam outros inquéritos nacionais que tenham medidas de aleitamento materno, como a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) de 1989³ e a PNDS de 1996⁴, as perguntas sobre amamentação e alimentação infantil não possibilitam a identificação do AME, de forma correspondente aos demais inquéritos, inviabilizando seu uso na construção do indicador.
- Por se utilizar como fonte de dados a PNDS⁵ e o ENANI⁶, que são pesquisas com representatividade nacional, mas com processos diferentes de seleção de amostra e amostragem, é necessário cautela na comparação das prevalências.
- Além disso, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais, e é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- O Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) poderia gerar essas informações atualizadas e de forma periódica da população acompanhada pela Atenção Primária à Saúde. Entretanto, a sua baixa cobertura limita o seu uso como fonte para o indicador.
- Na PNDS⁵ e no ENANI⁶, a identificação do AME utiliza informações do consumo alimentar no dia anterior à entrevista. Assim, este indicador pode não refletir diretamente o percentual de lactentes que chegaram aos 6 meses de idade em AME. Entretanto, pode retratar o cenário da amamentação exclusiva no primeiro semestre de vida. Ademais, as informações do consumo alimentar são autorreferidas, podendo influenciar a validade das respostas.

FONTES DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 2006⁵.
- Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 2019⁶.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de crianças em aleitamento materno exclusivo, por período, durante os 6 primeiros meses de vida, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de crianças menores de 6 meses de vida, em um local e ano de referência}} \times 100$$

Nota:

- O período corresponde a: menores de 6 meses (0-5 meses e 29 dias); menores de 4 meses (0 a 3 meses e 29 dias); e de 4 a 5 meses e 29 dias.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Quantitativo de crianças em AME, por período, durante os 6 primeiros meses de vida.
- Denominador: Quantitativo total de crianças menores de 6 meses de idade com registro das informações para AME.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- A rotina de análise, os bancos de dados e os respectivos dicionários podem ser encontrados no Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde⁶.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Notas:

- Essa variável refere-se à cor ou raça da mãe.
- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “ignorado”, “outros”, “não sabe”, ou “recusou-se a responder”.

Faixa etária:

- Menor de 6 meses;
- Menor de 4 meses; e
- 4 a 5 meses.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Nota:

- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “ignorado”, “outros”, “não sabe”, ou “recusou-se a responder”.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Indicador Econômico Nacional (IEN):

- 1º quinto;
- 2º quinto;
- 3º quinto;
- 4º quinto; e
- 5º quinto.

Nota:

- O IEN é um índice domiciliar sintético que avalia condições socioeconômicas a partir de um conjunto de itens⁷⁸. Na análise do ENANI 2019, foi considerada a atualização do IEN⁹.

GRANULARIDADE

- Região do Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (CGAN/DEPPROS/SAPS/MS).

NOTAS

- Para a categoria período da infância (faixa etária), especificamente para a “de 4 a 5 meses”, não foi possível calcular os valores referentes à PNDS (2006), pois essa desagregação gerou uma estimativa enviesada, em função do baixo quantitativo de crianças nesta faixa etária.
- Os relatórios e dados dos inquéritos não utilizados no cálculo deste indicador podem ser acessados nos documentos a seguir: (i) Relatório PNSN (1989)³; (ii) Relatório PNDS (1996)⁴; e (iii) Banco de dados PNDS (1996)¹⁰.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Os resultados da prevalência de AME entre crianças menores de 6 meses, menores de 3 meses e com 4 e 5 meses de idade estão apresentados nas tabelas 1 e 2, respectivamente. A prevalência de AME em crianças menores de 6 meses, no Brasil, apresentou os seguintes resultados: em 2006, 38,4%; e 45,8%, em 2019. Na região Nordeste, a prevalência passou de 28,6%, em 2006, para 39,0%, em 2019. No Centro-Oeste, a prevalência passou de 44,7%, em 2006, para 46,5%, em 2019. Na região Sul, a prevalência passou de 29,0%, em 2006, para 54,3%, em 2019.

Entre crianças menores de 4 meses (0-3 meses), no Brasil, em 2019, observou-se a prevalência de 59,7% de AME. Nas regiões, a menor prevalência foi observada na região Norte, 55,8%, e a maior, no Centro-Oeste, 64,1%. Na faixa etária entre 4 e 5 meses, 23,3% das crianças estavam em AME no Brasil em 2019. Entre as regiões, a maior prevalência foi observada na região Sul (41,8%), seguida do Sudeste (28,1%) e do Centro-Oeste (24,1%). As regiões Norte (16%) e Nordeste (12,9%) apresentaram as menores prevalências.

Tabela 1 – Prevalência (%) de aleitamento materno exclusivo, entre crianças menores de 6 meses. Brasil e regiões, 2006 e 2019

Variáveis	PNDS 2006		ENANI 2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil e regiões				
Brasil	38,4	30,4; 46,4	45,8	40,9; 50,7
Norte	38,2	26,7; 49,7	40,3	26,9; 53,7
Nordeste	28,6	17,0; 40,2	39,0	27,9; 50,1
Sudeste	48,1	31,4; 64,8	49,1	40,6; 57,7
Sul	29,0	16,7; 41,3	54,3	47,7; 60,9
Centro-Oeste	44,7	31,9; 57,4	46,5	39,7; 53,4

- Notas:**
- PNDS: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde; ENANI: Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil.
 - IC95%: intervalo de confiança de 95%.

Tabela 2 – Prevalência (%) de aleitamento materno exclusivo, entre crianças menores de 4 meses. Brasil e regiões, 2006 e 2019

Variáveis	PNDS 2006		ENANI 2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil e regiões				
Brasil	46,7	36,0; 57,0	59,7	53,3; 66,0
Norte	55,4	41,2; 70,1	55,8	35,2; 76,4
Nordeste	29,5	14,6; 44,3	57,3	40,9; 73,6
Sudeste	56,3	36,7; 75,9	61,3	51,6; 70,9
Sul	40,4	23,1; 57,8	60,3	52,9; 67,7
Centro-Oeste	59,2	43,3; 75,5	64,1	56,4; 71,7

- Notas:**
- PNDS: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde; ENANI: Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil.
 - IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos [Internet]. Ministério da Saúde. 2019 [citado 28 de março de 2025]. p. 1–265. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/Documentos/pdf/guia-alimentar-para-criancas-brasileiras-menores-de-2-anos.pdf>

2. World Health Organization. Indicators for assessing infant and young child feeding practices: definitions and measurement methods [Internet]. [citado 28 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240018389>
3. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA). Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição PNSN – 1989. 1980. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv81879.pdf>
4. Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM), Programa de Pesquisas de Demografia e Saúde (DHS) Macro International Inc. Pesquisa Nacional Sobre Demografia e Saúde 1996 [Internet]. 1997 [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr77/fr77.pdf>
5. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006: Dimensões do Processo Reprodutivo e da Saúde da Criança. 2009. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/pnds/>
6. Ministério da Saúde. Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil: ENANI-2019 [Internet]. OpenDATASUS. [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/estudo-nacional-de-alimentacao-e-nutricao-infantil-enani-2019>
7. Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde. Bancos para elaboração dos Indicadores de Fator de Risco e Proteção da Rede Interagencial de Informações para Saúde - Dimensão 6: Consumo Alimentar. Disponível em: <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/ripsa-fator-de-risco-e-protacao-6-consumo-alimentar>
8. Barros AJD, Victória CG. Indicador econômico para o Brasil baseado no censo demográfico de 2000. Rev Saude Publica [Internet]. 2005 [citado 10 de agosto de 2025];39(4):523–9. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/xq8S4XZ7sfV97LYGJfPF3hG/>
9. Andrade PG, Schincaglia R, Farias DR, Castro IRR de, Anjos LA dos, Lacerda EM de A, et al. The National Wealth Score in the Brazilian National Survey on Child Nutrition (ENANI-2019). Cad Saude Publica [Internet]. 2023 [citado 10 de agosto de 2025];39(suppl 2). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2023001404001&tling=en
10. Demographic and Health Surveys. The DHS Program – Brazil: Standard DHS, 1996 Dataset [Internet]. [citado 28 de março de 2025]. Disponível em: https://www.dhsprogram.com/data/dataset/Brazil_Standard-DHS_1996.cfm?flag=0

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.6.01 – Prevalência de aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18342803



Fatores de risco e proteção



FRP.6.02 – Prevalência de aleitamento materno continuado em crianças menores de 2 anos

FRP.6.02 – Continued breastfeeding prevalence in children under two years

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual de crianças residentes menores de 2 anos que foram alimentadas com leite materno, diretamente do peito ou por expressão, concomitantemente à alimentação complementar, quando a criança está recebendo outros líquidos, tipos de leite ou alimentos sólidos e semissólidos, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Níveis de prevalência elevados estão associados a boas condições gerais de saúde e de nutrição da população infantil, sugerindo sua potencial resistência a infecções.
- Os principais benefícios do aleitamento materno incluem a redução dos riscos de distúrbios nutricionais, como desnutrição, excesso de peso e anemia ferropriva, e a proteção contra as doenças infecciosas e alergias, como diarreia, pneumonia e dermatite atópica. Além disso, a amamentação efetiva contribui com o melhor desempenho cognitivo e com a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, ao longo da vida.
- A Organização Mundial da Saúde (OMS)¹ recomenda que toda criança seja alimentada com leite materno pelo menos até os 2 anos de idade. A meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030 é que 60% das crianças menores de 2 anos estejam em aleitamento materno continuado^{2,3}.

USOS

- Analisar variações populacionais, demográficas, geográficas e temporais na duração do aleitamento materno nos 2 anos de vida.
- Contribuir na análise das condições de saúde e nutrição dos lactentes e orientar medidas oportunas de avaliação e intervenção.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à saúde da criança e da mulher.

LIMITAÇÕES

- As principais pesquisas nacionais são realizadas sem periodicidade definida, como a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), com suas edições em 1996, 2006 e 2023. Uma periodicidade regular e alinhamento com outros inquéritos, a exemplo do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) 2019, possibilitariam melhor avaliação do indicador.

- O Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) poderia gerar essas informações atualizadas e de forma periódica sobre a população acompanhada pela Atenção Primária à Saúde (APS). Entretanto, a sua baixa cobertura limita o seu uso como fonte para o indicador.
- Por se utilizar como fonte de dados a PNDS⁴ e o ENANI⁵, que são pesquisas com representatividade nacional, mas com processos diferentes de seleção de amostra e amostragem, é necessário cautela na comparação das prevalências.
- Além disso, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais, e é necessária a estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- As informações do consumo alimentar são autorreferidas, podendo influenciar a validade das respostas.

FONTES DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 2006⁴.
- Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), 2019⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de crianças menores de 2 anos de idade em aleitamento materno continuado, por período, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de crianças menores de 2 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

Nota:

- Os períodos correspondem a: de 12 a 15 meses e 29 dias; de 16 a 19 meses e 29 dias; de 20 a 23 meses e 29 dias; e menores de 24 meses (0 a 23 meses e 29 dias).

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Quantitativo de crianças menores de 2 anos de idade em aleitamento materno continuado, por período.
- Denominador: Quantitativo total de crianças menores de 2 anos de idade com registro das informações para aleitamento materno continuado.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- A rotina de análise, os bancos de dados e os respectivos dicionários podem ser encontrados no Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde⁶.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Notas:

- Essa variável refere-se à cor ou raça da mãe.
- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “ignorado”, “outros”, “não sabe”, ou “recusou-se a responder”.

Faixa etária:

- 12 a 15 meses e 29 dias;
- 16 a 19 meses e 29 dias;
- 20 a 23 meses e 29 dias; e
- Menor de 24 meses.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Nota:

- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “ignorado”, “outros”, “não sabe”, ou “recusou-se a responder”.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Indicador Econômico Nacional (IEN):

- 1º quinto;
- 2º quinto;
- 3º quinto;
- 4º quinto; e
- 5º quinto.

Nota:

- O IEN é um índice domiciliar sintético que avalia condições socioeconômicas a partir de um conjunto de itens^{7,8}. Na análise do ENANI 2019, foi considerada a atualização do IEN⁹.

GRANULARIDADE _____

- Região do Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (CGAN/DEPPROS/SAPS/MS).

NOTA _____

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Os resultados da prevalência de aleitamento materno continuado entre crianças de 12 a 15 meses, de 16 a 19 meses, de 20 a 23 meses e menores de 2 anos de idade estão apresentados na tabela 1. A prevalência de aleitamento materno continuado entre crianças de 12 a 15 meses de idade, no Brasil, variou de 48,0%, em 2006, a 52,1% em 2019.

A prevalência de aleitamento materno continuado entre crianças de 16 a 19 meses, no Brasil, em 2019, foi de 43,0%, sendo maior na região Norte (50,0%) e menor na região Sul (36,3%). Quanto à faixa etária entre 20 e 23 meses, no Brasil, a prevalência do aleitamento materno continuado aumentou de 24,0%, em 2006, para 35,5% em 2019.

Por fim, a prevalência de aleitamento em crianças menores de 24 meses, em 2019, no Brasil, foi de 60,3%, alcançando a meta de 60% prevista nos ODS^{2,3} e sendo maior na região Norte (66,3%) e menor na região Sul (55,0%) (Tabelas 1, 2, 3 e 4).

Tabela 1 – Prevalência (%) de aleitamento materno continuado, em crianças de 12 a 15 meses. Brasil e regiões, 2006 e 2019

Variáveis	PNDS 2006		ENANI 2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil e regiões				
Brasil	48,0	37,2; 58,8	52,1	45,4; 58,9
Norte	59,8	44,2; 75,4	56,4	33,5; 79,2
Nordeste	54,2	38,1; 70,2	58,6	51,6; 65,5
Sudeste	40,5	17,0; 64,0	51,4	36,3; 66,6
Sul	49,2	30,7; 67,4	34,8	24,9; 44,8
Centro-Oeste	44,9	29,5; 60,3	54,4	44,8; 64,0

Nota:

- PNDS: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde; ENANI: Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil.

Tabela 2 – Prevalência (%) de aleitamento materno continuado, em crianças de 16 a 19 meses. Brasil e regiões, 2006 e 2019

Variáveis	PNDS 2006		ENANI 2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil e regiões				
Brasil	32,1	23,3; 40,7	43,0	37,3; 48,8
Norte	29,7	16,5; 42,8	50,0	27,7; 72,3
Nordeste	49,7	33,9; 65,5	48,3	36,3; 60,3
Sudeste	25,6	11,0; 40,2	39,3	29,4; 49,3
Sul		*	36,3	28,9; 43,7
Centro-Oeste	41,9	26,0; 57,9	47,0	38,3; 55,6

- Notas:**
- *Coeficiente de variabilidade 0,30, desconsiderar a estimativa.
 - PNDS: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde; ENANI: Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil.

Tabela 3 – Prevalência (%) de aleitamento materno continuado, em crianças de 20 a 23 meses. Brasil e regiões, 2006 e 2019

Variáveis	PNDS 2006		ENANI 2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil e regiões				
Brasil	24,0	14,4; 33,5	35,5	30,4; 40,6
Norte	30,2	14,0; 46,5	39,0	26,2; 51,7
Nordeste	38,5	18,4; 58,6	48,0	37,2; 58,8
Sudeste		*	23,4	16,4; 30,4
Sul		*	42,6	31,9; 53,4
Centro-Oeste		*	32,3	24,3; 40,2

- Notas:**
- *Coeficiente de variabilidade 0,30, desconsiderar a estimativa.
 - PNDS: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde; ENANI: Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil.

Tabela 4 – Prevalência (%) de aleitamento materno continuado, em crianças menores de 24 meses. Brasil e regiões, 2006 e 2019

Variáveis	PNDS 2006		ENANI 2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil e regiões				
Brasil	46,0	41,2; 50,8	60,3	57,3; 63,2
Norte	55,1	47,5; 62,8	66,3	56,6; 75,9
Nordeste	51,4	43,1; 59,6	63,2	58,7; 67,7
Sudeste	43,0	33,6; 52,3	57,7	51,7; 63,7
Sul	34,7	27,0; 42,3	55,0	50,6; 59,4
Centro-Oeste	50,6	42,6; 58,6	63,1	59,6; 66,5

- Nota:**
- PNDS: Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde; ENANI: Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services [Internet]. [citado 28 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550086>

2. Souza CB de, Melo DS, Relvas GRB, Venancio SI, Silva RPGVC da. Promoção, proteção e apoio à amamentação no trabalho e o alcance do desenvolvimento sustentável: uma revisão de escopo. Cien Saude Colet [Internet]. 7 de abril de 2023 [citado 28 de março de 2025];28(4):1059–72. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232023284.14242022>
3. World Health Organization, United Nations Children's Fund. Global breastfeeding scorecard, 2019: increasing commitment to breastfeeding through funding and improved policies and programmes. WHOLIS [Internet]. 2019 [citado 28 de março de 2025]; Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/326049>
4. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006: Dimensões do Processo Reprodutivo e da Saúde da Criança. 2009. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/pnds/>
5. Ministério da Saúde. Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil: ENANI-2019 [Internet]. OpenDATASUS. [citado 24 de março de 2025]. Disponível em: <https://enani.nutricao.ufrj.br/enani-2019/>
6. Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde. Bancos para elaboração dos Indicadores de Fator de Risco e Proteção da Rede Interagencial de Informações para Saúde - Dimensão 6: Consumo Alimentar. Disponível em: <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/ripsa-fator-de-risco-e-protecao-6-consumo-alimentar>
7. Barros AJD, Victória CG. Indicador econômico para o Brasil baseado no censo demográfico de 2000. Rev Saude Publica [Internet]. 2005 [citado 10 de agosto de 2025];39(4):523–9. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/xq8S4XZ7sfV97LYGJfPF3hG/>
8. Andrade PG, Schincaglia R, Farias DR, Castro IRR de, Anjos LA dos, Lacerda EM de A, et al. The National Wealth Score in the Brazilian National Survey on Child Nutrition (ENANI-2019). Cad Saude Publica [Internet]. 2023 [citado 10 de agosto de 2025];39(suppl 2). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2023001404001&tlng=en

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.6.02 – Prevalência de aleitamento materno continuado em crianças menores de 2 anos [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18342855



Fatores de risco e proteção



FRP.6.03 – Participação relativa diária *per capita* das calorias de frutas, verduras e legumes no total de calorias dos alimentos adquiridos no domicílio

FRP.6.03 – Daily per capita relative contribution of calories from fruits and vegetables to total calories of foods purchased for household consumption

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Participação relativa diária *per capita* das calorias provenientes de frutas, verduras e legumes no total de calorias de alimentos adquiridos no domicílio para consumo pela população residente.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a participação relativa de calorias provenientes de alimentos *in natura* e de alto valor nutricional adquiridos no domicílio para consumo diário. A estimativa é *per capita* e calculada em relação às calorias diárias totais provenientes dos alimentos adquiridos no domicílio.
- As frutas, verduras e legumes são alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais. O maior consumo desses alimentos faz parte da regra de ouro do *Guia Alimentar para a População Brasileira*, que recomenda que os alimentos *in natura* ou minimamente processados devem ser a base da alimentação.
- A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o consumo diário de frutas, verduras e legumes deve ser de 400g, o que corresponde a 6-7% do total de calorias da dieta diária, faixa de referência para a interpretação do indicador.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição da estimativa do consumo alimentar a partir da aquisição de frutas, verduras e legumes na população.
- Contribuir para a análise de condições de saúde relacionadas ao consumo de frutas, verduras e legumes.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à promoção da alimentação adequada e saudável, por meio de medidas preventivas e assistenciais relativas a doenças associadas à alimentação.

LIMITAÇÕES

- O indicador depende da realização de estudos amostrais de base populacional. Esses estudos têm custos elevados e apresentam operacionalização complexa.

- A fonte de dados representativos da população brasileira a partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002-2003 não possibilita a desagregação por sexo ou faixa etária, o que é possível apenas na POF 2008-2009 e na POF 2017-2018.
- São estimativas realizadas com base em dados agregados e medidas indiretas, a partir da aquisição e não do consumo de alimentos.
- Os dados de aquisição dos alimentos são baseados na disponibilidade domiciliar destes e não representa o consumo propriamente, tendendo à sua subestimação. Além disso, o indicador representa uma estimativa do domicílio, não capturando diferenças entre seus membros.

FONTES DE DADOS

- Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003, 2008-2009 e 2017-2018¹
- Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA): o banco deve ser obtido diretamente com a equipe da TBCA, a partir do e-mail: tbca.contato@usp.br.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Total de calorias (per capita) de frutas, verduras e legumes adquiridos para o consumo da população}}{\text{Total de calorias (per capita) dos alimentos adquiridos para consumo da população}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Valor calórico total proveniente das frutas, legumes e verduras adquiridos no domicílio *per capita* e por dia, calculado a partir da soma do valor calórico destes alimentos, utilizando-se a TBCA.
- Denominador: Valor calórico total proveniente de todos os alimentos adquiridos no domicílio *per capita* e por dia, calculado a partir da soma do valor calórico de todos os alimentos, utilizando-se a TBCA.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- A rotina de análise, os bancos de dados e os respectivos dicionários podem ser encontrados no Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde².

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Quinto de renda:

- 1º quinto;
- 2º quinto;
- 3º quinto;
- 4º quinto; e
- 5º quinto.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Nota:

- Recomenda-se que as categorias informadas anteriormente sejam utilizadas, desestimulando-se, portanto, a utilização de categorias sem informação, tais como “sem declaração”.

GRANULARIDADE

- Região do Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (CGAN/DEPPROS/SAPS/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O percentual de participação relativa de calorias provenientes de frutas, verduras e legumes no total de calorias dos alimentos adquiridos para consumo pela população brasileira, ao longo do período avaliado, correspondeu a apenas 2,8%, 3,2% e 3,8% do total calórico para 2002-2003, 2008-2009 e 2017-2018, respectivamente, com maiores percentuais nos dois últimos períodos. Em 2002-2003, a participação relativa foi menor na região Centro-Oeste (2,2%), com diferenças significativas em relação à região Norte (3,3%), que apresentou o maior percentual. Na POF 2008-2009, não foi observada diferença entre as regiões. De acordo com os dados da POF 2017-2018, o menor percentual foi observado na região Nordeste (3,5%), que foi significativamente menor que o da região Sudeste (3,9%) (Tabela 1).

Tabela 1 – Participação relativa diária (%) *per capita* de frutas, verduras e legumes no total de calorias, determinado pela aquisição de alimentos no domicílio. Brasil e regiões, 2002-2003, 2008-2009 e 2017-2018

Ano da pesquisa	Brasil		Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
2002-2003 POF	2,8	2,6; 3,0	3,4	2,8; 4,0	2,4	2,2; 2,6	2,9	2,6; 3,3	3,2	2,4; 3,9	2,2	1,8; 2,5
2008-2009 POF	3,2	3,1; 3,3	3,0	2,5; 3,6	3,0	2,8; 3,2	3,3	3,1; 3,6	3,3	3,1; 3,6	3,0	2,6; 3,3
2017-2018 POF	3,8	3,6 ;3,9	3,4	2,8; 4,0	3,5	3,3; 3,7	3,9	3,7; 4,2	3,8	3,5; 4,0	3,8	3,4; 4,2

Notas:

- POF: Pesquisa de Orçamentos Familiares.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Orçamentos Familiares [Internet]. IBGE. [citado 27 de novembro de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-2.html?=&t=o-que-e>
2. Portal de Dados Abertos do Ministério da Saúde. Bancos para elaboração dos Indicadores de Fator de Risco e Proteção da Rede Interagencial de Informações para Saúde - Dimensão 6: Consumo Alimentar. Disponível em: <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/ripsa-fator-de-risco-e-protecao-6-consumo-alimentar>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.6.03 – Participação relativa diária *per capita* das calorias de frutas, verduras e legumes no total de calorias dos alimentos adquiridos no domicílio [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18342705



Fatores de risco e proteção



FRP.7.01 – Proporção de nascidos vivos por idade da parturiente

FRP.7.01 – Proportion of live births by maternal age

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de nascidos vivos (NVs), por idade da parturiente, em relação ao total de NVs, filhos de parturientes residentes em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Indica a proporção de NVs, por idade das parturientes, em relação ao total de NVs.
- A idade da parturiente pode estar associada a condições de risco para o recém-nascido (RN), tais como a prematuridade, o baixo peso ao nascer, e a ocorrência de anomalias congênitas. Essas condições são mais frequentes entre os RNs de parturientes adolescentes ou em idade acima de 35 anos.
- Identifica a quantidade de pessoas que estão engravidando com diferentes idades, desde muito jovens, até uma idade mais avançada.

USOS

- Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da distribuição dos NVs de parturientes com diferentes faixas etárias.
- Contribuir na avaliação dos níveis de saúde infantil e da parturiente, bem como dos fatores socioeconômicos e culturais que intervêm na ocorrência da gravidez.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações voltadas para a promoção da saúde reprodutiva, bem como para a atenção à saúde infantil e materna.

LIMITAÇÕES

- A proporção de NVs filhos de parturientes de diferentes idades é influenciada pela estrutura etária da população feminina e pelo padrão de fecundidade. As proporções observadas para determinado grupo etário de parturientes podem depender da frequência de NVs em outros grupos etários. A proporção de nascimentos em um grupo etário pode aumentar, mesmo que a natalidade esteja caindo neste grupo. Isto ocorrerá se a queda na natalidade for maior nos demais grupos etários.
- Deve ser usado em associação com informações adicionais, entre as quais a taxa específica de fecundidade.
- A completude da variável idade não chega a 100%, dependendo do espaço geográfico avaliado.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de nascidos vivos, por idade da parturiente, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de nascidos vivos, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de NVs, por idade da parturiente, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número total de NVs, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 34 anos;
- 35 a 39 anos; e
- 40 anos ou mais.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Brasil (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- A cobertura do Sinasc tem sido progressiva, contribuindo com sua capacidade de avaliar, de forma adequada, indicadores de saúde materno-infantil.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Esse indicador cobre 100% dos NVs, com completitude da variável idade > 98%.

O Sinasc aponta a redução da proporção de NVs entre adolescentes de 10 a 14 anos, de 0,90% (2000) para 0,55% (2023), e de 15 a 19 anos de idade, de 22,50% (2000) para 11,40% (2023); e aumento entre mulheres de 20 a 34 anos de idade, de 67,40% (2000) para 70,10% (2023). Entre mulheres com 35 a 39 anos de idade, aumentou a proporção de NVs de 6,70% (2000) para 13,60% (2023); de 40 anos ou mais de idade, aumentou de 1,90% (2000) para 4,30% (2023) (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) de nascidos vivos, segundo a faixa etária das parturientes. Brasil, 2000 a 2023

Ano	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 34 anos	35 a 39 anos	40 anos ou mais
2000	0,90	22,50	67,43	6,70	1,89
2001	0,90	22,37	67,56	6,78	1,92
2002	0,90	21,75	68,17	6,98	1,95
2003	0,90	21,26	68,68	7,00	1,98
2004	0,87	20,98	68,79	7,13	2,06
2005	0,88	20,90	68,86	7,15	2,05
2006	0,94	20,55	68,96	7,42	2,13
2007	0,97	20,14	69,16	7,55	2,17
2008	0,98	19,44	69,66	7,74	2,18
2009	0,96	18,98	69,92	7,92	2,22
2010	0,95	18,36	70,22	8,21	2,25
2011	0,95	18,30	69,84	8,61	2,29
2012	0,97	18,31	69,44	8,92	2,35
2013	0,96	18,32	69,07	9,25	2,40
2014	0,95	17,94	68,88	9,76	2,47
2015	0,88	17,26	68,98	10,31	2,56
2016	0,84	16,70	69,00	10,76	2,70
2017	0,76	15,69	69,12	11,56	2,86
2018	0,72	14,77	68,99	12,42	3,10
2019	0,68	14,04	69,11	12,78	3,39
2020	0,64	13,34	69,49	12,93	3,61
2021	0,65	12,97	69,56	12,99	3,82
2022	0,56	11,76	70,09	13,43	4,16
2023	0,55	11,40	70,11	13,61	4,33

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Nascidos Vivos – desde 1994 [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.7.01 – Proporção de nascidos vivos por idade da parturiente [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18342908



Fatores de risco e proteção



FRP.7.02 – Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer por idade gestacional no momento do parto

FRP.7.02 – Proportion of low birth weight live births by gestational age at delivery

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de nascidos vivos (NVs) com peso ao nascer inferior a 2.500 gramas, por idade gestacional no momento do parto, filhos de parturientes residentes em um local e ano de referência.
- Compreende a primeira pesagem do recém-nascido (RN), preferencialmente realizada até a quinta hora de vida.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa o percentual de NVs de baixo peso (menos de 2.500g), nascidos pré-termo (<37 semanas), a termo (37 a 42 semanas) ou pós-termo (42 semanas ou mais), em relação ao total de NVs.
- O baixo peso ao nascer pode ser decorrente da restrição do crescimento intrauterino ou de uma menor duração da gestação ou, ainda, de uma combinação de ambos.
- É um preditor da sobrevivência infantil. Quanto menor o peso ao nascer, maior a probabilidade de morte precoce. Em países desenvolvidos, observam-se valores em torno de 5% a 6%.
- Proporções elevadas de NVs de baixo peso estão associadas, em geral, a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico e de assistência materno-infantil.

USOS

- Descrever variações populacionais, geográficas e temporais da proporção de NVs de baixo peso.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações voltadas para a promoção da saúde reprodutiva, assistência no pré-natal e parto e proteção e atenção à saúde infantil.
- Em conjunto com outras variáveis (idade da parturiente, por exemplo), analisar os fatores condicionantes para um RN nascer com baixo peso.

LIMITAÇÕES

- Está sujeita à padronização de procedimentos (tempo para aferição do peso ao nascer, natureza e condições do equipamento utilizado) e disponibilidade das informações por categoria de análise (por exemplo, idade gestacional). A mensuração está particularmente prejudicada no caso de partos não hospitalares.

- A completude das variáveis peso ao nascer e idade gestacional no momento do parto podem não chegar a 100%, dependendo do espaço geográfico avaliado.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de nascidos vivos com peso inferior a 2.500g, por idade gestacional no momento do parto, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de nascidos vivos, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de NVs com peso inferior a 2.500g, por idade gestacional, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número total de NVs, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 34 anos;
- 35 a 39 anos; e
- 40 anos ou mais.

Tempo de gestação:

- Pré-termo (menos de 37 semanas completas);
- A termo (37-42 semanas completas);
- Pós-termo (acima de 42 semanas completas); e
- Total de NVs com baixo peso (< 2.500g).

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- A cobertura do Sinasc tem sido progressiva, contribuindo com sua capacidade de avaliar de forma adequada indicadores de saúde materno-infantil.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A proporção de NVs de baixo peso aumentou no Brasil, em todas as faixas etárias. Para todas as faixas, passou de 7,60% (2000) para 9,47% (2023). A proporção de NVs de baixo peso foi mais elevada nos extremos etários. Entre parturientes de 10 a 14 anos de idade, foi de 12,50% (2000) e de 14,81% (2023); e em parturientes com 40 anos ou mais de idade, foi de 11,33% (2000) e de 12,90% (2023) (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) de nascidos vivos com baixo peso (< 2.500g), por faixa etária da parturiente. Brasil, 2000 a 2023

Ano	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 34 anos	35 a 39 anos	40 anos e mais	Idade ignorada	Total
2000	12,50	8,74	6,89	9,40	11,33	6,02	7,60
2001	13,15	8,98	7,15	9,65	11,42	5,56	7,85
2002	13,17	9,27	7,35	9,75	11,57	6,92	8,07
2003	13,53	9,47	7,47	9,98	11,82	7,41	8,21
2004	13,46	9,45	7,46	9,92	11,81	7,09	8,19
2005	13,37	9,15	7,40	9,81	11,78	5,75	8,08
2006	13,64	9,31	7,52	9,77	11,69	4,62	8,20
2007	13,12	9,20	7,53	9,90	12,01	2,35	8,20
2008	13,79	9,29	7,62	9,81	12,03	11,89	8,27
2009	13,48	9,35	7,79	10,04	12,17	10,00	8,41
2010	13,03	9,35	7,79	9,91	12,28	12,89	8,40
2011	12,93	9,37	7,93	10,05	12,15	15,46	8,52
2012	12,66	9,26	7,87	10,02	11,94	22,00	8,46
2013	13,21	9,30	7,92	9,92	12,05	9,76	8,51
2014	12,90	9,17	7,79	9,75	11,97	12,77	8,38
2015	13,07	9,23	7,83	9,91	12,02	16,49	8,44
2016	13,65	9,41	7,87	9,74	11,75	17,65	8,48
2017	13,79	9,45	7,87	9,75	12,00	13,33	8,49

Ano	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 34 anos	35 a 39 anos	40 anos e mais	Idade ignorada	Total
2018	13,36	9,43	7,85	9,84	12,03	17,39	8,50
2019	13,55	9,65	8,06	9,91	12,16	16,67	8,70
2020	13,76	9,49	7,95	9,83	11,99	14,00	8,58
2021	13,59	9,82	8,26	10,27	12,22	13,11	8,91
2022	14,88	10,60	8,79	10,63	12,73	12,50	9,45
2023	14,81	10,52	8,82	10,69	12,90	17,65	9,47

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Nascidos Vivos – desde 1994 [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.7.02 – Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer por idade gestacional no momento do parto [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18342973



Fatores de risco e proteção



FRP.7.03 – Prevalência de nascidos vivos com anomalias congênitas

FRP.7.03 – Prevalence of live births with congenital anomalies

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de nascidos vivos (NVs) com menção a, pelo menos, uma anomalia congênita, em relação ao total de NVs registrados em um local e ano de referência, por 10 mil NVs.

INTERPRETAÇÃO

- Representa o número de casos de NVs com anomalias congênitas a cada 10 mil nascidos vivos, no Brasil, regiões e Unidades da Federação (UFs).
- As anomalias congênitas são um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Atualmente, cerca de 24 mil NVs são registrados ao ano no país com tais condições, e elas representam a segunda principal causa de mortalidade infantil.
- As anomalias congênitas estão associadas à maior probabilidade de desfechos adversos à saúde do NV, tais como nascimento prematuro, com baixo peso, apgar inferior a 7 no 1º e 5º minutos de vida, entre outras complicações, incluindo-se a mortalidade neonatal e infantil.
- Tais condições são mais frequentes dependendo de características da mãe (por exemplo, idade materna avançada, doenças maternas etc.) ou de exposições da mãe durante a gestação (por exemplo, a drogas, agentes biológicos etc.).
- Considerando-se o impacto das anomalias congênitas na morbidade e mortalidade dos NVs, seu monitoramento é fundamental para o reconhecimento precoce de eventos adversos, bem como o delineamento de políticas públicas para prevenção da sua ocorrência e assistência oportuna e qualificada aos indivíduos acometidos.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição dos NVs com anomalias congênitas.
- Analisar o perfil das parturientes cujos filhos apresentam alguma anomalia congênita.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações voltadas para a promoção da saúde reprodutiva, bem como para a atenção à saúde infantil e materna.

LIMITAÇÕES

- Sabe-se que há subnotificação de casos de anomalias congênitas, principalmente devido a falhas no diagnóstico ou ainda por conta da falta de reconhecimento da importância e

necessidade de se notificar e descrever, na Declaração de Nascido Vivo (DNV), as anomalias congênitas presentes.

- Apesar dessa subnotificação, percebe-se que houve uma gradativa melhora na captação dos casos ao longo dos anos, especialmente após 2015 e 2016, anos da Emergência em Saúde Pública devido à epidemia de microcefalia no Brasil.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de nascidos vivos com anomalias congênitas, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de nascidos vivos, em um local e ano de referência}} \times 10.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de NVs com anomalias congênitas, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número total de NVs, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 10.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 34 anos;
- 35 a 39 anos; e
- 40 anos ou mais.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/DAENT/SVSA/MS).

NOTA

- A cobertura do Sinasc tem sido progressiva, contribuindo com sua capacidade de avaliar, de forma adequada, indicadores de saúde materno-infantil.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Ocorreu um aumento da prevalência de nascidos vivos por 10 mil NVs com anomalias congênitas em todas as faixas etárias, passando de 44,87 por 10 mil NVs (2000) para 99,00 por 10 mil NVs (2023). As prevalências foram mais elevadas entre nascidos vivos, filhos de parturientes com idade acima de 35 anos (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%) de nascidos vivos (NVs) com anomalias congênitas, por faixa etária da parturiente, por 10 mil nascidos vivos. Brasil e regiões, 2000 a 2023

Ano	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 34 anos	35 a 39 anos	40 anos e mais	Idade ignorada	Total
2000	44,87	43,68	43,30	58,19	91,12	22,08	45,18
2001	61,58	47,69	48,54	61,85	95,93	16,97	50,13
2002	60,37	50,64	51,21	63,63	100,57	28,13	52,94
2003	67,20	55,17	53,17	67,45	109,58	25,66	55,79
2004	65,08	61,10	57,41	75,23	113,76	37,55	60,65
2005	62,05	60,85	58,80	78,31	125,18	32,75	61,97
2006	67,37	60,62	58,60	77,66	128,13	115,61	62,00
2007	71,17	62,65	61,93	82,51	133,47	29,33	65,26
2008	67,65	66,06	64,08	85,66	135,31	209,79	67,73
2009	73,00	69,49	69,06	94,17	153,78	200,00	73,05
2010	76,16	73,54	71,64	99,04	151,58	51,55	76,08
2011	87,10	78,88	74,23	96,29	152,85	0,00	78,90
2012	76,85	77,57	72,16	95,51	149,06	0,00	77,09
2013	73,60	81,28	74,60	95,22	155,19	243,90	79,66
2014	79,66	73,41	70,46	89,96	144,21	0,00	74,80
2015	84,27	81,73	75,50	100,37	150,69	103,09	81,14
2016	105,24	90,60	85,57	108,68	163,58	0,00	91,17
2017	89,86	80,47	81,30	106,60	162,93	0,00	86,49
2018	99,19	83,59	81,26	109,62	171,53	0,00	88,06
2019	84,84	84,52	80,89	102,77	167,96	0,00	87,18
2020	87,60	79,96	79,64	106,69	168,11	400,00	86,43
2021	75,05	80,63	78,39	106,08	170,06	163,93	85,76
2022	93,75	88,74	84,74	108,82	170,27	208,33	92,05
2023	99,00	98,12	93,35	120,33	184,85	0,00	101,55

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Nascidos Vivos – desde 1994 [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.7.03 – Prevalência de nascidos vivos com anomalias congênitas [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18343056



Fatores de risco e proteção



FRP.8.01 – Prevalência de violências contra mulheres com 18 anos ou mais de idade (PNS)

FRP.8.01 – Prevalence of violence against women aged 18 years and over (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de algum tipo de violência (psicológica, física ou sexual) referida por mulheres com 18 anos ou mais de idade, como tendo ocorrido nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a prevalência de mulheres brasileiras, com 18 anos ou mais de idade, que referem ter sofrido pelo menos algum dos tipos de violência referidos nas questões da pesquisa, em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de violências contra mulheres de 18 anos ou mais no Brasil.
- Apoiar o monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Objetivo 5 e Objetivo 16. Tendo em vista os impactos das violências para os indivíduos, as famílias, a sociedade e a saúde dos adolescentes, o enfrentamento desse agravo foi inserido na discussão da Agenda 2030 dos ODS.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas direcionadas à violência contra a mulher e à promoção da cultura de paz.

LIMITAÇÕES

- Trata-se de informação autorreferida.
- Não é possível obter estimativas anuais, em virtude da periodicidade da pesquisa.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.
- Por se utilizar como fonte de dados a PNS, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados da PNS, que é um inquérito amostral de saúde, de base domiciliar e de âmbito nacional, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNS foi realizada nos anos de 2013² e 2019³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de mulheres de 18 anos ou mais de idade que sofreram pelo menos algum dos tipos de violência referidos nas questões da pesquisa, nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência}}{\text{Número de mulheres de 18 anos ou mais de idade entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de mulheres (18 anos ou mais de idade) que sofreram pelo menos algum dos tipos de violência referidos nas questões da pesquisa, nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência.
- **Denominador:** Número de mulheres (18 anos ou mais de idade) entrevistadas, em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

Notas:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral do morador selecionado.
- Para o cálculo do indicador, utiliza-se o módulo de violência da PNS 2019 (Módulo (v), que é constituído por perguntas sobre violência psicológica, física e sexual. São consideradas como tendo sofrido violência as mulheres entrevistadas que responderam afirmativamente às questões específicas deste módulo.

Quadro 1 – Código da variável, tipo de violência e descrição de cada pergunta utilizada na composição do indicador

Código da variável	Tipo de violência	Descrição
V00201	Violência psicológica	Nos últimos 12 meses, alguém: te ofendeu, humilhou ou ridicularizou na frente de outras pessoas?
V00202		Nos últimos 12 meses, alguém: gritou com você ou te xingou?
V00203		Nos últimos 12 meses, alguém: usou redes sociais ou celular para ameaçar, ofender, xingar ou expor imagens suas sem o seu consentimento?
V00204		Nos últimos 12 meses, alguém: te ameaçou de ferir ou machucar alguém importante para você?
V00205		Nos últimos 12 meses, alguém: destruiu alguma coisa sua de propósito?

Código da variável	Tipo de violência	Descrição
V01401	Violência física	Nos últimos 12 meses, alguém: te deu um tapa ou uma bofetada?
V01402		Nos últimos 12 meses, alguém: te empurrou, segurou com força ou jogou algo em você com a intenção de machucar?
V01403		Nos últimos 12 meses, alguém: te deu um soco, chutou ou arrastou pelo cabelo?
V01404		Nos últimos 12 meses, alguém: tentou ou efetivamente estrangulou, asfixiou ou te queimou de propósito?
V01405		Nos últimos 12 meses, alguém: te ameaçou ou feriu com uma faca, arma de fogo ou alguma outra arma ou objeto?
V02701	Violência sexual	Nos últimos 12 meses, alguém: tocou, manipulou, beijou ou expôs partes do seu corpo contra sua vontade?
V02702		Nos últimos 12 meses, alguém: te ameaçou ou forçou a ter relações sexuais ou quaisquer outros atos sexuais contra sua vontade?

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 18 a 24 anos;
- 25 a 34 anos;
- 35 a 44 anos;
- 45 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação de domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes e Promoção da Cultura de Paz do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGVIVA/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de casos é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, em 2019, verifica-se maior prevalência de relato de violência psicológica em todas as faixas etárias (Gráfico 1). A prevalência de mulheres de 18 anos ou mais que relataram sofrer alguma violência nos últimos 12 meses foi de 19,4% (IC95% 18,7%; 20,1%). No que tange às regiões, observa-se que o Nordeste apresentou maior prevalência, cerca de 20,0% (Tabela 1).

Gráfico 1 – Prevalência de vitimização por violência total, psicológica, física ou sexual nos últimos 12 meses, entre mulheres com 18 anos ou mais de idade. Brasil, 2019

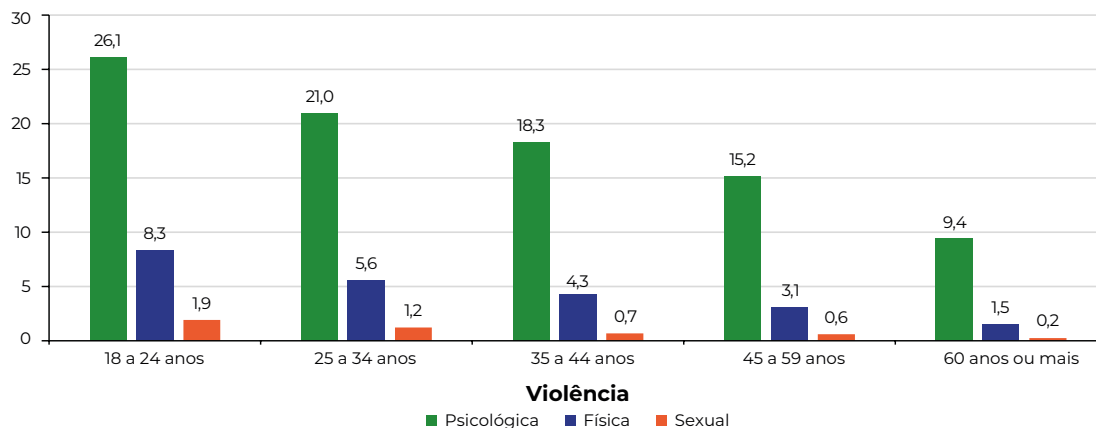


Tabela 1 – Prevalência (%) de vitimização por violência total, psicológica, física ou sexual nos últimos 12 meses, entre mulheres com 18 anos ou mais de idade. Brasil e regiões, 2019

Brasil e regiões	%	IC95%
Brasil	19,4	18,7; 20,1
Faixa etária		
18 a 24 anos	30,6	27,9; 33,3
25 a 34 anos	22,6	21,1; 24,2
35 a 44 anos	21,7	20,3; 23,2
45 a 59 anos	17,2	16,0; 18,4
60 anos ou mais	11,1	10,2; 12,1
Cor ou raça		
Branca	18,0	17,0; 19,0
Preta	21,3	19,5; 23,2
Amarela	19,1	11,3; 30,6
Parda	20,2	19,2; 21,2
Indígena*	28,0	19,5; 38,5
Norte	19,4	17,9; 21,1
Rondônia	14,4	11,8; 17,3
Acre	14,0	11,7; 16,7
Amazonas	19,3	16,6; 22,3
Roraima	25,2	21,7; 29,0
Pará	20,8	18,0; 24,0
Amapá	20,5	17,2; 24,3
Tocantins	18,5	15,6; 21,7
Nordeste	20,0	19,1; 21,0
Maranhão	19,2	17,4; 21,2
Piauí	20,0	16,8; 23,7
Ceará	19,5	17,5; 21,7
Rio Grande do Norte	19,7	17,1; 22,5
Paraíba	16,3	14,1; 18,8
Pernambuco	17,3	15,4; 19,2
Alagoas	16,5	13,6; 19,7
Sergipe	27,2	23,7; 30,9
Bahia	23,3	20,6; 26,2

Brasil e regiões	%	IC95%
Sudeste	19,6	18,3; 20,9
Minas Gerais	20,0	17,6; 22,6
Espírito Santo	20,8	17,9; 23,9
Rio de Janeiro	16,2	14,3; 18,2
São Paulo	20,6	18,7; 22,8
Região Sul	17,8	16,5; 19,3
Paraná	19,1	16,8; 21,7
Santa Catarina	14,2	12,1; 16,5
Rio Grande do Sul	18,9	16,6; 21,4
Centro-Oeste	18,9	17,1; 20,8
Mato Grosso do Sul	22,7	20,3; 25,4
Mato Grosso	14,8	11,7; 18,6
Goiás	19,4	16,1; 23,3
Distrito Federal	18,8	16,0; 21,9

Notas:

- *Na desagregação por raça/cor, as estimativas para indígenas devem ser interpretadas com cautela, pois a PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Dessa forma, a informação diz respeito a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2013: acesso e utilização dos serviços de saúde, acidentes e violências : Brasil, grandes regiões e unidades da federação [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 de março de 2025]. 1-105 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94074.pdf>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa nacional de saúde : 2019 : acidentes, violências, doenças transmissíveis, atividade sexual, características do trabalho e apoio social [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 de março de 2025]. 1-113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101800.pdf>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.8.01 – Prevalência de violências contra mulheres com 18 anos ou mais de idade (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 7p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18343111



Fatores de risco e proteção



FRP.8.02 – Prevalência de violência sexual contra meninas de 13 a 17 anos de idade (PeNSE)

FRP.8.02 – Prevalence of sexual violence against girls aged 13 to 17 years (PeNSE)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Prevalência de violência sexual contra meninas de 13 a 17 anos de idade que referiram ter sofrido alguma vez na vida violência sexual, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estimar a prevalência de meninas, com 13 a 17 anos de idade, que referem ter sofrido violência sexual alguma vez na vida, em um local e ano de referência.

USOS

- Identificar distribuições sociodemográficas, geográficas e temporais da prevalência de violência sexual contra meninas de 13 a 17 anos de idade.
- Apoiar o monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), mais especificamente os objetivos 5 e 16. Tendo em vista os impactos das violências para os indivíduos, as famílias, a sociedade e a saúde dos adolescentes, o enfrentamento desse agravo foi inserido na discussão da Agenda 2030 dos ODS.
- Subsidiar ações de intervenção, monitoramento e avaliação de políticas públicas de prevenção da violência sexual contra meninas e promoção da cultura de paz.

LIMITAÇÕES

- Tendo como fonte a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), que é programada para ser realizada a cada três anos, não será possível obter estimativas anuais.
- Por se utilizar como fonte de dados da PeNSE, uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados da PeNSE, que é um inquérito nacional coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com o apoio do Ministério da Educação.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de meninas de 13 a 17 anos de idade que relataram ter sofrido violência sexual alguma vez na vida, em um local e ano de referência}}{\text{Número de meninas de 13 a 17 anos de idade entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de meninas (de 13 a 17 anos de idade) que relataram ter sofrido violência sexual alguma vez na vida, em um local e ano de referência. Considerou-se terem sofrido violência sexual as meninas que responderam “sim” para uma das duas questões: (i) “Alguma vez na vida alguém o(a) ameaçou, intimidou ou obrigou a ter relações sexuais ou qualquer outro ato sexual contra a sua vontade?” e/ou (ii) “Alguma vez na vida alguém o(a) tocou, manipulou, beijou ou expôs partes do corpo contra a sua vontade?”
- **Denominador:** Número de meninas (de 13 a 17 anos de idade) entrevistadas, em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

Notas:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra da PeNSE.
- Para o cálculo do indicador, utiliza-se o módulo de violência da PeNSE 2019.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 13 a 15 anos; e
- 16 a 17 anos.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Trienal.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes e Promoção da Cultura de Paz do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CCVIVA/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem as condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Em 2019, a prevalência de meninas que referem ter sofrido violência sexual alguma vez na vida foi de 22,24% (IC95% 21,49%; 23,00%), sendo maior entre aquelas com 16 e 17 anos de idade. Verifica-se a maior prevalência nas regiões Sudeste (23,25%), Norte (23,21%) e Centro-Oeste (23,01%) (Tabela 1).

Tabela 1 – Prevalência (%) de meninas, com idade entre 13 e 17 anos, que referem ter sofrido violência sexual alguma vez na vida, segundo variáveis demográficas. Brasil, 2019

Variáveis e categorias	%	IC95%
Faixa etária		
13 a 15 anos	19,59	18,69; 20,52
16 e 17 anos	27,12	25,97; 28,31
Cor ou raça		
Branca	23,79	22,64; 24,97
Preta	21,76	19,87; 23,79
Amarela	-	-
Parda	20,90	19,96; 21,88
Indígena	-	-
Brasil e regiões		
Brasil	22,24	21,49; 23,00
Norte	23,21	21,07; 25,50
Nordeste	20,31	19,37; 21,30
Sudeste	22,21	20,37; 24,15
Sul	23,01	21,58; 24,50
Centro-Oeste	23,25	21,72; 24,85
Unidades da Federação		
Acre	21,59	19,18; 24,21
Amapá	27,67	25,74; 29,68
Amazonas	25,35	23,44; 27,37

Variáveis e categorias	%	IC95%
Para	22,64	18,57; 27,29
Rondônia	23,36	20,97; 25,92
Roraima	24,01	21,78; 26,38
Tocantins	19,09	16,69; 21,74
Alagoas	17,47	15,30; 19,88
Bahia	18,41	16,46; 20,52
Ceará	23,95	21,16; 26,99
Maranhão	20,70	18,07; 23,60
Paraíba	19,61	17,61; 21,78
Pernambuco	21,63	19,35; 24,10
Piauí	19,80	17,66; 22,14
Rio Grande do Norte	19,32	16,22; 22,54
Sergipe	18,25	16,35; 20,33
Espírito Santo	21,02	18,82; 23,40
Minas Gerais	20,98	18,01; 24,29
Rio de Janeiro	23,70	21,62; 25,91
São Paulo	24,33	21,89; 26,95
Paraná	22,62	19,66; 25,89
Rio Grande do Sul	20,74	17,53; 24,38
Santa Catarina	23,66	20,65; 26,95
Distrito Federal	24,22	21,22; 27,48
Goiás	21,97	19,78; 24,32
Mato Grosso	23,03	19,76; 26,67
Mato Grosso do Sul	24,18	21,59; 26,98
Capitais		
Rio Branco	24,49	20,43; 29,05
Macapá	28,99	26,41; 31,72
Manaus	24,97	22,72; 27,37
Belém	26,39	23,61; 29,37
Porto Velho	25,91	21,65; 30,67
Boa Vista	24,60	21,90; 27,51
Palmas	26,35	23,42; 29,50
Maceió	20,39	17,67; 23,40
Salvador	21,78	19,17; 24,65

Variáveis e categorias	%	IC95%
Fortaleza	28,79	25,52; 32,30
São Luís	25,00	21,94; 28,33
João Pessoa	21,84	19,79; 24,05
Recife	24,25	21,66; 27,04
Teresina	22,17	19,51; 25,08
Natal	25,12	21,98; 28,55
Aracaju	24,48	22,24; 26,87
Vitória	24,84	22,16; 27,73
Belo Horizonte	24,69	21,82; 27,81
Rio de Janeiro	23,87	20,21; 27,96
São Paulo	26,95	24,26; 26,98
Curitiba	24,19	21,61; 26,98
Porto Alegre	25,45	21,73; 29,56
Florianópolis	25,95	22,80; 29,37
Brasília	24,22	21,22; 27,48
Goiânia	23,41	21,03; 25,98
Cuiabá	22,15	19,42; 25,13
Campo Grande	27,72	25,09; 30,52

- Notas:**
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
 - Os valores das prevalências e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE – 2019 [Internet]. IBGE. [citado 28 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/9134-pesquisa-nacional-de-saude-doescolar.html?edicao=31442&t=downloads>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.8.02 – Prevalência de violência sexual contra meninas de 13 a 17 anos de idade (PeNSE) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18343174



Fatores de risco e proteção



FRP.9.01 – Índice CPO-D (número de dentes cariados, perdidos e obturados) aos 12 anos de idade

FRP.9.01 – DMFT index (decayed, missing, and filled teeth) at 12 years

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número médio de dentes permanentes cariados, perdidos (extraídos devido à cárie dentária) e obturados (restaurados), aos 12 anos de idade, em um local e ano de referência. A cárie dental corresponde ao código K02 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª revisão (CID-10) e DA08.0 da CID-11.

Nota:

- A letra “D” da sigla utilizada na denominação do índice refere-se a “dentes examinados”, com o objetivo de diferenciar este indicador de outro que trata de “superfícies dentárias examinadas” (ceo-s).

INTERPRETAÇÃO

- Estima a experiência acumulada da cárie dentária na dentição permanente aos 12 anos de idade, refletindo tanto os ataques atuais quanto os passados.
- A idade de 12 anos foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)¹ como parâmetro básico para uso do indicador.

USOS

- Identificar distribuições populacionais, geográficas, sociodemográficas e temporais da distribuição do índice CPO-D aos 12 anos de idade.
- Subsidiar ações de planejamento e avaliação de políticas públicas de prevenção e combate à cárie dentária.

LIMITAÇÕES

- Necessidade de estudos populacionais: sua aplicação depende de pesquisas amostrais em larga escala, que exigem alto investimento financeiro, apresentam dificuldades logísticas e, em geral, são realizadas em longos intervalos de tempo.
- Cobertura limitada das causas de perda dentária: o índice avalia apenas a experiência de cárie, não contemplando perdas dentárias decorrentes de outras condições, como doença periodontal, traumas, necessidades protéticas, indicações ortodônticas ou outras afecções bucais.
- Variações na interpretação clínica: os estágios iniciais da cárie podem ser interpretados de forma diferente entre examinadores, comprometendo a padronização dos resultados. Além disso, há tendência de subestimação do índice quando lesões restritas ao esmalte não são incluídas.

- Os levantamentos epidemiológicos nacionais realizados nos anos de 1986² e 1996³ diferem em aspectos metodológicos quando comparados aos levantamentos realizados a partir do ano 2000, cuja denominação é Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil)⁴.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil)⁴.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de dentes cariados, perdidos e obturados de indivíduos examinados aos 12 anos de idade, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de crianças examinadas aos 12 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número total de dentes cariados, perdidos (extraídos devido à cárie dentária) e obturados (restaurados) de indivíduos de 12 anos de idade completos, examinados no inquérito epidemiológico de saúde bucal (SB Brasil), em um ano de referência.

Dentes com extração indicada devem ser incluídos no componente C (cariados).

- **Denominador:** Número total de crianças com 12 anos de idade completos, examinadas no inquérito epidemiológico de saúde bucal (SB Brasil), no ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso pós-estratificação da amostra. São levadas em consideração as variáveis.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

Notas:

- Para o ano de 1996³, a granularidade está disponível apenas para o Brasil e regiões.
- A granularidade por UF está disponível apenas para o ano de 2023⁵.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Decenal.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (CGSB/DESCO/SAPS/MS).

NOTAS

- A OMS define, para o índice CPO-D, a escala de severidade: prevalência muito baixa (0,1 - 1,1); prevalência baixa (1,2 - 2,6); prevalência moderada (2,7 - 4,4); e prevalência alta (4,5 - 6,5)¹.
- Valores elevados do índice apontam para condições desfavoráveis de saúde bucal, frequentemente associadas a fatores socioeconômicos, barreiras de acesso aos serviços odontológicos e hábitos nocivos, como o consumo frequente de açúcares e acesso insuficiente ao flúor.
- Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal realizados em 1986 e 1996, assim como a Pesquisa sobre as Condições de Saúde Bucal da População Brasileira, realizada em 2003, possuem planos amostrais distintos das pesquisas nacionais de saúde bucal mais recentes, de modo que seus resultados não podem ser utilizados para compor uma série histórica⁴.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Em 2010, foi realizada a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal⁶, inquérito nacional de saúde bucal que incluiu, além de todas as 27 capitais, os municípios do interior das cinco regiões, a fim de trazer representatividade da amostra em nível nacional, bem como representatividade para grandes regiões, regiões do interior dos estados, capitais e Distrito Federal.

Neste estudo, o CPO-D aos 12 anos foi igual a 2,8, portanto, quase 3 dentes afetados pela cárie. Deve ser destacado que continuam sendo observadas importantes diferenças regionais. O CPO-D médio aos 12 anos nas capitais é de 1,7 enquanto, no interior, é de 2,2 (uma diferença de 27,0%). Comparando-se as regiões, o Norte (com 3,1), o Nordeste (com 3,2) e o Centro-Oeste (com 3,2) apresentam uma experiência de cárie aos 12 anos visivelmente maior que nas regiões Sudeste (2,3) e Sul (2,3). No Nordeste a proporção de dentes restaurados em relação ao CPO-D total é sensivelmente menor que no Sudeste. Em outras palavras, além de apresentar um ataque de cárie maior, no Nordeste há um padrão de acesso a serviços restauradores mais baixo, quando comparado com o Sudeste.

Ao se analisarem os dados da pesquisa SB Brasil 2023, verificou-se que, para 12 anos de idade, a média do índice CPO-D para o Brasil foi de 2,1, o que manteve o país dentro da meta da OMS para o ano 2000, a qual define um índice CPO-D de, no máximo, 3 dentes em média com experiência de cárie, meta já atingida em 2010. No entanto, as diferenças entre as UFs neste índice se mantiveram, com valores de CPO-D variando de 1,7, o valor mais baixo, na região Sudeste, a 3,2, o valor mais alto, na região Norte (Tabela 1).

Tabela 1 – Índice CPO-D (número médio de dentes cariados, perdidos e obturados) aos 12 anos de idade. Brasil e regiões, 2010 e 2023

Brasil e regiões	2010	2023
Brasil	2,8	2,1
Norte	3,1	3,2
Nordeste	3,2	2,6
Sudeste	2,3	1,7
Sul	2,3	2,1
Centro-Oeste	3,2	2,6

Notas:

- Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010 (SB Brasil 2010)⁷.
- Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2023 (SB Brasil 2023)⁵.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Oral health surveys: basic methods – 5th edition [Internet]. WHO. 2013 [citado 7 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.who.int/publications/item/9789241548649>
2. Ministério da Saúde. Levantamento epidemiológico em saúde bucal: Brasil, zona urbana, 1986 [Internet]. 1988 [citado 28 de setembro de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/brasil-sorridente/sb-brasil/dados/1986/relatorio-final-sb-brasil-1986.pdf>
3. Ministério da Saúde. Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal 1996 – cárie dental [Internet]. 1996 [citado 28 de setembro de 2025]. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sbucal/sbdescr.htm>
4. Ministério da Saúde. Dados SB Brasil [Internet]. MS. [citado 7 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/brasil-sorridente/sb-brasil/dados>
5. Ministério da Saúde. SB Brasil 2023: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: relatório final [Internet]. 1. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2025 [citado 28 de setembro de 2025]. 1–537 p. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sb_brasil_2023_relatorio_final_1edrev.pdf
6. Ministério da Saúde. Projeto SB Brasil 2003. Condições de saúde bucal da população brasileira 2002-2003 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2004 [citado 28 de setembro de 2025]. 1–52 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/condicoes_saude_bucal.pdf
7. Ministério da Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2012 [citado 28 de setembro de 2025]. 1–116 p. Disponível em: [www.saude.gov.br/bvsLegislaçãoemSaúdewww.saude.gov.br/saudelegiswww.saude.gov.br/bvs](http://www.saude.gov.br/bvs/LegislacaoemSaude/www.saude.gov.br/saudelegiswww.saude.gov.br/bvs)

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.9.01 – Índice CPO-D (número de dentes cariados, perdidos e obturados) aos 12 anos de idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18343207



Fatores de risco e proteção



FRP.9.02 – Proporção de crianças de 5 a 6 anos de idade livres de cárie (índice ceo-d igual a 0)

FRP.9.02 – Proportion of caries-free children aged 5 to 6 years (dmft Index equal to 0)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual de crianças de 5 a 6 anos de idade com índice ceo-d (número de dentes decíduos cariados, com extração indicada ou perdidos devido à cárie, e obturados) igual a zero, em um local e ano de referência. A cárie dental corresponde aos códigos K02 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª revisão (CID-10) e DA08.0 da CID-11.

Nota:

- A letra “d” da sigla utilizada na denominação do índice refere-se a “dentes examinados”, com o objetivo de diferenciar este indicador de outro que trata de “superfícies dentárias examinadas” (ceo-s).

INTERPRETAÇÃO

- Estima o percentual de crianças com a dentição decídua livre de cárie dental aos 5 e 6 anos de idade. Esta idade é adotada internacionalmente como parâmetro para uso do indicador¹.

USOS

- Identificar distribuições populacionais, geográficas, sociodemográficas e temporais da prevalência de cárie dental aos 5 e 6 anos de idade.
- Subsidiar ações de planejamento e avaliação de políticas públicas de prevenção e combate à cárie dentária.

LIMITAÇÕES

- Cobertura restrita: o indicador reflete apenas a experiência de cárie da criança, não incluindo perdas dentárias decorrentes de traumas ou de outras condições bucais.
- Variações na interpretação clínica: os estágios iniciais da cárie podem ser interpretados de forma diferente entre examinadores, o que compromete a uniformidade dos resultados.
- Subestimação dos casos: o índice pode ser subestimado quando lesões de esmalte não são consideradas na avaliação.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil)².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de crianças examinadas de 5 e 6 anos de idade com resultado } ceo - d = 0, \text{ em um local e ano de referência}}{\text{Número total de crianças examinadas de 5 e 6 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de crianças de 5 e 6 anos completos examinadas no inquérito epidemiológico de saúde bucal (SB Brasil), em determinado ano, que não apresentaram nenhum elemento dentário na dentição decídua com lesão de cárie, bem como nenhum elemento dentário com extração indicada devido à cárie ou perdido devido à cárie.
- **Denominador:** Número total de crianças de 5 e 6 anos completos examinadas no inquérito epidemiológico de saúde bucal (SB Brasil), no ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso pós-estratificação da amostra. São levadas em consideração as variáveis.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Decenal.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (CGSB/DESCO/SAPS/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem as condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.

- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.
- Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal realizados em 1986 e 1996, assim como a Pesquisa sobre as Condições de Saúde Bucal da População Brasileira, realizada em 2003, possuem planos amostrais distintos das pesquisas nacionais de saúde bucal mais recentes, de modo que seus resultados não podem ser utilizados para compor uma série histórica².

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O percentual de crianças brasileiras livres de cárie aos 5 e 6 anos de idade foi de 48,1% em 2010. Os resultados da SB Brasil 2023 mostraram que crianças com um ou mais dentes que possuem experiência de cárie corresponderam a 46,8%. Isso significa que 53,2% das crianças dessa idade estão livres de cárie no país. Destacam-se as diferenças regionais observadas, pois essa proporção é de 37,7% na região Norte, o valor mais baixo, e de 63,3% na região Sudeste, o valor mais alto, seguida da região Sul. Para avaliar o significado desses valores, é importante considerar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu que, até o ano 2000, essa porcentagem deveria ser superior a 50%. Como não foram estabelecidas metas para o período mais recente, essa referência é ainda utilizada para se avaliar a situação.

É importante ressaltar, também, que atenção especial deve ser dada à dentição temporária (decídua). Avaliando-se o ataque de cárie em crianças de 5 anos em 2023 (em que a presença majoritária é de dentição decídua), foi encontrada uma média de 2,14 dentes acometidos por cárie, com valores variando entre as regiões, de 1,67 (Sudeste) a 3,01 (Centro-oeste), sendo que 41,2% das crianças possuíam um ou mais dentes com cárie dentária não tratada (cariados). Comparando-se esse resultado com os resultados de 2010, nos quais as crianças de 5 anos possuíam 2,3 dentes afetados por cárie, sendo a maioria deles (80%) formada por dentes ainda não tratados, verificou-se que não houve redução estatisticamente significativa entre os dois índices ceo-d; porém, houve redução considerável no número de dentes cariados ainda não tratados. Assim como em relação ao número de crianças livres de cárie aos 5 anos, as médias do índice ceo-d são mais elevadas nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, em comparação com as regiões Sul e Sudeste (Tabela 1).

Tabela 1 – Percentual de crianças de 5 e 6 anos de idade com número de dentes decíduos cariados, extração indicada, perdidos devido à cárie e obturados (ceo-d) igual a 0, por ano. Brasil e regiões, 2010 e 2023

Brasil e regiões	2010	2023
Brasil	46,6	53,2
Norte	33,9	37,7
Nordeste	41,6	48,7
Sudeste	51,9	63,3
Sul	39,4	55,5
Centro-Oeste	38,8	38,0

Notas:

- Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010 (SB Brasil 2010)³.
- Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2023 (SB Brasil 2023)⁴.

REFERÊNCIAS

1. World Health Organization. Oral health surveys: basic methods – 5th edition [Internet]. WHO. 2013 [citado 7 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.who.int/publications/item/9789241548649>
2. Ministério da Saúde. Dados SB Brasil [Internet]. MS. [citado 7 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/brasil-sorridente/sb-brasil/dados>
3. Ministério da Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2012 [citado 28 de setembro de 2025]. 1–116 p. Disponível em: www.saude.gov.br/bvsLegislacaoemSaude
www.saude.gov.br/saudelegis
4. Ministério da Saúde. SB Brasil 2023: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: relatório final [Internet]. 1. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde; 2025 [citado 28 de setembro de 2025]. 1–537 p. Disponível em: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sb_brasil_2023_relatorio_final_1edrev.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Fatores de Risco e Proteção. FRP.9.02 – Proporção de crianças de 5 a 6 anos de idade livres de cárie (índice ceo-d igual a 0) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18343257





INDICADORES DE
COBERTURA (COB)

Indicadores de cobertura (COB)

Os indicadores do CGI Cobertura mensuram a utilização de serviços de saúde, como consultas médicas, realização de procedimentos e vacinação. São relevantes para a avaliação do atendimento das necessidades da população pelo sistema de saúde e apoio ao desenvolvimento das políticas e programas da área. Considerando-se as categorias de análise sugeridas para os indicadores, podem-se também identificar desigualdades e direcionar intervenções e políticas públicas para promoção da equidade em saúde.

O CGI apresenta uma composição intersetorial, e é constituído por representantes de mais de 30 instituições governamentais e acadêmicas. Desde a reativação da Ripsa, esse grupo realizou mais de 50 reuniões, com o objetivo de atualizar a lista de indicadores disponibilizados, considerando as mudanças nas fontes de dados, revisões metodológicas, e a proposição de novos indicadores. Esse processo colaborativo foi conduzido tendo como base o estabelecimento de consensos em todas as etapas de construção, validação, revisão e consolidação das FQIs e bases de dados.

Assim, os 23 indicadores de cobertura aqui apresentados representam o fruto de um amplo e contínuo esforço coletivo, orientado pela busca de consenso e pelo rigor técnico. Ao mensurar desde consultas e internações até a atenção à saúde da mulher, esses indicadores não apenas refletem a utilização dos serviços de saúde no Brasil, mas também se tornam ferramentas fundamentais para a avaliação do sistema, o planejamento de políticas públicas e a identificação de desigualdades. Sua construção intersetorial e metódica garante que possam, de fato, apoiar a promoção da equidade e o aprimoramento contínuo da saúde da população brasileira.



Dimensão 1 – Consultas médicas e odontológicas

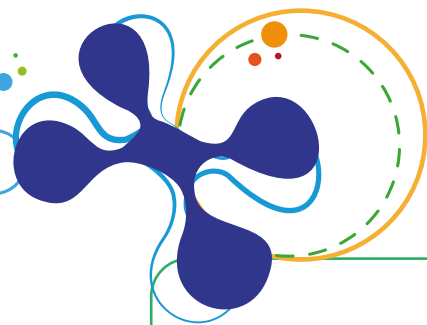
- COB.1.01 – Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Primária à Saúde por 100 habitantes
- COB.1.02 – Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Especializada em Saúde por 100 habitantes
- COB.1.03 – Razão de consultas médicas (saúde suplementar) por beneficiários de planos privados de saúde
- COB.1.04 – Proporção da população que referiu ter consultado médico nos últimos 12 meses (PNS)
- COB.1.05 – Proporção da população que referiu ter realizado consulta odontológica nos últimos 12 meses (PNS)
- COB.1.06 – Proporção da população que referiu nunca ter realizado consulta odontológica (PNS)

Dimensão 2 – Internações hospitalares

- COB.2.01 – Taxa de internações hospitalares (SUS) por 100 habitantes
- COB.2.02 – Taxa de internações hospitalares (saúde suplementar) por 100 beneficiários de planos privados de saúde
- COB.2.03 – Proporção da população que referiu internação hospitalar nos últimos 12 meses (PNS)

Dimensão 3 – Saúde da mulher

- COB.3.01.1 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero há menos de três anos (PNS)
- COB.3.01.2 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero há menos de três anos (Vigitel)
- COB.3.02.1 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero (PNS)
- COB.3.02.2 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero (Vigitel)
- COB.3.03.1 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de dois anos (PNS)
- COB.3.03.2 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de dois anos (Vigitel)



COB.3.04.1 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia (PNS)

COB.3.04.2 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia (Vigitel)

Dimensão 4 – Assistência ao parto e saúde reprodutiva

COB.4.01 – Proporção de nascidos vivos segundo o número de consultas de pré-natal

COB.4.02 – Proporção de partos hospitalares

COB.4.03 – Proporção de partos cesáreos

COB.4.04 – Proporção da população do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiu uso de métodos anticoncepcionais (PNS)

Dimensão 5 – Cobertura por planos de saúde

COB.5.01 – Proporção da população coberta por planos privados de assistência à saúde

COB.5.02 – Proporção da população que referiu cobertura por planos de saúde (PNS)

Cobertura



COB.1.01 – Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Primária à Saúde por 100 habitantes

COB.1.01 – Ratio of medical consultations (SUS) in Primary Health Care per 100 inhabitants

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Razão do número de consultas médicas no Sistema Único de Saúde (SUS) realizadas em estabelecimentos da Atenção Primária à Saúde (APS), por 100 habitantes, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a relação entre a produção de consultas médicas no SUS na APS e a população residente.
- Considera todas as consultas realizadas em estabelecimentos de saúde da APS vinculadas ao SUS e registradas nos sistemas de informação oficial.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; (ii) oferta de serviços, profissionais, recursos materiais, tecnológicos, financeiros etc.; (iii) políticas públicas de promoção da saúde, prevenção de doenças e atenção integral à saúde da população, incluindo-se critérios técnico-administrativos de pagamento adotados no âmbito do SUS; (iv) políticas públicas intersetoriais e gestão em saúde; (v) processos de trabalho das equipes; e (vi) cobertura por planos de saúde.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na realização de consultas médicas no SUS na APS, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir para a avaliação da produção de consultas médicas realizadas na APS em relação às necessidades da população.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médica na APS.

LIMITAÇÕES

- O numerador é por local de atendimento, e não por local de residência.
- Inclui as consultas médicas de pessoas não residentes, as quais não estão consideradas na população utilizada no denominador.
- Não inclui as consultas médicas realizadas sem vínculo com o SUS, embora o denominador seja a população total.

- Não inclui consultas médicas de APS registradas em outros sistemas de informação que não os destinados à produção da APS.
- Está disponível apenas a partir de 2018, ano em que os dados de produção da APS passaram a ser lançados exclusivamente em sistema específico para essa finalidade, conforme estabelecido nas portarias nº 1.412/2013/GM/MS, nº 2.148/2017/GM/MS e nº 7.639/2025/GM/MS.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informação da Atenção Básica (SISAB)¹.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções².
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número total de consultas médicas (SUS) realizadas na APS, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e ano de referência}}$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Soma das consultas médicas realizadas no SUS na APS e registradas no SISAB, em um local de atendimento e em um período de referência. Deve-se filtrar pelas categorias médicas da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): 2251 e 2252.
- **Denominador:** População residente.

Notas:

- A partir de 2025, o SISAB foi sucedido pelo Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde (Siaps).
- São considerados os registros de consultas médicas em conformidade com o Modelo de Informação de Atendimento Individual (MIAI) da estratégia e-SUS APS, que tenham sido realizados em estabelecimentos de APS de acordo com os critérios para entrada de dados do Siaps.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Ignorada.

Faixa etária:

- 0 a 9 anos;
- 10 a 19 anos;
- 20 a 49 anos;
- 50 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Faixa etária detalhada:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Estratégias, Acreditação e Componentes da Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (DEAPS/SAPS/MS).

NOTA

- A razão segundo cor ou raça não pode ser calculada, pois não há denominador disponível para essa desagregação.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, entre 2018 e 2024, a razão de consultas médicas na APS cresceu de forma consistente, após a queda observada em 2020, quando todas as regiões registraram redução, retomando a expansão a partir de 2021 e alcançando, em 2024, os maiores valores da série: 112,8 consultas por 100 habitantes (Tabela 1). Entre as regiões, evidenciaram-se desigualdades persistentes: o Sul apresentou as maiores razões em todo o período, aumentando de 104,6, em 2018, para 178,6, em 2024, enquanto a região Norte apresentou os menores valores, tendo evoluído de 48,3 para 73,4 consultas por 100 habitantes no mesmo intervalo. O Sudeste se manteve acima da média nacional após 2021, atingindo 116,9 consultas por 100 habitantes em 2024; por seu turno, o Centro-Oeste e o Nordeste também cresceram, chegando respectivamente a 107,5 e 84,9 consultas por 100 habitantes em 2024, mas seguem abaixo do patamar do Sudeste e do Sul.

Tabela 1 – Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Primária à Saúde (APS) por 100 habitantes. Brasil e regiões, 2018 a 2024

Brasil e regiões	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	70,0	70,6	60,1	73,1	88,3	102,1	112,8
Norte	48,3	49,5	43,5	52,8	57,5	63,4	73,4
Nordeste	58,9	58,8	49,9	58,2	69,4	78,8	84,9
Sudeste	71,1	70,0	59,3	72,4	88,9	105,7	116,9
Sul	104,6	108,7	91,5	116,4	141,4	161,4	178,6
Centro-Oeste	62,7	67,9	60,3	70,9	86,0	96,5	107,5

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) [Internet]. [citado 30 de dezembro de 2025]. Disponível em: <https://sisab.saude.gov.br/>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
3. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.1.01 – Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Primária à Saúde por 100 habitantes [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18497879



Cobertura



COB.1.02 – Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Especializada em Saúde por 100 habitantes

COB.1.02 – Ratio of medical consultations (SUS) in specialized healthcare per 100 inhabitants

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Razão do número de consultas médicas no Sistema Único de Saúde (SUS) realizadas na Atenção Especializada em Saúde, por 100 habitantes, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a relação entre a produção de consultas médicas no SUS realizadas na Atenção Especializada em Saúde e a população residente.
- Inclui todas as consultas realizadas pelas unidades de saúde da Atenção Especializada em Saúde vinculadas ao SUS registradas nos sistemas de informação oficiais.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de profissionais, recursos materiais, tecnológicos, financeiros etc.; (iii) políticas públicas de promoção da saúde, prevenção de doenças e atenção integral à saúde da população, incluindo-se critérios técnico-administrativos de pagamento adotados no âmbito do SUS; (iv) políticas públicas intersetoriais e gestão em saúde; (v) processos de trabalho das equipes; e (vi) cobertura por planos de saúde.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na realização de consultas médicas no SUS na Atenção Especializada em Saúde, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir para a avaliação da produção de consultas médicas realizadas na Atenção Especializada em Saúde em relação às necessidades da população.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médica na Atenção Especializada em Saúde.

LIMITAÇÕES

- O numerador é por local de atendimento, e não por local de residência.
- Inclui as consultas médicas de pessoas não residentes, as quais não estão consideradas na população utilizada no denominador. Como consequência, é possível que o indicador seja superestimado em localidades que atraem consultas da Atenção Especializada em Saúde, e subestimado nas demais localidades.

- Não inclui as consultas médicas realizadas sem vínculo com o SUS, embora o denominador seja a população total.
- As consultas são registradas por meio do Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I) ou do Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C). Este último não permite a desagregação por características do paciente (local de residência, sexo, faixa etária, cor ou raça, e outras).
- Considera as consultas registradas através do procedimento 03.01.01.007-2 – Consulta médica em Atenção Especializada. Eventualmente, outras consultas médicas de Atenção Especializada à Saúde podem estar registradas em outros códigos de procedimentos.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)¹.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções².
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número total de consultas médicas (SUS) realizadas na Atenção Especializada em Saúde, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Soma das consultas médicas no SUS realizadas na Atenção Especializada em Saúde e registradas no SIA/SUS, no local de atendimento, em um ano de referência.

Consultas médicas, aprovadas ou não, apresentadas no SIA/SUS: acessar as bases do SIA/SUS e considerar a quantidade de procedimentos apresentados (PA_QTDAPR), segundo o município de atendimento (PA_UFMUN) e o ano de atendimento (PA_MVM). Devem ser utilizados apenas os procedimentos (PA_PROC_ID) registrados como 03.01.007-2 que tenham sido executados por médicos (PA_CBOCOD – 4 primeiros dígitos = 2231, 2251, 2252 ou 2253).

- Denominador: População residente.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- A partir de 2011, houve uma reclassificação na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), quando as ocupações médicas foram reclassificadas da família 2231 – Médicos, para as famílias 2251 – Médicos clínicos, 2252 – Médicos em especialidades cirúrgicas e 2253 – Médicos em medicina diagnóstica e terapêutica. Algumas extensões feitas pelo Ministério na CBO, para acomodar algumas especialidades não previstas na mesma, tais como médicos residentes, broncoesofalogistas, de cardiologista Intervencionista, entre outras, continuaram a usar códigos na família 2231.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Especialidades médicas	CBO novo	CBO antigo
Médico clínico	225125	223115
Médico ortopedista e traumatologista	225270	223146
Médico oftalmologista	225265	223144
Médico ginecologista e obstetra	225250	223132
Médico pediatra	225124	223149
Médico cardiologista	225120	223106
Médico psiquiatra	225133	223153
Médico dermatologista	225135	223117
Médico endocrinologista e metabologista	225155	223125
Médico neurologista	225112	223142
Médico cirurgião geral	225225	223110
Médico urologista	225285	223157
Médico otorrinolaringologista	225275	223147
Médico gastroenterologista	225165	223128
Médico nefrologista	225109	223139
Médico oncologista clínico	225121	223145
Médico infectologista	225103	223136
Médico geriatra	225180	223131
Demais especialidades	Todas as demais especialidades médicas	

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Regulação Assistencial e Controle da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (DRAC/SAES/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, de 2015 a 2024, a razão de consultas médicas (SUS) realizadas na Atenção Especializada em Saúde pela população apresentou uma tendência de aumento, evoluindo de 49,4 (2015) para 57,2 (2024) consultas por 100 habitantes (Tabela 1). A região Sudeste apresentou os maiores valores ao longo do período, chegando a 64,2 consultas por 100 habitantes em 2024, enquanto a região

Norte permaneceu com os menores valores, atingindo 42,7 no mesmo ano. O Nordeste destaca-se pelo crescimento expressivo a partir de 2021, ultrapassando 50 consultas por 100 habitantes em 2024. Ressalte-se que, em 2020, ocorreu uma queda significativa em todas as regiões e no país, provavelmente relacionada à pandemia de COVID-19, seguida de recuperação nos anos seguintes.

Tabela 1 – Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Especializada em Saúde, por 100 habitantes. Brasil e regiões, 2015 a 2024

Brasil e regiões	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	49,4	47,6	46,8	48,3	50,2	36,2	45,5	49,2	53,0	57,2
Norte	36,5	34,7	34,0	34,5	33,6	23,8	29,9	37,6	40,8	42,7
Nordeste	36,2	35,3	35,5	38,9	43,5	36,7	52,2	46,6	48,4	52,3
Sudeste	60,4	56,8	55,3	56,7	57,8	39,0	46,4	53,5	58,7	64,2
Sul	49,7	49,8	49,2	48,7	49,8	35,0	40,7	47,1	50,4	54,2
Centro-Oeste	50,0	50,5	49,5	50,2	51,2	35,8	43,7	51,5	56,7	58,5

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (BR). Produção Ambulatorial (SIA/SUS) – DATASUS [Internet]. DATASUS. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-ambulatorial-sia-sus/>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
3. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.1.02 – Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Especializada em Saúde por 100 habitantes [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18497921



Cobertura



COB.1.03 – Razão de consultas médicas (saúde suplementar) por beneficiários de planos privados de saúde

COB.1.03 – Ratio of medical consultations (private health insurance) per private health plan beneficiaries

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Razão entre as consultas médicas realizadas por meio de operadoras de planos privados de saúde e os beneficiários de planos privados de saúde com cobertura ambulatorial residentes em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a relação entre a produção de consultas médicas na saúde suplementar e a população beneficiária de planos privados de saúde.
- É influenciada por: (i) tipo de contratação do plano privado (individual ou coletivo [empresarial e adesão]); (ii) presença de fatores moderadores de uso (coparticipação ou franquia); (iii) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; e (iv) infraestrutura de serviços do setor de saúde suplementar, com relação à disponibilidade de rede prestadora de serviços própria, contratada, credenciada, ou por reembolso.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na realização de consultas médicas na saúde suplementar, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir para se avaliar a adequação do volume da produção de consultas médicas em relação às necessidades da população beneficiária de planos privados de saúde.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação da rede prestadora de serviços de saúde das operadoras de planos privados de saúde.

LIMITAÇÕES

- O Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) contabiliza o número de vínculos a planos de saúde, e não o número de indivíduos. Desta forma, indivíduos que possuem mais de um plano privado de saúde serão contabilizados mais de uma vez.
- Consultas pagas em pacote não entram no cálculo do indicador, pois não é possível identificá-las na base Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS).

- Não inclui a população vinculada a instituição patronal de assistência ao servidor público civil e militar.
- Antes de 2017, a base de dados não era utilizada para avaliação de desempenho das operadoras de planos de saúde, e apresentava maior incompletude.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informações de Beneficiários (SIB)¹.
- Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS)².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de consultas médicas pagas por operadoras de planos privados de saúde, em um local e ano de referência}}{\text{Número de beneficiários de planos de assistência médica com cobertura ambulatorial, em um local e ano de referência}}$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de consultas médicas realizadas por meio de operadoras de planos privados de saúde.

A partir das bases de dados disponibilizadas pela ANS de atendimento ambulatorial do TISS², selecionar o número de consultas (QT_ITEM_EVENTO_INFORMADO), segundo o município de residência (CD_MUNICIPIO_BENEFICIARIO), o ano de realização (DT_REALIZACAO – quatro primeiros dígitos), a faixa etária (FAIXA_ETARIA) e o sexo do beneficiário (SEXO).

Será necessária uma seleção e agregação a partir dos dados detalhados, para recuperar as consultas, e, depois, proceder à junção com os dados consolidados para se obterem os dados de município, faixa etária e sexo. O campo de ligação entre ambos os arquivos é ID_EVENTO_ATENCAO_SAUDE.

Os procedimentos devem ser selecionados segundo CD_TABELA_REFERENCIA e CD_PROCEDIMENTO, na lista de procedimentos de consultas que consta no arquivo.xlsx DE-PARA SIP-TUSS³ na aba "Planilha 2_SIP-TUSS", incluindo-se consultas em pronto-socorro.

Descartar quantidades de itens superiores a 999.

- **Denominador:** Número de beneficiários de planos de assistência médica com cobertura ambulatorial¹.
- **Multiplicador:** Não se aplica.

Nota:

- As operadoras podem utilizar códigos próprios, caso o termo assistencial não conste na tabela TUSS 22 do Padrão TISS. Esses termos de tabela própria (tabela 00) não são passíveis de identificação, e por isso não são contabilizados no indicador.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 9 anos;
- 10 a 19 anos;
- 20 a 49 anos;
- 50 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Faixa etária detalhada:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;
- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Desenvolvimento Setorial da Gerência de Padronização, Interoperabilidade e Análise de Informações e Desenvolvimento Setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (DIDES/GPIND/ANS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Observa-se que, nos últimos dez anos, o Brasil apresentou entre 3,5 e 4,8 consultas médicas na saúde suplementar por beneficiários de planos privados de saúde. Entre 2015 e 2019, os valores mostraram-se crescentes, mas, em 2020, primeiro ano da pandemia de COVID-19, houve um decréscimo, em todas as regiões, em relação ao ano anterior. Em 2024, as regiões Sul e Nordeste apresentaram as maiores razões de consultas médicas na saúde suplementar por beneficiários de planos de saúde, 5,0 e 4,8, respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1 – Razão de consultas médicas (saúde suplementar) por beneficiários de planos privados de saúde. Brasil e regiões, 2015 a 2024

Brasil e regiões	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	3,5	4,1	4,7	4,7	4,8	3,5	4,1	4,5	4,7	4,7
Norte	2,8	2,9	3,7	4,4	4,3	3,2	3,8	4,2	4,3	4,4
Nordeste	3,2	3,6	4,4	4,7	5,0	3,4	4,2	4,8	4,9	4,8
Sudeste	3,7	4,3	4,8	4,6	4,8	3,5	4,1	4,5	4,8	4,7
Sul	3,3	3,5	4,4	4,6	4,7	3,6	4,2	4,8	4,9	5,0
Centro-Oeste	2,8	3,2	4,0	4,3	4,3	3,0	3,2	3,6	3,8	3,8

Nota:

- Os dados são provenientes do Sistema de Informações de Beneficiários (SIB)¹ e da base Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS)².

REFERÊNCIAS

1. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sistema de Informações de Beneficiários [Internet]. ANS. [citado 16 de abril de 2025]. Disponível em: https://dadosabertos.ans.gov.br/FTP/Base_de_dados/Microdados/dados_dbc/beneficiarios/municipios/
2. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Troca de Informações na Saúde Suplementar – TISS [Internet]. ANS. [citado 16 de abril de 2025]. Disponível em: <https://dadosabertos.ans.gov.br/FTP/PDA/TISS/AMBULATORIAL/>
3. Agência Nacional de Saúde Suplementar. SIP – Manual de Orientação e Outros Documentos. Tabela DE-PARA SIP-TUSS [Internet]. ANS. [citado 16 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais-do-portal-operadoras/sip-manual-de-instalacao-historico-de-versao-e-outros-arquivos>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.1.03 – Razão de consultas médicas (saúde suplementar) por beneficiários de planos privados de saúde [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18497972



Cobertura



COB.1.04 – Proporção da população que referiu ter consultado médico nos últimos 12 meses (PNS)

COB.1.04 – Proportion of population reporting medical consultation in the last 12 months (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população que referiu ter consultado médico nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a utilização de consultas médicas da população brasileira, independentemente da fonte de financiamento (Sistema Único de Saúde – SUS, planos de saúde e desembolso direto).
- É influenciado por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade, composição etária; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas assistenciais e preventivas; e (iv) cobertura por planos de saúde.

USOS

- Contribuir para avaliar a produção de consultas médicas em relação às necessidades assistenciais da população.
- Analisar variações geográficas e temporais no acesso a consultas médicas, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para o cuidado de saúde.

LIMITAÇÕES

- Como em toda informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode sofrer influência de respostas inexatas ao questionário, ocasionadas tanto pela compreensão do respondente em relação à pergunta, como pela resposta fornecida por terceiros.
- Existe a possibilidade de atendimentos realizados por outros profissionais de saúde serem referidos pela população como realizados por médicos.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas e pessoas amarelas devem ser interpretadas com cautela, devido ao pequeno número de observações na amostra.
- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas que referiram ter consultado médico nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de pessoas entrevistadas que responderam “Nos doze últimos meses” à questão: “Quando o(a) Sr.(a) consultou um médico pela última vez?”.

Utilizar as variáveis:

- › PNS 2013: J011 = 1; e
- › PNS 2019: J01101 = 1.

- **Denominador:** Número de pessoas entrevistadas.
- **Multiplicador:** 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra do morador selecionado do domicílio, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até ¼ do salário mínimo;
- Mais de ¼ até ½ salário mínimo;
- Mais de ½ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;

- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DAENT/SVSA/MS).
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Em 2019, no Brasil, 76,2% das pessoas referiram ter consultado um médico, nos 12 meses anteriores à data da entrevista, o que representa aumento em relação ao ano de 2013 (71,2%).

A menor proporção nos dois anos foi apresentada pela região Norte, apesar do aumento de 61,4% para 68,0% entre os anos avaliados. O maior valor foi alcançado pela região Sudeste, em 2019 (80,6%) (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) da população que referiu ter consultado médico nos últimos 12 meses, com indicação do IC95%. Brasil e regiões, 2013 e 2019

Brasil e regiões	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil	71,2	70,7; 71,7	76,2	75,8; 76,5
Norte	61,4	59,9; 62,8	68,0	66,9; 69,0
Nordeste	66,3	65,5; 67,1	71,9	71,3; 72,5
Sudeste	75,8	74,8; 76,8	80,6	79,9; 81,2
Sul	73,8	72,6; 74,9	77,7	76,9; 78,5
Centro-Oeste	69,5	68,4; 70,6	73,7	72,6; 74,8

Nota:

- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.1.04 – Proporção da população que referiu ter consultado médico nos últimos 12 meses (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18498040



Cobertura



COB.1.05 – Proporção da população que referiu ter realizado consulta odontológica nos últimos 12 meses (PNS)

COB.1.05 – Proportion of population reporting dental consultation in the last 12 months (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população que referiu ter realizado consulta odontológica nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a utilização de consultas odontológicas pela população brasileira, com financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) ou não.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas assistenciais e preventivas; e (iv) cobertura por planos de saúde.

USOS

- Contribuir para avaliar a produção de consultas odontológicas em relação às necessidades assistenciais da população.
- Analisar variações geográficas e temporais no acesso a consultas odontológicas, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para a saúde bucal.

LIMITAÇÕES

- Como em toda informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode sofrer influência de respostas inexatas ao questionário, ocasionadas tanto pela compreensão do respondente em relação à pergunta, como pela resposta fornecida por terceiros.
- Existe a possibilidade de atendimentos realizados por outros profissionais de saúde serem referidos pela população como realizados por odontólogos.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas e pessoas amarelas devem ser interpretadas com cautela, devido ao pequeno número de observações na amostra.
- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas que referiram ter realizado consulta odontológica nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de pessoas entrevistadas que responderam “Nos doze últimos meses” à questão: “Quando o(a) Sr.(a) consultou um dentista pela última vez?”.

Utilizar as variáveis:

- › PNS 2013: J013 = 1; e
- › PNS 2019: J01301 = 1.

- Denominador: Número de pessoas entrevistadas.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra do morador selecionado do domicílio, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Renda domiciliar per capita:

- Até ¼ do salário mínimo;
- Mais de ¼ até ½ salário mínimo;
- Mais de ½ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE _____

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DAENT/SVSA/MS).
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NOTA _____

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR _____

Observa-se incremento da proporção da população que referiu ter realizado consulta odontológica nos 12 meses anteriores à entrevista, de 2013 a 2019, no Brasil e em todas as regiões brasileiras. O indicador passou de 44,4%, em 2013, para 49,4%, em 2019, no Brasil.

As regiões Sudeste (de 48,3% para 53,0%) e Sul (de 51,9% para 55,8%) mantiveram os maiores percentuais em ambos os anos. A região Norte apresentou o menor percentual, de 34,4%, em 2013, e 40,8%, em 2019, embora tenha apresentado o maior aumento deste indicador (6,4 pontos percentuais). A região Nordeste também apresentou crescimento expressivo, de 37,5% para 43,3%. Incremento mais discreto foi observado no Centro-Oeste, de 44,9% para 49,0% (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) da população que referiu ter realizado consulta odontológica nos últimos 12 meses, com indicação do IC95%. Brasil e regiões, 2013 e 2019

Brasil e regiões	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil	44,4	43,8; 45,1	49,4	48,9; 49,9
Norte	34,4	32,9; 35,8	40,8	39,6; 42,0
Nordeste	37,5	36,5; 38,4	43,3	42,6; 44,0
Sudeste	48,3	47,1; 49,5	53,0	52,1; 54,0
Sul	51,9	50,2; 53,6	55,8	54,6; 56,9
Centro-Oeste	44,9	43,6; 46,1	49,0	47,8; 50,2

Nota:

- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.1.05 – Proporção da população que referiu ter realizado consulta odontológica nos últimos 12 meses (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18498101



Cobertura



COB.1.06 – Proporção da população que referiu nunca ter realizado consulta odontológica (PNS)

COB.1.06 – Proportion of population reporting never having had a dental consultation (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população que referiu nunca ter realizado consulta odontológica, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a falta de acesso a atendimentos odontológicos pela população brasileira.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas assistenciais e preventivas; e (iv) cobertura por planos de saúde.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais no acesso a consultas odontológicas, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para a saúde bucal.

LIMITAÇÕES

- Como em toda informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode sofrer influência de respostas inexatas ao questionário, ocasionadas tanto pela compreensão do respondente em relação à pergunta, como pela resposta fornecida por terceiros.
- Existe a possibilidade de atendimentos realizados por outros profissionais de saúde serem referidos pela população como realizados por odontólogos.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas e pessoas amarelas devem ser interpretadas com cautela, devido ao pequeno número de observações na amostra.
- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas que referiram nunca ter realizado consulta odontológica, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de pessoas entrevistadas que responderam “Nunca fui ao dentista” à seguinte questão: “Quando o(a) Sr.(a) consultou um dentista pela última vez?”.

Utilizar as variáveis:

- › PNS 2013: J013 = 5; e
- › PNS 2019: J01301 = 5.

- **Denominador:** Número de pessoas entrevistadas.
- **Multiplicador:** 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra do morador selecionado do domicílio, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até ¼ do salário mínimo;
- Mais de ¼ até ½ salário mínimo;
- Mais de ½ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE _____

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DAENT/SVSA/MS).
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NOTA _____

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR _____

Observa-se redução da proporção da população que referiu nunca ter realizado consulta odontológica, de 2013 a 2019, no Brasil e em todas as regiões brasileiras. Este indicador passou de 10,3%, em 2013, para 7,7%, em 2019, no Brasil.

Os maiores percentuais, em ambos os anos analisados, foram observados na região Norte (18,2%, em 2013, e 12,4% em 2019), seguida pela região Nordeste (15,2%, em 2013, e 10,8% em 2019). No entanto, ambas as regiões apresentaram os maiores decréscimos no período (-5,8 e -4,4 pontos percentuais absolutos, respectivamente).

As menores prevalências de não realização de consulta odontológica foram observadas nas regiões Sul (6,7%, em 2013, e 4,8% em 2019) e Sudeste (6,8%, em 2013, e 5,9% em 2019). A região Sul foi a que apresentou o menor valor para esse indicador em 2019. O Sudeste apresentou o menor declínio no período (-0,9 ponto percentual), enquanto o Centro-Oeste reduziu em -2,2% esse indicador, passando de 9,5% para 7,3% (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) da população que referiu nunca ter realizado consulta odontológica, com indicação do IC95%. Brasil e regiões, 2013 e 2019

Brasil e regiões	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil	10,3	9,9; 10,6	7,7	7,5; 8,0
Norte	18,2	16,6; 19,9	12,4	11,5; 13,2
Nordeste	15,2	14,4; 15,9	10,8	10,4; 11,2
Sudeste	6,8	6,3; 7,3	5,9	5,5; 6,3
Sul	6,7	6,0; 7,5	4,8	4,4; 5,2
Centro-Oeste	9,5	8,8; 10,2	7,3	6,7; 7,9

Nota:

- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.1.06 – Proporção da população que referiu nunca ter realizado consulta odontológica (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18498148



Cobertura



COB.2.01 – Taxa de internações hospitalares (SUS) por 100 habitantes

COB.2.01 – Hospital admission rate (SUS) per 100 population

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Número de internações hospitalares financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por 100 habitantes, na população residente, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a relação entre a produção de internações hospitalares com financiamento pelo SUS e a população residente na mesma área geográfica.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; (ii) infraestrutura de serviços, com relação à disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas assistenciais e preventivas, tais como a regionalização e hierarquização do sistema de saúde e critérios técnico-administrativos de pagamento adotados no âmbito do SUS; (iv) políticas públicas intersetoriais e gestão em saúde; (v) processos de trabalho das equipes; e (vi) necessidades de saúde das populações.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição das internações hospitalares realizadas no SUS, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir para se avaliar a adequação do volume de internações às necessidades da população atendida.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar de responsabilidade do SUS.

LIMITAÇÕES

- Pode não incluir todas as internações efetivamente realizadas pelo SUS, em função de limites definidos pela programação física e financeira do sistema público de saúde.
- Há possibilidade de subnotificação do número de internações realizadas em hospitais públicos financiados por transferência direta de recursos e não por produção de serviços.
- Não inclui as internações realizadas em unidades hospitalares sem vínculo com o SUS, embora o denominador seja a população total. Não estão contabilizadas, portanto, as internações que correspondem à saúde suplementar, à assistência aos servidores públicos civis e militares,

a recursos próprios da unidade de internação e a serviços prestados mediante desembolso direto (exclusivamente privados).

- Transferências e reinternações podem estar contadas como novas internações.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informações Hospitalares (SIH)¹.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de internações hospitalares financiadas pelo SUS, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de internações hospitalares – acessar o SIH/SUS¹, considerar a quantidade de internações (IDENT = 1), segundo o município de residência (MUNIC_RES) e o ano de internação (DT_INTER – quatro primeiros dígitos), com ESPEC fora da faixa 09 a 14.

Para seleção do tipo de especialidade, utilizar as seguintes seleções: Clínica (ESPEC = 03); Cirúrgica (ESPEC = 01); Pediátrica (ESPEC = 07); Obstétrica; (ESPEC = 02); e Outras (ESPEC = 04 – Cuidados Prolongados, 05 – Psiquiatria, 06 – Tisiologia, 08 – Reabilitação, 87 – Saúde Mental, 17 – Estabelecimento Exclusivo UTI SUS).

- Denominador: População total residente.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- As internações em hospital-dia não estão contabilizadas nesse indicador.
- A taxa de internações hospitalares pediátricas foi calculada sobre a população estimada de zero a 19 anos de idade.
- A taxa de internações hospitalares obstétricas foi calculada sobre a população feminina estimada de 10 a 49 anos de idade.
- As internações foram contabilizadas segundo município de residência do paciente e ano de internação.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Tipo de especialidade:

- Clínica;
- Cirúrgica;
- Pediátrica;
- Obstétrica; e
- Outras.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Regulação Assistencial e Controle da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (DRAC/SAES/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Observa-se, nos últimos dez anos, que o Brasil apresentou uma taxa total de aproximadamente 5,7 internações hospitalares financiadas pelo SUS por 100 habitantes, com maiores valores na região Sul. Em 2020, primeiro ano da pandemia de COVID-19, houve um decréscimo nas taxas em todas as regiões, seguido por uma recuperação em 2021, sendo atingido o valor máximo no intervalo de tempo, para todas as regiões, em 2024 (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de internações hospitalares (SUS) por 100 habitantes. Brasil e regiões, 2015 a 2024

Brasil e regiões	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	5,5	5,5	5,5	5,7	5,8	5,0	5,4	5,8	6,1	6,5
Norte	5,6	5,4	5,6	5,7	5,7	5,0	5,6	5,8	6,2	6,3
Nordeste	5,5	5,4	5,5	5,7	5,8	4,8	5,4	5,7	6,1	6,4
Sudeste	5,1	5,0	5,1	5,2	5,3	4,7	5,1	5,3	5,7	6,0
Sul	6,7	6,8	6,9	7,0	7,2	6,0	6,4	7,0	7,4	8,0
Centro-Oeste	5,6	5,5	5,6	5,6	5,8	5,1	5,6	5,9	6,4	6,7

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (BR). Produção Hospitalar (SIH/SUS) [Internet]. DATASUS. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-hospitalar-sih-sus/>
2. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.2.01 – Taxa de internações hospitalares (SUS) por 100 habitantes [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18498205



Cobertura



COB.2.02 – Taxa de internações hospitalares (saúde suplementar) por 100 beneficiários de planos privados de saúde

COB.2.02 – Hospital admission rate (private health insurance) per 100 private health plan beneficiaries

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Taxa de internações hospitalares realizadas por meio de operadoras de planos privados de saúde, por 100 beneficiários de planos privados de saúde com cobertura hospitalar, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a relação entre a produção de internações hospitalares na saúde suplementar e a população beneficiária de planos privados de saúde.
- É influenciada por: (i) tipo de contratação do plano privado (individual ou coletivo [empresarial e adesão]); (ii) presença de fatores moderadores de uso (coparticipação ou franquia); (iii) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; e (iv) infraestrutura de serviços do setor de saúde suplementar, com relação à disponibilidade de rede prestadora de serviços própria, contratada, credenciada, ou por reembolso.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na taxa de internações hospitalares na saúde suplementar, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir para se avaliar a adequação do volume de internações às necessidades da população beneficiária de planos privados de saúde com cobertura hospitalar.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação da rede prestadora de serviços de saúde das operadoras de planos privados de saúde.

LIMITAÇÕES

- O Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) contabiliza o número de vínculos a planos de saúde, e não o número de indivíduos. Desta forma, indivíduos que possuem mais de um plano privado de saúde serão contabilizados mais de uma vez.
- Não inclui a população vinculada a instituição patronal de assistência ao servidor público civil e militar.
- Transferências e reinternações podem estar contadas como novas internações.

- Antes de 2017, a base de dados não era utilizada para avaliação de desempenho das operadoras de planos de saúde, e apresentava maior incompletude.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informações de Beneficiários (SIB)¹.
- Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS)².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de internações hospitalares pagas por operadoras de planos privados de saúde, em um local e ano de referência}}{\text{Número de beneficiários de planos privados de saúde com cobertura hospitalar, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de internações hospitalares realizadas por meio de operadoras de planos privados de saúde.

A partir das bases de dados disponibilizadas pela ANS de atendimento hospitalar consolidado do TISS², selecionar o número de casos, segundo o município de residência (CD_MUNICIPIO_BENEFICIARIO), o ano de realização (ANO_MES_EVENTO – quatro primeiros dígitos), a faixa etária (FAIXA_ETARIA), o sexo (SEXO) e o tipo de internação (CD_TIPO_INTERNACAO – clínica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica e psiquiátrica).

- **Denominador:** Número de beneficiários de planos com cobertura hospitalar¹.
- **Multiplicador:** 100.

Notas:

- As internações em hospital-dia não estão contabilizadas nesse indicador, assim como as internações domiciliares e as internações em que não foi informado o regime.
- A razão de internações hospitalares pediátricas foi calculada sobre o número de beneficiários de zero a 19 anos de idade.
- A razão de internações hospitalares obstétricas foi calculada sobre o número de mulheres beneficiárias de 10 a 49 anos de idade.
- As internações foram contabilizadas segundo município de residência do paciente e ano de internação.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Faixa etária detalhada:

- Menor de 1 ano;
- 1 a 4 anos;
- 5 a 9 anos;
- 10 a 14 anos;

- 15 a 19 anos;
- 20 a 79 anos, de 10 em 10 anos; e
- 80 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Tipo de internação:

- Clínica;
- Cirúrgica;
- Pediátrica;
- Obstétrica; e
- Psiquiátrica.

GRANULARIDADE _____

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Diretoria de Desenvolvimento Setorial da Gerência de Padronização, Interoperabilidade e Análise de Informações e Desenvolvimento Setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (DIDES/GPIND/ANS).

NOTA _____

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR _____

Em 2024, no Brasil, ocorreram 13,1 internações hospitalares na saúde suplementar a cada 100 beneficiários, caracterizando um aumento de 52% em relação a 2015. A alta foi consistente até 2019, e a queda em 2020 evidencia os efeitos da pandemia de COVID-19 na suspensão de realização de procedimentos eletivos; observa-se recuperação e aceleração nas taxas a partir de 2022. A região Nordeste apresentou a maior taxa de internações em 2024, e a maior expansão no período. A região Centro-Oeste também apresentou alta taxa de internações hospitalares, e a região Norte, que partiu do menor patamar, obteve o segundo maior crescimento (Tabela 1).

Tabela 1 – Taxa de internações hospitalares (saúde suplementar) por 100 beneficiários de planos privados de saúde. Brasil e regiões, 2015 a 2024

Brasil e regiões	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	8,6	9,9	10,7	10,3	11,9	9,4	10,8	13,0	13,7	13,1
Norte	6,6	6,4	7,2	8,7	11,3	8,7	10,7	12,7	12,8	12,4
Nordeste	8,2	8,7	10,5	11,4	15,0	12,6	14,7	19,3	20,9	19,0
Sudeste	8,5	10,0	11,1	10,3	11,4	8,7	9,9	11,7	12,5	12,0
Sul	8,9	9,5	8,9	8,3	10,4	8,6	10,1	11,5	11,7	11,5
Centro-Oeste	10,6	11,1	10,7	11,2	12,9	9,9	11,2	13,5	13,6	13,7

Nota:

- Os dados são provenientes do Sistema de Informações de Beneficiários (SIB)¹ e da base Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS)².

REFERÊNCIAS

1. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sistema de Informações de Beneficiários [Internet]. ANS. [citado 16 de abril de 2025]. Disponível em: https://dadosabertos.ans.gov.br/FTP/Base_de_dados/Microdados/dados_dbc/beneficiarios/municipios/
2. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Troca de Informações na Saúde Suplementar – TISS [Internet]. ANS. [citado 16 de abril de 2025]. Disponível em: <https://dadosabertos.ans.gov.br/FTP/PDA/TISS/AMBULATORIAL/>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.2.02 – Taxa de internações hospitalares (saúde suplementar) por 100 beneficiários de planos privados de saúde [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18498268



Cobertura



COB.2.03 – Proporção da população que referiu internação hospitalar nos últimos 12 meses (PNS)

COB.2.03 – Proportion of population reporting hospital admission in the last 12 months (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população que referiu internação hospitalar por 24 horas ou mais nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a utilização de internações hospitalares pela população brasileira, independentemente da fonte de financiamento (Sistema Único de Saúde – SUS, planos de saúde e desembolso direto).
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como morbidade, nível de renda e composição etária; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas assistenciais e preventivas; (iv) cobertura por planos de saúde; (v) políticas públicas intersetoriais e gestão em saúde; (vi) processos de trabalho das equipes; e (vii) necessidades de saúde das populações.

USOS

- Contribuir para a avaliação da utilização de internações hospitalares pela população.
- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição das internações hospitalares, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para a assistência à saúde.

LIMITAÇÕES

- Como em toda informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode sofrer influência de respostas inexatas aos questionários, ocasionadas pela compreensão do respondente em relação à pergunta.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas e pessoas amarelas devem ser interpretadas com cautela, devido ao pequeno número de observações na amostra.
- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas que referiram internação hospitalar por 24 horas ou mais nos últimos 12 meses, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de pessoas entrevistadas que responderam “Sim” à seguinte questão: “Nos últimos 12 meses, o(a) Sr.(a) ficou internado(a) em hospital por 24 horas ou mais?”.

Utilizar as variáveis:

- › PNS 2013: J037 = 1; e
- › PNS 2019: J037 = 1.

- Denominador: Número de pessoas entrevistadas.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra do morador selecionado do domicílio, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até ¼ do salário mínimo;
- Mais de ¼ até ½ salário mínimo;
- Mais de ½ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 a até salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

Financiamento:

- SUS;
- Não SUS.

GRANULARIDADE _____

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DAENT/SVSA/MS).
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NOTA _____

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR _____

No país como um todo, observou-se um leve aumento da proporção da população que referiu internação hospitalar nos 12 meses anteriores à entrevista, de 6%, entre 2013 e 2019. Observam-se pequenas variações nos valores regionais, com destaque para a região Sudeste, que aumentou pouco mais de 1%, em 2019, em relação ao valor de 2013, e a região Centro-Oeste, que passou de 7,4% para 7,8%. As regiões Norte e Sul apresentaram uma ligeira redução no período, de -0,3%. As diferenças percentuais, entre os dois anos, são discretas; ainda assim, persiste a variação regional, com o Sul e o Centro-Oeste apresentando os maiores valores em ambos os anos, enquanto o Norte manteve os menores percentuais (5,8%, em 2013, e 5,5% em 2019) (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) da população que referiu internação hospitalar nos últimos 12 meses, com indicação do IC95%. Brasil e regiões, 2013 e 2019

Brasil e regiões	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil	6,0	5,8; 6,2	6,6	6,4; 6,7
Norte	5,8	5,4; 6,3	5,5	5,2; 5,8
Nordeste	5,6	5,3; 5,8	5,8	5,5; 6,0
Sudeste	5,7	5,3; 6,1	6,8	6,5; 7,2
Sul	7,5	7,1; 8,0	7,2	6,8; 7,6
Centro-Oeste	7,4	7,0; 7,9	7,8	7,3; 8,3

Nota:

- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.2.03 – Proporção da população que referiu internação hospitalar nos últimos 12 meses (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18498381



Cobertura



COB.3.01.1 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero há menos de três anos (PNS)

COB.3.01.1 – Proportion of women aged 25-64 years reporting cervical cancer screening in the last three years (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu realização do exame preventivo para câncer do colo do útero há menos de três anos, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a realização de exames preventivos para câncer do colo do útero pela população do sexo feminino na faixa etária de 25 a 64 anos de idade, financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou não.
- O Instituto Nacional de Câncer (INCA) recomenda como método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil o exame citopatológico (exame de Papanicolau), que deve ser oferecido às mulheres ou a qualquer pessoa com colo do útero, na faixa etária de 25 a 64 anos de idade e que já tiveram atividade sexual¹. Isso pode incluir homens trans e pessoas não binárias designadas mulheres ao nascer^{2,3}. Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Após dois exames seguidos (com um intervalo de um ano) apresentarem resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada três anos.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas assistenciais e preventivas; e (iv) cobertura por planos de saúde.

USOS

- Contribuir para avaliar a adequação da utilização de exames preventivos para câncer do colo do útero pela população do sexo feminino na faixa etária de 25 a 64 anos de idade.
- Analisar variações geográficas e temporais no acesso a exames preventivos para câncer do colo do útero da população do sexo feminino na faixa etária de 25 a 64 anos de idade, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para a saúde da população do sexo feminino.

LIMITAÇÕES

- Como em toda informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode sofrer influência de respostas inexatas aos questionários, ocasionadas pela compreensão do respondente em relação à pergunta.
- Existe a possibilidade de atendimentos ginecológicos por outros motivos serem referidos pela população como exame preventivo de câncer do colo do útero.
- O indicador não discrimina as pessoas que foram submetidas a histerectomia. No caso de histerectomia parcial (permanência do colo do útero), mantém-se a indicação deste exame.
- Há possibilidade de não serem contabilizados homens trans, pela não identificação com o sexo feminino.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas e pessoas amarelas devem ser interpretadas com cautela, devido ao pequeno número de observações na amostra.
- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)⁴.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos que referiram a realização de exame preventivo do câncer de colo de útero há menos de três anos, em um local e ano de referência}}{\text{Número de entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de pessoas entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que responderam “Menos de 1 ano atrás” ou “De 1 ano a menos de 2 anos” ou “De 2 anos a menos de 3 anos” à questão: “Quando foi a última vez que a Sra. fez um exame preventivo para câncer de colo do útero?”

Utilizar as variáveis:

- › PNS 2013: (C006 = 2 & (C008 >= 25 & C008 <= 64) & R001<= 3) / (C006 = 2 & (C008 >= 25 & C008 <= 64)); e
- › PNS 2019: (C006 = 2 & (C008 >= 25 & C008 <= 64) & R00101<= 3) / (C006 = 2 & (C008 >= 25 & C008 <= 64)).

- Denominador: Número de entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra do morador selecionado do domicílio, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela.
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 25 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 a 64 anos.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

Financiamento:

- SUS; e
- Não SUS.

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DAENT/SVSA/MS).
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Nacionalmente, a proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero há menos de três anos aumentou ligeiramente, de 78,7% (2013) para 81,3% (2019). A região Sul apresentou a maior proporção nos dois inquéritos, passando de 82,6% para 84,8%. As regiões Sudeste e Nordeste apresentaram aumento de 2,2% entre 2013 e 2019. Apesar da melhora, o Nordeste permaneceu com a menor proporção de realização do exame, enquanto o Norte apresentou a maior proporção de aumento: 4% no período (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero há menos de três anos, com indicação do IC95%. Brasil e regiões, 2013 e 2019

Brasil e regiões	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil	78,7	77,8; 79,7	81,3	80,6; 82,0
Norte	75,0	72,4; 77,7	79,0	77,3; 80,7
Nordeste	74,2	72,5; 75,9	76,4	75,2; 77,5
Sudeste	80,4	78,8; 82,1	84,1	82,8; 85,3
Sul	82,6	80,3; 84,8	84,8	83,3; 86,2
Centro-Oeste	80,6	78,8; 82,5	78,8	76,7; 80,9

Nota:

- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero [Internet]. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: INCA; 2016 [citado 21 de abril de 2025]. 114 p. Disponível em: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//diretrizes_para_o_rastreamento_do_cancer_do_colo_do_uterio_2016_corrigido.pdf
2. World Health Organization. WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention [Internet]. Second edition. World Health Organization; 2021 [citado 21 de abril de 2025]. 97 p. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824>
3. Connolly D, Hughes X, Berner A. Barriers and facilitators to cervical cancer screening among transgender men and non-binary people with a cervix: A systematic narrative review. Prev Med (Baltim) [Internet]. 1º de junho de 2020 [citado 21 de abril de 2025];135. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32243938/>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.3.01.1 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero há menos de três anos (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18498482



Cobertura



COB.3.01.2 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero há menos de três anos (Vigitel)

COB.3.01.2 – Proportion of women aged 25-64 years reporting cervical cancer screening in the last three years (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu realização do exame preventivo para câncer do colo do útero há menos de três anos, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a realização de exames preventivos para câncer do colo do útero pela população do sexo feminino na faixa etária de 25 a 64 anos, realizados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) ou não.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de profissionais, recursos materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas de atenção integral à saúde da mulher; e (iv) cobertura por planos de saúde.

USOS

- Contribuir para se avaliar a adequação da utilização de exames preventivos para câncer do colo do útero pela população do sexo feminino na faixa etária de 25 a 64 anos de idade.
- Analisar variações geográficas e temporais no acesso a exames preventivos para câncer do colo do útero da população do sexo feminino na faixa etária de 25 a 64 anos, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para a saúde da população do sexo feminino.

LIMITAÇÕES

- Como todo indicador derivado de informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode ser influenciado pela acurácia das respostas dos entrevistados, relacionada à compreensão das perguntas e à capacidade de recordação.
- Por se utilizar como fonte de dados o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que se trata de uma pesquisa amostral,

não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).
- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada cidade. Nos anos 2020 e 2021, houve redução da amostra para mil indivíduos em cada cidade, e, em 2023, para 800. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão.
- Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.
- O indicador não discrimina as pessoas que foram submetidas a histerectomia. No caso de histerectomia parcial (permanência do colo do útero), mantém-se a indicação deste exame.
- Há possibilidade de não serem contabilizados homens trans, pela não identificação com o sexo feminino.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade residentes em capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu a realização de exame preventivo do câncer de colo de útero, há menos de três anos, em um local e ano de referência}}{\text{Número de entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que respondeu “Menos de 1 ano atrás” ou “Entre 1 ano a menos de 2 anos” ou “Entre 2 anos a menos de 3 anos” à questão “A Sra. já fez alguma vez exame de Papanicolau, exame preventivo de câncer de colo do útero?”, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável *peso_rake*, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vígite! à distribuição da população adulta da cidade, projetada para cada ano.
- Maior detalhamento de informações pode ser encontrado no relatório oficial do Ministério da Saúde³.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE**Faixa etária:**

- 25 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 a 64 anos.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais das Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Durante o período analisado, a proporção de mulheres de 25 a 64 anos que realizaram o exame de Papanicolau há menos de três anos manteve-se elevada e relativamente estável até o fim da década de 2010, variando em geral entre 81% e 83%. A partir de 2017, iniciou-se um declínio gradual, que se acentuou em 2020, quando o indicador caiu para 80,1% (IC95% 78,4%; 81,8%). Em 2021 e 2023, as reduções foram ainda mais expressivas, alcançando 77,2% (IC95% 75,1%; 79,1%) e 76,8% (IC95% 74,9%; 78,7%), respectivamente, os menores níveis registrados na série (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero há menos de três anos, com indicação do IC95%, nas capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel). Brasil, 2007 a 2023*

Ano	Total	
	%	IC95%
2007	82,0	81,0; 82,9
2008	83,3	82,4; 84,2
2009	82,1	81,2; 83,1
2010	82,2	81,0; 83,3
2011	81,8	80,9; 82,7
2012	82,3	81,3; 83,3
2013	82,9	81,9; 83,9
2014	81,4	80,3; 82,5
2015	81,0	79,8; 82,1
2016	82,0	80,9; 83,1
2017	82,8	81,7; 83,9
2018	81,7	80,6; 82,8
2019	81,5	80,4; 82,6
2020	80,1	78,4; 81,8
2021	77,2	75,1; 79,1
2023	76,8	74,9; 78,7

- Notas:**
- *Não houve coleta de dados do Vigitel em 2022.
 - IC95%: intervalo de confiança de 95%.
 - Os valores das proporções e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Vigitel Brasil – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/download/Vigitel/>

2. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2006-2023: morbidade referida e autoavaliação de saúde: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de morbidade referida e autoavaliação de saúde nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2023 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2025 [citado 12 de agosto de 2025]. 1-57 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_2006_2023_morbidade_autoavaliacao.pdf

3. Ministério da Saúde. Acesse as Publicações do Ministério da Saúde sobre Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.3.01.2 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero há menos de três anos (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18498641



Cobertura



COB.3.02.1 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero (PNS)

COB.3.02.1 – Proportion of women aged 25-64 years reporting never having had cervical cancer screening (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo para câncer do colo do útero, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima o acesso a exames preventivos para câncer do colo do útero da população do sexo feminino na faixa etária de 25 a 64 anos, financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou não.
- O Instituto Nacional de Câncer (INCA) recomenda como método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil o exame citopatológico (exame de Papanicolau), que deve ser oferecido às mulheres ou a qualquer pessoa com colo do útero, na faixa etária de 25 a 64 anos de idade e que já tiveram atividade sexual¹. Isso pode incluir homens trans e pessoas não binárias designadas mulheres ao nascer^{2,3}. Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Após dois exames seguidos (com um intervalo de um ano) apresentarem resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada três anos.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de profissionais, recursos materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas e atenção integral à saúde da mulher; e (iv) cobertura por planos de saúde.

USOS

- Contribuir para a avaliação do acesso a exames preventivos para câncer do colo do útero da população do sexo feminino na faixa etária de 25 a 64 anos de idade.
- Analisar variações geográficas e temporais na realização de exames preventivos para câncer do colo do útero da população do sexo feminino na faixa etária de 25 a 64 anos de idade, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para a saúde da população do sexo feminino.

LIMITAÇÕES

- Como todo indicador derivado de informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode ser influenciado pela acurácia das respostas dos entrevistados, relacionada à compreensão das perguntas e à capacidade de recordação.
- Existe a possibilidade de atendimentos ginecológicos por outros motivos serem referidos pela população como exame preventivo de câncer do colo do útero.
- O indicador não discrimina as pessoas que foram submetidas a histerectomia. No caso de histerectomia parcial (permanência do colo do útero), mantém-se a indicação deste exame.
- Há possibilidade de não serem contabilizados homens trans, pela não identificação com o sexo feminino.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas e pessoas amarelas devem ser interpretadas com cautela, devido ao pequeno número de observações na amostra.
- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)⁴.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiram nunca ter realizado exame preventivo do câncer de colo de útero, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que responderam “Nunca fez” à seguinte questão: “Quando foi a última vez que a Sra. fez um exame preventivo para câncer de colo do útero?”.

Utilizar as variáveis:

- › PNS 2013: (C006 = 2 & (C008 >= 25 & C008 <= 64) & R001 = 5) / (C006 = 2 & (C008 >= 25 & C008 <= 64)); e
- › PNS 2019: (C006 = 2 & (C008 >= 25 & C008 <= 64) & R00101 = 5) / (C006 = 2 & (C008 >= 25 & C008 <= 64)).

- Denominador: Número de entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra do morador selecionado do domicílio, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 25 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 a 64 anos.

Renda domiciliar *per capita*:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DAENT/SVSA/MS).
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Observa-se uma redução do percentual da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero, em todas as regiões e no país como um todo, tendo o indicador passado de 9,7%, em 2013, para 6,1% em 2019. As maiores quedas proporcionais foram observadas nas regiões Norte (de 12,9% para 8,5%) e Sudeste (de 8,8% para 4,5%). Apesar da melhora geral, as regiões Norte e Nordeste ainda concentraram os maiores percentuais de pessoas do sexo feminino que nunca haviam realizado o exame, com 8,5% e 8,6%, respectivamente, em 2019 (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero, com indicação do IC95%. Brasil e regiões, 2013 e 2019

Brasil e regiões	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil	9,7	8,9; 10,4	6,1	5,7; 6,5
Norte	12,9	10,8; 15,0	8,5	7,2; 9,7
Nordeste	12,4	11,1; 13,6	8,6	7,9; 9,4
Sudeste	8,8	7,5; 10,2	4,5	3,8; 5,2
Sul	6,7	5,1; 8,3	4,5	3,6; 5,3
Centro-Oeste	7,9	6,6; 9,1	7,0	5,4; 8,5

Nota:

- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero [Internet]. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: INCA; 2016 [citado 21 de abril de 2025]. 114 p. Disponível em: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//diretrizes_para_o_rastreamento_do_cancer_do_colo_do_uterio_2016_corrigido.pdf
2. World Health Organization. WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention [Internet]. Second edition. World Health Organization; 2021 [citado 21 de abril de 2025]. 97 p. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824>
3. Connolly D, Hughes X, Berner A. Barriers and facilitators to cervical cancer screening among transgender men and non-binary people with a cervix: A systematic narrative review. Prev Med (Baltim) [Internet]. 1º de junho de 2020 [citado 21 de abril de 2025];135. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32243938/>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.3.02.1 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18498673



Cobertura



COB.3.02.2 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero (Vigitel)

COB.3.02.2 – Proportion of women aged 25-64 years who reported never having had a preventive screening for cervical cancer (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a falta de acesso a exames preventivos para câncer do colo do útero pela população do sexo feminino na faixa etária de 25 a 64 anos.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de profissionais, recursos materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas de atenção integral à saúde da mulher; e (iv) cobertura por planos de saúde.

USOS

- Contribuir para a avaliação do acesso ao exame preventivo do câncer do colo do útero da população do sexo feminino na faixa etária de 25 a 64 anos de idade.
- Analisar variações geográficas e temporais na ausência de realização de exame preventivo do câncer do colo do útero pela população do sexo feminino na faixa etária de 25 a 64 anos de idade, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para a saúde da mulher.

LIMITAÇÕES

- Como todo indicador derivado de informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode ser influenciado pela acurácia das respostas dos entrevistados, relacionada à compreensão das perguntas e à capacidade de recordação.
- Por se utilizar como fonte de dados o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que se trata de uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é

necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).
- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada cidade. Nos anos 2020 e 2021, houve redução da amostra para mil indivíduos em cada cidade, e, em 2023, para 800. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão.
- Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.
- Há possibilidade de não serem contabilizados homens trans, pela não identificação com o sexo feminino.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade residentes em capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiram nunca ter realizado exame preventivo do câncer de colo de útero, em um local e ano de referência}}{\text{Número de entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de pessoas do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que responderam negativamente à questão “A Sra. já fez alguma vez exame de Papanicolaou, exame preventivo de câncer de colo do útero?”, em um local e ano de referência.
- **Denominador:** Número de entrevistadas do sexo feminino de 25 a 64 anos, em um local e ano de referência.
- **Multiplicador:** 100.

Notas:

- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável *peso_rake*, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade, projetada para cada ano.
- Maior detalhamento de informações pode ser encontrado no relatório oficial do Ministério da Saúde³.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 25 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 a 64 anos.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais das Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/ DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No período de 2007 a 2023, a proporção de mulheres de 25 a 64 anos que nunca realizaram o exame preventivo do câncer do colo do útero apresentou estabilidade na maior parte do período, com valores variando entre 11% e 13%, seguida de um aumento mais evidente nos últimos anos (Tabela 1). A partir de 2017, porém, observou-se aumento progressivo na não realização do exame, tendo a proporção evoluído de 11,1% (IC95% 10,2%; 12,1%), naquele ano, para 16,0% em 2023 (IC95% 14,3%; 17,9%), o valor mais alto da série (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos de idade que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero, com indicação do IC95%, nas capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel). Brasil, 2007 a 2023*

Ano	Total	
	%	IC95%
2007	12,9	12,1; 13,7
2008	10,9	10,2; 11,7
2009	11,3	10,5; 12,0
2010	11,2	10,2; 12,3
2011	12,2	11,4; 12,9
2012	12,6	11,7; 13,5
2013	11,9	11,1; 12,6
2014	13,0	12,0; 13,9
2015	12,4	11,5; 13,4
2016	11,6	10,7; 12,6
2017	11,1	10,2; 12,1
2018	11,9	10,9; 12,8
2019	12,3	11,4; 13,3
2020	13,0	11,6; 14,5
2021	14,8	13,1; 16,6
2023	16,0	14,3; 17,9

- Notas:**
- *Não houve coleta de dados do Vigitel em 2022.
 - IC95%: intervalo de confiança de 95%.
 - Os valores das proporções e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Vigitel Brasil – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/download/Vigitel/>
2. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2006-2023: morbidade referida e autoavaliação de saúde: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de morbidade referida e autoavaliação de saúde nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2023 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2025 [citado 12 de agosto de 2025]. 1-57 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_2006_2023_morbidade_autoavaliacao.pdf

3. Ministério da Saúde. Acesse as Publicações do Ministério da Saúde sobre Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.3.02.2 – Proporção da população do sexo feminino de 25 a 64 anos que referiu nunca ter realizado exame preventivo do câncer do colo do útero (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>.doi: 10.5281/zenodo.18498752



Cobertura



COB.3.03.1 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de dois anos (PNS)

COB.3.03.1 – Proportion of women aged 50-69 years reporting mammography in the last two years (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu a realização de mamografia há menos de dois anos, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima o acesso da população do sexo feminino na faixa etária de 50 a 69 anos de idade a mamografias, realizadas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) ou não.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, culturais e demográficos, tais como nível de renda e escolaridade; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de profissionais, recursos materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas de atenção integral à saúde da mulher; (iv) cobertura por planos de saúde; (v) políticas públicas intersetoriais e gestão em saúde; (vi) processos de trabalho das equipes; e (vii) necessidades de saúde das populações.

USOS

- Contribuir para a avaliação do acesso a mamografias da população do sexo feminino na faixa etária de 50 a 69 anos de idade.
- Analisar variações geográficas e temporais na realização de mamografias da população do sexo feminino na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para a saúde da população do sexo feminino.

LIMITAÇÕES

- Como todo indicador derivado de informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode ser influenciado pela acurácia das respostas dos entrevistados, relacionada à compreensão das perguntas e à capacidade de recordação.
- Há possibilidade de não serem contabilizados homens trans, pela não identificação com o sexo feminino.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas e pessoas amarelas devem ser interpretadas com cautela, devido ao pequeno número de observações na amostra.

- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiram ter realizado mamografia há menos de dois anos, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que responderam “Sim” à seguinte questão: “A Sra. fez o exame de mamografia?”.

Utilizar as variáveis:

- › PNS 2013: (C006 = 2 & (C008 >= 50 & C008 <= 69) & R015 = 1 & R017 <= 2) / (C006 = 2 & (C008 >= 50 & C008 <= 69)) x 100; e
- › PNS 2019: (C006 = 2 & (C008 >= 50 & C008 <= 69) & R015 = 1 & R01701 <= 2) / (C006 = 2 & (C008 >= 50 & C008 <= 69)) x 100.

- Denominador: Número de entrevistadas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra do morador selecionado do domicílio, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 50 a 59 anos; e
- 60 a 69 anos.

Renda domiciliar per capita:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação de domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

Financiamento:

- SUS; e
- Não SUS.

GRANULARIDADE _____

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DAENT/SVSA/MS).
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NOTA _____

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR _____

No cenário nacional, houve um aumento de 4%, entre 2013 e 2019, no percentual da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de dois anos. As regiões Sudeste e Sul mantiveram os maiores percentuais nos dois anos. As regiões Norte e Nordeste apresentaram os menores valores, embora tenham mostrado crescimento – o Norte aumentou de 32,7% para 43,2%, e o Nordeste, de 41,6% para 49,5%. Observou-se crescimento igualmente no Centro-Oeste, com aumento de 8,2% no período (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de dois anos, com indicação do IC95%. Brasil e regiões, 2013 e 2019

Brasil e regiões	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil	54,3	52,4; 56,2	58,3	56,9; 59,7
Norte	32,7	28,1; 37,3	43,2	40,2; 46,2
Nordeste	41,6	38,6; 44,6	49,5	47,2; 51,8
Sudeste	62,2	59,0; 65,4	65,2	62,9; 67,6
Sul	59,7	55,4; 64,0	58,8	55,8; 61,8
Centro-Oeste	48,4	44,6; 52,3	56,6	53,3; 60,0

Nota:

- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.3.03.1 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de dois anos (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18498794



Cobertura



COB.3.03.2 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de dois anos (Vigitel)

COB.3.03.2 – Proportion of women aged 50-69 years reporting mammography in the last two years (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu a realização de mamografia há menos de dois anos, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima o acesso da população do sexo feminino, na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, a mamografias, realizadas por meio do SUS ou não.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de profissionais, recursos materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas de atenção integral à saúde da mulher; e (iv) cobertura por planos de saúde.

USOS

- Contribuir para a avaliação do acesso a mamografias da população do sexo feminino na faixa etária de 50 a 69 anos de idade.
- Analisar variações geográficas e temporais na realização mamografias da população do sexo feminino na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para a saúde da população do sexo feminino.

LIMITAÇÕES

- Como todo indicador derivado de informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode ser influenciado pela acurácia das respostas dos entrevistados, relacionada à compreensão das perguntas e à capacidade de recordação.
- Por se utilizar como fonte de dados o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que se trata de uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.

- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).
- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada cidade. Nos anos 2020 e 2021, houve redução da amostra para mil indivíduos em cada cidade, e, em 2023, para 800. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão.
- Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.
- Há possibilidade de não serem contabilizados homens trans, pela não identificação com o sexo feminino.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade residentes em capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiram ter realizado mamografia há menos de dois anos, em um local e ano de referência}}{\text{Número de entrevistadas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que responderam “menos de 1 ano” ou “entre 1 e 2 anos” à questão “Quanto tempo faz que a Sra. fez mamografia?”, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade entrevistadas, no mesmo local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável *peso_rake*, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade, projetada para cada ano.
- Maior detalhamento de informações pode ser encontrado no relatório oficial do Ministério da Saúde³.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 50 a 59 anos; e
- 60 a 69 anos.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais das Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/ DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A proporção de mulheres de 50 a 69 anos que realizaram mamografia há menos de dois anos manteve-se acima dos 70%, com tendência geral de aumento até meados da década de 2010. O indicador evoluiu de 71,1%, em 2007 (IC95% 69,1%; 73,1%), para cerca de 78% entre 2013 e 2018, atingindo seu maior valor em 2017, com 78,5% (IC95% 76,9%; 79,9%). A partir de 2019, observou-se uma leve redução, acentuada em 2021, quando o percentual caiu para 72,8% (IC95% 70,6%; 74,9%). Em 2023, o indicador se estabilizou em 73,1% (IC95% 70,2%; 75,8%), ainda abaixo dos níveis observados na década anterior (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de dois anos, com indicação do IC95%, nas capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel). Brasil, 2007 a 2023*

Ano	Total	
	%	IC95%
2007	71,1	69,1; 73,1
2008	71,7	69,7; 73,6
2009	72,3	70,5; 74,1
2010	73,4	71,5; 75,2
2011	74,4	72,6; 76,1
2012	77,4	75,6; 79,1
2013	78,0	76,4; 79,6
2014	77,8	76,0; 79,5
2015	78,1	76,4; 79,7
2016	78,2	76,4; 79,8
2017	78,5	76,9; 79,9
2018	78,0	76,5; 79,3
2019	76,9	75,4; 78,3
2020	78,0	75,9; 80,0
2021	72,8	70,6; 74,9
2023	73,1	70,2; 75,8

Notas:

- *Não houve coleta de dados do Vigitel em 2022.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das proporções e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Vigitel Brasil – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/download/Vigitel/>
2. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2006-2023: morbidade referida e autoavaliação de saúde: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de morbidade referida e autoavaliação de saúde nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2023 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2025 [citado 12 de agosto de 2025]. 1–57 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_2006_2023_morbidade_autoavaliacao.pdf

3. Ministério da Saúde. Acesse as Publicações do Ministério da Saúde sobre Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.3.03.2 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu ter realizado mamografia há menos de dois anos (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18510200



Cobertura



COB.3.04.1 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia (PNS)

COB.3.04.1 – Proportion of women aged 50-69 years who reported never having had a mammography (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a falta de acesso à realização de mamografia pela população brasileira do sexo feminino na faixa etária de 50 a 69 anos de idade.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, culturais e demográficos, tais como nível de renda e escolaridade; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas de atenção integral à saúde da mulher; (iv) cobertura por planos de saúde; (v) políticas públicas intersetoriais e gestão em saúde; (vi) processo de trabalho das equipes; e (vii) necessidades de saúde das populações.

USOS

- Contribuir para a avaliação do acesso a mamografias pela população do sexo feminino na faixa etária de 50 a 69 anos de idade.
- Analisar variações geográficas e temporais na não realização de mamografias pela população do sexo feminino na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para a saúde da população do sexo feminino.

LIMITAÇÕES

- Como todo indicador derivado de informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode ser influenciado pela acurácia das respostas dos entrevistados, relacionada à compreensão das perguntas e à capacidade de recordação.
- Há possibilidade de não serem contabilizados homens trans, pela não identificação com o sexo feminino.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas e pessoas amarelas devem ser interpretadas com cautela, devido ao pequeno número de observações na amostra.

- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiram nunca ter realizado mamografia, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que responderam “Não” à questão “Algum médico já lhe solicitou um exame de mamografia?” ou “Não” à questão “A Sra. fez o exame de mamografia?”.

Utilizar as seguintes variáveis:

- › PNS 2013: $(C006 = 2 \ \& \ (C008 \geq 50 \ \& \ C008 \leq 69) \ \& \ (R014 = 2 \ \text{ou} \ (R014 = 1 \ \& \ R015 = 2))) / (C006 = 2 \ \& \ (C008 \geq 50 \ \& \ C008 \leq 69)) \times 100$; e
- › PNS 2019: $(C006 = 2 \ \& \ (C008 \geq 50 \ \& \ C008 \leq 69) \ \& \ (R014 = 2 \ \text{ou} \ (R014 = 1 \ \& \ R015 = 2))) / (C006 = 2 \ \& \ (C008 \geq 50 \ \& \ C008 \leq 69)) \times 100$.

- Denominador: Número de entrevistadas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade.
- Multiplicador: 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra do morador selecionado do domicílio, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 50 a 59 anos; e
- 60 a 69 anos.

Renda domiciliar per capita:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE _____

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NOTA _____

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR _____

No Brasil, observou-se uma queda no percentual nacional da população do sexo feminino de 50 a 69 anos que referiu nunca ter realizado mamografia, de 31,5%, em 2013, para 24,2% em 2019. Redução semelhante desse indicador foi observada em todas as regiões. Apesar da redução de mais de 10% no período, as regiões Norte (42,1%) e Nordeste (33,7%) permaneceram com os maiores percentuais de mulheres que nunca fizeram o exame. Em contraste, o Sudeste apresentou o menor percentual em 2019, com apenas 16,6% da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia, seguido pelo Centro-Oeste (24,0%) (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia, com indicação do IC95%. Brasil e regiões, 2013 e 2019

Brasil e regiões	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil	31,5	29,7; 33,3	24,2	23,1; 25,3
Norte	55,0	49,9; 60,1	42,1	39,1; 45,1
Nordeste	45,4	42,0; 48,8	33,7	31,7; 35,7
Sudeste	23,0	20,2; 25,8	16,6	14,8; 18,4
Sul	26,7	22,7; 30,7	24,3	21,7; 26,9
Centro-Oeste	34,5	30,6; 38,4	24,0	21,0; 26,9

Nota:

- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.3.04.1 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18510235





COB.3.04.2 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia (Vigitel)

COB.3.04.2 – Proportion of women aged 50-69 years who reported never having had a mammography (Vigitel)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a falta de acesso à realização de mamografia pela população do sexo feminino na faixa etária de 50 a 69 anos de idade.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos, tais como nível de renda, perfil de morbidade e composição etária; (ii) oferta de serviços, com relação à disponibilidade de profissionais, recursos materiais, tecnológicos e financeiros; (iii) políticas públicas de atenção integral à saúde da mulher; e (iv) cobertura por planos de saúde.

USOS

- Contribuir para a avaliação do acesso a mamografias pela população do sexo feminino na faixa etária de 50 a 69 anos de idade.
- Analisar variações geográficas e temporais na ausência de realização de mamografia pela população do sexo feminino na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas voltadas para a saúde da mulher.

LIMITAÇÕES

- Como todo indicador derivado de informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode ser influenciado pela acurácia das respostas dos entrevistados, relacionada à compreensão das perguntas e à capacidade de recordação.
- Por se utilizar como fonte de dados o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), uma pesquisa amostral, não é possível produzir indicadores para pequenos agregados populacionais. Além disso, é necessário o uso da estimação de intervalos de confiança, a fim de se apresentar a imprecisão do indicador.
- De 2006 a 2021, o Vigitel foi restrito a residentes em domicílios com linha telefônica fixa e, a partir de 2023, foi expandido para incluir também residentes com linha móvel (exclusiva ou não).

- De 2006 a 2019, a amostra do Vigitel era estabelecida em cerca de 2 mil indivíduos em cada cidade. Nos anos 2020 e 2021, houve redução da amostra para mil indivíduos em cada cidade, e, em 2023, para 800. Nesses anos, as estimativas devem ser utilizadas com cautela, dada a diminuição da precisão.
- Em 2022, não foi realizada a coleta de dados.
- Há possibilidade de não serem contabilizados homens trans, pela não identificação com o sexo feminino.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)¹.

Nota:

- Este indicador é estimado a partir de dados do Vigitel, sistema coordenado pelo Ministério da Saúde. O Vigitel é um inquérito amostral, com periodicidade anual, realizado por meio de entrevistas telefônicas com pessoas com 18 anos ou mais de idade residentes em capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiram nunca ter realizado mamografia, em um local e ano de referência}}{\text{Número de pessoas entrevistadas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que responderam negativamente à questão “A Sra. já fez alguma vez mamografia, raio X das mamas?”, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número de pessoas do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade entrevistadas, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- No cálculo, deve-se considerar a ponderação dos dados, utilizando-se a variável peso_rake, para ajuste da distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade, projetada para cada ano.
- Maior detalhamento de informações pode ser encontrado no relatório oficial do Ministério da Saúde³.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 50 a 59 anos; e
- 60 a 69 anos.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais das Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGDNT/DAENT/SVSA/MS).

NOTAS

- Se o número de observações (questionários) que satisfazem às condições especificadas for inferior a 30 ($n < 30$), o resultado pode gerar estimativas muito imprecisas. Nestes casos, o resultado não deverá ser apresentado, pois o número de ocorrências é insuficiente para determinar qualquer estimativa com precisão aceitável.
- Se o coeficiente de variação calculado para um resultado for maior que 0,3, a estimativa deve ser utilizada com cautela, dada sua baixa precisão, sendo assinalada esta situação.
- Se o coeficiente de variação for maior que 0,5, a estimativa não deve ser utilizada, pois a pesquisa não foi dimensionada para o seu cálculo.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Entre 2007 e 2023, observou-se uma redução expressiva na proporção de mulheres de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia (Tabela 1). Em 2007, o percentual era de 17,2% (IC95% 15,5%; 18,9%), diminuindo de forma contínua, até atingir valores próximos a 6% a partir de 2016. Em 2023, foi alcançado o valor de 6,8% (IC95% 5,1%; 8,9%).

Tabela 1 – Proporção (%) da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia, com indicação do IC95%, nas capitais das Unidades da Federação e no Distrito Federal, em inquérito telefônico (Vigitel). Brasil, 2007 a 2023*

Ano	Total	
	%	IC95%
2007	17,2	15,5; 18,9
2008	13,7	12,3; 15,3
2009	13,5	12,2; 15,0
2010	12,3	11,0; 13,8
2011	11,3	10,1; 12,7
2012	10,1	8,9; 11,4
2013	10,3	9,1; 11,5
2014	9,2	8,1; 10,5
2015	8,1	7,1; 9,3
2016	6,0	5,1; 7,0
2017	6,0	5,2; 7,0
2018	6,1	5,3; 7,0
2019	6,5	5,7; 7,4
2020	5,1	4,1; 6,3
2021	6,7	5,5; 8,2
2023	6,8	5,1; 8,9

Notas:

- *Não houve coleta de dados do Vigitel em 2022.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%.
- Os valores das proporções e dos intervalos de confiança do indicador podem apresentar pequenas variações, em decorrência de arredondamentos e particularidades do *software* estatístico utilizado.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Vigitel Brasil – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/download/Vigitel/>
2. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2006-2023: morbidade referida e autoavaliação de saúde: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de morbidade referida e autoavaliação de saúde nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2023 [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2025 [citado 12 de agosto de 2025]. 1-57 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_2006_2023_morbidade_autoavaliacao.pdf

3. Ministério da Saúde. Acesse as Publicações do Ministério da Saúde sobre Vigitel [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.3.04.2 – Proporção da população do sexo feminino de 50 a 69 anos de idade que referiu nunca ter realizado mamografia (Vigitel) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18510290



Cobertura



COB.4.01 – Proporção de nascidos vivos segundo o número de consultas de pré-natal

COB.4.01 – Proportion of live births by number of prenatal care visits

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Distribuição percentual de nascidos vivos segundo o número de consultas de pré-natal das parturientes, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a adequação do número de consultas de pré-natal realizadas. São preconizadas no mínimo seis consultas: uma no 1º trimestre, duas no 2º trimestre e três no 3º trimestre.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, culturais e demográficos; (ii) oferta de serviços hospitalares para o parto; e (iii) políticas públicas de atenção integral à gestante e à criança.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na realização de consultas de pré-natal, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir na análise das condições de acesso à assistência pré-natal e da sua qualidade, em associação com outros indicadores, tais como a mortalidade materna e infantil.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas e ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal, ao parto e à atenção à saúde da criança.

LIMITAÇÕES

- Impossibilidade, antes de 2013, de se efetuarem comparações com o padrão mínimo de seis consultas de pré-natal estabelecido pelo Ministério da Saúde¹, em função do agrupamento do número de consultas no formulário de Declaração de Nascido Vivo (DNV). Até o ano 2000, estavam em vigor formulários que continham apenas as seguintes categorias: nenhuma, 1 a 6, 7 e mais consultas. Posteriormente, o formulário foi alterado e passou a contemplar as seguintes categorias: nenhuma, 1 a 3, 4 a 6, 7 e mais consultas. Em 2011, houve uma mudança no conteúdo da DNV, com maior detalhamento das informações coletadas, permitindo a obtenção do padrão mínimo de seis ou mais consultas.
- Há possibilidade de equívoco da gestante ao informar o número de consultas.
- Desconsideram-se, por restrição da fonte de dados, as consultas de pré-natal relativas a gestações que deram origem a natimortos e abortos.
- A ocorrência de partos gemelares resulta em contagem cumulativa de mulheres.

- A representatividade populacional do indicador pode estar comprometida nas áreas que apresentam insuficiente cobertura do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de nascidos vivos, segundo o número de consultas de pré-natal da parturiente, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de nascidos vivos de parturientes, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de nascidos vivos no ano considerado (DTNASC – 4 últimos dígitos), segundo o município de residência (CODMUNRES), a cor ou raça da parturiente (RACACORMAE), a idade da parturiente (IDADEMAE), a escolaridade (ESCMAE2010), o início do pré-natal (MESPRENAT) e o número de consultas de pré-natal (CONSULTASDET).

Observe-se que, nesta variável CONSULTADET, o valor de 99 – assim como o valor em branco – indica o número ignorado de consultas, não o número de consultas realizado.

- Denominador: Número de nascidos vivos no ano considerado (DTNASC – 4 últimos dígitos), segundo o município de residência (CODMUNRES), a cor ou raça da parturiente (RACACORMAE), a idade da parturiente (IDADEMAE), a escolaridade (ESCMAE2010) e o início do pré-natal (MESPRENAT).
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça da parturiente (a partir de 2012):

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Faixa etária da parturiente:

- Até 14 anos;
- 15 a 44 anos, de 5 em 5 anos; e
- 45 anos ou mais.

Escolaridade da parturiente (até 2011):

- Sem escolaridade;
- 1 a 3 anos;
- 4 a 7 anos;
- 8 a 11 anos;
- 12 anos ou mais; e
- Não informada.

Escolaridade da parturiente (a partir de 2012):

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo);
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo); e
- Não informada.

Número de consultas de pré-natal (até 2011):

- Nenhuma;
- 1 a 6 consultas; e
- 7 ou mais consultas.

Número de consultas de pré-natal (a partir de 2012):

- Nenhuma;
- 1 a 5 consultas; e
- 6 ou mais consultas.

Trimestre gestacional de início do pré-natal:

- 1º trimestre;
- 2º trimestre; e
- 3º trimestre.

GRANULARIDADE _____

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO _____

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL _____

- Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (CGSM/SAPS/MS).

NOTAS _____

- Em 2011, houve uma mudança no conteúdo da DNV, com maior detalhamento das informações coletadas, entre as quais a escolaridade, a cor ou raça da parturiente, o número de consultas de pré-natal e o início do pré-natal. Naquele ano e no seguinte, foram utilizados simultaneamente os dois formulários, abrangendo, também, alguns nascimentos ocorridos em 2010. As informações segundo estas variáveis são apresentadas então separadamente – até 2011, e a partir de 2012.

- A proporção de nascidos vivos, segundo o número de consultas de pré-natal, é calculada sobre o total de nascidos vivos, incluindo-se os casos em que o número de consultas não foi informado.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Observou-se um progressivo aumento da proporção de nascidos vivos com seis ou mais consultas de pré-natal, com uma inflexão em 2020 – ano inicial da pandemia de COVID-19 – em todas as regiões do país. Em 2023, o valor para o Brasil foi de 82,8%. As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentaram percentuais superiores aos do país em todos os anos do período de 2014 a 2023. Destaca-se que, apesar de partirem de patamares inferiores no início da série, as regiões Norte e Nordeste registraram os maiores avanços na cobertura de seis ou mais consultas de pré-natal, no período de análise (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção de nascidos vivos com seis ou mais consultas de pré-natal. Brasil e regiões, 2014 a 2023

Brasil e regiões	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brasil	75,7	76,6	77,7	78,5	79,6	80,2	78,9	80,2	81,6	82,8
Norte	59,4	60,8	61,3	62,3	63,5	65,2	61,5	65,3	69,1	71,9
Nordeste	69,1	70,7	72,3	73,1	75,8	76,6	74,8	77,2	79,9	81,6
Sudeste	81,9	82,4	83,4	84,2	84,5	85,0	84,5	85,2	85,1	86,0
Sul	83,4	84,0	84,5	85,5	86,1	85,9	85,1	85,1	85,4	85,3
Centro-Oeste	76,8	76,9	78,3	78,9	80,2	80,5	79,4	80,7	81,6	83,3

Nota:

- Nascidos vivos: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Ministério da Saúde/DATASUS. Situação da base em 20/12/2024.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Portaria nº 570, de 1º de junho de 2000 [Internet]. Ministério da Saúde. 2000 [citado 23 de abril de 2025]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0570_01_06_2000_rep.html
2. Ministério da Saúde. Nascidos Vivos – desde 1994 [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.4.01 – Proporção de nascidos vivos segundo o número de consultas de pré-natal [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18510343



Cobertura



COB.4.02 – Proporção de partos hospitalares

COB.4.02 – Proportion of hospital births

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de nascidos vivos por parto hospitalar entre o total de nascidos vivos de parturientes residentes, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a utilização de serviços hospitalares para partos, independentemente da forma de financiamento.
- É influenciada por: (i) fatores socioeconômicos, culturais e demográficos; (ii) oferta de serviços hospitalares para o parto; e (iii) políticas públicas de atenção integral à gestante e à criança.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na distribuição proporcional dos partos hospitalares, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir na análise das condições de acesso à assistência ao parto e da sua qualidade, no contexto do modelo assistencial adotado.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações voltadas para a atenção à saúde da mulher e da criança.

LIMITAÇÕES

- Desconsidera, por restrição da fonte de dados, os partos que deram origem a natimortos e abortos.
- A representatividade populacional do indicador pode estar comprometida nas áreas que apresentam insuficiente cobertura do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).
- Há possibilidade de superestimação do indicador, pela maior probabilidade de registro de partos hospitalares no Sinasc.
- Há possibilidade de nascidos vivos que morrem logo após o nascimento serem declarados como natimortos, com sub-registro do total de nascidos vivos.
- A ocorrência de partos gemelares resulta em contagem cumulativa de partos.
- Há partos em outros estabelecimentos de saúde que estão computados como partos hospitalares. E vice-versa: há partos em hospitais que não estão marcados como hospitalares, mas o volume é baixo.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de nascidos vivos, de parto hospitalar, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de nascidos vivos de parturientes residentes, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de nascidos vivos no ano considerado (DTNASC – 4 últimos dígitos), segundo o município de residência (CODMUNRES), a cor ou raça da parturiente (RACACORMAE), a idade da parturiente (IDADEMAE) e a escolaridade (ESMAE2010), que tenham nascido em hospital (LOCNASC = 1).
- **Denominador:** Número de nascidos vivos no ano considerado (DTNASC – 4 últimos dígitos), segundo o município de residência (CODMUNRES), a cor ou raça da parturiente (RACACORMAE), a idade da parturiente (IDADEMAE) e a escolaridade (ESMAE2010).
- **Multiplicador:** 100.

Nota:

- A proporção de partos hospitalares é calculada sobre o total de nascidos vivos, incluindo-se os casos em que o local do parto não foi informado.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça da parturiente (a partir de 2012):

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Nota:

- Seleção disponível a partir de 2012.

Faixa etária da parturiente:

- Menor de 14 anos;
- 15 a 44 anos, de 5 em 5 anos; e
- 45 anos ou mais.

Escolaridade da parturiente (até 2011):

- Sem escolaridade;
- 1 a 3 anos;
- 4 a 7 anos;

- 8 a 11 anos;
- 12 anos e mais; e
- Não informada.

Escolaridade da parturiente (a partir de 2012):

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo);
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo); e
- Não informada.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (DAHU/SAES/MS).

NOTA

- Em 2011, houve uma mudança no conteúdo da Declaração de Nascido Vivo (DNV), com maior detalhamento das informações coletadas, entre as quais a escolaridade, a cor ou raça da parturiente e o número de consultas de pré-natal. Naquele ano e no seguinte, foram utilizados simultaneamente os dois formulários, abrangendo, também, nascimentos ocorridos em 2010. As informações segundo estas variáveis são apresentadas, então, separadamente nesses dois períodos: até 2011 e a partir de 2012.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, o parto hospitalar é predominante, representando mais de 98% dos nascimentos no período de 2014 a 2023. A distribuição desse indicador mostra relativa homogeneidade entre as regiões – um padrão distinto de outros indicadores de saúde, que costumam refletir disparidades regionais mais acentuadas. As regiões Sul e Sudeste apresentam os percentuais mais elevados de parto hospitalar (acima de 99%), enquanto a região Norte registra os valores mais baixos (entre 94% e 95%) (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) de partos hospitalares. Brasil e regiões, 2014 a 2023

Brasil e regiões	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brasil	98,4	98,4	98,3	98,4	98,5	98,5	98,3	98,2	98,3	98,4
Norte	94,2	94,6	94,6	94,8	95,0	95,1	94,7	94,7	95,2	95,4
Nordeste	98,0	98,0	98,1	98,0	98,2	98,2	98,1	97,9	98,0	98,1
Sudeste	99,4	99,2	99,1	99,3	99,4	99,3	99,2	99,2	99,1	99,2
Sul	99,5	99,5	99,4	99,3	99,2	99,2	99,0	99,0	99,0	99,0
Centro-Oeste	98,9	99,0	98,9	98,8	98,8	98,7	98,7	98,6	98,6	98,7

Nota:

- Nascidos vivos: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Ministério da Saúde/DATASUS. Situação da base em 20/12/2024.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Nascidos Vivos – desde 1994 [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.4.02 – Proporção de partos hospitalares [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi:10.5281/zenodo.18510413



Cobertura



COB.4.03 – Proporção de partos cesáreos

COB.4.03 – Proportion of cesarean births

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção de partos cesáreos no total de partos, na população residente, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a participação relativa dos partos cesáreos no total de partos (normais e cesáreos). O número de nascidos vivos é adotado como uma aproximação do total de partos.
- É influenciado pelo modelo de assistência obstétrica adotado, pelas condições socioeconômicas e de saúde da gestante e pela disponibilidade de recursos especializados (tecnologias e serviços).

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais da proporção de partos cesáreos, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir na análise da qualidade da assistência ao parto e das condições de acesso aos serviços de saúde, no contexto do modelo assistencial adotado.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção à saúde da mulher e da criança.
- Contribuir na avaliação da qualidade da assistência prestada, uma vez que o aumento pode refletir um acompanhamento pré-natal inadequado ou indicações equivocadas do parto cesáreo, em detrimento do parto normal.

LIMITAÇÕES

- Pode requerer informações adicionais sobre as condições que determinaram a realização do parto cirúrgico.
- Desconsidera, por restrição da fonte de dados, os partos que deram origem a natimortos e abortos.
- A representatividade populacional do indicador pode estar comprometida nas áreas que apresentam insuficiente cobertura do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).
- A ocorrência de partos gemelares resulta em contagem cumulativa de partos.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de nascidos vivos de partos cesáreos}}{\text{Número total de nascidos vivos de parturientes residentes, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de nascidos vivos no ano considerado (DTNASC – 4 últimos dígitos), segundo o município de residência (CODMUNRES), a cor ou raça da parturiente (RACACORMAE), a idade da parturiente (IDADEMAE) e a escolaridade da parturiente (ESMAE2010), que tenham nascido de parto cesáreo (PARTO = 2).
- Denominador: Número de nascidos vivos no ano considerado (DTNASC – 4 últimos dígitos), segundo o município de residência (CODMUNRES), a cor ou raça da parturiente (RACACORMAE), a idade da parturiente (IDADEMAE) e a escolaridade (ESMAE2010).
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça da parturiente:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda;
- Indígena; e
- Não informada.

Nota:

- Seleção disponível a partir de 2012.

Faixa etária da parturiente:

- Até 14 anos;
- 15 a 44 anos, de 5 em 5 anos; e
- 45 anos ou mais.

Escolaridade da parturiente (até 2011):

- Sem escolaridade;
- 1 a 3 anos;
- 4 a 7 anos;
- 8 a 11 anos;
- 12 anos e mais; e
- Não informada.

Escolaridade da parturiente (a partir de 2012):

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo);
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo); e
- Não informada.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (DAHU/SAES/MS).

NOTAS

- Em 2011, houve uma mudança no conteúdo da Declaração de Nascido Vivo (DNV), com maior detalhamento das informações coletadas, entre as quais a escolaridade, a cor ou raça da parturiente, o número de consultas de pré-natal e o início do pré-natal. Naquele ano e no seguinte, foram utilizados simultaneamente os dois formulários, abrangendo, também, alguns nascimentos ocorridos em 2010.
- As informações segundo estas variáveis são apresentadas então separadamente – até 2011 e a partir de 2012.
- A proporção de nascidos vivos, segundo o número de consultas de pré-natal, é calculada sobre o total de nascidos vivos, incluindo-se os casos em que o número de consultas não foi informado.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

De 2014 a 2023, o percentual de nascidos vivos por parto cesáreo aumentou de 57,0% para 59,6%. Discretas variações, ao longo dos anos e segundo regiões, podem ser notadas. Em 2023, as proporções de cesarianas nas regiões Norte (52,6%) e Nordeste (57,3%) ficaram aquém dos valores nacionais, o que também ocorreu nos demais anos da série analisada. Em contraste, exibiram valores mais elevados o Centro-Oeste (65,4%) e o Sul (63,6%), seguidos pelo Sudeste (60,4%) (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) de partos cesáreos. Brasil e regiões, 2014 a 2023

Brasil e regiões	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brasil	57,0	55,5	55,4	55,7	55,9	56,3	57,2	57,0	58,1	59,6
Norte	46,8	46,2	45,5	46,5	47,2	47,7	48,7	49,2	51,1	52,6
Nordeste	50,9	49,6	49,9	50,1	51,5	52,4	53,2	53,5	55,3	57,3
Sudeste	61,0	59,1	58,8	58,6	58,4	58,5	59,2	58,5	59,3	60,4
Sul	62,4	60,5	60,7	61,4	61,0	61,3	62,8	62,7	62,4	63,6
Centro-Oeste	62,8	61,5	62,0	62,6	63,0	62,5	63,8	63,8	63,9	65,4

Nota:

- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Ministério da Saúde/DATASUS. Situação da base em 20/12/2024.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Nascidos Vivos – desde 1994 [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.4.03 – Proporção de partos cesáreos [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18510478



Cobertura



COB.4.04 – Proporção da população do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiu uso de métodos anticoncepcionais (PNS)

COB.4.04 – Proportion of women aged 18-49 years who reported using contraceptive methods (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiu ter tido relações sexuais nos últimos 12 meses antes da entrevista e fazia uso de métodos para evitar a gravidez, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima o uso de métodos anticoncepcionais pela população do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiu ter tido relações sexuais nos últimos 12 meses antes da entrevista.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais da proporção da população do sexo feminino em uso de anticoncepcionais, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir na análise das condições de saúde reprodutiva da população do sexo feminino.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas e ações de saúde voltadas para a saúde da população do sexo feminino, em especial quanto ao uso de métodos anticoncepcionais (provisão de insumos, materiais educativos, entre outros).

LIMITAÇÕES

- Como todo indicador derivado de informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode ser influenciado pela acurácia das respostas dos entrevistados, relacionada à compreensão das perguntas e à capacidade de recordação.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas e pessoas amarelas devem ser interpretadas com cautela, devido ao pequeno número de observações na amostra.
- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiram relações sexuais nos últimos 12 meses antes da entrevista e que faziam uso de métodos para evitar a gravidez, em um local e ano de referência}}{\text{Número de entrevistadas do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiram relações sexuais nos últimos 12 meses antes da entrevista, excluídas aquelas que querem engravidar, estão grávidas, ligaram as trompas, o companheiro fez vasectomia, ou não têm relações sexuais com homens, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de entrevistadas do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que respondeu “Sim” à questão “Nos últimos 12 meses, a Sra. teve relações sexuais?” e “Sim” à questão “A Sra. usa algum método para evitar a gravidez atualmente?”. Ou que respondeu “Não” à questão “A Sra. usa algum método para evitar a gravidez atualmente?”, porém respondeu “Ligou as trompas” ou “O companheiro fez vasectomia” à questão “Qual o principal motivo de não evitar a gravidez?”.
- **Denominador:** Número de entrevistadas do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses. São excluídas aquelas que responderam “Não” à questão “A Sra. usa algum método para evitar a gravidez atualmente?”, e responderam, quanto à questão “Qual o principal motivo de não evitar a gravidez?”, com uma das seguintes alternativas: “Quer engravidar ou não se incomoda de engravidar”; “Está grávida”; “Ligou as trompas”; “O companheiro fez vasectomia”; ou “Não tem relações sexuais com homens”.
- **Multiplicador:** 100.

Notas:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra do morador selecionado do domicílio, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral.
- Pessoas do sexo feminino que responderam que não menstruam ou que realizaram cirurgia de retirada do útero (histerectomia) não respondem à parte do questionário que trata de planejamento familiar e contracepção, e não estão incluídas no numerador nem no denominador.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 18 a 19 anos; e
- 20 a 49 anos, de 5 em 5 anos.

Renda domiciliar per capita:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DAENT/SVSA/MS).
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, a proporção de mulheres de 18 a 49 anos que referiu uso de métodos anticoncepcionais apresentou um leve aumento entre 2013 (90,4%) e 2019 (92,7%). De um modo geral, houve estabilidade ou um leve aumento na proporção também para as regiões. O Nordeste apresentou o maior crescimento, de 86,4% para 93,6%, enquanto o Sul manteve os maiores valores, com 94,2%, em 2013, e 94,1% em 2019. A região Norte registrou os menores percentuais, embora também tenha apresentado crescimento (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) da população do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiu uso de métodos anticoncepcionais, com indicação do IC95%. Brasil e regiões, 2013 e 2019

Brasil e regiões	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil	90,4	89,5; 91,3	92,7	92,0; 93,4
Norte	88,3	85,9; 90,3	89,1	87,1; 90,9
Nordeste	86,4	84,4; 88,2	93,6	92,6; 94,5
Sudeste	91,4	89,7; 92,8	92,4	91,0; 93,6
Sul	94,2	92,5; 95,5	94,1	92,6; 95,3
Centro-Oeste	90,1	88,3; 91,7	92,4	90,4; 94,0

Nota:

- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.4.04 – Proporção da população do sexo feminino de 18 a 49 anos de idade que referiu uso de métodos anticoncepcionais (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18510496



Cobertura



COB.5.01 – Proporção da população coberta por planos privados de assistência à saúde

COB.5.01 – Proportion of population covered by private health insurance

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população coberta por planos privados de assistência à saúde, exceto exclusivamente odontológicos, em um local e ano de referência.
- O número de vínculos de beneficiários de planos privados de assistência à saúde é adotado como uma aproximação da população coberta.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a proporção de beneficiários de planos privados de assistência à saúde, exceto os planos exclusivamente odontológicos, em relação à população total.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais da cobertura de planos e seguros privados de saúde, identificando-se situações que demandem ações e estudos específicos.
- Contribuir para a regulação de planos privados de assistência à saúde.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência e a promoção da saúde.

LIMITAÇÕES

- Não inclui a população vinculada a instituição patronal de assistência ao servidor público civil e militar.
- O Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) contabiliza o número de vínculos a planos de saúde, e não o número de indivíduos. Desta forma, indivíduos que possuem mais de um plano privado de saúde serão contabilizados mais de uma vez.

FONTES DE DADOS

- Sistema de Informações de Beneficiários (SIB)¹.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções².
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de vínculos de beneficiários de planos e seguros privados de saúde, exceto os exclusivamente odontológicos, em junho do ano de referência}}{\text{População total residente, ajustada para o meio do ano}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: A partir das bases de dados disponibilizadas pela ANS de número de beneficiários¹, recuperar, a partir do arquivo tb_bb_aaaa_mm.dbc. Selecionar junho de cada ano como mês de referência. Somar o número de beneficiários de planos ambulatoriais e/ou hospitalares (NR_BENEF_T), segundo o município de residência (CD_MUNICIP), o ano de competência (ID_CMPT – 4 primeiros dígitos), a faixa etária (CD_FAIXA_E), o sexo (SEXO) e o tipo de plano (CD_CONTR).
- Denominador: População total residente^{2,3}.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Faixa etária:

- 0 a 9 anos;
- 10 a 19 anos;
- 20 a 49 anos;
- 50 a 59 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Segmentação assistencial do plano:

- Ambulatorial (com ou sem odontologia);
- Hospitalar (com ou sem obstetrícia e/ou odontologia); e
- Hospitalar e ambulatorial (com ou sem obstetrícia e/ou odontologia).

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Desenvolvimento Setorial da Gerência de Padronização, Interoperabilidade e Análise de Informações e Desenvolvimento Setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (DIDES/GPIND/ANS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Apesar da redução geral no período para o Brasil, é possível identificar dois momentos distintos na série: de 2015 a 2020, houve redução progressiva da cobertura por planos privados de assistência à saúde; e de 2020 a 2024, ocorreu a retomada dos patamares iniciais da série histórica, alcançando a proporção 24,2% em 2024. Comportamento semelhante se repetiu nas regiões Sul, Sudeste e Norte. Na região Centro-Oeste, o aumento progressivo se iniciou em 2019. O Norte e o Nordeste registraram os menores valores percentuais em 2024, de 10,3% e 12,8%, respectivamente, enquanto o Sudeste apresentou o maior percentual (34,6%, em 2024) (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção da população coberta por planos privados de assistência à saúde, exceto os exclusivamente odontológicos. Brasil e regiões, 2015 a 2024

Brasil e regiões	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brasil	24,8	23,7	23,0	22,8	22,6	22,5	23,1	23,7	24,0	24,2
Norte	10,9	10,1	9,9	9,6	9,5	9,4	9,8	9,8	10,0	10,3
Nordeste	12,3	12,1	11,8	11,8	11,7	11,6	11,8	12,2	12,5	12,8
Sudeste	36,3	34,4	33,3	32,9	32,6	32,2	33,2	34,1	34,3	34,6
Sul	24,6	23,9	23,5	23,4	22,9	22,4	22,7	23,3	23,6	23,8
Centro-Oeste	20,9	20,7	20,2	19,9	20,0	22,9	23,4	23,7	24,3	24,7

Notas:

- Beneficiários da Saúde Suplementar: Sistema de Informações sobre Beneficiários (SIB). Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
- Situação da base em 5/6/2025, às 9h07min, sujeita a alterações. Os dados coletados se referem à competência “junho” de cada ano.
- Base demográfica: estimativas efetuadas em estudo coordenado pela Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa), para 2000 a 2024, realizado pelo CGI Demográfico/Ripsa e Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (CGIAE/SVSA/MS), sobre dados básicos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

REFERÊNCIAS

1. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sistema de Informações de Beneficiários [Internet]. ANS. [citado 16 de abril de 2025]. Disponível em: https://dadosabertos.ans.gov.br/FTP/Base_de_dados/Microdados/dados_dbc/beneficiarios/municipio/
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
3. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.5.01 – Proporção da população coberta por planos privados de assistência à saúde [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18510568



Cobertura



COB.5.02 – Proporção da população que referiu cobertura por planos de saúde (PNS)

COB.5.02– Proportion of population reporting health plan coverage (PNS)

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da população que referiu cobertura por plano de saúde, médico e/ou odontológico, particular, de empresa ou órgão público, em um local e ano de referência.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a parcela da população coberta por planos públicos e privados de assistência à saúde.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais da cobertura de assistência médica e/ou odontológica de planos públicos e privados de assistência à saúde.
- Contribuir para a implantação e o aperfeiçoamento da legislação que regulamenta esse setor.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência e a promoção da saúde.

LIMITAÇÕES

- Como em toda informação obtida a partir de inquéritos populacionais, o resultado pode sofrer influência de respostas inexatas ao questionário, ocasionadas tanto pela compreensão do respondente em relação à pergunta, como pela resposta fornecida por terceiros.
- Na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013, não é possível desagregar por planos médicos e planos odontológicos.
- Na desagregação por cor ou raça, as estimativas para indígenas e pessoas amarelas devem ser interpretadas com cautela, devido ao pequeno número de observações na amostra.
- A PNS não coleta informações em setores censitários localizados em terras indígenas. Desse modo, a informação diz respeito somente a indígenas não aldeados, grupo que não representa toda a população indígena.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)¹.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de pessoas entrevistadas que referiram cobertura por plano de saúde, médico ou odontológico, particular, de empresa ou órgão público, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de pessoas entrevistadas, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número ponderado de pessoas entrevistadas que responderam “Sim” à questão na PNS 2013: “O(A) Sr.(a) tem algum plano de saúde (médico ou odontológico), particular, de empresa ou órgão público?”.

Para a PNS de 2019, é o número de pessoas entrevistadas que responderam “Sim” às seguintes questões:

“Tem algum plano odontológico particular, de empresa ou órgão público?”;

“Tem algum plano de saúde médico particular, de empresa ou órgão público?”.

Utilizar as variáveis abaixo:

- › PNS 2013: I1 = 1; e
- › PNS 2019: I1a = 1 ou I1b = 1.

- **Denominador:** Número ponderado de entrevistadas.
- **Multiplicador:** 100.

Nota:

- No cálculo, deve-se considerar o desenho complexo da amostra do morador selecionado do domicílio, incluindo-se unidade primária de amostragem, estrato e peso amostral.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Cor ou raça:

- Branca;
- Preta;
- Amarela;
- Parda; e
- Indígena.

Faixa etária:

- 0 a 59 anos, de 10 em 10 anos; e
- 60 anos ou mais.

Sexo:

- Masculino; e
- Feminino.

Renda domiciliar per capita:

- Até $\frac{1}{4}$ do salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{4}$ até $\frac{1}{2}$ salário mínimo;
- Mais de $\frac{1}{2}$ até 1 salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Situação do domicílio:

- Urbano; e
- Rural.

Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto (0 a 8 anos de estudo);
- Ensino médio incompleto (9 a 11 anos de estudo); e
- Ensino médio completo e superior (12 anos e mais de estudo).

Tipo de plano:

- Médico; e
- Odontológico (apenas para a PNS 2019).

GRANULARIDADE

- Capitais de Unidades da Federação e Distrito Federal.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- A cada 6 anos.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (DAENT/SVSA/MS).
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

No Brasil, o percentual da população que referiu cobertura por planos de saúde mostrou-se estável, com variações dentro do intervalo de confiança: 27,9%, em 2013, e 28,5% em 2019. As regiões Sudeste e Sul apresentaram as maiores proporções em ambos os inquéritos, com 37,5% e 32,8%, respectivamente, em 2019. No outro extremo, as regiões Norte e Nordeste continuaram com os menores percentuais, 14,7% e 16,6%, respectivamente. A região Centro-Oeste permaneceu com valores intermediários, de 28,9%, em 2019 (Tabela 1).

Tabela 1 – Proporção (%) da população que referiu cobertura por planos de saúde, com indicação do IC95%. Brasil e regiões, 2013 e 2019

Brasil e regiões	2013		2019	
	%	IC95%	%	IC95%
Brasil	27,9	27,1; 28,8	28,5	27,8; 29,2
Norte	13,3	12,2; 14,4	14,7	13,6; 15,9
Nordeste	15,5	14,5; 16,4	16,6	15,8; 17,4
Sudeste	36,9	35,2; 38,5	37,5	35,9; 39,0
Sul	32,8	30,4; 35,2	32,8	31,2; 34,3
Centro-Oeste	30,3	28,6; 32,0	28,9	27,2; 30,6

Nota:

- IC95%: intervalo de confiança de 95%.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNS – Pesquisa Nacional de Saúde [Internet]. [citado 19 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html?=&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Cobertura. COB.5.02– Proporção da população que referiu cobertura por planos de saúde (PNS) [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18510848





INDICADORES
DE RECURSOS (REC)

Indicadores de recursos (REC)

Instituído no âmbito da Ripsa, o CGI Recursos tem como missão precípua a revisão, a atualização e o aprimoramento dos indicadores voltados à mensuração da disponibilidade e distribuição de recursos humanos, físicos e financeiros no sistema de saúde brasileiro. O comitê agrega um corpo técnico interinstitucional, composto por representantes do Ministério da Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), de conselhos de saúde (Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass; e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – Conasems), agências reguladoras e universidades, assegurando a transversalidade, a integralidade e a credibilidade dos indicadores produzidos.

A construção e validação do atual elenco de indicadores foi pautada em uma metodologia de trabalho colaborativa e criteriosa. O processo envolveu ciclos de reuniões técnicas e a formação de subgrupos temáticos responsáveis pelas dimensões de *força de trabalho*, *infraestrutura*, *financiamento* e *saneamento*. Mediante análises conjuntas e validações interinstitucionais, buscou-se harmonizar conceitos, definir fontes de dados contínuas e estabelecer fichas de qualificação que garantissem a transparência e a reprodutibilidade das metodologias.

No cenário atual da saúde pública no Brasil, a importância destes indicadores reside na superação de limitações metodológicas pretéritas e na adaptação à descontinuidade de antigas fontes de pesquisa. A nova matriz de indicadores do CGI Recursos oferece subsídios robustos para a identificação de lacunas de cobertura e detecção de desigualdades regionais na alocação de recursos em saúde. Trata-se de uma ferramenta essencial para instrumentalizar gestores e pesquisadores na formulação de políticas públicas baseadas em evidências, visando à equidade no acesso e à eficiência na gestão do complexo econômico e social da saúde. Recomenda-se a apropriação destes indicadores como instrumentos essenciais para a governança do SUS, cuja aplicabilidade transcende o monitoramento.

No contexto atual, marcado pela necessidade de alocação eficiente de recursos frente a demandas demográficas e epidemiológicas crescentes, a utilização sistemática da matriz do CGI Recursos torna-se indispensável para a tomada de decisão qualificada. Estes dados permitem aos gestores e pesquisadores diagnosticar assimetrias regionais na oferta de serviços e na força de trabalho, bem como avaliar a suficiência do financiamento, orientando, assim, um planejamento estratégico que objetive a redução de iniquidades e a sustentabilidade do sistema público de saúde.



Dimensão 1 – Recursos humanos

REC.1.01 – Trabalhadores da saúde por população

Dimensão 2 – Capacidade instalada

REC.2.01 – Leitos hospitalares por população

REC.2.02 – Distribuição proporcional de leitos hospitalares segundo natureza jurídica

REC.2.03 – Equipamentos de imagem por população

Dimensão 3 – Recursos financeiros: assistência à saúde

REC.3.01 – Valor médio de referência por atendimento ambulatorial no Sistema Único de Saúde

REC.3.02 – Valor médio de referência por autorização de internação hospitalar

REC.3.03 – Gasto em ações e serviços públicos de saúde como percentual do produto interno bruto

REC.3.04 – Gasto em ações e serviços públicos de saúde *per capita*

Dimensão 4 – Recursos financeiros: despesas em saúde

REC.4.01 – Despesa com saúde autorreferida como proporção da renda familiar

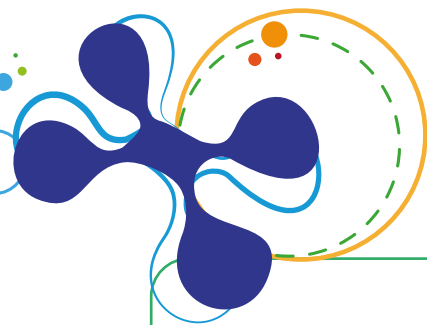
REC.4.02 – Despesa com saúde estimada como proporção da renda familiar

REC.4.03 – Gasto nacional com saúde como percentual do produto interno bruto

REC.4.04 – Gasto nacional *per capita* com saúde

REC.4.05 – Gasto federal com saúde como percentual do produto interno bruto

REC.4.06 – Gasto federal com saúde como percentual do gasto federal total



Dimensão 5 – Recursos financeiros: gasto com saneamento

- REC.5.01 – Gasto público com saneamento básico como percentual do produto interno bruto
- REC.5.02 – Gasto federal com saneamento básico como percentual do produto interno bruto
- REC.5.03 – Gasto federal com saneamento básico como percentual do gasto federal total

Dimensão 6 – Recursos financeiros: bens e serviços

- REC.6.01 – Proporção das importações de bens e serviços de saúde na oferta nacional

Recursos



REC.1.01 – Trabalhadores da saúde por população

REC.1.01 – Health workers per population

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Razão entre o número de trabalhadores da saúde e a população residente, em um local e ano de referência.
- Abrange o conjunto de trabalhadores que atuam nos serviços de saúde, incluindo tanto a assistência direta quanto as atividades-meio essenciais ao funcionamento do sistema.
- Inclui trabalhadores envolvidos na promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, abrangendo: equipes de assistência direta (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, entre outros), equipes técnicas de apoio diagnóstico e terapêutico (laboratoristas, técnicos de radiologia etc.) e trabalhadores das áreas administrativas e de suporte (gestão, recepção, limpeza, segurança e manutenção).
- São considerados os trabalhadores registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

INTERPRETAÇÃO

- Permite avaliar a densidade de trabalhadores da saúde disponíveis para atendimento à população, considerando-se os trabalhadores registrados no CNES.
- Reflete aspectos socioeconômicos regionais, políticas de formação profissional em saúde, políticas públicas de saúde e dinâmicas do mercado de trabalho no setor.
- Valores mais elevados sugerem maior capacidade potencial de oferta de serviços de saúde, enquanto valores mais baixos podem indicar possíveis limitações no acesso aos serviços, devido à insuficiência de gestão do trabalho em saúde.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais da distribuição de trabalhadores da saúde, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a prestação de serviços de saúde, assim como para a formação de trabalhadores de saúde e sua inserção no mercado de trabalho.
- Avaliar a disponibilidade e acessibilidade aos serviços de saúde em uma determinada região.

LIMITAÇÕES

- O indicador considera exclusivamente trabalhadores registrados no CNES, o que significa que aqueles não vinculados a estabelecimentos de saúde, como autônomos e liberais, podem não estar incluídos na contagem.
- Inexistem padrões nacionais ou internacionais validados. Alguns deles, que têm sido usados para comparação (por exemplo, pelo menos um médico por mil habitantes), não se aplicam a todas as realidades.
- O indicador não leva em conta a carga horária dos trabalhadores, uma vez que essa informação disponível no CNES apresenta inconsistências.
- O indicador pode apresentar imprecisões decorrentes da base de dados demográficos utilizada para estimar o número de habitantes.
- A contagem de trabalhadores pode apresentar duplicidade quando os dados são desagregados por município ou Unidade da Federação (UF). Isso ocorre porque o mesmo trabalhador pode possuir vínculos simultâneos em estabelecimentos localizados em diferentes municípios ou estados, resultando em contagem múltipla em cada unidade territorial onde há vínculo ativo. Entretanto, em agregações em nível nacional, cada trabalhador é identificado de forma única pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), independentemente do número de vínculos ou localidades em que atue, o que elimina a duplicidade.

FONTES DE DADOS

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)¹.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções².
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número total de trabalhadores da saúde, por categoria específica, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente em um local e ano de referência}} \times 1.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de trabalhadores da saúde, calculado como contagem dos registros de CPF únicos, com base no ano, nas categorias do Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e no município onde o trabalhador atua. As categorias devem seguir os padrões descritos nos itens da variável ocupação.
- Denominador: População residente, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 1.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Ocupação:

- Agente da saúde e do meio ambiente;
- Assistente social e economista doméstico;
- Biomédico;
- Biólogo e afins;
- Cirurgião-dentista;
- Cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos;
- Enfermeiro e afins;
- Farmacêutico;
- Fisioterapeuta;
- Fonoaudiólogo;
- Médico clínico;
- Médico em especialidades cirúrgicas;
- Médico em medicina diagnóstica e terapêutica;
- Médico (classificação geral);
- Nutricionista;
- Profissional de educação física;
- Psicólogo e psicanalista;
- Tecnólogo e técnico em métodos de diagnósticos e terapêutica;
- Tecnólogo e técnico em terapias complementares e estéticas;
- Terapeuta ocupacional, ortopedista e psicomotricista;
- Trabalhador em serviços de promoção e apoio à saúde;
- Técnico de imobilizações ortopédicas;
- Técnico de laboratório de saúde e bancos de sangue;
- Técnico de odontologia;
- Técnico e auxiliar de enfermagem;
- Técnico em produção, conservação e de qualidade de alimentos;
- Técnico em próteses ortopédicas;
- Técnico em segurança do trabalho;
- Técnico em óptica e optometria;
- Técnico em farmácia e em manipulação farmacêutica; e
- Veterinário e zootecnista.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Sistemas de Informação do Departamento de Regulação Assistencial e Controle da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (CGSI/DRAC/SAES/MS).

NOTA

- Vale destacar que a ocupação “médico (classificação geral)” originalmente concentrava todos os profissionais da área da família 2231. Com o tempo, essa categoria foi desagregada em três novas classificações: 2251, 2252 e 2253.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Todas as categorias analisadas apresentaram crescimento ao longo do período (em valores por mil habitantes; Tabela 1). Os maiores aumentos absolutos foram observados entre técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiros e afins e médicos clínicos. O grupo de técnicos e auxiliares de enfermagem apresentou o maior crescimento em termos absolutos, passando de 3,47, em 2018, para 4,75, em 2024, e os enfermeiros e afins cresceram de forma constante, evoluindo de 1,26 para 1,97 no mesmo intervalo, o que também representa um incremento relativo expressivo de aproximadamente 56,30%.

Médicos clínicos passaram de 1,90 para 2,63, configurando aumento tanto absoluto quanto percentual. Em contrapartida, médicos em especialidades cirúrgicas apresentaram crescimento mais discreto, de 0,74 para 0,85, assim como os médicos em medicina diagnóstica e terapêutica, que evoluíram de 0,15 para 0,20. Entre os nutricionistas, o número passou de 0,14 para 0,22, o que, embora represente um incremento absoluto pequeno, configura um dos maiores crescimentos relativos no período (57,10%). Cirurgiões-dentistas oscilaram durante o período, com queda em 2020 (0,76), mas retomaram o crescimento nos anos seguintes, atingindo 0,96 em 2024.

É importante destacar que categorias com valores iniciais menores, como nutricionistas e médicos da área diagnóstica, tendem a apresentar variações percentuais elevadas, mesmo com pequenas variações absolutas. Por isso, a análise conjunta dos incrementos absolutos e relativos é essencial para uma compreensão mais precisa da evolução no período.

Tabela 1 – Número de trabalhadores da saúde por mil habitantes. Brasil, 2018 a 2024

Ocupação	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cirurgião-dentista	0,81	0,83	0,76	0,82	0,87	0,91	0,96
Enfermeiro e afins	1,26	1,33	1,48	1,65	1,72	1,84	1,97
Médico (classificação geral)	0,16	0,16	0,17	0,19	0,19	0,20	0,22
Médico clínico	1,90	1,95	2,06	2,21	2,31	2,44	2,63
Médico em especialidades cirúrgicas	0,74	0,75	0,75	0,77	0,80	0,82	0,85
Médico em medicina diagnóstica e terapêutica	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20
Nutricionista	0,14	0,15	0,16	0,17	0,19	0,20	0,22
Técnico e auxiliar de enfermagem	3,47	3,55	3,80	4,16	4,25	4,48	4,75

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde [Internet]. DATASUS. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>

2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
3. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.1.01 – Trabalhadores da saúde por população [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18272779



Recursos



REC.2.01 – Leitos hospitalares por população

REC.2.01 – Hospital beds per population

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Razão entre o número de leitos hospitalares e a população, em um local e ano de referência.
- Consideram-se leitos hospitalares os leitos públicos ou privados, vinculados ou não ao Sistema Único de Saúde (SUS), dos estabelecimentos de saúde incluídos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Os leitos excluídos são: os de acolhimento noturno¹, reabilitação¹, suporte ventilatório pulmonar² e unidade de terapia intensiva (UTI) específica para COVID-19².
- Leito³: refere-se à unidade física destinada ao atendimento de pacientes internados em um hospital, clínica ou outra instituição de saúde. O leito é utilizado para oferecer cuidados assistenciais contínuos a pacientes que necessitam de observação, tratamento ou recuperação, os quais não podem ser realizados em ambulatório.
- Leitos disponíveis em hospitais públicos⁴: referem-se àqueles que são geridos com recursos públicos, seja em nível federal, estadual ou municipal, incluindo-se empresas públicas e sociedades de economia mista.
- Leitos hospitalares em hospitais privados⁴: referem-se aos leitos disponíveis em hospitais que são de propriedade e operados por entidades privadas, como empresas, organizações sem fins lucrativos ou indivíduos. Esses hospitais fazem parte do setor de saúde privado e podem ser conveniados ao SUS.
- Leitos SUS⁴: referem-se aos leitos de internação hospitalar ativos, utilizados no SUS, ou seja, disponíveis para pacientes atendidos pelo SUS. O quantitativo de leitos SUS é informado pelo gestor municipal ou estadual, exceto no caso dos leitos complementares, cujo registro decorre automaticamente do processo de habilitação pelo Ministério da Saúde.
- Leitos não SUS⁴: correspondem aos leitos existentes em estabelecimentos de saúde que não são destinados ao atendimento pelo SUS. Esse número é calculado automaticamente pelo sistema do CNES, por meio da subtração dos leitos SUS do total de leitos existentes. Portanto, o quantitativo de leitos não SUS não é informado diretamente pelos gestores municipais ou estaduais.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a relação entre a oferta de leitos hospitalares e a população residente em determinada área geográfica.
- É influenciado por múltiplos fatores: socioeconômicos (nível de renda e desenvolvimento tecnológico); demográficos (composição etária da população); epidemiológicos (perfil de morbimortalidade); assistenciais (disponibilidade de profissionais de saúde); e políticas

públicas de saúde, incluindo incentivos a procedimentos ambulatoriais, programas de desospitalização em saúde mental e serviços de atenção domiciliar.

- Em geral, a concentração de leitos está associada ao maior poder aquisitivo da população e à demanda por serviços especializados, condições que atraem investimentos do setor privado de saúde.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais na oferta de leitos hospitalares públicos e privados, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar.

LIMITAÇÕES

- Não considera a demanda hospitalar por não residentes, o que altera a relação de proporcionalidade entre os leitos disponíveis e a população residente.
- Inexistem padrões nacionais ou internacionais validados para análises comparativas, pois o indicador expressa uma combinação de fatores inerentes a realidades regionais ou locais distintas.
- Os estabelecimentos e leitos registrados no CNES podem apresentar inconsistências, devido à falta de atualização quando ocorrem alterações no quantitativo de leitos existentes ou disponíveis. Ressalta-se que o cadastramento, a manutenção e a atualização das informações sobre os estabelecimentos de saúde no CNES são atribuições dos gestores locais desses estabelecimentos.
- O indicador pode apresentar imprecisões decorrentes da base de dados demográficos utilizada para estimar o número de habitantes.
- Não considera a demanda hospitalar por não residentes, que altera a relação de proporcionalidade entre os leitos disponíveis e a população residente. Essa limitação está relacionada à organização regionalizada e hierarquizada do SUS, que prevê o encaminhamento de pacientes entre diferentes municípios e regiões para acesso a serviços especializados ou de maior complexidade, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988⁵ e na Lei nº 8.080/1990⁶.

FONTES DE DADOS

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)⁷.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁸.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁹.
- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)¹⁰.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de leitos hospitalares ativos, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, conforme tipo de leito, em um local e ano de referência}} \times 1.000$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de leitos hospitalares ativos, em um local e ano de referência. Deve-se quantificar o total de leitos hospitalares ativos na região geográfica de interesse, excluindo-se os leitos de acolhimento noturno, reabilitação, suporte ventilatório pulmonar e UTIs específicas para COVID-19. Para quantificar o número de leitos, considera-se a competência de julho de cada ano. Esses tipos de leitos são excluídos por não integrarem o conceito de leitos de internação hospitalar, conforme normativas do SUS⁴. Os leitos de reabilitação e acolhimento noturno pertencem a unidades ambulatoriais; os leitos de suporte ventilatório e UTI COVID-19, criados temporariamente durante a pandemia, foram posteriormente redirecionados para a atenção pediátrica².
- Denominador: População total residente, conforme tipo de leito, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 1.000.

Notas:

- Para leitos de UTI e unidade de cuidados intermediários UCI neonatais, considera-se no denominador a população de nascidos vivos.
- Para leitos de UTI e UCI pediátrica, considera-se no denominador a população 5 a 14 anos de idade.
- Para leitos de UTI e UCI adultos, considera-se no denominador a população com idade igual ou superior a 15 anos.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Esfera administrativa:

- Pública: federal, estadual, municipal, empresa pública e sociedade de economia mista; e
- Privada: com e sem fins lucrativos.

Tipo de vínculo:

- SUS; e
- Não SUS.

Tipo de leito:

- Leitos totais;
- Leitos de UTI neonatal;
- Leitos de UTI pediátrica;
- Leitos de UTI adulto;
- Leitos de UTI de queimados;
- Leitos de UTI coronariana;
- Leitos de UCI neonatal;
- Leitos de UCI pediátrica;
- Leitos de UCI adulto;
- Leitos de UCI de queimados; e
- Leitos de UCI coronariana.

Notas:

- Leitos totais são todos os leitos considerados no indicador, inclusive os de UTI, exceto os seguintes códigos:
- Código 48: Reabilitação;
- Código 51: UTI II Adulto - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - COVID-19;
- Código 52: UTI II Pediátrica - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - COVID-19;
- Código 84: Acolhimento noturno; e
- Código 96: Suporte ventilatório pulmonar - COVID-19.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Sistemas de Informação do Departamento de Regulação Assistencial e Controle da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (CGSI/DRAC/SAES/MS).

NOTA

- Para o cálculo desse indicador, alguns tipos de leitos foram excluídos, em função de características específicas, conforme conceituações a seguir.
 - › Leitos de reabilitação: no âmbito do SUS, esses leitos não são considerados de internação. São leitos que compõem unidades ambulatoriais.
 - › Leitos de acolhimento noturno: no âmbito do SUS, esses leitos não são considerados de internação. São leitos que compõem unidades ambulatoriais da Rede de Atenção Psicossocial, conforme Portaria GM nº 854, de 22 de agosto de 2012.
 - › Leitos de UTI COVID-19: leitos criados temporariamente para atender à demanda decorrente da pandemia de COVID-19, que, contudo, não fazem mais parte do rol de leitos de UTI do SUS.
 - › Leitos de suporte ventilatório: leitos criados temporariamente para atender aos casos com necessidade de suporte ventilatório, não invasivo e invasivo, decorrente da pandemia de COVID-19, que foram posteriormente direcionados para a atenção pediátrica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Em 2018, o Brasil apresentava uma disponibilidade de 2,17 leitos hospitalares por mil habitantes, com uma divisão de 1,49 leito no SUS e de 0,68 não SUS. Para leitos de UTI, a proporção era de 2,15 por 10 mil habitantes, sendo 1,05 no SUS e 1,11 não SUS. No ano seguinte, 2019, houve uma leve redução na quantidade total de leitos, que caiu para 2,12 por mil habitantes, com 1,46 no SUS e 0,67 não SUS, enquanto os leitos de UTI aumentaram para 2,20 por 10 mil habitantes. No ano de 2020, observou-se um aumento na disponibilidade total de leitos, que atingiu 2,21 por mil habitantes, impulsionado pelos leitos do SUS, que alcançaram 1,56 leito por mil habitantes, enquanto a categoria não SUS registrou 0,65.

Os leitos de UTI também cresceram, chegando a 2,27 por 10 mil habitantes. Em 2021, a disponibilidade total de leitos apresentou uma pequena queda, passando para 2,19 por mil habitantes, com 1,53 no SUS e 0,66 não SUS, mas os leitos de UTI continuaram a aumentar, alcançando 2,32 por 10 mil habitantes. Em 2022, o número total de leitos retornou para 2,17 por mil habitantes, com 1,50 no SUS e 0,67 não SUS; porém, os leitos de UTI apresentaram aumento, atingindo 2,84 por 10 mil habitantes, com 1,44 no SUS e 1,40 não SUS (Tabela 1).

Tabela 1 – Número de leitos hospitalares totais (por mil habitantes) e de leitos de UTI (por 10 mil habitantes), segundo as categorias leitos SUS e não SUS. Brasil, 2018 a 2022

Leitos hospitalares	2018		2019		2020		2021		2022	
	Leitos	Leitos de UTI	Leitos	Leitos de UTI	Leitos	Leitos de UTI	Leitos	Leitos de UTI	Leitos	Leitos de UTI
Leitos SUS	1,49	1,05	1,46	1,08	1,56	1,12	1,53	1,11	1,50	1,44
Leitos não SUS	0,68	1,11	0,67	1,13	0,65	1,16	0,66	1,21	0,67	1,40
Total de leitos	2,17	2,15	2,12	2,20	2,21	2,27	2,19	2,32	2,17	2,84

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 854, de 22 de agosto de 2012. Altera na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde os seguintes atributos dos procedimentos a seguir especificados, a partir da competência Outubro de 2012 [Internet]. Brasília; ago 22, 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/sas/Links%20finalizados%20SAS%202012/prt0854_22_08_2012.html
2. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 4.226, de 31 de dezembro de 2024. Dispõe sobre o procedimento para desmobilização e pagamentos de leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto e Pediátrico COVID-19 autorizados, em caráter excepcional e temporário, para o atendimento exclusivo de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave SRAC/COVID-19. [Internet]. Ministério da Saúde. 2021 [citado 29 de maio de 2025]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt4226_31_12_2021.html
3. Ministério da Saúde. Padronização da nomenclatura do censo hospitalar [Internet]. 2.ed. revista. Brasília; 2002 [citado 29 de maio de 2025]. 1–32 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/padronizacao_censo.pdf
4. Ministério da Saúde. Principais Conceitos – CNES [Internet]. Ministério da Saúde. [citado 29 de maio de 2025]. Disponível em: https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/Principais_Conceitos
5. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 [Internet]. Senado Federal; out 5, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
6. Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. [Internet]. Brasília; set 19, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm
7. Ministério da Saúde (BR). Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde [Internet]. DATASUS. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>
8. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>

9. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>
10. Ministério da Saúde. Nascidos Vivos – desde 1994 [Internet]. DATASUS. [citado 1º de abril de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.2.01 – Leitos hospitalares por população [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 6p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18272967



Recursos



REC.2.02 – Distribuição proporcional de leitos hospitalares segundo natureza jurídica

REC.2.02 – Proportional distribution of hospital beds by legal status

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Distribuição percentual de leitos hospitalares, classificados de acordo com a natureza jurídica do estabelecimento hospitalar, em um local e ano de referência.
- Leitos hospitalares são espaços destinados ao atendimento em saúde de pacientes internados em hospitais ou unidades de saúde¹. Eles podem ser distribuídos em estabelecimentos de natureza jurídica dos tipos descritos a seguir².
 - › Estabelecimentos públicos: Aqueles pertencentes ao setor público, mantidos e administrados por órgãos governamentais ou por meio de empresas públicas e sociedades de economia mista.
 - › Estabelecimentos privados sem fins lucrativos: Aqueles que prestam serviços sem objetivo de lucro, geralmente administrados por entidades privadas, como fundações, associações ou organizações filantrópicas.
 - › Estabelecimentos privados: Aqueles administrados por empresas ou pessoas físicas com o objetivo de gerar lucro.
- São considerados leitos hospitalares os leitos públicos ou privados, vinculados ou não ao Sistema Único de Saúde (SUS), dos estabelecimentos de saúde incluídos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). São excluídos os leitos de acolhimento noturno³, reabilitação³, suporte ventilatório pulmonar⁴ e unidade de terapia intensiva (UTI) específica para COVID-19⁴.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa a composição relativa dos leitos hospitalares segundo a natureza jurídica dos estabelecimentos, permitindo identificar o perfil jurídico da rede hospitalar em determinado território.
- É influenciado pelas tendências do modelo assistencial, assim como pela dinâmica de abertura e fechamento de leitos nos estabelecimentos de saúde.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais da oferta de leitos hospitalares, segundo a natureza jurídica, identificando-se situações de desigualdades e tendências que demandem ações e estudos específicos.

- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar de responsabilidade do SUS.

LIMITAÇÕES

- Não há padrões nacionais ou internacionais para comparações, pois a distribuição de leitos varia conforme fatores locais, como a natureza jurídica dos hospitais, a estrutura de saúde, a gestão e as necessidades específicas de cada região.
- Os estabelecimentos e leitos registrados no CNES podem apresentar inconsistências, devido à falta de atualização quando ocorrem alterações no quantitativo de leitos existentes ou disponíveis. Ressalta-se que o cadastramento, a manutenção e a atualização das informações sobre os estabelecimentos de saúde no CNES são atribuições dos gestores locais desses estabelecimentos.

FONTE DE DADOS

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de leitos hospitalares disponíveis, segundo a natureza jurídica dos estabelecimentos hospitalares, em um local e ano de referência}}{\text{Número de leitos hospitalares disponíveis, em um local e ano de referência}} \times 100$$

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Número de leitos hospitalares disponíveis, segundo a natureza jurídica dos estabelecimentos hospitalares, em um local e ano de referência. Deve-se contabilizar o número total de leitos ativos (SUS ou não SUS) conforme a categoria jurídica selecionada (sem fins lucrativos, público ou privado), em um local e ano de referência. Para quantificar o número de leitos, considera-se a competência de julho de cada ano.
- **Denominador:** Número de leitos hospitalares disponíveis, em um local e ano de referência. Para cada local e ano de referência, é necessário somar a quantidade total de leitos disponíveis, abrangendo todas as categorias. Para quantificar o número de leitos, considera-se a competência de julho de cada ano.
- **Multiplicador:** 100.

Nota:

- Leitos excluídos do cálculo do indicador: (i) Leitos de reabilitação e acolhimento noturno³, considerados ambulatoriais pelo SUS, não de internação; e (ii) Leitos de UTI COVID-19 e suporte ventilatório⁴, que, criados temporariamente durante a pandemia, não integram mais o rol oficial de leitos do SUS.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Tipo de vínculo:

- SUS; e
- Não SUS.

Tipo de leito:

- Leitos totais;
- Leitos de UTI neonatal;
- Leitos de UTI pediátrica;
- Leitos de UTI adulto;
- Leitos de UTI de queimados;
- Leitos de UTI coronariana;
- Leitos de UCI neonatal;
- Leitos de UCI pediátrica;
- Leitos de UCI adulto;
- Leitos de UCI de queimados; e
- Leitos de UCI coronariana.

Notas:

- Leitos totais são todos os leitos considerados no indicador, inclusive os de UTI, exceto os seguintes códigos:
- Código 48: Reabilitação;
- Código 51: UTI II Adulto - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - COVID-19;
- Código 52: UTI II Pediátrica - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - COVID-19;
- Código 84: Acolhimento noturno; e
- Código 96: Suporte ventilatório pulmonar - COVID-19.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Sistemas de Informação do Departamento de Regulação Assistencial e Controle da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (CGSI/DRAC/SAES/MS).

NOTAS

- A partir de 2012, as classificações de tipo de prestador e natureza jurídica foram enquadradas em uma única categorização, seguindo a tabela padrão brasileira. Com isso, o tipo de prestador foi incorporado à classificação por natureza jurídica².
- Para o cálculo desse indicador, em função de características específicas, foram excluídos os tipos de leitos elencados a seguir.
 - › Leitos de reabilitação: no âmbito do SUS, esses leitos não são considerados de internação. São leitos que compõem unidades ambulatoriais³.
 - › Leitos de acolhimento noturno: no âmbito do SUS, esses leitos não são considerados de internação. São leitos que compõem unidades ambulatoriais da Rede de Atenção Psicossocial, conforme Portaria GM nº 854, de 22 de agosto de 2012³.
 - › Leitos de UTI COVID-19: leitos criados temporariamente para atender à demanda decorrente da pandemia de COVID-19, que, contudo, não fazem mais parte do rol de leitos de UTI do

SUS⁴.

- › Leitos de suporte ventilatório: leitos criados temporariamente para atender aos casos com necessidade de suporte ventilatório, não invasivo e invasivo, decorrente da pandemia de COVID-19⁴, e que foram redirecionados para a atenção pediátrica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A distribuição percentual dos leitos hospitalares disponíveis no SUS demonstra que a maior parte está concentrada no setor público, com valores variando entre 36,36%, em 2018, e um pico de 38,65%, em 2020, seguido por uma leve redução para 37,48% em 2022.

Os leitos privados sem fins lucrativos mantêm uma participação relativamente estável, oscilando entre 25,53% e 26,35% ao longo dos anos. Por seu turno, os leitos privados com fins lucrativos representam a menor parcela dentro do SUS, variando entre 4,86%, em 2019, e 5,57%, em 2018, com pequenas oscilações nos demais anos. Entre os leitos não disponíveis para o SUS, a maior participação está no setor privado com fins lucrativos, variando de 17,85%, em 2020, a 18,97%, em 2022, sem grandes mudanças estruturais.

O setor público apresenta os menores percentuais nessa categoria, oscilando entre 1,85%, em 2020, e 2,29%, em 2022, com um leve crescimento na participação desse segmento no último ano analisado. Por sua vez, os leitos privados sem fins lucrativos flutuam entre 10,59%, em 2021, e 11,72% em 2019 (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição (%) de leitos hospitalares, segundo tipo de estabelecimento e natureza jurídica. Brasil, 2018 a 2022

Ano	Leitos SUS			Leitos não SUS		
	Privado	Público	Sem fins lucrativos	Privado	Público	Sem fins lucrativos
2018	5,57	36,36	25,82	18,82	2,03	11,40
2019	4,86	36,40	26,35	18,77	1,90	11,72
2020	4,97	38,65	25,74	17,85	1,85	10,95
2021	5,11	37,80	25,76	18,85	1,89	10,59
2022	4,88	37,48	25,53	18,97	2,29	10,83

Notas:

- Leito SUS privado: leito existente em estabelecimento de natureza jurídica privada, com contrato ou convênio com o SUS. Exemplo: hospital particular conveniado à prefeitura para internações via SUS.
- Leito SUS sem fins lucrativos: leito existente em estabelecimento de natureza jurídica sem fins lucrativos, com contrato ou convênio com o SUS. Exemplo: hospital filantrópico contratado pelo SUS para atendimentos ambulatoriais e internações.
- Leito SUS público: leito existente em estabelecimento de natureza jurídica pública, que oferta serviços ao SUS. Exemplo: hospital municipal gerido diretamente pela secretaria de saúde.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Padronização da nomenclatura do censo hospitalar [Internet]. 2.ed. revista. Brasília; 2002 [citado 29 de maio de 2025]. 1–32 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/padronizacao_censo.pdf

2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Concla: Comissão Nacional de Classificação – Natureza Jurídica [Internet]. [citado 2 de junho de 2025]. Disponível em: <https://concla.ibge.gov.br/estrutura/natjur-estrutura.html>
3. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 854, de 22 de agosto de 2012. Altera na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde os seguintes atributos dos procedimentos a seguir especificados, a partir da competência Outubro de 2012 [Internet]. Brasília; ago 22, 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/sas/Links%20finalizados%20SAS%202012/prt0854_22_08_2012.html
4. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 4.226, de 31 de dezembro de 2024. Dispõe sobre o procedimento para desmobilização e pagamentos de leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto e Pediátrico COVID-19 autorizados, em caráter excepcional e temporário, para o atendimento exclusivo de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave SRAG/COVID-19. [Internet]. Ministério da Saúde. 2021 [citado 29 de maio de 2025]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt4226_31_12_2021.html
5. Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde [Internet]. DATASUS. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.2.02 – Distribuição proporcional de leitos hospitalares segundo natureza jurídica [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18273193





REC.2.03 – Equipamentos de imagem por população

REC.2.03 – Medical imaging equipment per population

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Razão entre o número de equipamentos de imagem em uso e a população, em um local e ano de referência.
- Equipamentos de diagnóstico por imagem são dispositivos e tecnologias utilizados para capturar e visualizar imagens internas do corpo humano, com o objetivo de detecção, diagnóstico e acompanhamento de condições de saúde¹.
- Equipamentos em uso são considerados aqueles incluídos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)².

INTERPRETAÇÃO

- Mede a disponibilidade de equipamentos, segundo a sua localização geográfica.
- É influenciado pelas condições socioeconômicas regionais e, em menor escala, por políticas públicas de atenção à saúde.
- Os parâmetros, definidos pela Portaria GM/MS nº 1.631/2015³, transcrita para os arts. 102 a 106 da Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017⁴, são os descritos abaixo.
 - › Gama-câmara: Não há parâmetros.
 - › Mamógrafo: Os parâmetros disponíveis não permitem o cálculo da necessidade de equipamentos por habitante.
 - › Raio X simples: Não há parâmetros.
 - › Raio X para densitometria óssea: 1 por 166.667 habitantes (ou 0,6 por 100.000 habitantes).
 - › Raio X odontológico: Não há parâmetros.
 - › Raio X com fluoroscopia: Não há parâmetros.
 - › Raio X para hemodinâmica: Não há parâmetros.
 - › Ressonância magnética: 30 por 1.000 habitantes (ou 3.000 por 100.000 habitantes).
 - › Tomógrafo: Os parâmetros disponíveis não permitem o cálculo da necessidade de equipamentos por habitante.
 - › PET-CT: 1 para 1,5 milhão de habitantes.
 - › Ultrassom: 150 ultrassonografias por mil habitantes (ou 150 mil por 100 mil habitantes).

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais da oferta da distribuição de equipamentos de imagem em saúde, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas à prestação de serviços de saúde, assim como para aquisição e distribuição de equipamentos de imagem.

LIMITAÇÕES

- Há possibilidade de dupla contagem, principalmente em relação a mamógrafos, que podem ser registrados simultaneamente como simples e como com estereotaxia. Mamógrafos com estereotaxia permitem punção localizada e precisa com coleta de material para biópsia.
- Há limitações decorrentes do uso da base de dados demográfica para estimar o número de habitantes, pois podem ocorrer imprecisões na coleta de dados ou na metodologia de elaboração das estimativas.

FONTES DE DADOS

- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)⁵.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁶.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁷.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Número de equipamentos de imagem em uso, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente, em um local e ano de referência}} \times 100.000$$

Nota:

- Para quantificar o número de equipamentos do indicador, considera-se a competência de julho de cada ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Número de equipamentos de imagens em uso, em um local e ano de referência. Contabiliza o total de equipamentos de imagem em uso, por categoria e esfera administrativa, em um local e ano de referência. Para quantificar o número de equipamentos, considera-se a competência de julho de cada ano.
- Denominador: População total residente, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.000.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Categoria do equipamento:

- Gama-câmara;
- Mamógrafo;
- Raio X simples;
- Raio X odontológico;
- Raio X com fluoroscopia;
- Raio X para densitometria óssea;
- Raio X para hemodinâmica;
- Tomógrafo;
- Ressonância magnética;
- Ultrassom; e
- PET-CT.

Esfera administrativa:

- Pública; e
- Privada

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Sistemas de Informação do Departamento de Regulação Assistencial e Controle da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (CGSI/DRAC/SAES/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Entre 2018 e 2022, observou-se um aumento no número de equipamentos de imagem por 100 mil habitantes no Brasil, na maioria das categorias analisadas.

Destacam-se os maiores crescimentos relativos no período: PET-CT, com aumento de 100%, seguido por tomógrafo (37,6%), ressonância magnética (30,3%) e ultrassom (29,0%). Apesar de apresentarem valores absolutos mais baixos, esses equipamentos refletem forte expansão proporcional.

Durante o período analisado, verificou-se que o ultrassom apresentou os maiores valores absolutos, de 18,62 para 24,02 por 100 mil habitantes; o tomógrafo evoluiu de 2,21 para 3,04; e a ressonância magnética, de 1,19 para 1,55. O raio X simples manteve uma tendência de alta moderada, e o raio X odontológico, apesar de uma queda em 2020, voltou a crescer, com variação relativa de -0,2% no total do período. A gama-câmara apresentou queda de 15,2% entre 2018 e 2023, seguida de relativa estabilidade (Tabela 1).

Tabela 1 – Número de equipamentos de imagem, por 100 mil habitantes, segundo a categoria do equipamento. Brasil, 2018 a 2023

Categoria	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gama-câmara	0,46	0,35	0,35	0,36	0,37	0,39
Mamógrafo	2,77	2,79	2,73	2,84	3,03	2,98
PET-CT	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06
Raio X odontológico	23,53	24,25	20,98	22,13	23,00	23,49
Raio X simples	11,18	11,38	11,11	11,52	11,82	11,90
Raio X com fluoroscopia	0,75	0,81	0,81	0,84	0,86	0,86
Raio X para densitometria óssea	1,10	1,13	1,11	1,15	1,20	1,22
Raio X para hemodinâmica	0,43	0,43	0,44	0,46	0,48	0,49
Ressonância magnética	1,19	1,27	1,31	1,41	1,48	1,55
Tomógrafo	2,21	2,34	2,44	2,69	2,89	3,04
Ultrassom	18,62	19,77	19,75	21,43	22,84	24,02

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Manual Técnico do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – Versão 2 [Internet]. DATASUS. 2006 [citado 2 de junho de 2025]. p. 1–162. Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/pages/downloads/documentacao.jsp>
2. Ministério da Saúde. Wiki CNES [Internet]. [citado 2 de junho de 2025]. Disponível em: https://wiki.saude.gov.br/cnes/index.php/P%C3%A1gina_principal
3. Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 1.631/2015, de 1º de outubro de 2015. Aprova critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. [Internet]. Diário Oficial da União. 2015 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1631_01_10_2015.html
4. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017 [Internet]. Diário Oficial da União. 2017 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html
5. Ministério da Saúde (BR). Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde [Internet]. DATASUS. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
7. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025. 8 p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/doi:10.5281/zenodo.17990183>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.2.03 – Equipamentos de imagem por população [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18273313



Recursos



REC.3.01 – Valor médio de referência por atendimento ambulatorial no Sistema Único de Saúde

REC.3.01 – Average reference value per ambulatory care visit in Brazilian public health system

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- É a razão entre a soma dos valores monetários registrados para os atendimentos ambulatoriais classificados como de média e alta complexidade e o total de atendimentos dessa natureza, segundo os registros do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Refere-se ao valor médio por atendimento ambulatorial de média e alta complexidade no SUS, em um local e ano de referência.
- Os valores considerados são aqueles definidos na tabela SUS¹, que representa o parâmetro padronizado de remuneração utilizado pelo Ministério da Saúde para fins de registro e pagamento. Esses valores não refletem o custo total do atendimento, pois podem ser complementados por recursos estaduais ou municipais. Assim, o valor médio obtido expressa uma referência do financiamento federal, sem contemplar aportes adicionais locais.

INTERPRETAÇÃO

- Expressa o valor médio processado no Sistema de Informações na prestação de atendimento ambulatorial de média e alta complexidade.
- Variações dos valores médios são devidas à frequência relativa dos tipos de atendimento prestado, que possuem remuneração diferenciada.

USOS

- Analisar as variações geográficas, temporais e entre unidades de prestação de serviços em relação ao valor de referência do atendimento ambulatorial pelo SUS, com o objetivo de identificar discrepâncias que possam necessitar de investigações mais aprofundadas. É relevante destacar que o custo do atendimento ambulatorial pelo SUS pode não corresponder ao valor total despendido, mas apenas aos valores estipulados pela tabela SUS.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas de assistência ambulatorial no âmbito do SUS.

LIMITAÇÕES

- Os procedimentos realizados estão apropriados segundo o local de atendimento, o que não reflete a demanda, principalmente nos procedimentos de alta complexidade.
- A interpretação do indicador requer informações sobre a distribuição dos atendimentos realizados, segundo a classificação adotada para fins de pagamento no SUS.

- A análise dos serviços ambulatoriais prestados requer conhecimento dos fatores que determinam a demanda atendida, como as condições socioeconômicas e epidemiológicas da população-alvo, o modelo assistencial adotado e a disponibilidade de recursos especializados (tecnologias e serviços).
- Os custos são apresentados em reais correntes do ano, sendo necessários ajustes para comparação da série histórica.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Total do valor pago para atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade, no SUS, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade, no SUS, em um local e ano de referência}}$$

Nota:

- O valor total pago é em moeda corrente do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Total do valor pago para atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade realizados no SUS em um local e período de referência. Deve-se contabilizar o valor total das despesas com atendimentos ambulatoriais no SUS, de média ou alta complexidade, em um local e ano de referência.
- Denominador: Número total de atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade realizados no SUS em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Grupo de procedimentos:

- Ações de promoção e prevenção em saúde;
- Procedimentos com finalidade diagnóstica;
- Procedimentos clínicos;
- Procedimentos cirúrgicos;
- Transplantes de órgãos, tecidos e células;
- Medicamentosos;
- Órteses, próteses e materiais especiais; e
- Ações complementares da atenção à saúde.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Sistemas de Informação do Departamento de Regulação Assistencial e Controle da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (CGSI/DRAC/SAES/MS).

NOTA

- Até 2017, os procedimentos da atenção primária à saúde eram amplamente registrados no SIA. A partir de então, esses registros passaram a ser gradualmente transferidos para os sistemas próprios da atenção primária. Apesar disso, ainda há registros de atendimentos da atenção primária no SIA, embora em volume significativamente menor. A maior parte desses atendimentos é de baixa complexidade, sendo pouco expressiva a proporção de procedimentos classificados como de média ou alta complexidade.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Entre 2018 e 2024, o valor médio por atendimento ambulatorial de procedimentos de média e alta complexidade, calculado com base nos valores registrados na tabela SUS, em reais correntes do período de referência, variou entre os diferentes grupos de procedimentos no SUS (Tabela 1).

As ações de promoção e prevenção em saúde apresentaram uma redução no valor médio ao longo dos anos, passando de R\$ 2,91, em 2018, para R\$ 2,87 em 2024.

Os procedimentos cirúrgicos, por outro lado, tiveram um aumento expressivo, saindo de R\$ 74,81, em 2018, para R\$ 102,64, em 2024, com maior crescimento entre 2021 e 2024. Por sua vez, os transplantes de órgãos, tecidos e células apresentaram elevação no valor médio em reais correntes, passando de R\$ 191,99, em 2018, para R\$ 351,19 em 2024.

Tabela 1 – Valor médio (R\$) de atendimento ambulatorial, por grupos de procedimento. Brasil, 2018 a 2024

Categoria	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ações de promoção e prevenção em saúde	2,91	3,18	3,21	2,92	3,17	3,04	2,87
Procedimentos cirúrgicos	74,81	73,09	66,23	79,11	86,37	91,90	102,64
Transplantes de órgãos, tecidos e células	191,99	190,72	195,96	233,79	309,23	354,92	351,19

Nota:

- As variações observadas, ao longo do tempo, baseiam-se em valores nominais, expressos em reais do período de referência. Para análises de séries históricas com maior precisão comparativa, recomenda-se a aplicação de técnicas de atualização monetária.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) – DATASUS [Internet]. [citado 2 de junho de 2025]. Disponível em: <http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>

2. Ministério da Saúde. Produção Ambulatorial (SIA/SUS) – DATASUS [Internet]. DATASUS. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-ambulatorial-sia-sus/>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.3.01 – Valor médio de referência por atendimento ambulatorial no Sistema Único de Saúde [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18273485



Recursos



REC.3.02 – Valor médio de referência por autorização de internação hospitalar

REC.3.02 – Average reference value per hospital admission authorization

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Razão entre a soma dos valores pagos pelo Ministério da Saúde para as internações hospitalares no Sistema Único de saúde (SUS) e o número total de internações hospitalares realizadas no SUS, em um local e ano de referência.
- Corresponde à média dos valores pagos por Autorização de Internação Hospitalar (AIH), de acordo com os valores de referência estipulados na tabela SUS¹, por especialidade, em um local e ano de referência.
- A AIH é um documento administrativo utilizado no SUS para formalizar e registrar a internação de pacientes em unidades hospitalares². É essencial para o controle, acompanhamento e financiamento das internações hospitalares realizadas pelo SUS.
- As internações do SUS referem-se aos atendimentos realizados por pacientes que são atendidos em unidades hospitalares conveniadas ou habilitadas pelo SUS, cujos custos são parcialmente cobertos pelo Ministério da Saúde, com eventuais complementações estaduais ou municipais.

INTERPRETAÇÃO

- Mensura o valor médio de referência dos serviços de atendimento hospitalar por especialidade, com base nas AIHs emitidas.
- É influenciado por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e demográficos que determinam o perfil da demanda hospitalar ao SUS, bem como por políticas públicas de atenção à saúde.

USOS

- Analisar variações geográficas e temporais do gasto médio com internações hospitalares do Ministério da Saúde no SUS por especialidade, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas de assistência médico-hospitalar no âmbito do SUS.

LIMITAÇÕES

- O cálculo do indicador não contempla os valores e quantitativos referentes às AIHs de tipo 5, relativas a procedimentos de longa permanência ou internações prolongadas.

- O indicador é influenciado por variações na frequência relativa dos tipos de atendimento hospitalar prestado, que possuem remuneração diferenciada na classificação adotada para pagamento no SUS.
- Necessita de ajustes para comparação da série histórica, pois os valores pagos são apresentados em reais correntes do ano.
- Os valores utilizados para o cálculo do indicador são os da tabela de procedimentos, não incluindo abonos, fatores de reposição, incentivos e complementações estaduais e municipais.
- Os procedimentos registrados dizem respeito ao local onde a internação foi realizada, o que pode não representar a real demanda dos municípios de origem dos pacientes. Esse aspecto é especialmente relevante no caso dos atendimentos de média e alta complexidade, que são frequentemente ofertados em estabelecimentos de saúde de referência regional ou estadual, conforme os princípios de regionalização e hierarquização do SUS estabelecidos na Constituição Federal de 1988³ e na Lei nº 8.080⁴, de 1990.
- A interpretação do indicador exige conhecimento sobre como os atendimentos são distribuídos nas diferentes classificações de pagamento do SUS.

FONTE DE DADOS

- Sistema de Informações Hospitalares (SIH)⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Valor total pago pelo Ministério da Saúde para hospitalizações (AIH), no SUS, em um local e ano de referência}}{\text{Número total de hospitalizações (AIH), no SUS, em um local e ano de referência}}$$

Nota:

- O valor total pago é expresso em moeda corrente do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Valor total pago pelo Ministério da Saúde para hospitalizações (AIH), no SUS, em um local e ano de referência. Somar o valor total, em moeda corrente do ano, pago pelo Ministério da Saúde referente a todas as AIHs de tipo 1, em um local e ano de referência.
- **Denominador:** Número total de hospitalizações (AIH), no SUS, em um local e ano de referência. Contabilizar a quantidade total de AIHs emitidas de tipo 1 em um local e ano de referência.

Notas:

- Por padrão, sempre se utilizou como internação o número e valores de AIHs do tipo 1.
- AIHs do tipo 1 representam internações gerais, que são o padrão para a contabilização de internações hospitalares.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Especialidade:

- Clínica médica;
- Pediatria;
- Obstetrícia;
- Clínica cirúrgica;
- Psiquiatria;
- Hospital-dia – saúde mental;
- Hospital-dia – outros;
- Tisiologia; e
- Reabilitação e assistência a doentes em cuidados prolongados (crônicos).

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação-Geral de Sistemas de Informação do Departamento de Regulação Assistencial e Controle da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (CGSI/DRAC/SAES/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Entre 2018 e 2024, o valor médio das internações no SUS apresentou variações entre as diferentes especialidades (Tabela 1). A especialidade cirúrgica teve um aumento progressivo até 2021, quando atingiu R\$ 2.229,41, seguido por uma redução em 2022 para R\$ 2.118,57, retomando o crescimento nos anos seguintes e atingindo R\$ 2.491,15 em 2024. A especialidade clínica registrou crescimento até 2021, com pico em R\$ 2.408,10, mas apresentou queda expressiva em 2022, atingindo R\$ 1.415,56, mantendo-se estável nos anos posteriores em torno de R\$ 1.311,25.

As internações de pacientes em reabilitação/crônicos mantiveram valores elevados até 2020 (R\$ 4.841,77), com redução nos anos seguintes, chegando a R\$ 3.329,52 em 2024. Os valores médios das internações obstétricas se mantiveram relativamente estáveis ao longo da série, variando de R\$ 616,25, em 2018, a R\$ 638,03 em 2024. Na especialidade pediátrica, observou-se um aumento até 2020 (R\$ 1.703,98), seguido por reduções em 2021 e 2022, finalizando em R\$ 1.600,12 em 2024.

Tabela 1 – Valor médio (R\$) por AIH, por especialidade de internação. Brasil, 2018 a 2024

Especialidade	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cirúrgica	1.946,63	1.968,47	2.205,86	2.229,41	2.118,57	2.202,52	2.491,15
Clínica	980,96	1.003,02	1.507,03	2.408,10	1.415,56	1.324,49	1.311,25
Reabilitação/Crônicas	4.582,16	4.388,69	4.841,77	4.370,21	4.052,06	3.742,88	3.329,52
Obstétricas	616,25	609,86	618,17	625,76	627,77	631,70	638,03
Pediátricas	1.328,97	1.332,60	1.703,98	1.669,88	1.579,86	1.621,32	1.600,12

Notas:

- Os valores estão expressos em reais correntes de cada ano.
- Para comparações históricas mais precisas, recomenda-se a aplicação de técnicas de atualização monetária.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS [Internet]. [citado 2 de junho de 2025]. Disponível em: <http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>
2. Ministério da Saúde. Wiki SIH [Internet]. [citado 2 de junho de 2025]. Disponível em: https://wiki.saude.gov.br/sih/index.php/P%C3%A1gina_principal
3. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 [Internet]. Brasília: Presidência da República; 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
4. Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. [Internet]. Brasília; set 19, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm
5. Ministério da Saúde. Produção Hospitalar (SIH/SUS) [Internet]. DATASUS. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-hospitalar-sih-sus/>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.3.02 – Valor médio de referência por autorização de internação hospitalar [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18273581



Recursos



REC.3.03 – Gasto em ações e serviços públicos de saúde como percentual do produto interno bruto

REC.3.03 – Public health services and actions expenditure as percentage of GDP

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção do Produto Interno Bruto (PIB) destinada a ações e serviços públicos de saúde (ASPS), em determinado ano de referência.
- O PIB representa o fluxo de novos bens e serviços finais produzidos pelo país em um ano determinado.
- Os gastos em ASPS compreendem as despesas governamentais destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde da população, e podem ser contabilizados para fins da apuração da aplicação mínima obrigatória de cada ente da Federação em saúde.
- Essa obrigatoriedade foi estabelecida no art. 198 da Constituição Federal de 1988¹ e regulamentada pela Lei Complementar nº 141/2012² (LC 141).
- De acordo com o art. 2º da LC 141, despesas com ASPS são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios estabelecidos no art. 7º da Lei nº 8.080/1990, e às seguintes diretrizes: (i) sejam destinadas às ASPS de acesso universal, igualitário e gratuito; (ii) estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da Federação; e (iii) sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população².
- A União deve aplicar, no mínimo, o valor empenhado no exercício anterior, corrigido pela variação nominal do PIB. Os estados devem aplicar, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos estaduais, deduzidas as parcelas transferidas aos respectivos municípios. Os municípios devem aplicar, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos municipais; e o Distrito Federal, por possuir competências tanto de estado quanto de município, deve aplicar, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos estaduais e 15% da arrecadação dos impostos municipais. Adicionalmente, o Distrito Federal deve aplicar 12% da arrecadação dos impostos cuja base não possa ser segregada entre estadual e municipal.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a dimensão do gasto com ASPS das três esferas de governo em relação ao PIB, que é a soma do valor de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país em determinado período.

USOS

- Analisar as variações temporais do gasto com ASPS em relação ao PIB, identificando-se tendências e padrões que demandem ações e estudos específicos, incluindo-se comparações internacionais.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de saúde.

LIMITAÇÕES

- O indicador não representa a eficiência na utilização dos recursos alocados para a saúde, pois mede apenas o volume relativo de recursos, não seus resultados.
- A simples proporção não reflete a qualidade dos serviços de saúde oferecidos nem o impacto dos gastos na saúde da população.
- A proporção não revela como os recursos são distribuídos dentro do setor da saúde ou entre as diferentes regiões e grupos populacionais.
- O indicador pode ser afetado por variações significativas do PIB, sem que haja mudança real no financiamento da saúde.
- Os dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) relativos aos estados, Distrito Federal e municípios são declarados pelos gestores de saúde, enquanto os da União são obtidos diretamente do sistema orçamentário federal. Por se tratar de um sistema declaratório para os entes subnacionais, o SIOPS pode apresentar limitações quanto à consistência e à qualidade de suas informações.

FONTES DE DADOS

- Dados de despesas com ASPS federal: SIGA Brasil³ ou Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi)⁴. Critério: ID uso 6 para despesas com ASPS. Base de cálculo: despesas empenhadas.
- Dados de despesas com ASPS estaduais e municipais: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)⁵. Base de cálculo: despesas empenhadas de receitas próprias.
- Dados do PIB: Sistema de Contas Nacionais (SCN)⁶.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Valor total de despesas empenhadas em ASPS, no SUS, pelas três esferas de governo, em determinado ano de referência}}{\text{Valor total do PIB, em determinado ano de referência}} \times 100$$

Nota:

- O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Valor total de despesas empenhadas em ASPS, no Sistema Único de Saúde (SUS), pelas três esferas de governo, em um local e ano de referência.
- Denominador: Valor total do PIB, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- O PIB nacional é utilizado como padrão para o cálculo do indicador.
- Para análises regionais, podem ser utilizados os PIBs estaduais e municipais, o que permite comparações entre diferentes Unidades da Federação (UFs).
- O PIB pode sofrer revisões posteriores pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que pode impactar o valor do indicador.
- Recomenda-se sempre utilizar a série mais atualizada disponível.
- Para mais informações sobre a metodologia de cálculo do PIB, pode-se consultar a página do IBGE⁶.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Esfera de governo:

- Federal;
- Estadual; e
- Municipal.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação de Avaliação em Economia da Saúde do Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde (CAES/DESID/SCTIE/MS).

NOTAS

- O PIB nacional é utilizado como padrão para o cálculo do indicador. Para análises regionais, podem ser utilizados os PIBs estaduais e municipais, o que permite comparações entre diferentes unidades federativas.
- Para mais informações sobre o conceito e metodologia de cálculo do PIB, pode-se consultar a página do IBGE⁶.
- O PIB pode sofrer revisões posteriores pelo IBGE, o que pode impactar o valor do indicador. Recomenda-se sempre utilizar a série mais atualizada disponível.
- Para os anos de 2022 e 2023, a população utilizada é baseada no Censo 2022; portanto, é utilizada uma estimativa populacional com base no último censo demográfico. Essa estimativa é a mesma empregada por outras instituições para o cálculo populacional.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O gasto total com saúde como percentual do PIB apresentou tendência de crescimento entre 2012 e 2021, com oscilações (Tabela 1). O valor total passou de 3,67%, em 2012, para um pico de 4,48%, em 2020, e 4,39%, em 2021; seguiram-se uma redução para 4,03%, em 2022, e leve recuperação para 4,18%, em 2023.

O gasto federal apresentou variações no período: partiu de 1,66%, em 2012, atingiu seu pico de 2,13%, em 2020, reduziu-se para 1,52%, em 2022, e retornou a 1,67%, em 2023. O gasto estadual mostrou relativa estabilidade, variando entre 0,93% e 1,14%. Por sua vez, o gasto municipal apresentou tendência consistente de crescimento, aumentando gradualmente de 1,08%, em 2012, para 1,40% em 2023.

Tabela 1 – Gasto público (%) com saúde em relação ao PIB, por esfera de governo e total. Brasil, 2012 a 2023

Ano	Federal	Estadual	Municipal	Total
2012	1,66	0,93	1,08	3,67
2013	1,56	0,98	1,12	3,66
2014	1,60	0,99	1,17	3,75
2015	1,68	1,01	1,20	3,89
2016	1,70	1,01	1,25	3,96
2017	1,75	1,04	1,25	4,04
2018	1,68	1,04	1,21	3,92
2019	1,68	1,04	1,24	3,96
2020	2,13	1,07	1,27	4,48
2021	2,00	1,10	1,29	4,39
2022	1,52	1,14	1,37	4,03
2023	1,67	1,11	1,40	4,18

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil [Internet]. Diário Oficial da União. 1988 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
2. Brasil. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal e dá outras providências [Internet]. Diário Oficial da União. 2012 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm
3. Senado Federal. Siga Brasil – Portal do Orçamento [Internet]. Senado Federal. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil>
4. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. SIAFI — Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal [Internet]. Tesouro Nacional. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/siafi>

5. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde [Internet]. Ministério da Saúde. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/siops>
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Contas Nacionais Brasil [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; [citado 18 de fevereiro de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9052-sistema-de-contas-nacionais-brasil.html>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.3.03 – Gasto em ações e serviços públicos de saúde como percentual do produto interno bruto [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18273724



Recursos



REC.3.04 – Gasto em ações e serviços públicos de saúde *per capita*

REC.3.04 – Public health services and actions expenditure per capita

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Gasto com ações e serviços públicos de saúde (ASPS) por habitante, em um local e ano de referência.
- Os gastos em ASPS compreendem as despesas governamentais destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde da população, e podem ser contabilizados para fins da apuração da aplicação mínima obrigatória de cada ente da Federação em saúde.
- Essa obrigatoriedade foi estabelecida no art. 198 da Constituição Federal de 1988¹ e regulamentada pela Lei Complementar nº 141/2012² (LC 141).
- De acordo com o art. 2º da LC 141, despesas com ASPS são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios estabelecidos no art. 7º da Lei nº 8.080/1990, e às seguintes diretrizes: (i) sejam destinadas às ASPS de acesso universal, igualitário e gratuito; (ii) estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da Federação; e (iii) sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população².
- A União deve aplicar, no mínimo, 15% da receita corrente líquida (RCL) do exercício. Os municípios devem aplicar, no mínimo, 15% de seus recursos próprios (receitas de impostos somadas às transferências constitucionais e legais recebidas). Os estados devem aplicar, pelo menos, 12% dos seus recursos próprios; e o Distrito Federal, 15% dos recursos próprios de base municipal e 12% dos recursos próprios de base estadual.
- A RCL é a receita corrente total deduzida de transferências aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios (por determinação constitucional e legal) e de algumas contribuições sociais³.

INTERPRETAÇÃO

- Mede o valor, em moeda corrente, das despesas com ASPS por habitante, permitindo dimensionar o gasto público em saúde em relação ao tamanho da população.

USOS

- Analisar as variações temporais e geográficas do gasto com ASPS por habitante, identificando-se desigualdades regionais e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de saúde.

LIMITAÇÕES

- O valor *per capita* não explicita as desigualdades na distribuição dos gastos de saúde.
- A estrutura etária e o perfil epidemiológico, diferentes entre regiões, podem afetar a comparabilidade do indicador, já que as necessidades de saúde variam conforme estas características populacionais.
- A ausência de correção monetária dificulta comparações ao longo do tempo, sendo necessária a atualização dos valores para análises de séries históricas.
- Os dados, do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) relativos aos estados, Distrito Federal e municípios são declarados pelos gestores de saúde, enquanto os da União são obtidos diretamente do sistema orçamentário federal. Por se tratar de um sistema declaratório para os entes subnacionais, o SIOPS pode apresentar limitações quanto à consistência e à qualidade de suas informações.
- Imprecisões na base de dados demográficos utilizada para estimar o número de habitantes podem afetar o cálculo do indicador.

FONTES DE DADOS

- Dados de despesas com ASPS federal: SIGA Brasil⁴ ou Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi)⁵. Critério: ID uso 6 para despesas com ASPS. Base de cálculo: despesas empenhadas.
- Dados de despesas com ASPS estaduais e municipais: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)⁶. Base de cálculo: despesas empenhadas de receitas próprias.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: Estimativas e projeções⁷.
- Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade⁸.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Valor total de despesas empenhadas em ASPS, no SUS, pelas três esferas de governo, em um local e ano de referência}}{\text{População total, em um local e ano de referência}}$$

Nota:

- O numerador é expresso em reais correntes do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Valor total de despesas empenhadas em ASPS, no Sistema Único de Saúde (SUS), pelas três esferas de governo, em um local e ano de referência.
- Denominador: População total, em um local e ano de referência.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Esfera de governo:

- Federal;
- Estadual; e
- Municipal.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação de Avaliação em Economia da Saúde do Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde (CAES/DESID/SCTIE/MS).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A Tabela 1 apresenta os gastos públicos federais *per capita* com ASPS no Brasil, de 2012 a 2023, em reais correntes. Os dados indicam os montantes investidos pela esfera federal por habitante, em cada ano do período analisado. Por se tratar de valores nominais (não corrigidos pela inflação), não é adequada a comparação direta entre os anos.

Observa-se uma trajetória de crescimento nominal ao longo do período, com destaque para os aumentos significativos em 2020 e 2021, impulsionados pela pandemia de COVID-19.

A redução em 2022 reflete o encerramento de medidas emergenciais e o retorno das restrições fiscais impostas pelo teto de gastos. Em 2023, o gasto atinge o maior valor da série, possivelmente em razão da retomada de políticas públicas e da recomposição orçamentária federal na saúde.

Tabela 1 – Gasto público federal com ASPS *per capita* (R\$). Brasil, 2012 a 2023

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gasto <i>per capita</i>	405,03	416,88	459,35	496,34	523,46	561,66	568,73	596,85	776,51	857,23	726,41	861,54

Notas:

- Os valores estão expressos em reais correntes de cada ano.
- Para comparações históricas mais precisas, recomenda-se a aplicação de técnicas de atualização monetária.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil [Internet]. Diário Oficial da União. 1988 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
2. Brasil. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal e dá outras providências [Internet]. Diário Oficial da União. 2012 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm
3. Congresso Nacional. Termo: Receita Corrente Líquida (RCL) – Glossário de Termos Orçamentários [Internet]. [citado 23 de junho de 2025]. Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-/orcamentario/termo/receita_corrente_liquida_rcl
4. Senado Federal. Siga Brasil – Portal do Orçamento [Internet]. Senado Federal. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrazil>
5. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. SIAFI — Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal [Internet]. Tesouro Nacional. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/siafi>
6. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde [Internet]. Ministério da Saúde. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/siops>
7. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População [Internet]. IBGE. 2024 [citado 20 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
8. Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Estimativas populacionais dos municípios desagregadas por sexo e idade para o período 2000-2024 [Internet]. DATASUS. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popsvs2024br.def>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.3.04 – Gasto em ações e serviços públicos de saúde *per capita* [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18273939



Recursos



REC.4.01 – Despesa com saúde autorreferida como proporção da renda familiar

REC.4.01 – Health expenditure as share of household income

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual da renda familiar mensal despendida em gastos com saúde, ambos autorreferidos, em um local e ano de referência.
- Os gastos com saúde incluem despesas com planos de saúde, consultas, medicamentos, tratamentos, exames e outros serviços de assistência à saúde.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a dimensão do gasto familiar com saúde em relação ao total da renda familiar, indicando o comprometimento da renda com despesas em saúde.
- Está associado a diversos fatores, como: nível de renda familiar, perfil de morbidade da população, composição etária familiar, cobertura e qualidade dos serviços públicos de saúde.
- Valores elevados podem indicar situações de vulnerabilidade socioeconômica e/ou insuficiência na oferta de serviços públicos de saúde.

USOS

- Avaliar o impacto das despesas com saúde no orçamento familiar.
- Analisar variações geográficas e temporais na proporção da renda comprometida com gastos em saúde, identificando desigualdades regionais e socioeconômicas.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de saúde e de proteção social.

LIMITAÇÕES

- O indicador depende da autorreferência dos participantes sobre suas despesas com saúde e renda, o que pode introduzir vieses de sub ou superestimação.
- O indicador não reflete necessariamente a qualidade ou acessibilidade dos serviços de saúde utilizados pelas famílias.
- Não permite identificar situações em que as famílias deixam de realizar gastos necessários com saúde por restrições orçamentárias.
- A periodicidade irregular da fonte de dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)¹ limita o acompanhamento sistemático das mudanças no padrão de gastos familiares com saúde.

FONTE DE DADOS

- Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Valor médio mensal da despesa familiar autorreferida com saúde, em um local e ano de referência}}{\text{Valor médio da renda familiar total autorreferida, em um local e ano de referência}} \times 100$$

Notas:

- O numerador e o denominador são em reais correntes do ano.
- A renda disponível familiar média mensal exclui impostos e contribuições.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Soma da despesa autorreferida com saúde das famílias (média mensal), incluindo medicamentos, planos e seguros de saúde e outros gastos com assistência à saúde.
- Denominador: Renda total das famílias (média mensal), excluindo impostos e contribuições.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- A partir da POF 2017-2018, passaram a ser considerados também os serviços não monetários de saúde, como atendimentos realizados no Sistema Único de Saúde (SUS) ou procedimentos pagos por terceiros. Informações sobre a POF podem ser obtidas na página do IBGE¹.
- Para fins de comparabilidade com anos anteriores, não incluímos os serviços não monetários com saúde.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Renda domiciliar *per capita*:

- Até ¼ do salário mínimo;
- Mais de ¼ até ½ salário mínimo;
- Mais de ½ até um salário mínimo;
- Mais de 1 até 2 salários mínimos;
- Mais de 2 até 5 salários mínimos; e
- Mais de 5 salários mínimos.

Item de despesa com assistência à saúde:

- Medicamentos;
- Planos e seguros; e
- Outros.

GRANULARIDADE

- Unidade da Federação.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DPE/IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Em 2008, a despesa média mensal com saúde foi de R\$ 153,81 – enquanto a renda total familiar média mensal alcançou R\$ 2.763,53 –, correspondendo a 5,6% da renda destinada a gastos em saúde. Em 2018, a despesa média mensal com saúde foi de R\$ 302,06, enquanto a renda média mensal foi de R\$ 5.426,70. Observa-se, assim, que o indicador permaneceu estável em 5,6%, apresentando crescimento proporcional entre a despesa com saúde e a renda familiar no período analisado (Tabela 1).

Tabela 1 – Despesa (R\$) com saúde autorreferida como proporção da renda familiar. Brasil, 2008 e 2018

Ano	Despesa média mensal das famílias com saúde	Renda total familiar média mensal	Indicador %
2008	153,81	2.763,53	5,6
2018	302,06	5.426,70	5,6

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. POF - Pesquisa de Orçamento Familiar. O que é? [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-2.html?=&t=o-que-e>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. POF - Pesquisa de Orçamento Familiar [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-2.html?=&t=microdados>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.4.01 – Despesa com saúde autorreferida como proporção da renda familiar [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 3p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18495788



Recursos



REC.4.02 – Despesa com saúde estimada como proporção da renda familiar

REC.4.02 – Estimated household expenditure on health as a percentage of household income

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Proporção da renda disponível bruta das famílias destinada ao gasto com bens e serviços de saúde, em um local e ano de referência.
- O indicador é calculado com base na metodologia da Conta-Satélite de Saúde (CSS)¹ do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que segue os princípios do Sistema de Contas Nacionais (SCN), mas com adaptações específicas para o setor da saúde.
- A renda disponível bruta das famílias considera os rendimentos recebidos (como salários, aposentadorias, transferências sociais, lucros e dividendos), descontadas as transferências líquidas pagas, como impostos e contribuições.

INTERPRETAÇÃO

- Mede a proporção da renda disponível bruta das famílias gasta com o consumo de bens e serviços de saúde, indicando o comprometimento da renda familiar com despesas em saúde.
- Valores elevados deste indicador podem estar relacionados a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico, à insuficiência na oferta de serviços públicos de saúde e aos custos dos serviços privados de saúde.

USOS

- Analisar o peso das despesas com saúde na renda disponível bruta das famílias e a evolução desse percentual ao longo do tempo.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de saúde.

LIMITAÇÕES

- Os dados sobre despesas de consumo final e renda disponível bruta estão em valores correntes de cada ano.

FONTE DE DADOS

- Conta-Satélite de Saúde (CSS)².

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Despesa de consumo final das famílias com bens e serviços de saúde, em um local e ano de referência}}{\text{Renda nacional disponível bruta}} \times 100$$

Nota:

- O numerador e o denominar são expressos em reais correntes do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Soma das despesas de consumo final de bens e serviços de saúde das famílias.
- Denominador: Renda disponível bruta das famílias, que corresponde à renda recebida (salários, dividendos, benefícios sociais) deduzidas as transferências líquidas pagas (impostos, contribuições).
- Multiplicador: 100.

Notas:

- O cálculo segue a metodologia padronizada do SCN, operacionalizada pelo IBGE, conforme descrito na documentação técnica e na nota técnica específica sobre a CSS³⁻⁵.
- O conceito de despesa de consumo final de bens e serviços de saúde utilizado neste indicador segue a metodologia da CSS, conforme documentação técnica do IBGE.
- A CSS não possui periodicidade definida. Sua publicação depende do cronograma estabelecido pelo IBGE e está vinculada à divulgação do SCN.
- Os dados disponíveis mais recentes devem ser consultados diretamente nas publicações do IBGE.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação de Contas Nacionais da Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (CONAC/DPE/IBGE).

NOTA

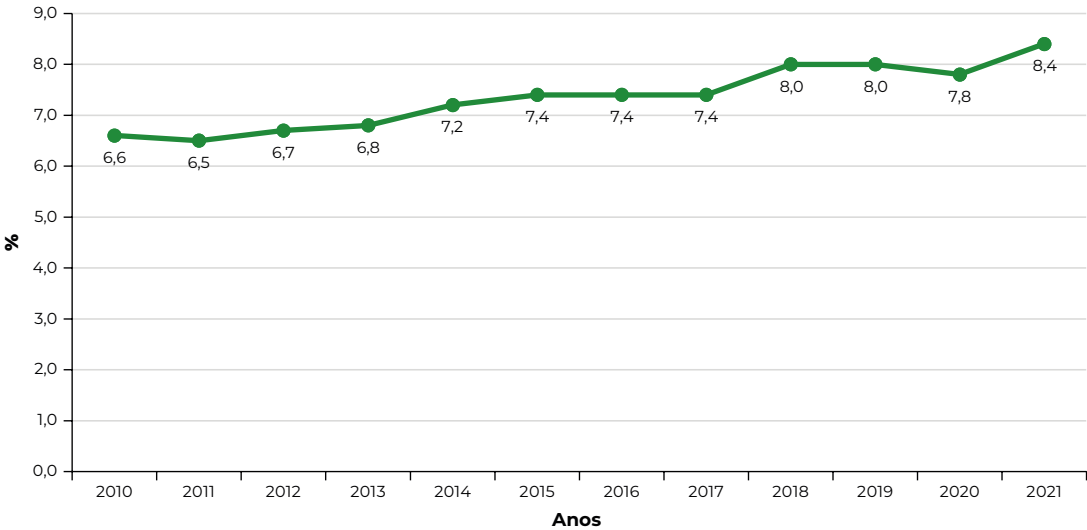
- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A despesa familiar com saúde, estimada como proporção da renda familiar, apresentou tendência geral de crescimento entre 2010 e 2021. O indicador iniciou a série em 6,6% (2010), teve uma pequena queda para 6,5%, em 2011, e depois cresceu gradualmente, até atingir 7,4% em 2015.

Observou-se um período de estabilidade entre 2015 e 2017, mantendo-se em 7,4%. Em 2018, houve um aumento para 8,0%, valor que se manteve em 2019. Após uma leve queda para 7,8%, em 2020, o indicador atingiu seu valor máximo em 2021, chegando a 8,4% da renda familiar (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Despesa familiar estimada com saúde como proporção de renda familiar (%). Brasil, 2010 a 2021



REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Contas Nacionais: Brasil 2022 – Notas técnicas. IBGE [Internet]. 2024 [citado 27 de março de 2025]; Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102128>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conta-Satélite de Saúde – Tabelas [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9056-conta-satelite-de-saude.html>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conta-Satélite de Saúde – Sobre [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9056-conta-satelite-de-saude.html?=&t=sobre>
4. United Nations. System of National Accounts 2008 [Internet]. European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank. 2009 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Contas Nacionais. Conta-Satélite de Saúde: Brasil 2010-2021. IBGE [Internet]. 2024 [citado 27 de março de 2025];(97). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102075_notas_tecnicas.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.4.02 – Despesa com saúde estimada como proporção da renda familiar [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18274017



Recursos



REC.4.03 – Gasto nacional com saúde como percentual do produto interno bruto

REC.4.03 – Nacional health expenditure as percentage of gross domestic product

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Corresponde à razão entre o total das despesas de consumo final de bens e serviços de saúde realizadas por todas as fontes de financiamento (governo, famílias, empresas e instituições sem fins lucrativos) e o valor do Produto Interno Bruto (PIB), expressa em percentual.
- O PIB representa o fluxo de novos bens e serviços finais produzidos pelo país em um ano determinado.
- A despesa de consumo final de bens e serviços de saúde diz respeito ao gasto realizado com serviços, tais como consultas médicas e exames, e bens, como medicamentos e produtos para a saúde.
- Os dados são baseados no Sistema de Contas Nacionais (SCN)¹, que fornece metodologia padronizada internacionalmente para medir a atividade econômica.
- O SCN possibilita que se selecione um setor-chave, como o da saúde, para um olhar mais detalhado sobre sua atividade econômica, o que é chamado de conta-satélite, neste caso específico, Conta-Satélite de Saúde (CSS)².
- A CSS permite a análise específica do setor, detalhando gastos por segmentos institucionais (famílias, governo e instituições sem fins lucrativos).
- Sob a ótica do SCN, o gasto público corresponde à despesa de consumo final do governo, e o gasto privado, à despesa de consumo final das famílias e das instituições sem fins lucrativos.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a proporção do PIB destinada ao consumo de bens e serviços de saúde, incluindo-se gastos públicos (governo) e privados (famílias e instituições sem fins lucrativos), refletindo o esforço total da sociedade no financiamento da saúde.

USOS

- Monitorar a evolução dos gastos nacionais com saúde em relação ao desempenho econômico do país, identificando-se variações temporais que possam sinalizar mudanças estruturais ou conjunturais e demandar estudos ou intervenções específicas.
- Analisar o peso relativo do consumo de bens e serviços de saúde na economia nacional, permitindo a compreensão da importância do setor da saúde na composição do PIB.

- Examinar a estrutura do financiamento da saúde, distinguindo a participação das fontes públicas e privadas no total do gasto nacional no setor.
- Apoiar o planejamento, a gestão, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas de saúde, fornecendo subsídios para a formulação de estratégias baseadas na relação entre os investimentos em saúde e a capacidade econômica do país.

LIMITAÇÕES

- O indicador não inclui o consumo de serviços de saúde de hospitais universitários públicos estaduais e municipais e nem os serviços de saúde de órgãos vinculados às secretarias de segurança pública e defesa civil, como o sistema penitenciário, órgãos de defesa civil e órgãos policiais civis e militares.
- O indicador pode apresentar variações decorrentes de mudanças no PIB, mesmo quando o consumo em saúde permanece estável, o que afeta sua interpretação temporal.
- Por ser um indicador agregado, não reflete desigualdades na distribuição dos gastos entre diferentes grupos populacionais ou regiões.
- A defasagem dos dados é uma limitação relevante, uma vez que a CSS não possui periodicidade regular e sua publicação depende do cronograma do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que pode comprometer a atualidade das análises.
- O uso do método de retropolação para estimar valores em anos anteriores à publicação da conta-satélite pode introduzir incertezas, pois baseia-se em hipóteses e aproximações que nem sempre refletem com precisão as variações reais do gasto em saúde. Essa abordagem pode afetar a comparabilidade temporal e a confiabilidade dos resultados para séries históricas.

FONTE DE DADOS

- Retropolação da série de consumo final de bens e serviços de saúde em Conta-Satélite de Saúde (CSS)³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Despesa de consumo final de bens e serviços de saúde, em um local e ano de referência}}{\text{Valor do PIB, em um local e ano de referência}} \times 100$$

Nota:

- O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Despesa de consumo final de bens e serviços de saúde, em um local e ano de referência.
- Denominador: Valor do PIB, em um local e ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- O cálculo segue a metodologia padronizada do SCN, operacionalizada pelo IBGE, que também é utilizada na produção da CSS. Para detalhamento completo, deve-se consultar o documento orientador⁴.
- Os procedimentos específicos para elaboração da CSS estão descritos na nota técnica do IBGE⁵.
- Para mais informações sobre o conceito e metodologia de cálculo do PIB, pode-se consultar a página do IBGE⁶.
- O conceito de despesa de consumo final de bens e serviços de saúde está detalhado na nota técnica da CSS⁵.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE**Sector:**

- Consumo final de bens e serviços de saúde do governo; e
- Consumo final de bens e serviços de saúde privado (das famílias e das instituições sem fins lucrativos [ISFL] a serviço das famílias).

GRANULARIDADE

- Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação de Contas Nacionais da Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (CONAC/DPE/IBGE).

NOTA

- A periodicidade irregular da CSS resulta em defasagem dos dados disponíveis, o que limita seu uso em análises de curto prazo ou no acompanhamento contínuo de políticas públicas.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Em 2021, as famílias e as ISFL foram responsáveis por 58,4% (5,7% do PIB) das despesas com o consumo final de bens e serviços de saúde no país. A administração pública respondeu por 41,6% (4,0% do PIB) desse total. Entre 2017 e 2021, a despesa das famílias e das ISFL com consumo final de bens e serviços de saúde foi, em média, de 5,7% do PIB, enquanto a do governo foi de 3,9% (Tabela 1).

Tabela 1 – Gasto nacional com saúde do PIB (%), por setor. Brasil, 2017 a 2021

Setor	2017	2018	2019	2020	2021
Governo	3,9	3,8	3,8	4,2	4,0
Famílias e ISFL	5,4	5,7	5,8	5,9	5,7
Total	9,3	9,5	9,6	10,1	9,7

Notas:

- ISFL: instituições sem fins lucrativos. Refere-se a entidades que prestam serviços de saúde sem fins lucrativos, como hospitais e clínicas de organizações não governamentais.
- Os valores apresentados referem-se ao gasto nacional com saúde como percentual do PIB, conforme os dados da CSS, que adota a metodologia do SCN para estimar o consumo final de bens e serviços de saúde, segmentado por setor.
- Os dados consideram tanto o gasto público (governo) quanto o gasto privado (famílias e ISFL).

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Contas Nacionais: Brasil 2022 – Notas técnicas [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102128>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conta-Satélite de Saúde – Sobre [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9056-conta-satelite-de-saude.html?=&t=sobre>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conta-Satélite de Saúde – Tabelas [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9056-conta-satelite-de-saude.html>
4. United Nations. System of National Accounts 2008 [Internet]. European Commission International, Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank. 2009 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Contas Nacionais. Conta-Satélite de Saúde: Brasil 2010-2021. IBGE [Internet]. 2024 [citado 27 de março de 2025];(97). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102075_notas_tecnicas.pdf
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produto Interno Bruto – PIB [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.4.03 – Gasto nacional com saúde como percentual do produto interno bruto [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18274116



Recursos

REC.4.04 – Gasto nacional *per capita* com saúde*REC.4.04 – National health expenditure per capita*

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Valor, em reais correntes, que corresponde ao gasto total (público e privado) com o consumo final de bens e serviços de saúde por habitante, em um local e ano de referência.
- A despesa de consumo final de bens e serviços de saúde diz respeito ao gasto realizado com serviços, tais como consultas médicas e exames, e bens, como medicamentos e produtos para a saúde.
- Os dados são baseados no Sistema de Contas Nacionais (SCN)¹, que fornece metodologia padronizada internacionalmente para medir a atividade econômica.
- O SCN possibilita que se selecione um setor-chave, como o da saúde, para um olhar mais detalhado sobre sua atividade econômica, o que é chamado de conta-satélite, neste caso específico, Conta-Satélite de Saúde (CSS)².
- A CSS permite a análise específica do setor, detalhando gastos por segmentos institucionais (governo, famílias e instituições sem fins lucrativos).

INTERPRETAÇÃO

- Estima o gasto médio por habitante, em reais correntes, com o consumo de bens e serviços de saúde, incluindo-se gastos públicos (governo) e privados (famílias e instituições sem fins lucrativos – ISFL).

USOS

- Analisar variações temporais do consumo de bens e serviços de saúde por habitante, utilizando-se a média populacional como referência.
- Avaliar a distribuição do gasto entre fontes públicas e privadas por habitante, utilizando-se a média populacional como referência.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de saúde.

LIMITAÇÕES

- O indicador não inclui o consumo de serviços de saúde de hospitais universitários públicos estaduais e municipais e nem os serviços de saúde de órgãos vinculados às secretarias de segurança pública e defesa civil, como o sistema penitenciário, órgãos de defesa civil e órgãos policiais civis e militares.

- Imprecisões na base de dados demográficos utilizada para estimar o número de habitantes podem afetar o cálculo do indicador, especialmente em anos intercensitários.
- A ausência de correção monetária dificulta comparações ao longo do tempo, sendo necessária a atualização dos valores para análises de séries históricas.
- O indicador está disponível apenas em nível nacional, o que impede análises desagregadas por Unidades da Federação ou outras subdivisões territoriais, limitando a capacidade de serem avaliadas disparidades regionais no gasto com saúde.

FONTES DE DADOS

- Conta-Satélite de Saúde (CSS)³.
- Projeções da população do Brasil e das Unidades da Federação: estimativas e projeções⁴.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Despesa de consumo final de bens e serviços de saúde, em um local e ano de referência}}{\text{População total residente em um local, ajustada para o meio do ano de referência}}$$

Nota:

- O numerador é expresso em reais correntes do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- **Numerador:** Despesa de consumo final de bens e serviços de saúde (pública e privada), em reais correntes.
- **Denominador:** População total residente em um local, ajustada para o meio do ano de referência.

Notas:

- O cálculo segue a metodologia padronizada do SCN¹, operacionalizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para detalhamento completo, consultar o documento orientador⁵.
- Os procedimentos específicos para elaboração da CSS estão descritos na nota técnica do IBGE⁶.
- O conceito de despesa de consumo final de bens e serviços de saúde está detalhado na nota técnica da CSS².

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Setor:

- Consumo final de bens e serviços de saúde do governo; e
- Consumo final de bens e serviços de saúde privado (das famílias e ISFL a serviço das famílias).

GRANULARIDADE

- Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação de Contas Nacionais da Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (CONAC/DPE/IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Como pode ser observado na Tabela 1, ao longo da série histórica (2010 a 2021), o gasto *per capita* com saúde realizado pelas famílias e pelas ISFL permaneceu superior ao realizado pelo governo. Em valores correntes, observa-se crescimento contínuo dos gastos em ambos os setores. Em 2010, o gasto total *per capita* era de R\$ 1.587,78, alcançando R\$ 4.091,11 em 2021.

No ano de 2021, do total de R\$ 4.091,11 *per capita*, R\$ 2.387,51 (58,4%) corresponderam a gastos privados (famílias e ISFL) e R\$ 1.703,60 (41,6%) a gastos públicos. A distribuição relativa entre os setores também se manteve relativamente estável ao longo do período, com maior participação do setor privado.

Tabela 1 – Gasto nacional (R\$) *per capita* com saúde, por setor e total. Brasil, 2010 a 2021

Ano	Governo	Famílias e ISFL	Total
2010	716,86	870,91	1.587,78
2011	776,31	961,98	1.738,29
2012	832,25	1.088,66	1.920,90
2013	947,00	1.229,89	2.176,89
2014	1.068,94	1.418,07	2.487,01
2015	1.138,38	1.546,31	2.684,69
2016	1.211,87	1.631,44	2.843,32
2017	1.228,60	1.715,51	2.944,11
2018	1.268,33	1.921,78	3.190,11
2019	1.352,34	2.035,56	3.387,91
2020	1.510,10	2.121,37	3.631,47
2021	1.703,60	2.387,51	4.091,11

Notas:

- ISFL: instituições sem fins lucrativos. Refere-se a entidades que prestam serviços de saúde sem fins lucrativos, como hospitais e clínicas de organizações não governamentais.
- Os valores apresentados estão em reais correntes, ou seja, refletem os preços do ano de referência e não estão corrigidos pela inflação. Portanto, as variações, ao longo do tempo, devem ser interpretadas com cautela, pois podem refletir tanto mudanças reais nos gastos, quanto efeitos da inflação.
- É importante destacar que os valores apresentados estão em reais correntes. Assim, parte do crescimento observado, ao longo do período, pode ser nominal, e não necessariamente de aumento real nos gastos com saúde *per capita*.

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Contas Nacionais: Brasil 2022 – Notas técnicas [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102128>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conta-Satélite de Saúde – Sobre [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9056-conta-satelite-de-saude.html?=&t=sobre>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conta-Satélite de Saúde – Tabelas [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9056-conta-satelite-de-saude.html>
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeções da População [Internet]. IBGE. 2024 [citado 20 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
5. United Nations. System of National Accounts 2008 [Internet]. European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank. 2009 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf>
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Contas Nacionais. Conta-Satélite de Saúde: Brasil 2010-2021. IBGE [Internet]. 2024 [citado 27 de março de 2025];(97). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102075_notas_tecnicas.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.4.04 – Gasto nacional *per capita* com saúde [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18274199



Recursos



REC.4.05 – Gasto federal com saúde como percentual do produto interno bruto

REC.4.05 – Federal health expenditure as percentage of gross domestic product

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual do Produto Interno Bruto (PIB) nacional que corresponde ao gasto público federal com saúde em um ano de referência.
- O PIB representa o fluxo de novos bens e serviços finais produzidos pelo país em um período de referência.
- Este indicador é baseado em dados de execução orçamentária da União (governo federal).
- O gasto federal com saúde compreende¹ os itens a seguir especificados.
 - › Gastos diretos: despesa com pessoal, outras despesas correntes e outros gastos diretos (despesas com investimentos e inversões financeiras) efetuados pelo governo federal (administração direta, autarquias e fundações).
 - › Transferências negociadas de recursos a outros níveis de governo (estados e municípios) e a instituições privadas.
 - › Gastos com hospitais universitários, realizados diretamente pelo Sistema Único de Saúde – SUS (Ministério da Saúde) e pelo Ministério da Educação, com residências médicas (nas unidades próprias ou não) e no apoio ao funcionamento dos hospitais de ensino.
- Foram consideradas despesas do Ministério da Saúde as despesas do Ministério da Educação executadas no apoio às residências e ao funcionamento e gestão de hospitais de ensino.
- Excluem-se os gastos com encargos da dívida (juros e amortização), os realizados com inativos e pensionistas do setor da saúde, os gastos com saúde destinados a clientela fechadas, como os realizados por hospitais da estrutura dos ministérios militares, bem como despesas com a assistência médica e odontológica prestada a servidores públicos federais, que são classificadas como benefícios concedidos a estes servidores.
- Excluem-se os gastos com saneamento básico, exceto aqueles diretamente relacionados ao controle de algum vetor específico, como drenagem e manejo ambiental para controle de malária ou dengue.
- Este indicador possui conceito diferente dos indicadores de gasto com ações e serviços públicos de saúde (ASPS) do Ministério da Saúde, pois inclui gastos realizados pelo Ministério da Educação com hospitais universitários.
- O gasto público federal considerado é financiado com recursos de impostos, contribuições sociais, convênios com organismos internacionais e com o setor privado, operações de crédito e outros, considerando-se o estágio de liquidação da despesa.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a dimensão do gasto federal com saúde em relação ao PIB, indicando o esforço do governo federal no financiamento do setor da saúde em relação à capacidade econômica do país.
- Indica a participação relativa dos diferentes componentes do gasto federal com saúde, permitindo análise da distribuição dos recursos entre gastos diretos e transferências.

USOS

- Analisar as variações temporais do gasto público federal com saúde em relação ao PIB, identificando-se situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Avaliar a composição do gasto federal em saúde, analisando-se a distribuição entre gastos diretos (pessoal, despesas correntes e outros) e transferências (estados, municípios e outras).
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de saúde.

LIMITAÇÕES

- O indicador é influenciado por variações do PIB, mesmo que o gasto com saúde se mantenha constante.
- A série de dados de 2009 a 2022 apresenta uma diferença metodológica importante em relação aos dados anteriormente publicados. Entre 2002 e 2011, era prática comum do governo federal realizar o procedimento contábil conhecido como "liquidação forçada", que considerava como liquidadas, ao final do exercício financeiro, as despesas empenhadas que passavam para o ano seguinte como restos a pagar não processados².
- Em anos recentes, o governo federal alterou esse procedimento, com impactos retrospectivos sobre a despesa liquidada. Consequentemente, os valores do indicador serão menores caso sejam recalculados para os anos já disponibilizados pela Ripsa.

FONTES DE DADOS

- Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)³.
- Sistema de Contas Nacionais (SCN)⁴.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Valor total da despesa federal com saúde, correspondente a itens de gasto, em um local e ano de referência}}{\text{Valor do PIB nacional em um local e ano de referência}} \times 100$$

Nota:

- O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Soma das despesas liquidadas pelo Ministério da Saúde e das despesas do Ministério da Educação, executadas nas seguintes ações orçamentárias:
 - › 00P1 – Apoio à Residência em Saúde;
 - › 4005 – Apoio à Residência em Saúde;
 - › 4005 – Apoio à Residência Multiprofissional;
 - › 4086 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino;
 - › 4086 – Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais; e
 - › 6379 – Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais.
- Exclui os gastos com encargos da dívida (juros e amortização), os realizados com inativos e pensionistas do setor da saúde, os gastos com saúde destinados a clientela fechadas, como os realizados por hospitais da estrutura dos ministérios militares, bem como despesas com a assistência médica e odontológica prestada a servidores públicos federais, que são classificadas como benefícios concedidos a estes servidores. Excluem-se, também, os gastos com saneamento básico, exceto aqueles diretamente relacionados ao controle de algum vetor específico, como drenagem e manejo ambiental para controle de malária ou dengue.
- Denominador: Valor corrente do PIB.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Item de gasto:

- Gasto direto com saúde (pessoal);
- Gasto direto com saúde (outras despesas correntes);
- Gasto direto com saúde (outros gastos diretos);
- Transferência a estados e ao Distrito Federal;
- Transferência a municípios; e
- Outras transferências.

GRANULARIDADE

- Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

NOTAS

- Os dados do numerador e do denominador são provenientes de fontes com metodologias distintas. O SIOP utiliza o regime de caixa, no qual as despesas e receitas são registradas no

- momento em que há efetivo pagamento ou recebimento. Esse modelo é típico dos controles orçamentário-financeiros da administração pública.
- Por sua vez, o PIB, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no âmbito do Sistema de Contas Nacionais (SCN), segue o princípio da competência econômica, que considera a geração de bens e serviços e a apropriação de receitas e despesas no período em que ocorrem, independentemente do pagamento ou recebimento.
 - A diferença entre os dois regimes pode gerar desalinhamentos na comparação entre os dados de despesa do governo federal e os agregados macroeconômicos nacionais, especialmente ao se relacionarem indicadores construídos com base no SIOP com variáveis do SCN, como o PIB.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O gasto federal com saúde, como percentual do PIB, apresentou variações no período de 2009 a 2023. Começando em 1,53% do PIB, em 2009, o indicador manteve-se relativamente estável até 2019, oscilando entre 1,44% e 1,60%. Durante a pandemia de COVID-19, observou-se um aumento expressivo do indicador, que atingiu 2,01%, em 2020, e 1,82% em 2021. Após esse período, houve redução para 1,38%, em 2022, com leve recuperação para 1,47% em 2023 (Tabela 1).

As transferências a municípios constituem o principal componente do gasto federal, variando de 0,67% do PIB, em 2009, para 0,81%, em 2023, com pico de 1,08% em 2020. As transferências aos estados e ao Distrito Federal apresentaram tendência de redução, caindo de 0,40%, em 2009, para 0,26% em 2023.

Tabela 1 – Gasto federal com saúde em relação ao PIB (%). Brasil, 2009 a 2023

Ano	Gasto federal com saúde	Gasto direto				Transferências a estados e ao Distrito Federal	Transferências a municípios	Outras transferências
		Total	Pessoal	Outras despesas correntes	Outros gastos diretos			
2009	1,53	0,44	0,24	0,19	0,01	0,40	0,67	0,01
2010	1,48	0,45	0,24	0,19	0,01	0,37	0,66	0,01
2011	1,51	0,48	0,24	0,23	0,01	0,30	0,72	0,01
2012	1,48	0,41	0,17	0,24	0,01	0,32	0,73	0,02
2013	1,44	0,43	0,16	0,27	0,01	0,29	0,69	0,03
2014	1,49	0,45	0,15	0,29	0,01	0,28	0,72	0,05
2015	1,58	0,50	0,15	0,34	0,01	0,28	0,75	0,05
2016	1,60	0,53	0,15	0,37	0,01	0,27	0,75	0,05
2017	1,57	0,50	0,14	0,35	0,01	0,27	0,75	0,05
2018	1,56	0,46	0,13	0,32	0,01	0,27	0,80	0,03
2019	1,57	0,45	0,12	0,33	0,01	0,28	0,82	0,02
2020	2,01	0,49	0,10	0,37	0,02	0,38	1,08	0,05
2021	1,82	0,67	0,08	0,58	0,01	0,28	0,83	0,04
2022	1,38	0,40	0,08	0,32	0,01	0,22	0,72	0,03
2023	1,47	0,36	0,07	0,28	0,00	0,26	0,81	0,04

REFERÊNCIAS

1. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dimensionamento e Acompanhamento do Gasto Social Federal [Internet]. Ipea. 1998 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_0547.pdf
2. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Restos a pagar de despesas com ações e serviços públicos de saúde da União: impactos para o financiamento federal do Sistema Único de Saúde e para a elaboração das contas de saúde [Internet]. Ipea. 2016 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/ef97d8c5-3eaf-4777-9916-dcc592bc3e16/content>
3. Ministério do Planejamento e Orçamento. Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP: dados abertos [Internet]. Ministério do Planejamento. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/doku.php/acesso_publico:dados_abertos
4. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conta-Satélite de Saúde – Tabelas [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9056-conta-satelite-de-saude.html>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.4.05 – Gasto federal com saúde como percentual do produto interno bruto [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18274238



Recursos



REC.4.06 – Gasto federal com saúde como percentual do gasto federal total

REC.4.06 – Federal health expenditure as percentage of total federal expenditure

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual do gasto público federal total que corresponde a despesas com saúde no ano de referência.
- Este indicador é baseado em dados de execução orçamentária da União (governo federal).
- O gasto federal com saúde compreende¹ os itens a seguir especificados.
 - › Gastos diretos: despesa com pessoal, outras despesas correntes e outros gastos diretos (despesas com investimentos e inversões financeiras) efetuados pelo governo federal (administração direta, autarquias e fundações).
 - › Transferências negociadas de recursos a outros níveis de governo (estados e municípios) e a instituições privadas.
 - › Gastos com hospitais universitários, realizados diretamente pelo Sistema Único de Saúde – SUS (Ministério da Saúde) e pelo Ministério da Educação, com residências médicas (nas unidades próprias ou não) e no apoio ao funcionamento dos hospitais de ensino.
- Foram consideradas despesas do Ministério da Saúde as despesas do Ministério da Educação executadas no apoio às residências e ao funcionamento e gestão de hospitais de ensino.
- Excluem-se os gastos com encargos da dívida (juros e amortização), os realizados com inativos e pensionistas do setor da saúde, os gastos com saúde destinados a clientela fechadas, como os realizados por hospitais da estrutura dos ministérios militares, bem como despesas com a assistência médica e odontológica prestada a servidores públicos federais, que são classificadas como benefícios concedidos a estes servidores.
- Excluem-se os gastos com saneamento básico, exceto aqueles diretamente relacionados ao controle de algum vetor específico, como drenagem e manejo ambiental para controle de malária ou dengue.
- As despesas federais podem ser classificadas em: (i) despesas financeiras que são relacionadas ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública; e (ii) despesas não financeiras (ou primárias), que são todas as demais despesas do governo federal, excluindo-se as despesas financeiras.
- Este indicador possui conceito diferente dos indicadores de gasto com ações e serviços públicos de saúde (ASPS) do Ministério da Saúde, pois inclui gastos realizados pelo Ministério da Educação com hospitais universitários.

- O gasto público federal considerado é financiado com recursos de impostos, contribuições sociais, convênios com organismos internacionais e com o setor privado, operações de crédito e outros, considerando-se o estágio de liquidação da despesa.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a dimensão do gasto federal com saúde em relação ao conjunto das despesas realizadas pelo governo federal (fiscais, com seguridade social e de empresas estatais).

USOS

- Analisar variações temporais da distribuição percentual do gasto federal com saúde em relação ao gasto federal total, identificando-se tendências que demandem ações e estudos específicos.
- Delinear a participação do gasto com saúde na composição do gasto público federal.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de saúde.

LIMITAÇÕES

- O indicador é influenciado por variações na composição do gasto federal total, mesmo que o gasto com saúde se mantenha constante.
- A série de dados de 2009 a 2022 apresenta uma diferença metodológica importante em relação aos dados anteriormente publicados. Entre 2002 e 2011, era prática comum do governo federal realizar o procedimento contábil conhecido como "liquidação forçada", que considerava como liquidadas, ao final do exercício financeiro, as despesas empenhadas que passavam para o próximo ano como restos a pagar não processados².
- Em anos recentes, o governo federal alterou esse procedimento, com impactos retrospectivos sobre a despesa liquidada. Consequentemente, os valores do indicador serão menores caso sejam recalculados para os anos já disponibilizados pela Ripsa.
- Os dados estão disponíveis apenas em nível nacional, o que impede análises desagregadas por Unidades da Federação ou outras subdivisões territoriais, limitando a identificação de desigualdades regionais no financiamento federal da saúde.
- A ausência de correção monetária dificulta comparações ao longo do tempo, sendo necessária a atualização dos valores para análises de séries históricas.

FONTE DE DADOS

- Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Valor total da despesa federal com saúde no ano de referência}}{\text{Valor total das despesas federais no ano de referência}} \times 100$$

Nota:

- O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Soma das despesas liquidadas pelo Ministério da Saúde e das despesas do Ministério da Educação, executadas nas seguintes ações orçamentárias:
 - › OOP1 – Apoio à Residência em Saúde;
 - › 4005 – Apoio à Residência em Saúde;
 - › 4005 – Apoio à Residência Multiprofissional;
 - › 4086 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino;
 - › 4086 – Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais; e
 - › 6379 – Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais.
- Exclui os gastos com encargos da dívida (juros e amortização), os realizados com inativos e pensionistas do setor da saúde, os gastos com saúde destinados a clientela fechadas, como os realizados por hospitais da estrutura dos ministérios militares, bem como despesas com a assistência médica e odontológica prestada a servidores públicos federais, que são classificadas como benefícios concedidos a estes servidores. Excluem-se, também, os gastos com saneamento básico, exceto aqueles diretamente relacionados ao controle de algum vetor específico, como drenagem e manejo ambiental para controle de malária ou dengue.
- Denominador: Soma de todas as despesas liquidadas por órgãos da União. No caso do cálculo da proporção em relação às despesas não financeiras, deduzem-se os valores executados na categoria de resultado primário RP 0 – Financeira.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE**Tipo de despesa federal com saúde:**

- Despesa federal total: Soma das despesas financeiras e não financeiras; e
- Despesa federal não financeira (ou primária): Exclui encargos da dívida e inclui apenas as despesas voltadas à prestação de serviços públicos (por exemplo, em saúde, educação e assistência social).

GRANULARIDADE

- Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

NOTA

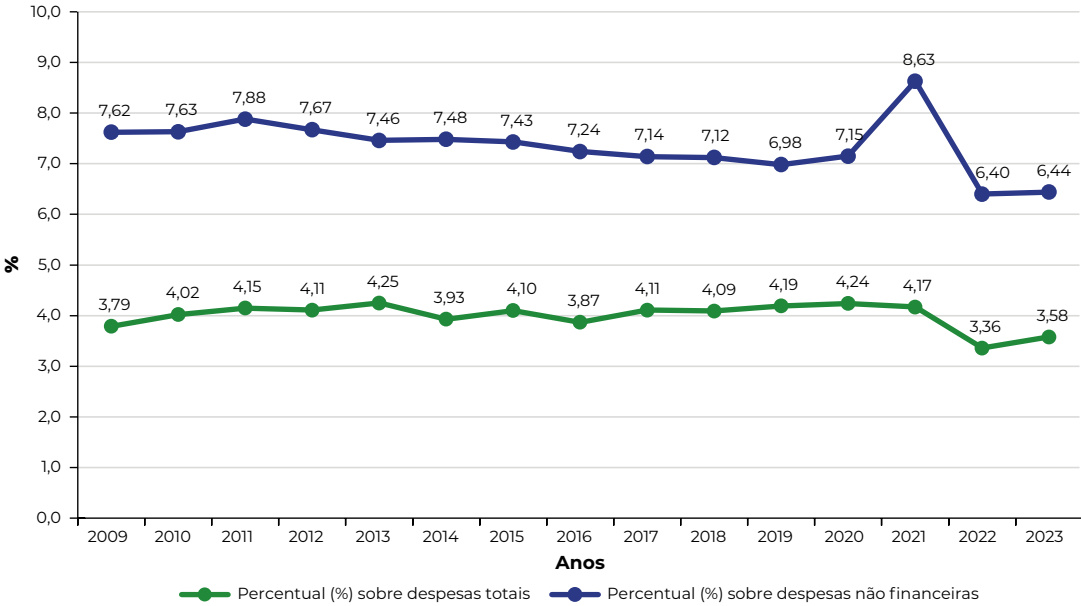
- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Em relação às despesas totais, o percentual diminuiu de 3,79%, em 2009, para 3,58%, em 2023, tendo alcançado seu valor máximo em 2020 (4,24%), durante a pandemia de COVID-19, e seu menor valor em 2022 (3,36%).

Quando o gasto é analisado em relação às despesas não financeiras (excluídas as despesas com juros, encargos e amortização da dívida), observa-se que a redução foi mais acentuada, tendo o percentual passado de 7,62%, em 2009, para 6,44% em 2023. Nesta perspectiva, destaca-se o ano de 2021, quando o percentual atingiu seu pico de 8,63%, seguido de uma queda para 6,40% em 2022 (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Gasto federal com saúde como percentual do gasto federal total, por tipo de despesa federal com saúde. Brasil, 2009 a 2023



REFERÊNCIAS

1. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dimensionamento e Acompanhamento do Gasto Social Federal [Internet]. Ipea. 1998 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_0547.pdf
2. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Restos a pagar de despesas com ações e serviços públicos de saúde da União: impactos para o financiamento federal do Sistema Único de Saúde e para a elaboração das contas de saúde [Internet]. Ipea. 2016 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/ef97d8c5-3eaf-4777-9916-dcc592bc3e16/content>

3. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP: dados abertos [Internet]. Ministério do Planejamento. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/doku.php/acesso_publico:dados_abertos

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.4.06 – Gasto federal com saúde como percentual do gasto federal total [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18274340



Recursos



REC.5.01 – Gasto público com saneamento básico como percentual do produto interno bruto

REC.5.01 – Public expenditure on sanitation as percentage of gross domestic product

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual do Produto Interno Bruto (PIB) que corresponde ao gasto público com saneamento básico, em um local e ano de referência.
- O PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos pelo país durante um ano de referência.
- Segundo o art. 3º da Lei nº 11.445/2007¹, o saneamento básico se refere ao conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais abaixo especificados.
 - › Abastecimento de água potável: Constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição.
 - › Esgotamento sanitário: Constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente.
 - › Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: Constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana.
 - › Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: Constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes.
- Para mais informações sobre os gastos federais com saneamento básico, orçamentários e extraorçamentários, pode-se consultar o artigo *Saneamento básico no Brasil: perfil do investimento público para a universalização e promoção do direito humano à água*².

INTERPRETAÇÃO

- Estima a dimensão do gasto público com saneamento básico no valor total de novos bens e serviços finais produzidos pelo país durante um período, sinalizando o esforço fiscal com saneamento básico realizado nas três esferas de governo.

- Estima a participação relativa de cada esfera de governo no financiamento das ações de saneamento básico

USOS

- Analisar variações temporais do gasto público com saneamento básico em relação ao PIB.
- Analisar o financiamento governamental através da participação de cada esfera de governo nos gastos totais com saneamento básico em relação ao PIB nacional.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de saneamento básico.

LIMITAÇÕES

- Por questões metodológicas, a série de dados a partir de 2013 não é comparável à série até 1997, havendo uma interrupção no levantamento entre 1997 e 2012, o que impossibilita a análise de tendências históricas mais longas.
- O indicador é influenciado por variações do PIB, mesmo que o gasto com saneamento básico se mantenha constante, o que pode afetar sua interpretação.
- O indicador apresenta limitações na cobertura dos gastos³, conforme indicado a seguir
 - › Não inclui gastos tributários com saneamento básico, que são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário, correspondendo a uma perda de arrecadação derivada de um tratamento tributário mais favorável.
 - › Não deduz das despesas municipais as transferências recebidas dos estados.
 - › Pode haver dupla contagem em algumas situações de transferências intergovernamentais.

FONTES DE DADOS

- Dados de despesas para a União: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)⁴.
- Dados de despesas estaduais, distritais e municipais: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi)⁵.
- Dados do PIB: Sistema de Contas Nacionais (SCN)⁶.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Valor total da despesa do setor público com saneamento básico, em um local e ano de referência}}{\text{Valor do PIB, em um local e ano de referência}} \times 100$$

Nota:

- O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

Numerador: No cálculo do gasto público com saneamento básico, foram incluídas despesas liquidadas pelas três esferas de governo, como segue.

- › No caso da União, consideraram-se o orçamento fiscal e o orçamento da seguridade social.
- › Não foram executadas despesas com saneamento básico no orçamento de investimento das empresas estatais no período de 2013 a 2022.
- › Inclui despesas executadas nas seguintes subfunções: 511 – Saneamento básico rural; e 512 – Saneamento básico urbano.
- › Não se utilizou a função 17 – Saneamento básico, porque, ao se considerar apenas esta função, não seriam contabilizados gastos com a subfunção 511 – Saneamento básico rural, registrados em outras funções.
- › No caso dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, foram consideradas as despesas registradas na função 17 – Saneamento.
- **Denominador:** PIB em valores correntes.
- **Multiplicador:** 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Esfera de governo:

- Federal;
- Estadual e distrital; e
- Municipal.

GRANULARIDADE

- Município.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

Os municípios são os principais responsáveis pelos gastos em saneamento básico, mantendo uma participação relativamente estável, em torno de 0,20% do PIB, ao longo do período (Tabela 1).

Os gastos estaduais apresentaram redução, caindo de 0,06%, em 2013, para 0,03%, em 2023, com seu menor patamar (0,02%) entre 2019 e 2021.

A participação da União mostrou-se consistentemente baixa, partindo de 0,02%, em 2013, e chegando a valores próximos a zero em 2022 e 2023.

O menor valor total da série foi observado em 2021 (0,21% do PIB), enquanto os valores mais altos foram registrados no início do período (0,28%, em 2013, e 0,27% em 2014). Nos últimos anos, o indicador tem se estabilizado em 0,25% do PIB, sustentado principalmente pelos gastos municipais.

Tabela 1 – Gasto público com saneamento básico em relação ao PIB (%).
União, estados e Distrito Federal, e municípios, 2013 a 2023

Ano	União	Estados e Distrito Federal	Municípios	Total
2013	0,02	0,06	0,20	0,28
2014	0,01	0,07	0,18	0,27
2015	0,01	0,05	0,19	0,25
2016	0,01	0,04	0,19	0,25
2017	0,02	0,04	0,17	0,23
2018	0,01	0,04	0,18	0,24
2019	0,01	0,02	0,20	0,23
2020	0,01	0,02	0,20	0,24
2021	0,01	0,02	0,18	0,21
2022	0,00	0,04	0,20	0,25
2023	0,00	0,03	0,21	0,25

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências [Internet]. Diário Oficial da União. 2007 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
2. Capobianco JPR, Santos GR dos, Checco GB, Mendes AT. Saneamento básico no Brasil: perfil do investimento público para a universalização e promoção do direito humano à água. Bol Reg Urbano Ambient [Internet]. 2023 [citado 27 de março de 2025];29:25–33. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.38116/brua29art2>
3. Senado Federal. Instituição Fiscal Independente – IFI. Box 1 – Gasto Tributário: Definição, Experiência Internacional e Brasileira [Internet]. [citado 23 de junho de 2025]. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529484/RAF_1_Box_1.pdf
4. Ministério do Planejamento e Orçamento. Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP: dados abertos [Internet]. Ministério do Planejamento. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/doku.php/acesso_publico:dados_abertos

5. Brasil. Siconfi – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro [Internet]. Secretaria do Tesouro Nacional. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf>
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. SCN – Sistema de Contas Nacionais – Tabelas [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9052-sistema-de-contas-nacionais-brasil.html>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.5.01 – Gasto público com saneamento básico como percentual do produto interno bruto [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 5p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18274415



Recursos



REC.5.02 – Gasto federal com saneamento básico como percentual do produto interno bruto

REC.5.02 – Federal expenditure on basic sanitation as percentage of gross domestic product

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual do Produto Interno Bruto (PIB) nacional que corresponde ao gasto público federal com saneamento básico no ano considerado.
- O PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos pelo país durante um período.
- Segundo o art. 3º da Lei nº 11.445/2007¹, o saneamento básico se refere ao conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais abaixo especificados.
 - › Abastecimento de água potável: Constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição.
 - › Esgotamento sanitário: Constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente.
 - › Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: Constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana.
 - › Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: Constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes.
- Para mais informações sobre os gastos federais com saneamento básico, orçamentários e extraorçamentários, pode-se consultar o artigo *Saneamento básico no Brasil: perfil do investimento público para a universalização e promoção do direito humano à água*².

INTERPRETAÇÃO

- Estima a dimensão do gasto federal com saneamento básico em relação ao PIB, indicando o esforço do governo federal no financiamento do setor em relação à capacidade econômica do país.

USOS

- Analisar variações temporais do gasto público com saneamento básico em relação ao PIB.
- Analisar o financiamento governamental, com base na participação de cada esfera de governo no gasto total com saneamento básico, em relação ao valor total de novos bens e serviços finais produzidos pelo país durante um período (PIB).
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de saneamento básico.

LIMITAÇÕES

- Por questões metodológicas, a série de dados a partir de 2013 não é comparável à série até 1997, havendo uma interrupção no levantamento entre 1997 e 2012, o que impossibilita a análise de tendências históricas mais longas.
- O indicador é influenciado por variações do PIB, mesmo que o gasto federal com saneamento se mantenha constante, o que pode afetar sua interpretação temporal.
- O indicador não inclui gastos tributários com saneamento básico, que são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário, correspondendo a uma perda de arrecadação derivada de um tratamento tributário mais favorável³, o que pode subestimar o esforço total do governo federal no setor.

FONTES DE DADOS

- Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)⁴.
- Sistema de Contas Nacionais (SCN)⁵.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Valor total da despesa federal com saneamento básico, no ano de referência}}{\text{Valor do PIB, no ano de referência}} \times 100$$

Nota:

- O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: No cálculo do gasto público federal com saneamento, foram incluídas despesas liquidadas nas seguintes subfunções: 511 – Saneamento básico rural; e 512 – Saneamento básico urbano. Não se utilizou a função 17 – Saneamento, porque, ao se considerar apenas esta função, não seriam contabilizados gastos com a subfunção 511 – Saneamento básico rural, registrados em outras funções.
- Denominador: PIB em valores correntes.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O gasto federal com saneamento como percentual do PIB apresentou redução no período de 2013 a 2023 (Tabela 1). No início da série, em 2013, o indicador representava 0,02% do PIB, e manteve-se em 0,01% na maior parte do período (2014-2021), com uma breve recuperação para 0,02% em 2017. Nos últimos anos, observou-se redução mais acentuada, e os valores se aproximaram de zero em 2022 e 2023 (0,004%).

Tabela 1 – Gasto federal com saneamento básico em relação ao PIB (%). Brasil, 2013 a 2023

Ano	Gasto federal
2013	0,02
2014	0,01
2015	0,01
2016	0,01
2017	0,02
2018	0,01
2019	0,01
2020	0,01
2021	0,01
2022	0,00
2023	0,00

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências [Internet]. Diário Oficial da União. 2007 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
2. Capobianco JPR, Santos GR dos, Checco GB, Mendes AT. Saneamento básico no Brasil: perfil do investimento público para a universalização e promoção do direito humano à água. Bol Reg Urbano Ambient [Internet]. 2023 [citado 27 de março de 2025];29:25–33. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.38116/brua29art2>
3. Senado Federal. Instituição Fiscal Independente – IFI. Box 1 – Gasto Tributário: Definição, Experiência Internacional e Brasileira [Internet]. [citado 23 de junho de 2025]. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529484/RAF_1_Box_1.pdf
4. Ministério do Planejamento e Orçamento. Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP: dados abertos [Internet]. Ministério do Planejamento. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/doku.php/acesso_publico:dados_abertos
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. SCN – Sistema de Contas Nacionais – Tabelas [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9052-sistema-de-contas-nacionais-brasil.html>

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.5.02 – Gasto federal com saneamento básico como percentual do produto interno bruto [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18274462



Recursos



REC.5.03 – Gasto federal com saneamento básico como percentual do gasto federal total

REC.5.03 – Federal sanitation expenditure as percentage of total federal expenditure

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Percentual do gasto público federal total que corresponde a despesas com saneamento básico no ano considerado.
- Segundo o art. 3º da Lei nº 11.445/2007¹, o saneamento básico se refere ao conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais abaixo especificados.
 - › Abastecimento de água potável: Constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição.
 - › Esgotamento sanitário: Constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente.
 - › Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: Constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana.
 - › Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: Constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes.
- Para mais informações sobre os gastos federais com saneamento básico, orçamentários e extraorçamentários, pode-se consultar o artigo *Saneamento básico no Brasil: perfil do investimento público para a universalização e promoção do direito humano à água*².

INTERPRETAÇÃO

- Estima a dimensão do gasto federal com saneamento básico em relação ao conjunto das despesas realizadas pelo governo federal, indicando a priorização deste setor no orçamento federal.

USOS

- Analisar variações temporais da participação do gasto com saneamento básico no gasto federal total, identificando-se tendências que demandem estudos específicos.
- Avaliar a priorização do setor de saneamento básico na alocação dos recursos federais, auxiliando em decisões sobre investimentos no setor.
- Subsidiar processos de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas.

LIMITAÇÕES

- Por questões metodológicas, a série de dados a partir de 2013 não é comparável à série até 1997, havendo uma interrupção no levantamento entre 1997 e 2012, o que impossibilita a análise de tendências históricas mais longas.
- O indicador é influenciado por variações na composição do gasto federal total, mesmo que o gasto com saneamento básico se mantenha constante, podendo mascarar a real priorização do setor.
- O indicador não inclui gastos tributários com saneamento básico, que são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário, correspondendo a uma perda de arrecadação derivada de um tratamento tributário mais favorável³, o que pode subestimar o esforço federal no setor.

FONTE DE DADOS

- Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)⁴.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Valor total da despesa federal com saneamento básico no país e ano de referência}}{\text{Valor total das despesas federais no país e ano de referência}} \times 100$$

Nota:

- O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: No cálculo do gasto público federal com saneamento, foram incluídas despesas liquidadas nas seguintes subfunções: 511 – Saneamento básico rural; e 512 – Saneamento básico urbano. Não se utilizou a função 17 – Saneamento, porque, ao se considerar apenas esta função, não seriam contabilizados gastos com a subfunção 511 – Saneamento básico rural, registrados em outras funções.
- Denominador: Soma de todas as despesas liquidadas por órgãos da União.
- Multiplicador: 100.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

- Não se aplica.

GRANULARIDADE

- Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (DISOC/IPEA).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

O indicador caiu de 0,05%, em 2013, para 0,01%, em 2023, com oscilações no período intermediário. O valor mais baixo foi observado nos três últimos anos da série (2021-2023), mantendo-se em 0,01% (Tabela 1).

Tabela 1 – Gasto federal com saneamento básico em relação ao gasto federal total (%). Brasil, 2013 a 2023

Ano	Despesas totais
2013	0,05
2014	0,04
2015	0,02
2016	0,03
2017	0,04
2018	0,03
2019	0,02
2020	0,03
2021	0,01
2022	0,01
2023	0,01

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências [Internet]. Diário Oficial da União. 2007 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm

2. Capobianco JPR, Santos GR dos, Checco GB, Mendes AT. Saneamento básico no Brasil: perfil do investimento público para a universalização e promoção do direito humano à água. Bol Reg Urbano Ambient [Internet]. 2023 [citado 27 de março de 2025];29:25–33. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.38116/brua29art2>
3. Senado Federal. Instituição Fiscal Independente – IFI. Box 1 – Gasto Tributário: Definição, Experiência Internacional e Brasileira [Internet]. [citado 23 de junho de 2025]. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529484/RAF_1_Box_1.pdf
4. Ministério do Planejamento e Orçamento. Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP: dados abertos [Internet]. Ministério do Planejamento. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/doku.php/acesso_publico:dados_abertos

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.5.03 – Gasto federal com saneamento básico como percentual do gasto federal total [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18274503



Recursos



REC.6.01 – Proporção das importações de bens e serviços de saúde na oferta nacional

REC.6.01 – Import share in total supply of health goods and services

Rede Interagencial de Informações para a Saúde

CONCEITO

- Indica a participação das importações de bens e serviços de saúde no total da oferta nacional destes produtos, em um ano de referência.
- A oferta total de bens e serviços de saúde corresponde à soma de produção nacional e das importações.
- Os bens e serviços de saúde incluem¹: produtos farmoquímicos e medicamentos para uso humano; preparações farmacêuticas; aparelhos e instrumentos para uso médico e odontológico e outros materiais para uso médico, odontológico e óptico, inclusive prótese; e serviços de saúde. Os valores são calculados a preços básicos, permitindo comparabilidade entre períodos e setores.
- Os dados são baseados no Sistema de Contas Nacionais (SCN)², que fornece metodologia padronizada internacionalmente para medir a atividade econômica.
- O SCN possibilita que se selecione um setor-chave, como o da saúde, para um olhar mais detalhado sobre sua atividade econômica, o que é chamado de conta-satélite – neste caso específico, Conta-Satélite de Saúde (CSS)¹.

INTERPRETAÇÃO

- Estima a proporção de bens e serviços de saúde importados em relação ao total ofertado na economia nacional, a preços básicos, indicando o grau de dependência externa do setor da saúde.

USOS

- Avaliar o grau de dependência de um país em relação a produtos e serviços de saúde importados. Isso é importante para entender a vulnerabilidade do sistema de saúde a flutuações no comércio internacional, variações cambiais e interrupções na cadeia de suprimentos global.
- Compreender a proporção de produtos e serviços de saúde importados pode orientar o planejamento estratégico de longo prazo para o desenvolvimento do setor. Isso inclui a identificação de áreas em que o país pode aumentar sua autossuficiência, promover a produção local e reduzir a dependência de recursos externos.
- Avaliar os riscos do setor da saúde em situações de crises globais, como pandemias, conflitos comerciais ou desastres naturais. O indicador auxilia na identificação de vulnerabilidades e na formulação de estratégias para mitigar esses riscos, como diversificação de fornecedores, estoques estratégicos e desenvolvimento de capacidades de produção local.

LIMITAÇÕES

- O indicador é sensível a variações cambiais, que podem afetar significativamente os valores das importações, sem que isso represente mudanças reais no volume de produtos e serviços importados.
- Não reflete aspectos qualitativos importantes, como a transferência de tecnologia e conhecimento associada às importações, elemento fundamental para o desenvolvimento do complexo econômico-industrial da saúde.

FONTE DE DADOS

- Conta-Satélite de Saúde (CSS)³.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\frac{\text{Valor de importação, por produto, no ano de referência}}{\text{Valor da oferta total, por produto, no ano de referência}} \times 100$$

Nota:

- O numerador e o denominador são expressos em reais correntes do ano.

MÉTODO DE CÁLCULO

- Numerador: Valor de importação, por produto, em um ano de referência.
- Denominador: Valor da oferta total, por produto, em um ano de referência.
- Multiplicador: 100.

Notas:

- Os produtos nas CSS¹ são: produtos relacionados à saúde; produtos farmoquímicos; medicamentos para uso humano; preparações farmacêuticas; aparelhos e instrumentos para uso médico e odontológico; outros materiais para uso médico, odontológico e óptico, inclusive prótese; saúde privada; e outros (não saúde).
- O cálculo segue a metodologia padronizada do SCN, operacionalizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para detalhamento completo, consultar o documento orientador⁴.
- Os procedimentos específicos para elaboração da CSS estão descritos na nota técnica do IBGE⁵.
- Valor apresentado como percentual para cada produto. Ou seja, da oferta nacional de um produto, determinado percentual é decorrente de importações.

VARIÁVEIS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

Item de importação:

- Produtos relacionados à saúde;
- Produtos farmoquímicos;
- Medicamentos para uso humano;
- Preparações farmacêuticas;
- Aparelhos e instrumentos para uso médico e odontológico;
- Outros materiais para uso médico, odontológico e óptico, inclusive prótese;
- Saúde privada; e
- Outros (não saúde).

GRANULARIDADE

- Brasil.

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

- Anual.

RESPONSABILIDADE GERENCIAL

- Coordenação de Contas Nacionais da Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (CONAC/DPE/IBGE).

NOTA

- Não se aplica.

ANÁLISE DESCRITIVA DO INDICADOR

A proporção das importações nos produtos relacionados à saúde apresentou crescimento entre 2010 e 2021, passando de 4,7% para 8,0%. Este crescimento foi mais acentuado nos últimos anos da série, especialmente a partir de 2017 (Tabela 1). Os produtos farmoquímicos apresentaram a maior dependência externa, com participação crescente das importações, passando de 71,2%, em 2010, para 84,6%, em 2021, tendo atingido seu pico em 2019 (88,1%). Os medicamentos para uso humano mostraram aumento na participação das importações, de 21,9%, em 2010, para 37,3%, em 2021, com crescimento mais expressivo nos últimos anos da série. Os aparelhos e instrumentos para uso médico e odontológico apresentaram oscilações importantes, variando entre 19,3% (2011) e 34,0% (2020), e fechando 2021 em 29,7%.

Tabela 1 – Proporção (%) das importações na oferta por bens e serviços de saúde, por itens de importação. Brasil, 2010 a 2021

Item de importação	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produtos relacionados à saúde	4,7	4,2	4,7	4,9	4,6	5,3	5,1	4,6	5,3	5,3	6,2	8,0
Produtos farmoquímicos	71,2	74,1	75,9	74,0	69,5	77,4	76,8	76,4	81,8	88,1	87,4	84,6
Medicamentos para uso humano	21,9	20,7	22,5	24,3	23,6	26,3	26,5	24,0	25,5	26,8	28,7	37,3
Preparações farmacêuticas	16,3	16,4	20,0	19,9	23,2	30,3	25,2	22,3	25,6	22,7	18,7	19,6
Aparelhos e instrumentos para uso médico e odontológico	21,3	19,3	21,5	23,4	22,3	25,8	21,8	20,7	24,6	23,7	34,0	29,7
Outros materiais para uso médico, odontológico e óptico, inclusive próteses	29,0	29,7	36,4	37,1	34,4	37,1	32,9	32,8	33,1	31,2	32,6	35,7
Saúde privada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1
Outros (não saúde)	6,7	6,9	7,3	7,7	7,6	7,8	6,8	6,7	7,8	8,1	8,5	9,2

REFERÊNCIAS

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conta-Satélite de Saúde – Sobre [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9056-conta-satelite-de-saude.html?=&t=sobre>
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Contas Nacionais: Brasil 2022 – Notas técnicas [Internet]. IBGE. 2024 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102128>
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conta-Satélite de Saúde – Tabelas [Internet]. IBGE. [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9056-conta-satelite-de-saude.html>
4. United Nations. System of National Accounts 2008 [Internet]. European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank. 2009 [citado 27 de março de 2025]. Disponível em: <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf>
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Contas Nacionais. Conta-Satélite de Saúde: Brasil 2010-2021. IBGE [Internet]. 2024 [citado 27 de março de 2025];(97). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102075_notas_tecnicas.pdf

COMO CITAR

Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Comitê de Gestão de Indicadores de Recursos. REC.6.01 – Proporção das importações de bens e serviços de saúde na oferta nacional [Internet]. Brasília: Ripsa; 2026. 4p. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/fichasidb>. doi: 10.5281/zenodo.18274582





CAPÍTULO 4

FONTES DE INFORMAÇÃO

Fontes de informação

Este capítulo apresenta a fundamentação e a diversidade das fontes de informação que sustentam a construção dos Indicadores Básicos da Ripsa. A qualidade, a abrangência e a confiabilidade dos indicadores dependem diretamente dos sistemas, pesquisas e bases de dados que os alimentam.

A construção dos indicadores é resultado da integração meticulosa de dados provenientes de um amplo espectro de sistemas oficiais, pesquisas populacionais e projeções demográficas. Cada uma dessas fontes traz contribuições específicas, cobrindo distintas dimensões da saúde, da assistência, dos determinantes sociais e do contexto socioeconômico da população brasileira.

Para organizar e elucidar essa ampla rede de informações, as fontes utilizadas foram classificadas em quatro grandes grupos:

1. Sistemas de Informações do Ministério da Saúde
2. Outros Sistemas de Informações de Entidades Públicas
3. Pesquisas e Inquéritos Populacionais
4. Projeções Populacionais

1. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

1.1 Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)

O SIM foi criado em 1975 pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de padronizar e qualificar o registro de óbitos no Brasil. Surgiu em um contexto de necessidade de melhor compreensão do perfil de mortalidade da população brasileira, permitindo o monitoramento das causas de morte e subsidiando políticas públicas.

Ao longo das décadas, o sistema aumentou sua cobertura, e passou por aprimoramentos metodológicos, incorporação de novas tecnologias e fortalecimento das rotinas de vigilância dos óbitos, tornando-se uma das bases de dados mais consolidadas do Sistema Único de Saúde (SUS). A gestão do sistema, na esfera federal, é de responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS), por meio da Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas (CGIAE) e, nos estados e municípios, das Secretarias Estaduais (SES) e Secretarias Municipais de Saúde (SMS), respectivamente.

O documento-base do SIM é a Declaração de Óbito (DO), preenchida exclusivamente por médico. As SMS são responsáveis pela coleta, consolidação e validação das DOs. O sistema desempenha papel estratégico na produção de indicadores de mortalidade, no monitoramento epidemiológico, em estudos de carga de doença, na avaliação de políticas públicas e em análises demográficas. O seu uso abrange desde a gestão local de saúde até pesquisas acadêmicas e o planejamento estratégico nas três esferas do SUS.

O sistema possui abrangência nacional, com cobertura estimada em cerca de 98,9% dos óbitos ocorridos no território brasileiro em 2023. As bases de dados são continuamente atualizadas, com consolidação anual, e o acesso às informações agregadas é disponibilizado

principalmente pelo TabNet/DATASUS, enquanto os microdados anonimizados podem ser obtidos pelo OpenDATASUS, em conformidade com as normas de sigilo e confidencialidade¹.

1.2 Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)

O Sinasc foi criado em 1990 pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de padronizar e qualificar os registros de nascimentos no Brasil. Nasceu como resposta à necessidade de melhorar o conhecimento sobre a situação de saúde materno-infantil, complementando o sistema de mortalidade e permitindo análises mais completas de indicadores como fecundidade, prematuridade, baixo peso ao nascer e características maternas.

Desde sua implantação, o Sinasc passou por atualizações tecnológicas, revisões do formulário da Declaração de Nascido Vivo (DNV) e fortalecimento das rotinas de vigilância. Esses avanços contribuíram para o crescimento contínuo da cobertura e para a melhoria da qualidade das informações produzidas.

A gestão do sistema, em âmbito federal, é realizada pela SVSA/MS, e, em âmbito estadual e municipal, pelas SES e SMS, responsáveis pela coleta, digitação, consolidação e validação das DNVs. O Sinasc é uma fonte essencial para o planejamento em saúde, a vigilância de eventos obstétricos e infantis, o monitoramento de indicadores materno-infantis, a avaliação de políticas públicas e a realização de estudos epidemiológicos. Seu uso abrange de análises locais de serviços de saúde a pesquisas acadêmicas e monitoramentos nacionais, constituindo um componente fundamental da vigilância do ciclo gravídico-puerperal.

O sistema possui abrangência nacional e elevada cobertura, estimada em 99,6% em 2023. Os dados são constantemente atualizados e têm consolidação anual. As informações agregadas podem ser acessadas principalmente pelo TabNet/DATASUS, e os microdados anonimizados estão disponíveis no OpenDATASUS, em conformidade com as normas de sigilo e proteção de dados pessoais.

O Sinasc é reconhecido pela qualidade e consistência das informações, embora ainda apresente desafios em áreas de maior vulnerabilidade social. A vigilância ativa dos nascimentos, a capacitação das equipes, a revisão periódica da DNV e a integração com outros sistemas têm contribuído para aprimorar a completude, a confiabilidade e a tempestividade dos dados².

1.3 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)

O Sinan foi criado no início da década de 1990, tendo sua implantação nacional iniciada a partir de 1993, como parte da estratégia do Ministério da Saúde para padronizar e fortalecer o registro de doenças e agravos de notificação compulsória em todo o território brasileiro. Seu desenvolvimento original esteve alinhado à necessidade de integrar dados epidemiológicos dispersos e apoiar a consolidação das ações de vigilância em saúde no contexto da criação do SUS.

Por meio do Sinan, são notificadas doenças transmissíveis, agravos relacionados ao trabalho, violências interpessoais e autoprovocadas, intoxicações, eventos de interesse sanitário e outros problemas de saúde definidos em legislação específica. As notificações permitem acompanhar tendências, distribuições demográficas, características clínicas, vias de transmissão e a magnitude dos agravos no território nacional.

O sistema é estruturado com fichas padronizadas de notificação individual e de investigação, garantindo a comparabilidade das informações entre regiões e períodos. Os dados

registrados, quando analisados, subsidiam a tomada de decisão das equipes de vigilância, a detecção precoce de surtos, o planejamento de ações de prevenção e controle, bem como a formulação de políticas públicas em saúde.

Assim, o Sinan desempenha papel estratégico na produção de conhecimento epidemiológico no país, contribuindo diretamente para a resposta oportuna a emergências, o fortalecimento das redes de atenção e a melhoria das condições de saúde da população³.

1.4 Sistema de Informações RESP-Microcefalia

O RESP-Microcefalia consolidou-se como uma das principais fontes de dados de vigilância específicos para o monitoramento de casos de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika no Brasil. Criado no contexto da emergência em saúde pública relacionada ao vírus Zika, o sistema buscou integrar notificações, investigações clínicas e dados laboratoriais, para permitir uma resposta rápida e coordenada das autoridades sanitárias. Sua implementação representou um marco na capacidade do país de detectar precocemente eventos de grande impacto para a saúde materno-infantil.

Ao centralizar informações provenientes das redes de atenção e vigilância epidemiológica, o RESP-Microcefalia qualificou os critérios diagnósticos, aprimorou a comunicação entre os serviços e possibilitou análises mais robustas sobre a distribuição dos casos no território. Também contribuiu para identificar perfis epidemiológicos, estimar riscos associados e orientar ações de prevenção e cuidado, inclusive no que se refere ao acompanhamento das crianças acometidas. Assim, tornou-se uma ferramenta estratégica para subsidiar decisões clínicas e de políticas públicas⁴.

1.5 Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica - Malária (Sivep-Malária)

O Sivep-Malária foi implantado em 2003 como sistema nacional para registro e monitoramento dos casos de malária no Brasil, com foco na Região Amazônica. Consolida dados de diagnóstico (lâminas e testes rápidos), espécie parasitária, positividade e acompanhamento do tratamento (incluindo lâminas de verificação de cura – LVCs), permitindo análises espaço-temporais e o direcionamento de ações de controle, prevenção e eliminação da doença⁵.

1.6 Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe)

O Sivep-Gripe foi implantado em 2000 para o monitoramento da influenza por meio da vigilância sentinela e, em 2009, no contexto da pandemia de influenza A(H1N1) pdm09, teve sua vigilância fortalecida para síndrome respiratória aguda grave (SRAG), tornando-se a principal base para notificação e análise de casos graves respiratórios no Brasil. O sistema consolida dados de notificação, internação e óbitos por SRAG, apoiando a detecção de surtos, o monitoramento da circulação de vírus respiratórios (influenza, SARS-CoV-2, VSR e outros) e a caracterização do perfil epidemiológico dos casos. Durante a pandemia de COVID-19, foi essencial para a tomada de decisão em tempo oportuno⁶.

1.7 Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

O SIA é a ferramenta operacional de registro de volume e custo da atenção à saúde ambulatorial e extra-hospitalar no Brasil; teve sua origem instituída pela Portaria GM/MS nº 896, de 29 de junho de 1990. Abrange de registros de consultas básicas de pediatria na unidade básica de saúde (UBS) a sessões complexas de hemodiálise e quimioterapia (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade ou Custo – APAC), operando na lógica de faturamento dos procedimentos e outras ações de saúde realizadas nos territórios.

Embora o SIA e o SIH funcionem no contexto de faturamento de procedimentos ambulatoriais e internações hospitalares, a análise do volume de dados registrados subsidia o planejamento, a programação e a regulação da assistência em saúde. O acesso para extração de dados brutos ou tabulados é feito via TabNet Informações de Saúde (TabNet) – DATASUS ou *download* de arquivos de transferência no *site* do DATASUS, ambos sistemas disponíveis no *link*: Transferência de Arquivos – DATASUS⁷.

1.8 Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

A origem do SIH remonta à crise financeira do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), no final da década de 1970. O sistema anterior, baseado na Guia de Internação Hospitalar (GIH) e no pagamento por ato médico, era inflacionário, imprevisível e permeado por fraudes. Para recuperar o controle do gasto, foi desenvolvido, a partir de 1979, o Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social/Autorização de Internação Hospitalar (SAMHPS/ AIH), implementado em parceria com a Dataprev. Com a constituição do SUS, em 1988/1990, o modelo da AIH foi absorvido e expandido, para cobrir não apenas a rede contratada privada, mas também hospitais públicos, filantrópicos e universitários.

O SIH constitui-se como a ferramenta nacional de registro dos dados de internação, tais como diagnósticos, tempo de permanência, utilização de unidade de terapia intensiva (UTI) e taxas de mortalidade hospitalar. Opera na lógica de pagamento prospectivo do pacote ofertado para a atenção e cuidados específicos em saúde. O SIH ganhou precisão e confiabilidade na medida em que os municípios ampliaram a regulação do SUS, realizando auditorias e validação dos procedimentos e internações realizadas. O acesso para extração de dados brutos ou tabulados é feito via TabNet Informações de Saúde (TabNet) – DATASUS ou *download* de arquivos de transferência no *site* do DATASUS, disponíveis no *link*: Transferência de Arquivos – DATASUS⁸.

1.9 Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde (Siaps)

O Siaps é uma ferramenta de monitoramento e registro das informações que permite o acompanhamento de indicadores, garantindo maior controle e gestão dos serviços de saúde prestados à população.

O primeiro sistema utilizado pelo Ministério da Saúde, denominado Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB)⁹, foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando a ser o sistema de informação vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica. De 2013 a 2016, ocorreu a substituição gradual do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), seu antecessor; e, a partir de janeiro de 2016, instituiu-se a obrigatoriedade do envio de dados exclusivamente para o SISAB (Portaria nº 1.113, de 31 de julho de 2015).

A partir de 2025 (Portaria GM/MS nº 7.639, de 18 de julho de 2025), o SISAB foi sucedido pelo Siaps. O Siaps é operacionalizado por meio da Estratégia e-SUS Atenção Primária à Saúde (e-SUS APS). Esta estratégia estrutura o processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico (e-SUS), e tem como objetivo concretizar um novo modelo de gestão de informação que apoie os municípios e os serviços de saúde na gestão efetiva da APS no território e a qualificação do cuidado dos usuários. A entrada de dados ocorre por meio do sistema de *softwares* que instrumentalizam a coleta dos dados nos municípios, como a Coleta de Dados Simplificados (CDS); o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC); e aplicativos (por exemplo, o e-SUS território). Além disso, existe a possibilidade de integração com sistemas já existentes, sendo utilizadas tecnologias próprias. A disponibilização das informações ocorre em plataforma federal, para consulta pública e extração de dados não sensíveis, para tipos de atendimentos realizados pelas equipes da APS, procedimentos, atividades coletivas, atendimento odontológico e visitas domiciliares.

1.10 Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

No que tange à articulação federativa do financiamento em saúde, o SIOPS, criado em 2000 e gerido pelo Ministério da Saúde, atua como instrumento de governança para o cumprimento da Emenda Constitucional (EC) nº 29. O sistema coleta dados declaratórios bimestrais sobre receitas e despesas, verificando a aplicação mínima de recursos em saúde pelos entes federados e condicionando o recebimento de transferências voluntárias à regularidade do envio dos dados. Produz o Demonstrativo das Despesas com Saúde do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), documento exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), assegurando acesso público e ferramentas para *download*. Cabe destacar que, no âmbito federal, o SIOPS¹⁰ articula-se com outros sistemas de planejamento e execução orçamentária, como o SIOP, o Siafi e o SigaBrasil.

1.11 Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (Siscel)

O Siscel foi criado em 1997 pelo Ministério da Saúde para gerenciar e monitorar exames laboratoriais relacionados ao HIV/aids, integrando a rede de laboratórios públicos e conveniados. O sistema registra e permite acompanhar exames como CD4, carga viral e genotipagem, fundamentais para diagnóstico, definição de condutas e seguimento clínico. Seus dados são utilizados de forma complementar ao Sinan e ao Siclom para apoiar análises epidemiológicas e o planejamento das políticas de prevenção e tratamento¹¹.

1.12 Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom)

O Siclom foi implantado em 1997 como sistema informatizado do Ministério da Saúde para o gerenciamento logístico da dispensação e do estoque de antirretrovirais no país. Por meio do registro da dispensação aos pacientes, permite monitorar a adesão ao tratamento, apoiar a gestão da cadeia logística e estimar o número de pessoas em terapia antirretroviral. Integrado ao Siscel e ao Sinan, constitui um dos pilares da resposta brasileira ao HIV/aids, subsidiando a vigilância, o planejamento de compras e a avaliação da assistência farmacêutica¹².

1.13 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Instituído pela Portaria SAS/MS nº 376/2000 e gerido pelo Ministério da Saúde, o CNES foi criado para substituir sistemas locais e centralizar informações, constituindo-se como

o registro oficial de abrangência nacional de todos os estabelecimentos, equipes, leitos e equipamentos das redes pública e privada de saúde. Sua atualização mensal é obrigatória para a contratualização e o repasse de recursos financeiros, configurando-se como fonte primária para o planejamento, o financiamento, a auditoria e o controle da rede assistencial. Em consonância com o princípio da transparência, seus dados são acessíveis publicamente¹³.

1.14 Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP)

O SIGTAP é um sistema desenvolvido pelo Ministério da Saúde do Brasil Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) em 2008, responsável pela gestão da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. Essa base é essencial para o registro, faturamento e análise dos procedimentos realizados no sistema público de saúde, sendo amplamente utilizada em estudos epidemiológicos, financeiros e de gestão em saúde¹⁴.

2. OUTROS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE ENTIDADES PÚBLICAS

2.1 Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibiliza, desde 2015, as estimativas dos totais dos eventos vitais (nascimentos e óbitos), obtidos através do trabalho de pareamento dos dados das Estatísticas do Registro Civil, do IBGE, e dos Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde¹⁵. Também são estimados os sub-registros e as subnotificações desses eventos nas duas fontes – sub-registro representando a fonte IBGE e subnotificação representando a fonte SIM/Sinasc.

As estimativas dos totais de nascidos vivos e óbitos foram obtidas a partir de um Modelo Linear Generalizado (*Generalized Linear Model* – GLM). A modelagem parte do pareamento bem-sucedido entre as Estatísticas do Registro Civil e os dados do Sinasc (para nascidos vivos) e do SIM (para óbitos)^{16,17}. O GLM é então utilizado para estimar a probabilidade de um indivíduo ser capturado, considerando-se as variáveis comuns às bases de dados do IBGE e do Ministério da Saúde, o que permite a obtenção dos totais populacionais com maior precisão.

Dentre as variáveis utilizadas nos modelos GLM, constam informações provenientes do Censo Demográfico 2022. As variáveis utilizadas para estimativa do total de nascidos vivos foram: Unidade da Federação (UF) de residência da mãe; grupo de idade da mãe; local de nascimento; percentagem da população municipal de mulheres de 25 a 39 anos de idade que completou o ensino médio; e densidade populacional do município, as duas últimas obtidos do Censo Demográfico. Para estimativa do total de óbitos, as variáveis foram: UF de residência do falecido; sexo do falecido; grupo de idade do falecido; local da morte; causa da morte (natural/não natural); percentagem da população municipal de mulheres de 25 a 39 anos de idade que completou o ensino médio; e densidade populacional município, ambas obtidas do Censo Demográfico.

As estimativas de sub-registro/subnotificação de nascimentos e óbitos levam em consideração os eventos ocorridos e não registrados até o 1º trimestre do ano subsequente ao ano de sua ocorrência, atendendo ao prazo legal para efetivação de tal registro.

2.2 Sistema de Informações de Beneficiários (SIB)

O SIB é o sistema informatizado que contém os dados cadastrais dos beneficiários de planos privados de saúde no Brasil. Objetiva apoiar o processo de regulação do setor de saúde suplementar, tendo sido instituído em setembro de 1999, a fim de implementar o processo de ressarcimento ao SUS, conforme estabelecido nos arts. 20 e 32 da Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde).

Sua estrutura é composta por três grupos de dados, os quais devem ser atualizados pelas operadoras sempre que houver alguma alteração: (i) identificação pessoal do beneficiário; (ii) identificação de endereço; e (iii) informações contratuais.

Funciona, portanto, como um cadastro de vínculos de pessoas aos planos de saúde, contendo dados fornecidos mensalmente pelas operadoras de planos privados de saúde sobre a inclusão, a alteração e o cancelamento de beneficiários. A movimentação dessas informações é processada, consolidada e analisada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No cadastro do SIB, constam as informações de mais de 53 milhões de beneficiários ativos em planos de assistência médica e de cerca de 35 milhões em planos exclusivamente odontológicos, ou seja, de beneficiários cujos contratos de planos de saúde estão em vigor (posição em outubro de 2025).

Trata-se também de um importante instrumento de identificação dos beneficiários que receberam assistência médico-hospitalar do SUS, mediante cruzamento de seus dados com os da AIH, para posterior ressarcimento de despesas. Além disso, permite a produção de informações, em âmbito nacional, sobre a cobertura e o perfil epidemiológico dos beneficiários¹⁸.

2.3 Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS)

O Padrão TISS foi estabelecido pela ANS, em 2005, como o padrão obrigatório para as trocas eletrônicas de dados de atenção à saúde dos beneficiários de planos privados de saúde, entre os agentes da saúde suplementar.

O Padrão TISS abrange as trocas dos dados de atenção à saúde entre os seguintes agentes da saúde suplementar: (i) operadoras de planos privados de assistência à saúde; (ii) prestadores de serviços de saúde; (iii) contratantes de plano privado de assistência à saúde familiar/individual, coletivo por adesão e coletivo empresarial; (iv) beneficiários de plano privado de assistência à saúde ou seu responsável legal ou ainda terceiros formalmente autorizados por ele; e (v) ANS.

A implementação do Padrão TISS visa uniformizar as ações administrativas, subsidiar as ações de avaliação e acompanhamento econômico, financeiro e assistencial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e compor o Registro Eletrônico de Saúde.

O Padrão TISS tem por diretriz a interoperabilidade entre os sistemas de informação em saúde preconizados pela ANS e pelo Ministério da Saúde, e, ainda, a redução da assimetria de informações para os beneficiários de planos privados de assistência à saúde.

O Padrão TISS é organizado em cinco componentes: (i) Organizacional (regras operacionais); (ii) Conteúdo e estrutura (arquitetura dos dados); (iii) Representação de conceitos em saúde (terminologias); (iv) Comunicação (meios e métodos); e (v) Segurança e privacidade (proteção dos dados)¹⁹.

O componente de Representação de conceitos em saúde do TISS estabelece o conjunto de termos para identificar os eventos e itens assistenciais na saúde suplementar, consolidados na Terminologia Unificada da Saúde Suplementar (TUSS). A TUSS contém, inclusive, os termos referentes ao rol de procedimentos e eventos em saúde, cobertos obrigatoriamente pelas operadoras de planos de saúde²⁰.

2.4 Sistema de Contas Nacionais (SCN)

Enquanto os sistemas citados anteriormente tratam da execução orçamentária e da capacidade instalada na área da saúde, a dimensão macroeconômica é mensurada pelo SCN do IBGE, que é alinhado a padrões internacionais, e inclui a Conta-Satélite de Saúde (CSS), a qual apresenta dados organizados sobre a estrutura produtiva e a dinâmica do setor saúde no Brasil, oferecendo um panorama claro dos recursos disponíveis e de seus usos²¹.

O SCN brasileiro segue rigorosamente o manual *System of National Accounts* (SNA 2008)²², da Organização das Nações Unidas (ONU) em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), garantindo que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil seja comparável ao de outros países que utilizam a mesma metodologia. A CSS, por sua vez, adota o padrão *System of Health Accounts* (SHA 2011), focado especificamente na economia da saúde. Os resultados são públicos e disseminados por meio de publicações técnicas do IBGE e do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), disponível no *link* <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9056-conta-satelite-de-saude.html?edicao=39672>.

Não obstante este conjunto de sistemas de informação impor desafios, também traz oportunidades para a elaboração e o monitoramento de um conjunto mínimo de indicadores. A riqueza dos dados permite um monitoramento granular da eficiência do gasto público e da situação epidemiológica, mas a fragmentação histórica e a complexidade das regras de negócio exigem um alto nível de especialização para sua interpretação correta.

2.5 Sistema de Contas Regionais (SCR)

Com origens na segunda metade dos anos 1990 e lançamento em 2004, o SCR é uma iniciativa do IBGE, em parceria com órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), cujo objetivo é produzir informações sobre o PIB das UFs.

Os resultados são completamente integrados ao Sistema de Contas Nacionais (SCN) e estão disponíveis para *download* no *site* do IBGE (<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9054-contas-regionais-do-brasil.html>). A série atual, com ano de referência de 2010, foi calculada para o período entre 2010 e 2023, com dados re-tropolados até 2002. Em 2027, os resultados do SCR serão atualizados, em conjunto com a divulgação da nova série do SCN com ano de referência de 2021.

O SCR é a fonte oficial para o cálculo do PIB e do PIB *per capita* das UFs, permitindo melhor compreensão da distribuição espacial das atividades econômicas no país. As informações são tipicamente usadas em planejamento econômico, pesquisas e políticas públicas²⁴.

2.6 Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP)

O Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) é a ferramenta central do governo federal, instituído oficialmente em 2002, por meio do Decreto nº 4.376, de 12 de setembro de 2002, para gerenciar o ciclo completo do dinheiro público, do planejamento ao gasto efetivo. Sob a responsabilidade do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), o sistema organiza e integra os três principais instrumentos legais da gestão orçamentária: o Plano Plurianual (PPA), que define os programas e metas para um período de quatro anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as prioridades e regras para o ano seguinte; e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que detalha e autoriza os gastos anuais por área e ação governamental. Além disso, o SIOP gerencia eventuais remanejamentos ou aumentos de verba (créditos adicionais) e permite o acompanhamento contínuo da execução financeira, garantindo que o planejamento estratégico se transforme em despesa autorizada de forma organizada e rastreável²⁵.

2.7 Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi)

Uma vez aprovado o orçamento, a execução orçamentária e financeira é operacionalizada no Siafi. Operacional desde 1987, sob a tutela do Tesouro Nacional, o Siafi registra em tempo real todos os atos de gestão financeira da União que englobam o empenho, a liquidação e o pagamento. Para garantir a transparência e o controle social desses dados complexos, o Senado Federal mantém a plataforma de *business intelligence* (BI) SigaBrasil – disponibilizado amplamente desde 2005, esse sistema extrai e organiza as informações do Siafi em painéis gerenciais de livre acesso, facilitando o acesso à informação sobre a alocação de recursos²⁶.

2.8 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi)

No que tange à gestão financeira pública, além do Siafi, destaca-se o Siconfi, mantido pelo Tesouro Nacional. Implementado pela Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, o Siconfi consolida e padroniza as informações contábeis de todos os entes federados – municípios, estados, Distrito Federal e União – garantindo o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Com foco na transparência e na consolidação das contas nacionais, o sistema é fundamental para a elaboração do Balanço do Setor Público Nacional (BSPN), que abrange os três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – em todas as esferas de governo. Dessa forma, o Siconfi constitui-se como um pilar essencial da contabilidade pública brasileira, assegurando a comparabilidade e a fiscalização dos dados fiscais em todo o país²⁷.

2.9 SIGA Brasil (Senado Federal)

O SIGA Brasil é um sistema de informações orçamentárias e financeiras criado pelo Senado Federal do Brasil em 2004, com o objetivo de ampliar a transparência e o acompanhamento da execução orçamentária e dos gastos públicos federais. Permite acessar dados detalhados sobre orçamento, despesas, emendas parlamentares e execução financeira do governo federal²⁸.

3. PESQUISAS E INQUÉRITOS POPULACIONAIS

3.1 Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS)

Realizada em 1996 e 2006, a PNDS descreveu o perfil da população feminina em idade fértil e de menores de 5 anos no Brasil, e identificou as mudanças ocorridas na situação da saúde e da nutrição desses dois grupos. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas domiciliares, incluindo mensurações antropométricas (altura, peso e circunferência da cintura), coleta de amostras de sangue e informações sobre o uso de sal iodado. Em 2006, a amostra foi de 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças menores de 5 anos, com amostragem representativa das cinco macrorregiões brasileiras e dos contextos urbano e rural²⁹.

3.2 Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)

Constitui a mais ampla pesquisa de saúde do Brasil, tendo sido realizada em 2013^{30,31} e 2019^{32,33}. Utiliza subamostra da Amostra Mestra do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE, empregando amostragem conglomerada em três estágios (unidade primária de amostragem, domicílios, indivíduos). O desenvolvimento da pesquisa envolveu a coleta das informações nos seguintes eixos: Condições de saúde; Atenção à saúde (acesso, utilização, continuidade do cuidado e financiamento); Vigilância das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) e fatores de risco associados, além das questões relacionadas às desigualdades sociais em saúde³⁴.

3.3 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)

A PNADC é realizada pelo IBGE desde 2012, e, a partir de 2016, substituiu a antiga PNAD como a principal fonte de informações sobre o mercado de trabalho e as condições de vida no Brasil.

A PNADC adota um desenho de painel rotativo de domicílios particulares permanentes, com abrangência nacional, selecionados a partir da Amostra Mestra do SIPD. Os domicílios são investigados a cada três meses, por cinco trimestres consecutivos, sendo que cerca de 180 mil domicílios respondem às entrevistas a cada trimestre.

O questionário básico é aplicado em todas as visitas, sendo coletadas informações demográficas, educacionais e sobre o mercado de trabalho. Além disso, há questionários suplementares aplicados em visitas ou trimestres específicos³⁵.

As informações da PNADC estão sujeitas às mesmas limitações de pesquisas domiciliares de outros países, mas são consideradas de alta qualidade para padrões internacionais, sendo amplamente utilizadas para diagnóstico, monitoramento e avaliação de políticas públicas³⁶.

3.4 Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)

Realizada pelo IBGE desde 1961, a POF inclui informações sobre compra de alimentos a partir dos anos de 2002/2003, e sobre consumo alimentar nas edições de 2008/2009 e 2017/2018. Investiga os orçamentos familiares combinados com outras informações sobre as condições de vida das famílias brasileiras, os índices de preços, as condições de vida a partir do consumo e orçamento das famílias, além de abranger estudos sobre consumo alimentar pessoal e análise da disponibilidade domiciliar de alimentos³⁷.

3.5 Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)

Realizado entre os anos de 2006 e 2023, o Vigitel é um inquérito telefônico de base populacional, empreendido anualmente pelo Ministério da Saúde, que coleta informações sobre as DCNTs e seus principais fatores de risco e proteção, em adultos de 18 anos e mais, nas capitais brasileiras. Nas edições realizadas entre 2006 e 2019, estabeleceu-se um tamanho amostral mínimo de cerca de 2 mil indivíduos em cada cidade, contactados por meio de telefone fixo. No entanto, nos anos de 2020 e 2021, em virtude de dificuldades impostas pela pandemia de COVID-19 à coleta dos dados, estabeleceu-se um tamanho amostral reduzido de cerca de mil indivíduos em cada cidade. Para o ano de 2023, foram realizadas 800 entrevistas em cada uma das localidades, e foram incluídas entrevistas por telefone celular na amostra, devido à queda da cobertura por telefone fixo. São usados pesos de pós-estratificação por sexo, idade e escolaridade, para representar os adultos nas capitais³⁸.

3.6 Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE)

Realizada em 2009, 2012, 2015, 2019 e 2024 pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, a PeNSE constitui a mais importante pesquisa entre adolescentes. A partir de 2015, passou a representar a população de escolares de 13 a 17 anos, em subamostra, e, em 2019, a amostra de 13 a 17 anos abrangeu cerca de 150 mil escolares brasileiros, de escolas públicas e privadas. A PeNSE tem como objetivos: (i) determinar a prevalência de fatores de risco comportamentais junto à população de adolescentes; (ii) acompanhar as tendências destas prevalências ao longo do tempo; e (iii) gerar evidências para orientar e avaliar intervenções³⁹.

3.7 Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil)

Trata-se de um inquérito epidemiológico nacional de saúde bucal, elaborado pelo Ministério da Saúde. Realizada com amostragem probabilística em conglomerados, a SB Brasil é representativa para capitais de UFs, macrorregiões e o país como um todo, abrangendo diferentes faixas etárias⁴⁰. Permite comparabilidade para as edições em 2010 e 2023. A partir de entrevistas e exames clínicos, foram avaliados indicadores como cárie dentária, consequências clínicas de cárie não tratada (*pulp, ulcer, fistula, abscess* – PUFA), necessidades de prótese, entre outros⁴⁰.

3.8 Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN)

Realizada em 1989, incluindo uma amostra domiciliar com representatividade nacional, a PNSN possibilitou a coleta sobre amamentação, estado nutricional, características dos domicílios, entre outras informações, contribuindo para o diagnóstico alimentar e nutricional e para o planejamento das políticas públicas⁴¹.

3.9 Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI)

O ENANI é um inquérito populacional de base domiciliar, com uma primeira edição realizada em 2019⁴², em uma amostra probabilística de crianças menores de 5 anos de idade, distribuídas em 123 municípios dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, sendo a amostra constituída de 14.558 crianças. O estudo incluiu indicadores de nutrição e saúde infantil, como amamentação e estado nutricional.

3.10 Pesquisa Industrial Anual-Produto (PIA-Produto)

Inserir-se no Programa de Modernização das Estatísticas Econômicas do IBGE, com o objetivo de atender à crescente demanda por informações estatísticas sobre bens e serviços industriais produzidos no país. Com a série iniciada em 1998, a PIA-Produto tem por objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a produção de bens e serviços industriais, em quantidade e valor, dos produtos fabricados nas principais empresas do país⁴³. Os dados analisados referem-se à produção, importação e consumo de álcool no país, e foram ajustados por outras informações oriundas da Organização das Nações Unidas (ONU), como as Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat)⁴⁴ e as estatísticas sobre turistas da ONU, que possibilitam estimar novas origens de álcool e de consumo.

4. PROJEÇÕES POPULACIONAIS

4.1 População Residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade, 2000-2024

A base de dados com populações municipais, desagregada por idade e sexo, foi desenvolvida no âmbito do CGI Demográfico, através da formação do Comitê Temático Interdisciplinar (CTI) Estimativas Municipais, da Ripsa. Esse comitê foi formado por componentes do CGI Demográfico e pesquisadores convidados, a fim de se discutir a metodologia para o cálculo das estimativas. Trabalho similar foi coordenado pelo CGI Demográfico entre 2013 e 2015; contudo, naquele momento, a Rede foi desativada. Não obstante a inatividade da Ripsa, a SVSA/MS assumiu a responsabilidade pelo cálculo e a divulgação dessas estimativas até o ano de 2021.

Por meio de reuniões quinzenais, o CTI definiu uma metodologia que deveria ser seguida para o novo cálculo das estimativas populacionais, considerando o conhecimento já adquirido anteriormente na própria Ripsa e os limites de tempo para que nova metodologia fosse proposta. Os dados básicos utilizados para o trabalho foram as Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação, Revisão 2024 (IBGE); as populações municipais, por idade e sexo, obtida dos Censos Demográficos (de 2000, 2010 e 2022); e, para os anos a partir de 2023, as populações municipais totais, calculadas pelo IBGE e divulgadas para o Tribunal de Contas da União (TCU). Também foram utilizadas informações sobre alterações de limites territoriais com efeito sobre a população dos municípios, ocorridas ao longo dos anos.

A metodologia para obtenção das populações desagregadas por idade e sexo seguiu o método de relação de coortes. É assegurada a igualdade entre os somatórios das populações municipais, por sexo e idade, e os totais estaduais projetados pelo IBGE para o período considerado. Esse alinhamento é fundamental, pois as projeções populacionais estaduais são elaboradas pelo método das componentes demográficas, que considera diretamente os padrões históricos e atuais de fecundidade, mortalidade e migração para projetar tendências.

As estimativas de população em pequenas áreas, como é o caso das estimativas dos municípios desagregadas por idade e sexo, possuem algumas limitações. A mais importante delas é que o crescimento populacional calculado entre censos demográficos reflete médias entre pontos no tempo que se distanciam por dez anos ou mais, o que pode mascarar variações específicas nas coortes, pontuais no tempo, ou a partir de um determinado ano. Como variações específicas, podem-se citar crises econômicas, ambientais ou sociais capazes de impactar fortemente a migração, a natalidade e a mortalidade, alterando rapidamente os padrões populacionais de determinados municípios, particularmente em áreas menores.

Assim, é importante conhecer as realidades locais, para se analisarem os resultados de indicadores de saúde calculados por idade e sexo e se avaliar a sua viabilidade.

A operacionalização do cálculo foi coordenada pela SVSA/MS, e contou com a parceria do IBGE no fornecimento dos mapas e informações sobre alterações populacionais decorrentes de mudanças nos limites territoriais entre municípios, ao longo dos anos.

Inicialmente, essa base de dados foi calculada para os anos de 2000 a 2023, e deve ser atualizada anualmente. As Estimativas Municipais da Ripsa deverão ter revisão e atualização anual, de acordo com o calendário de disponibilização de novas informações da dinâmica demográfica e populacional do IBGE, especialmente aquelas relativas aos totais de população municipais disponibilizados pelo instituto a cada mês de agosto e publicadas no Diário Oficial da União (DOU)⁴⁵.

4.2 Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: estimativas e projeções. Revisão 2024

O IBGE elabora projeções da população para o Brasil pelo método das componentes demográficas desde 1973, por meio da Coordenação de População e Indicadores Sociais, Diretoria de Pesquisas. A partir de 1975, as UFs tiveram suas populações calculadas, primeiramente, por métodos matemáticos. Somente a partir do ano de 2013, suas populações também passaram a ser estimadas pelo método das componentes demográficas. Esse método considera a interação das componentes demográficas fecundidade, mortalidade e migração, proporcionando maior aproximação dos dados à realidade demográfica de cada UF.

O conjunto de projeções disponibilizado pelo IBGE na Revisão 2024 incorpora os dados do Censo Demográfico 2022, base fundamental para a atualização da distribuição populacional no território brasileiro. Além deles, foram trabalhados, minuciosamente, os números sobre nascimentos e óbitos desde o ano 2000 até o ano de 2023, para cada UF. A atualização desses dados possibilitou uma visão atual das dinâmicas demográficas nacional e regional, peças essenciais na elaboração das hipóteses futuras das componentes demográficas para cada UF.

As projeções populacionais da Revisão 2024 fornecem indicadores para o período de 2000 a 2070, e são a principal fonte de informação populacional disponível para o período intercensitário. Como importantes usos das projeções, podem-se destacar o planejamento e o monitoramento de políticas e ações nos setores público e privado. Exemplos práticos desses usos no setor de saúde são os programas de avaliação das campanhas nacionais de vacinação, as tendências nos nascimentos para o país, indicadores como o de esperança de vida ao nascer, além de diversos indicadores de saúde que têm a população como denominador⁴⁶.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (BR). Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM [Internet]. Brasília: MS; [citado 1º abr. 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10>
2. Ministério da Saúde (BR). Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc [Internet]. Brasília: MS; [citado 1º abr. 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994>

3. Ministério da Saúde (BR). Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan [Internet]. Brasília: MS; [citado 16 jul. 2025]. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes>
4. Ministério da Saúde (BR). Painel do Registro de Eventos em Saúde Pública – RESP (Microcefalia) [Internet]. Brasília: MS; [citado 20 jan. 2026]. Disponível em: <http://www.resp.saude.gov.br/microcefalia#/painel>
5. Ministério da Saúde (BR). Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica – Malária [Internet]. Brasília: MS; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/sivep-malaria>
6. Ministério da Saúde (BR). Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe [Internet]. Brasília: MS; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html>
7. Ministério da Saúde (BR). Produção Ambulatorial (SIA/SUS) [Internet]. Brasília: DATASUS; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-ambulatorial-sia-sus/>
8. Ministério da Saúde (BR). Produção Hospitalar (SIH/SUS) [Internet]. Brasília: DATASUS; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/producao-hospitalar-sih-sus/>
9. Ministério da Saúde (BR). Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) [Internet]. Brasília: MS; [citado 30 dez. 2025]. Disponível em: <https://sisab.saude.gov.br/>
10. Ministério da Saúde (BR). Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde [Internet]. Brasília: MS; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://portalfns.saude.gov.br/siops/>
11. Ministério da Saúde (BR). Sistema de Controle de Exames Laboratoriais – Siscel [Internet]. Brasília: MS; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/ajuda/pt-br/indicadores-epidemiologicos/sistemas-de-informacao/siscel>
12. Ministério da Saúde (BR). Sistema de Controle Logístico de Medicamentos – Siclom [Internet]. Brasília: MS; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/ajuda/pt-br/indicadores-epidemiologicos/sistemas-de-informacao/siclom>
13. Ministério da Saúde (BR). Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES [Internet]. Brasília: MS; [citado 2 jun. 2025]. Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>
14. Ministério da Saúde (BR). Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos – SIGTAP [Internet]. Brasília: DATASUS; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/sigtap/>
15. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistema de Estatísticas Vitais – Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; [citado 3 jul. 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/26176-estimativa-do-sub-registro.html>
16. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativas de subregistro de nascimentos e óbitos: estimativas desagregadas dos totais de nascidos vivos

- e óbitos: 2016-2019 [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2022 [citado 1º abr. 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101927.pdf>
17. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pareamento das Estatísticas do Registro Civil e dos Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos e Mortalidade (Sinasc e SIM): aplicação da Técnica de Captura-Recaptura para estimativa dos totais de nascidos vivos e óbitos. 2019. Nota metodológica n. 01 [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2019 [citado 1º abr. 2025]. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3098/rc_sev_pe_2015_2016_2017.pdf
 18. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Sistema de Informações de Beneficiários [Internet]. Rio de Janeiro: ANS; [citado 16 abr. 2025]. Disponível em: https://dadosabertos.ans.gov.br/FTP/Base_de_dados/Microdados/dados_dbc/beneficiarios/municipios/
 19. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Padrão TISS – Troca de Informações na Saúde Suplementar [Internet]. Rio de Janeiro: ANS; [citado 16 abr. 2025]. Disponível em: <https://dadosabertos.ans.gov.br/FTP/PDA/TISS/AMBULATORIAL/>
 20. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). SIP – Manual de Orientação e Outros Documentos. Tabela DE-PARA SIP-TUSS [Internet]. Rio de Janeiro: ANS; [citado 16 abr. 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais-do-portal-operadoras/sip-manual-de-instalacao-historico-de-versao-e-outros-arquivos>
 21. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistema de Contas Nacionais Brasil [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; [citado 18 fev. 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9052-sistema-de-contas-nacionais-brasil.html>
 22. United Nations, European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank. System of National Accounts 2008 [Internet]. New York: UN; 2009 [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf>
 23. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conta-Satélite de Saúde: Brasil 2010-2021 [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2024 [citado 27 mar. 2025];(97). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102075_notas_tecnicas.pdf
 24. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Contas Regionais do Brasil [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9054-contas-regionais-do-brasil.html>
 25. Brasil. Decreto nº 4.376, de 12 de setembro de 2002. Dispõe sobre o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo Federal. Diário Oficial da União. 13 set. 2002.
 26. Ministério do Planejamento e Orçamento (BR). Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP: dados abertos [Internet]. Brasília: MPO; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/doku.php/acesso_publico:dados_abertos

27. Ministério da Fazenda (BR), Secretaria do Tesouro Nacional. SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal [Internet]. Brasília: STN; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/siafi>
28. Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional. Siconfi – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro [Internet]. Brasília: STN; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf>
29. Senado Federal (BR). SIGA Brasil – Portal do Orçamento [Internet]. Brasília: Senado Federal; [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil>
30. Ministério da Saúde (BR). Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006 [Internet]. Brasília: MS; 2009 [citado 24 mar. 2025]. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/pnds/>
31. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 mar. 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf>
32. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde 2013: acesso e utilização dos serviços de saúde, acidentes e violências [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [citado 19 mar. 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94074.pdf>
33. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 mar. 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>
34. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde 2019: acidentes, violências, doenças transmissíveis, atividade sexual, características do trabalho e apoio social [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2020 [citado 19 mar. 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101800.pdf>
35. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde – PNS [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; [citado 19 mar. 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html>
36. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; [citado 19 mar. 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html>
37. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual – PNAD Contínua [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; [citado 28 out. 2025]. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticas/operacoes-estatisticas/B5>
38. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; [citado 27 nov. 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-2.html>

39. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico [Internet]. Brasília: MS; [citado 19 mar. 2025]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/download/Vigitel/>
40. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; [citado 28 mar. 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/9134-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar.html>
41. Ministério da Saúde (BR). Dados SB Brasil [Internet]. Brasília: MS; [citado 7 abr. 2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/brasil-sorridente/sb-brasil/dados>
42. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE), Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA). Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição – PNSN 1989 [Internet]. Brasília: INAN; 1990 [citado 24 mar. 2025]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv81879.pdf>
43. Ministério da Saúde (BR). Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil – ENANI-2019 [Internet]. Brasília: MS; [citado 24 mar. 2025]. Disponível em: <https://enani.nutricao.ufrj.br/enani-2019/>
44. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Industrial Anual – PIA-Produto [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2022 [citado 20 mar. 2025]. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pia-produto/tabelas>
45. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (BR). ComexStat – Estatísticas de Comércio Exterior [Internet]. Brasília: MDIC; [citado 20 mar. 2025]. Disponível em: <https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>
46. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa). População residente: estudo de estimativas populacionais para os municípios brasileiros, desagregadas por sexo e idade [Internet]. Brasília: Ripsa; 2025 [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://www.ripsa.org.br/notas-tecnicas/>. doi:10.5281/zenodo.17990183
47. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Projeções da População do Brasil e das Unidades da Federação: Revisão 2024 [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2024 [citado 27 mar. 2025]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>



LISTA DE SIGLAS

Abep	Associação Brasileira de Estudos Populacionais
ABRASCO	Associação Brasileira de Saúde Coletiva
ABTMS	Associação Brasileira de Telemedicina e Telessaúde
AgSUS	Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde
AIH	Autorização de Internação Hospitalar
ANS	Agência Nacional de Saúde Suplementar
APAC	Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade ou Custo
APC	Álcool puro <i>per capita</i>
API	<i>Application programming interface</i> (interface de programação de aplicações)
APS	Atenção Primária à Saúde
ASPS	Ações e serviços públicos de saúde
BEMFAM	Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil
BI	<i>Business intelligence</i>
BIREME	Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
BPA-C	Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado
BPA-I	Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado
BSPN	Balanço do Setor Público Nacional
BVS	Biblioteca Virtual em Saúde
CAES	Coordenação de Avaliação em Economia da Saúde
CBO	Classificação Brasileira de Ocupações
CDS	Coleta de Dados Simplificados
CGARB	Coordenação-Geral de Vigilância das Arboviroses
CGDDI	Coordenação-Geral de Disseminação e Integração de Dados e Informações em Saúde
CGDNT	Coordenação-Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis
CGHDE	Coordenação-Geral da Hanseníase e Doenças em Eliminação
CGI	Comitê de Gestão de Indicadores
CGCOVID	Coordenação-Geral de Vigilância da Covid-19, Influenza e Outros Vírus Respiratórios
CGIAE	Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas
CGSB	Coordenação-Geral de Saúde Bucal
CGSI	Coordenação-Geral de Sistemas de Informação
CGSM	Coordenação-Geral de Saúde das Mulheres
CGVIVA	Coordenação-Geral de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes e Promoção da Cultura de Paz
CGZV	Coordenação-Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial
Cidacs	Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs - Fiocruz/BA)
CID-10	Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CNIE	Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica
COB	Cobertura
Comex Stat	Estatísticas de Comércio Exterior
CONAC	Coordenação de Contas Nacionais

Conasems	Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
Conass	Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
CPO-D	Dentes cariados, perdidos e obturados (dentição permanente)
CSS	Conta-Satélite de Saúde
CTI	Comitê Temático Interdisciplinar
DAENT	Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis
DAHU	Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência
DATHI	Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis
DATASUS	Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde
DCNT	Doenças crônicas não transmissíveis
DEDT	Departamento de Doenças Transmissíveis
DEF	Dispositivos eletrônicos para fumar
DEM	Demográfico
DEMAS	Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde
DEPPROS	Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde
DESCO	Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária
DESID	Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde
DIDES	Diretoria de Desenvolvimento Setorial
DISOC	Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA
DM	Diabetes <i>mellitus</i>
DNV	Declaração de Nascido Vivo
DO	Declaração de Óbito
DOI	Digital Object Identifier
DOU	Diário Oficial da União
DPE	Diretoria de Pesquisas
DRAC	Departamento de Regulação Assistencial e Controle
E/I	Estatuta para Idade
EBIA	Escala Brasileira de Insegurança Alimentar
EC	Emenda Constitucional
EJA	Educação de jovens e adultos
ENANI	Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil
ENSP	Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP - Fiocruz/RJ)
e-SUS APS	Estratégia e-SUS Atenção Primária à Saúde
FA	Febre amarela
FGV	Fundação Getulio Vargas
Fiocruz	Fundação Oswaldo Cruz
FJP	Fundação João Pinheiro
FMI	Fundo Monetário Internacional
FQI	Ficha de Qualificação do Indicador
FRP	Fatores de Risco e Proteção
Fundacentro	Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
GLM	<i>Generalized Linear Model</i> (Modelo Linear Generalizado)

GM	Gabinete do Ministro
GPIND	Gerência de Padronização, Interoperabilidade e Análise de Informações e Desenvolvimento Setorial
GT	Grupo de Trabalho
GT-DTP	Grupo Técnico de Difteria, Tétano e Coqueluche
HA	Hipertensão arterial
IAM	Instituto Aggeu Magalhães (IAM - Fiocruz/PE)
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC95%	Intervalo de confiança de 95%
Icict	Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict - Fiocruz/RJ)
IDB	Indicadores e Dados Básicos
IE	Índice de Envelhecimento
IEN	Indicador Econômico Nacional
IMC	Índice de Massa Corporal
IMIP	Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira
Inamps	Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
INAN	Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição
INCA	Instituto Nacional de Câncer
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
IPARDES	Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
IPCA	Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IRR	Instituto René Rachou (IRR - Fiocruz/MG)
ISFL	Instituições sem fins lucrativos
LC	Lei Complementar
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA	Lei Orçamentária Anual
LRF	Lei de Responsabilidade Fiscal
LVC	Lâmina de verificação de cura
MGDI	Módulo de Gestão de Dados e Indicadores
MIAI	Modelo de Informação de Atendimento Individual
MPO	Ministério do Planejamento e Orçamento
MPS	Ministério da Previdência Social
MRB	Morbidade
MRT	Mortalidade
MS	Ministério da Saúde
NIE	Núcleo de Informações Estratégicas
NV	Nascido vivo
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OIT	Organização Internacional do Trabalho
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
OPAS	Organização Pan-Americana da Saúde
OTI	Oficina de Trabalho Interagencial

P/I	Peso para idade
PEC	Prontuário Eletrônico do Cidadão
PeNSE	Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
PET-CT	Tomografia por Emissão de Pósitrons – Tomografia Computadorizada
PIA-Produto	Pesquisa Industrial Anual-Produto
PIB	Produto interno bruto
Plansab	Plano Nacional de Saneamento Básico
PNAD	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNADC	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
PNDS	Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde
PNE	Plano Nacional de Educação
PNH	Primatas não humanos
PNS	Pesquisa Nacional de Saúde
PNSN	Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição
POF	Pesquisa de Orçamentos Familiares
POP	Planejamento Operacional de Produtos
PPA	Plano Plurianual
PPC	Paridade do poder de compra
PUFA	<i>Pulp, ulcer, fistula, abscess</i> (Índice de Consequências Clínicas de Cárie não Tratada)
RCL	Receita Corrente Líquida
REC	Recursos
RESP	Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP-Microcefalia)
Ride	Região Integrada de Desenvolvimento
Ripsa	Rede Interagencial de Informações para a Saúde
RM	Região Metropolitana
RMM	Razão de mortalidade materna
RN	Recém-nascido
ROR	Research Organization Registry
RREO	Relatório Resumido da Execução Orçamentária
SAES	Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
SAGE	Sala de Apoio à Gestão Estratégica
SAMHPS	Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social
SAPS	Secretaria de Atenção Primária à Saúde
SB Brasil	Pesquisa Nacional de Saúde Bucal
SBIS	Sociedade Brasileira de Informática em Saúde
SCN	Sistema de Contas Nacionais
SCR	Sistema de Contas Regionais
SCTIE	Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
SE	Secretaria Executiva (no contexto SE/MS)
Seade	Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
SEIDIGI	Secretaria de Informação e Saúde Digital
SES	Secretaria Estadual de Saúde
Sesai	Secretaria de Saúde Indígena
SGTES	Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
SIA/SUS	Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS

Siafi	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Siaps	Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde
SIB	Sistema de Informações de Beneficiários
Siclom	Sistema de Controle Logístico de Medicamentos
Siconfi	Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
SIDRA	Sistema IBGE de Recuperação Automática
SIGA Brasil	Sistema de Informações Gerenciais do Orçamento
SIGTAP	Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
SIH	Sistema de Informações Hospitalares
SIM	Sistema de Informação sobre Mortalidade
SINAJUVE	Sistema Nacional de Juventude
Sinan	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
Sinasc	Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
SIOPS	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
SIOPI	Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
SIPD	Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares
SISAB	Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica
Siscel	Sistema de Controle de Exames Laboratoriais
SIVEP-Gripe	Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica – Gripe
SIVEP-Malária	Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica – Malária
SM	Salário mínimo
SMS	Secretaria Municipal de Saúde
SOC	Socioeconômico
SRAG	Síndrome respiratória aguda grave
SRC	Síndrome da rubéola congênita
ST	Secretaria Técnica
Suframa	Superintendência da Zona Franca de Manaus
SUS	Sistema Único de Saúde
SVSA	Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente
TabNet	Tabulador de dados do DATASUS
TBCA	Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
TBM	Taxa bruta de mortalidade
TBN	Taxa bruta de natalidade
TCU	Tribunal de Contas da União
TEF	Taxa específica de fecundidade
TFT	Taxa de fecundidade total
TISS	Troca de Informações na Saúde Suplementar
TMP	Taxa de mortalidade padronizada
TR	Termo de Referência
TUSS	Terminologia Unificada da Saúde Suplementar
UBS	Unidade básica de saúde
UCI	Unidade de cuidados intermediários
UCO	Unidade de Cuidados Coronarianos
UDI	Usuário de drogas injetáveis
UERJ	Universidade do Estado do Rio de Janeiro

UF	Unidade da Federação
Ufac	Universidade Federal do Acre
UFAM	Universidade Federal do Amazonas
UFBA	Universidade Federal da Bahia
UFG	Universidade Federal de Goiás
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UFPA	Universidade Federal do Pará
UFPE	Universidade Federal de Pernambuco
UFPeI	Universidade Federal de Pelotas
UFPI	Universidade Federal do Piauí
UFRN	Universidade Federal do Rio Grande do Norte
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina
UFSCar	Universidade Federal de São Carlos
UnB	Universidade de Brasília
Unesp	Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
Unicamp	Universidade Estadual de Campinas
Unifesp	Universidade Federal de São Paulo
USP	Universidade de São Paulo
UTI	Unidade de terapia intensiva
UX	<i>User experience</i> (experiência do usuário)
Vigitel	Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico



EQUIPE TÉCNICA DOS COMITÊS
DE GESTÃO DE INDICADORES

Equipe técnica dos comitês de gestão de indicadores

A presente edição do livro *Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações* é, acima de tudo, o resultado de um vigoroso e qualificado esforço coletivo. Mais do que um agradecimento institucional, cabe aqui o reconhecimento do papel central desempenhado pelos representantes das 45 instituições que integram a Ripsa e que, nos Comitês de Gestão de Indicadores (CGIs), protagonizaram um processo único de construção colaborativa. Foi o envolvimento comprometido e a busca permanente pelo consenso entre diferentes saberes e *expertises* que permitiram não apenas a criação dos 168 indicadores que compõem esta obra, mas também o desenvolvimento de inúmeros outros produtos que qualificam a informação em saúde no Brasil.

Ao longo desta caminhada, fomos muitos. Diversos rostos e vozes integraram este esforço; alguns precisaram seguir outros caminhos, enquanto outros chegaram para somar novas energias. A cada um e a cada uma que, em algum momento, dedicou tempo, inteligência e paixão ao serviço público e à ciência, registramos nossa profunda gratidão. A contribuição de todos está indelével na solidez deste legado – uma ferramenta indispensável para a análise da saúde no Brasil, fruto de uma construção colaborativa que honra o propósito da Ripsa.

Ademar Barbosa Dantas Junior	Sesai/MS	Barbara Coelho Barbosa da Cunha	Sesai/MS
Adilson Apolinário	IPARDES	Bárbara Cristina Marinho Souza	Sesai/MS
Adriana Araujo Beringuy	IBGE	Bernardo Lanza	UFMG
Adriana Lucia Gonçalves da Silva	SVSA/MS	Bernardino Geraldo Alves Souto	UFSCar
Adriana Nunes Ferreira	Unicamp	Betzaide Cortes	OPAS/OMS
Adriana Regina Farias Pontes Lucena	Sesai/MS	Bianca Borges Leandro	ABRASCO
Adriane Miró Vianna Benke	SVSA/MS	Blenda Leite Saturnino Pereira	Conasems
Adriene dos Santos Sá	SAPS/MS	Caio César Soares Golçalves	FJP
Adriny Galvão Rodrigues	Sesai/MS	Camila Alves Bahia	SAPS/MS
Afra Suassuna Fernandes	IMIP	Camila Azevedo	SVSA/MS
Aglaêr Alves da Nóbrega	SVSA/MS	Carla Gianna Luppi	Unifesp
Alanderson Alves Ramalho	Ufac	Carla Lourenço Tavares de Andrade	ENSP - Fiocruz/RJ
Alda Pimentel	IPEA	Carlos Antônio de Souza Teles Santos	Cidacs - Fiocruz/BA
Alessandro Aldrin Pinheiro Chagas	Conasems	Carlos Eduardo Menezes de Rezende	USP
Alessandra Analu Moreira da Silva	Sesai/MS	Carolina de Campos Carvalho	Icict - Fiocruz/RJ
Alexandre Chater Taleb	ABTMS	Cássia Rebeca de Lima Souza	SAES/MS
Alexandre Dias Porto Chiavegatto Filho	USP	Célia Landmann Szwarcwald	Icict - Fiocruz/RJ
Alexandre Zioli	MPS	Celina Oliveira	ANS
Alexandra Crispim Boing	UFSC	Cezar Akiyoshi Saito	Fundacentro
Alexandra Monteiro Grisolia	ABTMS	Cheila Marina de Lima	SVSA/MS
Alexsandra Silva	Sesai/MS	Cimar Azeredo Pereira	IBGE
Aline Almeida da Silva	AgSUS	Cinthia Kalyne de Almeida Alves	UFPE
Aline Fernanda Silva Sampaio	Ufac	Cintia Honório Vasconcelos	SVSA/MS
Aline Gonçalves Pereira	SAPS/MS	Cintia Simões Agostinho	IBGE
Aluísio Jardim Dornellas de Barros	UFPEl	Cláudia Dias de Jesus	Sesai/MS
Álvaro Escrivão Júnior	FGV e ABRASCO	Claudia Costa Meirelles	SBIS
Amarilis Bahia Bezerra	SVSA/MS	Cláudia Júlia Guimarães Horta	FJP
Ana Carolina Delgado de Almeida	Sesai/MS	Cláudia Maria Cabral Moro Barra	SBIS
Ana Carolina Laraia Ciarlini	SVSA/MS	Cleber Nascimento do Carmo	ENSP - Fiocruz/RJ
Ana Carolina Mota de Faria	SVSA/MS	Cristiane dos Santos Moutinho	IBGE
Ana Júlia Tomasini	SAPS/MS	Cristiano Barreto de Miranda	SAPS/MS
Ana Lorena Lima Ferreira	SAPS/MS	Cristiano Siqueira Boccolini	Icict - Fiocruz/RJ
Ana Lucia Andrade da Silva	UFPE	Cristina Guimarães Rodrigues	Abep
Ana Luiza Braz Pavão Grootenboer	Icict - Fiocruz/RJ	Cristina Maria Rabelais Duarte	Icict - Fiocruz/RJ
Ana Maria Nogaes Vasconcelos	UnB e Abep	Dácio de Lyra Rabello Neto	SVSA/MS
Ananda Beatriz Rodrigues Marques	SAPS/MS	Daila Nina Freire	SVSA/MS
André Salem Szklo	INCA	Dália Elena Romero Montilha	Icict - Fiocruz/RJ e ABRASCO
Andrea Gerger	OPAS/OMS	Daliana Thaisa Maria Teles de Oliveira Souza	SGTES/MS
Andrea de Paula Lobo	SVSA/MS	Daniel Resende Faleiros	Conasems
Andréa Ramos da Silva Bessa	Ufac	Daniel Savignon Marinho	ENSP - Fiocruz/RJ
Andréia Moreira de Andrade	Ufac	Daniela da Silva Feitosa	UFPE
Andressa Gorla	SAES/MS	Daniela Nickel	UFSC
Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira	UFRN	Danielle Ramos de Miranda Pereira	FJP
Angélica Baptista Silva	ENSP - Fiocruz/RJ	Danielle Tupinanmbá Emmi	UFPA
Angélica Saraiva Rangel de Sá	SAPS/MS	David Soeiro Barbosa	UFMG
Anna Beatriz Souza Antunes	SVSA/MS	Débora Franca dos Santos	SVSA/MS
Anselmo Rocha Romao	Icict - Fiocruz/RJ	Debora Siqueira Ramos Beltrammi	SAPS/MS
Antônio César Leal	Unesp	Deborah Carvalho Malta	UFMG
Antonio Fernando Boing	UFSC	Deise Garrido	ABTMS
Antônio Neves Ribas	AgSUS	Delaine Costa	ENSP - Fiocruz/RJ
Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira	SVSA/MS	Denise Lopes Porto	SVSA/MS
Augustus Tadeu Relo de Mattos	UFSCar	Diego Ferreira Lima Silva	AgSUS

Diego Ricardo Xavier Silva	Icict - Fiocruz/RJ	Isabela da Costa Gaspar da Silva	SVSA/MS
Douglas Francisco Kowaleski	UFSC	Isabella Carolyne Martins	SGTES/MS
Edemilson Canale	Sesai/MS	Isabelle Ribeiro Barbosa Mirabal	UFRN
Edinilsa Ramos de Souza	ENSP - Fiocruz/RJ	Isis Moura Santos	SAES/MS
Eduardo Luiz Andrade Mota	UFBA	Iuri da Costa Leite	ENSP - Fiocruz/RJ
Eduardo Rosseti	SVSA/MS	Ivan César Ribeiro	Unifesp
Eliana Cyrino	Unesp	Ivanessa Thaiane do Nascimento Cavalcanti	SCTIE/MS
Élida Amorim Valentim	Sesai/MS	Izabel Guimarães Marri	IBGE
Eliseu Alves Waldman	USP	Izabela Brant da Silva Sena Barbosa	SAPS/MS
Elizabeth França	UFMG	Jacqueline Alves Torres	ANS
Elzo Pereira Pinto Junior	Cidacs - Fiocruz/BA	Jacson Batista de Carvalho	Sesai/MS
Emanuele Souza Marques	UERJ	Jacques Levin	SEIDIGI/MS
Emerson Luiz Lima Araujo	SAPS/MS	Jailson de Barros Correia	IMIP
Emily Maviana da Trindade Santos	Sesai/MS	Janine Schirmer	Unifesp
Erica da Silva Gomes Rabelo	SE/MS	Janise Braga Barros Ferreira	USP-RP
Eugenio Pedroso Lisboa	SAPS/MS	Janne Carla Lopes Mendes	AgSUS
Evandro Penteado Villar Felix	FGV	Jerônimo de Souza Vaz	SAPS/MS
Everton Emanuel Campos de Lima	Unicamp	Jerônimo Oliveira Muniz	UFMG
Everton Nunes da Silva	UnB	Joana Danielle Brandão Carneiro	SAPS/MS
Fabiana Almeida da Matta	SE/MS	João Hallak Neto	IBGE
Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira	UERJ	João Matheus Bremm	SVSA/MS
Fabiola Sulpino Vieira	IPEA	João Paulo Dias de Souza Matieli	BIREME/OPAS/OMS
Felipe Ferré	Conass	João Victor Inglês de Lara	SAPS/MS
Fernanda Cristina de Lima Pinto Tavares	UFPE	Joaquim Pedro Ribeiro Vasconcelos	SGTES/MS
Fernanda Lopes Regina	SVSA/MS	Joanlise Marco de Leon Andrade	UnB
Fernanda Santos Bordalo	SVSA/MS	José Eudes Vieira Barroso	SAPS/MS
Fernando Bellissimo Rodrigues	USP	José Ueleres Braga	UERJ
Fernando Campos Avendanho	Conass	Josué Laguardia	Icict - Fiocruz/RJ
Fernando José Guedes da Silva Júnior	UFPI	Josy Maria de Pinho da Silva	OPAS/OMS
Flávia Avelino Goursand	SVSA/MS	Juan Cortez-Escalante	OPAS/OMS
Flávia Cristina Silveira Lemos	UFPA	Julia do Amaral Gomes	SVSA/MS
Flávia Nascimento de Carvalho	INCA	Julianna Miwa Takarabe	SAPS/MS
Flavia Reis de Andrade	UnB	Juliana Lourenço Sousa	BIREME/OPAS/OMS
Flávia Saraiva Leão Fernandes	Unifesp	Juliana Vaz de Melo Mambrini	IRR - Fiocruz/MG
Flavio Álvares	Conasems	Juliano Marcelo Schaurich Junior	SGTES/MS
Francisco José Aragão Pedroza Cunha	ABRASCO	Jussara Macedo	SBIS
Fúlvio Borges Nedel	UFSC	Jussara Rafael Angelo	ENSP - Fiocruz/RJ
Gabriel Mendes Borges	IBGE	Kandice de Melo Falcão	Conasems
Gabriela Freitas da Cruz	IBGE	Kathie Njaine	ENSP - Fiocruz/RJ
Gabriela Oliveira	SVSA/MS	Keiti Gomes Nery	SE/MS
Gabriella Farias Gomes	SVSA/MS	Kelb Bousquet Santos	UnB
Garibaldi Dantas Gurgel Junior	IAM - Fiocruz/PE	Kenio Costa de Lima	UFRN
Giovanni Máximo	Abep	Klauss Kleydmann Sabino Garcia	SVSA/MS
Giovanny Vinícius Araújo de França	SCTIE/MS	Laércio Reis	SAES/MS
Gislaine Aparecida Fonseca Carvasan	Unicamp	Lais Moraes Paiz	Unesp
Gislene Henrique de Souza	SGTES/MS	Larissa Fortunato Araújo	UFC
Glauucia Talita Possolli	SEIDIGI/MS	Larissa Otaviano Mesquista	SVSA/MS
Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano	MPS	Laura Nogueira Cruz	SAPS/MS
Gustavo Henrique Naves Givisiez	Abep	Leandro Fórnias Machado de Rezende	Unifesp
Hugo Fernandes	Unifesp	Leandro Tavares Correia	UnB
Idalacy Barreto	UFPE	Leila Posenato Garcia	Fundacentro
Ilara Hammerli Sozzi de Moraes	ENSP - Fiocruz/RJ e ABRASCO	Leonardo Costa de Castro	ENSP - Fiocruz/RJ
		Leonardo de Souza Lourenço Carvalho	SVSA/MS

Leonildo Pereira de Souza	IPARDES	Marina Jorge de Miranda	SVSA/MS
Lerida Bartheman Pinheiro Serrano	SAPS/MS	Mário Roberto Dal Poz	UERJ
Leticia Mendes Ricardo	SVSA/MS	Marizelia Leão Moreira	Conasems
Liana Wernersbach Pinto	ENSP - Fiocruz/RJ	Mariza Miranda Theme Filha	ENSP - Fiocruz/RJ
Lidsy Ximenes Fonseca	SVSA/MS	Marli de Mesquita Silva Montenegro	SVSA/MS
Liliane Cristina Gonçalves Bernardes	IPEA	Mateus Vinicius dos Anjos Neves	Sesai/MS
Lincoln de Assis Moura Júnior	SBIS	Matheus Santos Melo	SVSA/MS
Lissandra Amorim Santos Degner	SAPS/MS	Matheus Zuliane Falcão	ABRASCO
Livia Teixeira de Souza Maia	UFPE	Mauro Rodrigues da Silva Júnior	SGTES/MS
Lucas Cardoso dos Santos	USP	Max Moura de Oliveira	UFG
Luci Fabiane Scheffer Moraes	SEIDIGI/MS	Mayara Alves Luis	SVSA/MS
Luciana Correia Alves	Abep	Mayara Maia Lima	SVSA/MS
Luciana Mendes Servo	IPEA	Maykeline dos Santos Leite	AgSUS
Lucia Rolim Santana de Freitas	UnB	Meiry Fernanda Pinto Okuno	Unifesp
Luís Felipe Leite Martins	INCA	Michael Luiz Diana de Oliveira	Conasems
Luiz Alberto Reis Mattos Junior	UFPE	Michell Viudes Garcia Martins	SE/MS
Luiz Antonio Alves de Menezes Junior	SVSA/MS	Mirella Cristina Bezerra de Melo	SVSA/MS
Luiza Eunice Sá da Silva	SVSA/MS	Mirian Carvalho de Souza	INCA
Madalena Monteiro Rosa de Oliveira	IMIP	Mônica Cristina Bogoni Savian	UFPEl
Marceli Diana Helfenstein Albeirice da Rocha	UFPEl	Monica La Porte Teixeira	Seade
Marcela Alvarenga de Moraes	Conasems	Mônica da Silva Nunes	UFSCar
Marcelle Araújo Ribeiro	SVSA/MS	Monica Silva Martins	ENSP - Fiocruz/RJ
Márcia Furquim e Almeida	USP	Naiza Nayla Bandeira de Sá	UFPA
Marcia Leite de Sousa Gomes	SVSA/MS	Nathalia Paula de Souza	UFPE
Marcia Sarpa de Campos Mello	INCA	Nereu Henrique Mansano	Conass
Márcio D. M. Mascarenhas	UFPI	Otaliba Libânio de Moraes Neto	UFG
Márcio Mitsuo Minamiguchi	IBGE	Patricia Driusso	UFSCar
Marco Antônio Bussacos	Fundacentro	Paula Hino	Unifesp
Marco Antonio Ratzsch de Andreazzi	IBGE	Paulo César Andrade Almeida	MPS
Marcos Roberto Gonzaga	Abep	Paulo Henrique Gomes	SAPS/MS
Marcus Tolentino Silva	UnB	Pauline Cristine da Silva Cavalcanti	SAES/MS
Margarida Cristiana Napoleão Rocha	SVSA/MS	Pedro Herculano Guimarães Ferreira de Souza	IPEA
Margareth Cristosomo Portela	ENSP - Fiocruz/RJ	Polyana Caroline de Lima Bezerra	Ufac
Maria de Fátima Marinho	SVSA/MS	Priscila Olin Silva	SAPS/MS
Maria de Fátima Pereira	SAPS/MS	Priscila Reis	SVSA/MS
Maria de Fátima Pina	Icict - Fiocruz/RJ	Rafael Bello Corassa	SVSA/MS
Maria do Socorro Castelo Branco de Oliveira Bastos	UFPA	Rafael dos Santos Henrique	UFPE
Maria Helena Prado de Mello Jorge	USP	Rafael Osório	IPEA
Maria Lucia Franca Pontes Vieira	IBGE	Ranielle de Paula Silva	SVSA/MS
Maria Paula Ferreira	Seade	Raquel Barbosa de Lima	SCTIE/MS
Maria Yury Travassos Ichihara	Cidacs - Fiocruz/BA	Raquel Brandini de Boni	Icict - Fiocruz/RJ
Mariana Gonçalves de Freitas	SVSA/MS	Raquel Medeiros Lisboa	ANS
Mariana Madruga	Sesai/MS	Raul Borges Guimarães	Unesp
Mariana Vercesi Albuquerque	ENSP - Fiocruz/RJ	Reagan Nzudu Boigny	SVSA/MS
Marianna de Camargo Cancela	INCA	Rebeca Carmo de Souza Cruz	SE/MS
Mariângela Carneiro	UFMG	Rebeca de Castro Oliveira	SAPS/MS
Marília Gava	MPS	Renata Bertazzi Levy	USP
Marília Cristina Prado Louvison	USP	Renata de Saldanha da Gama Gracie Carrijo	Icict - Fiocruz/RJ
Marília Miranda Forte Gomes	Abep	Renata Goulart Castro	UFSC
Marina Campos Araújo	ENSP - Fiocruz/RJ	Renata Torres Sena Pita	SAPS/MS
Marina Fernandes Bueno	SVSA/MS	Ricardo Antunes Dantas de Oliveira	Icict - Fiocruz/RJ
		Ricardo Bruno Nascimento dos Santos	UFPA

Ricardo José de Souza Castro	UFPE	Suely Oliveira Campos	SE/MS
Rita Catarina Medeiros Sousa	UFPA	Susana Cecagno	UFPEl
Roberio Rebouças da Silva	UFAM	Tamires Carneiro de Olivedira Mendes	UFRN
Roberta de Vilhena Pires	SAPS/MS	Tarcilla Corrente Borghesan	SVSA/MS
Roberta Souza Freitas	SVSA/MS	Tassia Gaze Holguin	IBGE
Roberto Donato da Silva Júnior	Unicamp	Tatiana Henriques Leite	UERJ
Roberto Meyer Nascimento	UFBA	Tatiana Mingote Ferreira Ázara	IRR - Fiocruz/MG
Roberto Sena Rocha	IRR - Fiocruz/MG	Tereza Cristina Lins Amaral	Conass
Rodrigo Ferreira de Araujo	SE/MS	Tereza Maciel Lyra	IAM - Fiocruz/PE
Ronaldo Fernandes Alves	SVSA/MS	Thaiza Karolline Quirino de Sousa	SVSA/MS
Rosa Marina Soares Doria	IBGE	Thainá Souza Ribeiro	Ufac
Rosane Aparecida Monteiro	USP	Thais Alessa Leite	SAES/MS
Rosana Vieira das Neves	ANS	Thais Barbosa de Oliveira	SAPS/MS
Rose Alexander	OPAS/OMS	Thais Cláudia Roma de Oliveira	Unifesp
Rosemeyre Donato de Brito	UFAM	Konstantyner	SAPS/MS
Ruanna Sandrelly de Miranda Alves	AgSUS	Thanise Sabrina Souza Santos	AgSUS
Sacha Santos Saboia Diniz de Carvalho	SVSA/MS	Thayna Karoline Sousa Silva	Sesai/MS
Sandro Haruyuki Terabe	Conass	Thayna Maria Holanda de Souza	UFPE
Selma Lina Suzuki Akabane	SEIDIGI/MS	Tony Meireles dos Santos	Unifesp
Sergio Vicente Serrano	ABTMS	Tulio Konstantyner	ENSP - Fiocruz/RJ
Sérgio Ricardo Schierholt	UnB	Valeska Carvalho Figueiredo	SE/MS
Silvana Paiva Orlandi	UFPEl	Vanizia Marques de Freitas	ENSP - Fiocruz/RJ
Sílvia Carla da Silva André Uehara	UFSCar	Vera Lucia Luiza	SVSA/MS
Sílvio Ferreira Júnior	FJP	Vera Lucia Tierling	UFPI
Sonia Duarte de Azevedo Bittencourt	ENSP - Fiocruz/RJ	Viriato Campelo	UFPE
Soraia Matilde M. Buchhorn	Unifesp	Vitor Caiaffo Brito	SAPS/MS
Spártaco Galvão Fogaça de Almeida	SAPS/MS	Vitor Venâncio Pires Carvalho Lima	UnB
Stanley Mendes Fonseca	Conasems	Walter Massa Ramalho	Icict - Fiocruz/RJ
Sueli Zeferino Ferreira Almeida	SAPS/MS	Wanessa da Silva Almeida	USP
		Zilda Pereira da Silva	

Nota:

- Integrandes dos CGIs de agosto/2023 a fevereiro/2026.



www.ripsa.org.br

